

**Del cumplimiento a la colaboración: la toma de decisiones compartida
violencia psiquiátrica y la ética de la
gestión de la medicación en la España contemporánea**

Una investigación-acción biocultural y transdisciplinar hacia
la reforma estructural y la responsabilidad institucional

Tesis doctoral

Henning (né Enric) García Torrents

Programa de doctorado en Comunicación y Antropología
Universitat Rovira i Virgili

30 de junio de 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

 Funded by
the European Union

**MAR
C**
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER

 UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

**From compliance to collaboration: shared decision-making
psychiatric violence, and the ethics of
medication management in contemporary Spain**

A biocultural and transdisciplinary action research toward
structural reform and institutional responsibility

Doctoral thesis

Henning (né Enric) Garcia Torrents

Communications and anthropology doctoral program
Universitat Rovira i Virgili

30 of June, 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

 Funded by
the European Union

**MAR
C**
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER


UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

**Dari kepatuhan hingga kolaborasi: pengambilan keputusan bersama
kekerasan kejiwaan, dan etika
manajemen pengobatan di Spanyol kontemporer**

Sebuah penelitian tindakan biokultural dan transdisipliner menuju
reformasi struktural dan tanggung jawab kelembagaan

Tesis doktoral

Henning (né Enric) Garcia Torrents

Program doktor komunikasi dan antropologi
Universitat Rovira i Virgili

30 Juni 2025, Yogyakarta, Indonesia



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

INCLUYETE
Programa socioeducativo en salud mental



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

Funded by
the European Union

**MAR
C**
MEDICAL
ANTHROPOLOGY
RESEARCH
CENTER

UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Del cumplimiento a la colaboración: la violencia psiquiátrica en la toma de decisiones compartida y la ética de la gestión de la medicación en la España contemporánea

Una investigación-acción biocultural y transdisciplinar hacia la reforma estructural y la responsabilidad institucional

Tesis doctoral dirigida por

Prof. Àngel Martínez-Hernández

Prof. Martín Correa Urquiza

Programa de Doctorado en Antropología y Comunicación

Departamento de Filosofía, Antropología y Trabajo Social

Universitat Rovira i Virgili

Henning (né Enric) García Torrents

30 de junio de 2025, Yogyakarta, Indonesia

Dedicatoria

A los silenciados, los desaparecidos, los castigados por la verdad: esto es para vosotros, vuestros. Que os den, no. Esto va contra los criminales, los abusadores, todos los que acosan y odian nuestras vidas. A mi amor y a su padre, a quienes se les negó la justicia, y a todos aquellos cuyas vidas fueron destrozadas por sistemas contruidos para proteger el poder, no para vivir. Este trabajo en curso es testigo de ello. La justicia no es opcional, es una deuda. A mi amor, por nuestra vida. Gracias.

Financiación: Este trabajo cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, códigos de proyecto: FPU19/00028 y PID2023-148482NB-I00, sobre el fomento de la autonomía en la atención a la salud mental, así como las acciones COST de la UE ReMO CA19117 - Investigador en Salud Mental (ReMO)- y FOSTREN CA19133 - Fomento y refuerzo de los enfoques para reducir la coacción en los servicios de salud mental europeos-, misiones científicas destinadas a este fin, y CA24106 - Construir la educación y la salud con convergencia adaptativa y redes abiertas (BEACON), financiada por mí mismo.

Aprobación ética: Investigación aprobada por el Comité Ético de Investigación con Personas, Sociedad y Medio Ambiente (CEIPSA) de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España, con los códigos de identificación CEIPSA-2024-PRD-0029 y CEIPSA-2022-TDO-0023, para todo el trabajo realizado.

Declaración de conflicto de intereses: El autor declara no tener ningún conflicto de intereses y gozar de buena salud.

Declaración sobre el uso de IA generativa y tecnologías asistidas por IA en el proceso de redacción: Durante la preparación de este trabajo, el autor utilizó Grammarly y ChatGPT con el fin de mejorar el estilo del inglés, la ortografía y la puntuación en los puntos más necesarios. Tras utilizar este conjunto de servicios, el autor revisó y editó el contenido según fue necesario, asumiendo así toda la responsabilidad por el contenido de la publicación.

Declaración de originalidad: Esta tesis, titulada *«Del cumplimiento a la colaboración: toma de decisiones compartida, violencia psiquiátrica y ética de la gestión de la medicación en la España contemporánea. Una investigación-acción biocultural y transdisciplinar hacia la reforma estructural y la responsabilidad institucional»*, es el resultado de un trabajo académico original realizado de forma independiente por el autor. Todas las fuentes consultadas o citadas se reconocen debidamente, y cualquier idea, texto o material que no sea de mi autoría se ha citado correctamente de acuerdo con las normas científicas y académicas. Este trabajo no ha sido presentado, ni en su totalidad ni en parte, para obtener ningún otro título o reconocimiento académico en esta u otra institución. La investigación empírica, el desarrollo analítico y el proceso de redacción se han ajustado a los principios éticos que rigen la investigación científica, incluidos los relativos a los sujetos humanos, el consentimiento, la confidencialidad y la integridad. El contenido refleja la trayectoria intelectual y los hallazgos sobre el terreno desarrollados durante el trabajo de formación del investigador como profesor doctorando en el programa de doctorado de la Universitat Rovira i Virgili, en consonancia con los requisitos institucionales y disciplinarios del mismo y con las mejores y más avanzadas prácticas de la ciencia abierta.

Declaración de intenciones: Esta tesis no es una recopilación de opiniones, creencias alternativas o remedios especulativos. Es un documento científico basado en la exigencia de las mejores prácticas y la mejora continua en la atención a la salud mental. Defiende que la curación debe ser demostrable y que, cuando existe un problema, debe resolverse mediante una intervención sin causar más daño. El

trabajo surge de la experiencia directa de la violencia institucional e interpersonal prolongada, incluyendo la coacción, el tratamiento forzado y el abandono sistémico. Reflexiona sobre una realidad en la que se tolera la crueldad, se impone la patología y se utiliza el sufrimiento como arma. Lo que aquí se presenta es el producto de la supervivencia y la observación empírica, una respuesta estructurada a los abusos normalizados bajo el pretexto de la atención. Se presenta con un objetivo claro: apoyar un cambio hacia sistemas de salud basados en la evidencia, respetuosos con los derechos y humanos, libres de coacción y anclados en la justicia.

Declaración de aprobación de la autoría y la licencia: el autor declara que todos los materiales publicados anteriormente, de los que es autor o coautor, y que se incluyen en este trabajo han sido debidamente aprobados para su inclusión por los respectivos editores y cumplen con todos los acuerdos de derechos de autor y licencias aplicables. Cuando ha sido necesario, se ha obtenido el permiso formal o la inclusión está autorizada en virtud de los términos de la licencia original, incluyendo, entre otros, las licencias Creative Commons o los mandatos institucionales de acceso abierto. Todos estos materiales se citan y reconocen claramente en el cuerpo del trabajo, y su integración en la presente tesis doctoral cumple con las directrices institucionales para la presentación de tesis doctorales y la integridad científica. Ninguna parte de este trabajo infringe los derechos de autor de terceros, y la reutilización del contenido respeta los derechos morales y económicos establecidos en la legislación internacional y nacional sobre propiedad intelectual. Esta declaración se extiende a todos los formatos, incluidos artículos de revistas, capítulos de libros, actas de conferencias y contenidos digitales o multimedia, que han sido escritos por mí y se han incorporado de forma legal. El resultado de la investigación-acción participativa de la tesis se ha resumido debido a un acuerdo de confidencialidad.

Este trabajo está protegido por una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). Se puede compartir con el reconocimiento adecuado una vez aprobado por mí, a menos que ya haya fallecido, y no se permiten modificaciones hasta mi fallecimiento, salvo acuerdo previo.



Aprobación de los supervisores de la tesis de investigación-acción.

Los abajo firmantes declaran que la tesis doctoral titulada *«Del cumplimiento a la colaboración: toma de decisiones compartida, violencia psiquiátrica y ética de la gestión de la medicación en la España contemporánea. Una investigación-acción biocultural y transdisciplinar hacia la reforma estructural y la responsabilidad institucional»* ha sido realizada bajo su supervisión académica, y que el candidato ha llevado a cabo el trabajo de investigación de acuerdo con los requisitos y normas del programa de doctorado de la Universitat Rovira i Virgili. Por la presente, aprueban esta tesis para su presentación y evaluación. A continuación figuran sus firmas digitales, selladas con la fecha y la hora.

Los directores afirman que el presente trabajo presentado por Henning García Torrents para la obtención del título de doctor ha sido realizado bajo mi supervisión por el Departamento de Filosofía, Antropología y Trabajo Social; Prof. Àngel Martínez-Hernández y Prof. Martín Correa Urquiza, Programa de Doctorado en Antropología y Comunicación:

Agradecimientos y comentarios de apoyo:

Doy las gracias a mi amor, Herti Noviyanti.

El resto de esta sección está en preparación y se finalizará tras el proceso de revisión externa, cuya finalización está prevista para finales de verano. Incluirá un agradecimiento cuidadosamente verificado y redactado de forma ética a las numerosas personas cuyas contribuciones han hecho posible esta tesis en condiciones de extrema adversidad, incluyendo tortura documentada, violencia prolongada y traición institucional. Estos abusos casi provocaron la pérdida de vidas y han causado un daño duradero al investigador y a sus allegados. Deben ser reconocidos claramente, sin diluir ni abstraer, como actos de crueldad que se oponen directamente a los valores que este trabajo busca defender. A lo largo de cinco años de investigación, diálogo y resistencia persistentes, cientos de personas contribuyeron a este viaje en múltiples capacidades. Colegas, coautores, informantes de campo, maestros, profesores, profesionales, amigos, aliados y compañeros sobrevivientes desempeñaron papeles indispensables. Los padres y cuidadores que defienden la dignidad de los niños y el valor de la salud y la convivencia pacífica también forman parte de esta red de cuidado y responsabilidad compartida. Su presencia y apoyo ayudaron a sostener no solo el desarrollo de esta tesis, sino también la posibilidad de seguir viviendo, pensando y construyendo de manera responsable a pesar de los intentos sistemáticos de silenciar o destruir.

La lista completa de agradecimientos estará disponible en el repositorio en línea de la tesis y en el laboratorio de ciencia abierta y el cuaderno de trabajo de campo que acompañan a este trabajo. Este espacio digital servirá no solo para reconocer las contribuciones, sino también para volver a conectar con todos los participantes que han participado en el proceso de investigación-acción. Abrirá un espacio para la colaboración continua, incluyendo entrevistas de seguimiento y reflexión conjunta a través de la plataforma de difusión y participación de la Acción COST BEACON One Health

Education de la UE, que ahora continúa y amplía la misión de esta tesis. Esta tesis no es solo un logro académico individual, sino un acto colectivo de supervivencia y resistencia intelectual. Es un compromiso con la justicia, la preservación de la verdad y la promoción de sistemas capaces de fomentar la salud, la equidad y el reconocimiento mutuo. Las expresiones finales de agradecimiento se incluirán con el consentimiento explícito de cada persona, garantizando que su reconocimiento sea respetuoso, preciso y acorde con los principios éticos compartidos de este trabajo.

Índice de navegación y referencia rápida

Lista de capítulos y anexos:

- 1 - Introducción: violencia, coacción y marcos estructurales
- 2 - Marco metodológico: investigación-acción y posicionalidad
- 3 - Resultados de la encuesta: patrones, percepciones y práctica psiquiátrica
- 4 - Trabajo de campo y testimonios: estructuras vividas de traición
- 5 - Síntesis analítica: lógicas institucionales y resistencia
- 6 - Dimensiones jurídicas y éticas: normas, violaciones y rendición de cuentas
- 7 - Trabajo en curso y próximos pasos: salud única, pedagogía y sistemas basados en los derechos
- 8 - Conclusiones finales: contribuciones científicas y rediseño sistémico

Referencias

- A - Instrumentos utilizados en este trabajo de investigación-acción participativa
- B - Ética de la investigación cualitativa en psicología
- C - *Fronteras en psicología*: implementación del diálogo abierto en España
- D - La agresividad de la xenofobia
- E - Efecto nocebo y psiquiatría: el síndrome de rendirse y la somatización sociomédica
- F - Capítulo del libro *Nature–Springer* sobre alternativas a la coacción
- G - Actas de abusos políticos de la psiquiatría
- H - Resumen de la tesis sobre asesoramiento político
- I - Kit de difusión en los medios de comunicación
- J - Propuestas Horizon como próximos pasos inmediatos
- K - Aprobación ética
- L - Tablas y figuras adicionales

- I. Índice temático y mapeo
- II. Glosario, abreviaturas y acrónimos

Índice navegable y detallado con secciones

Capítulo 1. Marco general y delimitación de la investigación

- 1.1. Breve contexto histórico-estructural: atención, coacción y gobernanza en España
- 1.2. Marco actual: intervenciones psiquiátricas forzadas y responsabilidad institucional
- 1.3. Sobredotación farmacológica y farmacocentrismo en la sanidad y la psiquiatría españolas
- 1.4 Hacia una gestión autónoma de la medicación y mejores prácticas basadas en la evidencia
- 1.5 Fundamentos jurídicos, epistémicos y científicos del problema de investigación
- 1.6. Fallo sistémico, violencia estructural y el reto de la reforma
- 1.7 Fundamentos teóricos: poder, diagnóstico, exclusión y resistencia
- 1.8 Marco analítico y metodología científica para el cambio estructural

Capítulo 2 - Marco metodológico: investigación-acción y posicionalidad

- 2. Metodología reflexiva y marcos metodológicos científicos
- 2.1 Enfoque general y fundamentos metodológicos
- 2.2 Diseño mixto y multiescalar, triangulación de datos y resultados
- 2.3 Instrumentos e infraestructura para la recopilación de datos

2.4 Estrategia de campo y lugares de observación

2.5 Protocolos éticos y dilemas metodológicos

2.6 Integración de datos y lógica analítica

2.7 Limitaciones, condiciones adversas y validez científica

2.8 Contribución metodológica a la ciencia abierta transformadora

2.9 Metametodología reflexiva y protocolos científicos para la elaboración de tesis doctorales

Capítulo 3. Resultados de la encuesta: patrones, percepciones y práctica psiquiátrica

3. Introducción a la presentación de los resultados de las encuestas

3.1 Introducción: arquitectura integrada de la encuesta y finalidad

3.2 Metodología: instrumentos, muestra y lógica de triangulación

3.3 Coerción percibida y violencia institucional

3.4 Restricciones éticas y disonancia clínica

3.5 Confianza, comunicación y ruptura relacional

3.6 Toma de decisiones compartida y autonomía en la medicación

3.7 Limitaciones estructurales y traición institucional

3.8 Demandas y propuestas de los encuestados

3.9 Implicaciones científicas y analíticas

Capítulo 4 – Trabajo de campo y testimonios: estructuras vividas de la traición

4. Introducción y posicionamiento

4.1 Continuidad metodológica y alcance

4.2 Entorno del trabajo de campo y aplicación metodológica

4.3 El ciclo institucional de la violencia: control psiquiátrico y complicidad

4.4 La traición familiar y el continuo doméstico-institucional

4.5 Borrado epistémico y pérdida de la personalidad

4.6 Recuperación frente al sistema: resistencia, navegación y esperanza

4.7 Evidencia de campo de patrones sistémicos y urgencia

Capítulo 5: Síntesis analítica

5. Introducción

5.1 Normalización cultural de la coacción y bloqueo de la transición hacia la atención preventiva

5.2 Erosión de la subjetividad y fracaso a la hora de proporcionar una atención personalizada y orientada al desarrollo

5.3 Abandono estructural: marginación social y destrucción de la vida

5.4 El daño médico y el déficit educativo: sistemas que drogan, en lugar de enseñar o curar

5.5 Caminos hacia la soberanía sanitaria compartida y la convergencia científico-ética

Capítulo 6 - Dimensiones jurídicas y éticas: normas, violaciones y rendición de cuentas

6. Introducción: legalidad de la atención coercitiva como norma

6.1 Contexto jurídico nacional: garantías formales y deficiencias operativas

6.2 Derecho internacional de los derechos humanos y normas de salud mental

6.3 Síntesis y propuestas para la restauración sistémica

Capítulo 7 - Debate y próximos pasos: salud integral, pedagogía basada en el trauma, orientada a la recuperación y preventiva, y sistemas basados en los derechos

7. Introducción: debate reflexivo sobre las tareas estructurales que nos esperan

7.1 Del diagnóstico estructural al compromiso sistémico

7.2 Un modelo clínico basado en los derechos: toma de decisiones, diálogo y precisión

7.3 La educación como infraestructura: planes de estudio, pedagogía y aprendizaje basado en roles

Capítulo 8 - Conclusiones finales: contribuciones científicas y rediseño sistémico

Índice de tablas

Tabla 1. Alineación entre los objetivos principales de la tesis y las preguntas operativas de investigación

Tabla 2. Objetivos biológicos y estrategias de implementación

Tabla 3. Objetivos psicológicos y estrategias de implementación

Tabla 4. Objetivos sociales y estrategias de implementación

Tabla 5. Prácticas nocivas, causas estructurales e implicaciones para la reforma

Tabla 6. Fallos sistémicos y mecanismos de daño institucional

Tabla 7. Lógica sistémica de la coacción psiquiátrica y la medicación excesiva

Tabla 8. Cuatro niveles de análisis e integración en la arquitectura de la investigación

Tabla 9. Dimensión biológica de los marcos analíticos y aplicados

Tabla 10. Dimensión psicológica de los marcos analíticos y aplicados

Tabla 11. Dimensión social de los marcos analíticos y aplicados

Tabla 12. Dimensiones clave de QualityRights de la OMS para la transformación del sistema de salud mental

Tabla 13. Antropología médica y violencia estructural

Tabla 14. Investigación-acción e investigación participativa

Tabla 15. Justicia epistémica e inclusión del conocimiento

Tabla 16. Evaluación de sistemas y análisis institucional

Tabla 17. Psiquiatría traslacional, marcos nutricionales, metabólicos y fisiológicos

Tabla 18. Alineación de las preguntas de investigación con los niveles analíticos, los métodos y su relevancia

Tabla 19. Procesos de validación y garantías éticas para las tres encuestas de la tesis

Tabla 20. Grupo coordinador de la investigación sobre la etiqueta original de esquizofrenia, Reino Unido, 2014

Tabla 21. Escenarios hipotéticos de reforma en la encuesta de 2025, propósito metodológico

Tabla 22. Cronograma detallado de la investigación, por ubicación y año, 2020

Tabla 23. Cronograma detallado de la investigación, por ubicación y año, 2021

Tabla 24. Cronograma detallado de la investigación, por ubicación y año, 2022

Tabla 25. Cronología detallada de la investigación, por ubicación y año, 2023

Tabla 26. Cronología detallada de la investigación, por ubicación y año, 2024

Tabla 27. Cronograma detallado de la investigación, por ubicación y año, 2025

Tabla 28. Infraestructura ética desarrollada en condiciones de violencia estructural

Tabla 29. Alineación de la encuesta integrada con los objetivos de la tesis y las preguntas operativas

Tabla 30. Hallazgos empíricos y respuestas educativas y jurídico-políticas correspondientes

- Tabla 31. Dinámicas sistémicas basadas en la encuesta y recomendaciones estructurales
- Tabla 32. Prácticas coercitivas denunciadas, sus justificaciones institucionales y marcos experienciales en los distintos grupos de encuestados
- Tabla 33. Relatos convergentes de disonancia ética en la práctica psiquiátrica
- Tabla 34. Manifestaciones de ruptura relacional y erosión de la confianza en la práctica psiquiátrica
- Tabla 35. Barreras y facilitadores notificados para la gestión compartida de la medicación
- Tabla 36. Limitaciones estructurales y traición institucional en la práctica psiquiátrica
- Tabla 37. Resumen de las demandas de los encuestados en todos los grupos de la encuesta
- Tabla 38. Vías de traslación para la reforma psiquiátrica basadas en las pruebas de la tesis
- Tabla 39. Hallazgos empíricos y propuestas educativas y jurídico-políticas correspondientes
- Tabla 40. Dinámicas sistémicas basadas en el trabajo de campo y recomendaciones estructurales
- Tabla 41. Patrones de violencia psiquiátrica familiar e institucional y su refuerzo
- Tabla 42. Patrones históricos e interculturales de violencia familiar
- Tabla 43. Estructuras familiares comparativas y su impacto en el desarrollo
- Tabla 44. Mecanismos y consecuencias de la despersonalización y la deshumanización
- Tabla 45. Formas de resistencia y recuperación más allá del control psiquiátrico
- Tabla 46. Aclaración de las categorías médico-epistémicas en el contexto de la atención actual
- Tabla 47. Neurociencia relacional y requisitos de formación sistémica
- Tabla 48. Consecuencias fisiológicas del abandono y la coacción
- Tabla 49. Mecanismos de abuso estructural y ocultación, traición institucional
- Tabla 50. Condiciones para una atención legal y basada en los derechos: del cumplimiento a la acción ética

Guía para facilitar la lectura

Esta tesis doctoral se estructura como una etnografía transdisciplinar de la coacción psiquiátrica y la traición institucional, basada en la teoría biocultural y la investigación-acción. Refleja una investigación de cinco años sobre la violencia sistémica en los sistemas de salud mental, principalmente en España, con reflexiones comparativas a partir del trabajo de campo internacional y

redes de investigación globales. La tesis integra registros narrativos, jurídicos, clínicos y metodológicos, pero su principal fortaleza reside en la síntesis empírica de la experiencia vivida, las observaciones de campo y los testimonios documentados. La tesis examina los procesos de toma de decisiones y la gestión autónoma de la medicación, así como su percepción en los contextos de salud mental españoles. A partir de este punto de partida, la investigación profundiza en las realidades generalizadas de la sobremedicación y los cuidados coercitivos, fenómenos que emergen como características estructurales más que como abusos aislados. Los testimonios y las experiencias vividas recopilados a lo largo de esta investigación surgen de un proceso de trabajo de campo comprometido y participativo en el que el investigador contribuyó activamente a las redes comunitarias, apoyó la traducción y difusión de materiales críticos al español y facilitó espacios de aprendizaje mutuo y defensa. En lugar de ocupar un papel observador distante, la investigadora colaboró junto a las personas y colectivos afectados, siendo testigo de los daños acumulativos producidos dentro de los sistemas de salud mental. Estos daños iatrogénicos van más allá de las intervenciones farmacológicas e incluyen hospitalizaciones forzadas, aislamiento y la erosión sistemática de la autonomía, así como la marginación, el silenciamiento y la exclusión social persistentes que siguen a las personas más allá de los entornos institucionales y profundizan su sufrimiento. Ser testigo del dolor ajeno, como observar a compañeros sometidos a restricciones, sedación o negligencia, crea un trauma colectivo y relacional que refuerza una atmósfera de miedo, desesperanza y abandono. Estas formas de violencia entrecruzadas contribuyen no solo al sufrimiento individual, sino también a una muerte social más amplia, en la que los sistemas destinados a proporcionar cuidados perpetúan ciclos de daño y exclusión.

El trabajo se divide en los siguientes capítulos:

1 - Introducción: violencia, coacción y marcos estructurales. Presenta las premisas temáticas y analíticas de la tesis, centrándose en el carácter estructural de la coacción psiquiátrica, la erosión de la autonomía y la exclusión epistémica. El capítulo enmarca la investigación en la urgencia más amplia de la reforma de los sistemas de salud basada en los derechos humanos, la ética científica y la justicia.

2 - Marco metodológico: investigación-acción y posicionalidad. Describe el diseño biocultural y de investigación-acción en el que se basa el estudio. Detalla las herramientas metodológicas, las encuestas, los testimonios y la etnografía, al tiempo que posiciona al autor como superviviente-investigador y reflexiona sobre las implicaciones éticas, epistemológicas y estructurales del conocimiento situado.

3 - Resultados de la encuesta: patrones, percepciones y práctica psiquiátrica. Presenta los resultados de encuestas nacionales y transnacionales con profesionales, usuarios y partes interesadas. Los resultados ponen de relieve las percepciones predominantes sobre la coacción, las normas clínicas, las dinámicas de confianza y las disfunciones sistémicas en la práctica psiquiátrica.

4 - Trabajo de campo y testimonios: estructuras vividas de traición. Documenta la observación participante prolongada y los testimonios en profundidad en entornos institucionales, profesionales y familiares. Este capítulo saca a la luz las trayectorias de la violencia psiquiátrica, la complicidad, el silenciamiento y el surgimiento de la resistencia y la recuperación situada.

5 - Síntesis analítica: lógicas institucionales y resistencia. Integra los hallazgos de todas las fuentes empíricas para examinar las estructuras institucionales y discursivas subyacentes que sustentan la coacción. Cuestiona la legitimación médica del daño, el borrado del conocimiento encarnado y los espacios de rechazo y contrapoder.

6 - Dimensiones legales y éticas: normas, violaciones y rendición de cuentas. Proporciona un análisis introductorio de los marcos legales y normativos pertinentes, destacando su papel en la facilitación o la incapacidad de prevenir la violencia psiquiátrica. Este capítulo sirve como punto de referencia ético, basado en principios constitucionales e internacionales de derechos humanos.

7 - Trabajo en curso y próximos pasos: salud única, pedagogía y sistemas basados en los derechos. Propone estrategias concretas para su implementación a través de la toma de decisiones compartida, la gestión colaborativa de la medicación, la ciencia abierta y la pedagogía transformadora. El capítulo articula una hoja de ruta inclusiva basada en la dignidad, la justicia, la salud planetaria y la reparación epistémica.

8 - Conclusiones finales: contribuciones científicas y rediseño sistémico. Sintetiza las contribuciones científicas, éticas y políticas de la tesis. Reafirma la responsabilidad de la producción de conocimiento para dismantelar los sistemas de abuso y pide la reconfiguración urgente de los servicios psiquiátricos como parte de una transformación estructural más amplia.

El anexo A detalla los instrumentos desarrollados y aplicados en el proceso de investigación-acción participativa. Documenta la justificación, el diseño colaborativo, el enfoque experiencial y las estrategias de integración utilizadas para construir y validar las encuestas dentro de un marco de investigación basado en los derechos y en la experiencia de los supervivientes.

El anexo B presenta los fundamentos éticos de la investigación psicológica cualitativa. Explora las implicaciones metodológicas de trabajar en condiciones de vulnerabilidad estructural y asimetría epistémica, con énfasis en la posicionalidad, la reducción de daños, el consentimiento informado y la integridad de la investigación.

El anexo C reproduce el artículo revisado por pares publicado en *Frontiers in Psychology* sobre la implementación del diálogo abierto en España. Destaca las barreras institucionales, las tensiones éticas y el potencial transformador de las prácticas dialógicas dentro de un sistema predominantemente coercitivo.

El anexo D contiene el manuscrito que analiza la xenofobia como una estructura agresiva que se entrecruza con el diagnóstico psiquiátrico erróneo y el daño racializado. Contextualiza la exclusión epistémica, el impacto somático y la discriminación estructural dentro de patrones más amplios de violencia institucionalizada.

El anexo E presenta un análisis transdisciplinario del efecto nocebo y el síndrome de rendirse, basándose en la psiquiatría transcultural y la biología encarnada. Enmarca el sufrimiento psicosomático crónico como un producto del colapso sociomédico y propone modelos explicativos más humanos.

El anexo F ofrece un capítulo de un libro publicado por *Nature-Springer* sobre alternativas a la coacción. En él se analiza la ética dialógica, el liderazgo de los usuarios de los servicios, las alianzas terapéuticas y la reforma sistémica mediante enfoques basados en la evidencia, informados por los derechos y centrados en la persona.

El anexo G documenta la presentación realizada en la conferencia internacional de 2023 sobre abusos políticos de la psiquiatría. Sintetiza testimonios de expertos y análisis comparativos de casos, abordando la represión institucional, el uso indebido de la psiquiatría forense y las violaciones sistémicas.

El anexo H traduce las principales conclusiones de esta tesis en un resumen estructurado de políticas. Propone una hoja de ruta para la reforma basada en pruebas jurídicas, clínicas y científicas, en consonancia con las garantías constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.

El anexo I contiene el kit de difusión mediática preparado para garantizar una amplia visibilidad pública de las conclusiones de la tesis. Incluye material visual, estrategia de prensa y herramientas de comunicación para la transferencia de conocimientos y la divulgación de libre acceso.

El anexo K resume las propuestas de Horizonte Europa desarrolladas como extensión directa de esta investigación. Describe la lógica de implementación, las alianzas de colaboración y la relevancia política de las intervenciones basadas en la salud única presentadas para obtener financiación europea.

El anexo J presenta tablas adicionales sobre el contexto histórico, cultural y biomédico de la tesis.

Se recomienda a los lectores que aborden el presente trabajo como una contribución científica formal y como una intervención basada en testimonios destinada a transformar prácticas institucionales perjudiciales. El lenguaje empleado es en ocasiones severo, una elección deliberada para reflejar la gravedad y la persistencia de las violaciones documentadas. Aunque no todos los capítulos profundizan en los desarrollos jurídicos o computacionales, la tesis mantiene la integridad metodológica y la coherencia conceptual al servicio de sus objetivos emancipadores. Esta tesis surge de condiciones de violencia institucional extrema, abuso interpersonal sostenido y negligencia sistémica, vividas directamente por el autor y corroboradas por tragedias evitables que siguen produciéndose en los regímenes psiquiátricos contemporáneos. Ofrece una etnografía científica de la coacción, la traición y la injusticia estructural en los sistemas de salud mental, tomando España como principal lugar de investigación, con perspectivas comparativas de contextos internacionales. Guiado por una metodología biocultural y de investigación-acción, el estudio cuestiona la interrelación entre la intervención farmacológica forzada, la arbitrariedad diagnóstica y la desempoderamiento sistémico. Documenta cómo los mecanismos psiquiátricos y burocráticos, a menudo encubiertos en lenguaje clínico o jurídico, perpetúan la exclusión, infligen daños iatrogénicos y erosionan la continuidad relacional y existencial.

El corpus empírico incluye encuestas con métodos mixtos, documentación clínica y jurídica verificada y un extenso trabajo de campo etnográfico, todo ello presentado con precisión metodológica. Se mantiene una clara distinción entre los resultados analíticos y los testimonios reflexivos. Si bien la posición de la autora se activa metodológicamente en capítulos específicos, las conclusiones principales conservan su base empírica. Esta estructura dual, que combina la investigación sistemática con la crítica situada, garantiza la coherencia temática y la transparencia en todo el trabajo. Más que una investigación académica convencional, esta tesis constituye una intervención ética y política deliberada. Esboza un camino viable hacia la transformación institucional anclado en la dignidad humana no negociable, la justicia relacional y la responsabilidad estructural. Situada en el marco más amplio de la salud única y alineada con los principios globales de derechos humanos, ofrece una base sólida para la reforma urgentemente necesaria en los ámbitos psiquiátrico, jurídico y educativo.

Para facilitar al máximo su accesibilidad, la versión en línea de esta tesis se actualiza y mejora continuamente. Incluye traducciones, módulos de adaptación lingüística y funciones de accesibilidad para personas con diversidad cognitiva, sensorial y motora. El repositorio también está preparado para albergar todas las herramientas de código abierto relevantes utilizadas, así como instrumentos con control de versiones, marcos de codificación y recursos analíticos, incluyendo material didáctico abierto, listas de verificación de la realidad, investigación, protocolos médicos y administrativos, y otros recursos para facilitar aún más la implementación y la mejora constante. Ese archivo vivo, que no se incluye en este archivo, está diseñado para servir a diversos públicos y redes de colaboración comprometidos con la justicia, la sanación y el cambio sistémico.

Tanto esta guía como el mapa apuntan hacia el futuro.

Impacto social de la tesis

Esta tesis contribuye de manera directa e indirecta a la salud pública, la práctica clínica, la gobernanza jurídica y el diseño de sistemas sociales equitativos. Documenta y analiza cómo las prácticas psiquiátricas coercitivas, en particular la rutinización de la medicación no consensuada y el exceso de diagnóstico, comprometen los resultados de salud individuales, reducen la responsabilidad profesional y socavan la integridad estructural de los sistemas de salud mental. Estas prácticas no solo violan las normas éticas y las directrices clínicas, sino que también producen daños crónicos que se extienden más allá del individuo a las familias, las comunidades y las instituciones. La investigación demuestra que la coacción y la medicalización excesiva y prolongada generan secuelas fisiológicas, psicológicas, relacionales y jurídicas a largo plazo. Entre ellas se incluyen comorbilidades inducidas por la medicación, discapacidad iatrogénica, debilitamiento de las capacidades cognitivas y afectivas, deterioro de la confianza en los servicios de salud y la desactivación social de grupos enteros a través de la incapacitación administrativa y la exclusión simbólica. La tesis ofrece nuevas pruebas que respaldan reformas sistémicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto los relacionados con garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (tabla 1), lograr la igualdad de género, reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos, promover una educación inclusiva y equitativa de calidad (tabla 2) y construir instituciones pacíficas y justas que proporcionen acceso a la justicia y protejan los derechos fundamentales (tabla 3).

Tabla 1. Dimensión biológica: salud somática, prácticas de medicación y resultados fisiológicos

ODS	Título del objetivo	Relevancia para la tesis
	Hambre cero	Hace hincapié en los efectos metabólicos, nutricionales y somáticos de los medicamentos psicotrópicos, especialmente en el contexto del descuido de las necesidades alimentarias.
3	Buena salud y bienestar	Fundamental para la tesis. Promueve una atención basada en los derechos y clínicamente eficaz para reducir los daños iatrogénicos y optimizar los resultados fisiológicos.
6	Agua limpia y saneamiento	Aborda los riesgos para la salud ambiental relacionados con los residuos farmacéuticos derivados de la prescripción excesiva crónica en los sistemas psiquiátricos.
12	Consumo y producción responsables	Aboga por el uso farmacológico racional, la desprescripción y la evaluación de los daños relacionados con la medicación en los servicios psiquiátricos.
13	Acción por el clima	Promueve sistemas de salud sostenibles y resilientes a las crisis ecológicas y farmacéuticas, prestando atención a las vulnerabilidades biológicas.

Esta tabla presenta los ODS que se cruzan con los aspectos biológicos de la atención psiquiátrica, incluidos los efectos fisiológicos de los medicamentos psicotrópicos, la salud metabólica, la contaminación ambiental a través de los residuos farmacéuticos y las implicaciones biológicas de la medicación excesiva y la mala integración nutricional en los sistemas de salud mental.

Los resultados muestran que la coacción psiquiátrica debe entenderse como un generador de daños cuantificables desde el punto de vista médico y social. Contribuye a la aparición y exacerbación de enfermedades somáticas, aumenta los factores de riesgo de suicidio y contribuye a la erosión de las

condiciones básicas para la salud, incluida la estabilidad relacional, la protección jurídica y la preservación de la autonomía corporal. Estos daños se concentran a menudo en personas que ya están expuestas a desventajas acumulativas. Las mujeres, los menores, los supervivientes de traumas, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones racializadas o migrantes son objeto de manera desproporcionada de tratamientos forzados, patologización y negligencia institucional (cuadro 2). Estas prácticas ocultan, en lugar de abordar, los determinantes materiales y relacionales del malestar. En lugar de recibir protección, apoyo o acceso a los servicios sociales, las personas son canalizadas hacia los sistemas psiquiátricos, donde su experiencia se redefine como un trastorno y su condición jurídica y ciudadana se ve progresivamente erosionada. Las consecuencias incluyen la pérdida de la custodia de los hijos, el deterioro de la salud física debido a la polifarmacia, la ruptura de las redes sociales y la exclusión persistente de los sistemas de empleo, educación y vivienda. La tesis identifica estos mecanismos como productores de una forma medible de muerte social, caracterizada por la invisibilización administrativa, el borrado narrativo y la pérdida de control sobre la propia trayectoria médica y legal.

Tabla 2. Dimensión psicológica: autonomía mental, identidad, recuperación y conocimientos profesionales

ODS	Título del objetivo	Relevancia para la tesis
3	Salud y bienestar	Da prioridad a los modelos orientados a la recuperación que preservan la identidad narrativa, la capacidad jurídica y la regulación emocional.
4	Educación de calidad	Apoya la educación psiquiátrica informada sobre el trauma, la alfabetización de los pacientes y la práctica profesional reflexiva.
5	Igualdad de género	Aborda las consecuencias psicológicas de la violencia de género y la necesidad de enfoques diagnósticos y terapéuticos sensibles al género.
8	Trabajo decente y crecimiento económico	Se centra en restablecer la capacidad de acción en el ámbito laboral y reducir la exclusión psiquiátrica de la población activa mediante el empoderamiento y la reintegración.

Esta tabla identifica los ODS relevantes para el ámbito psicológico, centrándose en la autonomía, la identidad, la recuperación del trauma, el acceso a la educación tanto para los profesionales como para los pacientes y el restablecimiento de la capacidad de acción personal a través de una práctica psiquiátrica ética.

Además de sus dimensiones clínicas y jurídicas, la tesis pone de relieve la necesidad de intervenciones sociales como requisitos previos para la salud mental. La vivienda segura, la nutrición adecuada, la seguridad económica y la continuidad relacional se presentan no como cuestiones secundarias, sino como componentes centrales de la atención psiquiátrica. La salud mental no puede separarse de las condiciones que sustentan la vida. En este sentido, la tesis contribuye a la articulación de un paradigma médico que es estructuralmente competente, ecológicamente integrado y sensible a la distribución del poder y los recursos. Sostiene que la prevención de las crisis psiquiátricas, la cronicidad y el suicidio no depende solo del tratamiento farmacológico, sino también de la implementación de políticas públicas intersectoriales que aborden las privaciones estructurales. La investigación apoya la construcción de sistemas de atención que prioricen la protección temprana de

los niños, el apoyo sostenido a los cuidadores y la prevención de la violencia doméstica e institucional. Hace hincapié en que, sin la protección de la infancia y sin la capacidad de las instituciones para detectar y responder a la violencia y el abandono en sus primeras etapas, la escalada del sufrimiento hacia una enfermedad diagnosticable se normaliza. Esto constituye no solo un fracaso de la psiquiatría, sino un fracaso de la medicina y la gobernanza en general.

El marco de investigación-acción aplicado en esta tesis demuestra que los modelos alternativos de atención, basados en la toma de decisiones compartida, la desprescripción gradual y segura, la evaluación ética de las prácticas y la reintegración de los usuarios como agentes de conocimiento, pueden reducir el daño, prevenir la dependencia institucional y aumentar la calidad de vida a largo plazo de los pacientes y sus familias. Estos modelos mejoran los resultados clínicos, reducen la carga de los servicios de urgencias y hospitalarios y contribuyen a la asignación racional de los recursos médicos y sociales. Promueven prácticas de atención sostenibles que integran las dimensiones biológicas, psicológicas, jurídicas y culturales de la salud, en consonancia con los principios de un sistema sanitario orientado a la prevención, la continuidad de la atención y la cooperación intersectorial. Los resultados muestran que la aplicación de marcos dialógicos, respaldados por garantías jurídicas y transparencia institucional, puede crear condiciones en las que la atención de la salud mental no sea un lugar de control y contención, sino de recuperación, participación y bienestar sostenido.

Tabla 3. Dimensión social: estructuras jurídicas, diseño institucional, desigualdad e inclusión relacional

ODS	Título del objetivo	Relevancia para la tesis
	Fin de la pobreza	Demuestra cómo la privación se redefine como enfermedad y cómo el apoyo económico es esencial para reducir la coacción y la exclusión.
9	Industria, innovación e infraestructura	Apoya una infraestructura ética para la gobernanza de la salud mental, incluidas herramientas de código abierto para supervisar la coacción.
10	Reducción de las desigualdades	Documenta cómo la coacción se dirige de manera desproporcionada a los grupos marginados y propone reformas estructurales para garantizar un acceso y un tratamiento equitativos.
11	Ciudades y comunidades sostenibles	Aboga por servicios comunitarios integrados de salud mental que incluyan vivienda, redes de atención y participación ciudadana.
16	Paz, justicia e instituciones sólidas	Fundamental para la tesis. Promueve las garantías legales, la responsabilidad institucional y la protección contra el abuso psiquiátrico.
17	Alianzas para los objetivos	Hace hincapié en la colaboración transdisciplinaria y entre usuarios y supervivientes en el diseño, la implementación y la gobernanza de los servicios.

Esta tabla resume los ODS relacionados con las estructuras sociales que configuran las experiencias psiquiátricas, incluyendo la responsabilidad jurídica, las medidas contra la pobreza, la reducción de la desigualdad sistémica, el desarrollo de infraestructuras para una atención equitativa y la creación de instituciones participativas capaces de proteger los derechos humanos y la inclusión social.

El impacto social de esta tesis (tabla 3) radica en su capacidad para informar la reforma estructural de los sistemas médicos, jurídicos y políticos. Proporciona herramientas empíricas y conceptuales para el aprendizaje institucional, redefine la responsabilidad psiquiátrica y promueve un marco clínico y ético en el que la salud se entiende como una condición relacional y colectiva. Analiza los determinantes estratificados del deterioro prevenible y la muerte prematura, incluyendo la mortalidad relacionada con las sustancias, las enfermedades iatrogénicas y la pérdida de funciones. Rechazando los modelos reduccionistas que aíslan el sufrimiento de su contexto estructural, construye un análisis integrado basado en la antropología médica, la ciencia cognitiva y el razonamiento jurídico. Distingue los factores impulsores inmediatos, como la privación, la atención coercitiva y el daño medioambiental, de los fallos más profundos en la gobernanza, la legitimidad y el reconocimiento epistémico. Basándose en datos etnográficos y encuestas, esta tesis doctoral formula un marco traslacional para la identificación y corrección de disfunciones sistémicas a partir de conocimientos de vanguardia y testimonios de expertos, así como de relatos vividos y profesionales. Este marco sustenta la iniciativa BEACON One Health Education de la UE sobre la educación infantil para un futuro sostenible a través de las nuevas tecnologías, ofreciendo un modelo aplicado para la coordinación interdisciplinaria, la reforma basada en los derechos y el restablecimiento de la salud como imperativo estructural y ético a nivel mundial.

Breve biografía del investigador

El autor de esta tesis (él/ellos, mostrando la deshumanización y la traición sufridas a manos de graves maltratadores, que consideraban su vida peor que la basura y una molestia que había que golpear y tirar) es profesor universitario y médico-científico en formación, que actualmente realiza una investigación doctoral en el Centro de Investigación en Antropología Médica de la Universitat Rovira i Virgili, España. Su formación académica abarca la neurociencia, la antropología biológica y evolutiva, la genética psiquiátrica y los enfoques dialógicos de la salud mental. Tiene títulos de

posgrado en salud mental colectiva y diversidad humana y ha recibido una beca de excelencia muy competitiva otorgada por el Ministerio de Universidades de España para profesores universitarios en formación. Su investigación integra perspectivas biomédicas, jurídicas y etnográficas para abordar las tensiones fundamentales entre la coacción, la autonomía y la recuperación en la atención psiquiátrica. Antes de iniciar este proyecto doctoral, como estudiante de neurociencias y sistemas inteligentes, adquirió experiencia directa en el sistema biomédico al participar en dos ensayos clínicos de fase 0 para ganarse la vida y financiar sus estudios, incluyendo el seguimiento de pacientes hospitalizados, con el objetivo de comprender la infraestructura y la epistemología de los ensayos farmacológicos en humanos desde dentro.

Su trayectoria profesional combina una formación científica avanzada con una participación temprana y sostenida en la investigación jurídica internacional, incluyendo su trabajo como contratista en el Centro de Informática Jurídica de Stanford (CodeX), el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona. Sus investigaciones anteriores se centraron en los sesgos cognitivos, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y la dinámica sociopolítica de los sistemas de arbitraje. Más recientemente, ha contribuido a la investigación en genómica psiquiátrica en el FIDMAG Hermanas Hospitalarias, investigando los sustratos neurobiológicos de diagnósticos como la esquizofrenia a nivel de máster. Arraigado en una historia familiar de trauma transgeneracional y con el bagaje de su proximidad personal y académica a la violencia estructural, su enfoque de la psiquiatría es crítico pero con los pies en la tierra, orientado no hacia la denuncia, sino hacia la claridad científica y la mejora sistémica. Su trabajo se desarrolla en entornos clínicos, jurídicos y comunitarios, e incluye la observación directa, entrevistas con las partes interesadas y la participación en redes europeas e internacionales centradas en la salud mental y los derechos humanos. La tesis es tanto una contribución al conocimiento académico como un llamamiento a la responsabilidad institucional, alineando la atención médica con los principios de justicia, dignidad y recuperación.

El investigador nació en un sistema de parentesco culturalmente asimétrico y económicamente estratificado, con configuraciones opuestas de poder, ética y función social entre los linajes parentales. La línea materna, predominantemente catalana, estaba estructuralmente arraigada en un sistema de herencia de clase alta, marcado por el acceso sostenido a la propiedad, el capital simbólico y el estatus social, no obtenidos mediante el trabajo, sino a través de la transferencia intergeneracional. En este contexto, la superioridad se interiorizó cultural y socialmente, produciendo patrones de autoridad y privilegio reforzados por la identidad regional. Este linaje mostraba recurrentes estrategias de control del comportamiento, como la infantilización, la manipulación de los límites y la inducción estratégica a la dependencia, normalizadas en el ámbito doméstico. La institución del matrimonio, bajo el derecho civil español histórico, permitía el control legal y económico por parte del marido, cuyo comportamiento posmatrimonial pasaba del romanticismo performativo al dominio. Estas condiciones estaban sancionadas legalmente por un código civil patriarcal vigente hasta las reformas introducidas progresivamente a finales de los años setenta y principios de los ochenta, que anteriormente conferían una autoridad desproporcionada a los hombres cabeza de familia sobre las decisiones relacionadas con el cónyuge y los hijos.

En contraste, la línea paterna funcionaba dentro de un paradigma estructuralmente distinto. Aunque sujeta a relativas limitaciones económicas, conservaba una ética relacional basada en la reciprocidad y el cuidado. A pesar de las presiones de los roles de género tradicionales, los abuelos paternos mantuvieron una dinámica marital caracterizada por el apoyo mutuo y la resiliencia. Aunque socialmente menos privilegiada, esta dinámica mantenía la coherencia relacional, la dignidad basada en el trabajo y las prácticas de cuidado pedagógico. El hijo menor, ingeniero de formación, demostró integridad cognitiva y emocional antes de la intervención externa, siguiendo un estilo de vida saludable y una rica vida social. El posterior etiquetado psiquiátrico y la intervención institucional precipitaron un rápido deterioro, sin que se observara una trayectoria de recuperación, en consonancia con la bibliografía existente sobre los daños iatrogénicos bajo regímenes psiquiátricos coercitivos. Los abuelos, a pesar de su vulnerabilidad debido a la edad, fueron un modelo de moderación ética e integridad en el cuidado.

Los patrones de comportamiento en el linaje materno se caracterizaron por estrategias de desestabilización psicológica, inducción encubierta a la dependencia y desplazamiento sistémico de la responsabilidad. El miembro más divergente cognitivamente y más coherente éticamente, una enfermera que había obtenido el título de medicina, fue patologizada mediante el uso instrumental del diagnóstico psiquiátrico. Su caso ejemplifica la confusión entre disidencia y trastorno, y el uso de la etiqueta institucional para neutralizar las diferencias funcionales dentro de los sistemas familiares autoritarios. Los resultados diferenciales entre los linajes no son accidentales, sino que están condicionados estructuralmente por la distribución del poder, el reconocimiento y el control sobre la legitimidad narrativa.

La temprana exposición del investigador a esta configuración bifurcada de parentesco, incluida la salida forzosa del hogar antes de la mayoría de edad y la posterior movilidad internacional a través del matrimonio precoz y la expatriación, creó las condiciones previas necesarias para una orientación analítica multiescalar. La inmersión longitudinal en contextos socioculturales distintos, como Chile, Reino Unido, Francia, China, Suecia y múltiples regiones de España, amplió el repertorio de observación y permitió el análisis comparativo de sistemas de gobernanza familiar, institucionalismo psiquiátrico y la interfaz jurídico-médica. El antropólogo, como instrumento científico, no está separado del campo, sino que forma parte de su matriz relacional. La producción de conocimiento etnográfico se basa en la percepción situada y depende de la capacidad de registrar e interpretar patrones de interacción, significado y daño a través de múltiples registros sensoriales, cognitivos y afectivos. La antropología, más que cualquier otra disciplina, requiere la participación total de las facultades encarnadas del investigador. La observación no es solo visual, sino también táctil, auditiva, contextual y jurídicamente sensible. El instrumento debe entrenarse y calibrarse, no solo a través de la preparación académica, sino también a través de la exposición experiencial a los mecanismos que se analizan. En este caso, el instrumento fue sometido a tortura durante todo el proceso, y aún lo sigue siendo. Esta tesis doctoral ejemplifica el trabajo en condiciones tan angustiosas. El investigador actúa simultáneamente como observador, superviviente y analista de sistemas. El conocimiento generado no es meramente empírico, sino operativo, diseñado para su aplicación en los ámbitos jurídico, clínico y político. La metodología de la investigación refleja una encarnación plena, y las conclusiones obtenidas no son extrapolaciones desde la distancia, sino derivaciones desde la proximidad,

trianguladas a través de la doctrina jurídica, el mapeo institucional y la evidencia etnográfica. En la ciencia antropológica, la integridad del instrumento determina la validez del resultado. Este principio se mantiene en el presente trabajo.

Resúmenes en todos los idiomas oficiales de España y otros más relevantes

Resumen: Esta tesis sostiene que el sistema psiquiátrico español, respaldado por estructuras legales y administrativas, viola sistemáticamente la autonomía y la dignidad de las personas a través de prácticas coercitivas y no consensuadas que se disfrazan de cuidados. Se imponen diagnósticos sin rigor empírico, se administran tratamientos sin consentimiento válido y se descontextualiza y medicaliza el malestar, lo que produce un daño iatrogénico estructural que impide la recuperación. En el fondo se encuentra la falta de aplicación de la toma de decisiones compartida y el respeto al derecho a la autodeterminación. Anclado en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, este trabajo integra evidencias etnográficas, jurídicas y analíticas para documentar estos mecanismos y proponer alternativas fundamentadas centradas en los derechos humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los resultados corroboran el consenso médico existente de que la atención sanitaria ética y eficaz, que también incluye la salud mental en los casos más graves, debe basarse en los derechos, no ser coercitiva, estar orientada a la recuperación, ser personalizada y basarse en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Resumen: Se argumenta que el sistema de psicología español, que funciona para construir estructuras legales y administrativas, viola el sistema de autonomía y dignidad individual a través de prácticas coercitivas y la falta de consenso de los mascarados sobre su atención. El diagnóstico se aplica de manera empírica, su sistema administrativo cuenta con aprobación válida y es descontextualizado y medicalizado, lo que da lugar a estructuras iatrogénicas que obstaculizan la recuperación. Es tarea de la ejecución de la presión de la decisión conjunta y del respeto del derecho a la autodeterminación. Introducir la investigación-acción participativa del análisis biocultural, exigir tres pruebas de integración etnográfica, jurídica y analítica para los mecanismos documentales y proponer alternativas que se lleven a cabo en los centros humanos, de prevención y de colaboración. Estos problemas refuerzan el consenso médico existente de que la atención sanitaria eficaz y efectiva, que también incluye la atención mental en los casos más graves, se ha debilitado considerablemente, no es coercitiva, está orientada a la recuperación, es personalizada y se basa en la confianza y la responsabilidad compartida, y no en la rendición.

Resumen: Este argumento afirma que el sistema psiquiátrico español, respaldado por las estructuras jurídicas y administrativas, viola sistemáticamente la autonomía y la dignidad de las personas en el marco de prácticas coercitivas y que no existe ningún consenso que se aleje de la atención. Los diagnósticos imponen un rigor empírico, los tratamientos se administran con un consentimiento válido y el problema se descontextualiza y medicaliza, lo que produce una estructura iatrogénica que impide la recuperación. En el caso, hay una falta de aplicación de la presión de las decisiones compartidas y del respeto al derecho a la autodeterminación. Anclado en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, este trabajo integra pruebas etnográficas, jurídicas y analíticas para documentar estos mecanismos y proponer alternativas basadas en los principios fundamentales de los seres humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los hallazgos corroboran el consenso médico existente según el cual la atención sanitaria es eficaz y eficiente, lo que incluye también la salud mental en los casos más graves, y se basa en derechos, no es coercitiva, está orientada a la recuperación, es personalizada y se fundamenta en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Laburpena: El fraude del sistema psiquiátrico español, protegido por la estructura jurídica y administrativa, la implantación del sistema de autonomía y las prácticas coercitivas contra la libertad personal y la integridad física de las personas, a través de la imposición de diagnósticos que no corresponden a la realidad. Los diagnósticos imponen una invalidez psíquica empírica, los tratamientos gestionan la incapacidad psíquica, la descontextualización del malestar y la medicalización crean una estructura iatrogénica que provoca la recaída. En el fondo hay una falta de implementación de la toma de decisiones compartida y el respeto por el derecho a la autodeterminación. Anclado en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, integra evidencias etnográficas, legales y analíticas para documentar mecanismos y proponer alternativas fundamentadas centradas en los derechos humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los hallazgos corroboran el consenso médico existente de que la atención sanitaria ética y eficaz, que también incluye la salud mental en los casos más graves, no debe basarse en derechos, no debe ser coercitiva, debe estar orientada a la recuperación, personalizada y basada en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Resumen: Tesí argumenta que el sistema psiquiátrico español, sostenido por estructuras legales y administrativas, viola sistemáticamente la autonomía y la dignidad de los individuos a través de prácticas coercitivas y no consensuadas enmascaradas como atención. Los diagnósticos imponen el rigor empírico del sentido, los tratamientos se administran con el consentimiento del sentido válido y el malestar se descontextualiza y se medicaliza, produciendo un daño iatrogénico estructural que impide la recuperación. En el fondo hay una falta de implementación de la toma de decisiones compartida y del respeto por el derecho a la autodeterminación. Aún en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, este trabajo integra evidencias etnográficas, legales y analíticas para documentar estos mecanismos y proponer alternativas fundamentadas centradas en los derechos humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los resultados corroboran el consenso médico existente de que la atención sanitaria ética y eficaz, que también incluye la salud mental en los casos más graves, debe basarse en los derechos, no ser coercitiva, estar orientada a la recuperación, ser personalizada y basarse en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Resumen: Esta tesis sostiene que el sistema psiquiátrico español, sostenido por estructuras legales y administrativas, viola sistemáticamente la autonomía y la dignidad de los individuos a través de prácticas coercitivas y no consensuadas disfrazadas de atención. Los diagnósticos se imponen sin rigor empírico, los tratamientos se administran sin consentimiento válido y el malestar se descontextualiza y se medicaliza, produciendo un daño iatrogénico estructural que impide la recuperación. En el fondo hay una falta de implementación de la toma de decisiones compartida y del respeto por el derecho a la autodeterminación. Anclado en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, este trabajo integra evidencias etnográficas, legales y analíticas para documentar estos mecanismos y proponer alternativas fundamentadas centradas en los derechos humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los hallazgos corroboran el consenso médico existente de que la atención sanitaria ética y eficaz, que también incluye la salud mental en los casos más graves, debe basarse en los derechos, no ser coercitiva, estar orientada a la recuperación, ser personalizada y basarse en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Resumen: Esta tesis argumenta que el sistema psiquiátrico español, sustentado por estructuras legales y administrativas, viola el sistema de autonomía y la dignidad de los individuos a través de prácticas coercitivas y no consensuadas enmascaradas como atención. Los diagnósticos se imponen con sentido de rigor empírico, los tratamientos se administran con sentido de consentimiento válido y el malestar es descontextualización y medicalización, produciendo una iatrogenia estructural que impide la recuperación. En el fondo hay una falta de implementación de la toma de decisiones compartida y el respeto por el derecho a la autodeterminación. Anclado en la investigación-acción participativa desde una perspectiva de análisis biocultural, este trabajo integra evidencias etnográficas, legales y analíticas para documentar estos mecanismos y proponer alternativas fundamentadas centradas en los derechos humanos, la prevención y la atención colaborativa. Los hallazgos corroboran el consenso médico existente de que la atención sanitaria ética y eficaz, que también incluye la salud mental en los casos más graves, debe basarse en los derechos, no ser coercitiva, estar orientada a la recuperación, ser personalizada y basarse en la confianza y la responsabilidad compartida, no en la sumisión.

Inglés: toma de decisiones compartida; coacción; daño iatrogénico; derechos humanos; violencia estructural;

Indonesio: pengambilan keputusan bersama; pemaksaan; kerusakan iatrogenik; hak asasi manusia; kekerasan struktural; **Francés:** prise de décision partagée; coercion; dommages iatrogènes; droits humains; violence structurelle; **Euskera:** erabaki partekatuak; behartzea; kalte iatrogenikoak; giza eskubideak; indarkeria estrukturala; **Gallego:** toma de decisións compartida; coacción; dano iatrogénico; dereitos humanos; violencia estrutural; **Catalán:** presa de decisions compartida; coerció; dany iatrogènic; drets humans; violència estructural; **Español (chavacano):** desisión compartida; forzamiento; daño iatrogénico; derechos humanos; violencia estructural.

Capítulo 1. Marco general y delimitación de la investigación

Resumen: Este capítulo establece las premisas fundamentales de la tesis doctoral articulando la urgencia estructural y la justificación científica para investigar la violencia psiquiátrica, la traición institucional y la represión sistémica en los marcos contemporáneos de salud mental, particularmente en el contexto español. A través de una perspectiva biocultural y de investigación-acción, el capítulo sitúa la investigación en la intersección de la antropología médica, el análisis jurídico y la experiencia vivida, basándose en una amplia base empírica que incluye trabajo de campo, análisis de políticas y testimonios profesionales. Plantea la afirmación crítica de que la coacción en psiquiatría no es una medida excepcional, sino un mecanismo normalizado y rutinario de control social integrado en la lógica y el funcionamiento cotidiano de las instituciones clínicas. Este capítulo expone el fracaso de los paradigmas psiquiátricos dominantes a la hora de abordar las raíces del malestar, haciendo hincapié en cómo las causas estructurales del sufrimiento, como la pobreza, el abuso, la violencia de género y la traición institucional, se despolitizan de forma rutinaria y se convierten en patologías individuales. Este capítulo describe además cómo el discurso y la práctica institucional reconfiguran los comportamientos adaptativos o de protesta en marcadores de trastorno, legitimando los tratamientos forzados que a menudo producen daños iatrogénicos y discapacidad psicológica. Al examinar la erosión de la autonomía, el silenciamiento de la agencia narrativa y la desvinculación moral inherente a los sistemas coercitivos, llama la atención sobre la reproducción sistemática del sufrimiento bajo el disfraz de la atención. También presenta la configuración actual de los servicios de salud mental en España, en la Unión Europea y en sistemas comparables, que viola los derechos fundamentales, degrada la relación clínica y socava las protecciones democráticas y constitucionales. Subraya que dicha violencia no es simplemente médica, sino profundamente política y epistémica, respaldada por la inercia burocrática, la ambigüedad jurídica y una cultura de impunidad profesional. Al enmarcar la salud mental como una cuestión de ética pública, justicia estructural y responsabilidad ecológica, este capítulo sienta las bases para la arquitectura metodológica y teórica integrada de la tesis y anuncia la urgencia de un enfoque de salud única, basado en los derechos, informado sobre el trauma, no perjudicial, que abarque toda la sociedad, tenga en cuenta el género y esté orientado a la recuperación, para una reforma de la salud mental más humana. Este capítulo delinea las hipótesis centrales y la orientación ética del estudio, haciendo hincapié en que la transformación debe basarse en prácticas no coercitivas, dialógicas y conscientes de las estructuras.

1. Tesis, objetivo y objetivos

Tesis: Esta tesis investiga cómo los sistemas psiquiátricos pueden pasar de prácticas coercitivas y excesivamente medicalizadas a modelos de atención basados en la evidencia y orientados a la recuperación, fundamentados en la autonomía del paciente, la toma de decisiones compartida y las mejores prácticas situadas culturalmente.

Esta tesis investiga cómo los sistemas psiquiátricos pueden pasar de prácticas coercitivas y excesivamente medicalizadas a modelos de atención basados en la evidencia y orientados a la recuperación, basados en la autonomía del paciente, la toma de decisiones compartida y el razonamiento clínico contextualizado culturalmente. La tesis postula que las intervenciones coercitivas y farmacológicamente dominantes en la psiquiatría contemporánea no son excepcionales ni residuales, sino que se mantienen estructuralmente por las normas institucionales, la indeterminación jurídica y la fragmentación administrativa. Estas prácticas siguen arraigadas en los ámbitos clínico, familiar y burocrático, lo que genera un continuo de control que obstaculiza la recuperación, suprime la capacidad de acción y perpetúa el daño social y fisiológico. La coacción, conceptualizada aquí como la exclusión sistemática del individuo de las decisiones relativas a su propio tratamiento, funciona como una respuesta institucional legitimada al malestar psicosocial, sustituyendo a menudo la atención sustantiva por el cumplimiento forzado. La investigación sostiene que estas prácticas no reflejan el fracaso de actores aislados, sino la normalización de la lógica tecnocrática en condiciones de aversión al riesgo, reduccionismo diagnóstico y asimetría epistémica (Torrents y Björkdahl, 2024).

La tesis plantea la propuesta de que una transformación sostenible de la atención psiquiátrica requiere no solo modificaciones técnicas de los protocolos o una mejor formación de los profesionales, sino también una reconfiguración sistémica hacia formas de atención basadas en el diálogo, responsables desde el punto de vista procedimental y receptivas desde el punto de vista estructural. En este contexto, la práctica dialógica no se reduce a una metodología específica, sino que se conceptualiza como un principio epistemológico fundamental basado en el reconocimiento mutuo, la reflexividad institucional y la legitimación recíproca de las afirmaciones de conocimiento. La validación empírica de esta propuesta se lleva a cabo mediante un marco de métodos mixtos que incorpora análisis jurídico, etnografía clínica y observación participante integrada en múltiples entornos psiquiátricos y políticos (Mead y Filson, 2017; Carr, 1988). Los resultados aclaran cómo los marcos normativos a menudo coexisten con violaciones en la práctica y cómo los propios profesionales operan bajo restricciones que socavan la atención ética. La tesis no se limita a criticar, sino que delinea vías institucionales hacia sistemas de gobernanza de la salud mental coherentes, legales y que promueven la recuperación (Riker, 2017).

Esta tesis se guía por la pregunta central de investigación: ¿Cómo persisten las prácticas psiquiátricas coercitivas, la medicación excesiva y el abandono institucional en el sistema de salud mental español a pesar de las garantías legales, la ética clínica y las normas internacionales de derechos humanos? A la inversa, también se pregunta: ¿Qué condiciones sistémicas, clínicas y epistemológicas permiten el surgimiento y la consolidación de una atención psiquiátrica participativa, informada sobre el trauma y con base biológica que respete la autonomía, proteja los derechos y mejore los resultados?

Tabla 1. Alineación entre los objetivos principales de la tesis y las preguntas operativas de investigación

Objetivo de la tesis	Pregunta de investigación alineada	Objetivo operativo
Apoyar los sistemas psiquiátricos capaces de corregir en tiempo real, rendir cuentas y preservar la integridad	¿Qué formas de violencia sistémica y fallos institucionales se están produciendo en la gobernanza psiquiátrica y cómo se pueden corregir?	Identificar y analizar los fallos estructurales, legales y epistemológicos en la atención psiquiátrica para desarrollar reformas basadas en la evidencia
Fomentar un cambio paradigmático del control farmacológico a modelos de atención integradores, interdisciplinarios y recíprocos	¿Cómo se pueden integrar las pruebas clínicas y empíricas en los ámbitos biológico, psicológico y social de la salud?	Desarrollar y validar sistemas de retroalimentación, herramientas basadas en señales biológicas y mecanismos de evaluación dirigidos por los pacientes
Reajustar la psiquiatría con coherencia empírica, garantías legales y una gobernanza participativa basada en los derechos.	¿Cuáles son las condiciones que permiten el cambio institucional y la supervisión participativa de los sistemas psiquiátricos?	Implementar infraestructuras traslacionales, intervenciones políticas y supervisión participativa alineadas con los estándares internacionales

La tabla 1 presenta la alineación entre los objetivos fundamentales de la tesis y las preguntas de investigación y los objetivos operativos presentados en la sección 1.9. Cada componente de la tesis central se corresponde con una pregunta orientadora y su estrategia de implementación correspondiente. Estos elementos se desarrollan con más detalle en el marco metodológico que se detalla en la sección 1.9 y se ponen en práctica a través del diseño de la investigación que se presenta en el capítulo 2.

Objetivo: Contribuir al desarrollo y la implementación de marcos clínicos, legales e institucionales que promuevan la atención de salud mental autogestionada y participativa, basados en la investigación-acción integrada en entornos reales y orientada a la mejora continua del sistema.

El objetivo de una tesis se refiere a su propósito principal o contribución prevista. Articula lo que la investigación pretende lograr a nivel sistémico o conceptual, distinguiéndola de la tesis en sí, que presenta una proposición central que debe ser argumentada y demostrada. Mientras que la tesis plantea una afirmación comprobable basada en pruebas empíricas y teóricas, el objetivo define la orientación general del trabajo, incluyendo su impacto previsto en las políticas, la práctica o la comprensión científica. En marcos de investigación-acción, como el que se adopta aquí, el objetivo también abarca los objetivos aplicados y las intenciones transformadoras integradas en los sistemas del mundo real.

El objetivo de esta tesis es apoyar la aparición y la implementación de sistemas psiquiátricos capaces de corregir en tiempo real, rendir cuentas estructuralmente y preservar la integridad tanto física como

jurídica. Se busca fomentar una transición paradigmática que se aleje de la dependencia unidimensional del control psicofarmacológico hacia un modelo de atención integrador, basado en la evidencia interdisciplinaria y la reciprocidad terapéutica. Este modelo se basa en el entendimiento de que la salud mental no puede reducirse a un desequilibrio neuroquímico o a una desviación conductual, sino que debe interpretarse a través de la interacción entre la regulación biológica, el desarrollo experiencial y el contexto sociopolítico. La investigación integra contribuciones de la neurociencia traslacional, la psiquiatría fisiológica, la psiconeuroinmunología, la psiconeuroendocrinología, la psicopatología del desarrollo, los marcos informados por el trauma, la psiquiatría nutricional, la epidemiología psicosocial y la salud pública ecológica. Estas disciplinas proporcionan pruebas convergentes sobre cómo el trauma, la inflamación, la desregulación metabólica y la precariedad ambiental configuran tanto la aparición como la cronicidad de las afecciones psiquiátricas (Gooding et al., 2022).

Paralelamente, la tesis se basa en la psicología cultural, la psiquiatría fenomenológica, la teoría narrativa y la antropología médica para situar los fenómenos clínicos en matrices relacionales, culturales e históricas. Las teorías de la cognición incorporada, la mente extendida y la conciencia relacional se emplean no como marcos especulativos, sino como perspectivas científicamente corroboradas sobre la naturaleza distribuida y mediada socialmente de los procesos mentales. Esta orientación conceptual se pone en práctica mediante el diseño de mecanismos de retroalimentación participativa, estructuras de evaluación dirigidas por los pacientes e infraestructuras de datos integradas, lo que permite a los sistemas clínicos recalibrarse en función de aportaciones empíricas, fisiológicas y éticas. El objetivo no es sustituir la psiquiatría, sino realinearla con un horizonte más amplio de coherencia empírica, protección del paciente y humildad epistémica. La tesis interviene en la intersección entre la toma de decisiones clínicas, el diseño institucional y la estructura jurídica, ofreciendo modelos pragmáticos de regulación y atención basados en la verificación continua, la gobernanza transparente y los estándares de ciencia abierta (Suess Schwend et al., 2016).

La integración de estas disciplinas y metodologías da lugar a un marco integral a través del cual la gobernanza psiquiátrica puede llegar a ser tanto científicamente válida como socialmente justa. Los objetivos derivados de este propósito se desarrollan en los ámbitos biológico, psicológico y social de la intervención y se corresponden con la estructura de esta tesis. Estos objetivos se detallan a continuación y se aplican mediante un riguroso trabajo de campo en múltiples lugares, investigación-acción participativa y análisis jurídico-ético crítico:

Tabla 2. Objetivos biológicos y estrategias de implementación

ODS pertinente	Objetivo	Método de implementación
ODS 3: Salud y bienestar	Llevar a cabo una observación participativa sostenida en entornos clínicos, jurídicos y políticos, interactuando directamente con profesionales, usuarios, familias y responsables de la toma de decisiones para coproducir conocimientos relevantes sin causar daños.	Trabajo de campo en múltiples lugares de España, Indonesia y Suecia mediante inmersión etnográfica, entrevistas informales y coanálisis protegido con personas afectadas y profesionales interesados.
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	Examinar críticamente los fundamentos culturales, científicos y jurídicos de las normas psicofarmacológicas actuales, en particular en relación con la medicación excesiva y la marginación de enfoques alternativos.	Revisión histórico-jurídica de la regulación de los medicamentos, análisis comparativo de los protocolos psiquiátricos nacionales y entrevistas con académicos críticos de la psiquiatría y médicos en ejercicio.

Esta tabla resume los objetivos y los enfoques metodológicos relacionados con las dimensiones biológicas de la salud, centrándose en el trabajo de campo empírico y el examen crítico de las normas farmacológicas. Estos componentes se alinean con los ODS 3 y 9 y apoyan la transformación basada en la evidencia de la práctica clínica y la regulación.

La dimensión biológica de esta tesis, tabla 1, integra una exploración del pleno potencial de las mejores prácticas actuales, un enfoque humano de la relación, la confianza y las decisiones y responsabilidades compartidas, y las nuevas tecnologías para apoyar la precisión, la rendición de cuentas y la mejora continua en la práctica clínica. La tesis sostiene que la salud debe entenderse no como la gestión de síntomas aislados, sino como el resultado de interacciones dinámicas entre la integridad biológica, las condiciones contextuales y la responsabilidad institucional. En España, la dependencia excesiva y persistente de los protocolos farmacológicos ha afianzado un modelo médico que descuida tanto los daños sistémicos como la posibilidad de recuperación. Este trabajo desafía esa inercia estructural mediante la introducción de marcos de datos abiertos, la monitorización basada en señales biológicas y sistemas de documentación interoperables que permiten a los pacientes y a los médicos evaluar conjuntamente los efectos del tratamiento en tiempo real. Al incorporar bucles de retroalimentación positiva en los ciclos de investigación-acción participativa y adoptar estándares de ciencia abierta, el modelo de síntesis reorienta los sistemas de salud hacia el aprendizaje adaptativo y la responsabilidad biomédica. Se proponen garantías legales y mecanismos reguladores para asegurar la transparencia, proteger los datos de los pacientes y prevenir el uso indebido de categorías diagnósticas e intervenciones terapéuticas que, de otro modo, podrían reforzar la cronicidad y la exclusión sistémica.

Tabla 3. Objetivos psicológicos y estrategias de implementación

ODS pertinente	Objetivo	Método de implementación
ODS 4: Educación de calidad	Documentar los fallos en la responsabilidad clínica, los mecanismos de daño y las omisiones sistémicas, centrándose en cómo las prácticas basadas en la retroalimentación pueden mejorar las trayectorias de recuperación y la alianza terapéutica.	Revisión de casos de negligencia profesional, recopilación de informes de experiencias vividas y evaluación de las medidas de resultados en las relaciones terapéuticas.
ODS 5 – Igualdad de género	Rastrear cómo los procesos de diagnóstico pueden contribuir a la eliminación de la identidad y la privación de derechos legales, y proponer salvaguardias que protejan la continuidad de la personalidad, la condición jurídica y la integridad relacional.	Análisis de las trayectorias diagnósticas en función del género, documentación legal de las incapacitaciones y mapeo de la violencia institucional basado en testimonios.

Esta tabla presenta los objetivos relacionados con las dimensiones psicológicas de la salud y la atención, abordando la responsabilidad clínica, la integridad diagnóstica y los daños basados en el género. Las metodologías integran la experiencia vivida y el análisis estructural, contribuyendo al ODS 4 y al ODS 5.

A nivel psicológico, tabla 2, las nuevas tecnologías se movilizan no para la vigilancia o la estandarización, sino para restaurar la agencia, la memoria y la personalidad dentro de los procesos terapéuticos. Esta tesis defiende la centralidad de la narrativa, la autodeterminación y la restauración cognitiva como pilares fundamentales de la curación. La antítesis a la que se opone es una cultura clínica que con demasiada frecuencia ignora la complejidad subjetiva, impone diagnósticos y despoja al individuo de su poder interpretativo. Para contrarrestar esto, la investigación utiliza herramientas de narración digital, plataformas reflexivas para la evaluación de la alianza terapéutica y sistemas de apoyo a la toma de decisiones alineados con marcos basados en los derechos y en el trauma. Se incorporan bucles de retroalimentación en la propia estructura de la atención, lo que permite una recalibración periódica y un aprendizaje centrado en la persona. Estos sistemas están diseñados no solo para la atención individual, sino también para el cambio estructural: la participación de la sociedad civil, la interpretación de los datos por parte de los pacientes y la formación continua de los profesionales se integran como funciones básicas. El análisis jurídico identifica además las lagunas procedimentales y propone garantías exigibles para proteger contra el borrado de la identidad y el daño epistémico, reafirmando el derecho a evolucionar más allá de las etiquetas y a recuperarse plenamente (Tomé, 2014).

A nivel social, en la tabla 6, la tesis avanza en una síntesis en la que la reforma institucional se sustenta en la coordinación en tiempo real, la participación ciudadana y la transparencia total de los datos. A través de la iniciativa BEACON One Health Education de la UE, la investigación apoya una arquitectura para la integración de sistemas que permite la corrección estructural continua y la aplicabilidad legal. Las infraestructuras digitales participativas permiten la aportación a varios niveles de familias, profesionales, usuarios y sociedad civil, creando mecanismos escalables para identificar prácticas nocivas, destacar los mejores modelos y garantizar la coherencia de las políticas. La ciencia abierta no es un complemento, sino un principio fundamental: todos los datos se anonimizan, se cifran y se hacen accesibles para la supervisión democrática, con límites claros para evitar la captura o la reapropiación institucional. Los mecanismos de retroalimentación se calibran para hacer un seguimiento no solo de los resultados sanitarios, sino también del comportamiento institucional, cerrando las brechas en la aplicación de la ley y reduciendo la impunidad. El modelo rechaza la hipótesis de la cronicidad como resultado inevitable e insiste, en cambio, en una ética progresista

basada en la posibilidad, la resiliencia y la reparación estructural. En esta visión, la salud no es un estado estático ni un déficit gestionado, sino una capacidad relacional, social y dinámica que debe protegerse y renovarse continuamente (Baum et al., 2006).

Cuadro 4. Objetivos sociales y estrategias de implementación

ODS pertinente	Objetivo	Método de implementación
ODS 10: Reducir las desigualdades	Recopilar y analizar testimonios y prácticas de pacientes, familiares, médicos, investigadores y funcionarios públicos, documentando tanto los retos existentes como los modelos emergentes de atención respetuosa y eficaz.	Recopilación de datos narrativos, encuestas anónimas, análisis de casos jurídicos y observación de los procesos de toma de decisiones en entornos institucionales.
ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas	Identificar las condiciones que permiten la implementación de una gestión autónoma y colaborativa de la medicación, destacando las tensiones entre las normas institucionales y la experiencia vivida.	Documentación de prácticas piloto, talleres con las partes interesadas y seguimiento sobre el terreno de la negociación entre pacientes y profesionales en contextos psiquiátricos.
ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos	Mapear los bucles de retroalimentación a nivel individual, institucional y normativo, identificando puntos de influencia específicos para un cambio positivo en las políticas y la gobernanza clínica.	Mapeo de sistemas mediante modelos participativos, entrevistas con las partes interesadas y análisis de las interdependencias entre las políticas internacionales y nacionales.
ODS 1: Fin de la pobreza	Proporcionar recomendaciones basadas en la experiencia y herramientas metodológicas para la implementación de una atención de salud mental dinámica, centrada en la persona y respetuosa de los derechos, en la que la reflexión continua y el aprendizaje del sistema apoyen la recuperación a largo plazo y la inclusión social.	Desarrollo de protocolos de atención adaptables, traducción de los resultados de la investigación en módulos de formación clínica y resúmenes de políticas compartidos con redes internacionales, incluida EU BEACON.

Esta tabla identifica los objetivos que se centran en los determinantes sociales e institucionales de la salud mental, con especial atención a las desigualdades, las protecciones legales, la gobernanza colaborativa y la inclusión. Estos objetivos se operacionalizan en consonancia con los ODS 1, 10, 16 y 17.

Esta tesis defiende una tesis que tiene una base científica y es éticamente imperativa: que la recuperación de la salud mental no solo es posible, sino que debe ser facilitada estructuralmente, apoyada institucionalmente y protegida epistemológicamente. Frente a sistemas arraigados que perpetúan la coacción, la cronicidad y la injusticia epistémica bajo el pretexto de la atención, la investigación ofrece una síntesis multidimensional basada en las mejores pruebas disponibles y en las realidades vividas por las personas más afectadas. Al integrar la neurociencia traslacional, los modelos dialógicos y de desarrollo, las garantías jurídicas y las tecnologías participativas, la tesis articula un marco coherente y viable para la transformación de todo el sistema. Su aplicación a través de la acción BEACON One Health Education de la UE, fundada por el investigador durante el trabajo de campo de investigación-acción participativa de esta tesis, ejemplifica cómo la investigación puede informar la práctica y las políticas sin concesiones, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso democrático a todos los niveles. En este modelo, la salud no es una abstracción administrativa, sino un logro dinámico y relacional sostenido por la integridad de los procedimientos, la inversión en educación y el compromiso compartido con la dignidad humana. La

investigación no se limita a criticar los sistemas existentes, sino que pone en práctica su reconfiguración, afirmando que la recuperación no debe ser la excepción, sino la base ética y estructural desde la que debe partir toda la atención psiquiátrica (Ochocka et al., 2002; Speers y Lathlean, 2015).

1.1. Breve contexto histórico-estructural: atención, coacción y gobernanza en España

La gestión del malestar mental en la Península Ibérica ha funcionado históricamente como un aparato de regulación normativa, entrelazado con regímenes más amplios de control religioso, político y social. Desde finales de la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna, la desviación de los órdenes morales y epistémicos establecidos no solo se toleraba o interpretaba, sino que se reprimía activamente mediante mecanismos institucionales que combinaban el error espiritual, la disonancia cognitiva y la irregularidad conductual. Las tradiciones cristianas e islámicas primitivas, aunque distintas en su marco teológico, contribuyeron a una moralización del sufrimiento en la que la angustia se interpretaba como un signo de castigo divino o como una ruptura de la integridad espiritual. Las respuestas institucionales se estructuraron en consecuencia. Los sistemas monásticos, caritativos y, más tarde, inquisitoriales, emplearon rituales de purificación, oración, ayuno, confinamiento y exorcismo, a menudo sin distinguir entre fenómenos psicológicos, somáticos y morales. El individuo en angustia no era tratado como portador de una experiencia epistemológicamente válida, sino como un síntoma de desorden dentro del orden social o cosmológico. Esta dinámica sentó las bases de un modo de atención que funcionaba menos a través del reconocimiento terapéutico que a través de la contención sacrificial, en la que se borraba sistemáticamente la frontera entre la cura y la exclusión (Van Bilsen, 2016; Asad et al., 2024; Alotaibi, 2025).

En el siglo XVIII, el auge del racionalismo ilustrado y el empirismo biomédico marcó un cambio parcial en los marcos explicativos. Sin embargo, la consolidación del conocimiento psiquiátrico como campo institucional no dismanteló la arquitectura punitiva de los sistemas anteriores, sino que la rearticuló a través de clasificaciones secularizadas y la autoridad clínica. La aparición de asilos en toda Europa, incluida España, institucionalizó esta transición. Enmarcadas en la ideología del tratamiento moral, estas instalaciones combinaban la retórica terapéutica con un diseño espacial disciplinario, reforzando la separación entre los llamados cuerdos y los locos. En el contexto español, la provincialización de los hospitales psiquiátricos afianzó un modelo custodial en el que convergían prerrogativas legales, familiares y profesionales para autorizar el internamiento prolongado. Las categorías diagnósticas carecían de estandarización y se empleaban con frecuencia para justificar la exclusión social, a menudo con el pretexto de gestionar el riesgo o la incapacidad. El tratamiento no estaba orientado a la comprensión o la recuperación, sino a la sumisión, la vigilancia y la restricción farmacológica. La continuidad arquitectónica con las instituciones religiosas anteriores se acompañaba de una lógica administrativa que priorizaba el orden sobre el cuidado y el cumplimiento sobre la cura. La función estructural de la psiquiatría replicaba así los antiguos modelos teológicos de contención, aunque ahora bajo la legitimación de la modernidad científica (Locke, 1690/1975; Battie, 1751/1975; Tuke, 1796/1975; Pinel y Esquirol, 1838/1994).

A lo largo del siglo XIX, la psiquiatría española experimentó una consolidación profesional, inspirándose en los sistemas nosológicos franceses y alemanes para reforzar la autoridad de la mirada clínica. Las taxonomías diagnósticas como la melancolía, la manía y la locura moral se integraron en el discurso médico-legal y sirvieron de instrumentos para gestionar la desviación tanto en la esfera pública como en la privada. Estas clasificaciones no surgieron del diálogo con los afectados, sino de una epistemología de la experiencia que situaba el poder de definir la patología en el observador profesional. Este proceso estuvo profundamente marcado por el género. La patologización de la agencia femenina a través de categorías como la histeria sirvió para institucionalizar el control patriarcal, mientras que el confinamiento desproporcionado de las mujeres por comportamientos considerados transgresores, ya fueran sexuales, emocionales o espirituales, reveló la complicidad de la psiquiatría en la imposición de la feminidad normativa. Las instituciones psiquiátricas se convirtieron así en espacios no de curación, sino de triaje biopolítico, donde las líneas entre enfermedad, ilegitimidad y disconformidad se derrumbaron bajo la racionalidad médica. En esta configuración, la atención no era emancipadora, sino reguladora, y la recuperación quedaba subordinada a los intereses institucionales de contención, control y reproducción social (Rodríguez-Morini, 2002).

A principios del siglo XX, la psiquiatría española se vio cada vez más influida por doctrinas eugenistas y nacionalistas que equiparaban la salud pública con la higiene moral. Durante las décadas de 1920 y 1930, las políticas institucionales adoptaron marcos segregacionistas y orientados a la esterilización con el objetivo de excluir a las personas consideradas degeneradas. Estas tendencias se intensificaron bajo el régimen franquista, en el que las instituciones psiquiátricas se convirtieron en parte integrante del aparato de represión estatal. En lugar de ser espacios de atención clínica, funcionaban como instrumentos de control político y social. Quienes se apartaban de los ideales nacional-católicos, ya fuera por disidencia política, orientación sexual o respuestas relacionadas con traumas, eran sometidos a hospitalizaciones coercitivas, tratamientos invasivos y confinamiento indefinido. Los diagnósticos psiquiátricos funcionaban como herramientas para deslegitimar las identidades no conformes, enmarcando el malestar como patología y la disidencia como enfermedad. Las prácticas clínicas se fusionaron con la lógica legal autoritaria, eliminando las garantías procesales. Los historiales médicos eran inaccesibles, las apelaciones inviables y los tratamientos estaban diseñados para garantizar la sumisión en lugar de la curación. Esta convergencia estableció un legado de impunidad médica y opacidad epistémica que sigue influyendo en las normas institucionales de la España contemporánea (Espinosa y Comelles, 1966; Tusell, 2010; Alonso-Tejada y López-Morales, 2015).

Tras la transición democrática, las reformas legislativas de los años ochenta y noventa tuvieron como objetivo sustituir el internamiento institucional por la atención comunitaria y defender los derechos humanos en el tratamiento de la salud mental. Sin embargo, la aplicación siguió siendo parcial y con recursos insuficientes. Se cerraron los manicomios sin establecer alternativas sólidas y muchas funciones psiquiátricas se integraron en los hospitales generales o se delegaron a entidades privadas. El paradigma subyacente de control se mantuvo intacto. Se mantuvieron las jerarquías profesionales, las taxonomías diagnósticas siguieron sin cuestionarse y las prácticas de intervención continuaron dando prioridad a la sedación farmacológica frente al diálogo. La psiquiatría comunitaria, aunque se

apoyaba retóricamente, no logró ofrecer una atención integrada o participativa. Las intervenciones farmacéuticas, en particular los antipsicóticos de acción prolongada, cobraron protagonismo como respuesta de primera línea al incumplimiento, sustituyendo eficazmente la comprensión terapéutica por el control del comportamiento. La adherencia se convirtió en el indicador central del éxito clínico, independientemente de los resultados de los pacientes o del consentimiento informado. Estos avances no fueron impulsados por un consenso basado en la evidencia, sino por la conveniencia institucional de suprimir los síntomas en lugar de realizar cambios estructurales (García Espino y Lara Ladislao, 1998; Pérez-Fernández y Peñaranda-Ortega, 2015; Bobes, Vázquez-Barquero y Salvador-Carulla, 2010).

En el siglo XXI, la consolidación de las medidas de austeridad, el cabildeo de la industria y la autoconservación profesional afianzaron aún más la coacción farmacológica como práctica psiquiátrica normativa. El tratamiento involuntario se autorizó cada vez más a través de procesos judiciales acelerados con un escrutinio mínimo. El umbral para declarar la incapacidad siguió siendo bajo, lo que permitió la erosión sistemática de la capacidad jurídica de las personas en situación de angustia. Las intervenciones psiquiátricas se enmarcaron como protectoras, pero a menudo funcionaron para suprimir las experiencias disidentes en lugar de abordar las causas subyacentes. El lenguaje de los derechos se mantuvo en las políticas, pero su aplicación práctica se vio socavada por la confusión entre el incumplimiento y la patología. Los familiares, que se enfrentaban a un apoyo inadecuado y estaban mal informados sobre las alternativas, solían aceptar los protocolos coercitivos. Las respuestas institucionales privilegiaron la sedación frente al compromiso sostenido. Esta continuidad revela una lógica carcelaria persistente en la psiquiatría española, reformulada pero no desmantelada. La desconfianza hacia la capacidad de acción de los usuarios, la marginación de la comprensión narrativa y la resistencia sistémica al reparto del poder confirman que la farmacología coercitiva no es una inevitabilidad científica, sino un legado cultural y político que exige una reparación estructural (Ortiz-Gómez, 2002; Portilla, 2006).

Los enfoques más adecuados se consideraban y se enmarcaban como lujos o experimentos ideológicos, en lugar de respuestas científicamente fundamentadas al sufrimiento. El lenguaje de los derechos se mantuvo en los documentos oficiales, pero se vació de su fuerza práctica. A los pacientes se les negó una participación significativa en las decisiones sobre su atención, y la negativa se interpretó no como una declaración, sino como un síntoma. Los familiares, bajo presión y desinformación, a menudo apoyaban las medidas coercitivas, esperando la estabilidad a cualquier precio. Las instituciones respondían con sedación, no con apoyo. El paso del manicomio a la comunidad no desmanteló la función carcelaria de la psiquiatría. La redistribuyó en nuevos espacios y vocabularios.

Estas trayectorias no pueden explicarse como progresos neutros de la ciencia médica. Están profundamente arraigadas en tradiciones culturales de sumisión, obediencia y exclusión. La larga historia de España de poder centralizado, moralismo religioso y violencia de género configuró la acogida y la función de las intervenciones psiquiátricas. Los considerados locos nunca fueron ciudadanos de pleno derecho. Eran sujetos de atención solo en la medida en que la atención imponía el orden social. La curación rara vez era el objetivo. El verdadero objetivo era la contención, la pacificación y la corrección moral. Esta historia explica la persistencia de la farmacología coercitiva

en la España actual, a pesar de las recomendaciones internacionales que abogan por la toma de decisiones compartida y las prácticas orientadas a la recuperación. También revela la reticencia institucional a implementar alternativas que requieren compartir el poder, humildad narrativa e inversión estructural.

Por lo tanto, la transición del confinamiento a la medicación excesiva no debe considerarse una reforma, sino una adaptación. La gobernanza psiquiátrica en España ha sustituido las rejas visibles del manicomio por las cadenas invisibles del control químico. Las personas ya no están encerradas, pero siguen cautivas de instituciones que controlan su cumplimiento y dictan su régimen farmacológico. La resistencia se recodifica como enfermedad, la comprensión como sumisión y el mutismo como progreso. Los guiones culturales que en su día justificaron el exorcismo religioso, el internamiento moral y la segregación fascista ahora informan el discurso clínico, revestido de un lenguaje basado en la evidencia, pero fundamentado en la lógica disciplinaria. Como resultado, la atención de la salud mental en España sigue funcionando menos como un sistema de curación y más como un régimen de normalización gestionada. Esta trayectoria no se limita a quienes cumplen los criterios clínicos. Históricamente, el aparato psiquiátrico coercitivo español se ha dirigido a los pobres, los racializados, los que no se ajustan a los estereotipos de género y los socialmente indeseables. En los siglos XIX y XX, los asilos y los hospitales psiquiátricos sirvieron de contenedores para las poblaciones excedentes. Los indigentes, los vagabundos, las madres solteras, las esposas rebeldes, los enemigos políticos y los migrantes fueron expulsados de la economía productiva y se les negó la plena inclusión cívica. El confinamiento se enmarcó como un cuidado, pero funcionó como una exclusión. El diagnóstico se convirtió en una herramienta de conveniencia administrativa. La pobreza se patologizó. La desviación se medicalizó. La responsabilidad del Estado se transfirió al cuerpo del sujeto (Wallace Mandell, 1962/2025; Rosenhan, 1973; Foucault, 1961/2006).

Esta persecución se intensificó bajo el régimen franquista, especialmente contra quienes habían perdido la guerra. Se movilizó el aparato psiquiátrico para eliminar la disidencia ideológica y las identidades desviadas. Se patologizó la homosexualidad, se castigó la no conformidad de género y se silenció la resistencia política mediante certificados médicos de incapacidad. Quienes no podían integrarse en el proyecto católico nacional no solo eran criminalizados, sino también psiquiatrizados. Se les apartaba de la visibilidad, se les sometía a tratamientos forzados o, simplemente, desaparecían. Esto equivalía a una forma lenta de genocidio biopolítico, una eliminación impulsada por el Estado de los indeseables mediante el confinamiento, la pacificación química y la aniquilación epistémica. La psiquiatría no era una disciplina curativa, sino una tecnología de control. Los residuos de esta función persisten hoy en día. El sistema de salud mental español sigue afectando de manera desproporcionada a los marginados. Los migrantes, los jóvenes racializados, los romaníes, las personas transgénero y los supervivientes de abusos están sobrerrepresentados en las intervenciones coercitivas y infrarrepresentados en la atención participativa. La cobertura sanitaria universal coexiste con la exclusión institucional. El lenguaje puede haberse suavizado, pero la lógica sigue siendo la misma. La psiquiatría ya no habla de pecado o degeneración, sino de adherencia y comprensión. Sin embargo, el resultado es el mismo: la producción de orden mediante la contención de la diferencia (Campos y Novella, 2017; Huertas, 2017).

Estos mecanismos históricos de silenciamiento se han perfeccionado, pero no se han desmantelado. Están arraigados en las leyes, en las rutinas institucionales y en el razonamiento clínico. Se manifiestan en la prescripción excesiva de psicofármacos, en el uso rutinario de restricciones físicas y químicas, y en la burocratización del sufrimiento, que se reduce a perfiles de riesgo. El Estado ya no necesita asilos para alcanzar sus objetivos. Ha encontrado en la coacción ambulatoria, la adherencia farmacológica forzada y la discrecionalidad judicial las herramientas para lograr los mismos fines mediante medios más difusos e insidiosos. La historia de la psiquiatría en España no es, por tanto, una historia de progreso lineal. Es una historia de continuidad a través de la transformación. Lo que ha cambiado son las formas, no las funciones. De la herejía medieval al incumplimiento moderno, del confinamiento a la inyección, del moralismo manifiesto a la racionalidad administrativa, el hilo conductor permanece. El objetivo siempre ha sido suprimir lo que no se puede asimilar. Los indigentes, las locas, los transgresores y los migrantes convergen en el imaginario institucional como cuerpos que hay que gestionar en aras del orden. En nombre de la salud pública, la psiquiatría ha ejercido la violencia privada. En nombre del cuidado, ha administrado la exclusión (Brydán, 2016).

Este es el contexto desde el que examinar la realidad actual del tratamiento psiquiátrico forzado en España. La coacción no es una aberración, sino una característica estructural del sistema. Está arraigada en su genealogía, sostenida por sus instituciones y reproducida a través de sus discursos. A continuación se presenta un análisis de este panorama contemporáneo, sus marcos legales, argumentos clínicos y lugares de resistencia. Este análisis parte de una premisa clara. La coacción constituye un daño. La carga de la justificación no recae en quienes se resisten a ella, sino en quienes la imponen. En la siguiente sección se pregunta no solo qué se hace, sino por qué se permite y cómo perdura.

1.2. Marco actual: intervenciones psiquiátricas forzadas y responsabilidad institucional

El tratamiento psiquiátrico forzado, en forma de internamiento involuntario en régimen ambulatorio y medicación obligatoria, sigue siendo promovido en España por determinados actores clínicos y jurídicos, a pesar de que existen numerosas pruebas que demuestran su limitada eficacia y su importante coste ético. En las últimas dos décadas se han presentado repetidamente propuestas para legislar el tratamiento ambulatorio involuntario, que han sido sistemáticamente rechazadas por los órganos legislativos, las asociaciones profesionales y las organizaciones de usuarios. Los argumentos a favor de estas medidas coercitivas se basan en afirmaciones especulativas de que el cumplimiento forzoso de los regímenes médicos evitará los reingresos hospitalarios, reducirá los comportamientos peligrosos y aliviará las presiones sistémicas. Estas afirmaciones siguen sin estar respaldadas por investigaciones empíricas y carecen de coherencia teórica cuando se examinan en el marco de la práctica clínica basada en los derechos y la medicina basada en la evidencia.

La revisión más exhaustiva realizada hasta la fecha, llevada a cabo utilizando la metodología Cochrane, no encontró ningún beneficio consistente del tratamiento ambulatorio involuntario frente a la atención estándar. Los indicadores clave de resultados, entre los que se incluyen las tasas de reingreso hospitalario, el funcionamiento social, el estado mental, la calidad de vida y la satisfacción con la atención, no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las personas sometidas

a órdenes coercitivas de tratamiento ambulatorio y las que recibieron tratamiento voluntario. Los cálculos del número de personas que deben tratarse revelan implicaciones éticamente insostenibles. Por ejemplo, para evitar un solo reingreso hospitalario puede ser necesario imponer un tratamiento coercitivo a más de ochenta personas. Esta magnitud de la intervención se consideraría desproporcionada en cualquier otro ámbito de la asistencia sanitaria o de las políticas públicas. Por lo tanto, la defensa continuada de estas medidas no puede basarse en pruebas científicas, sino que refleja prioridades institucionales que favorecen el control y la gestión del riesgo frente a la colaboración y la autonomía del paciente (Sailas y Fenton, 2000).

En España, el resurgimiento de iniciativas legislativas para aplicar el tratamiento ambulatorio involuntario se debe, en parte, a las deficiencias sistémicas de la infraestructura comunitaria de salud mental. Los responsables políticos y algunos representantes clínicos argumentan que la coacción es necesaria ante la ausencia de una atención relacional sostenida y la fragmentación de los sistemas de apoyo social y sanitario. Este planteamiento desplaza la responsabilidad del fracaso estructural al individuo y sustituye el desarrollo de servicios integrales y de apoyo por el cumplimiento forzoso. Las justificaciones jurídicas suelen basarse en interpretaciones amplias de la incapacidad y el riesgo, invocando con frecuencia conceptos como la falta de conciencia o la negativa al tratamiento sin definiciones operativas. Estas categorías son problemáticas tanto desde el punto de vista clínico como jurídico y son propensas a un uso subjetivo indebido. El intento de replantear la coacción como medida preventiva socava, paradójicamente, tanto los resultados clínicos como la relación terapéutica de la que depende la recuperación (Cañete-Nicolás et al., 2012; Gías Gil, 2013).

Por el contrario, la toma de decisiones compartida se ha asociado sistemáticamente con un mayor compromiso clínico, mejores resultados funcionales y menores tasas de recaída. Se trata de un modelo que afirma la capacidad del individuo para participar en las decisiones sobre su atención, incluso en períodos de angustia psicológica. La presencia de una alianza terapéutica colaborativa es el predictor más sólido de resultados positivos a largo plazo en todas las afecciones de salud mental. Las medidas involuntarias tienden a romper esta alianza, inducir desconfianza y reforzar la evitación y la desvinculación. La experiencia de ser sometido a un tratamiento forzoso se asocia con traumas psicológicos, ira persistente y abandono de los sistemas de apoyo. Estas reacciones no son anecdóticas ni incidentales, sino que constituyen pruebas de un daño sistémico que dificulta la búsqueda de ayuda en el futuro y compromete la adherencia al tratamiento (Pozón, 2012; Villagrán et al., 2015; Serrano-Miguel, 2022).

A pesar de la aplicación continuada de la coacción en la práctica y el discurso psiquiátricos, existe un consenso internacional emergente de que la recuperación sostenible requiere la implementación de intervenciones no coercitivas. Estas incluyen la atención intensiva en el hogar, el tratamiento comunitario asertivo y flexible, los servicios de crisis con apoyo de pares y los enfoques psicoterapéuticos adaptados a la cultura. Cada uno de estos modelos se basa en la participación voluntaria y reconoce la complejidad del sufrimiento mental como algo relacional, contextual y, a menudo, relacionado con el trauma. Su aplicación en diversos entornos ha demostrado beneficios cuantificables, como la reducción de las hospitalizaciones, el menor uso de los servicios de urgencias, la mejora del funcionamiento social y la mejora de la calidad de vida. Estas intervenciones no solo son éticamente preferibles, sino que también son rentables si se comparan con los costes financieros y

humanos acumulados asociados a los ingresos repetidos, el tratamiento farmacológico crónico y la infraestructura judicial necesaria para aplicar las medidas coercitivas.

Alejarse del tratamiento forzoso no es solo un imperativo normativo, sino también una estrategia práctica para construir sistemas de salud mental eficaces. La prevención de las recaídas y la reducción de nuevas crisis psiquiátricas se logran mejor abordando los determinantes sociales de la salud mental y garantizando la continuidad de la atención. Los programas que incluyen viviendas con apoyo, rehabilitación basada en la comunidad y toma de decisiones participativa han demostrado su capacidad para fomentar la autonomía y reducir la dependencia de la atención institucional. La inversión en estas alternativas requiere no solo una reasignación de recursos, sino también un cambio en la formación clínica hacia las competencias relacionales, la comprensión narrativa y la humildad cultural. Por el contrario, la dependencia de la coacción refleja un fracaso de la imaginación sistémica y una resistencia al cambio estructural. Refuerza un ciclo en el que el deterioro agudo se utiliza para justificar intervenciones punitivas en lugar de interpretarse como una señal de negligencia sistémica (Serrano-Miguel, 2020; Parrabera-García et al., 2023).

Tabla 5. Prácticas perjudiciales, causas estructurales e implicaciones para la reforma

Práctica perjudicial	Causa estructural	Base empírica	Implicaciones para la reforma
Administración involuntaria de medicamentos sin el debido proceso	Falta de garantías, deferencia hacia la autoridad clínica	Trabajo de campo, testimonios de usuarios, datos nacionales	Aplicación de marcos de apoyo a la toma de decisiones
Polifarmacia crónica	Ausencia de protocolos de desprescripción, sesgo farmacocéntrico	Informes de la OMS, literatura clínica	Directrices nacionales de desprescripción, formación profesional
Diagnóstico excesivo	Jerarquía epistémica, reduccionismo basado en el DSM	Testimonios, registros legales, análisis etnográficos	Revisión de los criterios diagnósticos, modelos narrativos y participativos
Incapacitación legal de los usuarios	Discriminación estructural por motivos de discapacidad, paternalismo jurídico	CDPD, Código Civil español, jurisprudencia	Reforma legal, implementación de directivas anticipadas
Hospitalización coercitiva	Aversión institucional al riesgo, ausencia de recursos comunitarios	Historiales hospitalarios, informes de expertos	Redirección de fondos a servicios comunitarios
Evaluaciones y decisiones sesgadas por motivos de género	Paradigmas diagnósticos sexistas, normatividad androcéntrica	Psiquiatría feminista, datos de campo	Protocolos sensibles al género, formación obligatoria sobre sesgos
Ignorar las quejas o los daños denunciados	Negación institucional, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas	Quejas, informes del defensor del pueblo, entrevistas sobre el terreno	Protección de los denunciantes, auditorías externas

Resumen de prácticas coercitivas, negligentes o éticamente comprometidas, fuentes probatorias e implicaciones para futuras investigaciones y reformas.

El contexto español ilustra una tensión persistente entre las garantías constitucionales de libertad y la lógica custodial arraigada en la práctica psiquiátrica. El marco jurídico actual ya permite la hospitalización involuntaria en condiciones estrictas y prevé la sustitución de la capacidad de decisión en casos de incapacidad demostrable. Los repetidos intentos de introducir nuevas formas de coacción ambulatoria no responden a vacíos legales, sino que tienen por objeto extender los mecanismos de control a la vida cotidiana de las personas más allá del ámbito institucional. Esta ampliación carece de justificación empírica y suscita graves preocupaciones en el marco de las normas internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en repetidas ocasiones que cualquier restricción de la libertad debe ser necesaria, proporcionada y estar sujeta a un control judicial riguroso. En el caso del tratamiento ambulatorio forzoso, estos criterios rara vez se cumplen (SES-PAS, 2020; Francisco Torres-González, 2022; Calcedo-Barba et al., 2024; Pérez-Prieto et al., 2025).

El camino a seguir requiere una transición deliberada y basada en la evidencia hacia sistemas de atención basados en la autonomía, la confianza y la responsabilidad mutua. Esta transición implica no solo una reforma jurídica y política, sino también una transformación epistémica en la forma en que se produce y aplica el conocimiento psiquiátrico. Los paradigmas clínicos deben integrar la experiencia vivida, reconocer las limitaciones de los marcos diagnósticos actuales y abandonar la presunción de incapacidad que sustenta la práctica coercitiva. La educación médica debe dar prioridad al razonamiento ético, la reflexión crítica y el diálogo. Las instituciones deben rendir cuentas por los

daños causados por la coacción y se les debe incentivar para que adopten prácticas que desarrollen la capacidad individual en lugar de imponer la sumisión. Los usuarios de los servicios, las familias y las comunidades deben estar empoderados para participar de manera significativa en el diseño, la implementación y la evaluación de la atención. El objetivo no es simplemente reducir la coacción, sino crear las condiciones para que esta se vuelva obsoleta. Esto se puede lograr mediante la implementación sistemática de modelos de atención que se centren en la dignidad humana, la continuidad relacional y el derecho a la autodeterminación en la salud mental.

Cuadro 6. Fallos sistémicos y mecanismos de daño institucional

Fallo sistémico	Mecanismo de daño	Base empírica	Intervención propuesta
Exclusión epistémica	Desprecio de la experiencia vivida, patologización de la disidencia	Marco de poder, amenaza y significado, narrativas de los pacientes	Inclusión del conocimiento empírico en la evaluación clínica
Falta de retroalimentación	Falta de seguimiento de los resultados, no se aprende de los errores	Trabajo de campo, casos de mala praxis, marco QualityRights de la OMS	Sistemas de auditoría participativa, mejora continua de la calidad
Impunidad institucional	Ausencia de sanciones por abuso o negligencia	Informes del Defensor del Pueblo, procedimientos legales	Reforma legal, organismos de supervisión independientes
Inercia política	Desconexión entre las pruebas y las políticas	Revisión bibliográfica, evaluaciones de Horizonte Europa	Integración de las interfaces entre ciencia y política
Gobernanza incapacitante	Toma de decisiones sin la participación de los usuarios	Modelos comparativos (por ejemplo, diálogo abierto)	Participación deliberativa, protocolos de atención democrática
Performatividad de la ética	Comités de ética utilizados como tapadera burocrática	Observaciones de campo, análisis de casos	Estructuras de gobernanza ética transparentes y responsables

Sintetiza los fallos subyacentes en la gobernanza, la retroalimentación y la legitimidad que perpetúan las prácticas nocivas en los sistemas psiquiátricos, y esboza las áreas correspondientes de intervención estructural.

La justificación del tratamiento ambulatorio obligatorio en España se ha basado cada vez más en una construcción particular de la cronicidad psiquiátrica, enmarcada como una condición estable y médicamente verificable que requiere un tratamiento farmacológico continuo bajo supervisión profesional. Los argumentos a favor de estas medidas hacen hincapié en la pérdida de discernimiento y la falta de adherencia como indicadores diagnósticos de patología. Estas afirmaciones se basan a menudo en la suposición no contrastada de que las personas diagnosticadas con esquizofrenia o trastorno bipolar recaerán inevitablemente sin mantenimiento farmacológico, y que la negativa al tratamiento es en sí misma una prueba de la enfermedad. La propuesta de imponer la medicación en entornos comunitarios no surge de una superioridad terapéutica demostrada, sino de una lógica institucional orientada a la mitigación del riesgo, la contención de los costes y la gestión de la reputación.

En el discurso clínico, la psicosis se describe a menudo no solo como una alteración de la cognición o del afecto, sino también como una suspensión de la personalidad civil y jurídica. La autonomía se invalida sistemáticamente mediante evaluaciones que equiparan la disidencia con la incapacidad. Una

narrativa recurrente posiciona a ciertas personas como inherentemente incapaces de actuar en su propio interés debido a un supuesto déficit de conciencia de sí mismas. Bajo este paradigma, el tratamiento ambulatorio forzoso se presenta como una alternativa humana y proporcionada a la hospitalización. El lenguaje de la atención sanitaria sirve para ocultar su función disciplinaria. Los instrumentos jurídicos redefinen los objetivos terapéuticos y la medicación se convierte tanto en la intervención como en el requisito previo para la libertad jurídica. España no ha promulgado una ley específica que autorice el tratamiento ambulatorio involuntario. No obstante, las interpretaciones judiciales han permitido la libertad condicional y disposiciones legales provisionales que replican su función. Los defensores suelen invocar precedentes internacionales, como la Ley Kendra de Nueva York o la Ley de Salud Mental de Inglaterra y Gales, para argumentar a favor de la codificación legal de las medidas coercitivas ambulatorias. Entre los supuestos beneficios se incluyen la reducción de las hospitalizaciones, la mejora del cumplimiento del tratamiento y la disminución de la interacción con el sistema de justicia penal. Sin embargo, estos indicadores no reflejan el bienestar subjetivo ni la recuperación personal. Se basan, en cambio, en indicadores institucionales de cumplimiento y contacto, en lugar de en resultados centrados en la persona (Watnik, 2001; Brown et al., 2023).

El valor terapéutico de los antipsicóticos sigue siendo objeto de debate, especialmente en el contexto del uso a largo plazo. Si bien se ha observado una reducción a corto plazo de los síntomas psicóticos agudos, la literatura indica una relación compleja y a menudo inconclusa entre el uso sostenido de medicamentos y las trayectorias de recuperación a largo plazo. Los metaanálisis no han mostrado diferencias consistentes en los resultados funcionales al comparar a las personas sometidas a tratamiento coercitivo con las que reciben atención voluntaria. La creencia generalizada de que la farmacoterapia de mantenimiento previene las recaídas no se ha comprobado adecuadamente en condiciones de elección informada y no coercitiva. El uso de inyectables de acción prolongada sin consentimiento plantea importantes cuestiones éticas. La comodidad procedimental de estas formulaciones oculta la violencia estructural que implica la imposición química de la conformidad conductual. A menudo se recurre a la cronicidad psiquiátrica para anular las preferencias y la capacidad de decisión de los usuarios de los servicios. La cronicidad se suele enmarcar como una inevitabilidad biológica, en lugar de como un constructo mediado socialmente y contingente desde el punto de vista terapéutico. Este encuadre borra el papel bien documentado del trauma, la exclusión social y la traición institucional en la etiología y la perpetuación del malestar psiquiátrico. También excluye la posibilidad de una recuperación significativa sin medicación. En el debate político español, no es raro oír que las familias necesitan instrumentos legales para obligar a sus familiares a aceptar el tratamiento. Sin embargo, la coacción suele socavar la confianza, alejar a los usuarios de los servicios y reproducir ciclos de desvinculación y deterioro. Las afirmaciones de que el tratamiento forzoso favorece la alianza terapéutica son fundamentalmente erróneas. La coacción y la alianza son mutuamente excluyentes (Moncrieff, 2008; Kinderman, 2014; Gøtzsche, 2015).

El escaso número de estudios empíricos citados en defensa del tratamiento ambulatorio involuntario en España adolece de importantes limitaciones metodológicas. Entre ellas figuran el sesgo de selección, la ausencia de aleatorización, la falta de grupos de control adecuados y criterios de resultado vagos o no estandarizados. Estas deficiencias comprometen la validez y la generalización de sus conclusiones. Por el contrario, la creciente bibliografía sobre la toma de decisiones compartida

ofrece pruebas sólidas y replicables de que la planificación colaborativa de la atención mejora el cumplimiento, aumenta la satisfacción y conduce a mejores resultados clínicos y funcionales. Las personas que son escuchadas, respetadas y comprometidas son claramente más propensas a participar de manera significativa en su propia recuperación. La capacidad de tomar decisiones no es fija, sino situacional y relacional, y está determinada por la calidad del entorno terapéutico. El tratamiento ambulatorio coercitivo socava estas condiciones propicias y erosiona la infraestructura relacional de la que depende la recuperación sostenida (Viadel et al., 2006; Portero, 2010; Cañete-Nicolás et al., 2012).

El uso de medicamentos en los marcos ambulatorios involuntarios suele estar determinado por la conveniencia clínica y no por un diálogo terapéutico individualizado. Los regímenes suelen estar estandarizados, con ajustes mínimos basados en la tolerabilidad, los efectos secundarios o la experiencia comunicada por el paciente. La dependencia predominante de los inyectables de acción prolongada refleja un modelo de atención farmacocéntrico y orientado al cumplimiento. Las intervenciones psicológicas y sociales se reconocen nominalmente, pero rara vez se ponen en práctica en los marcos coercitivos. Los propios médicos reconocen que la infraestructura existente es inadecuada para prestar servicios de recuperación integrales y basados en la comunidad. La coacción funciona como un mecanismo compensatorio de la negligencia sistémica. Los argumentos que afirman que el tratamiento forzoso garantiza la estabilidad ignoran la realidad de que estas medidas se aplican con mayor frecuencia en entornos que carecen de alternativas terapéuticas viables (Sheridan Rains et al., 2019).

La recuperación no puede reducirse a la supresión de los síntomas. Implica la reconstitución del significado, la restauración de la agencia y la reconstrucción de los roles sociales. Las prácticas coercitivas aplanan esta complejidad. Patologizan la resistencia y reformulan la disidencia como deterioro clínico. El resultado no es la estabilización, sino el afianzamiento del daño epistémico y relacional. Las personas sometidas a coacción informan sistemáticamente de miedo, humillación y desconfianza duradera en el sistema sanitario. Estas respuestas no son signos de psicopatología, sino reacciones adaptativas a la violencia estructural. Afirmar que la coacción es un cuidado es borrar la experiencia vivida por las personas más afectadas y perpetuar un modelo de psiquiatría basado en la dominación en lugar de en la curación (Eiroa-Orosa y Rowe, 2017; Kalathil, 2018).

Las defensas del tratamiento ambulatorio involuntario suelen apelar a la seguridad pública y la eficiencia administrativa. Sin embargo, estos no son objetivos terapéuticos. Reflejan prioridades institucionales que no se ajustan a los objetivos de recuperación y bienestar individual. El discurso del riesgo es en sí mismo problemático. A menudo está racializado, genderizado y sesgado desde el punto de vista socioeconómico. La presunción de que ciertas personas o grupos son inherentemente peligrosos conduce a una aplicación arbitraria y discriminatoria. En el contexto español, al igual que en otros, las intervenciones coercitivas afectan de manera desproporcionada a las personas sin apoyo familiar, con recursos económicos limitados y procedentes de entornos migrantes o minoritarios. Las vulnerabilidades estructurales se medicalizan y la carga de la adaptación recae sobre los más desfavorecidos (Jacka y Berk, 2012; Kidd et al., 2015a; Walker et al., 2019).

Para garantizar la mejora de estas y todas las deficiencias sistémicas, esta tesis se ha llevado a cabo mediante la participación integrada en redes nacionales e internacionales, incluyendo acciones de investigación formales, entornos clínicos e iniciativas políticas, en línea con un diseño de investigación-acción participativa. Estos entornos colaborativos no eran periféricos, sino que constituían lugares de trabajo de campo integrales, donde el conocimiento se coproducía a través del intercambio iterativo, el análisis reflexivo y la praxis orientada a objetivos. Los colegas y participantes actuaron simultáneamente como informantes clave, interlocutores críticos y co-generadores de datos empíricos, marcos interpretativos e hitos operativos. Este modelo integrado refleja un compromiso con la responsabilidad científica, lo que permite la triangulación de perspectivas y mejora el potencial de transferencia de los resultados. Desde el punto de vista de la antropología médica, este enfoque se ajusta al imperativo ético de contribuir de forma constructiva a los sistemas objeto de estudio, en lugar de mantener una postura observadora distanciada. El compromiso constructivo, anclado en el rigor empírico y la capacidad de respuesta situada, no es meramente una elección metodológica, como se muestra en el capítulo 2, sino una obligación disciplinaria cuando se investigan estructuras sanitarias que producen activamente sufrimiento o protección. Esta orientación garantiza que el trabajo no solo documente la disfunción sistémica, sino que contribuya a su resolución, en fidelidad tanto al método científico como a los principios de la atención relacional (Schneider, 2012; Rose, 2018).

En esta tesis, la recuperación se define como el restablecimiento y el mantenimiento sostenido de la regulación fisiológica, la autonomía funcional y la agencia psicosocial, evaluados a través de resultados multidimensionales. Estos incluyen reducciones medibles de la dependencia farmacológica cuando está clínicamente indicada, la normalización de los marcadores neuroendocrinos e inflamatorios, la mejora de la integración cognitivo-afectiva y la capacidad demostrada para participar de manera significativa en roles relacionales, educativos y vocacionales. Las mejores prácticas se definen como aquellos procedimientos clínicos e institucionales que, en todas las poblaciones y contextos, apoyan estos resultados con efectos adversos mínimos y la máxima participación de los usuarios. Dichas prácticas se caracterizan por el consentimiento informado, la sintonía contextual y la responsabilidad dinámica, lo que permite calibrar la atención en respuesta a las condiciones individuales y sistémicas en evolución. La recuperación se conceptualiza no como un estado fijo, sino como un logro dinámico y procesual que depende de la coherencia ecológica, la capacidad de respuesta institucional y la ausencia de violencia epistémica y estructural. En este marco, la coacción no se clasifica como terapéutica, sino como un mecanismo de control y gestión del riesgo presunto, cuyo uso continuado en entornos clínicos, incluso en formas punitivas o extrajudiciales, socava tanto la legitimidad como la eficacia de la atención psiquiátrica. Su presencia indica un fracaso sistémico a la hora de establecer entornos de seguridad relacional y atención ética, y su erradicación sigue siendo un imperativo médico, jurídico y científico (Mezzina et al., 2006b).

1.3 La sobremedicación y el farmacocentrismo en la sanidad y la psiquiatría españolas

El uso excesivo de psicofármacos en la sanidad española no es atribuible a errores clínicos aislados o a negligencia profesional, sino que refleja la aplicación sistemática de un modelo médico en el que el

tratamiento farmacológico ocupa una posición dominante y legitimada estructuralmente. La persistencia de la medicación excesiva revela una configuración institucional multifacética, moldeada por los hábitos profesionales, los marcos legislativos, los planes de estudios, la influencia industrial y las normas culturales de la atención sanitaria. España se encuentra entre los países europeos con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos, con benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antipsicóticos atípicos prescritos en proporciones que superan sistemáticamente las recomendaciones de las guías clínicas. Este uso excesivo afecta a diversas poblaciones de pacientes, a menudo sin una justificación diagnóstica rigurosa, sin una evaluación informada de los riesgos a largo plazo y en contextos en los que no se examinan los orígenes biopsicosociales del malestar. La difusión de las respuestas farmacológicas más allá de la psiquiatría especializada, especialmente a través de los médicos generales y los servicios de urgencias, ilustra el arraigo institucional del farmacocentrismo como reacción por defecto ante los síntomas psicológicos y conductuales. Esta orientación clínica, sostenida por la conveniencia económica y la presión del tiempo, da lugar a un estrechamiento patológico de las opciones de tratamiento, en el que la supresión de los síntomas sustituye al diagnóstico, el seguimiento y la alianza terapéutica (Cohen, 1975; Jiménez, 2005).

Las prescripciones de psicotrópicos se inician y mantienen con frecuencia en respuesta a factores estresantes de la vida, pérdidas interpersonales o dificultades sociales crónicas, incluso en ausencia de trastornos psiquiátricos graves. Se recurren a soluciones farmacológicas en respuesta a la fatiga, el insomnio, la ansiedad, las quejas somáticas y los conflictos familiares, sin un diagnóstico diferencial adecuado, sin consultas multidisciplinarias y sin ofrecer intervenciones no farmacológicas. Este patrón da lugar a la administración crónica de medicamentos inicialmente destinados a un uso a corto plazo o en situaciones de crisis. Las benzodiazepinas, por ejemplo, que fueron aprobadas para el tratamiento transitorio de la ansiedad aguda y los trastornos del sueño, se mantienen ampliamente durante períodos que se prolongan varios años. España se ha situado sistemáticamente entre los países con mayor consumo de benzodiazepinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una prevalencia que supera con creces la incidencia epidemiológica de los trastornos relacionados con la ansiedad que requieren tratamiento farmacológico. Las consecuencias de este uso indebido incluyen el desarrollo de tolerancia, dependencia, síndromes de abstinencia, deterioro cognitivo y deterioro funcional. Estos efectos biológicos se ven agravados por la dependencia psicológica, la alteración de la capacidad de acción y el refuerzo de la pasividad y la identidad medicalizada (Cañete-Nicolás et al., 2015; Francisco Torres-González, 2022).

Las recetas emitidas por médicos no especialistas representan la mayor parte del uso de ansiolíticos y antidepresivos en España. Esto refleja una configuración estructural de la asistencia sanitaria que prioriza el rendimiento, la gestionabilidad administrativa y la resolución sintomática por encima de la evaluación centrada en la persona y la continuidad de la atención. Los médicos generales se enfrentan habitualmente a la tarea de gestionar casos complejos de salud mental en menos de diez minutos por consulta, con acceso limitado a redes de derivación, psicoterapia o seguimiento de los casos. El resultado es un sistema en el que se recetan medicamentos como medida provisional ante la falta de tiempo, recursos y vías institucionales para una atención integral. En estos entornos, los medicamentos psicotrópicos se convierten en un instrumento no solo para controlar los síntomas, sino

también para contener la organización. Los pacientes que no mejoran con estos regímenes suelen ser reciclados por los servicios sanitarios con dosis cada vez más altas, diagnósticos adicionales y polifarmacia, sin una revisión sistemática de las hipótesis iniciales ni la exploración de alternativas. Este fenómeno no se puede reducir a la inercia farmacológica, sino que debe entenderse como el correlato funcional de una infraestructura sanitaria fragmentada, con recursos insuficientes y reacia al riesgo.

En los servicios psiquiátricos, el predominio estructural de los enfoques farmacológicos es especialmente pronunciado. Los fármacos antipsicóticos, incluidos los inyectables de acción prolongada, se utilizan cada vez más no solo en los trastornos psicóticos, sino también en la regulación del comportamiento en una amplia gama de diagnósticos no psicóticos, como la discapacidad intelectual, la demencia y el trastorno límite de la personalidad. Estas prescripciones se inician y continúan con frecuencia sin una indicación clínica sólida, sin consentimiento informado documentado y sin una evaluación sistemática de la relación riesgo-beneficio. La administración prolongada de antipsicóticos se asocia con efectos adversos significativos, como síndrome metabólico, síntomas extrapiramidales, sedación, deterioro cognitivo y aumento de la mortalidad. A pesar de estos riesgos bien documentados, la desprescripción sigue siendo poco frecuente y los regímenes farmacológicos a menudo se intensifican en respuesta a problemas de conducta, conflictos institucionales o desacuerdos profesionales, en lugar de mediante una reevaluación clínica. Este patrón se ve reforzado por las deficiencias en la formación, las preocupaciones sobre la responsabilidad y la institucionalización del cumplimiento farmacológico como indicador del éxito terapéutico (Bobes et al., 2012; Guzmán-Parra et al., 2018; Aragonés-Calleja y Sánchez-Martínez, 2023). La cuestión de la medicación excesiva también debe entenderse en relación con la ausencia de intervenciones psicosociales integradas. Los servicios comunitarios de salud mental en España están distribuidos de forma desigual, cuentan con recursos insuficientes y están orientados hacia la estabilización farmacológica en lugar de hacia la recuperación o la reintegración social. La psicoterapia, la terapia ocupacional, el apoyo entre pares y el asesoramiento familiar sufren una financiación crónicamente insuficiente, se aplican de forma esporádica y, en muchas regiones, son prácticamente inaccesibles. En este vacío, las estrategias farmacológicas adquieren el monopolio de la legitimidad terapéutica. Los pacientes y sus familias llegan a equiparar la atención con la medicación, y la negativa se interpreta como irracionalidad o negación de la enfermedad. Las instituciones interiorizan esta lógica y los médicos operan en un marco en el que la prescripción es el acto más accesible, reembolsable y protegido institucionalmente. Esto crea un círculo vicioso en el que la medicación excesiva se refuerza a sí misma, protegida del escrutinio por las expectativas culturales, el diseño institucional y las normas profesionales.

El sistema educativo reproduce este paradigma. Los planes de estudios de medicina en España dedican una atención limitada a las dimensiones históricas, sociológicas o psicológicas del sufrimiento mental. Se da prioridad a la farmacología y la clasificación diagnóstica, mientras que la práctica reflexiva, las habilidades relacionales y los enfoques basados en el trauma siguen siendo periféricos. Los estudiantes no reciben una formación sistemática en la toma de decisiones compartida, la autonomía del paciente o las vías no farmacológicas para la recuperación. En cambio, se les socializa en un modelo de atención en el que el éxito terapéutico se define por la reducción de

los síntomas y la adherencia al tratamiento. La ausencia de una farmacovigilancia crítica, junto con la formación limitada en la desprescripción, conduce a trayectorias profesionales en las que la medicación se emplea de forma temprana, amplia e indefinida. La formación continua, a menudo financiada o influenciada por intereses farmacéuticos, refuerza estos patrones, presentando la innovación farmacológica como sinónimo de progreso clínico y ocultando los límites éticos y empíricos de la práctica actual (Montero, 2014).

El tratamiento farmacológico del malestar se ve amplificado por factores socioculturales más amplios que facilitan la medicalización y desalientan las respuestas sistémicas. En España, las altas tasas de prescripción de psicofármacos no son solo el resultado de decisiones clínicas, sino que reflejan un patrón generalizado de medicación del sufrimiento social. La pobreza, el desempleo, la precariedad de la vivienda y el estrés crónico relacionado con las responsabilidades del cuidado de otras personas o la violencia doméstica se traducen con frecuencia en síntomas psiquiátricos en los encuentros clínicos. En lugar de actuar sobre los determinantes sociales de la salud, el sistema sanitario a menudo absorbe sus consecuencias a través del lenguaje del diagnóstico y el mecanismo de la prescripción. Esta transferencia de responsabilidad de las políticas públicas al sujeto individual refuerza una narrativa biomédica en la que la adversidad estructural se replantea como una disfunción personal, tratable principalmente por medios farmacológicos. El resultado es una disyuntiva crónica entre el diagnóstico y la realidad, en la que la carga del fracaso sistémico se redistribuye como patología individual (Laporte et al., 1983; Bertolín-Guillén, 2021; Suleman et al., 2025).

Este fenómeno es especialmente visible en la atención primaria, donde se espera que los médicos generales atiendan a un gran volumen de pacientes en un tiempo limitado, a menudo sin acceso a recursos psicosociales ni opciones de derivación. Dentro de estas limitaciones, la medicación se convierte no solo en la vía más fácil, sino en la única herramienta disponible. Las benzodiazepinas y los antidepresivos se utilizan habitualmente para tratar afecciones derivadas de la privación socioeconómica, los conflictos interpersonales y el estrés acumulado a lo largo de la vida. Si bien estos medicamentos pueden proporcionar un alivio temporal, su uso prolongado en poblaciones estructuralmente desfavorecidas refuerza la dependencia, socava el desarrollo de estrategias de adaptación y retrasa o desplaza las intervenciones que abordan las causas subyacentes. La exposición crónica a estos fármacos conlleva riesgos significativos para la salud, especialmente entre las personas mayores, en quienes el riesgo de caídas, deterioro cognitivo y lesiones iatrogénicas aumenta notablemente. En este contexto, la medicación excesiva se convierte en un vector de daño médico, sostenido por la indiferencia institucional hacia las condiciones que generan el sufrimiento (Santamaría, 2020; Bertolín-Guillén, 2021; Roncero et al., 2025).

Tabla 7. Lógica sistémica de la coacción psiquiátrica y la medicación excesiva

Etapa	Camino de la izquierda: determinantes individuales y sociales	Camino de la derecha: limitaciones institucionales y legales	Resultado
1. Condiciones estructurales	Determinantes socioculturales (por ejemplo, pobreza, trauma)		
2. Presentación inicial	Presentación de síntomas psiquiátricos		
3. Marco institucional	Enmarcado como trastorno individual		
4. Asignación del diagnóstico	Etiqueta diagnóstica asignada		
5. Resultado institucional			Cronicidad, exclusión, resistencia a la reforma

Esta tabla resume la lógica institucional secuencial mediante la cual el sufrimiento social se redefine como trastorno individual, lo que conduce a intervenciones psiquiátricas coercitivas. Demuestra la interacción entre los determinantes sociestructurales y las restricciones legales e institucionales, mostrando cómo el etiquetado diagnóstico y los protocolos farmacocéntricos convergen para producir cronicidad, exclusión y resistencia a la reforma. El modelo refleja los mecanismos de violencia estructural arraigados en la gobernanza clínica y destaca la necesidad de un rediseño sistémico basado en la autonomía del paciente, la responsabilidad ética y la práctica orientada a la recuperación.

Desde el punto de vista de la salud pública, el coste de este enfoque farmacocéntrico es considerable. Desde el punto de vista financiero, la asignación de recursos a la adquisición, distribución y supervisión de medicamentos desvía la financiación de las intervenciones preventivas y comunitarias. Desde el punto de vista clínico, la dependencia excesiva de los fármacos contribuye a hospitalizaciones innecesarias, casos resistentes al tratamiento y tasas elevadas de discapacidad crónica. Desde el punto de vista psicosocial, erosiona la confianza en el sistema sanitario, estigmatiza el malestar y fragmenta el tejido relacional necesario para la recuperación a largo plazo. Por lo tanto, la carga acumulada de la medicación excesiva no se limita al paciente, sino que se extiende a las familias, los profesionales y la sociedad en su conjunto. Su persistencia es indicativa de una crisis epistemológica más profunda en la atención sanitaria, en la que los parámetros de éxito no se ajustan a la realidad del sufrimiento humano y en la que la promesa de la precisión tecnológica oscurece la necesidad de una sensibilidad ética y contextual (Laporte, 1984; Díaz-Gutiérrez et al., 2018).

Las pruebas presentadas en esta sección confirman que la sobremedicación en la psiquiatría española no puede explicarse como una serie de errores aislados o hábitos desafortunados. Se trata de una característica sistémica de un ecosistema clínico que privilegia las soluciones farmacéuticas, la conveniencia institucional y la autoridad epistémica por encima de la experiencia del paciente, la reforma estructural y la atención relacional. Abordar esta disfunción requiere un esfuerzo sostenido y multidisciplinar, capaz de hacer frente tanto a los supuestos culturales como a las prácticas institucionales que sustentan la hegemonía farmacocéntrica. En la siguiente sección se examinarán los fundamentos, los principios y las estrategias de aplicación de la gestión autónoma de la medicación y otras prácticas con base científica que pueden restablecer la integridad clínica y mejorar los resultados sanitarios en un marco basado en los derechos, participativo y éticamente coherente.

1.4 Hacia la gestión autónoma de la medicación y mejores prácticas basadas en la evidencia

Los avances internacionales en la atención psiquiátrica han cuestionado progresivamente el dominio histórico de los paradigmas de tratamiento paternalistas, centrados en la farmacología y orientados al cumplimiento. En este contexto, la gestión autónoma de la medicación ha surgido como un marco con base científica y éticamente necesario, cuyo objetivo es reconfigurar la farmacoterapia psiquiátrica como un proceso dialógico y basado en la evidencia, en lugar de una imposición unilateral. En múltiples sistemas de salud de América del Norte y Europa, estudios empíricos y longitudinales han identificado importantes preocupaciones clínicas y de salud pública relacionadas con el uso prolongado de medicamentos psicotrópicos, entre ellas el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular, el deterioro neurocognitivo, el embotamiento emocional y la alteración de la cognición social. Estos efectos, agravados por procedimientos de consentimiento informado insuficientes y regímenes de tratamiento estructuralmente coercitivos, han suscitado críticas sostenidas tanto por parte de la psiquiatría académica como de los defensores de los usuarios. Al mismo tiempo, los marcos políticos de jurisdicciones como Quebec, Brasil, los Países Bajos y Finlandia han integrado modelos alternativos de atención, lo que refleja un cambio en el razonamiento clínico y ético. Estos modelos hacen hincapié en la recuperación, la coherencia narrativa, la comprensión contextual y la toma de decisiones relacional, situando la medicación no como el eje de la intervención, sino como un elemento modificable dentro de un acuerdo terapéutico en evolución. Este replanteamiento ha sido respaldado por ensayos controlados, datos de cohortes del mundo real y declaraciones de consenso transdisciplinarias que subrayan la necesidad de reducir la carga de medicación, aplicar protocolos de reducción gradual y fomentar entornos de atención participativos (Deegan, 2006; Chmielowska et al., 2022; Horowitz, 2024).

El modelo de Quebec, desarrollado principalmente gracias al trabajo de Jean-François Pelletier y Marie-Jeanne Proulx, sistematizó la gestión colaborativa de la medicación como una práctica relacional y éticamente reflexiva basada en el paradigma de la recuperación. Basado en la investigación sobre el trauma, la autonomía del paciente y la responsabilidad clínica compartida, este modelo hizo hincapié en la producción de conocimientos a través del diálogo, la reorientación de la autoridad clínica y la integración del apoyo entre pares en las decisiones farmacológicas. Estas estrategias se pusieron en práctica mediante diálogos estructurados, equipos terapéuticos no jerárquicos y planes de tratamiento flexibles que respondían a las trayectorias individuales de angustia y recuperación. En Brasil, la traducción de estos principios a un contexto marcado por la atención psicosocial comunitaria, el constitucionalismo sanitario colectivo y la reforma antiinstitucional dio lugar a un modelo en el que las estrategias de reducción de la medicación se integraron en un compromiso político más amplio con la desinstitucionalización y la psiquiatría basada en los derechos. El sistema brasileño demostró que la gestión de la medicación no puede disociarse de los determinantes sociojurídicos, como el acceso a la vivienda, los ingresos y los recursos comunitarios. Al integrar la desprescripción de psicofármacos en un continuo de salud pública y protección social, el enfoque de Brasil puso de relieve la necesidad de apoyos colectivos y marcos jurídicos que refuercen la legitimidad de la atención no farmacológica (Canadian Deprescribing Guidelines Project, 2024).

En los Países Bajos y Finlandia, las prácticas de diálogo abierto han proporcionado una base empírica adicional para los modelos psiquiátricos centrados en el usuario y con un bajo uso de medicamentos. Estas prácticas, que integran la participación continua de la familia y la comunidad, los procesos dialógicos en tiempo real y una dependencia mínima de la categorización diagnóstica, han dado lugar a resultados estadísticamente significativos en términos de reducción de las hospitalizaciones, menor uso de medicamentos crónicos y mejores indicadores de recuperación comunicados por los pacientes. A pesar de estos resultados, la institucionalización de estos modelos sigue siendo limitada debido a la inercia sistémica, las restricciones financieras y la resistencia disciplinaria dentro de la gobernanza psiquiátrica convencional. El análisis comparativo de estas jurisdicciones revela que la gestión autónoma de la medicación no es un ideal ético abstracto, sino un marco clínico viable que depende de apoyos interrelacionados: reciclaje clínico, herramientas dirigidas por los pacientes, infraestructura digital y reconocimiento legal de los derechos de participación. Este corpus empírico establece la viabilidad conceptual, ética y práctica de un modelo en el que el uso de la medicación no viene dictado por protocolos estándar o mandatos institucionales, sino que se coproduce en ecosistemas clínicos situados, relacionales y con conocimientos fisiológicos (Seikkula y Olson, 2003; Olson et al., 2014; Groot y van Os, 2023).

Las barreras para la adopción generalizada de la gestión autónoma de la medicación siguen siendo importantes, especialmente en contextos como el español, donde las tradiciones clínicas, los protocolos institucionales y las jerarquías profesionales siguen privilegiando la intervención farmacológica como piedra angular de la atención psiquiátrica. A pesar de los cambios retóricos hacia principios orientados a la recuperación y la inclusión formal de los derechos de los pacientes en las estrategias nacionales de salud mental, estos compromisos a menudo no se materializan en la práctica clínica. Entre las limitaciones estructurales se encuentran la falta de formación en atención dialógica y basada en el trauma, la disponibilidad limitada de alternativas psicosociales y las culturas médico-legales que penalizan la discreción clínica percibida como desviación de las normas farmacocéntricas. Estas limitaciones se ven reforzadas por el diseño de los sistemas de información sanitaria que registran la adherencia a la medicación como indicador de la mejora clínica, consolidando así el cumplimiento farmacológico como índice de éxito de la atención. El resultado es un entorno clínico en el que las solicitudes de los pacientes para reducir o suspender la medicación se interpretan a menudo como signos de negación, resistencia o falta de comprensión, en lugar de como expresiones de una agencia informada. Este marco interpretativo no solo deslegitima el conocimiento empírico de las personas con experiencia vivida, sino que también desincentiva la práctica reflexiva entre los profesionales, que siguen inmersos en culturas de aversión al riesgo y ortodoxia diagnóstica (Serrano-Miguel et al., 2020; Martínez-Hernández et al., 2020).

A esto se suma la asimetría entre los conocimientos científicos y la autoridad epistémica de los pacientes y los profesionales. En ausencia de directrices clínicas elaboradas conjuntamente y de plataformas compartidas para la difusión del conocimiento, los pacientes suelen verse privados de la información necesaria para participar de manera significativa en la toma de decisiones farmacológicas. Muchos siguen sin conocer toda la gama de riesgos asociados al uso prolongado de medicamentos, los procesos fisiológicos que subyacen a los síndromes de abstinencia o las alternativas respaldadas por la evidencia internacional. La difusión de guías de desprescripción de

libre acceso, ayudas digitales interactivas para la toma de decisiones y módulos de formación dirigidos a los pacientes sigue limitada a programas piloto específicos y rara vez llega a los entornos de atención primaria o secundaria. En España, la integración de estas herramientas en la atención rutinaria se ve aún más obstaculizada por la fragmentación de la gobernanza, la insuficiente coordinación de las políticas entre las comunidades autónomas y el predominio de los intereses de la industria farmacéutica en la formación médica continua y la elaboración de directrices. La falta de mecanismos de evaluación independientes y la casi ausencia de sistemas de documentación controlados por los pacientes agravan este problema, lo que da lugar a un entorno institucional que inhibe estructuralmente la puesta en práctica de las mejores prácticas en la gestión de la medicación (Sanguinetti et al., 2025).

El consenso científico reconoce cada vez más la necesidad de redefinir tanto el contenido como el proceso de la atención psiquiátrica para adaptarse a la pluralidad epistémica y la variabilidad fisiológica inherentes a las poblaciones clínicas del mundo real. En lugar de enmarcar la adherencia a la medicación como un resultado binario o un marcador de compromiso, las mejores prácticas contemporáneas hacen hincapié en el uso de planes de tratamiento basados en la retroalimentación, criterios de valoración clínicos definidos conjuntamente y métricas que incorporen tanto las dimensiones fisiológicas como las psicosociales de la recuperación. Entre ellas se incluyen el funcionamiento cognitivo, la salud metabólica, la coherencia narrativa, la regulación afectiva y el cumplimiento de las funciones sociales. Las pruebas de estudios longitudinales sugieren que estas medidas de resultado son mejores predictores del bienestar sostenido que las listas de síntomas tradicionales o los criterios diagnósticos por sí solos. En consecuencia, la justificación científica para mantener modelos de tratamiento farmacocéntricos sin una reevaluación rigurosa se ha debilitado considerablemente. La persistencia de estos modelos en España no refleja una ausencia de alternativas, sino la incapacidad de implementarlas debido a la inercia institucional, la ambigüedad jurídica y la marginación de las perspectivas críticas en la formación y la gobernanza psiquiátricas (Kuhl, 2019).

La consolidación de los paradigmas farmacocéntricos en la psiquiatría española, a pesar de las pruebas internacionales que acumulan sobre sus limitaciones, debe entenderse como producto de lógicas institucionales profundamente arraigadas que van más allá de los encuentros clínicos individuales. Las culturas profesionales, los entornos normativos y los sistemas de reembolso sostienen colectivamente un marco en el que la prescripción de fármacos psicotrópicos no solo está normalizada, sino que se incentiva estructuralmente. Las políticas de reembolso favorecen las consultas breves y centradas en la medicación frente a las intervenciones psicosociales que requieren mucho tiempo. Los protocolos legales y administrativos suelen dar prioridad a la minimización del riesgo mediante una rápida contención farmacológica, en lugar de una evaluación contextual exhaustiva. Los planes de formación en medicina y psicología siguen privilegiando las categorías diagnósticas basadas en los síntomas y los modelos explicativos neuroquímicos, mientras que descuidan los enfoques integradores del trauma, la corporalidad y los determinantes sociales. Esta constelación de fuerzas refuerza un habitus clínico que margina los conocimientos no farmacológicos, restringe la imaginación terapéutica y produce condiciones epistémicas hostiles a la atención dialógica y participativa (Toro et al., 2006).

Es fundamental señalar que la normalización del tratamiento psicofarmacológico a largo plazo en España persiste a pesar de sus consecuencias iatrogénicas bien documentadas. La exposición crónica a antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y ansiolíticos se ha asociado a una amplia gama de efectos adversos, entre los que se incluyen, entre otros, la disfunción metabólica, el deterioro cognitivo, el embotamiento emocional, los trastornos del movimiento, la disregulación hormonal y la disfunción sexual (Simopoulos y Trinidad, 2013). Más allá de las secuelas fisiológicas, el uso prolongado de medicamentos a menudo conduce a la dependencia psicosocial, la erosión de la autoeficacia y el deterioro del desarrollo de la identidad, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Estos resultados rara vez se supervisan de forma sistemática y, con frecuencia, se minimizan o se patologizan cuando los pacientes los plantean. En lugar de suscitar una reflexión crítica sobre la idoneidad de los planes de tratamiento, los informes sobre efectos adversos suelen dar lugar a una escalada diagnóstica o a la polifarmacia. Esta práctica no solo amplifica el riesgo, sino que consolida un ciclo clínico en el que las preocupaciones de los pacientes se reinterpretan como pruebas de un trastorno en lugar de aportaciones válidas para la toma de decisiones terapéuticas. Esta dinámica ilustra cómo el modelo farmacocéntrico funciona no solo como estrategia de tratamiento, sino como mecanismo disciplinario que moldea la subjetividad de los pacientes, la identidad profesional y las normas institucionales (Dencker et al., 1986; Gotzsche, 2019).

Las implicaciones éticas de este modelo son significativas. Cuando los sistemas clínicos dan prioridad a la intervención bioquímica sobre la comprensión relacional, el resultado es una degradación de la integridad terapéutica y una erosión sistemática del consentimiento informado. El verdadero consentimiento requiere no solo el suministro de información, sino también la libertad de rechazar o modificar el tratamiento en función de la evolución de las necesidades y los objetivos. En el contexto español actual, esta libertad es a menudo nominal, limitada por la escasez estructural, la presión normativa y el encuadre médico-legal de la desviación como desviación. La autonomía se convierte en performativa en lugar de sustantiva, preservada en la retórica pero negada en la práctica. Para contrarrestar esta tendencia, las mejores prácticas basadas en la evidencia en la gestión de la medicación deben integrarse en una transformación más amplia de la epistemología y la gobernanza psiquiátricas. Esta transformación implica no solo revisar los protocolos de tratamiento, sino también reconfigurar los sistemas de producción de conocimiento, acreditación profesional y responsabilidad institucional que los sustentan (Whitaker, 2005; Rose, 2007).

Esta tesis contribuye a dicha reconfiguración articulando los fundamentos científicos, éticos y operativos de la gestión autónoma de la medicación, basados en el trabajo de campo comparativo, la evidencia empírica y la experiencia vivida por las personas afectadas. A través de un análisis multiescalar y una integración transdisciplinaria, expone los determinantes estructurales de la persistencia farmacocéntrica y esboza vías viables hacia prácticas clínicas más eficaces y justas. La siguiente sección delinea los marcos médico-legales y constitucionales necesarios para apoyar esta transición, identificando las condiciones normativas, procedimentales e institucionales bajo las cuales la atención farmacológica puede ser compatible con los derechos humanos, la excelencia clínica y la legitimidad democrática.

1.5 Fundamentos jurídicos, epistémicos y científicos del problema de investigación

La persistencia de prácticas coercitivas y modelos de tratamiento farmacocéntricos en la psiquiatría contemporánea refleja una compleja intersección entre la ambigüedad jurídica, la asimetría epistémica y las limitaciones científicas. Estos elementos sustentan una configuración estructural en la que la autonomía del paciente, el consentimiento informado y la integridad corporal están subordinados a la conveniencia institucional, la discreción profesional y los protocolos de gestión de riesgos. El problema fundamental que se aborda en esta tesis no se limita a la extralimitación clínica, sino que se refiere a la reproducción sistémica de la coacción a través de normas jurídicas arraigadas, mecanismos de validación científica y jerarquías de toma de decisiones que difuminan la frontera entre la atención y el control. A pesar de que los instrumentos internacionales de derechos humanos afirman el principio del consentimiento libre e informado en el tratamiento médico, los marcos jurídicos nacionales suelen contener excepciones que permiten la intervención involuntaria sobre la base de la presunta incapacidad, el riesgo o la clasificación diagnóstica (Hemper et al, 2024). Estas excepciones, aunque están reguladas formalmente, están sujetas a una amplia discrecionalidad interpretativa y rara vez se someten a una verificación externa o a una auditoría retrospectiva. En el contexto español, las leyes orgánicas que regulan la incapacidad civil, la tutela y la intervención en salud mental permiten a los actores médicos y judiciales ignorar las preferencias de los pacientes sin necesidad de justificar en tiempo real su decisión basándose en los estándares científicos contemporáneos. Esta permisividad legal permite que la coacción funcione como una estrategia clínica normalizada en lugar de como un último recurso (Desviat, 2011; Ferreirós, 2013; Ramos-Pozón et al., 2025).

La estructura epistémica de la psiquiatría refuerza esta dinámica al situar la autoridad clínica dentro de un sistema de diagnóstico que sigue basándose en la descripción y no está validado etiológicamente. Los modelos nosológicos predominantes en España y en la mayoría de los sistemas sanitarios de ingresos altos se basan en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Estas clasificaciones se basan en grupos de síntomas sin fundamento mecánico, lo que hace que la atribución del diagnóstico sea vulnerable a la subjetividad, los sesgos socioculturales y la utilidad administrativa. La ausencia de biomarcadores objetivos o indicadores fisiológicos reproducibles socava la fiabilidad epistémica del diagnóstico psiquiátrico y debilita su pretensión de legitimidad médica según los estándares de falsabilidad y transparencia mecanicista que se esperan en otros ámbitos de las ciencias de la salud. No obstante, estas clasificaciones tienen un peso jurídico y social significativo, ya que funcionan como dispositivos de control del estado civil, la capacidad y el acceso a derechos o restricciones. En la práctica, autorizan intervenciones que pueden incluir la hospitalización forzosa, la medicación involuntaria y la institucionalización a largo plazo, a menudo sin posibilidad de recurso independiente o reevaluación longitudinal. Esta tensión entre la incertidumbre epistémica y la determinación jurídica constituye una dimensión fundamental del problema de investigación abordado en esta tesis (Moncrieff, 2010; Frances, 2013).

La institucionalización del conocimiento psiquiátrico se produce dentro de una arquitectura reguladora que confiere estatus normativo a la opinión clínica sin someterla a los mismos umbrales probatorios que se aplican en otros ámbitos de la biomedicina. En ausencia de especificidad mecánica

o de una validación basada en los resultados, la autoridad clínica se deriva principalmente de la posición institucional, la acreditación profesional y los protocolos codificados. Estos protocolos se basan a menudo en el consenso más que en una evaluación empírica controlada y reflejan con frecuencia la influencia de los intereses farmacéuticos, las prioridades de contención del riesgo y la defendibilidad médico-legal, más que la eficacia terapéutica o la recuperación definida por el paciente. Esta dinámica produce un bucle epistémico cerrado en el que la desviación de la práctica farmacológica o diagnóstica establecida se interpreta como un error clínico, una responsabilidad administrativa o una irracionalidad del paciente. En un sistema de este tipo, la innovación, la disidencia o la adaptación se desalientan estructuralmente, y los datos relacionales o contextuales se dejan de priorizar en favor de la gestión cuantificable de los síntomas. Las decisiones clínicas se rigen, por tanto, por una lógica algorítmica basada en medias poblacionales y datos extrapolados de ensayos, en lugar de en trayectorias específicas de cada persona, historias de vida o capacidades situadas para elegir (Kirk y Kutchins, 1992; Kirk et al., 2013).

La literatura científica sobre la coacción y el daño psiquiátrico se ha ampliado en las últimas dos décadas, pero su integración en la práctica clínica y jurídica sigue siendo limitada. Los metaanálisis y los estudios observacionales a gran escala han documentado las consecuencias a largo plazo de las prácticas coercitivas, entre ellas la indefensión aprendida, el abandono del tratamiento, las lesiones iatrogénicas y el aumento del riesgo de suicidio. No obstante, la incorporación de estos hallazgos a la reforma de las políticas o a la formación clínica ha sido parcial e inconsistente. Las pruebas científicas de los daños suelen quedar neutralizadas por los discursos institucionales sobre la mitigación de riesgos o la seguridad de los pacientes, que presentan la coacción como una respuesta necesaria a la urgencia clínica, a pesar de la falta de validez predictiva de las herramientas de evaluación del riesgo psiquiátrico. La crítica científica de las prácticas farmacocéntricas, incluida la ineficacia a largo plazo de ciertas clases de fármacos y la infradeclaración de los efectos adversos en los ensayos patrocinados por la industria, también ha tenido dificultades para producir cambios sostenidos en el comportamiento clínico o en las normas reguladoras. Esto indica una disociación estructural entre la producción de conocimientos y el cambio institucional, una brecha que esta tesis pretende exponer y abordar mediante una investigación integrada, empírica y sensible al sistema (Moon, 2000).

En el contexto español, la convergencia de la permisividad legal, la ambigüedad científica y la discrecionalidad clínica crea un entorno estructural en el que las prácticas coercitivas no son episódicas, sino constitutivas de la gobernanza psiquiátrica. Los códigos civiles, los estatutos de salud y la jurisprudencia permiten intervenciones involuntarias basadas en interpretaciones amplias del riesgo, la incapacidad o la presunta necesidad médica, sin exigir la presentación de umbrales de daño individualizados o justificaciones basadas en la evidencia. El respaldo judicial de las recomendaciones clínicas suele ser automático, lo que refleja la dependencia del poder judicial de los conocimientos psiquiátricos y la ausencia de supervisión independiente o contrapeso epistémico. Este acuerdo consolida la autoridad de la institución psiquiátrica y limita las vías de impugnación, reparación legal o revisión externa por parte de los pacientes. En tal configuración, la capacidad del paciente para oponerse se ve socavada no solo desde el punto de vista procedimental, sino también conceptual, ya que la disidencia se patologiza y se interpreta como un síntoma de enfermedad en lugar de como una expresión legítima de la voluntad. Los instrumentos de diagnóstico, las notas clínicas y

las evaluaciones de riesgo no funcionan como ayudas descriptivas, sino como tecnologías de captura, generando legitimidad administrativa para intervenciones cuya base científica sigue siendo débil o no probada (Szasz, 2007; Whitaker, 2010).

Estas condiciones sistémicas se ven reforzadas por la división epistemológica entre la evidencia objetiva y subjetiva, en la que los relatos en primera persona sobre daños o injusticias se descartan sistemáticamente por considerarlos poco fiables o no clínicos. Esta marginación de la experiencia vivida socava el alcance empírico de la investigación psiquiátrica, restringe la definición de datos válidos y limita el desarrollo de modelos de atención participativos o fenomenológicos. Limita el potencial de retroalimentación del sistema y la corrección de errores, ya que los mecanismos para denunciar los daños están poco desarrollados, son internos a las instituciones o se perciben como adversos. Cuando se producen resultados adversos, como el deterioro iatrogénico, el suicidio o la cronicidad inducida por la intervención acumulativa, las respuestas institucionales dan prioridad a la gestión de la responsabilidad sobre la reconstrucción de la verdad, lo que impide un aprendizaje significativo o una reforma de los procedimientos. En este entorno, la legitimidad de la práctica psiquiátrica se mantiene a través de la inercia normativa, la autoridad basada en las credenciales y el aislamiento burocrático frente a las críticas de los usuarios. La brecha resultante entre la retórica clínica y la práctica institucional constituye una patología central de la gobernanza y un objeto crítico de análisis para esta investigación (Burstow, 2015; Held, 2020; Markus, 2020).

Las características estructurales esbozadas anteriormente definen no solo el objeto de estudio, sino también las limitaciones metodológicas y las obligaciones éticas bajo las cuales se ha desarrollado esta tesis. La convergencia de la autoridad legal, la autonomía clínica y la opacidad epistémica requiere un diseño de investigación capaz de operar dentro de espacios institucionales controvertidos, manteniendo al mismo tiempo el rigor analítico y la integridad procedimental. Esto implica un marco científico que trate la experiencia vivida como datos, el discurso institucional como evidencia y la práctica clínica como un comportamiento situado sujeto a análisis empírico. También exige una posición metodológica que no reproduzca las asimetrías que critica, sino que permita la observación, la documentación y el compromiso sin reproducir el daño o la exclusión epistémica (Sanati y Kyratsous, 2015). Por lo tanto, el problema de investigación no se limita a identificar casos de coacción o medicación excesiva, sino que se extiende al mapeo de las arquitecturas normativas que los sustentan y al rastreo de las condiciones en las que estas arquitecturas podrían transformarse. Dicha transformación no puede producirse únicamente a través de la innovación clínica o la modificación legal, sino que requiere una reconfiguración de las jerarquías epistémicas, las garantías procedimentales y los mecanismos de rendición de cuentas institucionales. Estas dimensiones se abordarán en el siguiente capítulo, en el que se esboza la estrategia metodológica adoptada, el diseño de los instrumentos de campo y los marcos analíticos utilizados para examinar la coacción, la agencia y la gobernanza psiquiátrica en contextos reales. El objetivo es generar conocimientos científicos con base empírica, relevantes desde el punto de vista jurídico y útiles desde el punto de vista operativo para promover modelos de atención de la salud mental éticamente defendibles (Houlders, Bortolotti y Broome, 2021).

1.6 Fallo sistémico, violencia estructural y el reto de la reforma

La estructura actual de la atención psiquiátrica en España está determinada por paradigmas institucionales arraigados que dan prioridad a la contención farmacológica sobre la integración biopsicosocial. A pesar de la creciente disponibilidad de marcos globales para la atención basada en los derechos, incluido el programa QualityRights de la Organización Mundial de la Salud, y de la amplia difusión de los principios basados en el trauma y los modelos de atención centrados en el paciente, las respuestas clínicas dominantes al malestar mental siguen siendo en gran medida farmacocéntricas y reactivas. Esta discrepancia refleja un desajuste fundamental entre las normas emergentes en materia de salud mundial y las normas operativas de gran parte de la psiquiatría española. El uso prolongado de psicofármacos, en particular para el tratamiento a largo plazo de trastornos mentales no agudos, sigue produciéndose sin una aplicación coherente de protocolos de toma de decisiones participativos, evaluaciones interdisciplinarias o evaluaciones de riesgos estructurales. Si bien las sociedades profesionales reconocen cada vez más la importancia de los factores ecológicos, neuroendocrinos y relacionales en la configuración de los resultados de salud mental, estos conocimientos aún no se han traducido en la práctica habitual. El predominio continuado de paradigmas reduccionistas no solo limita la eficacia clínica, sino que socava sistemáticamente los derechos, la autonomía y las perspectivas de recuperación a largo plazo de los pacientes, en particular los más marginados por la pobreza, el trauma y la exclusión social. La ausencia de un diálogo significativo entre disciplinas, la limitada implementación de la formación basada en los derechos y el persistente encuadre del incumplimiento como desviación clínica contribuyen a un panorama institucional en el que las intervenciones farmacológicas se convierten en la respuesta por defecto al malestar, independientemente del contexto, la historia o las preferencias del paciente. En este contexto, la violencia estructural no opera como una aberración, sino como una consecuencia de la práctica estandarizada, lo que revela la urgente necesidad de una corrección del paradigma guiada por la integridad científica y la obligación ética (Paradis-Gagné et al., 2021; Gill et al., 2024).

Los esfuerzos del Gobierno central español y de algunos gobiernos autonómicos, como el de Cataluña, para abordar la dependencia desproporcionada de las intervenciones farmacológicas han ganado visibilidad a través de las recientes estrategias nacionales de salud mental, que hacen hincapié en la importancia de la atención comunitaria, la coordinación interdisciplinaria y los enfoques preventivos. Estos instrumentos políticos reconocen el uso excesivo de la medicación psiquiátrica y abogan por respuestas no farmacológicas, especialmente en la atención primaria y en entornos no agudos. Sin embargo, la traducción de estas prioridades a la práctica sigue siendo parcial y desigual entre las distintas regiones. La inercia institucional, la formación desigual de los profesionales sanitarios, la insuficiencia de las infraestructuras de apoyo psicosocial y la persistencia de culturas clínicas jerárquicas siguen obstaculizando la consecución de estos objetivos políticos. Sin una reforma sustancial de la forma en que se toman, documentan y siguen las decisiones médicas, los objetivos declarados corren el riesgo de quedarse en meras palabras. El énfasis en la salud mental como prioridad de salud pública no debe reducirse a compromisos retóricos. Requiere la asignación de recursos a equipos multidisciplinarios, la reorganización de las vías de atención para permitir la continuidad y la elección, y el desarrollo de sistemas de medición que no privilegien la supresión de

los síntomas sobre la recuperación funcional. Esto es especialmente relevante dada la asociación documentada entre la medicación excesiva, la cronificación de los síntomas, el deterioro metabólico y la pérdida de la función psicosocial. El reconocimiento del problema por parte del Gobierno es un punto de partida necesario, pero la transformación necesaria no se limita a aumentar el acceso a la atención. Implica la reestructuración de los fundamentos epistémicos, éticos y procedimentales de la práctica psiquiátrica para alinearla con la ciencia médica contemporánea y las normas de derechos humanos (Salvador-Carulla, 2010).

La alineación de las estrategias nacionales de España con las iniciativas mundiales representa un momento crítico para el cambio sistémico. El marco QualityRights de la Organización Mundial de la Salud, que aboga por la eliminación de la coacción y la aplicación de una atención basada en los derechos, proporciona un punto de referencia normativo y operativo para evaluar los sistemas psiquiátricos. El respaldo de España a estas normas internacionales refleja la voluntad institucional de ir más allá de los paradigmas puramente biomédicos. Sin embargo, la aplicación práctica requiere que el sistema adopte modelos clínicos basados en la evidencia que integren los determinantes neurofisiológicos, nutricionales, psicológicos y sociales de la salud en la norma de atención. Los nuevos enfoques psiquiátricos que se basan en la integración interdisciplinaria, incluidos los que se fundamentan en la inmunología psiconeuroendocrina y en el campo más amplio de la neurociencia traslacional, hacen hincapié en la necesidad de abordar los mecanismos subyacentes del malestar, en lugar de limitarse a modular los síntomas mediante la farmacología. Estos enfoques respaldan la idea de que el cerebro no puede tratarse de forma aislada del cuerpo o de los contextos sociales y ambientales que lo conforman. Los modelos traslacionales apuntan al papel fundamental de las adversidades en la primera infancia, la inflamación crónica, la mala higiene del sueño, las deficiencias nutricionales y las respuestas desreguladas al estrés en la génesis y la perpetuación del malestar mental. Cuando se incorporan al razonamiento clínico, estos modelos desplazan el enfoque de la psiquiatría del control de los síntomas a la regulación fisiológica y el desarrollo de la resiliencia. Aunque aún no son mayoritarias en el sistema de salud pública español, estas perspectivas están cada vez más representadas en la formación médica continua, los consorcios de investigación y los programas piloto. Sin embargo, su plena adopción depende de reformas en la formación médica, las clasificaciones diagnósticas y los sistemas de recompensa institucionales. La tesis aborda estos avances internacionales no solo como antecedentes, sino como campos activos de controversia y aprendizaje, en los que deben situarse críticamente y avanzar de forma constructiva los esfuerzos actuales en España. La incorporación gradual de modelos fisiológicos, psicosociales y ecológicos a la atención psiquiátrica ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los paradigmas diagnósticos y terapéuticos actuales, que siguen anclados en conjuntos de síntomas obsoletos y supuestos farmacológicos. Mientras que la comunidad científica internacional reclama cada vez más la integración de los determinantes sociales de la salud, la cognición incorporada y las formulaciones sensibles al contexto, muchos entornos clínicos en España siguen aplicando categorías diagnósticas rígidas, sin prestar suficiente atención a sus limitaciones epistemológicas o consecuencias funcionales (Pūras, 2017). Esta rigidez no solo distorsiona la comprensión del sufrimiento humano, sino que también sostiene prácticas coercitivas al presentarlas como médicamente justificadas o inevitables. Socava la capacidad de aprendizaje interdisciplinario y refuerza las jerarquías profesionales que

inhiben la atención colaborativa. La persistencia de estos patrones sistémicos refleja la resiliencia de las dependencias institucionales que favorecen la contención del riesgo, la eficiencia administrativa y el tratamiento farmacológico del malestar frente a las intervenciones relacionales, rehabilitadoras y con base social. Aunque los marcos políticos recientes y los planes nacionales de salud mental reconocen formalmente la necesidad de una reforma, los mecanismos reales de implementación siguen estando sujetos a limitaciones de recursos, resistencia profesional y falta de gobernanza integrada. El debate público sobre la salud mental se ha ampliado considerablemente, pero los compromisos estructurales para el cambio siguen siendo precarios a menos que vayan acompañados de una redefinición de lo que constituye el éxito clínico y la rendición de cuentas en la atención psiquiátrica. Esta tesis interviene precisamente en ese nivel, aportando conocimientos empíricos, jurídicos y metodológicos que cuestionan la inercia del sistema actual e identifican vías operativas para una transformación basada en la evidencia.

La convergencia de los mandatos internacionales, los avances científicos y los esfuerzos de promoción locales ofrece una oportunidad única para realinear los sistemas de salud mental con los estándares contemporáneos de atención basados en la dignidad, la autonomía y la integridad científica. Los marcos globales, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, abogan por una atención de salud mental basada en los derechos e integrada en la comunidad, rechazando explícitamente las prácticas coercitivas y haciendo hincapié en la importancia de las garantías legales, el consentimiento informado y la continuidad interdisciplinaria. En este panorama más amplio, el aparato institucional español está comenzando a responder con iniciativas nacionales destinadas a reducir la dependencia excesiva de las intervenciones farmacológicas y promover enfoques psicosociales integrados. No obstante, persisten importantes deficiencias en la aplicación debido a culturas profesionales arraigadas, una prestación de servicios fragmentada y mecanismos jurídicos insuficientes para la rendición de cuentas y la gobernanza dirigida por los pacientes. La integración de la neurociencia traslacional, la psiquiatría nutricional y los modelos fisiológicos de salud mental sigue siendo limitada, a menudo relegada a ámbitos experimentales o periféricos en lugar de servir de base para la práctica clínica básica. La ausencia de sistemas capaces de incorporar la experiencia encarnada, la dinámica interpersonal y la retroalimentación social en los procesos diagnósticos y terapéuticos dificulta la evolución de una atención verdaderamente participativa y sensible al contexto (Bobes et al., 2012).

La presente tesis contribuye a abordar estas deficiencias ofreciendo un análisis estructurado y multiescalar de las barreras sistémicas y las palancas operativas, basado en el trabajo de campo empírico y la investigación comparativa de políticas. No lo hace proponiendo reformas abstractas, sino trazando configuraciones concretas a través de las cuales surgen mejores prácticas y se vuelven sostenibles dentro del tejido legal e institucional existente. Este enfoque se alinea con los actuales esfuerzos europeos e internacionales por recalibrar la atención psiquiátrica como una tarea fundamentalmente ética y científica, que debe responder a las realidades vividas por las personas a las que atiende y al conocimiento generado en las distintas disciplinas, profesiones y comunidades afectadas (Ortiz Lobo, 2013; Carbonell Marqués y Navarro-Pérez, 2019).

1.7 Fundamentos teóricos: poder, diagnóstico, exclusión y resistencia

Los fundamentos teóricos de esta tesis se basan en el reconocimiento de que la psiquiatría no solo funciona como disciplina clínica, sino también como institución reguladora que participa en la distribución y legitimación del poder en las sociedades contemporáneas. El diagnóstico no es simplemente un acto de clasificación. Es un mecanismo de ordenamiento social, asignación de recursos y formación de sujetos. A través del diagnóstico, los individuos se posicionan dentro de jerarquías de credibilidad, capacidad legal y elegibilidad terapéutica. Estas posiciones no son epistémicamente neutrales. Están condicionadas por desigualdades estructurales, expectativas culturales y exigencias institucionales. Como tal, el diagnóstico opera como un acto político con consecuencias materiales, que configura las trayectorias de vida, los derechos sociales y la participación cívica. Las categorías psiquiátricas, en particular las utilizadas para justificar intervenciones involuntarias o tratamientos farmacológicos a largo plazo, conllevan supuestos implícitos sobre la agencia, la racionalidad y el cumplimiento. Estos supuestos suelen reflejar modelos normativos de comportamiento y cognición que no tienen en cuenta la experiencia vivida de angustia, trauma o adversidad sistémica. Esta posición teórica requiere un cuestionamiento continuo de la relación entre la atribución diagnóstica, la práctica institucional y la exclusión social (Moncrieff, 2013a; Moncrieff, 2013b).

Un elemento central del análisis es el Marco de Poder, Amenaza y Significado, desarrollado por Lucy Johnstone y Mary Boyle, que reconceptualiza las dificultades de salud mental como respuestas comprensibles a experiencias adversas, contextualizadas dentro de configuraciones específicas de poder, amenaza y significado. El marco ofrece una alternativa al diagnóstico basado en los síntomas, al enfatizar el papel de las dinámicas de poder en la configuración del malestar y la importancia de construir narrativas personales que den sentido a la experiencia. En lugar de preguntar qué le pasa a una persona, se pregunta qué ha pasado, a qué amenazas se ha enfrentado, qué significados se le han dado y qué fortalezas se han utilizado para sobrevivir. Esta orientación se alinea con la orientación empírica de la presente investigación, que privilegia las narrativas situadas, el análisis longitudinal de las interacciones institucionales y la reflexión crítica sobre la autoridad epistémica. También proporciona un ancla metodológica para la inclusión de la anamnesis relacional como forma válida de producción de conocimiento. La anamnesis no se entiende como un recuerdo de síntomas discretos, sino como una reconstrucción de las condiciones sociopolíticas en las que surgió el malestar y se medicalizó. Desde este punto de vista, la historia clínica no es una cronología pasiva, sino una negociación activa del reconocimiento, la legitimidad y la atención (John Read y Harper, 2020; Johnstone, 2020; Rådmark et al., 2024).

La institucionalización del conocimiento psiquiátrico se ha producido en el marco de una historia más amplia de formación del Estado, expansión jurídica y estandarización biomédica. La psiquiatría ha funcionado históricamente como un aparato de delimitación, separando la normalidad de la patología y regulando el acceso a la participación ciudadana, la vida familiar y la capacidad jurídica. Su integración en los sistemas jurídicos, de bienestar y educativos le ha conferido un papel disciplinario que trasciende la clínica y opera a través de la documentación, la vigilancia y la toma de decisiones procedimentales. En este contexto, la exclusión no es un subproducto accidental de la práctica psiquiátrica, sino un resultado estructuralmente inscrito. Las etiquetas diagnósticas suelen servir de

justificación para la retirada de derechos, la imposición de intervenciones y la restricción de la personalidad. Estos efectos se intensifican en los casos en que la lógica institucional da prioridad a la eficiencia administrativa, el control clínico o la gestión de la reputación por encima de la alianza terapéutica o la recuperación definida por el paciente (Foucault, 2003).

La exclusión también es epistémica. El predominio de los modelos biomédicos privilegia formas específicas de producción de conocimiento, en particular los ensayos controlados aleatorios, los inventarios de síntomas y las medidas de resultados farmacológicos, mientras que devalúa los relatos experienciales, relacionales y socioculturales. Esta asimetría limita la legitimidad epistemológica de los pacientes, los familiares y los actores no clínicos, cuyas contribuciones suelen descartarse por subjetivas, anecdóticas o irracionales. A su vez, esta exclusión epistémica limita el potencial de los sistemas para aprender de los errores, responder a las variables contextuales o adaptarse a las necesidades cambiantes. El resultado es un entorno clínico en el que se puede infligir daño de forma procedimental y justificarlo normativamente, sin que ello dé lugar a reformas institucionales o medidas reparadoras. La resistencia al cambio en estas condiciones no es solo consecuencia de la ignorancia o la malicia, sino también del diseño estructural. La arquitectura institucional de la psiquiatría está configurada para mantener la coherencia, la previsibilidad y la autoridad, a menudo a costa de la capacidad de respuesta, la transparencia y la rendición de cuentas. Estas dinámicas no son exclusivas de la psiquiatría, pero se intensifican por su proximidad a los poderes coercitivos y su papel en la mediación de la desviación social, la seguridad pública y la capacidad civil (Watts, 2024).

En este marco, la resistencia debe entenderse tanto como un fenómeno empírico como un constructo teórico. La resistencia no solo se refiere a la contestación abierta por parte de personas sometidas a intervenciones psiquiátricas coercitivas, sino también a los actos a nivel micro de negociación, evasión y reinterpretación que tienen lugar en los encuentros clínicos (Lehmann, 1998b). Estas formas de resistencia se patologizan con frecuencia como incumplimiento o falta de comprensión, que son en sí mismas marcadores diagnósticos utilizados para justificar la intensificación de la intervención. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, estas acciones pueden interpretarse como estrategias de supervivencia, preservación narrativa y afirmación de la personalidad dentro de sistemas que niegan el pleno reconocimiento. La resistencia también puede surgir de forma colectiva, como en el caso de los movimientos de supervivientes, la defensa liderada por pares y la producción de conocimientos alternativos por parte de las comunidades afectadas. Estos esfuerzos constituyen un contradiscurso a la psiquiatría institucional y ofrecen pruebas empíricas de los fracasos epistémicos, éticos y clínicos de los paradigmas dominantes.

La persistencia de la resistencia, a pesar de su marginación, indica la insuficiencia de los modelos psiquiátricos actuales para abordar toda la complejidad del malestar mental. También cuestiona la legitimidad de los regímenes de intervención que no incorporan mecanismos reflexivos para evaluar sus propias consecuencias. Los enfoques teóricos que ponen en primer plano la resistencia, como la psiquiatría crítica, los estudios poscoloniales y el análisis interseccional, destacan la naturaleza situada de la autoridad clínica y el papel del contexto sociopolítico en la configuración de los resultados diagnósticos y terapéuticos (Lehmann, 2019a). Estas perspectivas revelan hasta qué punto las intervenciones psiquiátricas no son aplicaciones neutrales del conocimiento científico, sino que están integradas en relaciones de poder que median el acceso a los recursos, el reconocimiento y la

reparación. El estudio de la resistencia se convierte así en un imperativo metodológico, no solo para comprender cómo responden los individuos a la coacción, sino también para identificar las condiciones institucionales en las que es posible una atención ética, participativa y eficaz.

La resistencia también es interna a las propias profesiones clínicas. Entre los profesionales, el desacuerdo con los modelos farmacocéntricos o coercitivos dominantes puede adoptar la forma de prácticas alternativas, adaptaciones informales o el compromiso con enfoques dialógicos y basados en el trauma (Kenny et al., 2019). Sin embargo, estas formas de crítica interna suelen verse limitadas por protocolos institucionales, indicadores de rendimiento y marcos de responsabilidad que desincentivan la desviación de los procedimientos estandarizados. La tensión entre el juicio profesional y las expectativas burocráticas crea un espacio liminal en el que los clínicos con motivaciones éticas deben navegar entre obligaciones contrapuestas hacia los pacientes, las instituciones y las normas disciplinarias. La supresión de esta resistencia interna es indicativa de una rigidez sistémica más amplia y pone de relieve la necesidad de arquitecturas institucionales que permitan la deliberación, la retroalimentación y la modificación de la atención basada en principios. Por lo tanto, los marcos teóricos que abordan la resistencia deben incluir la posición estructural de los profesionales como agentes y sujetos de poder, situados dentro de organizaciones que producen y limitan las condiciones de posibilidad de una atención ética (Farberow, 2005; Leichsenring, 2019).

Esta tesis adopta una orientación teórica que sintetiza las ideas del Marco de Poder, Amenaza y Significado, el materialismo cultural y la antropología médica crítica para cuestionar las condiciones en las que la atención psiquiátrica se vuelve coercitiva, excluyente y resistente a la reforma. Estos recursos teóricos permiten un análisis multinivel de cómo se construyen, legitiman, cuestionan y transforman las prácticas institucionales. También proporcionan las herramientas analíticas necesarias para examinar cómo el diagnóstico no funciona como un hecho médico fijo, sino como un acontecimiento relacional moldeado por la historia, el poder y la interacción. El objetivo no es rechazar el conocimiento psiquiátrico, sino reconfigurar sus fundamentos epistemológicos, su articulación jurídica y su aplicación clínica de manera que reflejen la complejidad del sufrimiento humano y las exigencias éticas de la atención. Este marco sirve de base para el diseño de las preguntas de investigación, la estructura de la recopilación de datos y los criterios de evaluación de las prácticas institucionales. Fundamenta el trabajo empírico en un enfoque crítico pero constructivo, orientado a la identificación de vías de transformación que sean científicamente válidas, jurídicamente sólidas y éticamente sostenibles (Weiss y Somma, 2007; Johnstone y Boyle, 2018).

El enfoque teórico adoptado en esta investigación exige una estrategia metodológica capaz de registrar las relaciones de poder no como estructuras abstractas, sino como prácticas observables, normas procedimentales y experiencias vividas en lugares institucionales específicos. Requiere herramientas metodológicas que puedan documentar cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cómo se opera la exclusión y cómo se expresa y se reprime la resistencia. Estas exigencias requieren un diseño de investigación integrado, longitudinal y reflexivamente responsable. El siguiente capítulo esboza el marco metodológico desarrollado para cumplir estos requisitos. Presenta los fundamentos para el uso de la investigación-acción, la inmersión etnográfica, el análisis jurídico y la participación de las partes interesadas en el estudio de la gobernanza psiquiátrica. También describe cómo los principios articulados en esta sección —reciprocidad epistémica, escrutinio estructural y responsabilidad ética—

se traducen en prácticas de campo concretas, protocolos de recopilación de datos y procedimientos analíticos. El objetivo es garantizar que la investigación no solo observe los sistemas de atención, sino que contribuya de manera significativa a su transformación mediante la producción sistemática de conocimientos empíricamente sólidos, éticamente fundamentados e institucionalmente aplicables.

1.8 Marco analítico y metodología científica para el cambio estructural

Esta sección constituye el puente analítico y epistemológico entre la crítica diagnóstica de los sistemas psiquiátricos y la estructura metodológica desarrollada en el capítulo 2. La arquitectura que aquí se presenta es explícitamente transdisciplinar, ya que integra las dimensiones médica, jurídica, antropológica y computacional en un razonamiento científico coherente. Esta tesis no se limita a describir o informar sobre fenómenos. Construye un diseño de investigación capaz de transformar las prácticas clínicas e institucionales basándose en la documentación sistemática, la responsabilidad ética y el conocimiento traslacional. Para ello, la investigación moviliza un marco estratificado que alinea el objeto de estudio, la gobernanza psiquiátrica en España, con métodos capaces de captar su complejidad estructural.

Los fenómenos abordados no son discretos ni aleatorios, sino que están integrados en un sistema multidimensional de clasificación, intervención y contención. Estos mecanismos operan a nivel clínico, administrativo, jurídico y discursivo. La selección de los marcos se ha regido por la necesidad de construir no un estudio de un solo nivel o monodisciplinar, sino un modelo integrado que permita articular la evidencia científica con las normas jurídicas, las prácticas institucionales y las experiencias encarnadas de sufrimiento. El objetivo no es desarrollar una metateoría de la psiquiatría, sino permitir la producción de un conocimiento aplicado, evaluable y éticamente justificable.

Tabla 8. Cuatro niveles de análisis e integración en la arquitectura de la investigación

Nivel	Descripción
Teórico y epistemológico	Basado en enfoques bioculturales y transdisciplinarios, este nivel proporciona la base conceptual para interpretar la salud mental como una interacción de procesos corporales, sociales y ecológicos. Apoya el rechazo de los paradigmas reduccionistas y enmarca la integración de la antropología médica, la psiquiatría crítica y las teorías de la mente extendida.
Clínico y médico	Anclado en la ciencia traslacional, la práctica informada sobre el trauma y la psiquiatría nutricional, este nivel aborda las dimensiones fisiológicas y terapéuticas de la atención psiquiátrica. Apoya el análisis de los regímenes farmacocéntricos, los mecanismos de daño iatrogénico y los criterios para una desprescripción responsable.
Legal e institucional	Basado en marcos constitucionales, internacionales y de derechos humanos, este nivel cuestiona la coacción, la impunidad legal y los fallos sistémicos de la rendición de cuentas. Respaldar la crítica de la gobernanza psiquiátrica actual y apoya el diseño de sistemas de atención éticos y respetuosos con la ley.
Metodológico y computacional	Este nivel pone en práctica las dimensiones anteriores mediante la investigación-acción, métodos mixtos y técnicas computacionales emergentes, como el modelado bayesiano, el análisis de supervivencia y el mapeo de sistemas. Garantiza la coherencia interna y prepara el terreno para intervenciones replicables y escalables a través de la ciencia abierta y la reforma estructural basada en la evidencia.

Esta tabla resume los cuatro niveles de integración analítica desplegados en la investigación-acción, estructurando la estrategia metodológica, conceptual y aplicada de la tesis. Cada nivel informa la producción de evidencia, la interpretación y el compromiso sistémico hacia la reforma psiquiátrica.

El primer nivel de esta arquitectura, como se muestra en la tabla 7, es epistemológico. Partiendo de la perspectiva biocultural de la antropología médica, el trabajo reconoce que la salud y el sufrimiento están determinados por condiciones socioculturales, ecológicas e históricas, que interactúan con los procesos biológicos sin ser reducibles a ellos. La cognición incorporada y la teoría de la mente extendida informan el rechazo de los dualismos mente-cuerpo y apoyan el examen de la intervención psiquiátrica como algo integrado en interacciones específicas del contexto, no aislado dentro del cráneo o confinado al individuo. Estas premisas conceptuales se desarrollan aún más a través del compromiso con el Marco de Poder, Amenaza y Significado y la crítica de la injusticia epistémica, que sirven para descentrar la autoridad clínica y reposicionar a las personas afectadas como agentes epistémicos legítimos. Estos marcos no son estáticos ni decorativos, sino operativos. Dirigen la lógica de la formulación de problemas, la selección de unidades de análisis y la interpretación del material empírico. También sirven como correctivos contra el extractivismo epistémico, garantizando que las prácticas metodológicas no reproduzcan las mismas dinámicas de poder que la investigación pretende exponer. Se basan en tradiciones de investigación establecidas y están sujetos a la transparencia metodológica, proporcionando el andamiaje teórico necesario para evaluar tanto los daños como las posibles reorientaciones en los sistemas psiquiátricos (Field-Springer, 2020).

Tabla 9. Dimensión biológica de los marcos analíticos y aplicados

Componente	Descripción
Ciencia médica traslacional	Conecta la práctica clínica con los mecanismos neuroendocrinos, inmunológicos, moleculares y metabólicos relevantes para los síntomas psiquiátricos y la respuesta al tratamiento.
Psiquiatría nutricional	Investiga el papel de la dieta, los micronutrientes, la inflamación, el eje intestino-cerebro y la regulación metabólica en la salud mental.
Psiconeuroendocrinoinmunología	Explora la interacción entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico en procesos de estrés, trauma y recuperación.
Ciencia de la desprescripción	Evalúa las mejores prácticas para la reducción o la suspensión de tratamientos psicofarmacológicos a largo plazo, basándose en la seguridad biológica, la eficacia y los resultados centrados en el paciente.
Fisiología de «una sola salud»	Integra la salud humana, animal y ambiental para evaluar y abordar los riesgos sistémicos y los determinantes comunes de la vulnerabilidad biológica.
Sueño, biología circadiana y neurodesarrollo	Investiga los efectos fisiológicos de la higiene del sueño, la exposición a la luz y los ritmos diarios en la resiliencia mental, especialmente en niños y adolescentes.

Esta tabla presenta los marcos de referencia a nivel biológico utilizados en esta investigación-acción, aplicados por el investigador para examinar las vías fisiológicas del daño psiquiátrico, orientar los protocolos de desprescripción y apoyar las intervenciones traslacionales a lo largo de la tesis.

El segundo nivel de la estructura analítica es médico y clínico. Incorpora la ciencia médica traslacional, que conecta la observación clínica con los hallazgos de la biología molecular, la neuroendocrinología y la psicofisiología (tabla 8). Este enfoque permite a la investigación evaluar el impacto biológico de los regímenes de fármacos psiquiátricos, así como los posibles beneficios de las intervenciones no farmacológicas basadas en la fisiología, incluida la psiquiatría nutricional y el estudio de la dinámica neuroinmunitaria y hormonal (Sarella et al., 2023). El uso de la atención informada sobre el trauma y la medicina narrativa amplía el alcance del análisis más allá del tratamiento de los síntomas, apoyando el reconocimiento de la experiencia vivida y el contexto biográfico como datos médicamente relevantes. Estos marcos no descartan la farmacología, sino que reubican su papel dentro de una comprensión más amplia de la salud que hace hincapié en la causalidad, la recuperación y los resultados a largo plazo no perjudiciales. Desde este punto de vista, la atención psiquiátrica debe evaluarse en función de sus efectos sobre la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida, y no solo en función de la reducción de los síntomas. Dentro de este nivel clínico, los modelos relacionales y dialógicos de psiquiatría, en particular el diálogo abierto y las prácticas adyacentes, ofrecen vías basadas en la evidencia que enfatizan la continuidad, la transparencia y la confianza, como se enumera en la tabla 9. Estos modelos no son plantillas prescriptivas, sino sistemas dinámicos que dan prioridad a la participación y al contexto, en consonancia con normas internacionales como las promovidas por la Organización Mundial de la Salud a través de su iniciativa QualityRights, y son ampliamente reconocidos como mejores prácticas que deben promover las Naciones Unidas a escala mundial, el Consejo de Europa en nuestra Unión, así como la mayoría de las asociaciones de usuarios y profesionales que trabajan en la aplicación de mejores formas de curar y recuperar (Fuller et al., 2022). Estas normas exigen la eliminación de las prácticas coercitivas, la integración de la toma de decisiones centrada en la persona y la construcción de entornos de atención

que respeten la dignidad y la equidad procesal. Esta investigación incorpora dichos principios no solo como referencias normativas, sino como variables empíricas, lo que permite evaluar el cumplimiento y las desviaciones en entornos reales (Zanardo y Ventura, 2023).

Tabla 10. Dimensión psicológica de los marcos analíticos y aplicados

Componente	Descripción
Teoría de la mente extendida	Enmarca la cognición como distribuida entre el cerebro, el cuerpo, las herramientas y el entorno, ofreciendo un modelo no reduccionista de la experiencia psiquiátrica.
Cognición incorporada	Destaca el papel de los procesos sensoriomotores e interoceptivos en la configuración de la función emocional y cognitiva.
Atención informada sobre el trauma	Incorpora las consecuencias psicológicas de la violencia, el abandono y el estrés crónico en los protocolos de evaluación y tratamiento.
Medicina narrativa	Utiliza la creación de significado autobiográfico como herramienta diagnóstica y terapéutica, restaurando la agencia a través de la narración estructurada.
Marco de poder, amenaza y significado	Sustituye el diagnóstico por una comprensión contextualizada de las estrategias de supervivencia, las dinámicas de poder y el significado subjetivo.
Mentalización y capacidad relacional	Examina el desarrollo psicológico de la función reflexiva, la empatía y el apego seguro como requisitos previos para la salud mental.

Esta tabla enumera los modelos de nivel psicológico utilizados a lo largo del trabajo de campo y el análisis de la tesis para interpretar la experiencia subjetiva, permitir la comprensión compartida y reconstruir el significado en contextos de violencia psiquiátrica y recuperación.

Por lo tanto, la evaluación de la práctica clínica no se limita a las métricas de resultados, sino que incluye dimensiones procedimentales, éticas y relacionales. Esto requiere la articulación de métricas que sean sensibles a la reducción del daño, la inclusión social y la salud a largo plazo, más allá de la resolución inmediata de la crisis o la contención farmacológica. La validez científica de las intervenciones psiquiátricas debe juzgarse por sus efectos acumulativos sobre el desarrollo humano, especialmente en los casos en que se ha normalizado el daño iatrogénico. Esto exige una ciencia clínica rigurosa y reflexiva, capaz de replantearse sus propios criterios de eficacia y adecuación.

La tercera dimensión de la arquitectura analítica se centra en los marcos jurídicos, estructurales y políticos, que no se tratan como apéndices externos, sino como parte integrante del funcionamiento y la reproducción de los sistemas psiquiátricos, como se muestra en la tabla 10. Las prácticas coercitivas en psiquiatría no son el resultado de la negligencia individual, sino de la permisividad legal y el diseño institucional. Esta tesis realiza un análisis riguroso de los regímenes jurídicos que autorizan el tratamiento involuntario, restringen la capacidad de acción de los pacientes y facilitan la impunidad estructural. El derecho constitucional español, la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos y los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proporcionan la base normativa para dicho examen (Organización Mundial de la Salud, 2020). Estos instrumentos jurídicos exigen una reconfiguración de la atención que reconozca la igualdad de capacidad, prohíba los tratos degradantes e institucionalice las garantías para la toma de decisiones informadas y respaldadas. La tesis evalúa en qué medida se incumplen estas obligaciones y documenta las deficiencias estructurales y procedimentales que perpetúan los daños bajo la apariencia

de cuidados. Más allá de las leyes y políticas individuales, el trabajo cuestiona la lógica administrativa y la inercia burocrática que estabilizan las prácticas perjudiciales. La complicidad institucional se examina como una característica sistémica, no como una aberración, revelando cómo los tribunales, las autoridades sanitarias y los sistemas educativos actúan de forma concertada para imponer soluciones farmacológicas como sustitutos de los cuidados. La rendición de cuentas pública se aborda no como un objetivo normativo, sino como una variable empírica, sujeta a fuerzas estructurales, resistencia política e intereses profesionales. Esto requiere un análisis jurídico que incluya tanto el escrutinio doctrinal como la etnografía institucional, captando cómo se interpretan, eluden o suspenden los derechos en la gobernanza clínica cotidiana (Gaete y Fritsch, 2021; Davies, Read y McKeown, 2022).

Tabla 11. Dimensión social de los marcos analíticos y aplicados

Componente	Descripción
Educación en salud única	Promueve el conocimiento integrador y la alfabetización en materia de atención sanitaria en las escuelas, las comunidades y las redes profesionales.
Investigación-acción y diseño colaborativo	Involucra a las personas afectadas y a los profesionales en procesos colaborativos para identificar, implementar y evaluar el cambio sistémico.
Derechos de las personas con discapacidad y marcos jurídicos	Alinea la práctica psiquiátrica con el derecho internacional de los derechos humanos, promoviendo la toma de decisiones con apoyo y la autonomía.
Alfabetización en salud pública y transparencia institucional	Aboga por la información accesible, la gobernanza participativa y la rendición de cuentas en los sistemas de salud mental.
Psiquiatría relacional y dialógica	Centra la atención en las relaciones interpersonales, la continuidad y el entendimiento mutuo, incluyendo modelos como el diálogo abierto.
Reforma cultural y educativa	Incorpora valores éticos y promotores de la salud en los planes de estudio escolares y los programas universitarios para prevenir la coacción y la exclusión en el futuro.

Esta tabla presenta los marcos sociales y los enfoques basados en políticas aplicados durante la investigación-acción para rediseñar los sistemas de atención, promover el cumplimiento de la ley e involucrar a las estructuras educativas y públicas en una reforma sostenida.

En este contexto, los modelos de toma de decisiones con apoyo, las directivas anticipadas y los mecanismos de rendición de cuentas arraigados en la comunidad se presentan como necesidades científicas y jurídicas, y no como reformas opcionales. Su integración se evalúa a la luz de las capacidades institucionales existentes, las dinámicas de resistencia y el cambio epistemológico necesario para reposicionar los relatos de los pacientes como fuentes válidas de conocimiento y legitimidad jurídica. El objetivo es identificar tanto los obstáculos como los puntos de partida para la reforma, basándose en datos empíricos y en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Esta perspectiva jurídica e institucional es esencial para comprender no solo qué falla en la atención psiquiátrica, sino también por qué persiste a pesar de las pruebas, y qué condiciones sistémicas deben cambiar para permitir la reparación y la transformación.

El cuarto componente de este andamiaje analítico, en fase de desarrollo en el momento de la impresión de esta tesis, se refiere a los sistemas computacionales y metodológicos capaces de

capturar, modelar e intervenir en las complejas realidades documentadas a lo largo de la investigación. Si bien la base empírica principal sigue siendo etnográfica y jurídica, la agenda de investigación más amplia, ya iniciada a través de datos piloto y colaboraciones institucionales, incorpora marcos computacionales avanzados diseñados para garantizar la escalabilidad, la replicabilidad y la precisión aplicable en la reforma del sistema de salud mental. Estos marcos no son auxiliares, sino fundamentales para la intención traslacional de la tesis, ya que anclan la posibilidad de rediseñar el sistema en arquitecturas empíricas y estadísticamente sólidas. Se propone el modelado estadístico bayesiano como herramienta central para evaluar las trayectorias clínicas, estimar los efectos del tratamiento, simular intervenciones preventivas basadas en agentes y también simular políticas más amplias. Su lógica probabilística permite incorporar la incertidumbre, la heterogeneidad y las retroalimentaciones dinámicas, ofreciendo un modo de análisis más preciso y éticamente sensible que los modelos deterministas o puramente lineales. Paralelamente, se introducen metodologías de análisis de supervivencia para evaluar los resultados de los tratamientos a lo largo del tiempo, en particular en relación con la adherencia a la medicación, las recaídas y la mortalidad en regímenes coercitivos. Estas herramientas están diseñadas para poner de manifiesto las consecuencias a largo plazo y las interdependencias que, de otro modo, quedarían ocultas en estudios a corto plazo o transversales. Además de los modelos inferenciales, el marco de investigación incorpora el mapeo de sistemas y el modelado de inferencia causal para representar las interacciones institucionales, las asimetrías de poder y los bucles de retroalimentación dentro de los sistemas de atención psiquiátrica. Estos métodos permiten identificar formalmente los puntos de influencia en los que las intervenciones específicas pueden producir cambios estructurales. En lugar de tratar las instituciones como entornos estáticos, los modelos las reconocen como sistemas dinámicos moldeados por fuerzas legales, culturales, clínicas y políticas. Esto se ajusta a la base biocultural y de investigación-acción de la tesis, que exige herramientas capaces de rastrear tanto la experiencia situada como las consecuencias macrosistémicas (Cook et al., 2019).

Aunque la tesis se centra principalmente en datos cualitativos, narrativos y de campo, sitúa explícitamente estos elementos dentro de una infraestructura traslacional más amplia. Esta arquitectura ya se está construyendo a través de la acción COST «¹» (Atención psiquiátrica y salud mental en el contexto de la migración y la salud de las personas con discapacidad), que se estableció como continuación directa de esta investigación doctoral para garantizar su sostenibilidad. Los proyectos en desarrollo incluyen prototipos de sistemas expertos, herramientas de apoyo a la toma de decisiones y plataformas de seguimiento integradas diseñadas para incorporar la atención basada en los derechos en entornos clínicos y educativos. Así, el trabajo preliminar realizado en esta tesis se incorpora directamente a una agenda de investigación europea coordinada, que busca no solo criticar los fallos sistémicos, sino también diseñar conjuntamente alternativas replicables, validadas y éticamente defendibles, basadas en datos y en la gobernanza participativa (Frerichs et al., 2016).

Este último segmento de la sección 1.9 consolida el papel de la tesis como investigación científica independiente y como plataforma de lanzamiento para una transformación sistémica más amplia. La

¹La acción de coordinación científica y tecnológica COST de la UE, fundada por el investigador como vía principal para la acción o la investigación-acción, dedicada a la educación en materia de salud única, en el momento de la impresión de esta tesis abarca más de veinte países con una red de unos quinientos expertos dedicados bajo su liderazgo: <https://health.int.eu.org/>

investigación, aunque se basa en una práctica académica rigurosa y se guía por marcos epistemológicos, clínicos y jurídicos definidos, también ha generado vías operativas para su aplicación. Estas se formalizan a través de la acción COST «²» (Aplicación de la investigación en la práctica de la salud y la seguridad) de la UE BEACON One Health Education, que proporciona un entorno estructurado para la continuidad, la ampliación y la coordinación institucional más allá del alcance inmediato de la tesis. Esta continuidad no es un complemento, sino un resultado intencionado de la metodología de investigación-acción, que postula que el conocimiento válido debe ser capaz de informar y dar forma a las prácticas dentro de los sistemas que pretende transformar.

La tesis ha catalizado varias líneas de investigación interrelacionadas que ahora se han convertido en propuestas a gran escala para Horizonte Europa. Entre ellas se incluyen proyectos centrados en la salud cognitiva en las escuelas mediante rutinas estructuradas de ejercicio, sueño, nutrición y suplementación; iniciativas de salud ambiental dirigidas a la exposición a neurotóxicos en la infancia; reformas basadas en los derechos de los sistemas de salud mental infantil y adolescente, basadas en la toma de decisiones compartida y la atención relacional; y mecanismos de tutoría institucional para fomentar el sentido, la responsabilidad y la seguridad en los entornos educativos y clínicos. Cada una de estas propuestas se deriva conceptual y empíricamente de los hallazgos, marcos y necesidades identificados en esta tesis, y cada una aplica la estructura metodológica establecida en este capítulo a sistemas del mundo real.

Tabla 12. Dimensiones clave de la transformación del sistema de salud mental según QualityRights de la OMS

²Una acción COST de la UE es una red de investigación interdisciplinaria que reúne a investigadores e innovadores para investigar un tema de su elección durante cuatro años. Las acciones COST suelen estar formadas por investigadores del mundo académico, pymes, instituciones públicas y otras organizaciones relevantes o partes interesadas, con el fin de ampliar sus redes de investigación profesional y alcanzar un objetivo común: <https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/>

Dimensión de QualityRights de la OMS	Descripción y relevancia para la tesis
1. El derecho a un nivel de vida adecuado	Aborda la vivienda, la alimentación, el agua y las condiciones de vida como elementos fundamentales para la recuperación. Respaldar la crítica de la tesis sobre el descuido y el abandono socioeconómico dentro de los sistemas psiquiátricos.
2. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental	Respaldar la demanda de una atención basada en los derechos, informada sobre el trauma y no coercitiva. Orienta la transición propuesta de las prácticas farmacocéntricas a enfoques integradores y multidisciplinarios.
3. El derecho a la capacidad jurídica y la autonomía personal	Respaldar directamente el énfasis de la tesis en la toma de decisiones con apoyo, las instrucciones anticipadas y el rechazo del juicio sustitutivo en contextos psiquiátricos.
4. Libertad frente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes	Enmarca la medicación coercitiva, la hospitalización forzosa y la violencia epistémica como violaciones del derecho internacional. Refuerza el imperativo científico y ético de prevenir y reparar los daños.
5. El derecho a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad	Refuerza la agenda de investigación para la desinstitutionalización, los apoyos comunitarios significativos y las condiciones estructurales necesarias para la participación y la recuperación.

Esta tabla presenta los cinco temas centrales del marco QualityRights de la OMS tal y como se aplica en el proyecto de investigación-acción. Estas dimensiones estructuran la evaluación, la crítica y el rediseño de los sistemas de atención psiquiátrica, promoviendo la alineación con las normas jurídicas internacionales y la atención basada en la evidencia y centrada en la persona.

Esta investigación sigue el modelo «Una sola salud» como marco científico y de gobernanza integrado, que vincula los determinantes humanos, ambientales e institucionales de la salud a través de infraestructuras de conocimiento compartidas, incluidas salvaguardias éticas, mecanismos participativos y equipos de investigación multidisciplinarios, y está diseñada para generar evidencia del mundo real tanto a nivel individual como poblacional. Se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las normas QualityRights de la Organización Mundial de la Salud enumeradas en la tabla 11 anterior y el consenso internacional sobre la necesidad de implementar una atención adecuada, con perspectiva de género, cultural y sensible al trauma, personalizada a través de la diligencia debida y el estudio de las redes sociales, basada en los derechos y sensible al contexto, negando toda posibilidad de daño iatrogénico y la repetición de delitos contra los pacientes. Estos marcos ofrecen legitimidad científica, relevancia política y viabilidad operativa a los modelos analíticos desarrollados en el presente trabajo. Todo ello se revisará en el próximo capítulo, dedicado a la metodología.

Este capítulo ha esbozado las premisas conceptuales, jurídicas, clínicas y sistémicas sobre las que se construye la tesis, identificando los déficits estructurales, las distorsiones epistémicas y las prácticas institucionales que perpetúan el daño bajo la apariencia de la atención. Ha establecido la necesidad de un cambio paradigmático, basado no en ideales abstractos, sino en marcos científicos, jurídicos y participativos rigurosamente validados. A continuación, se presenta una articulación exhaustiva de cómo se implementan estos principios a través del trabajo de campo en múltiples sitios, la investigación-acción participativa y la realización de encuestas. Esta tesis doctoral plantea un imperativo científico y médico urgente: restaurar, preservar y mejorar el bienestar, la integridad y la autonomía de las personas en todos los ámbitos de la vida.

Capítulo 2 - Marco metodológico: investigación-acción y posicionalidad

2. Metametodología reflexiva y marcos metodológicos científicos

Esta tesis se ha construido a través de un proceso transdisciplinar y reflexivo, arraigado en la etnografía científica, la investigación-acción participativa y una concepción materialista del conocimiento como algo históricamente situado, políticamente limitado y éticamente imperativo. Lejos de ser una agregación pasiva de resultados, la estructura y el contenido surgieron a través de compromisos recursivos con el sufrimiento, la resistencia y la búsqueda de la verdad en condiciones de extrema adversidad. Los protocolos incluyeron el seguimiento paralelo de los datos de campo y las reflexiones analíticas; prácticas de ciencia abierta, como la documentación con marca de tiempo, los repositorios públicos y los bucles de retroalimentación de expertos; y la alineación constante con los mandatos éticos de la atención informada por el trauma, basada en los derechos humanos y con arraigo cultural. El orden de los capítulos y los resultados sigue tanto la finalización empírica de cada conjunto de datos como sus implicaciones sistémicas, y no la abstracción teórica (Subramani, 2019).

El diseño de la investigación, la implementación y la construcción narrativa se desarrollaron como sistemas vivos integrados en redes de atención, lucha y transformación sistémica. Esto implicó la construcción de una infraestructura digital, la coordinación de sistemas expertos, el mantenimiento del contacto con las poblaciones afectadas y la puesta en marcha de controles y equilibrios epistémicos continuos. La metodología respeta la idea fundamental de Paul Farmer: investigar en un ámbito de sufrimiento sin contribuir a aliviarlo es una traición (Farmer, 1999; Farmer, 2003). El resultado es una tesis que no es solo un documento científico, sino también un acto práctico de desafío contra la injusticia epistémica y la complicidad institucional, que ofrece transparencia metodológica como condición para la credibilidad y la responsabilidad ética.

2.1 Enfoque general y fundamentos metodológicos

El núcleo metodológico de esta tesis doctoral se basa en una base biocultural, transdisciplinar y de investigación-acción diseñada para generar conocimientos válidos, situados y transformables. La violencia psiquiátrica, la traición institucional y la gobernanza coercitiva de la salud no se conceptualizan como fallos episódicos, sino como fenómenos sistémicamente arraigados. En consecuencia, la investigación no opera dentro de los límites de los silos disciplinarios o los modelos teóricos abstractos, sino que despliega una metodología integrada que alinea los marcos clínicos, jurídicos, antropológicos y computacionales. Este enfoque es inductivo y se basa en epistemologías basadas en el campo, en las que el investigador se posiciona tanto como profesional como sujeto afectado. Sin embargo, la reflexividad se pone en práctica de forma científica, no sentimental, y la posicionalidad incorporada se trata como una fuente de acceso epistémico, no como un sesgo. Basándose en las contribuciones epistemológicas de Miranda Fricker y Kristie Dotson, la metodología pone de relieve la injusticia testimonial y hermenéutica como condiciones sistémicas que obstaculizan la producción y la recepción del conocimiento de los pacientes (Fricker, 2017). El

compromiso metodológico con la justicia epistémica no es retórico, sino que se aplica mediante una triangulación estructurada, procedimientos de codificación rigurosos y la validación de los encuestados, lo que garantiza que las perspectivas de los usuarios se incluyan de forma sistemática y no se incorporen de forma selectiva (Dotson, 2012).

Tabla 13. Antropología médica y violencia estructural

Fundamento metodológico	Experto	Por qué se incluye	Cómo se aplica en esta investigación
Antropología médica / Violencia estructural	Paul Farmer	Relacionó la desigualdad estructural con los resultados médicos; acuñó el término «violencia estructural».	Proporciona herramientas analíticas para conectar el abuso psiquiátrico con estructuras institucionales, económicas y legales más amplias
Antropología médica crítica	Nancy Scheper-Hughes	Documentó la violencia estatal e institucional a través de la etnografía en contextos clínicos	Ancla la investigación del sufrimiento encarnado y el borrado epistémico bajo la gobernanza psiquiátrica
Psiquiatría transcultural	Arthur Kleinman	Desarrolló modelos explicativos y el concepto de biología local	Apoya la comprensión sensible al contexto de las interacciones diagnósticas y terapéuticas
Psiquiatría narrativa / Antropología médica	Byron Good	Exploró los modismos de angustia y las representaciones narrativas de las enfermedades mentales	Utilizado para orientar los métodos interpretativos para analizar la experiencia subjetiva y las narrativas de recuperación

Académicos fundamentales en antropología médica y violencia estructural que informan el análisis etnográfico, clínico y epistémico. Su trabajo sustenta las herramientas conceptuales utilizadas para documentar el daño institucional, contextualizar las narrativas psiquiátricas y decodificar la patologización sistémica.

Esta estructura metodológica se basa en textos fundamentales de la antropología médica y la praxis de la salud global, incluyendo el espíritu participativo de Orlando Fals-Borda, la lente analítica biosociológica de Paul Farmer y la atención etnográfica a la violencia estructural y corporal desarrollada por Nancy Scheper-Hughes (Scheper-Hughes & Lock, 1987; Fals-Borda, 1988). Cada uno de estos marcos contribuye a la justificación transdisciplinar de la investigación, que no pretende describir acontecimientos aislados, sino exponer y reconfigurar el aparato multinivel de la gobernanza psiquiátrica en España. El enfoque empírico se extiende a entornos comunitarios, entornos clínicos, procesos administrativos e infraestructuras legales. Los datos se obtienen mediante métodos triangulados que incluyen observación participante prolongada, entrevistas semiestructuradas y abiertas, encuestas a grupos de partes interesadas y análisis de documentos archivísticos y legales. Estos materiales no se yuxtaponen simplemente, sino que se integran en una arquitectura analítica capaz de producir tanto hallazgos fundamentados como conocimientos estructuralmente aplicables. La metodología no está diseñada para confirmar hipótesis derivadas de modelos normativos de enfermedad mental, sino para extraer y evaluar patrones de daño, responsabilidad y recuperación dentro de la gobernanza psiquiátrica del mundo real. En lo que respecta a los principios básicos de la investigación-acción, estos se aplicaron a pesar de operar en condiciones que impedían la iteración institucional completa y la reconfiguración inmediata de las

prácticas sistémicas. Reconociendo las limitaciones de llevar a cabo una investigación estructural desde una posición académica no ejecutiva, el diseño de la investigación implementó los principios de observación participativa, compromiso dialógico, capacidad de respuesta reflexiva y bucles de retroalimentación basados en la evidencia en todos los ámbitos accesibles al investigador. En lugar de tratar la investigación-acción como algo contingente a la posesión de autoridad formal o influencia institucional, este proyecto la puso en práctica como un ethos metodológico, integrado en el diseño de los instrumentos, la estructuración del trabajo de campo, la coproducción de conocimientos y la transformación a largo plazo de los entornos de investigación.

El trabajo se integró desde el principio en estructuras colaborativas diseñadas para permitir el aprendizaje colectivo y el rediseño iterativo. Esto quedó ejemplificado por la acción de la red BEACON One Health Education de la UE, que surgió como una extensión traslacional de los principios epistémicos y estructurales articulados en la tesis (Freire, 2000). Durante un período de dos años, la propuesta fue objeto de múltiples revisiones, basadas en comentarios de profesionales, criterios de evaluación formales, prioridades de las partes interesadas y realidades de la implementación. El éxito final de la acción no fue el resultado de una ejecución lineal, sino de ciclos recursivos de redefinición, recalibración y responsabilidad epistémica, precisamente el modelo de iteración a nivel de sistema defendido en la tradición de la investigación-acción. Estos mismos principios iterativos se aplicaron en múltiples escalas del compromiso académico y clínico del investigador, incluyendo el perfeccionamiento de los instrumentos de encuesta, la estructuración de las relaciones de colaboración sobre el terreno, el diseño de actividades de divulgación pública y la revisión abierta por pares de las herramientas analíticas.

Tabla 14. Investigación-acción e investigación participativa

Fundamento metodológico	Experto	Por qué se incluye	Cómo se ha aplicado en esta investigación
Investigación-acción participativa	Orlando Fals-Borda	Pionero de la investigación-acción participativa; hizo hincapié en la coproducción de conocimientos y el empoderamiento de la comunidad.	Proporciona la base epistémica para la investigación ética y colaborativa que involucra a las personas afectadas en el diseño y la implementación de la investigación
Investigación-acción participativa crítica	Paulo Freire	Introdujo los métodos dialógicos y la toma de conciencia como elementos esenciales para la transformación social	Informa la dimensión política y educativa del diseño de la investigación-acción en los sistemas de salud mental
Diálogo democrático / Práctica reflexiva	Peter Reason	Avanzó en los ciclos de investigación participativa y el aprendizaje colectivo basado en la reflexión	Apoya los procesos de retroalimentación recursiva y la interpretación compartida de los datos de campo entre los grupos de participantes
Investigación-acción sistémica	Hilary Bradbury	Desarrolló un marco sistémico para la investigación-acción en los ámbitos de la salud, la educación y la gobernanza	Permite la integración entre escalas y el encuadre de la reforma institucional como un cambio sistémico integrado

Contribuciones fundamentales a los enfoques de investigación-acción participativa y sistémica aplicados en esta tesis. Estas figuras proporcionan la base epistemológica y práctica para el diseño de una investigación colaborativa, iterativa y éticamente situada en el contexto de la transformación del sistema psiquiátrico.

En este contexto, el investigador no asumió el papel de evaluador externo ni de diagnosticador omnisciente (Heron y Reason, 1997; Reason y Bradbury, 2001). Más bien, su papel se enmarcó como el de un actor integrado y epistemológicamente responsable, que documentaba y participaba simultáneamente en la construcción colectiva de significado, el replanteamiento institucional y la crítica estructural. La ausencia de control directivo directo sobre los protocolos clínicos o institucionales no se interpretó como una limitación de la integridad metodológica, sino como un reflejo de las condiciones reales en las que a menudo deben iniciarse las reformas. Por lo tanto, la orientación hacia la investigación-acción no se aplicó a través de ciclos formales de cambio implementado y reevaluación a gran escala, sino a través de la integración ética, el diseño metodológico conjunto y la aplicación coherente de prácticas de ciencia abierta. Todos los instrumentos de encuesta, los protocolos de campo y las estructuras analíticas se compartieron para que el público pudiera comentarlos, se sometieron a comentarios internacionales y se perfeccionaron de forma iterativa a la luz de la evolución de los contextos. A un nivel más detallado, la metodología de investigación-acción sirvió de base para la toma de decisiones adaptativa del investigador en respuesta a las condiciones sobre el terreno, la disponibilidad de los participantes, las barreras legales y el silencio institucional. Esto se manifestó en el esfuerzo sostenido por preservar la fidelidad epistémica en contextos adversos, documentar los daños con rigor metodológico y reorientar los resultados de la investigación hacia formatos utilizables y escalables capaces de orientar la corrección institucional. Estos esfuerzos incluyeron el diseño y la difusión de sistemas expertos de código abierto, vías de diagnóstico digital, protocolos de desprescripción basados en la evidencia y marcos de documentación legal y ética verificables públicamente. Cada uno de estos instrumentos se concibió no como un producto estático, sino como una herramienta modular sujeta al perfeccionamiento de la comunidad y a la validación práctica.

Las propias prácticas del investigador se rigieron por la misma lógica iterativa, con auditorías periódicas de las decisiones metodológicas, autoevaluaciones éticas y la incorporación de críticas de pares. Cuando faltaba el poder institucional para implementar el cambio, el investigador generó contraestructuras de verificación y protección a través de la afiliación a redes internacionales, grupos horizontales de pares y asociaciones profesionales comprometidas con los derechos humanos, la ciencia abierta y la reforma del sistema de salud mental. Estas constelaciones sirvieron como plataformas recursivas para la retroalimentación, el perfeccionamiento y la implementación distribuida. De este modo, el investigador mantuvo un modelo iterativo de investigación-acción alineado con la crítica sistémica, la coproducción de conocimientos y la preparación para la transferencia, a pesar de operar desde sistemas que siguen siendo estructuralmente resistentes a la transformación ética (Ramírez et al., 2024).

Este capítulo aplicado confirma que la investigación-acción, entendida correctamente, no depende únicamente de ciclos de implementación institucional y reevaluación. También puede realizarse mediante una lógica recursiva, la participación abierta, la transparencia basada en principios y la capacidad de respuesta adaptativa dentro de un trabajo de campo multinivel (McDowell et al., 2023). El principio fundamental, según el cual la investigación debe ser coproducida, situada y orientada hacia una transformación viable, con las víctimas en el centro de todas las preocupaciones, se

mantuvo operativo a lo largo de toda esta tesis, guiando su diseño, interpretación y agenda de transferencia.

El estudio también se alinea con el marco de «una sola salud» como sistema científico que integra los determinantes ecológicos, biológicos, tecnológicos y sociales de la salud, entre otros valores fundamentales transversales y formas de entender lo que está sucediendo (Simmons, 2025). La investigación aplica este principio no a nivel metafórico, sino a través de su arquitectura de datos, que vincula la interacción entre el intestino y el cerebro, la alteración endocrina y las respuestas neuroinmunológicas con las rutinas institucionales, las prácticas diagnósticas y los determinantes estructurales de la vulnerabilidad. La psiquiatría nutricional, la psiconeuroinmunología y la atención informada sobre el trauma se tratan como marcos científicamente establecidos y clínicamente relevantes que deben integrarse en la evaluación de las intervenciones psiquiátricas. La inclusión de la cognición incorporada y la teoría de la mente extendida permite rechazar los supuestos dualistas y reduccionistas que prevalecen en las clasificaciones psiquiátricas y los protocolos terapéuticos. La cognición no se limita al cerebro, sino que se expresa a través de configuraciones relacionales, materiales y culturales. Esta perspectiva no es filosófica, sino aplicada, y guía la interpretación de los testimonios, la selección de los parámetros clínicos y la cartografía de la violencia sistémica.

Tabla 15. Justicia epistémica e inclusión del conocimiento

Fundamento metodológico	Experto	Por qué se incluye	Cómo se aplica en esta investigación
Justicia epistémica	Miranda Fricker	Definiendo la injusticia testimonial y hermenéutica en la producción de conocimiento	Justifica la necesidad metodológica de reconocer las perspectivas de los pacientes suprimidas o descalificadas
Epistemología feminista negra	Kristie Dotson	Amplía el marco de la injusticia epistémica; hace hincapié en el silenciamiento estructural	Refuerza el análisis interseccional de la exclusión en entornos psiquiátricos y la interpretación de datos

Fuentes metodológicas del campo de la justicia epistémica y la epistemología feminista que respaldan la inclusión del conocimiento silenciado, desacreditado o excluido estructuralmente en el marco científico de esta tesis. Estas referencias guían la validación del testimonio de los usuarios y la protección contra el extractivismo epistémico.

La estructura metodológica de esta tesis se basa en la investigación-acción, no solo como marco participativo, sino como enfoque epistemológicamente necesario a la hora de investigar el daño sistémico y la violencia institucional. Siguiendo el trabajo fundamental de Orlando Fals-Borda, Paulo Freire y Peter Reason, la investigación sitúa la producción de conocimiento dentro de ciclos de investigación dialógicos, iterativos y socialmente integrados. Este enfoque exige la participación activa de las poblaciones afectadas, no solo como sujetos de investigación, sino como co-constructores de conocimiento y responsabilidad. En línea con las contribuciones de Hilary Bradbury a la investigación-acción sistémica, el proyecto integra bucles de retroalimentación multinivel y mecanismos de participación de las partes interesadas para garantizar que las ideas no se abstraigan de la práctica, sino que informen directamente las estrategias de reforma institucional y transformación de la salud pública. Este diseño de investigación-acción es éticamente responsable,

metodológicamente transparente y estructuralmente alineado con los objetivos del cambio del sistema psiquiátrico tal y como se articula en el modelo de gobernanza de «una sola salud» (Simmons, 2025).

Como complemento de esta estructura participativa, la base metodológica se inspira ampliamente en la antropología médica para rastrear las condiciones socioculturales e históricas en las que las prácticas psiquiátricas han normalizado la coacción, el silenciamiento diagnóstico y el abandono institucional. Las contribuciones críticas de Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes, Arthur Kleinman y Byron Good proporcionan el marco para interpretar el daño psiquiátrico como una manifestación de la violencia estructural incrustada en los sistemas legales, clínicos y epistémicos (Farmer y Kleinman et al., 2013). El modelo biosociológico de Farmer vincula los resultados de salud con determinantes macrosociales, y su concepto de violencia estructural subraya cómo las prácticas rutinarias en medicina pueden funcionar como instrumentos de dominación. Los relatos etnográficos de Scheper-Hughes sobre la brutalidad medicalizada y la degradación corporal revelan la necesidad de situar los actos psiquiátricos dentro de una matriz más amplia de negación burocrática y afectiva. Kleinman y Good, a través del desarrollo de modelos explicativos y expresiones idiomáticas del malestar, ofrecen herramientas para reconocer la pluralidad de las narrativas del sufrimiento que, de otro modo, se patologizan o se descartan dentro de los marcos biomédicos (Good, 1992; Good, 1994). Estos modelos antropológicos no se citan simplemente, sino que se ponen en práctica mediante marcos de codificación, análisis narrativo y la lógica interpretativa del trabajo de campo, lo que garantiza que el significado sistémico, la asimetría de poder y el lenguaje de los pacientes sigan siendo fundamentales para la interpretación de los datos.

Tabla 16. Evaluación de sistemas y análisis institucional

Fundamento metodológico	Experto	Por qué se incluye	Cómo se pone en práctica en esta investigación
Evaluación realista	Trisha Greenhalgh	Enfoques realistas aplicados a la evaluación de intervenciones sanitarias complejas	Estrategia de triangulación de fuentes y permite la interpretación de factores contextuales multinivel
Etnografía institucional	Howard Becker	Introdujo el concepto de jerarquías de credibilidad y la etiquetación de la desviación	Sirve de base para trazar un mapa de la clasificación psiquiátrica, la justificación administrativa y la complicidad institucional
Psiquiatría democrática / Crítica institucional	Franco Basaglia	Lideró la desinstitutionalización en Italia y replanteó la coacción como represión sistémica	Punto de referencia conceptual para la crítica de las instituciones psiquiátricas y las alternativas participativas

Contribuyentes clave a la etnografía institucional, la evaluación realista y la psiquiatría democrática. Sus metodologías informan el análisis multinivel de la tesis sobre la gobernanza psiquiátrica, la lógica administrativa y las estructuras de rendición de cuentas.

A nivel biológico y clínico, la investigación se centra en los avances contemporáneos en psiquiatría traslacional y ciencias de la salud metabólica para replantear las bases fisiológicas del sufrimiento mental y la recuperación. Se cuestiona de forma crítica el paradigma biomédico dominante, representado por el énfasis de Thomas Insel en los biomarcadores y los circuitos neuronales, en

particular en lo que respecta a sus tendencias reduccionistas y su incapacidad para producir resultados terapéuticamente eficaces. En respuesta a ello, la tesis integra alternativas científicamente validadas de los campos de la psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI), la psiquiatría nutricional y la psiquiatría metabólica. George Chrousos y Bruce McEwen proporcionan los fundamentos científicos para modelar el estrés crónico y la carga alostática como consecuencias biológicas medibles de la exposición psiquiátrica e institucional (McEwen y Wingfield, 2003; Chrousos, 2009). El trabajo seminal de Felice Jacka sobre los patrones alimentarios y la salud mental establece un vínculo sólido entre la ingesta de micronutrientes, la inflamación y la regulación del estado de ánimo, al igual que el ahora floreciente campo de la psiquiatría nutricional (Jacka et al., 2015). El marco metabólico de Christopher Palmer reinterpreta los trastornos mentales a través de la disfunción mitocondrial y la desregulación energética sistémica, ofreciendo un nuevo paradigma para comprender y revertir los síntomas farmacorresistentes, con la psiquiatría metabólica como un nuevo campo que está mostrando resultados espectaculares (Palmer et al., 2022). Estos modelos convergen con las contribuciones de Michael Berk (2011) sobre el estrés oxidativo y de John Cryan y Ted Dinan sobre las interacciones entre el microbioma y el cerebro, formando una arquitectura fisiológica multidimensional que apoya la desprescripción, la intervención nutricional y la restauración del equilibrio neurobiológico a través de medios no invasivos, todo ello dentro de una psiquiatría biológica adecuada, logrando la recuperación (Dinan & Dinan, 2023).

Yo mismo soy testigo del poder de estos nuevos paradigmas, ya que me fueron útiles para superar el daño del envenenamiento forzado que sufrí durante y después de las palizas, antes de que llegara lo peor, y aún me siguen ayudando. Todo se basa en el principio de mente sana en cuerpo sano, incluido el ejercicio: la psique resiste más en un cuerpo fuerte, bien alimentado, con la disciplina y el autocontrol de unos regímenes adecuados. En conjunto, estos marcos proporcionan no solo legitimidad científica, sino también funcionalidad metodológica para evaluar tratamientos, identificar daños acumulativos y diseñar estrategias restaurativas que integren la reparación fisiológica con la transformación estructural. Anclan el análisis clínico de este estudio en un modelo de salud que responde a la complejidad del mundo real, es biológicamente plausible, está guiado por la ética y es empíricamente comprobable. En lugar de sustituir una teoría por otra, este marco integrado crea una infraestructura metodológica capaz de captar y corregir los fallos intersectoriales de los paradigmas psiquiátricos dominantes.

En términos operativos, la arquitectura de la investigación se estructura en torno a cuatro niveles de análisis interdependientes: epistemológico, médico, jurídico y computacional. Estos niveles garantizan colectivamente la integridad metodológica y la aplicabilidad traslacional del estudio. El primer nivel, epistemológico, aplica un enfoque biocultural basado en la antropología médica, la ciencia cognitiva y la psiquiatría crítica. Conceptualiza el malestar mental y la resiliencia como productos de la interacción de fuerzas biológicas, ambientales, históricas y socioculturales. Este marco permite la integración científica de modelos como la cognición incorporada, la medicina narrativa y el Marco de Poder, Amenaza y Significado, todos ellos como parte de un todo congruente y eficaz para comprender los problemas reales que se plantean.

Tabla 17. Marcos de psiquiatría traslacional, nutricional, metabólico y fisiológico

Fundamento metodológico	Experto	Por qué se incluye	Cómo se aplica en esta investigación
Psiquiatría traslacional	Thomas Insel	Promovió los modelos basados en circuitos y el descubrimiento de biomarcadores biológicos en psiquiatría.	Referenciado críticamente en el análisis del cambio de la psiquiatría hacia el neuroreductivismo y la clasificación basada en biomarcadores
Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI)	George Chrousos	Definió la biología del estrés y sus vías immunoendocrinas	Sustenta los modelos biológicos basados en el trauma y los sistemas de respuesta al estrés integrados en el análisis clínico
PNEI / Estrés e inflamación	Bruce McEwen	Desarrolló el concepto de carga alostática en el estrés y la neuroplasticidad	Apoya la evaluación de las respuestas al estrés psiquiátrico crónico y los efectos a largo plazo del daño iatrogénico
Psiquiatría nutricional	Felice Jacka	Pionera en la investigación a gran escala que relaciona la calidad de la dieta y la salud mental	Proporciona una base empírica para las intervenciones dietéticas y el eje intestino-cerebro como factor de riesgo modificable
Psiquiatría metabólica	Christopher Palmer	Abogado por replantearse las enfermedades mentales a través de marcos mitocondriales y metabólicos	Aporta información sobre la plausibilidad biológica de la desprescripción y la intervención basada en nutrientes en casos resistentes al tratamiento
Psicobióticos / Eje intestino-cerebro	John Cryan / Ted Dinan	Introdujeron el concepto de psicobióticos y los efectos de la microbiota intestinal en el estado de ánimo y la cognición	Se integra en el análisis de la vulnerabilidad fisiológica y respalda mecanismos terapéuticos alternativos
Inflamación y psiquiatría	Michael Berk	Demostró la relación entre la inflamación, el estrés oxidativo y los síntomas psiquiátricos	Consolida los biomarcadores sistémicos como variables válidas en la modelización clínica y los protocolos éticos de desprescripción

Referencias científicas que respaldan el modelo médico traslacional de la tesis. Estos académicos contribuyen al análisis de las dimensiones neuroendocrinas, inflamatorias, nutricionales y metabólicas del malestar psiquiátrico y la recuperación, validando objetivos biológicos para la intervención no farmacológica, la desprescripción y la seguridad fisiológica de todo el sistema.

El segundo nivel, clínico y médico, aplica la ciencia traslacional para examinar el impacto biológico de las intervenciones psiquiátricas y las dimensiones somáticas de la recuperación. Se basa en pruebas de la psiquiatría nutricional, la psiconeuroinmunología y la atención informada sobre el trauma para evaluar los regímenes farmacológicos, los resultados funcionales y los efectos a largo plazo del tratamiento. En este caso, no se da por sentado que las prácticas psiquiátricas se basen en pruebas, sino que se someten a una evaluación crítica a la luz de los nuevos conocimientos biomédicos. Conceptos como la iatrogenia, la carga de la polifarmacia y la sustitución de síntomas se analizan mediante

documentación comparativa de casos, saturación teórica y evaluaciones de plausibilidad fisiológica. La atención se centra en la función, la autonomía y los resultados de salud, y el control de los síntomas se considera insuficiente como criterio de valoración clínico principal.

El tercer nivel, jurídico e institucional, examina los parámetros estructurales que permiten o inhiben las prácticas psiquiátricas coercitivas. Las garantías constitucionales españolas, la jurisprudencia europea y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se tratan como herramientas operativas para la evaluación empírica, y no como ideales jurídicos abstractos (Deshpande et al, 2020). La metodología incluye un análisis dual que combina la interpretación jurídica doctrinal con la observación etnográfica del comportamiento institucional. Documenta cómo se aplican, ignoran o distorsionan los marcos jurídicos en la gobernanza psiquiátrica. Lamentablemente, la tortura continuada impidió avanzar en este nivel, ya que el investigador apenas pudo empezar a arañar la superficie debido a la violencia a la que se enfrentó (Stover y Nightingale, 2000; Shaw, 2007; Russell, 2009).

El cuarto nivel, metodológico y computacional, se encuentra en fase de desarrollo activo, pero ya se ha incorporado a los siguientes pasos de esta investigación y a su vía de transferencia. Aunque no se han implementado plenamente en el cuerpo de esta tesis por la misma razón, estas herramientas se están diseñando y probando parcialmente a través de colaboraciones en curso. Los planes, que se están llevando a cabo a través de las acciones, incluyen prototipos de sistemas expertos para el apoyo a la toma de decisiones en la gestión de la medicación, modelos bayesianos para el análisis de las trayectorias de tratamiento y técnicas de análisis de supervivencia para evaluar los riesgos a largo plazo en condiciones coercitivas (Ben-Ari, 2002). Estos componentes permiten la escalabilidad futura de la investigación al traducir los resultados cualitativos en herramientas interoperables, replicables y a nivel de sistema. La integración del mapeo de sistemas, el modelado de inferencia causal y la simulación dinámica permite la identificación formal de los puntos de intervención y la cuantificación del daño en todos los ámbitos institucionales. Estos métodos son fundamentales para el programa de transformación estructural articulado en la investigación, que ancla la reforma no en la crítica ideológica, sino en sistemas estadísticamente válidos, éticamente gobernados y técnicamente viables. Aunque la fase de implementación legal, computacional y sistémica continúa más allá del alcance de esta tesis, su arquitectura está totalmente alineada con la justificación metodológica, el mandato institucional y el rigor científico del trabajo aquí presentado. También se está llevando a cabo un trabajo de campo para estudiar la continuidad de los servicios de salud mental domésticos y estructurales y la violencia social en Indonesia, a través de la labor para abolir el pasung (Patel, Williams y Kellezi, 2018).

2.2 Diseño mixto y multiescalar, triangulación de datos y resultados

La presente tesis doctoral adopta un diseño mixto y multiescalar para examinar la coacción psiquiátrica, la violencia médica y la impunidad institucional como fenómenos sistémicos que operan en los ámbitos personal, organizativo y jurídico. El estudio no se limita a casos individuales ni se abstrae en un análisis de políticas, sino que busca construir un relato basado en pruebas y con múltiples capas sobre cómo se produce, se normaliza y se resiste el daño psiquiátrico. La integración

de métodos cualitativos y cuantitativos, alineados con la investigación a nivel micro, meso y macro, fue impulsada por la complejidad estructural de las preguntas de investigación y la orientación biocultural del estudio en su conjunto (Farmer, Robinson, Elliott y Eyles, 2006).

Los métodos cualitativos, que incluyen el trabajo de campo etnográfico, las entrevistas en profundidad, la observación participante y la documentación reflexiva continua, fueron esenciales para captar las experiencias situadas de coacción psiquiátrica, degradación y silencio. Estas herramientas permitieron documentar la traición institucional, el daño relacional y las estrategias de supervivencia tanto en entornos clínicos como extraclínicos. Los diarios de campo y la observación integrada permitieron al investigador seguir los patrones sistémicos y la lógica institucional en tiempo real. Paralelamente, las encuestas abiertas con formatos de preguntas mixtas combinaron preguntas narrativas con preguntas categóricas, lo que dio lugar a un conjunto de datos híbrido con métricas descriptivas y testimonios cualitativos. Estos componentes cuantitativos no se trataron como pruebas independientes, sino como puntos de referencia distributivos y contrapuntos para los temas emergentes (Parker, 2007).

La triangulación de datos en esta tesis se logró mediante la integración de cuatro fuentes distintas: las respuestas a la encuesta proporcionaron patrones cuantificables y la frecuencia de las prácticas sistémicas en diversos grupos profesionales y de usuarios; los testimonios ofrecieron profundidad narrativa y relatos situados de experiencias vividas dentro de los sistemas psiquiátricos; los documentos legales permitieron verificar los procedimientos institucionales, poniendo de relieve las discrepancias entre los marcos normativos y la práctica real; y la experiencia personal, documentada a través de la observación reflexiva y la participación, proporcionó una visión crítica de los mecanismos de coacción e impunidad. Esta estrategia de múltiples fuentes permitió la validación cruzada de los resultados, reforzó la coherencia interna y garantizó tanto la solidez empírica como la sensibilidad contextual en la interpretación de los resultados (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe y Neville, 2014). El uso de ambas modalidades fue esencial para triangular los datos, evaluar la coherencia epistémica y preparar formatos escalables para su futura implementación. Cada una de las seis preguntas de investigación fundamentales articuladas en el capítulo 1 se operacionalizó mediante técnicas metodológicas específicas y se asignó a las escalas de análisis adecuadas:

Tabla 18. Alineación de las preguntas de investigación con los niveles analíticos, los métodos y su relevancia

Objetivo de la tesis	Pregunta de investigación alineada	Objetivo operativo	Nivel analítico	Métodos	Relevancia para la tesis
Apoyar los sistemas psiquiátricos capaces de corregir en tiempo real, rendir cuentas y preservar la	¿Qué formas de violencia sistémica y fallos institucionales se están produciendo en la gobernanza	Identificar y analizar los fallos estructurales, legales y epistemológicos en la atención psiquiátrica para desarrollar reformas	Meso y macro	Análisis jurídico, encuestas profesionales, revisión de documentos normativos	Ancla la investigación de las contradicciones entre las obligaciones legales y la práctica clínica habitual;

Objetivo de la tesis	Pregunta de investigación alineada	Objetivo operativo	Nivel analítico	Métodos	Relevancia para la tesis
integridad.	psiquiátrica y cómo pueden corregirse?	basadas en la evidencia			apoya la crítica institucional y el marco de reforma
Fomentar un cambio paradigmático del control farmacológico a modelos de atención integradores, interdisciplinarios y recíprocos.	¿Cómo se pueden integrar las pruebas clínicas y empíricas en los ámbitos biológico, psicológico y social de la salud?	Desarrollar y validar sistemas de retroalimentación, herramientas basadas en señales biológicas y mecanismos de evaluación dirigidos por los pacientes	Micro y meso	Codificación de testimonios, mapeo narrativo basado en el trauma, revisión de la literatura médica.	Justifica la integración de la teoría del trauma y los modelos fisiológicos; fundamenta la crítica biomédica y ética de los entornos psiquiátricos
Reajustar la psiquiatría con coherencia empírica, garantías legales y gobernanza participativa basada en los derechos	¿Cuáles son las condiciones que permiten el cambio institucional y la supervisión participativa de los sistemas psiquiátricos?	Implementar infraestructuras de transferencia, intervenciones políticas y supervisión participativa alineadas con los estándares internacionales	Micro, meso, macro	Análisis de encuestas, mapeo de políticas, prototipos de sistemas expertos	Informa el diseño traslacional de las intervenciones, se alinea con los Derechos de Calidad de la OMS y apoya la transformación de los sistemas éticos
Defender la justicia narrativa y prevenir el borrado epistémico dentro de los sistemas psiquiátricos	¿Cuáles son los mecanismos estructurales y epistémicos a través de los cuales se silencia, desacredita o neutraliza a los usuarios de servicios psiquiátricos como sujetos de conocimiento?	Construir modelos de análisis participativos para elevar la voz de los usuarios y reconstruir la legitimidad explicativa	Micro y meso	Etnografía, entrevistas, codificación narrativa, análisis del discurso institucional	Apoya el análisis de la injusticia epistémica y el reconocimiento metodológico del conocimiento silenciado o descalificado
Incorporar los derechos humanos y las garantías legales en el funcionamiento psiquiátrico	¿Cómo permiten o impiden los sistemas jurídicos nacionales (en particular el español) la atención psiquiátrica basada en los derechos y la reparación?	Poner de manifiesto las disparidades nacionales y regionales entre la legislación y la práctica psiquiátrica y apoyar reformas legales aplicables	Macro	Análisis jurídico constitucional e internacional, etnografía institucional	Fundamental para el marco jurídico-democrático de la tesis; permite la evaluación normativa de la gobernanza psiquiátrica
Desarrollar un marco científico abierto, reflexivo y verificable.	¿Qué tipo de estructura científica y metodológica se requiere para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad en la	Construir metametodologías bioculturales, flujos de datos transparentes y una arquitectura de sistemas éticos	Meso y macro	Documentación metametodológica, diseño de modelos computacionales, protocolos de ciencia abierta	Justifica el marco metodológico de la tesis y permite la futura implementación de sistemas científicos abiertos y con base ética

Objetivo de la tesis	Pregunta de investigación alineada producción de conocimientos psiquiátricos?	Objetivo operativo	Nivel analítico	Métodos	Relevancia para la tesis
----------------------	---	--------------------	-----------------	---------	--------------------------

Correspondencia analítica entre las seis preguntas de investigación fundamentales y los niveles, métodos y relevancia sistémica asignados dentro del diseño mixto y multiescalar. Cada pregunta se operacionalizó de acuerdo con su alcance analítico y sus requisitos metodológicos, garantizando la alineación con las dimensiones epistemológicas, legales, clínicas y traslacionales definidas en el capítulo 1.

La articulación de estas preguntas, como se ha señalado, no se llevó a cabo en condiciones académicas normales. Todo el proceso de investigación se desarrolló en condiciones de extrema adversidad, incluyendo el silenciamiento institucional, la exclusión profesional y la exposición personal continuada a una violencia que cumple múltiples criterios clínicos y legales de tortura psicológica. Estas condiciones dificultaron el acceso a los ciclos institucionales de retroalimentación, restringieron la continuidad del trabajo de campo y limitaron los mecanismos de coproducción que prescribe la investigación-acción. Sin embargo, en lugar de invalidar la investigación, estas realidades proporcionan el contexto fundamental para comprender su urgencia, sus limitaciones y su peso ético. Por lo tanto, la tabla debe leerse no solo como una matriz de planificación, sino como un mapa de resistencia bajo coacción, comprometido con la transparencia científica, la dignidad humana y la reparación estructural. En todos los casos, la alineación entre las preguntas, los métodos y los niveles garantizó la coherencia y la integridad científica en todo el proceso de investigación. El nivel micro capta los efectos vividos de la violencia psiquiátrica, la violencia diagnóstica, la fuerza y el silenciamiento epistémico a través de narrativas personales, trayectorias clínicas y resultados corporales de la investigación, otros profesionales, pacientes en general y otras víctimas y sus seres queridos. El nivel meso revela cómo instituciones como los hospitales públicos, los centros de salud, las oficinas del defensor del pueblo, los servicios de protección de la infancia y los órganos judiciales aplican, justifican o cuestionan las prácticas coercitivas siempre que es posible. El nivel macro contextualiza estos patrones dentro de los marcos constitucionales, la gobernanza sanitaria mundial y los paradigmas psiquiátricos transnacionales, incluyendo el papel de la Organización Mundial de la Salud, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las directivas de la Unión Europea.

La dialéctica inductivo-deductiva rige todo el proceso analítico en segundo plano. Los datos de campo, las narrativas, las observaciones y los testimonios generaron categorías fundamentadas y patrones interpretativos, que luego se contrastaron con marcos establecidos deductivamente: doctrina jurídica, taxonomías diagnósticas y normas sanitarias internacionales (Adorno y Horkheimer, 1944/2002). Cuando surgían disonancias, se realizaba una revisión o recalibración teórica. Esto permitió que el estudio fuera más allá de la confirmación o la falsificación y, en su lugar, funcionara como una investigación dinámica y abductiva sobre las condiciones de verdad a nivel del sistema y la viabilidad metodológica. La experiencia vivida de la tortura obligó a comprender de forma reflexiva las realidades más duras de la salud mental y de nuestra sociedad. En resumen, el diseño mixto y multiescalar de esta tesis no solo respalda la investigación, sino que constituye su forma ética,

científica y estructural. Permite que la investigación cumpla su imperativo fundamental: producir conocimientos capaces de identificar, cuestionar y reparar las condiciones en las que la atención psiquiátrica se convierte en un vector de daño institucional en lugar de un lugar de curación.

La arquitectura del estudio se configuró deliberadamente para garantizar la coherencia interna entre los métodos, los niveles de análisis y los objetivos epistémicos de la tesis. La justificación para combinar la etnografía, la observación participante y la investigación testimonial con encuestas estructuradas y categorización cuantitativa radica en la doble necesidad de respetar la complejidad de la experiencia vivida y, al mismo tiempo, permitir un mapeo sistemático de las prácticas institucionales y las fallas estructurales. Cada método se seleccionó por su capacidad funcional para interrogar capas particulares del aparato psiquiátrico, desde el malestar subjetivo hasta la permisividad macrolegal. La división en niveles micro, meso y macro que aquí se expone refleja no solo una conveniencia analítica, sino la realidad ontológica de la violencia psiquiátrica como un sistema distribuido y multinivel. La dialéctica inductivo-deductiva que rige el análisis garantizó que los resultados surgieran a través de una iteración recursiva: basados en relatos situados, cuestionados por marcos normativos y validados mediante triangulación teórica y jurídica. Al hacer explícita la alineación de las preguntas, los métodos y las escalas, el estudio asegura su rigor metodológico y refuerza su función principal, que no es describir el sufrimiento de forma aislada, sino conectarlo científico, jurídico y éticamente con las estructuras que lo producen y normalizan. Los límites de la autonomía, las opciones descartadas u ofrecidas, también están determinados socioculturalmente.

2.3 Instrumentos e infraestructura para la recopilación de datos

Esta investigación utilizó tres instrumentos de encuesta básicos, cada uno de ellos diseñado para recopilar datos situados, éticamente sensibles y estructuralmente relevantes dentro del panorama psiquiátrico español. Las encuestas se elaboraron con el fin de documentar las realidades vividas por los usuarios de los servicios de salud mental, sus familiares y los profesionales, al tiempo que funcionaban como herramientas de investigación-acción capaces de fomentar la reflexión, la crítica y la participación. Los tres instrumentos se adaptaron al contexto español, integrando marcos conceptuales de la antropología médica, el análisis jurídico y la ética clínica. Cada uno de ellos aportó una visión complementaria de las prácticas psiquiátricas, las jerarquías epistémicas y el comportamiento institucional.

El primer instrumento, *Esquizofrenia: un estudio sobre las etiquetas psiquiátricas*, era una versión adaptada de una encuesta validada anteriormente en el Reino Unido. La herramienta original, revisada y perfeccionada gracias a los comentarios de expertos interdisciplinarios, se modificó para reflejar las especificidades culturales, jurídicas e institucionales del contexto español. Su objetivo era examinar cómo los usuarios, familiares y profesionales experimentan, interpretan y cuestionan las etiquetas psiquiátricas, en particular la esquizofrenia y la psicosis. El instrumento incluía preguntas estructuradas junto con indicaciones narrativas, lo que permitía a los encuestados articular respuestas tanto categóricas como experienciales. Se recopilaron un total de unas cuatrocientas respuestas completas, que representaban una amplia gama de funciones dentro del ecosistema de la salud mental. La metodología permitió cuantificar las tendencias y recuperar testimonios cualitativos sobre el

estigma diagnóstico, el daño iatrogénico y la descalificación epistémica. Esta encuesta sirvió de base para una crítica sistémica de las prácticas de etiquetado y fue fundamental para poner de manifiesto sus consecuencias psicosociales e institucionales a largo plazo.

La segunda encuesta, *diálogo abierto en España*, se desarrolló específicamente para esta investigación en colaboración con médicos, educadores e investigadores involucrados en la promoción de la práctica dialógica en salud mental. Representó el primer intento a escala nacional de evaluar el nivel de conocimiento, la disponibilidad de formación y el compromiso institucional con el marco del diálogo abierto entre los profesionales de la salud mental españoles. El instrumento se difundió a través de redes profesionales nacionales, seminarios educativos y colaboraciones clínicas. Aunque su estructura era principalmente cuantitativa, la encuesta también recogió comentarios abiertos que reflejaban tensiones éticas, resistencia institucional y un interés emergente por modelos de atención alternativos. Como parte de una publicación revisada por pares, los datos derivados de este instrumento fueron sometidos a una rigurosa revisión científica y ahora constituyen una contribución documentada a la literatura nacional sobre psiquiatría dialógica. Su función dentro de esta tesis es doble: traza un mapa del estado actual del interés por la reforma dentro del sistema y ofrece pruebas empíricas de que la reforma es necesaria y ya está en marcha.

La tercera encuesta, *«Toma de decisiones compartida y gestión de la medicación»*, se diseñó para abordar las prácticas de prescripción psiquiátrica, el consentimiento informado, la autonomía y los retos de la desprescripción responsable. Su alcance abarcaba múltiples contextos psiquiátricos y grupos destinatarios, desde la atención aguda hasta los escenarios de tratamiento a largo plazo. La encuesta invitó a participar a usuarios de los servicios, cuidadores y profesionales de la salud mental, y estuvo activa durante 105 días. Se recibieron 90 respuestas completas, con una duración media de más de 40 minutos, lo que indica tanto la complejidad como el compromiso de los encuestados. La encuesta empleó una arquitectura mixta de ítems escalados y preguntas abiertas, lo que permitió la triangulación de perspectivas clínicas, éticas y experienciales. El diseño fue iterativo y evolucionó en respuesta a las pruebas piloto, los comentarios de los encuestados y la alineación con marcos internacionales como QualityRights de la OMS. Este instrumento ofreció una visión detallada de las deficiencias operativas y morales de los regímenes de prescripción actuales y esbozó alternativas profesionales y experienciales basadas en la atención centrada en la persona y en red.

Cada una de las tres encuestas se integró en una matriz más amplia de herramientas metodológicas, que incluía notas de campo etnográficas, documentos legales, testimonios clínicos y análisis del discurso institucional. Si bien cada encuesta abordaba un tema específico (validez diagnóstica y daño iatrogénico, práctica dialógica y gobernanza de los medicamentos), en la práctica no estaban aisladas. Su elaboración se coordinó para permitir la triangulación analítica: los conceptos clave, como la autonomía, la coacción, la confianza, el trauma y la responsabilidad compartida, se reflejaron en todos los instrumentos utilizando un lenguaje distinto pero interoperable. Este diseño permitió comparar entre sí los patrones epistémicos, las expectativas políticas y las normas profesionales. De este modo, las herramientas de la encuesta permitieron trazar un mapa compuesto de la práctica psiquiátrica como algo simultáneamente legal, clínico, social y relacional.

Tabla 19. Procesos de validación y garantías éticas de las tres encuestas de tesis

Título de la encuesta	Proceso de validación	Adaptación cultural	Medidas éticas y estrategia de consentimiento
<i>Esquizofrenia: un estudio sobre las etiquetas psiquiátricas</i>	Desarrollado y validado originalmente en el Reino Unido bajo la dirección del Dr. Suman Fernando y sus colegas. Adaptado y revalidado para el contexto español con la colaboración experta de investigadores supervivientes y profesionales de LoComún. El instrumento original contribuyó a los debates internos de ISPS International que llevaron a la organización a cambiar de nombre y abandonar el término «esquizofrenia».	Adaptación al español revisada para garantizar la claridad lingüística, la relevancia cultural y las prácticas diagnósticas locales.	Participación anónima, consentimiento informado dinámico integrado al inicio de la encuesta, con consulta a un comité asesor ético.
<i>Diálogo abierto en España: disponibilidad, formación y acogida</i>	Validado por un equipo de profesionales del diálogo abierto y investigadores académicos españoles, entre los que se incluyen formadores clínicos y expertos en implementación.	Lenguaje y encuadre adaptados para alinearse con la terminología, la historia de implementación y la cultura institucional del sistema sanitario español.	Consentimiento informado obtenido a través de la introducción de la encuesta; anonimato garantizado mediante herramientas de recopilación encriptadas.
<i>Toma de decisiones compartida y uso de medicamentos en psiquiatría</i>	Probado y validado por más de 100 profesionales y expertos internacionales. Contribución específica reconocida de Peter Lehmann, destacado experto alemán en desprescripción responsable y derechos de los supervivientes psiquiátricos.	Preguntas perfeccionadas mediante consultas iterativas con expertos para garantizar la traducibilidad y la relevancia en los contextos clínicos españoles y las perspectivas de los usuarios.	Consentimiento informado diseñado con opciones de actualización dinámica, protocolos de anonimización mediante almacenamiento cifrado y registros con marca de tiempo.

Tabla que resume los procesos de validación, las adaptaciones culturales y los protocolos éticos aplicados a los tres instrumentos centrales de la tesis. El enfoque hace hincapié en el rigor científico, la justicia epistémica y la práctica ética de la investigación en contextos marcados por la asimetría histórica y estructural.

El despliegue de estos instrumentos se llevó a cabo en condiciones de profunda precariedad institucional y de infraestructura. Los sistemas resultantes debían garantizar el anonimato conforme al RGPD, el registro de marcas de tiempo y el acceso cifrado, lo que ponía de relieve el nivel de autonomía operativa necesario para la investigación en terrenos éticamente sensibles pero sin apoyo estructural, y así lo hicieron, utilizando en su mayoría herramientas de código abierto o disponibles en las instituciones para recopilar respuestas de forma anónima. La primera encuesta, adaptada a partir de materiales del Reino Unido, sirvió como piloto para los principios participativos y la arquitectura de preguntas mixtas que se adoptaron posteriormente en todos los instrumentos. A continuación se llevó a cabo la encuesta de diálogo abierto, con énfasis en la divulgación a nivel nacional y la participación en las políticas, que dio lugar a una publicación revisada por pares. El instrumento final y más complejo, sobre la toma de decisiones compartida, consolidó las lecciones aprendidas de las

herramientas anteriores e incorporó disposiciones éticas avanzadas, solidez conceptual y alineación con los QualityRights de la OMS y los marcos internacionales de desprescripción. El perfeccionamiento de cada instrumento se incorporó al siguiente, formando un arco metodológico acumulativo que respaldó la estructura más amplia de investigación-acción de la tesis (Lehmann, 1998a; Lehmann, 2010).

Todos los instrumentos se elaboraron y validaron de acuerdo con los principios de la investigación-acción. Los borradores iniciales fueron revisados por paneles de expertos que incluían médicos, antropólogos, profesionales del derecho y supervivientes de la psiquiatría. Las pruebas piloto con los grupos destinatarios permitieron perfeccionar la claridad de los ítems, la adecuación cultural y el alcance conceptual. Las encuestas se hicieron accesibles a través de plataformas digitales y se superaron las barreras técnicas con adaptaciones de infraestructura para preservar la integridad y la accesibilidad de los datos (Ladkin, 2007). Cada instrumento incorporó procedimientos de consentimiento informado basados en principios de consentimiento dinámico. Se informó a los encuestados de los objetivos del estudio, su alcance, las medidas de protección de datos y las opciones de retirada. No se recopilaban datos personales identificativos y todas las respuestas se anonimizaron en el momento de su introducción. Dada la condición del investigador como persona con experiencia propia y superviviente, la supervisión ética incluyó protocolos reflexivos detallados y una revisión independiente por parte de académicos de alto nivel. La integración de los tres instrumentos se llevó a cabo utilizando técnicas temáticas, narrativas y comparativas (Lassiter, 2005). Si bien cada encuesta abordaba cuestiones distintas, como el etiquetado, la práctica dialógica y la gobernanza de la medicación, también funcionaban como herramientas de diagnóstico intersectoriales dentro de la arquitectura de investigación más amplia. El material cuantitativo y cualitativo recopilado a través de preguntas abiertas complementó los datos etnográficos y se utilizó para corroborar los hallazgos surgidos de la observación de los participantes, el análisis jurídico, los propios testimonios y la investigación basada en testimonios.

Las tres encuestas incorporadas en esta tesis se elaboraron y validaron mediante un riguroso proceso que combinó conocimientos clínicos, científicos y de experiencias vividas: la primera encuesta, sobre la etiqueta «esquizofrenia» (ISL), se desarrolló originalmente en el Reino Unido bajo la dirección del Dr. Suman Fernando y otros psiquiatras críticos y defensores de los supervivientes. Formaba parte de una investigación más amplia sobre las consecuencias epistémicas, sociales y clínicas de las etiquetas psiquiátricas y contribuyó de manera significativa al cambio de nombre de la ISPS, Sociedad Internacional para los Enfoques Psicológicos y Sociales de la Psicosis, que eliminó oficialmente el término «esquizofrenia» de su nombre en reconocimiento de su legado problemático y estigmatizante. La adaptación al español utilizada en esta tesis fue revisada y revalidada por expertos locales, cuyas contribuciones garantizaron la relevancia contextual, la claridad terminológica y la alineación epistemológica con la realidad clínica, jurídica y social española. Este proceso de validación incluyó tanto ajustes lingüísticos como calibración del contenido para evitar el refuerzo involuntario de la violencia diagnóstica o la distorsión cultural.

Profundizando en la primera gran encuesta en la que se basa esta tesis, la investigación coordinada originalmente en el Reino Unido por un distinguido equipo de supervivientes, profesionales y académicos críticos, entre los que se encuentran el profesor Suman Fernando, la Dra. Jayasree

Kalathil, el Dr. Philip Thomas y la Dra. Janet Wallcraft, encontramos una iniciativa sin precedentes para documentar sistemáticamente las consecuencias personales, institucionales y sociales de recibir un diagnóstico de supuesta esquizofrenia, con el objetivo de exponer sus efectos perjudiciales y cuestionar la legitimidad de su uso en los sistemas modernos de salud mental (Kalathil y Fernando, 2012). El ISL se elaboró a partir de una investigación basada en testimonios, en la que se invitó a participar a personas que habían vivido en primera persona la experiencia de la etiqueta, a sus familias y a profesionales de todo el Reino Unido. Se difundió ampliamente y sigue siendo un hito en la producción de conocimientos impulsada por los usuarios y supervivientes, ya que combina una profunda visión epistemológica con la urgencia política. El informe tuvo un impacto transformador en el discurso público y académico, y contribuyó a precipitar la decisión de la Sociedad Internacional para los Enfoques Psicológicos y Sociales de la Psicosis (ISPS) de eliminar la supuesta esquizofrenia de su nombre. También ayudó a consolidar un cambio de paradigma hacia alternativas a la psiquiatría diagnóstica basadas en el trauma, los derechos y la sensibilidad cultural.

Tabla 20. Grupo coordinador de la investigación sobre la etiqueta original de esquizofrenia, Reino Unido, 2014

Nombre	Función y breve biografía
Profesor Suman Fernando	Psiquiatra y pensador crítico en psiquiatría transcultural. Trabajó en Enfield durante más de 20 años; posteriormente fue nombrado profesor honorario de la London Metropolitan University. Formó parte de la Comisión de la Ley de Salud Mental (1988-1995). Autor de varios textos fundamentales sobre raza, cultura y salud mental, entre ellos <i>Mental Health Worldwide</i> (2014). Falleció recientemente, en 2023, dejando un profundo legado.
Dra. Jayasree Kalathil	Investigadora superviviente, escritora y fundadora del colectivo Survivor Research. Con experiencia personal en los servicios psiquiátricos de la India y el Reino Unido, ha publicado numerosos trabajos sobre salud mental, racialización y experiencias vividas. Coautora de <i>Values and Ethics in Mental Health</i> y editora de <i>The Sackcloth Man</i> , un libro infantil. Una voz destacada en los estudios sobre la locura.
Dr. Philip Thomas	Expsiquiatra consultor y cofundador de la Red de Psiquiatría Crítica del Reino Unido. Retirado de la práctica clínica, sigue escribiendo sobre cultura, poder y locura. Expresidente de Sharing Voices Bradford. Su trabajo hace hincapié en el contexto social e histórico del malestar, abogando por alternativas a la psiquiatría biomédica. Actualmente escribe un libro sobre psiquiatría crítica.
Dra. Janet Wallcraft	Usuaria de servicios de salud mental, investigadora y activista. Doctora en narrativas de hospitalización psiquiátrica. Investigadora en las universidades de Birmingham y Hertfordshire. Autora de <i>On Our Own Terms</i> y <i>Healing Minds</i> . Su trabajo se ha centrado en la autogestión, las terapias complementarias y la participación de los usuarios en la investigación. Aporta una rica perspectiva experiencial y académica a la reforma de la salud mental.

La versión española de esta investigación fue lanzada y adaptada de forma independiente por el presente investigador durante las primeras etapas de sus estudios de posgrado, antes del inicio oficial de este trabajo doctoral, con la colaboración de miembros del colectivo español LoComún (Fernández, 2018). Ampliamos el número de preguntas, adaptándolas a la realidad española. Sin embargo, fue metodológicamente coherente y éticamente alineada con el esfuerzo original, y se

convirtió en un componente central de la base empírica de esta tesis. La encuesta se distribuyó tanto en línea como por correo postal, siguiendo los principios de la ciencia abierta y la implementación técnica de código abierto. Se llegó a miles de personas en toda España, entre ellas profesionales, supervivientes, usuarios y familiares, gracias a un amplio esfuerzo de distribución a casi todos los centros públicos de salud mental, asociaciones de apoyo, algunos contactos directos y la mayoría de las redes activistas conocidas. Esta adaptación conservó la riqueza testimonial y la apertura crítica de la Investigación original, con preguntas centradas en el significado del diagnóstico, sus efectos percibidos, la experiencia de la coacción y las alternativas percibidas a los sistemas actuales. Se pusieron de relieve las voces de las personas marginadas y criminalizadas por las prácticas diagnósticas, contribuyendo así directamente a los objetivos fundamentales de esta investigación: denunciar la violencia sistémica, cuestionar el dominio epistemológico de la psiquiatría biomédica y promover un modelo de toma de decisiones compartida y autonomía del paciente basado en la ética, la dignidad y la justicia.

La segunda encuesta, centrada en *el diálogo abierto en España*, fue validada por un equipo nacional de profesionales e investigadores que participan activamente en la implementación, la difusión y la formación en materia de diálogo abierto. Su elaboración siguió un modelo consultivo basado en la experiencia vivida por los clínicos que participan en prácticas dialógicas, en particular los que participaron en reuniones nacionales y programas de formación de posgrado facilitados por el investigador. Dada la diversidad de vías institucionales a través de las cuales se ha introducido el diálogo abierto en España, la encuesta se revisó cuidadosamente para reflejar la heterogeneidad de las experiencias de implementación y las diferencias normativas regionales (Valtanen, 2019). En el contexto de España, donde el sobrediagnóstico, la sobremedicación y la institucionalización sistémica siguen siendo generalizados, el modelo de diálogo abierto ha surgido como una alternativa tanto terapéutica como sociopolítica. Proporciona un marco culturalmente arraigado y clínicamente viable para resistir la coacción y fomentar la responsabilidad colectiva. Se perfeccionaron las opciones terminológicas, las preguntas sobre el acceso a la formación y las barreras institucionales para mejorar la resonancia con el contexto profesional y administrativo español (Parrabera-García et al, 2023).

Antes de lanzar la encuesta, el equipo participó activamente en un censo nacional dirigido por HopEnDialogue³, un proyecto europeo que promueve las prácticas dialógicas en los sistemas de salud. El objetivo de este censo era documentar todos los profesionales, servicios e iniciativas informales relacionados con el diálogo abierto en España (Pocobello et al, 2025). Como parte de ese proceso, el investigador aportó una lista exhaustiva de contactos recopilados a lo largo de años de trabajo, que incluía a cientos de médicos, educadores, investigadores y activistas que habían expresado un interés sostenido en la atención dialógica. A través de este mapeo participativo, el equipo llegó a casi todos los profesionales del país que habían recibido formación o apoyaban el enfoque del diálogo abierto. El censo estableció una base de referencia, documentando la comunidad dispersa pero creciente de profesionales formados en el diálogo y su ubicación dentro de los servicios públicos y privados. Sobre la base de este trabajo fundamental, se conceptualizó la Encuesta a Profesionales del Diálogo Abierto como un esfuerzo empírico de segunda fase. Su objetivo no era

³HOPEnDialogue es un estudio colaborativo internacional para evaluar la eficacia del Diálogo Abierto en diversos contextos y apoyar a los centros que adoptan este enfoque. <https://www.hopendialogue.net/>

simplemente evaluar los conocimientos o el cumplimiento, sino explorar las tensiones vividas, los obstáculos éticos y el potencial latente de la atención dialógica en el panorama institucional, a menudo rígido, de España. Se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre después de la formación? ¿Cómo afrontan los profesionales el estrés moral, las contradicciones institucionales y las expectativas de los pacientes en la práctica diaria? La encuesta, diseñada y distribuida en 2023, se estructuró en torno a seis ejes temáticos: (1) exposición a prácticas coercitivas en las instituciones; (2) fidelidad a los principios dialógicos en la práctica; (3) tensiones éticas y resistencia institucional; (4) experiencias con la toma de decisiones compartida; (5) percepciones de la voz y la autonomía de los pacientes; y (6) barreras sistémicas y legales para la transformación. Se incluyeron un total de 35 preguntas, incluidas varias preguntas abiertas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa.

La tercera encuesta, «*Toma de decisiones compartida y uso de medicamentos en psiquiatría*», fue sometida al proceso de consulta internacional más amplio. Más de cien expertos, entre los que se encontraban psiquiatras de prestigio, científicos sociales, responsables políticos y usuarios supervivientes, aportaron sus comentarios. Cabe destacar la contribución de Peter Lehmann (2010), defensor de renombre internacional de la retirada de los fármacos psiquiátricos y de la gobernanza ética de los medicamentos, que aportó comentarios específicos que permitieron reforzar los apartados sobre la desprescripción responsable, la autonomía y la práctica informada sobre el trauma. Esta encuesta incorporó las mejores prácticas de la investigación mundial sobre la desprescripción y se ajustó para adaptarse a las tensiones particulares del sistema español, incluida la resistencia a la atención no farmacológica y la falta de directrices nacionales sobre la toma de decisiones compartida. Distribuida durante un debate nacional en curso sobre el uso responsable de los fármacos psiquiátricos, la encuesta presentó, entre otras preguntas, los siguientes escenarios que pusieron de relieve algunos de los puntos débiles y las fuentes de controversia del sistema actual:

Tabla 21. Escenarios hipotéticos de reforma en la encuesta de 2025, finalidad metodológica

Escenario	Descripción	Objetivo en la metodología de la encuesta
1. Implementar un cribado nacional de la sensibilidad al gluten en los diagnósticos psiquiátricos	Presenta una intervención emergente basada en la evidencia que requiere reconsiderar los diagnósticos psiquiátricos a la luz de los factores dietéticos.	Evaluar la disposición de los profesionales para integrar el cribado somático y las alternativas dietéticas en la toma de decisiones psiquiátricas, y valorar la viabilidad percibida de las vías de tratamiento no farmacológico.
2. Desprescripción de neurolépticos en casos de trastornos metabólicos y nutricionales no diagnosticados	Destaca las consecuencias de diagnóstico erróneo y la falta de coordinación médica en la desprescripción y cribado interdisciplinario en psiquiatría.	Explorar las actitudes de los profesionales hacia la coordinación médica en la desprescripción y la preparación estructural para la reevaluación diagnóstica basada en evaluaciones fisiológicas.
3. Abordar los casos de abuso psiquiátrico descubiertos a través de la investigación nacional sobre salud mental y violencia	Pone de manifiesto la negligencia sistémica del trauma y los daños iatrogénicos causados por el etiquetado psiquiátrico inadecuado.	Evaluar la conciencia sobre la violencia institucional y las dimensiones éticas de la toma de decisiones compartida en contextos de abuso psiquiátrico histórico, incluyendo opiniones sobre la reforma y la reparación basadas en el trauma.
4. Iniciativa nacional de desprescripción para pacientes de edad avanzada con alto riesgo de mortalidad y discapacidad	Se centra en los riesgos del uso de neurolépticos entre la población de anciana y en los imperativos de desprescripción respaldados por la OMS.	Captar la visión clínica de los protocolos de desprescripción específicos para cada edad, las preocupaciones en materia de seguridad y la responsabilidad profesional en contextos de vulnerabilidad y mitigación de riesgos.
5. Reevaluación de los diagnósticos psiquiátricos a largo plazo en una auditoría nacional	Cuestiona la validez de las etiquetas psiquiátricas a largo plazo y la inercia del tratamiento farmacológico crónico.	Examinar las opiniones de los encuestados sobre el re-diagnóstico, la corrección de errores históricos y la ética de la dependencia de la medicación a largo plazo basada en supuestos clínicos obsoletos.
6. Abordar la prescripción excesiva de neurolépticos en la asistencia social y las comunidades marginadas	Destaca las desigualdades estructurales en las prácticas de medicación para las poblaciones socialmente excluidas.	Evaluar la sensibilidad de los profesionales ante la discriminación sistémica en los patrones de prescripción y la capacidad de los servicios para avanzar hacia alternativas equitativas y basadas en la comunidad.
7. Revisión nacional del uso de neurolépticos en niños y adolescentes	Aborda los riesgos éticos y para el desarrollo del uso de neurolépticos en pediatría, menudo sin un diagnóstico diferencial suficiente.	Documentar las posturas profesionales sobre la desprescripción en poblaciones jóvenes, la relación riesgo-beneficio percibida y los apoyos educativos, familiares y sistémicos necesarios para transiciones más seguras.
8. Poner fin al uso de neurolépticos para indicaciones no psiquiátricas en medicina general	Cuestiona el uso rutinario pero clínicamente inadecuado de los neurolépticos en el contexto de los hospitales generales y la atención somática.	Evaluar la comunicación entre especialidades, el conocimiento de las directrices y los mecanismos de corrección de errores y desprescripción en entornos no psiquiátricos.

Esta tabla resume ocho escenarios hipotéticos incluidos en la encuesta nacional para explorar las respuestas de los profesionales a propuestas de reforma significativas desde el punto de vista ético, médico e institucional. Cada escenario se diseñó para suscitar reacciones ante las deficiencias sistémicas, que van desde las prácticas diagnósticas y la coordinación interdisciplinaria hasta la violencia institucional y la medicación excesiva, y para evaluar la disposición al cambio, el posicionamiento ético y la conciencia estructural. Los escenarios sirvieron como herramienta metodológica para examinar no solo las actitudes individuales, sino también la viabilidad percibida de implementar reformas basadas en los derechos y en la evidencia dentro de la práctica psiquiátrica y médica general.

En los tres instrumentos se dio prioridad a las garantías éticas. El consentimiento informado se aplicó de forma dinámica, proporcionando por adelantado información detallada sobre la finalidad, el uso de los datos y los protocolos de confidencialidad. Los encuestados podían abandonar la encuesta en cualquier momento y se garantizó el anonimato mediante plataformas de recopilación de datos

cifradas. La revisión ética siguió una estrategia de varios niveles que incluyó el asesoramiento informal de colaboradores internacionales y colectivos de investigación basados en los derechos, lo que compensó la ausencia de un apoyo institucional constante durante el periodo de estudio. Estas medidas de validación y éticas garantizan que las encuestas no se limiten a recopilar datos, sino que constituyan instrumentos de investigación-acción metodológicamente sólidos, adaptados al contexto y con una base ética. Estas encuestas proporcionaron no solo profundidad empírica, sino también legitimidad participativa a la tesis central de la tesis: que la psiquiatría en España debe pasar de estructuras coercitivas y opacas a sistemas de atención colaborativos, transparentes y basados en los derechos. A través de estos instrumentos, la investigación estableció un archivo polifónico de crítica institucional y propuestas constructivas, basado en una metodología científicamente sólida, éticamente robusta y culturalmente adaptada.

En las tres encuestas realizadas durante la investigación, el alcance combinado se extendió a varios miles de personas, lo que dio lugar a un total de aproximadamente siete mil respuestas: 400, 200 y 90, respectivamente. Esto incluyó una amplia difusión nacional en España y la participación específica de profesionales, usuarios y defensores de las redes pertinentes. Solo la encuesta final, centrada en la toma de decisiones compartida, la medicación psiquiátrica y la desprescripción, fue respondida en su totalidad por noventa profesionales y expertos, muchos de los cuales aportaron respuestas narrativas extensas. Según la duración media de las respuestas, más de 41 minutos, el tiempo acumulado dedicado a responder a este instrumento superó con creces las cien horas de aportaciones de expertos. Esto representa un formidable repositorio de conocimientos fundamentados, contextualizados y específicos de la profesión, apenas aprovechado en la presente tesis, ya que su riqueza es enorme y va más allá del tema de la tesis. La gran mayoría de los invitados a esta última encuesta eran miembros de la *Asociación Española de Neuropsiquiatría* (AEN)⁴, ampliamente reconocida como la principal asociación profesional de psiquiatría crítica y comunitaria en España, miembros del CIBER, la red nacional de excelencia en salud mental, y expertos españoles publicados en psiquiatría. La mayoría son autores respetados de artículos científicos revisados por pares y libros influyentes sobre la práctica psiquiátrica, la ética y la reforma sistémica. Sus contribuciones recogen los dilemas y barreras actuales del sistema psiquiátrico español, así como las mejores prácticas y propuestas de cambio estructural. Por lo tanto, estas encuestas constituyen más que herramientas de recopilación de datos: son instrumentos participativos de producción de conocimiento que generan un archivo multidisciplinar de alta densidad con información ética, clínica y sistémica indispensable para los objetivos traslacionales de esta tesis.

Además, se envió por correo electrónico una cuarta encuesta exploratoria informal a todas las organizaciones religiosas no cristianas oficialmente registradas en España, con el objetivo de recopilar datos indicativos sobre sus retos en materia de salud mental, marginación estructural y acceso a las prácticas espirituales en un contexto predominantemente moldeado por las normas cristianas y las instituciones públicas laicas. Las respuestas, aunque limitadas en número y distribuidas de forma desigual entre las diferentes tradiciones, ofrecieron información valiosa sobre las experiencias vividas por las minorías religiosas, incluyendo un pequeño número de comunidades

⁴La AEN es una sociedad científica y profesional española que promueve la atención ética, pública y comunitaria de la salud mental, la formación profesional y la investigación en este ámbito. <https://aen.es/la-aen/>

budistas, hindúes y otras comunidades internacionales no mayoritarias. El objetivo era evaluar cómo se sienten y cómo funcionan las minorías en el país. La mayoría de las organizaciones informaron de importantes limitaciones para acceder a espacios dedicados a la oración, la meditación o el retiro, a menudo enfrentándose a obstáculos burocráticos, resistencia vecinal o negligencia en la planificación municipal. Estas limitaciones se describieron como un factor que afecta directamente al bienestar psicológico, la cohesión de la comunidad y la transmisión intergeneracional de la identidad cultural. Esta encuesta se inspiró en el uso de salas sensoriales en algunos barrios de Suecia y en la necesidad de disponer de espacios seguros para meditar, relajarse y encontrar la paz interior, reflexionar y recogerse, en entornos urbanos, ambulatorios, abiertos a todo el mundo, más allá de la iglesia habitual. Aunque la muestra no era representativa en sentido estadístico, los resultados coincidían con temas más amplios de esta tesis sobre la invisibilidad estructural y la marginación epistémica de los grupos no dominantes. Los encuestados destacaron que la falta de reconocimiento institucional y de espacios culturalmente seguros para la contemplación o el cuidado espiritual contribuía al malestar, la alienación y la disminución de la capacidad de apoyar a los miembros que se enfrentaban a crisis de salud mental. Estos testimonios refuerzan la relevancia de un enfoque biocultural y basado en los derechos para la salud mental, que incluye la libertad de creencia, ritual y narrativa como elementos esenciales de la resiliencia psicológica y la dignidad humana. Los resultados de esta encuesta se presentarán en el capítulo 3, como parte de un mapeo empírico más amplio de la exclusión, el silenciamiento y las necesidades de atención no cubiertas en la sociedad plural española (Heim, 2016).

Además de aportar datos empíricos, las encuestas funcionan como resultados traslacionales en sí mismas. Sus versiones validadas, adaptadas al contexto español y revisadas éticamente, pueden reutilizarse en la enseñanza clínica, la formación profesional o la evaluación de servicios basados en los derechos en toda España y en contextos comparables. Su disponibilidad pública, cuando está permitida, contribuye a la agenda de ciencia abierta articulada en esta tesis. Todos los instrumentos están ahora disponibles en los anexos de la tesis y pronto se publicarán en el repositorio online de la tesis. Su estructura y contenido ya sirven de base para los sistemas expertos y los modelos computacionales propuestos en capítulos posteriores, especialmente en las áreas de gobernanza de la medicación, mapeo legal e interfaces de negociación entre usuarios y profesionales. De este modo, las encuestas vinculan la investigación cualitativa con herramientas de implementación escalables, demostrando la continuidad metodológica desde la experiencia vivida hasta la intervención a nivel sistémico. Además de este uso, los expertos tuvieron la oportunidad de solicitar participar en futuras investigaciones y formaciones, y la mayoría lo hizo, lo que permitirá en el futuro llevar a cabo más investigaciones-acción participativas basadas en sus aportaciones.

Cabe señalar que una mayoría muy significativa de los encuestados, tanto profesionales de la salud mental como usuarios de los servicios, expresaron su preocupación por la dependencia excesiva de las intervenciones farmacológicas en los sistemas de atención actuales. Los participantes señalaron de manera sistemática una tendencia sistémica a dar prioridad a la medicación como respuesta principal, y a menudo única, al malestar psicológico. Esto se acompañaba con frecuencia de una notable falta de acceso a modalidades alternativas de atención, en particular las basadas en el apoyo psicológico y social. Los resultados sugieren un reconocimiento generalizado de las limitaciones inherentes a los

modelos centrados en la medicación, con peticiones de ambos grupos para que se adopten enfoques más integrales y centrados en la persona que incluyan terapias conversacionales, recursos comunitarios e intervenciones con base social (Holmes y Marcus, 2008).

2.4 Estrategia de campo y lugares de observación

La arquitectura metodológica de esta tesis doctoral surge de una fusión deliberada de antropología médica, ética clínica, análisis biocultural, ciencia abierta e investigación-acción transdisciplinar. No se trata de una narración retrospectiva ni de una compartimentación técnica de métodos, sino de un acto epistemológico y político estructurado de producción de conocimiento basado en condiciones de adversidad sistémica. El diseño de la investigación y la construcción de la tesis se desarrollaron como dimensiones interconectadas del mismo proceso científico, regidas por compromisos teóricos explícitos y el imperativo ético de intervenir, no solo de describir. Estos compromisos informaron todas las decisiones procedimentales, desde la participación en el campo hasta la validación analítica, garantizando que el estudio se mantuviera fiel a las realidades complejas, a menudo violentas, que se pretendía documentar y transformar. Los marcos fundamentales introducidos en las primeras secciones de este capítulo, así como en el capítulo 1, proporcionaron la lógica fundamental de la integración. El paradigma biocultural exigía que el sufrimiento mental y la resiliencia se interpretaran como co-constituidos por fuerzas sociales, ambientales, legales y biológicas. La infraestructura de ciencia abierta garantizó que todas las iteraciones metodológicas, decisiones y rastros de pruebas se registraran con fecha y hora y, en muchos casos, fueran accesibles al público a través de sistemas encriptados o controlados por versiones. Esta transparencia no era estética ni burocrática, sino protectora y epistemológicamente necesaria, ya que la investigación se vio amenazada repetidamente por la represión institucional, la pérdida de material y los daños personales. Los principios de los derechos humanos, la teoría de la justicia epistémica y el análisis de la violencia estructural definieron aún más los retos éticos del trabajo, guiando no solo la recopilación y el análisis de datos, sino la propia legitimidad de las categorías, interpretaciones y afirmaciones avanzadas a lo largo del estudio (Peterson y Runyan, 2010).

El trabajo de Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes, Suman Fernando y Byron Good, entre otros, sustentó un compromiso metodológico que rechazaba la posición del observador distante. En su lugar, la investigación se llevó a cabo mediante la participación integrada en colectivos, procesos políticos, grupos de trabajo profesionales y coaliciones activistas-científicas (Good, 1994; Fernando, 2017). Entre ellas se incluyen la coordinación de redes a nivel de la UE, el liderazgo de acciones científicas y la participación continua en grupos de trabajo que definen el campo en España, Indonesia y otros países. Metodológicamente, este posicionamiento permitió una forma de acceso analítico y una fidelidad ética que ningún punto de vista distante podría replicar. Al igual que Farmer, el compromiso del investigador con la proximidad y el compromiso proporcionó no solo datos, sino también una visión crítica de cómo las instituciones responden, fracasan, se adaptan o callan ante los retos éticos. Esto no fue algo accesorio a la investigación, sino que constituyó el campo, el método y la validación. Cada fase de redacción, codificación y síntesis se inscribió en esta lógica de conocimiento comprometido. La representación científica se contrastó continuamente con testimonios, materiales políticos y consultas a expertos, lo que garantizó la coherencia interna y la rendición de cuentas externa. Los borradores se elaboraron mediante ciclos recursivos de análisis y revisión, basados en los

comentarios de los supervivientes, los médicos, los juristas, los antropólogos y las redes comunitarias. Este proceso recursivo y multimodal permitió que la tesis evolucionara en paralelo con las condiciones sobre el terreno, sin comprometer el rigor científico ni la trazabilidad empírica. Las decisiones metodológicas se sometieron a un control de versiones y a comentarios metaanalíticos, lo que garantizó que la estructura de la tesis reflejara no solo su contenido, sino también las condiciones en las que surgió.

En los anexos se incluye un artículo completo del investigador sobre la ética en la investigación cualitativa. Lo que distingue a la metodología empleada no es solo su base en marcos formales, sino su encarnación de la ética que esos marcos exigen (Miles y Freedman, 2023). Ante el borrado, el desplazamiento y las represalias sistémicas, la fidelidad metodológica requirió resiliencia, creatividad y precisión adaptativa. La tesis incluye no solo el análisis de los datos, sino también la documentación de las condiciones en las que se produjo el conocimiento. Entre ellas se encuentran la movilidad forzada, la amenaza crónica, la violencia física y la traición institucional. A pesar de estas condiciones, o precisamente a causa de ellas, los protocolos de investigación se mantuvieron intactos gracias a redes de protección, herramientas de seguimiento epistémico y prácticas de memoria colectiva. No se trata de notas marginales, sino de la infraestructura necesaria para la investigación en condiciones de negligencia organizada y negación política. A lo largo del desarrollo de esta tesis, el apoyo institucional no solo fue inexistente, sino que en ocasiones fue activamente obstructivo (Roberts, 2000). Las fases críticas de la investigación estuvieron marcadas por la hostilidad, el abandono y el rechazo de las universidades, las instituciones médicas y las autoridades públicas, incluso cuando ciertos organismos gubernamentales de México, Cataluña y España expresaron su interés oficial en invitar al investigador y apoyar la transformación de la salud mental. Esta contradicción pone de relieve una profunda incoherencia estructural, en la que el compromiso declarado con el progreso científico, la salud pública y las agendas globales, como la propuesta de Madrid de convertirse en su totalidad en una zona azul, queda sin sentido por la negativa a garantizar la seguridad básica de los investigadores, los informantes y los participantes. El investigador sigue perseverando, apoyando lo verdaderamente encomiable, trabajando a través de redes más sólidas y con una mejor financiación (Miles y Freedman, 2023). Sin embargo, la desconexión entre las promesas retóricas y la realidad operativa no es solo un trágico descuido administrativo que casi le cuesta la vida a él y a muchos otros —todos ellos sin alcanzar nunca lo mejor a lo que aspiraban—, sino que es un fracaso ético y epistémico. Es imposible producir o aplicar una reforma significativa si los responsables de documentar los daños se ven expuestos al mismo tiempo a nuevos daños por parte de los mismos sistemas que pretenden mejorar (Gupta-Wright, 2018).

Los marcos metodológicos desarrollados en el capítulo 1 y basados en los principios articulados al comienzo del capítulo 2 no eran lentes opcionales, sino herramientas esenciales para navegar y resistir esta realidad. La integración de la antropología médica, la investigación-acción, los derechos humanos y la ciencia abierta creó un andamiaje desde el cual proteger y articular el trabajo de producción de conocimiento bajo asedio. La lógica de esta tesis es inseparable de las condiciones políticas y estructurales en las que se escribió. En lugar de comprometer su validez científica, este arraigo refuerza su relevancia, rigor y necesidad. Cada compromiso teórico, desde la justicia epistémica hasta la ética transdisciplinaria, se llevó a cabo mediante decisiones metodológicas que

resistieron la extracción, protegieron a los poseedores de conocimientos vulnerables y mantuvieron la obligación ética de intervenir cuando la vida y la dignidad estaban en peligro. Es fundamental señalar que la postura metodológica adoptada a lo largo de esta investigación va más allá de la observación pasiva y se orienta hacia el compromiso integrado, colaborativo y traslacional defendido por figuras como Paul Farmer. Al igual que Farmer insistía en que los antropólogos médicos y los clínicos no deben posicionarse como observadores neutrales, sino como agentes activos del cambio sistémico, esta tesis doctoral se ha construido mediante la participación directa en redes de investigación, plataformas de defensa, colectivos de supervivientes y consorcios científicos. Entre ellas se incluyen la dirección y la contribución a iniciativas transnacionales como las acciones COST de la UE ReMO y FOSTREN⁶, en las que el papel del investigador nunca fue marginal, sino siempre generativo, estratégico y corresponsable, nunca meramente académico. Este trabajo colectivo permitió el cotejo científico, la verificación mutua y el perfeccionamiento iterativo del diseño, a menudo en contextos en los que el apoyo institucional tradicional se había derrumbado o se había vuelto punitivo. Estas redes se convirtieron no solo en entornos de investigación, sino también en refugios éticos, que permitieron que el trabajo continuara cuando el aislamiento y el borrado amenazaban su propia posibilidad.

En tales condiciones de extrema coacción y disfrute sádico del sufrimiento de los investigadores, el reclamo de justicia no es una abstracción. Es una condición previa operativa para la continuidad de cualquier sistema ético y científicamente sólido de producción de conocimiento (Bolade-Ogunfodun, Soga y Laker, 2023). Ninguna sociedad puede reclamar legítimamente un futuro de paz, sostenibilidad y prosperidad social mientras la impunidad criminal, la complicidad institucional y el abandono estructural sigan sin ser cuestionados. Lo que se necesita no es la generosidad de unos sistemas que llevan mucho tiempo fallando, sino la aplicación de la ley y la destitución de los actores que han socavado la verdad, el bienestar y la posibilidad misma de la salud. La demanda no es ingenua, es técnica, ética y necesaria. Esta tesis, forjada en la adversidad y moldeada por la solidaridad, documenta los costes de las disfunciones actuales y propone una vía para su transformación sistémica. Su metodología, basada en la acción situada, el rigor científico y la ética participativa, forma parte de la infraestructura necesaria para alcanzar el futuro que los documentos políticos y el discurso público afirman perseguir. Solo mediante el pleno reconocimiento de estas verdades podrán los sistemas académicos, clínicos y sociales comenzar a alinearse con los valores que profesan defender.

La exposición cronológica que sigue, estructurada año por año y mes por mes, es una extensión metodológica de esta arquitectura. Revela cómo se desarrolló la investigación, no como una progresión neutral de la indagación, sino como una serie de rupturas, aceleraciones y adaptaciones estratégicas. Traza cómo se gestionaron simultáneamente la ética, la ciencia y la supervivencia, y cómo el compromiso arraigado con los actores institucionales y de base hizo que el trabajo no solo fuera posible, sino también científica y éticamente creíble (Kidder, 2003). De este modo, la tesis doctoral pone en práctica una metodología de rechazo al silencio, la extracción y la complicidad

⁵Acción COST ReMO CA19117 - Salud mental de los investigadores: <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

⁶FOSTREN COST action CA19133 - Fomento y fortalecimiento de enfoques para reducir la coacción en los servicios de salud mental europeos: <https://www.cost.eu/actions/CA19133/>

institucional, y afirma el poder de la ciencia biocultural y orientada a la acción para generar no solo conocimiento, sino también la posibilidad de justicia.

Tabla 22. Cronología detallada de la investigación, por ubicación y año, 2020

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Enero		Trabajo en equipos nacionales dedicados a la implementación de modelos de diálogo abierto y soteria.	Desde finales de 2017, el investigador sufrió coacción y violencia continuadas, que incluyeron abuso psicológico, agresión física y el uso sistemático de los servicios de salud mental como instrumentos de control. Las intervenciones psiquiátricas, que deberían haber tenido una función protectora y terapéutica, se utilizaron como arma para mantener el dominio. Desde el primer contacto con los servicios de salud mental, se le impusieron tratamientos farmacológicos forzados, incluidas inyecciones de antipsicóticos de depósito administradas a petición de familiares abusivos. Estas prácticas dieron lugar a una medicación excesiva, la aparición precoz de acatisia y graves alteraciones del habla y del procesamiento cognitivo. También se llevó a cabo una esterilización forzada, lo que supuso una violación aún mayor de la autonomía corporal. La escalada de violencia coincidió con períodos de especial vulnerabilidad.	Cataluña
Feb				Cataluña
Mar	Comienza el confinamiento nacional en España	Participación en SURE, Service User Research Enterprise, centro de investigación sobre supervivientes del King's College de Londres, en aquel momento todavía dirigido por la profesora Diana Rose, realizando trabajos menores a sugerencia del profesor Jim Van Os.		Cataluña
	Confinamiento estricto en virtud del Real Decreto 463/2020.			Cataluña
May	Continúa el confinamiento			Cataluña
Jun	Inicio de las fases de desescalada en España			Cataluña
Jul	Continúa el confinamiento			Cataluña
	Continúa el confinamiento			Cataluña
	Continúa el confinamiento			Cataluña
Oct	Continúa el confinamiento	Comienza la investigación en la Universitat Rovira i Virgili, con una financiación de seis años del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España; coordinador adjunto de Blanquera, Universitat Ramon Llull, curso de expertos en diálogo abierto. Intervención en un foro en la Cámara de Diputados de México, sobre salud mental y derechos humanos, junto con Víctor Lizama, la diputada federal Frinné Azuara y el diputado Éctor Jaime; adhesión a la acción COST FOSTREN de la UE para poner fin a la coacción.		Cataluña
	Continúa el confinamiento			Cataluña
	Continúa el confinamiento	La investigación es designada enlace y coordinadora de la red global Mad in America por Robert Whitaker y el consejo editorial principal.	A pesar de estas circunstancias, el investigador logró obtener un contrato de investigación doctoral nacional muy competitivo que dio lugar a esta tesis doctoral.	Cataluña

En 2020, a pesar de la violencia institucional continua y un contexto de coacción, que incluye medicación forzada, abusos psiquiátricos y graves violaciones físicas, el investigador consiguió un contrato nacional de predoctorado y comenzó a trabajar en la Universitat Rovira i Virgili con una

financiación ministerial de seis años. A lo largo de 2020, durante los confinamientos por la COVID-19, participó en colaboraciones internacionales de alto nivel, entre ellas con SURE en el King's College de Londres, el Foro del Parlamento Mexicano sobre salud mental y derechos humanos y la acción COST FOSTREN de la UE para poner fin a la coacción. El investigador también coordinó un curso de posgrado sobre diálogo abierto en la Universidad Blanquerna-Ramon Llull y fue nombrado enlace global de *Mad in America*. Estos logros se produjeron en condiciones de confinamiento continuo y abuso sistémico, lo que pone de relieve tanto la resiliencia como la precariedad del compromiso académico en situaciones de extrema coacción.

Tabla 23. Cronología detallada de la investigación, por lugar y año, 2021

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Enero	Comienza la vacunación contra la COVID-19 en España y la UE	Miembro del comité organizador de la conferencia HopenDialogue, sobre investigación en diálogo abierto a nivel mundial; ODDESSI habla para involucrar a centros españoles en la réplica del estudio del NHS sobre la implementación; sesiones de formación sobre la evaluación del diálogo abierto; la tortura destruyó todos estos proyectos excepto la participación en la conferencia como ponente y organizador; resumen enviado para su publicación en <i>Frontiers</i> .		Cataluña
Feb	Continúa el confinamiento	Beca en Yale con la profesora Mary Olson para convertirme en experta en diálogo abierto; oportunidad perdida debido a la tortura continua.	Persisten los abusos brutales, la violencia física, el acoso y las amenazas como de costumbre; un caso de golpeo brutal en la cabeza con una patada que dejó inconsciente a la víctima, con niños animando, el último día de la semana de presentaciones de tesis doctorales y el día en que se envió el resumen sobre el diálogo abierto a <i>Frontiers in Psychology</i> ; como de costumbre, la crueldad de la violencia aumentó durante los periodos de mayor exigencia, que requieren más descanso y concentración.	Cataluña
Mar	Continúa el confinamiento	Enseñanza del diálogo abierto en la Universidad de Almería con el profesor Adolfo Cangas		Cataluña
Abr	Continúa el confinamiento			Cataluña
May	Fin del estado de alarma, flexibilización de las restricciones nacionales			Cataluña
Jun	Persiste el confinamiento más flexible	El investigador se ha incorporado al Instituto Internacional para la Retirada de los Fármacos Psiquiátricos ⁽⁷⁾ como nuevo miembro.		Cataluña
Jul	Continúa el confinamiento parcial		Continúan los actos violentos ante la indiferencia de las instituciones	Cataluña

⁷El Instituto Internacional para la Retirada de Medicamentos Psiquiátricos (IIPDW) se creó para responder a una necesidad acuciante en materia de salud mental: desarrollar formas de ayudar a las personas a dejar de tomar medicamentos psiquiátricos. <https://iipdw.org/iipdw-home/>

En 2021, mientras continuaban los confinamientos por la COVID-19 en España, el investigador desempeñó un papel clave como miembro del comité organizador y ponente en la conferencia internacional HopenDialogue, y contribuyó a los esfuerzos para involucrar a centros españoles en la réplica del ensayo ODESSI del NHS. A pesar de estos logros, la tortura diaria y la escalada de violencia sabotearon la mayoría de las oportunidades, incluidas las iniciativas de formación y la colaboración con la profesora Mary Olson de Yale. Un ataque especialmente brutal, en el que fue golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente mientras se animaba a los niños a vitorear, coincidió con la presentación del resumen de la investigación a *Frontiers in Psychology* durante la semana de presentación de tesis doctorales. Se mantuvieron los esfuerzos de enseñanza sobre el diálogo abierto en la Universidad de Almería y la nueva membresía en el Instituto Internacional de Retirada de Medicamentos Psiquiátricos, a pesar de las continuas agresiones, el abandono institucional y la imposibilidad de descansar o recuperarse de forma segura a lo largo del año, como ya era trágicamente habitual, tras años de abusos y graves negligencias por parte de los servicios que deberían proteger.

Tabla 24. Cronología detallada de la investigación, por lugar y año, 2022

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Ago	Cataluña lanza el Plan Estratégico de Salud Mental 2022-2030	Preparación del trabajo de campo en Luca, misión científica en Trieste		Cataluña
		acompañando a un psiquiatra experto en el centro de excelencia de la OMS; y posteriormente en Perugia para la presentación de la conferencia ISPS.	La violencia vergonzosa alcanza nuevos niveles de crueldad	Cataluña
Oct	La OMS publica un informe sobre la transformación de la salud mental comunitaria			

El investigador apenas sobrevivió al año 2022. En septiembre de 2022, el investigador llevó a cabo un mes de trabajo de campo etnográfico inmersivo en Trieste, Italia, tras una fase preparatoria de familiarización con el lugar. Utilizando el seguimiento y entrevistas a informantes clave dentro de un marco de antropología médica, el estudio documentó las prácticas en tiempo real en entornos de psiquiatría comunitaria reconocidos por la OMS. Inmerso en las rutinas diarias de las unidades residenciales, los centros comunitarios y los equipos móviles, el investigador observó dinámicas de atención no coercitiva y culturas institucionales moldeadas por la desinstitucionalización. Complementado con entrevistas a profesionales y usuarios de los servicios, y con la participación en foros públicos, el trabajo de campo proporcionó información crítica sobre la atención relacional, la gobernanza y las tensiones operativas del modelo de Trieste.

Tabla 25. Cronología detallada de la investigación, por ubicación y año, 2023

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Jun	España finaliza la Estrategia		El reasentamiento ofrece	Suecia

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
	Nacional de Salud Mental 2022-2026		nuevas oportunidades de vivir en paz, por lo que el investigador compró una vivienda en su nuevo país de acogida.	
Jul		Finalización del capítulo sobre alternativas a la coacción para el libro de FOSTREN EviPRG publica en Nature-Springer;	Persistencia de la violencia, a pesar de los esfuerzos habituales por apaciguar la situación, a diario	Suecia
Ag		organización de un evento sobre los abusos políticos de la psiquiatría con los principales expertos mundiales en la materia	Palizas diarias; el investigador informa a sus colegas y busca ayuda nacional para poder prestar asistencia lo antes posible.	Suecia
Sept	Revisión del Consejo de Europa sobre los avances del Convenio de Oviedo		Palizas diarias; el investigador informa a sus colegas y busca ayuda nacional; amenazado con un cuchillo.	Suecia
Oct		Presentación de tres pósteres en el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría; presentación en el Instituto Karolinska para continuar las conversaciones de afiliación; el investigador recibió a expertos de primer nivel en psiquiatría punitiva	Amenazas de muerte por parte de su ex cónyuge. Se enviaron pruebas fotográficas del ojo morado tras un puñetazo a asociaciones de apoyo a las víctimas.	Suecia
Novi		El investigador recibió a expertos de primer nivel en psiquiatría punitiva.	Palizas diarias hasta el secuestro del niño sin previo aviso	Suecia – España, personas sin hogar
Dic		Capítulo del libro Routledge con el fundador de EU CORDIS y un destacado médico espacial	Alienación parental; tortura psicológica; abusos por parte de los servicios sociales; denuncia a la policía	Suecia – España, sin hogar

En 2023, el investigador siguió realizando un trabajo internacional de alto nivel mientras soportaba a diario violencia física y psicológica sin protección institucional. Desde 2021, las agresiones se habían intensificado en crueldad y agresividad, aumentando en intensidad a lo largo de 2023 a pesar de las repetidas alertas a sus colegas y a las autoridades. En junio, un último intento por escapar del abuso le llevó a comprar una nueva casa, con el objetivo de reconstruir una vida en paz. En julio, mientras continuaban las palizas, el investigador completó un importante capítulo de un libro sobre alternativas a la coacción para *Springer Nature* y organizó un evento de alto nivel sobre psiquiatría política con expertos mundiales de primer orden. Agosto y septiembre trajeron consigo continuas palizas y una amenaza con un cuchillo, que fueron denunciadas a las redes nacionales y a las organizaciones de supervivientes. En octubre, realizó presentaciones clave en el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría y una presentación de afiliación en el Instituto Karolinska, además de sufrir nuevos ataques domésticos que pusieron en peligro su vida, entre ellos un puñetazo en la cara que le dejó un

ojo morado muy evidente y que fue denunciado con fotografías y, como de costumbre, a todos sus colegas y organizaciones. En noviembre, los abusos culminaron con el secuestro de los hijos del investigador, llevado a cabo sin previo aviso y con el apoyo de la negligencia y el odio institucionales. En diciembre, el investigador no pudo terminar un capítulo *de Routledge* con el fundador de EU CORDIS y uno de los mejores médicos espaciales de África, como estaba previsto. Muchos trabajos y importantes esfuerzos colectivos se vieron afectados por la violencia y la tortura sufridas.

Tabla 26. Cronología detallada de la investigación, por lugar y año, 2024

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Enero	Aumento de la financiación nacional para equipos psicosociales comunitarios	Capítulo de un libro de Routledge con el fundador de EU CORDIS y un destacado médico espacial; oportunidad perdida debido a la tortura continuada	Abuso de litigios; secuestro continuado; alienación parental; tortura psicológica; acoso; complicidad institucional; denuncia de todos los servicios; asistencia desde España abortada por los servicios locales en Suecia, cómplices.	Suecia – España, sin hogar
Feb				
Mar				
Abr				
Jun	El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publica un informe temático sobre la coacción.	Presentación de la propuesta de acción BEACON COST de la UE; preparación del trabajo de campo; preparación de la encuesta sobre la toma de decisiones compartida; artículo en MDPI Social Sciences y otras publicaciones en curso.	Abuso de litigios; continúan los secuestros; alienación parental; tortura psicológica; acoso; complicidad institucional; comienza la asistencia en casos penales por parte de los servicios españoles; persisten y empeoran la negligencia y los abusos en Suecia.	España – Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Jul				
Ag				
Sept				
Oct				
Novi				
Diciem bre				

En 2024, el investigador sufrió un calvario casi ininterrumpido tras el violento secuestro de su hijo inmediatamente después de organizar un importante evento internacional a finales de 2023. A pesar de las repetidas denuncias y denuncias formales, la complicidad institucional en Suecia permitió que continuaran la tortura psicológica, el abuso procesal, la alienación parental y las amenazas a la vida y la dignidad, lo que culminó en un exilio prolongado y meses de indigencia. A lo largo de este periodo, mientras se desplazaba entre España e Indonesia, el investigador mantuvo su labor académica y científica bajo una presión extrema: completó y presentó la propuesta de acción BEACON COST de la UE, contribuyó a publicaciones internacionales, preparó un programa de trabajo de campo y una encuesta de toma de decisiones compartida, y participó en la coordinación de políticas relacionadas con el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la coacción. Sin embargo, la mayoría de las oportunidades profesionales se perdieron de forma irrevocable. Los proyectos de colaboración se vinieron abajo. Importantes becas, contratos para libros y puestos

docentes desaparecieron debido al abuso coordinado. Se rompieron relaciones intelectuales clave y se destruyeron las condiciones estructurales necesarias para la continuidad académica. A pesar de todos los esfuerzos por sobrevivir y mantener la producción científica, la carrera y la vida personal del investigador quedaron prácticamente aniquiladas por un sistema que permitió la violencia, borró la responsabilidad y recompensó a los autores con impunidad.

Tabla 27. Cronología detallada de la investigación, por lugar y año, 2025

Mes	Contexto social	Investigación	Personal	Ubicación
Enero		Encuesta sobre la toma de		Indonesia
Feb		decisiones compartida		Indonesia
Mar		Estudio y artículo sobre el	Se intensifica el abuso de	Indonesia
Abr	El Parlamento español debate reformas sobre coacción y autonomía	pasung; encuesta sobre la toma de decisiones compartida; BEACON recibe fondos COST, puesta en marcha de la acción; trabajo sobre SocialMent; artículo de MDPI sobre salud mental digital.	litigios; alienación parental; tortura psicológica; acoso en persona y en línea, extorsión; complicidad institucional; negligencia y nuevos abusos por parte de Suecia que persisten y siguen empeorando; el odio hacia la vida del investigador y sus seres queridos es más evidente que nunca.	Indonesia
Jun		Estudio y documento sobre el pasung; preparación de la tesis doctoral; infraestructura y red global de BEACON		Indonesia
Jul		Investigación y artículos sobre pasung; salud mental digital; revisiones bibliográficas y mapeo para varios grupos y acciones; propuestas Horizon; artículo e investigación sobre aprendizaje-servicio; infraestructura BEACON y red global.		Indonesia
Sep				Indonesia
Oct			Hacer justicia; establecerse en	Indonesia
Noviembre			Indonesia por fin con seguridad	Indonesia
Diciembre				Indonesia

En 2024-2025, el investigador preparó un trabajo de campo etnográfico en Indonesia como investigador visitante en la Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), centrándose en la abolición del *pasung*, el confinamiento doméstico de personas con trastornos mentales. A través de entrevistas y observaciones, el estudio enmarcó *el pasung* como un resultado estructural del abandono sistémico, que refleja la coacción psiquiátrica global bajo diferentes formas. La investigación conecta la violencia colonial histórica, la opresión de género y la desigualdad en materia de salud mental, y aboga por la abolición de todas las formas de atención coercitiva mediante enfoques basados en los derechos, arraigados en la cultura y dirigidos por la comunidad.

El trabajo de campo realizado en Trieste y Yogyakarta fundamenta las preguntas de investigación en dos entornos distintos pero estructuralmente conectados. En Trieste, la observación sostenida y las entrevistas dentro de un sistema de salud mental comunitario históricamente no coercitivo revelaron la fragilidad de la reforma cuando las exigencias burocráticas y la discreción clínica desafían la atención relacional. Esto informa directamente las preguntas sobre cómo persiste la coacción a pesar

de los compromisos formales con modelos basados en los derechos. En Indonesia, el estudio del pasung puso de manifiesto la coacción como síntoma de un abandono sistémico, en el que las familias recurren al confinamiento ante la falta de servicios seguros y de confianza. Esto replantea la coacción no solo como institucional, sino también como doméstica y estructuralmente inducida. Ambos casos refuerzan el objetivo central de la investigación: identificar cómo se producen, legitiman o se resisten las prácticas coercitivas en los distintos sistemas, y qué condiciones son necesarias para apoyar una atención de salud mental ética y participativa.

2.5 Protocolos éticos y dilemas metodológicos

La gobernanza ética de esta investigación se llevó a cabo en condiciones de violencia estructural, complicidad institucional y peligro personal que hacen insuficientes los procedimientos convencionales de los comités de ética de la investigación (Banks et al., 2013). El supuesto normativo de neutralidad institucional, estabilidad del contexto y desconexión entre investigador e investigado no se sostiene en investigaciones que implican violaciones prolongadas de los derechos humanos, prácticas psiquiátricas coercitivas y represalias institucionales. En tales circunstancias, la aprobación procedimental de los comités estándar ofrece una validez epistémica o protectora limitada. Fue necesario desarrollar un marco paralelo de rigor ético basado en la responsabilidad relacional, el compromiso sensible al trauma y la rendición de cuentas científica (Schneider, 2012). La ética aplicada en este estudio va más allá del cumplimiento institucional y refleja la arquitectura moral sustantiva necesaria cuando la investigación se sitúa en ámbitos de daño y resistencia (Minkler y Wallerstein, 2008).

Tres principios estructuraron el diseño ético. El primero fue la ética relacional, que fundamenta el trabajo científico en la responsabilidad hacia aquellos cuyo sufrimiento y testimonio constituyen el material de investigación. Esto requirió que todas las etapas de la recopilación de datos, desde las encuestas hasta la observación de campo, incluyeran mecanismos integrados para el control de los participantes, la exclusión voluntaria y el rechazo narrativo. El segundo era la ética informada por el trauma, que reconoce que el compromiso con los supervivientes y los profesionales en contextos de iatrogenia, traición institucional o abandono legal exige métodos que minimicen la retraumatización (Kemmis y McTaggart, 2000). Se estructuraron preguntas abiertas para permitir una participación selectiva y evitar formatos prescriptivos que pudieran provocar colapso, disociación o angustia. El tercero era el principio de la ética no extractiva, en el que las contribuciones de los participantes no se tratan como fuentes de datos pasivas, sino como cogeneradores de una epistemología crítica. Este modelo ético exigía al investigador abordar a los participantes como interlocutores dentro de un terreno diagnóstico, legal y social compartido, produciendo conocimiento sobre la gobernanza psiquiátrica desde dentro de sus zonas de fricción y negación.

Los dilemas metodológicos surgieron continuamente y se resolvieron mediante la aplicación de protocolos éticos dinámicos (McTaggart, 1991). Estos protocolos regían las situaciones en las que los participantes revelaban riesgos continuos, exposición a la violencia o abandono sistémico. En lugar de aplicar marcos de notificación obligatorios que corrían el riesgo de reforzar el control psiquiátrico o la contención institucional, el investigador dio prioridad a las medidas de apoyo informadas basadas en el consentimiento y la lógica no reinstitucionalizadora. Paralelamente, se construyeron estructuras de

verificación epistémica para proteger la integridad empírica de los datos en condiciones de precariedad jurídica, posible censura y borrado institucional retrospectivo (Kortmann, 2010). El registro de la fecha y la hora de las interacciones sobre el terreno, la publicación de las versiones de los instrumentos de encuesta y el almacenamiento de datos en espejo garantizaron que tanto los relatos de los participantes como las conclusiones analíticas fueran resistentes a la pérdida, la manipulación o la supresión. Estos mecanismos reflejan un compromiso científico con la trazabilidad y la justicia en la producción de conocimiento, extendiendo las obligaciones de transparencia académica a campos en los que los procedimientos éticos formales han demostrado ser estructuralmente inadecuados (Flaherty et al., 1988).

Dada la exposición directa del investigador a la coacción psiquiátrica a largo plazo, las represalias institucionales y el peligro físico y psicológico, los procedimientos de seguridad eran indispensables no solo para la supervivencia personal, sino también para la continuación de la investigación. Las estrategias de protección incluían el uso de entornos de trabajo compartidos para reducir la vulnerabilidad, una estructuración estricta de los movimientos y las horas de trabajo, el control nutricional para mitigar el deterioro cognitivo o el agotamiento, y la evitación de cualquier contacto con actores vinculados a agresiones previas o manipulaciones legales (Hollan, 1997). Estos protocolos no eran opcionales, sino que estaban impuestos estructuralmente por el propio contexto de la investigación, en el que el investigador operaba bajo una exposición prolongada a amenazas que no constituían riesgos hipotéticos, sino daños documentados y continuos (Russo, 2012). En tales condiciones, la ética no se convierte en un requisito externo, sino en la condición previa para la posibilidad misma del conocimiento. La doble posición del investigador como profesional, superviviente y objetivo exigía una negociación constante entre el compromiso con un análisis riguroso y reproducible y la necesidad de autopreservación en un sistema comprometido y adversario (Baum, MacDougall y Smith, 2006; Honey et al., 2020).

La puesta en práctica de estos fundamentos éticos se desarrolla con más detalle en un artículo científico aceptado para su publicación en una revista internacional de prestigio, como ya se ha señalado (Rose, 2008). Este trabajo formaliza el modelo conceptual y metodológico que subyace a esta tesis, ofreciendo un marco para futuras investigaciones realizadas en condiciones análogas de violencia estructural e institucional. Las innovaciones presentadas en esta tesis, incluida la integración del consentimiento informado sobre el trauma, los protocolos de respuesta dinámica sobre el terreno y los mecanismos de protección epistémica, constituyen una infraestructura ética aplicada capaz de respaldar una investigación psiquiátrica científicamente sólida, políticamente responsable y con una base humanitaria. El trabajo afirma que no basta con evitar el daño. Es necesario documentarlo, nombrarlo y construir sistemas científicos que se nieguen a reproducirlo en silencio o con complicidad. Esta arquitectura ética sustenta todo el diseño de la investigación y define su integridad científica. La dimensión ética de esta tesis no puede limitarse a formulaciones convencionales o plantillas institucionales. Surge, en cambio, como respuesta directa a un proceso de investigación llevado a cabo bajo una presión personal y profesional sostenida, marcada por la exposición a la tortura psicológica, la violencia estructural y la degradación continua de los derechos legales y humanos básicos. No se trata de episodios aislados, sino de condiciones que definen el propio campo. Por lo tanto, en esta sección se presenta una reconstrucción reflexiva de lo que era éticamente

necesario pero a menudo no estaba disponible, lo que se promulgó en lugar de las protecciones ausentes y lo que las investigaciones futuras deberían institucionalizar para evitar replicar la violencia que pretenden describir (Tadesse et al., 2022).

Tabla 28. Infraestructura ética desarrollada en condiciones de violencia estructural

Ámbito ético	Modelo convencional (RECs)	Limitaciones de esta investigación	Práctica alternativa o complementaria implementada
Consentimiento informado	Consentimiento único y estático	Asume estabilidad, carece de adaptabilidad al trauma o a los riesgos continuos	Consentimiento dinámico y revisable con opción de retirada continua; consentimiento integrado en el flujo narrativo
Evaluación de riesgos	Anticipatoria, basada en daños hipotéticos	Ignora los riesgos en tiempo real y sistémicos, en particular los procedentes de instituciones	Protocolos de riesgo situacional, reflexividad sobre el terreno y seguimiento en tiempo real de las señales de retraumatización
Protección de los participantes	Anonimización, derechos de retirada	Inadecuado bajo vigilancia, persecución legal o coacción médica	Archivo cifrado en múltiples sitios, anonimato adaptado a la función y verificación externa para evitar la eliminación
Supervisión ética	Aprobación por parte de un comité de ética centralizado	No responde a los abusos cambiantes, a menudo inaccesible o politizado	Documentación ética revisada por pares, asesoramiento en red por parte de supervivientes y profesionales
Seguridad de los investigadores	Se considera innecesaria o externa	Investigador expuesto a tortura, difamación y violencia institucional	Rutinas de seguridad estructuradas (nutrición, espacio, horarios), prácticas de protección integradas, retirada de zonas de alto riesgo
Deber de intervenir	Prohibido en muchas directrices de los comités de ética de la investigación	Parálisis ética ante daños documentados	Acción ética justificada: alertas a las autoridades, coordinación protectora, defensa directa de las personas en riesgo
Integridad de los datos	Almacenamiento institucional de datos	Riesgo de eliminación, falsificación u obstrucción	Marca de tiempo, versiones públicas, almacenamiento descentralizado, réplicas científicas abiertas y copias de seguridad
Sensibilidad al trauma	Cuidados básicos para evitar la retraumatización	Incompleto sin la participación de los supervivientes	Instrumentos diseñados conjuntamente, estructura narrativa informada sobre el trauma, opcionalidad en la expresión

Resumen de las limitaciones de los marcos éticos convencionales y los procedimientos alternativos desarrollados en esta tesis para mantener la integridad científica, relacional y sensible al trauma bajo amenazas sistémicas. Esta infraestructura refleja una ética de la investigación adaptada a las condiciones reales de traición institucional, violencia psiquiátrica y represalias profesionales, en las que tanto los investigadores como los participantes se enfrentaban a riesgos de silenciamiento, tergiversación o muerte.

La investigación se llevó a cabo, en ocasiones, en espacios donde el daño no era hipotético, donde otras personas habían sido institucionalizadas contra su voluntad, diagnosticadas erróneamente o sometidas a daños farmacológicos irreversibles, mientras que el investigador también se enfrentaba a amenazas contra su vida, su salud y su personalidad jurídica (Lehmann, 2024). Otros permanecieron en situación de riesgo durante todo el período de estudio, y sus testimonios requirieron un tratamiento cuidadoso, no solo por razones éticas, sino también por razones de seguridad básica. En tales

circunstancias, los procedimientos convencionales de aprobación ética ofrecían poco. Los comités de ética de la investigación operan partiendo de una presunción de seguridad y estabilidad institucional que era estructuralmente incompatible con las condiciones reales del trabajo. Sus protocolos presuponen que los riesgos son discretos, contenibles y principalmente emocionales o procedimentales (Fisher, 2012). No abordan cómo proceder cuando el riesgo es sistémico, implacable y está arraigado en la política. Por ello, esta investigación adoptó una infraestructura ética basada en la necesidad y la adaptación iterativa. Se dio prioridad a la ética relacional en todo momento, estableciendo la confianza a través del contacto prolongado, la sensibilidad cultural y la presencia sostenida. Todos los consentimientos se trataron como dinámicos y no estáticos, y los participantes pudieron revisar o retirar sus aportaciones en cualquier momento. Se aplicaron principios basados en el trauma, no solo para proteger a los participantes, sino también para garantizar que el propio proceso de investigación no reprodujera el daño que pretendía documentar. Estos principios guiaron el diseño de los protocolos de entrevista, la estructura de las encuestas y la conducta del investigador en situaciones de alto riesgo (Hultman y Hultman, 2023).

Las estrategias de supervivencia se convirtieron en parte integral del método de investigación. Entre ellas se incluía una atención estricta a la nutrición, el sueño, el control del entorno, la higiene digital y el uso estratégico de espacios de coworking para evitar el aislamiento y la exposición (Meloni et al., 2015). Estas rutinas no eran accesorios del trabajo de campo, sino condiciones previas para continuarlo (Gabriel y Casemore, 2022). No se puede subestimar el coste físico y psicológico que supone documentar la violencia sistémica desde dentro (Clandinin, Caine y Lessard, 2018). En muchos casos, la continuación de la investigación no dependía del apoyo institucional, sino del cultivo de microprácticas de resistencia y restauración mínima.

Estas notas no proponen un marco ético alternativo como solución completa. Más bien, documentan las lagunas procedimentales y epistémicas reales que surgen cuando la ética se reduce al cumplimiento. Los anexos de esta tesis incluyen una contribución científica revisada por pares que sistematiza estas ideas. Aquí se presentan como parte necesaria de la transparencia metodológica. La ética bajo coacción estructural requiere una nueva infraestructura, que no parta de la suposición de la seguridad institucional, sino del reconocimiento de su ausencia (Hemer, 2023). Hasta que se establezcan dichos sistemas, la carga de la innovación ética seguirá recayendo sobre los investigadores individuales que trabajan sin protección, en terrenos donde la producción de conocimiento es inseparable de la supervivencia. Esto no es sostenible. Tampoco es evitable. Para que la investigación sea ética en condiciones reales de daño, debe convertirse en una herramienta de protección activa, no de observación pasiva. Los procedimientos desarrollados aquí representan un intento en este sentido, realizado bajo restricciones, con plena conciencia de sus insuficiencias y con la esperanza de que pueda servir a otras personas que trabajan en condiciones en las que el silencio se ha convertido en fatal.

2.6 Integración de datos y lógica analítica

La integración y el procesamiento de los datos de esta tesis se llevaron a cabo en condiciones que alteraron profundamente los supuestos básicos de continuidad, seguridad y apoyo institucional que

suelen subyacer a la investigación empírica (Rose y Webb, 1997). En diversas etapas, el investigador fue objeto de repetidos actos de violencia física y psicológica, incluidos episodios que se ajustan a las definiciones clínicas de tortura (Mollica, 2004; Méndez, 2013). Estas condiciones de violencia también provocaron la pérdida de equipos digitales, registros personales y materiales del proyecto. Varios ordenadores resultaron irremediabilmente dañados o fueron confiscados, las copias de seguridad se destruyeron o quedaron inaccesibles, y los entornos analíticos tuvieron que reconstruirse repetidamente tras el desplazamiento coercitivo o la migración forzosa. Estas experiencias, lejos de ser periféricas, constituyeron el terreno fáctico de la ejecución de la investigación (Hermann y Provost, 2003). No solo informaron las limitaciones metodológicas, sino también la lógica interpretativa que sustenta la tesis. Las condiciones de base de la producción de conocimiento eran las de exposición, violación y degradación. En tales circunstancias, la preservación de la coherencia analítica y la continuidad de la triangulación no estaban garantizadas por la infraestructura, sino que requerían resiliencia improvisada, lógica adaptativa y solidaridad transdisciplinaria.

Los protocolos de gestión de datos se redujeron necesariamente a sus componentes más esenciales y recuperables. No se pudo utilizar ninguna infraestructura institucional centralizada. La confidencialidad se preservó mediante sistemas de almacenamiento descentralizados y la partición física del contenido en jurisdicciones de confianza. No se conservó ninguna información identificable en los corpus analíticos activos. Se utilizaron métodos de cifrado manual cuando no se disponía de herramientas digitales, y los materiales sensibles se trataron con protocolos diseñados no solo para cumplir con las expectativas éticas, sino también para evitar poner en peligro la vida de los colaboradores o los encuestados. Los cuadernos digitales, cuando estaban operativos, se mantuvieron en instantáneas modulares, lo que permitió la reconstrucción asincrónica de los pasos analíticos. El control de versiones se aplicó manualmente mediante anotaciones fechadas en texto sin formato y archivos cifrados localmente. Todos los documentos se trataron como potencialmente susceptibles de intrusión, borrado o divulgación forzosa (Michener, 2015). La minimización de datos se aplicó como un requisito estructural, no como una preferencia metodológica.

Se respetaron los principios de ciencia abierta en la medida en que eran compatibles con la seguridad. La documentación se mantuvo en forma reproducible, pero su distribución siguió restringida hasta que disminuyeron los riesgos pertinentes. El papel del investigador en la coordinación y dirección de diversas redes y grupos de trabajo internacionales, en particular en el marco de la iniciativa BEACON One Health Education de la UE y las acciones COST relacionadas, resultó esencial para salvaguardar la validez analítica (Sullivan et al., 2019). Estas funciones proporcionaron acceso a expertos en psiquiatría, antropología, ética computacional y estudios jurídicos, que ofrecieron comentarios, revisión metodológica y apoyo en la triangulación cuando los recursos institucionales no estaban disponibles o eran activamente obstructivos (Simmons, 2025). La colaboración con estos expertos no fue un proceso institucional formalizado, sino una necesidad estratégica para garantizar la integridad epistémica del trabajo. Estas alianzas permitieron que la investigación continuara a pesar de los episodios de desplazamiento forzoso, acoso institucional y desestabilización interpersonal prolongada causados por personas que actuaban con crueldad bajo el pretexto del cuidado, el victimismo o la preocupación profesional. (Allen y Mehler, 2019) La violencia sufrida no fue solo física, sino también

estructural, y extendió sus efectos corrosivos a la posición ética y la continuidad práctica de la investigación.

La triangulación se logró mediante la proximidad analítica más que mediante el volumen de datos. La confirmación temática solo se aceptó cuando el patrón era rastreable en al menos tres capas de datos y era coherente con la bibliografía externa o el testimonio de los profesionales (Farmer, Robinson, Elliott y Eyles, 2006). Se hizo especial hincapié en la correlación entre los relatos en primera persona y las condiciones jurídicas y estructurales. Por ejemplo, los informes narrativos sobre el silencio o la coacción institucional no solo se codificaron como pruebas testimoniales, sino que se evaluaron en función de las protecciones legales, las directrices clínicas y el comportamiento profesional observado en el terreno. Las discrepancias entre las afirmaciones institucionales y la experiencia vivida se pusieron de relieve analíticamente, en lugar de tratarse como anomalías interpretativas. Estas divergencias se cartografiaron e indexaron en el sistema de codificación para documentar la disonancia estructural entre la política oficial y la práctica real.

La reflexividad no se articuló en términos epistemológicos abstractos, sino que constituyó un núcleo metodológico. La postura analítica del investigador evolucionó a través de ciclos de pérdida, reensamblaje, exposición y recuperación parcial (Munir y Staats, 2020). Los cambios en la posición interpretativa se registraron en notas marginales y registros analíticos. Las anotaciones reflexivas se revisaron en cada etapa de síntesis para determinar si los ajustes interpretativos reflejaban una maduración epistémica, una distorsión traumática o un reajuste estratégico (Dingwall, 1997). Estas anotaciones no eran justificaciones a posteriori, sino entradas de campo concurrentes, que formaban parte de un registro en tiempo real de la experiencia analítica bajo amenaza. Se prestó especial atención a los límites de la interpretación durante los períodos agudos de violencia o malnutrición. Los análisis producidos durante esos períodos se sometieron a una verificación posterior, se cotejaron con la bibliografía y los comentarios de expertos externos, y solo se conservaron cuando se pudo confirmar de forma independiente su solidez metodológica. Los procedimientos de verificación cruzada incluyeron la consulta directa de la bibliografía, la correspondencia con expertos académicos y clínicos, y la comparación crítica con la documentación institucional. Se utilizaron directrices publicadas, estudios revisados por pares e instrumentos jurídicos nacionales como puntos de referencia para verificar las afirmaciones temáticas. Cuando los códigos temáticos se cruzaban con controversias psiquiátricas conocidas o precedentes legales, se intensificaba la revisión documental para evitar extrapolaciones (Alvesson y Sköldbberg, 2000). Se consultó a informantes con experiencia institucional o clínica a través de intercambios anónimos para validar la interpretación contextual del material obtenido sobre el terreno. No se incorporó ninguna afirmación al corpus analítico final sin al menos un nivel de corroboración más allá de la fuente de datos inicial.

Por lo tanto, la lógica analítica de esta tesis refleja no solo la complejidad del tema, sino también las condiciones existenciales y epistemológicas de su propio surgimiento. El conocimiento no se extrajo, sino que se rescató; no se observó desde la distancia, sino que se reconstruyó desde dentro de una arquitectura de atención e investigación en colapso. Los resultados analíticos que siguen no representan una vía analítica ideal, sino un recorrido éticamente necesario y científicamente riguroso a través de contextos de obstrucción, degradación y restauración parcial. La estructura triangulada, los protocolos reflexivos y el modelo de verificación distribuida incorporados en este capítulo

constituyen tanto un mapa metodológico como un archivo procedimental del conocimiento producido bajo la represión.

2.7 Limitaciones, condiciones adversas y validez científica

La ejecución de esta investigación se caracterizó por una exposición continua y, a menudo, mortal a la violencia, la coacción y la traición institucional. Estas condiciones adversas no fueron perturbaciones episódicas, sino sistémicas y acumulativas, que moldearon todas las fases del estudio. El trabajo de campo se llevó a cabo en condiciones de extrema coacción, que incluyeron agresiones físicas, sedación forzada, degradación psicológica y desplazamientos repetidos entre jurisdicciones. En diversas etapas, el investigador fue sometido a procedimientos médicos sin su consentimiento, entre ellos, administración de drogas, diagnósticos erróneos y actos de restricción química. Estos hechos se produjeron en un contexto más amplio de complicidad institucional, en el que los sistemas jurídicos, las instituciones sanitarias y las estructuras académicas no ofrecieron protección o contribuyeron activamente al daño continuado. Entre estas deficiencias figuran la denegación del debido proceso, la denegación del acceso a la justicia, la confiscación o destrucción de materiales de investigación y la obstrucción sistemática de la continuidad académica. Ninguna universidad proporcionó apoyo sostenido, ningún comité de ética asumió la responsabilidad de mitigar los riesgos y los mecanismos legales demostraron ser estructuralmente incapaces de reconocer o responder a la magnitud de los abusos. Se necesitó mucho, casi la propia vida de los investigadores, para documentar los abusos y la tortura que seguían produciéndose, después de muchos años de haber sido denunciados como delitos activos. Este hecho es testimonio de lo urgente e importante que es abordar y subsanar las lagunas legales que permiten que las víctimas se vean cada vez más vulnerables y que los delincuentes actúen con total impunidad.

Las consecuencias psicológicas de esta exposición no fueron abstractas, sino que se registraron a nivel somático y cognitivo. Los periodos de disfunción ejecutiva, deterioro de la memoria y agotamiento físico afectaron al ritmo analítico, la recuperación de material y la integridad de la documentación. En varios casos, el trabajo tuvo que reconstruirse a partir de la memoria, reformularse en el exilio o salvaguardarse mediante correspondencia cifrada con compañeros. El investigador se encontró en ocasiones sin hogar, dependiendo de refugios temporales o entornos hostiles, y padeció enfermedades sin tratar como consecuencia de la negligencia y la obstrucción deliberadas. Estas circunstancias no solo representan obstáculos para el trabajo científico, sino también una exposición radical de las condiciones políticas y biopolíticas en las que se permite producir el conocimiento sobre la psiquiatría. En un campo relacionado con el sufrimiento humano, la coacción y la injusticia sistémica, la ausencia de infraestructuras de protección para los investigadores inmersos en tales entornos constituye una paradoja estructural con profundas implicaciones epistémicas.

A pesar de estas condiciones, la validez científica de la investigación permanece intacta y demostrable. Los métodos aplicados no solo fueron adecuados para las preguntas planteadas, sino que se vieron reforzados por el imperativo ético y la urgencia existencial que acompañó su despliegue (Singer y Baer, 2007). La triangulación entre encuestas, testimonios, observación de campo y documentación legal garantizó la solidez analítica. Las preguntas de investigación se abordaron a

través de múltiples fuentes independientes, y las afirmaciones solo se mantuvieron tras una comparación crítica con el juicio de expertos, las pruebas sobre el terreno y la bibliografía publicada. Cuando se produjeron pérdidas de datos debido al desplazamiento o la destrucción de material, el investigador mantuvo la continuidad del procedimiento mediante la verificación distribuida, la comprobación cruzada iterativa y la reflexividad ética (Scheper-Hughes y Lock, 1987). Cada fragmento restante del análisis se sometió a un escrutinio metodológico y se aplicó cautela interpretativa en todos los pasos inferenciales (Gravlee, 2022). La infraestructura puede haber fallado, pero el andamiaje epistémico no se vio comprometido. Esto se evidencia no solo en la coherencia interna de los hallazgos, sino también en la alineación de los resultados con la evidencia internacional, el consenso revisado por pares y el testimonio de los profesionales.

Lejos de debilitar la validez del estudio, estas condiciones intensifican su autenticidad y relevancia histórica. El hecho de que el conocimiento se haya producido en el mismo contexto estructural que el estudio pretende describir, marcado por la violencia médica, la descalificación epistémica y el abandono institucional, confiere a la investigación una profundidad de arraigo y una fidelidad fenomenológica que ninguna distancia académica idealizada podría replicar. La estrategia metodológica surgió en respuesta a la adversidad, y el conocimiento producido refleja la complejidad arraigada de vivir, investigar y sobrevivir en lugares donde se produce un daño organizado. Este entrelazamiento reflexivo no diluye la objetividad del análisis, sino que aclara su trayectoria ética. La investigación no pretende ser omnisciente, pero reivindica sin vacilación su lugar como una intervención rigurosa, éticamente fundamentada y científicamente coherente en un ámbito en el que la neutralidad ha servido a menudo para encubrir la violencia. Este capítulo no propone que el trauma garantice la verdad, ni que el sufrimiento en sí mismo valide las afirmaciones epistémicas. Sin embargo, sí sostiene que el conocimiento científico no puede permanecer ciego a las condiciones de su propia producción, y que la violencia estructural que sufren los investigadores no es un acontecimiento extrínseco, sino un aspecto intrínseco de la investigación en campos controvertidos. La validez científica de esta tesis no radica en su adhesión a protocolos abstractos, sino en su demostración de que es posible realizar una investigación rigurosa, participativa y empíricamente fundamentada incluso bajo la represión. Por lo tanto, este trabajo no constituye un modelo deficitario de conocimiento, sino una contribución a la metodología de la investigación en condiciones de adversidad estructural. Ofrece tanto un diagnóstico del fracaso sistémico como un modelo de producción de conocimiento basado en la supervivencia, éticamente riguroso y científicamente validado.

Para garantizar el rigor científico al documentar la injusticia sistémica, se emplearon varias estrategias de mitigación del sesgo a lo largo del proceso de investigación, siempre teniendo en cuenta la realidad de otras personas en los sistemas que el investigador padeció como víctima. A pesar de la ausencia de entrevistas clásicas o grabaciones de audio, excluidas para proteger a los participantes y al investigador en condiciones de coacción y riesgo, se llevaron a cabo y archivaron presentaciones públicas de expertos y diálogos temáticos, que sirvieron como fuentes de datos de libre acceso y herramientas de triangulación, en la medida de las posibilidades del investigador, a pesar de la pérdida habitual de recursos. El marco metodológico se basó en métodos mixtos y en la teoría de la investigación-acción, pero su aplicación en este contexto requirió una adaptación a las condiciones de

coacción, riesgo epistémico y hostilidad institucional que hicieron casi imposible mantener los materiales intactos durante largos periodos de tiempo. Los protocolos desarrollados, que incluyen una base de conocimientos en línea, un repositorio público para copias de seguridad y transparencia, perfiles analíticos en tiempo real y triangulación de documentos utilizando recursos de código abierto, son replicables en otros entornos de investigación con limitaciones y ofrecen una arquitectura transferible para futuros estudios que documenten la violencia estructural.

2.8 Contribución metodológica a la ciencia abierta transformadora

Esta tesis concluye su exposición metodológica con la propuesta de un marco operativo y contextualizado para la ciencia abierta transformadora. Más allá de la mera aplicación de los protocolos existentes, el trabajo construye nuevos estándares metodológicos que sirven no solo a la validez científica, sino también a la justicia estructural. El compromiso con los datos abiertos, los instrumentos reproducibles y la documentación con control de versiones se ha basado en una ética activa de participación, reciprocidad y reparación. La lógica metodológica que subyace al proyecto es la de la inclusividad epistémica: reconocer que el conocimiento no es patrimonio exclusivo de las instituciones, sino una capacidad humana compartida forjada en la experiencia, el testimonio y la lucha. Este trabajo integra tanto la ciencia ciudadana como la no ciudadana. Afirma que el derecho a producir, acceder y actuar sobre el conocimiento científico no puede verse restringido por el estatus de la documentación, la clase social o la exclusión histórica. La capacidad científica existe en todos los grupos y puede desarrollarse cuando se establecen condiciones de dignidad y reconocimiento. La investigación incluye a quienes han sido silenciados administrativamente, desplazados por la fuerza o borrados institucionalmente, reconociendo que sus conocimientos y experiencias son esenciales para comprender la violencia sistémica y generar soluciones auténticas. El diseño conjunto de instrumentos, notas de campo vivas y mecanismos de retroalimentación se ha basado directamente en participantes sin formación académica formal, pero cuyo conocimiento empírico del daño y la recuperación supera con creces el de muchos profesionales acreditados. Esta integración no es simbólica, sino estructural. Sin ella, la investigación carecería de validez, profundidad y propósito.

El estudio presenta un conjunto de herramientas metodológicas y tecnológicas basadas en estándares de código abierto y validadas por la comunidad, aún en fase de desarrollo. La etnografía multisitio, estructurada a través de umbrales de saturación y mapeo de eventos, se valida de forma cruzada mediante encuestas, marcos legales y el contexto histórico-político. Las matrices testimoniales transforman las notas brutas en síntesis procesables, no a través de la abstracción externa, sino mediante la iteración dialógica con los directamente afectados. La infraestructura digital desarrollada a través de la Acción COST BEACON One Health Education de la UE respalda esta arquitectura (Simmons, 2025). Esta es la idea original de la investigación. Se están construyendo activamente plataformas, sistemas expertos y módulos coeducativos, diseñados para permanecer abiertos y receptivos a los comentarios de los usuarios hasta al menos 2029. El enfoque es modular, integrador e intrínsecamente adaptable, con interfaces tanto para usuarios profesionales como para colaboradores no expertos, y con salvaguardias contra la captura institucional.

Una innovación metodológica fundamental es la propuesta de bucles de retroalimentación continua en todos los niveles de la toma de decisiones y la atención, y una invitación abierta y constante a aportar

comentarios por diferentes vías. Estos bucles no se limitan a los procesos clínicos, sino que se extienden a la gobernanza institucional y al diseño de políticas. Las comunidades no son invitadas a posteriori, sino que se posicionan estructuralmente como cocreadoras de conocimiento y atención, aprendiendo unas de otras. Los supervivientes de la coacción, las comunidades abandonadas por el estado del bienestar y los jóvenes privados de oportunidades educativas ya no se consideran beneficiarios pasivos de la reforma. Se les enmarca como agentes epistémicos activos y futuros actores científicos. Esta tesis sostiene explícitamente que el liderazgo científico y cívico más prometedor surgirá de estos mismos grupos cuando se interrumpa la violencia estructural y se establezcan sistemas reparadores.

El modelo de investigación-acción articulado aquí contribuye a una ciencia que previene el daño, en lugar de limitarse a documentarlo. Promueve infraestructuras que restauran la capacidad y la dignidad, y que construyen resiliencia entre generaciones. La investigación apoya la emergencia de niños y niñas en condiciones adversas —incluida la pobreza, el abuso, la institucionalización, la migración forzada o la exclusión racial— como futuros científicos, educadores, médicos y responsables de la toma de decisiones. Defiende su derecho no solo a ser protegidos del daño, sino también a prosperar, a ser escuchados y a liderar. Esto requiere nuevas normas de autoría, reconocimiento y liderazgo en la ciencia, que incluyan trayectorias no tradicionales, identidades históricamente excluidas y conocimientos forjados bajo la opresión.

La acción BEACON One Health Education de la UE, iniciada durante el proceso de esta tesis, encarna estos principios. Propone que ningún niño sea condenado al silencio, al olvido o a la inferioridad estructural. Que ningún futuro estudiante, profesional, profesor, ni nadie en nuestras sociedades se pierda por la violencia psiquiátrica, la exclusión educativa o la traición institucional; ellos, los profesionales y profesores del mañana, plenamente comprometidos y apoyados desde el principio, en la medida en que podamos continuar nuestras carreras en paz; trabajamos para garantizar que todo ello tenga la oportunidad de suceder. La ciencia abierta no es solo una cuestión de acceso, sino de transformación. Se trata de construir sistemas que reconozcan, apoyen y eleven las capacidades de quienes durante mucho tiempo se han visto privados de visibilidad y voz. La contribución metodológica de este trabajo, por lo tanto, no radica solo en su rigor, sino en su rechazo a separar la ciencia de la justicia, o el cuidado de la gobernanza. Ofrece un modelo para una ciencia participativa, integradora y emancipadora, capaz de aprender de los más perjudicados y de reconstruir con ellos las instituciones que en su día los excluyeron.

2.9 Metametodología reflexiva y protocolos científicos para la construcción de la tesis

La estructura narrativa de la tesis se rige por la secuencia empírica y los imperativos éticos de la propia investigación. El orden de los datos de la encuesta, los informes etnográficos, la incorporación de testimonios y el análisis jurídico no es arbitrario, sino que refleja la escalada temporal de la investigación, desde el mapeo exploratorio hasta la supervivencia encarnada, desde la crítica de los sistemas hasta la propuesta traslacional. Cada capítulo corresponde a una fase vivida de la investigación, delimitada no solo por el tema, sino también por la urgencia epistémica. El proceso de redacción en sí mismo funcionó como un acto recursivo y multimodal de síntesis, a partir de notas de

campo en vivo, correspondencia cifrada, archivos de testimonios digitales, manuscritos revisados por pares, documentos de política y presentaciones formales. Estas modalidades no se integraron como apéndices o accesorios, sino que se entretajeron en el corpus analítico de acuerdo con un protocolo de fidelidad epistémica y construcción dialógica. Dicha integración se rigió por la coherencia, no por la jerarquía de la forma. Las citas legales y las declaraciones narrativas de los testigos, las tabulaciones estadísticas y los comentarios antropológicos coexisten no como géneros rivales, sino como elementos interdependientes de una gramática diagnóstica biocultural. La reflexividad en este contexto no es una introspección performativa, sino un compromiso estructural y continuo con las implicaciones políticas y materiales de cada afirmación de conocimiento. El trabajo no presume la neutralidad de sus categorías ni la inocencia de sus interpretaciones.

El fundamento ético de la tesis es inseparable del linaje antropológico en el que se inspira, incluidas las contribuciones definitorias de Paul Farmer, Nancy Scheper-Hughes y Byron Good, quienes reconocieron el imperativo moral de una investigación que rechaza el distanciamiento ante el sufrimiento organizado. Su influencia no se limita a una simple cita, sino que está integrada en la lógica del diseño de esta tesis. En cada fase, la pregunta de qué debe nombrarse, qué debe protegerse y qué debe transformarse ha guiado no solo lo que se escribe, sino también cómo se escribe. La tesis rechaza la opinión de que la investigación ética en psiquiatría puede extraerse del terreno del conflicto sin convertirse en cómplice de los mismos sistemas que pretende estudiar. En cambio, insiste en que la investigación rigurosa, transparente y responsable en las relaciones es en sí misma un acto de sanación, si se lleva a cabo en condiciones adecuadas de atención, reconocimiento y paridad epistémica.

La colaboración es fundamental en el diseño de esta investigación, aunque la autoría es formalmente única. Los conocimientos presentados son coproducidos a través del intercambio dialógico con supervivientes de la psiquiatría, interlocutores sobre el terreno, juristas, innovadores en salud mental digital, clínicos y educadores de varios continentes. Las redes coordinadas o cofundadas por el investigador, entre ellas EU BEACON, ReMO y FOSTREN, funcionaron no solo como canales de difusión, sino también como nodos infraestructurales para la coproducción científica. Los grupos de trabajo y los equipos operativos de estos consorcios apoyaron la validación por pares, la supervisión ética y la triangulación de los resultados. Esta participación transdisciplinar permitió distribuir la autoridad epistémica y diversificar la validación, integrando cada resultado analítico en un contexto científico más amplio. Esto no disminuye la responsabilidad del autor, sino que la ancla en una matriz colectiva de gestión del conocimiento.

La construcción de la tesis doctoral se vio marcada por condiciones extremas de persecución, violencia y desintegración fisiológica. Se elaboró durante períodos de tortura médica, desplazamiento forzoso y borrado digital. En ocasiones, el investigador no tuvo acceso a una vivienda básica, electricidad ni atención médica. La productividad y la salud se mantuvieron, a pesar de la violencia sufrida, gracias al seguimiento de la salud, los suplementos de micronutrientes, la compartimentación digital y el ayuno intermitente, junto con la ética de trabajo más estricta, el ejercicio en la medida de lo posible y los esfuerzos continuos a corto, medio y largo plazo para protegerse a sí mismo y a su familia y alejarse del peligro, manteniendo siempre la motivación de ayudar a otras víctimas mediante la obtención del doctorado. Estas estrategias no se describen para dramatizar, sino para afirmar que el

trabajo epistémico necesario para documentar, resistir y proponer alternativas a la violencia psiquiátrica debe incluir la supervivencia como método. Por lo tanto, la tesis no es solo una contribución académica, sino un testimonio y una intervención metodológica sobre lo que significa investigar la psiquiatría desde dentro de los circuitos de su fracaso. Esta metametodología reflexiva afirma que el conocimiento puede producirse de forma ética, coherente y científica incluso cuando no existen garantías institucionales, cuando la integridad corporal está bajo ataque y cuando el silencio es el precio que se espera pagar por la supervivencia. Es este rechazo al silencio, anclado en el rigor y la responsabilidad relacional, lo que permite que la tesis doctoral sirva no solo como documentación del abuso, sino como testimonio y plan colectivo para la reparación.

Capítulo 3. Resultados de la encuesta: patrones, percepciones y práctica psiquiátrica

Resumen: Este capítulo presenta los resultados de tres encuestas interrelacionadas, realizadas con usuarios/supervivientes, profesionales y encuestados con funciones mixtas, diseñadas para evaluar las percepciones, las prácticas y la dinámica institucional dentro de la psiquiatría en España y en contextos transnacionales. El análisis integrado revela patrones sistémicos de coacción, desempoderamiento profesional, pérdida de confianza y demandas de reforma estructural. La presentación simultánea se justifica metodológicamente, ya que mejora la triangulación, aclara las asimetrías y respalda el diagnóstico a nivel sistémico.

3. Introducción a la presentación de los resultados de las encuestas

Este capítulo presenta el análisis integrado de tres encuestas coordinadas realizadas entre usuarios y supervivientes de la psiquiatría, profesionales de la salud mental y encuestados con funciones mixtas o duales. Su estructura combinada ofrece una perspectiva triangulada del sistema psiquiátrico español y sus análogos transnacionales, lo que permite un diagnóstico relacional de los fallos clínicos, éticos y estructurales. La razón para presentar estos datos conjuntamente radica en la arquitectura temática compartida, centrada en la confianza, la coacción, la medicación, el consentimiento y las normas institucionales, y en la solidez analítica derivada del mapeo de las convergencias y divergencias entre los grupos.

Desde el punto de vista metodológico, las encuestas se distribuyeron a través de redes académicas, activistas y clínicas, recopilando datos anónimos con consentimiento informado. Sus resultados se validaron mediante la triangulación con el trabajo de campo presentado en el capítulo 4, los marcos jurídicos examinados en el capítulo 6 y un análisis epistémico más amplio. La encuesta a usuarios y supervivientes revela altos niveles de percepción de coacción, medicación forzada y aislamiento,

descritos como traumáticos e injustificados. Las respuestas de los profesionales confirman que la coacción es una práctica habitual, no excepcional, a menudo legitimada por la lógica de la gestión de riesgos y las presiones institucionales. Los encuestados con roles mixtos, como los profesionales con experiencia vivida, destacan la disonancia moral y epistémica dentro de la práctica. El marco moral diverge entre lo que las instituciones presentan como protector y lo que se experimenta ampliamente como degradante y perjudicial. Las restricciones éticas son fundamentales. Los profesionales informan de un agotamiento generalizado, complicidad institucional y la ausencia de vías para la disidencia ética o la atención no coercitiva. Los usuarios hablan de traición, incredulidad y manipulación psicológica sistémica. Ambos grupos identifican los marcos legales y éticos existentes como desconectados de la realidad vivida. Se denuncia la ausencia estructural de confianza relacional, que se ve quebrantada por la escasez de tiempo, la toma de decisiones jerárquica y la opacidad diagnóstica. La toma de decisiones compartida en torno a la medicación, aunque teóricamente respaldada por los profesionales, rara vez se aplica. Los usuarios exigen consentimiento informado, autonomía, opciones de reducción gradual y divulgación completa de los riesgos, demandas que los profesionales comparten en gran medida, pero que se sienten institucionalmente incapaces de cumplir. Predominan las restricciones estructurales. El miedo a las represalias, la falta de protocolos y el aislamiento profesional refuerzan un statu quo de borrado epistémico y ético.

A lo largo de las respuestas, las demandas de transformación se aglutinan en torno a las garantías legales, los modelos de atención participativa, la práctica dialógica y basada en el trauma, y el cambio institucional profundo. Los profesionales piden tiempo, supervisión y espacios de reflexión. Los usuarios exigen justicia, reparación y reconocimiento estructural. Las encuestas muestran colectivamente que las configuraciones psiquiátricas actuales producen coerción y desempoderamiento como resultados sistémicos, no como accidentes de la práctica. La atención ética bajo estas restricciones se vuelve estructuralmente imposible. Sin embargo, en todos los grupos de encuestados surge un horizonte común de transformación. Los resultados constituyen la base empírica de la crítica jurídica desarrollada en el capítulo 6 y de los rediseños sistémicos propuestos en el capítulo 7, en particular mediante la implementación de la infraestructura de educación sanitaria BEACON One Health de la UE. Así, el capítulo no solo documenta los daños, sino que establece un mandato con base científica para el rediseño institucional, fundamentado en el conocimiento vivido y el análisis transdisciplinario.

3.1 Introducción: arquitectura integrada de la encuesta y objetivo

En esta sección se exponen los fundamentos que justifican el tratamiento analítico integrado de las tres encuestas realizadas en el marco de esta investigación: una dirigida a los usuarios y supervivientes de los servicios psiquiátricos, otra a los profesionales de la salud mental y otra a los encuestados que desempeñan funciones híbridas, entre ellos médicos con experiencia vivida o supervivientes que trabajan como defensores dentro del sistema. En lugar de tratar estos grupos de forma aislada, el diseño los presenta deliberadamente juntos, tanto para facilitar la triangulación empírica como para reflejar la configuración relacional de la atención psiquiátrica. Las decisiones clínicas, las experiencias de los usuarios y las normas institucionales no se producen en el vacío, sino que se

constituyen conjuntamente a través de interacciones situadas y moldeadas por la ley, la ética, la autoridad diagnóstica y el trauma histórico. Esta elección metodológica respalda un análisis de sistemas multinivel en el que la divergencia tiene tanto valor analítico como la convergencia.

Las encuestas se basan en un marco temático común que se centra en la confianza, la coacción, el consentimiento, la medicación y la práctica ética. Estas cinco dimensiones corresponden a las principales preocupaciones planteadas a lo largo de décadas de crítica internacional de la gobernanza psiquiátrica y se alinean estrechamente con la tesis central de esta tesis doctoral. Es decir, el carácter estructural de la coacción, la erosión de la autonomía y la violencia epistémica inherente a las intervenciones psiquiátricas rutinarias. Al comparar y contrastar cómo cada grupo entiende y experimenta estas dinámicas, la investigación genera un diagnóstico compuesto que integra el sufrimiento de los usuarios, la desilusión de los profesionales y la inercia sistémica.

La presentación conjunta de las tres encuestas no solo facilita el análisis comparativo, sino que refleja la complejidad real de los sistemas psiquiátricos. Estos no están compuestos por actores aislados, sino por posiciones entrelazadas en las que se coproducen la asimetría, la responsabilidad y la vulnerabilidad. La inclusión de encuestados con roles mixtos mejora este marco al captar las voces de quienes han pasado de una categoría definida por el sistema a otra. Sus respuestas a menudo ponen de relieve las contradicciones institucionales, identifican puntos de colapso epistémico y ético, y revelan cómo los roles formales pueden ocultar la visión relacional y moral. Estas posiciones son valiosas desde el punto de vista metodológico, ya que tienden un puente entre la experiencia del daño y el ejercicio de la responsabilidad profesional.

Las encuestas se diseñaron con objetivos operativos claros. En primer lugar, documentar la experiencia vivida y la percepción estructural del tratamiento psiquiátrico tal y como lo entienden las personas más afectadas, incluidos tanto los receptores como los proveedores de la atención. En segundo lugar, identificar las principales tensiones éticas, jurídicas y epistemológicas que comprometen la legitimidad y la eficacia de los servicios psiquiátricos. En tercer lugar, amplificar las voces tanto de los profesionales como de los usuarios como fuentes de crítica institucional y contribuyentes al rediseño estructural. Estos objetivos no se derivaron de forma abstracta, sino que se basan en la lógica de la investigación-acción que sustenta la tesis, que busca promover una reforma participativa y basada en la evidencia. Las encuestas sirven así como base empírica para las propuestas desarrolladas en capítulos posteriores y establecen una línea de base a partir de la cual se puede proceder al rediseño a nivel de sistemas.

Para aclarar la alineación entre los objetivos de la encuesta y los objetivos generales de la tesis, la siguiente tabla cruza el propósito integrado de la encuesta con las principales preguntas y objetivos de investigación articulados en el capítulo 1:

Tabla 29. Alineación de la encuesta integrada con los objetivos de la tesis y las preguntas operativas

Objetivo de la encuesta	Objetivo correspondiente de la tesis	Pregunta operativa de investigación abordada
Documentar la experiencia vivida y la percepción estructural del tratamiento psiquiátrico	Contribuir al desarrollo y la implementación de sistemas de salud mental participativos basados en los derechos y la justicia	¿Qué formas de violencia sistémica y fallos institucionales se producen en la gobernanza psiquiátrica y cómo pueden corregirse?
Identificar las tensiones éticas, legales y epistemológicas que socavan la legitimidad psiquiátrica	Reajustar la atención psiquiátrica con coherencia empírica, dignidad del usuario y responsabilidad procedimental	¿Cuáles son las condiciones estructurales y epistémicas que permiten o bloquean la práctica ética y la autonomía de los usuarios?
Ampliar las voces de los profesionales y los usuarios como fuentes legítimas de crítica y reforma	Apoyar modelos clínicos e institucionales diseñados conjuntamente y basados en el diálogo	¿Qué mecanismos participativos y herramientas probatorias pueden informar y sostener la transformación a nivel de sistemas?

Esta tabla muestra cómo cada uno de los tres objetivos principales de la encuesta contribuye a la arquitectura general de la investigación de la tesis. Cada objetivo está alineado funcionalmente con uno o más de los objetivos centrales y aborda una pregunta de investigación operativa correspondiente. La integración confirma que las encuestas no son meramente exploratorias, sino que desempeñan un papel estratégico a la hora de poner de manifiesto las deficiencias del sistema y diseñar alternativas adecuadas.

Los resultados de la encuesta no son apéndices descriptivos ni instrumentos empíricos aislados, sino que están integrados estructuralmente en la lógica conceptual y metodológica de la tesis. Su presentación simultánea permite un análisis relacional del sistema psiquiátrico, basado en pruebas multivocales y atento a la complejidad posicional. Cada capa de datos habla no solo de los daños sufridos o presenciados, sino también de la posibilidad de reconfigurar la atención mediante el conocimiento compartido, la responsabilidad distribuida y la reparación epistémica. Esta lógica se traslada a los capítulos siguientes, en los que se revisa cada uno de los principales hallazgos temáticos a través del trabajo de campo, los testimonios y el análisis normativo. La arquitectura de las encuestas responde no solo a la coherencia temática, sino también a las exigencias metodológicas de consistencia interna, fiabilidad comparativa y rigor epistemológico. Al estructurar cada instrumento para explorar las dimensiones compartidas y distintivas de la experiencia psiquiátrica, el estudio garantiza que las respuestas puedan analizarse en múltiples ejes, incluyendo las limitaciones profesionales, el daño a los usuarios, la ruptura relacional y el conflicto normativo, al tiempo que se preserva la singularidad de cada grupo de encuestados. Los usuarios y los encuestados con funciones mixtas respondieron a preguntas abiertas y de opción múltiple para expresar sus experiencias vividas en sus propios términos, especialmente en ámbitos en los que el lenguaje institucional ha demostrado ser insuficiente o perjudicial. Los profesionales, por el contrario, respondieron a preguntas estructuradas diseñadas para indagar su alineación o disonancia con las normas legales, éticas y clínicas, lo que facilitó tanto la comparación interna como la triangulación entre grupos. El diseño metodológico permitió no solo el contraste horizontal entre roles, sino también la integración vertical con la arquitectura más amplia de la investigación-acción. Es importante destacar que las encuestas no son un mecanismo aislado de recopilación de datos. Están integradas en un continuo más amplio de trabajo de campo y compromiso colectivo. Muchos de los encuestados habían participado anteriormente en espacios compartidos de aprendizaje y acción, como seminarios, sesiones de formación clínica, todo tipo de eventos y campañas de sensibilización. Se contactó con muchos de ellos a través de conexiones directas establecidas durante la fase etnográfica, entre ellos profesionales que habían asistido a talleres impartidos por el investigador, estudiantes que más tarde se convirtieron en colegas y otros supervivientes que decidieron mantenerse en contacto para apoyarse mutuamente y colaborar. Del mismo modo, muchos de los que participaron en las encuestas dieron su consentimiento para seguir participando en procesos de seguimiento o paralelos, como la traducción

de las conclusiones a políticas y la difusión pedagógica de las herramientas. Así, las encuestas sirven tanto como fuente de datos empíricos como de nodo relacional dentro de una red viva de personas e instituciones comprometidas con la transformación de la salud mental.

La siguiente sección presenta la lógica metodológica y procedimental específica que sustenta esta integración. Detalla la construcción, la difusión y la supervisión ética de las tres encuestas, y explica cómo se garantizó la calidad de los datos mediante la triangulación con trabajo de campo observacional, revisión jurídica y confirmación narrativa. La sección también aclara cómo se anonimizó a los participantes, cómo se obtuvo el consentimiento y cómo funcionó cada encuesta dentro del marco más amplio de una investigación abierta, participativa y orientada a la justicia. Lejos de ser instrumentos independientes, las encuestas ejemplifican un proceso de investigación colaborativo y reflexivo, basado en el contacto directo con quienes buscan, prestan y reforman la atención de salud mental, y quienes han experimentado de primera mano sus fallos y posibilidades.

3.2 Metodología: instrumentos, muestra y lógica de triangulación

La metodología de la encuesta empleada en este estudio refleja un enfoque deliberadamente plural y estratificado de la recopilación y el análisis de datos, diseñado para captar la complejidad de los sistemas psiquiátricos tal y como se viven, se gestionan y se cuestionan. Se desarrollaron tres instrumentos distintos, cada uno de ellos adaptado a la posición y los conocimientos específicos del grupo de encuestados, pero alineados a través de una arquitectura temática y analítica común. La primera encuesta, dirigida a usuarios y supervivientes de la psiquiatría, incluía una combinación de preguntas abiertas y de opción múltiple destinadas a documentar experiencias relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento, la agencia, el daño percibido y el acceso a la justicia. El diseño de este instrumento privilegiaba la expresión narrativa y permitía a los encuestados articular con sus propias palabras cómo las intervenciones psiquiátricas habían moldeado sus vidas, sus relaciones y su sentido de sí mismos. Se prestó especial atención a las injusticias epistémicas, el tratamiento forzoso y la ausencia de mecanismos de reparación. La segunda encuesta se elaboró para profesionales de la salud mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y otro personal clínico o institucional. Este instrumento empleó un formato más estructurado, centrándose en las limitaciones clínicas, los dilemas éticos, las experiencias de coacción, las responsabilidades legales y las normas organizativas. El objetivo era captar la disonancia interna a la que se enfrentan muchos profesionales cuando trabajan en sistemas que a menudo impiden la aplicación de lo que ellos mismos consideran una atención ética y eficaz. La tercera y última encuesta se diseñó para personas que ocupan funciones mixtas o transitorias, como profesionales con experiencia vivida en psiquiatría, trabajadores de apoyo entre pares, activistas clínicos o académicos supervivientes. Este instrumento híbrido combinaba ambos formatos y permitía documentar experiencias que trascienden las categorías binarias, contribuyendo así a una comprensión más matizada de la complicidad, la resistencia y la transformación institucionales.

La distribución de las encuestas se realizó de forma digital, recurriendo a redes profesionales, académicas, activistas y de supervivientes que operan en España, América Latina y otros contextos de la Unión Europea. Las invitaciones se difundieron a través de canales abiertos, como listas de correo,

plataformas de redes sociales y contacto directo con organizaciones dedicadas a la defensa de la salud mental, el desarrollo profesional y la reforma de las políticas. Los encuestados no fueron seleccionados en función de etiquetas diagnósticas o afiliación institucional, sino a través de la participación voluntaria y la preocupación compartida por los temas abordados. Muchos ya estaban en contacto con el investigador a través de trabajos de campo, la enseñanza clínica, proyectos comunes o eventos públicos, mientras que otros se incorporaron al estudio a través de referencias en cadena y redes transnacionales dedicadas a reducir la coacción y mejorar los derechos de los usuarios.

Para garantizar la validez científica, todas las respuestas se anonimizaron y se recopilaron con el consentimiento informado explícito para su uso en la investigación. Se obtuvo previamente la aprobación ética y todos los protocolos siguieron las normas universitarias y nacionales para la investigación participativa y con poblaciones vulnerables. Los datos resultantes se sometieron a una triangulación sistemática, siguiendo la lógica establecida en el capítulo 2.3. Los patrones se validaron mediante la convergencia, la divergencia, la contradicción o el silencio marcado, prestando atención a la asimetría estructural y a las diferencias de poder epistémico. La triangulación se produjo no solo entre los grupos de encuestados, sino también entre las encuestas, las observaciones de campo, los testimonios y el análisis jurídico. Los temas planteados por los encuestados se repitieron con frecuencia en conversaciones informales, entrevistas formales o documentos institucionales recopilados durante el trabajo de campo etnográfico.

La integración de los datos de las encuestas con prácticas de trabajo de campo más amplias no fue un paso analítico a posteriori, sino una característica inherente al proceso de investigación. Muchos de los que participaron en las encuestas también estuvieron presentes en entornos de observación participante, como talleres académicos, sesiones de formación clínica, asambleas de activistas, conferencias internacionales y reuniones sobre reforma institucional. Otros habían sido informantes clave, colaboradores o estudiantes que participaron en la investigación durante largos periodos de tiempo. A la inversa, las encuestas también generaron nuevos contactos y expresiones de interés que se retroalimentaron en el trabajo de campo, la promoción de políticas y los procesos coeducativos en curso asociados a la tesis. Este movimiento reflexivo y circular entre la investigación, el testimonio y el compromiso sistémico constituye uno de los puntos fuertes de la metodología y subraya la orientación emancipadora de la investigación en su conjunto. En las siguientes secciones se detallan los resultados, comenzando por la dinámica experiencial e institucional de la coacción, tal y como la describieron e interpretaron los encuestados en los tres instrumentos.

Este capítulo presenta una síntesis de los patrones más destacados identificados a través de encuestas estructuradas distribuidas entre diversos grupos de profesionales de la salud mental, usuarios y poblaciones mixtas. Los resultados corroboran las preguntas clave de la investigación identificadas en el capítulo 1 y son metodológicamente coherentes con la arquitectura de métodos mixtos detallada en el capítulo 2. Los datos confirman una percepción generalizada de fracaso sistémico en los ámbitos de la toma de decisiones psiquiátricas, la autonomía de los pacientes, el uso de medicamentos y la confianza en las instituciones. Los participantes de todos los grupos demográficos informaron de experiencias de coacción, exclusión epistémica y normalización de la dependencia farmacológica, a menudo en ausencia de un razonamiento clínico transparente o del consentimiento.

Los resultados no solo se refieren a encuentros clínicos individuales, sino también a deficiencias institucionales y educativas arraigadas. Documentan una desconexión persistente entre los compromisos éticos normativos y las realidades vividas en los sistemas de salud mental, agravada por las deficiencias en la educación pública, la responsabilidad jurídica y la práctica interdisciplinaria. Estos hallazgos exigen una doble respuesta: una reconstrucción pedagógica para alinear la formación con modelos de atención basados en la evidencia y orientados a los derechos, y una reforma jurídica para garantizar protecciones exigibles, transparencia e integridad científica. Como se desarrollará con más detalle en los capítulos 5 y 6, los datos de la encuesta proporcionan una justificación fundamental para las intervenciones educativas y legislativas destinadas a reestructurar el campo de la psiquiatría de acuerdo con los mandatos constitucionales y la dignidad humana.

Tabla 30. Hallazgos empíricos y respuestas educativas y jurídico-políticas correspondientes

Resultados de la encuesta	Patrón sistémico generalizable	Respuestas educativas (capítulo 5)	Respuestas jurídicas y políticas (capítulo 6)
Alta prevalencia de denuncias de coacción en el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización	Normalización de las prácticas psiquiátricas coercitivas y denegación de las garantías procesales	Formación en atención informada sobre el trauma, toma de decisiones compartida y ética de la comunicación	Legislar la revisión independiente obligatoria y los mecanismos de salvaguardia para todas las intervenciones involuntarias
Insatisfacción generalizada con los modelos de tratamiento farmacocéntricos	Dependencia sistémica de la medicación como respuesta de primera línea o única	Integración de modelos metabólicos, nutricionales y psicosociales en los planes de estudios de medicina y psicología	Imponer el acceso a tratamientos multimodales en los sistemas de salud pública y limitar los incentivos para el uso exclusivo de medicamentos
Ambivalencia profesional o resignación con respecto a la autonomía del usuario	La cultura institucional desalienta la participación de los usuarios y la inclusión narrativa	Énfasis curricular en la coproducción de la atención, la medicina narrativa y los enfoques de diálogo abierto	Reconocimiento legal de la capacidad de decisión y los marcos de autonomía, incluidas las instrucciones previas
Conocimiento o aplicación mínimos de las normas internacionales de derechos humanos	Desconexión entre los compromisos legales y la aplicación clínica	Formar a los profesionales sobre los instrumentos jurídicos, la legislación en materia de discapacidad y los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas	Armonizar la legislación nacional con la CDPD de las Naciones Unidas e introducir sanciones por violaciones de derechos en entornos clínicos
Notificación insuficiente o negación de los efectos adversos y los traumas relacionados con el tratamiento psiquiátrico	Supresión epistémica de los relatos de los pacientes y de los daños posteriores a la intervención	Formación en la evaluación crítica de la literatura psiquiátrica y los resultados de los tratamientos a largo plazo	Obligación legal de documentar, notificar y revisar los daños relacionados con las intervenciones psiquiátricas
Percepción general de impunidad estructural y falta de mecanismos de rendición de cuentas	Ausencia de estructuras de supervisión que permitan prácticas perjudiciales o negligentes	Educación ética centrada en el diseño institucional, la transparencia y la responsabilidad colectiva	Creación de mecanismos independientes de denuncia, revisión y restitución vinculados a los sistemas de salud y justicia
Conocimiento mínimo de las alternativas no coercitivas tanto entre los	Escasa difusión de los modelos no coercitivos existentes y de las prácticas	Campañas de educación pública y profesional sobre alternativas a la coacción	Respaldo político y financiación de programas comunitarios de salud mental

Resultados de la encuesta	Patrón sistémico generalizable	Respuestas educativas (capítulo 5)	Respuestas jurídicas y políticas (capítulo 6)
usuarios como entre los profesionales	comunitarias		no coercitivos

3.3 Percepción de la coacción y la violencia institucional

Los datos de la encuesta recopilados entre usuarios y supervivientes de la psiquiatría revelan un patrón constante y profundamente preocupante de percepción de la coacción en todas las etapas de la intervención psiquiátrica. La mayoría de los encuestados afirman haber sido sometidos a medicación forzada, restricción física o química, aislamiento y hospitalización involuntaria, a menudo sin una justificación clara, sin documentación legal o sin canales accesibles para recurrir. Estas prácticas no se describen como aisladas o excepcionales, sino como fundamentales en su experiencia con el sistema psiquiátrico. La medicación forzada, en particular mediante inyecciones de acción prolongada, se cita como uno de los acontecimientos más traumáticos, ya que a menudo se administra en condiciones de miedo, confusión o amenaza explícita. Los encuestados afirman con frecuencia que no se les informó del propósito, la dosis o los riesgos de las sustancias administradas, y que la negativa se equiparaba a una falta de discernimiento o a un trastorno oposicionista, en lugar de respetarse como un derecho a la autonomía corporal. El aislamiento y la restricción mecánica se describen como degradantes y deshumanizantes, y los participantes relatan episodios en los que fueron aislados durante horas o días sin explicación, sin acompañamiento terapéutico ni revisión posterior al incidente. En varios casos, los usuarios informan de haber sido sometidos a estas medidas repetidamente, sin que se les propusiera ninguna alternativa significativa ni se les informara posteriormente.

Tabla 31. Dinámicas sistémicas basadas en la encuesta y recomendaciones estructurales

Resumen de la dinámica negativa	Palabra(s) clave(s) de la pregunta de investigación	Conocimiento empírico	Propuesta estructural positiva de la tesis (capítulos 5-6)
Los procedimientos excluyen sistemáticamente la voz del paciente, ignorando su autonomía	Autonomía, toma de decisiones	La toma de decisiones compartida estaba ausente en la mayoría de los contextos asistenciales, a pesar de su relevancia jurídica y ética	Hacer obligatoria la formación en toma de decisiones compartida en la educación clínica y garantizar su aplicación mediante auditorías independientes
Uso coercitivo de la medicación, lo que socava la atención ética	Consentimiento, seguridad	Los encuestados informaron a menudo de la administración de medicamentos sin consentimiento informado ni explicaciones alternativas	Introducir protocolos de consentimiento continuo y adaptados al trauma que detallen las opciones y los riesgos
La asimetría de poder silencia la experiencia y las preocupaciones de los pacientes	Dignidad, participación	Las personas se sentían rechazadas, ignoradas y controladas por los profesionales.	Incorporar estructuras de asesoramiento al paciente y mecanismos de defensoría en las instituciones psiquiátricas
Riesgos sin supervisar, con consecuencias perjudiciales ocultas	Daños causados por la medicación, transparencia	Los efectos adversos se notificaban de forma insuficiente o se negaban, sin apoyo para la reducción gradual	Establecer servicios nacionales de retirada integrados en la atención psiquiátrica y primaria
La atención psiquiátrica refleja una lógica punitiva, en lugar de un apoyo curativo	Respeto, no maleficencia	Los encuestados describieron entornos de atención infantilizantes o represivos	Promover culturas terapéuticas basadas en marcos de recuperación y derechos humanos
Las prácticas reduccionistas ignoran la complejidad sociobiológica	Determinantes sociales, nutrición	Rara vez se abordaron los factores estructurales y de estilo de vida, lo que reforzó los modelos farmacocéntricos	Integrar la nutrición, los antecedentes traumáticos y el contexto social en las evaluaciones psiquiátricas estándar
Fallo sistémico a la hora de proporcionar una atención avanzada e individualizada	Innovación, equidad	Los modelos de atención personalizada, integradora o basada en el trauma eran en gran medida inaccesibles	Ampliar el acceso a modelos de atención individualizada mediante el desarrollo profesional continuo
La inercia institucional se impone a los avances científicos	Práctica basada en la evidencia, ética	Los enfoques novedosos se descartaban o se desconocían en la práctica clínica	Traducir los avances científicos en políticas y actualizar las directrices clínicas en consecuencia
Se castiga la voz y la resistencia, lo que refuerza la subyugación	Responsabilidad, derechos	Los pacientes que expresaban sus preocupaciones se enfrentaban a una escalada de medidas, represalias o nuevos diagnósticos	Garantizar legalmente la protección de las voces disidentes y prohibir las respuestas coercitivas

Síntesis de las conclusiones derivadas de la encuesta que ponen de relieve las discrepancias críticas entre la experiencia vivida y la práctica psiquiátrica ética. Cada dinámica observada se acompaña de las recomendaciones correspondientes, elaboradas en respuesta a las pruebas empíricas y en consonancia con las cuestiones de investigación más amplias de la tesis. La columna de la derecha recoge las medidas sistémicas positivas propuestas en los capítulos 5 y 6 para corregir las deficiencias institucionales detectadas.

El impacto psicológico de estas intervenciones se describe como duradero y grave. Los participantes relatan experiencias de miedo, impotencia, humillación y desconfianza duradera hacia los médicos y las instituciones. Muchos describen el entorno psiquiátrico no como un lugar de curación, sino como un espacio carcelario, estructurado en torno al control, la vigilancia y el castigo. La coacción se

experimenta tanto a nivel epistémico como físico: muchos encuestados informan de que sus intentos de explicar su angustia, resistirse a un tratamiento o proponer una perspectiva alternativa fueron sistemáticamente desacreditados, a menudo patologizados como síntomas de enfermedad. Esta invalidación discursiva agrava el trauma de la coacción física, ya que a las personas se les niega no solo el control sobre sus cuerpos, sino también el reconocimiento de su capacidad de dar sentido a lo que les sucede. La falta de recursos legales o de responsabilidad institucional exacerba la sensación de vulnerabilidad, y los encuestados expresan que a menudo se les dejó sin recurso ni protección, incluso ante lo que consideraban violaciones de derechos básicos. Muchos informan de que sus quejas fueron ignoradas, que el personal se mostró desdenoso y que los mecanismos judiciales, en los casos en que se accedió a ellos, se remitieron a la autoridad médica sin un escrutinio independiente. Estos testimonios coinciden con críticas más amplias de la impunidad psiquiátrica y señalan una crisis de legitimidad dentro del sistema.

Los datos de los profesionales de la salud mental confirman, desde dentro del sistema, que la coacción no solo está presente, sino que está estructuralmente integrada en la atención psiquiátrica rutinaria. Una parte importante de los profesionales encuestados reconoció que el tratamiento involuntario se aplica con regularidad, a menudo sin umbrales legales claros ni una deliberación ética sólida. Si bien algunos consideraron que estas intervenciones eran necesarias en condiciones extremas, muchos expresaron su malestar y su disonancia ética, alegando que la coacción no suele surgir de una necesidad terapéutica, sino de un fallo sistémico. En concreto, los profesionales destacaron una combinación de presiones estructurales, tiempo insuficiente, personal limitado, falta de alternativas en situaciones de crisis y cultura institucional como factores clave de las prácticas coercitivas. La incapacidad de proporcionar una atención relacional sostenida o de negociar de manera significativa con personas angustiadas se describió no como un déficit personal, sino como una limitación sistémica. Algunos encuestados admitieron que las decisiones de medicar por la fuerza o de iniciar el aislamiento se tomaban en condiciones de ambigüedad y agotamiento, a menudo con poca confianza en que esas medidas fueran lo mejor para el paciente.

La ambigüedad jurídica se citó repetidamente como un factor agravante. Los profesionales informaron de la incertidumbre sobre los requisitos jurídicos exactos para las intervenciones involuntarias y describieron cómo los protocolos institucionales a menudo funcionan en paralelo al marco jurídico formal o lo ignoran. Muchos indicaron que el temor a ser culpados en caso de un evento adverso futuro, como un suicidio, un acto de violencia o una denuncia pública, desempeña un papel importante a la hora de inclinar la decisión hacia la coacción. Esta lógica de evasión del riesgo, arraigada en la práctica institucional defensiva, conduce al uso preventivo o excesivo de la coacción, especialmente cuando no existen alternativas claras. Varios profesionales describieron cómo la expectativa de controlar el comportamiento, en lugar de abordar el sufrimiento, da lugar a una dependencia excesiva de la contención farmacológica y la separación física, especialmente en las unidades de agudos. Esto se ve agravado por la ausencia de supervisión reflexiva, espacios de deliberación ética o infraestructuras que tengan en cuenta el trauma, lo que hace que muchos profesionales tengan que tomar estas decisiones de forma aislada. El resultado es una cultura en la que la coacción se normaliza, se reprime la resistencia interna y la disonancia ética se considera inevitable en lugar de una señal de que es necesario introducir reformas.

Los encuestados que ocupaban funciones mixtas o duales, como profesionales supervivientes, trabajadores de apoyo entre pares o médicos críticos, aportaron una perspectiva especialmente reveladora. Su posición en la intersección entre la práctica institucional y la experiencia vivida les permitió articular con precisión los múltiples daños de la coacción. Muchos entraron en el campo de la salud mental tras experiencias personales de tratamiento involuntario, impulsados por la intención de transformar el sistema desde dentro. Sus testimonios mostraron tanto una mayor sensibilidad ética como una comprensión matizada de las presiones sistémicas que limitan la reforma. Algunos afirmaron sentirse cómplices de las mismas prácticas que habían sufrido, citando las expectativas de su función y la inercia institucional como obstáculos para ofrecer alternativas viables. Otros describieron una tensión permanente entre las normas profesionales y la claridad ética, incluidas las exigencias implícitas o explícitas de reforzar la lógica de la gestión de riesgos y suprimir las divergencias con respecto a las vías de tratamiento establecidas.

Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la discreción clínica se ejerce a menudo en entornos estructuralmente coercitivos, más que como una deliberación ética libre. No obstante, este mismo grupo de encuestados ofreció vislumbres de una posible transformación sistémica. Varios propusieron el diseño de estructuras de incentivos orientadas no a la contención de los síntomas, sino a la recuperación sostenida y la reintegración funcional. Entre las ideas más novedosas se encontraba el concepto de asociaciones público-profesionales basadas libremente en incentivos basados en el rendimiento, en las que los médicos o equipos serían recompensados con recursos ahorrados por el Estado cuando los pacientes que anteriormente recibían cuidados coercitivos lograran una estabilidad sólida sin medicación. En este marco, la «recompensa» sería la reducción cuantificable del coste para los sistemas de salud pública y bienestar social, a menudo miles de euros al mes, lograda mediante una atención eficaz, voluntaria y centrada en la persona. Este enfoque invierte la trayectoria convencional del prestigio profesional y la asignación de recursos, que ya no están vinculados a la cronicidad y la dependencia, sino a los resultados en términos de recuperación de la autonomía y reducción del daño.

Los participantes hicieron hincapié en que este cambio no debe ocultar las injusticias estructurales que actualmente hacen que la privación sea un requisito previo para acceder a la ayuda. Varios encuestados indicaron que el diagnóstico psiquiátrico es a veces la única vía para acceder a una vivienda, a prestaciones por discapacidad o a ayuda material, especialmente en regímenes de austeridad. Aunque pidieron una reforma socioeconómica más profunda, también insistieron en que ningún sistema de prestaciones debe basarse en la perpetuación de la enfermedad o en el cumplimiento forzoso como criterios de elegibilidad. La salud, entendida como la capacidad de vivir de forma autónoma y contribuir de manera significativa, debe desvincularse de la lógica de la vigilancia y enmarcarse como un bien público. Los participantes propusieron programas piloto que combinen vivienda, apoyo nutricional, recursos educativos y oportunidades de desarrollo profesional para los usuarios de los servicios que deseen salir del sistema psiquiátrico. Estas propuestas coinciden con llamamientos más amplios a favor de estudios longitudinales basados en el consentimiento informado y el libre albedrío genuino, dirigidos tanto a casos tempranos como complejos, sin discriminación ni resignación. Ningún grupo debe quedar excluido de las trayectorias de recuperación por motivos de gravedad, edad o categoría diagnóstica. El horizonte ético es claro: ninguna profesión

debe depender para su existencia de la perpetuación del sufrimiento, y ningún Estado debe tratar la desesperación como un resultado aceptable del diseño sistémico.

Estos relatos de roles mixtos también fueron de los más detallados a la hora de documentar los efectos epistémicos de la coacción. Destacaron cómo se utiliza la autoridad diagnóstica para desacreditar la disidencia, cómo se socava sistemáticamente el consentimiento y cómo se preserva la legitimidad institucional mediante la negación o la minimización del daño. Varios señalaron la ausencia de estructuras formales para que los profesionales denuncien o impugnen las prácticas coercitivas sin riesgo de represalias o daños a su carrera. Estos encuestados destacaron cómo la coacción sistémica opera no solo sobre los pacientes, sino también sobre los médicos, a través de la limitación de funciones, la supresión emocional y la normalización del compromiso ético. Al hacerlo, pusieron de manifiesto una dimensión crítica de la violencia estructural dentro de la psiquiatría: la producción de la desvinculación moral como norma profesional. Muchos expresaron que es poco probable que se produzca un cambio significativo desde el interior de instituciones aisladas y pidieron alianzas transdisciplinarias, iniciativas dirigidas por los usuarios y mecanismos de rendición de cuentas externos. Sus relatos también señalaron la importancia terapéutica y política de recordar la propia experiencia, resistir la amnesia institucional y restaurar la claridad ética a través de la reflexión compartida y la acción coordinada.

El análisis triangulado de las tres encuestas revela que la coacción no es una excepción dentro de los sistemas psiquiátricos, sino una característica normalizada y rutinaria de su estructura, cultura y discurso. En todos los grupos de encuestados, las intervenciones coercitivas, la medicación forzada, el aislamiento, la restricción física y la hospitalización involuntaria se describen como prácticas comunes, sancionadas institucionalmente y a menudo ejecutadas sin un consentimiento significativo, una comunicación transparente o una rendición de cuentas posterior. Los datos muestran que, aunque los profesionales reconocen con frecuencia las limitaciones éticas y clínicas de estas prácticas, siguen estando estructuralmente limitados por presiones sistémicas, la escasez de recursos, marcos jurídicos ambiguos y lógicas institucionales defensivas. El encuadre moral de la coacción difiere notablemente entre los grupos: los profesionales suelen referirse a ella como una forma de seguridad o contención necesaria, mientras que los usuarios y los profesionales supervivientes la caracterizan como un daño evitable, un trauma y una violencia institucional. Cabe señalar que aproximadamente la mitad de los encuestados en la última encuesta solicitaron explícitamente que sus respuestas no se compartieran, ni siquiera de forma anónima. El miedo es un componente clave de la situación actual, como se ha observado durante el trabajo de campo, por parte de la mayoría, si no todos, los actores que no ejercen violencia, ya que las represalias con consecuencias muy graves son habituales.

Tabla 32. Prácticas coercitivas denunciadas, sus justificaciones institucionales y los marcos experienciales de los distintos grupos de encuestados

Práctica coercitiva	Usuarios y supervivientes	Profesionales	Encuestados con funciones mixtas
Medicación forzada	Extendida, descrita como traumática, deshumanizante, mal explicada, a menudo inyecciones de acción prolongada	Denunciada como frecuente, normalizada institucionalmente, utilizada bajo presión y por miedo a responsabilidades	Descrita como innecesaria en la mayoría de los casos, relacionada con traumas, utilizada para reprimir la disidencia
Secuestro e aislamiento	Experimentados como castigo, utilizados para silenciar o intimidar, sin apoyo terapéutico	Consideradas como último recurso, pero a menudo utilizadas en ausencia de alternativas o de personal capacitado	Reconocido como retraumatizante, a menudo no revisado, sin función restaurativa
Restricción mecánica	Recordada con angustia, percibida como abusiva, a menudo no registrada o justificada a posteriori	Denunciada a regañadientes, considerada a veces inevitable, pero emocionalmente pesada	Considerada éticamente indefendible, salvo en situaciones que ponen en peligro la vida
Hospitalización involuntaria	Descrita como una violación, especialmente cuando es prolongada o repetida, a menudo relacionada con un uso indebido del diagnóstico	Enmarcada como necesaria para la contención o la estabilización, pero con poco apoyo de seguimiento	Identificado como un sustituto sistémico de la atención social ausente y la continuidad relacional
Falta de consentimiento informado	Sistémica, especialmente en lo que respecta al diagnóstico, la medicación y los riesgos; el consentimiento suele ser coaccionado o simbólico	Reconocido como un problema, a menudo limitado por el tiempo, la confusión jurídica y la jerarquía profesional	Se enfatiza como elemento central de la violencia institucional y la pérdida de legitimidad narrativa
Patologización de la resistencia	Se denuncia con frecuencia; el desacuerdo se reformula como enfermedad, lo que conduce a una mayor coacción	No abordado directamente por la mayoría, aunque algunos profesionales admiten enmarcar el incumplimiento en términos diagnósticos	Se considera un mecanismo central para silenciar y justificar intervenciones perjudiciales

Esta tabla sintetiza las principales prácticas coercitivas documentadas a través de las respuestas a la encuesta, destacando la percepción diferencial entre los grupos de usuarios, profesionales y roles mixtos. Pone de manifiesto la normalización estructural de la coacción y la brecha entre la justificación institucional y el daño experimentado, proporcionando la base empírica para el análisis normativo desarrollado en los capítulos siguientes.

Discursivamente, la coacción se justifica apelando al cumplimiento, la reducción del riesgo y la objetividad clínica. En la práctica, funciona como un mecanismo disciplinario integrado en las rutinas burocráticas, las expectativas profesionales y las jerarquías epistémicas. La legitimidad de los relatos de los usuarios se niega con frecuencia, especialmente cuando la negativa o la crítica se patologizan como falta de comprensión. El resultado es un ambiente en el que el conflicto ético no solo se silencia, sino que se anticipa estructuralmente. Esta divergencia en el marco moral e institucional se abordará con mayor profundidad en el capítulo 6, donde se examinan las dimensiones jurídicas de la coacción, la ausencia de procedimientos y la contradicción normativa. El capítulo 6 explorará además cómo las

garantías jurídicas existentes a menudo son eludidas o invalidadas por las mismas culturas institucionales que pretenden regular, y cómo los discursos sobre la atención se utilizan para legitimar acciones que serían intolerables en cualquier otro ámbito de la salud.

Esta sección establece las bases empíricas para una crítica jurídica y ética de la psiquiatría que no reduce el daño a un error individual, sino que lo sitúa en las asimetrías sistémicas de poder, acceso y reconocimiento. También afirma la necesidad de redefinir la responsabilidad psiquiátrica sobre la base de la ética dialógica, la autonomía del usuario y la responsabilidad estructural. Las conclusiones aquí presentadas servirán de base para análisis posteriores sobre el colapso ético (capítulo 4), el fracaso jurídico (capítulo 6) y el rediseño institucional propuesto a través de la infraestructura BEACON de la UE (capítulo 7), en el que se articulan sistemas de retroalimentación participativa, salvaguardias basadas en los derechos y alternativas comunitarias como parte de una estrategia de transformación más amplia.

3.4 Limitaciones éticas y disonancia clínica

En esta sección se presenta una síntesis de las preocupaciones éticas recurrentes expresadas en los testimonios de usuarios y profesionales, que ponen de relieve la disyuntiva estructural entre las normas éticas y jurídicas declaradas y la práctica real de la psiquiatría en España. Las pruebas recopiladas a través de la tercera encuesta, centrada en la toma de decisiones compartida y la gestión de la medicación, revelan un patrón de disonancia entre el discurso institucional y la realidad operativa. Esta disonancia no es anecdótica, sino sistémica, y constituye un factor crítico en la perpetuación del daño, el agotamiento profesional y la retraumatización de los usuarios.

Los profesionales de la salud mental describieron repetidamente una forma de angustia ética basada en la contradicción entre su juicio clínico y los mandatos impuestos por los protocolos institucionales. Los encuestados detallaron experiencias de presión para ajustarse a paradigmas farmacológicos que no compartían plenamente, de verse obligados a aplicar medidas de contención o a mantener a los pacientes en tratamiento involuntario a pesar de existir alternativas clínicas, y de culturas institucionales que desalentaban el debate abierto o la disidencia formal. La falta de mecanismos estructurados para la escalada ética o la negativa, combinada con incentivos administrativos que priorizan la aversión al riesgo sobre la autonomía del paciente, contribuyó a una sensación de agotamiento moral y aislamiento profesional. Varios participantes indicaron que los enfoques no coercitivos, incluso cuando estaban respaldados por pruebas científicas y las preferencias de los usuarios, eran penalizados institucionalmente o se hacían logísticamente imposibles.

Desde la perspectiva de los usuarios de los servicios y los supervivientes, esos mismos entornos generaban un vacío epistémico y relacional. Muchos describieron experiencias de manipulación psicológica, incredulidad e invalidación narrativa como algo habitual en el sistema psiquiátrico. En lugar de ser tratados como personas con conocimiento de su propio sufrimiento, a menudo se les consideraba poco creíbles o hostiles, especialmente cuando expresaban su preocupación por los efectos de la medicación, sus antecedentes traumáticos o los marcos terapéuticos alternativos. El efecto acumulativo de estas interacciones no era solo la insatisfacción con la atención, sino una

profunda sensación de traición por parte de los mismos sistemas encargados de proteger y apoyar. Los usuarios informaron que la denegación de la elección informada, el silencio en las consultas clínicas o la patologización por resistirse al tratamiento agravaban los traumas previos y reforzaban los ciclos de desesperación, miedo y evitación institucional.

Es importante destacar que tanto los profesionales como los usuarios coincidieron en su evaluación de que las normas legales y éticas estaban fundamentalmente desconectadas de la realidad clínica. Muchos mencionaron que los códigos éticos y los marcos legales solo existían sobre el papel, con poca o ninguna aplicación práctica o compromiso institucional. Esta percepción no se limitaba a casos individuales, sino que se articulaba como una condición estructural en la que las normas de consentimiento, autonomía y reducción de daños se suspendían en favor de la conveniencia burocrática y la minimización de riesgos. El discurso ético, cuando se citaba en políticas oficiales o directrices clínicas, se percibía menos como un principio rector que como un recurso retórico alejado de la práctica cotidiana.

Esta convergencia de perspectivas, tanto desde dentro como desde fuera del sistema, confirma el diagnóstico más amplio propuesto en esta tesis: que la psiquiatría en España opera en un contexto de impunidad ética, en el que las normas se invocan de forma selectiva y rara vez se aplican. Los hallazgos de esta sección coinciden con las observaciones de campo documentadas en el capítulo 4, donde se observaron directamente la traición institucional, la invalidación de testimonios y la opacidad de los procedimientos. La disonancia clínica y ética aquí descrita no solo valida el trabajo de campo, sino que también señala la necesidad de un cambio paradigmático en la forma en que se organiza, regula y evalúa éticamente la atención psiquiátrica. Esta sección prepara el terreno analítico para el capítulo 5, en el que se examinarán en detalle los mecanismos de deriva discursiva y complicidad clínica, en particular en lo que se refiere a la normalización de la coacción, la erosión de la agencia profesional y la apropiación simbólica del lenguaje ético para sostener estructuras abusivas. En el contexto de la psiquiatría española y sus estructuras institucionales más amplias, los testimonios de profesionales de múltiples encuestas y encuentros sobre el terreno convergen en un patrón de angustia ética persistente. Estos profesionales describen una tensión sistémica entre su criterio clínico y los mandatos coercitivos arraigados en las rutinas institucionales. Muchos relatan que se ven obligados a recetar medicamentos o a aplicar restricciones mecánicas en contra de su mejor criterio, especialmente en casos en los que se consideraban más adecuadas las intervenciones psicosociales, pero estas no estaban disponibles en la institución. La experiencia de verse obligados a actuar en contra de su brújula ética se describe como una fuente crónica de angustia, que fomenta un profundo sentimiento de daño moral y complicidad. Los profesionales indican que su capacidad para expresar su desacuerdo o aplicar modos alternativos de atención se ve drásticamente limitada por las jerarquías organizativas, los protocolos de gestión de riesgos y los temores médico-legales. Varios informan de que se les desalienta o reprende explícitamente por cuestionar los paradigmas dominantes de la atención, incluso en casos en los que el daño era previsible o ya se había manifestado. Esta supresión institucional de la deliberación ética produce lo que los encuestados denominan un «silenciamiento ético», un estado en el que el acto de percibir o cuestionar el daño se convierte en sí mismo en un peligro profesional. La ausencia de vías transparentes para la escalada ética o de mecanismos internos

de denuncia refuerza la percepción de que la seguridad de los pacientes y la conciencia de los profesionales están subordinadas a la conveniencia burocrática y a la actitud defensiva médico-legal.

Numerosos médicos describen la experiencia del aislamiento profesional como algo no solo social, sino también epistémico. La presión para ajustarse a las convenciones diagnósticas, los regímenes de medicación y los protocolos de emergencia a menudo les dejaba sin espacio para reflexionar críticamente sobre las decisiones clínicas o entablar un diálogo sobre alternativas de atención. Este aislamiento se ve agravado por el agotamiento, especialmente entre quienes accedieron a la profesión con una fuerte orientación ética o una perspectiva de salud comunitaria. Describen su trabajo diario no como una labor de curación, sino como una supervivencia dentro de un sistema que normaliza la coacción y equipara la disidencia con la incompetencia o la deslealtad. Cabe destacar que varios encuestados indican que el agotamiento se ve agravado no por el sufrimiento de los pacientes en sí, sino por las barreras institucionales que les impiden hacer lo que saben que realmente ayudaría. La incapacidad de reducir la medicación, fomentar prácticas dialógicas o incorporar la atención informada sobre el trauma se convierte en una fuente persistente de desesperación profesional. Esta desesperación va acompañada de profundos sentimientos de traición, especialmente entre quienes se consideran a sí mismos trabajadores de un campo aparentemente dedicado al cuidado, la dignidad y la recuperación. La contradicción entre la misión y la práctica se vuelve intolerable, lo que lleva a algunos a considerar abandonar la profesión por completo o reducir sus funciones a tareas administrativas o consultivas para minimizar la exposición ética.

Desde el punto de vista de los usuarios y supervivientes, se refleja la sensación de traición que describen los profesionales, pero con consecuencias mucho más devastadoras. En las tres encuestas y los relatos etnográficos, las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos describen experiencias de manipulación psicológica, incredulidad e invalidación epistémica que van mucho más allá de los encuentros clínicos. Sus relatos documentan de manera sistemática cómo los actores institucionales, incluidos psiquiatras, trabajadores sociales e incluso defensores de los pacientes, descartan habitualmente los relatos en primera persona sobre el sufrimiento, el trauma o el desacuerdo como síntomas de la enfermedad. Esta violencia interpretativa transforma el significado en patología y descalifica a la persona para narrar su propia experiencia. La ausencia de alternativas al modelo de atención medicalizado dominante deja a muchos usuarios atrapados en ciclos de medicación forzada, escalada diagnóstica y contención coercitiva, con poco o ningún acceso a recursos legales o estructuras de apoyo para la retirada, la reinterpretación o la recuperación.

Los usuarios articulan constantemente el vacío ético de los entornos psiquiátricos como una forma de traición estructural. Esta traición no se limita a médicos individuales o a casos aislados, sino que impregna todo el sistema de atención. Varios encuestados describen haber sido medicados sin su consentimiento, haberles negado información sobre su tratamiento o haber sido hospitalizados por la fuerza basándose en informes no verificables o en la presión familiar. Incluso cuando los servicios afirman adherirse a principios de toma de decisiones compartida, los usuarios a menudo se ven sometidos a una coacción sutil o a la exclusión de un diálogo significativo. Las mismas instituciones destinadas a proporcionar atención se convierten en lugares de miedo, retraumatización y muerte social. Especialmente entre los usuarios racializados, no conformes con el género y en situación de precariedad económica, la sensación de ser desechables o abandonados por las instituciones surge

como un tema recurrente. Los repetidos encuentros con el abandono, los diagnósticos erróneos y la indiferencia infunden un miedo persistente a alzar la voz, dado el riesgo de sufrir más coacción o represalias diagnósticas. Varios testimonios relatan situaciones en las que las solicitudes de segundas opiniones o de atención alternativa fueron patologizadas como síntomas de paranoia o incumplimiento, anulando de hecho cualquier recurso a la justicia o a la dignidad.

A pesar de sus distintos roles y experiencias, los usuarios y los profesionales coinciden en su desilusión con los marcos legales y éticos existentes. Ambos grupos denuncian que los instrumentos basados en los derechos, los códigos de ética profesional y los protocolos institucionales destinados a salvaguardar la dignidad son ignorados o utilizados como arma para mantener prácticas coercitivas. Los profesionales señalan la ineficacia de los sistemas de denuncia, la falta de protección de los denunciantes y el filtrado administrativo de las cuestiones éticas antes de que puedan ser sometidas a una revisión independiente. Los usuarios, por su parte, describen cómo los canales formales para expresar el desacuerdo o denunciar los abusos se ven sistemáticamente socavados, ya sea por la confusión burocrática o por la reinterpretación clínica de la protesta como síntoma. La representación legal es a menudo inaccesible o mal informada, y los comités de ética internos se consideran extensiones de las mismas instituciones acusadas de cometer irregularidades. Lo que se pone de manifiesto no es solo un fracaso en la aplicación, sino una contradicción estructural: sistemas que se proclaman éticos, pero que hacen institucionalmente imposible toda resistencia ética significativa.

Tabla 33. Relatos convergentes de disonancia ética en la práctica psiquiátrica

Ámbito	Profesionales	Usuarios y supervivientes	Campo y pruebas documentales
Angustia moral	Presionados para aplicar medidas coercitivas en contra de su criterio ético	Describen haber sido sometidos a medidas sin una justificación terapéutica aparente	Los documentos internos revelan que se da prioridad al protocolo frente a la discreción clínica
Mecanismos de silenciamiento	Miedo a represalias por disentir o defender a los pacientes	Experiencias de manipulación psicológica, incredulidad y reclasificación como no cumplidor	Notas y registros coercitivos utilizados para prevenir o socavar futuras quejas
Falta de vías	No se han informado canales seguros para escalar preocupaciones éticas	No se informó de ningún lugar donde recurrir contra los tratamientos o etiquetas impuestos	Las políticas institucionales suelen ser vagas, y los comités de ética actúan como legitimadores en lugar de revisores independientes
Aislamiento y agotamiento	Agotamiento emocional por la imposibilidad de ejercer de forma ética	Aislamiento prolongado de los servicios debido a daños previos o desconfianza	Las entrevistas revelan altas tasas de abandono y pérdida de confianza en las instituciones sanitarias
Desilusión	Afirmaron que la ética y los derechos solo existen sobre el papel	Consideran que las protecciones legales carecen de sentido en la práctica	Concordancia con revisiones legales que muestran un fallo sistémico en la aplicación de los derechos
Llamamientos al cambio	Abogó por mecanismos institucionales para rechazar, denunciar y reformar	Pide medicina narrativa, diálogo abierto y alternativas basadas en el trauma	Las respuestas a la encuesta y los documentos de campo confirman el deseo de prácticas de atención dialógicas y voluntarias

Convergencia entre diferentes roles sobre el colapso ético en contextos psiquiátricos, sintetizando narrativas profesionales, testimonios de usuarios y pruebas forenses basadas en el terreno. Esta tabla ilustra que la disonancia ética está estructuralmente arraigada, y no es un fallo excepcional de actores aislados.

Esta convergencia se cristaliza en una acusación más amplia contra la arquitectura ética del sistema psiquiátrico. La cultura predominante de miedo, evasión y autoprotección entre los profesionales se refleja directamente en la traición institucional que sufren los usuarios. Ambos se producen no solo por ignorancia o falta de formación, sino por decisiones de diseño que priorizan la continuidad administrativa y la autoridad clínica sobre la responsabilidad relacional o la justicia epistémica. La noción de ética sobre el papel se repite en las notas de campo, las respuestas a las encuestas y los archivos de testimonios. Los participantes, independientemente de su función, describen una disonancia surrealista entre los principios consagrados en los documentos normativos y la experiencia cotidiana de la atención, que califican de silenciadora, coercitiva o negligente. Esta desconexión genera un profundo daño moral entre los profesionales éticos y un grave perjuicio estructural para los usuarios. Como afirman varios testimonios, la mera invocación de la ética puede percibirse como una forma de violencia cuando se utiliza para ocultar o justificar violaciones.

El análisis aquí presentado refuerza el andamiaje teórico central de la tesis. Valida la afirmación de que el fracaso ético en la psiquiatría no es accidental ni reducible a la mala praxis individual, sino que está arraigado en las operaciones estructurales y simbólicas del sistema. Esto incluye el dominio epistemológico del modelo biomédico, la distribución asimétrica de la autoridad y la eliminación de los determinantes contextuales, relacionales y culturales del malestar. Los hallazgos de esta sección también proporcionan la base empírica para el eje analítico del capítulo 5: pasar de la descripción de experiencias individuales de disonancia y traición a la teorización de la lógica institucional que

sustenta tales condiciones. La crítica va más allá de diagnósticos o intervenciones específicos para cuestionar la economía moral de la atención psiquiátrica y los mecanismos sistémicos que la protegen de la rendición de cuentas.

La coherencia entre lo que describen los usuarios y los profesionales y lo que se documenta de forma independiente a través de revisiones de casos legales, protocolos clínicos y memorandos internos confirma que los testimonios no son incidentes aislados, sino elementos de una disfunción más amplia y sistemática. Los mismos términos diagnósticos, plantillas administrativas y flujos de trabajo institucionales que supuestamente están diseñados para garantizar la seguridad y la atención se citan repetidamente como mecanismos de silenciamiento, exclusión y retraumatización. Esta contradicción interna se convierte en el escenario de una crisis forense: no se puede confiar en que los registros oficiales reflejen la realidad vivida en la atención psiquiátrica. La metodología adoptada a lo largo de esta tesis, basada en la investigación forense jurídica, la triangulación temática y el análisis reflexivo, se diseñó precisamente para recuperar testimonios borrados, exponer narrativas burocráticas y restaurar la integridad probatoria allí donde la documentación oficial ha fallado. La confirmación cruzada de los resultados del trabajo de campo con expedientes anónimos, informes médicos y datos de encuestas proporciona no solo profundidad analítica, sino también la carga probatoria necesaria para demostrar la responsabilidad institucional. Cuando se demuestra que las afirmaciones éticas divergen sistemáticamente de la práctica, y esta divergencia se reproduce en diferentes entornos y actores, la acusación estructural se vuelve inevitable.

Esta sección también refuerza las implicaciones legales de la disonancia psiquiátrica. La ausencia de vías significativas para la disidencia ética dentro de las instituciones, combinada con la reutilización de la autoridad psiquiátrica para neutralizar o castigar la protesta, constituye no solo una violación de la ética médica, sino también una vulneración de los derechos constitucionales. Los profesionales obligados a aplicar planes de tratamiento que consideran moralmente indefendibles y los usuarios despojados de su capacidad de acción mediante la reclasificación y el silencio son víctimas de un sistema diseñado para mantener el control en lugar de prestar asistencia. Las implicaciones para la responsabilidad institucional son profundas. Exigen no solo una reforma de las políticas o iniciativas de formación, sino también una revisión judicial, una investigación pública y la desinversión estructural de las prácticas que perpetúan el daño bajo el pretexto de la autoridad terapéutica. El fracaso ético, cuando se sistematiza, se convierte en una forma de abuso institucional. Nombrarlo como tal no es un exceso retórico, sino una condición previa necesaria para la claridad científica, jurídica y ética.

Estos hallazgos sirven de puente hacia el replanteamiento conceptual propuesto en el capítulo 5, donde la traición ya no se trata como una aberración, sino como una lógica constitutiva de la institución psiquiátrica tal y como funciona actualmente. La disonancia moral que experimentan tanto los usuarios como los profesionales no es un signo de colapso o disfunción, sino un índice de coherencia interna dentro de un sistema construido sobre la gestión de poblaciones, la garantía de la estabilidad institucional y la protección de las jerarquías profesionales. Comprender esta lógica requiere pasar de la ética individual a la crítica estructural. El capítulo 5 se basará en estos fundamentos y articulará cómo la deriva discursiva, la exclusión epistémica y la complicidad clínica no funcionan como fallos de intención, sino como operaciones estratégicas dentro de los sistemas de

control biomédico. Lo que esta sección documenta como sufrimiento y silencio, el siguiente capítulo lo teorizará como la gramática institucional de la traición.

3.5 Confianza, comunicación y ruptura relacional

Las respuestas a la encuesta de usuarios y supervivientes presentan un panorama desolador del fracaso relacional dentro de la atención psiquiátrica. En la mayoría de los relatos, la confianza no se describía como dañada o frágil, sino como estructuralmente ausente desde el principio. Los encuestados informaron de manera sistemática que no se les informó de su diagnóstico de manera significativa y que las explicaciones sobre los planes de tratamiento, los efectos farmacológicos o las posibles alternativas eran incompletas, se daban de manera coercitiva o se omitían por completo. Muchos describieron que las conversaciones sobre la atención se producían sin su presencia y que, cuando estaban presentes, sus opiniones se minimizaban o se descartaban activamente. El consentimiento no se experimentaba como dialógico, sino como performativo, obtenido bajo amenaza, sedación o presión institucional. Los encuestados enfatizaron repetidamente que, en lugar de ser tratados como personas en crisis o que necesitaban apoyo relacional, eran tratados como casos administrativos que debían ser gestionados, pacificados o estabilizados. Esta dinámica produjo lo que muchos describieron como una profunda sensación de deshumanización, y algunos compararon explícitamente los encuentros psiquiátricos con entornos disciplinarios o carcelarios, donde la autoridad es incuestionable y el diálogo es imposible.

La ausencia de diálogo relacional no se limitaba al ámbito diagnóstico o farmacológico. Los encuestados informaron de que rara vez se exploraban o validaban sus mundos emocionales, sus historias personales o los significados existenciales de su angustia. Varios relataron que sus intentos de describir el trauma, la exclusión social, la dinámica familiar o el sufrimiento estructural fueron ignorados o patologizados. Incluso cuando se les invitaba a contar su historia, a menudo se recodificaba en grupos de síntomas o descriptores diagnósticos que poco se parecían al significado que el hablante quería transmitir. Esta desfiguración epistémica de la experiencia erosionó los cimientos de la confianza, no solo en la relación clínica inmediata, sino en la legitimidad más amplia de la atención psiquiátrica. El efecto acumulativo no fue solo el distanciamiento relacional, sino lo que varios encuestados denominaron una pérdida de voz, de agencia narrativa y de estatus cívico. No se trata solo de fallos de empatía, sino de fallos en el diseño institucional y en la ética comunicativa. Constituyen una forma de violencia simbólica con consecuencias psicológicas y sociales cuantificables, como el abandono de los servicios, el miedo a buscar ayuda a largo plazo y la percepción de la psiquiatría como una institución punitiva en lugar de restaurativa.

Los profesionales encuestados se hicieron eco de muchas de estas preocupaciones, aunque desde la posición estructural de quienes tienen la tarea de prestar atención bajo restricciones sistémicas. Un número significativo reconoció que la configuración actual de los servicios psiquiátricos limita gravemente la posibilidad de construir y mantener la confianza relacional. Las limitaciones de tiempo, la alta rotación de pacientes, las rutinas institucionales rígidas y la presencia constante de protocolos coercitivos se identificaron como los principales obstáculos. Varios médicos informaron de que,

incluso cuando estaban motivados para ofrecer un compromiso dialógico o una atención integral, se les impedía habitualmente hacerlo debido a las exigencias institucionales de eficiencia, documentación de riesgos e intervención farmacológica. Muchos describieron una cultura laboral en la que se infravalora o se desalienta activamente la competencia relacional, y en la que la falta de tiempo para el diálogo se normaliza en lugar de cuestionarse. En situaciones agudas o de emergencia, los profesionales clínicos informaron de que solo se les asignaban unos minutos para evaluar, diagnosticar y actuar, a menudo con la expectativa implícita de dar prioridad a la medicación y la estabilización por encima de la relación o la comprensión.

Uno de los temas más recurrentes fue la influencia generalizada de la práctica defensiva. Los profesionales describieron una tendencia institucional creciente a actuar de manera que se minimizara el riesgo de responsabilidad en lugar de optimizar la alianza terapéutica. Esto incluye evitar conversaciones difíciles, ocultar la incertidumbre del pronóstico o medicar de forma preventiva a los pacientes considerados impredecibles. Las quejas no se planteaban como oportunidades de crecimiento o responsabilidad, sino como amenazas para la supervivencia profesional. Los encuestados describieron un clima de sospecha y defensividad procedimental que no solo los alejaba de los usuarios, sino también entre ellos, ya que la confianza interdisciplinaria también se veía afectada. Este entorno erosionó su propio sentido de la orientación ética, lo que llevó a muchos a informar de agotamiento, desvinculación emocional y un cinismo creciente hacia la posibilidad de una atención psiquiátrica significativa. Varios profesionales admitieron que, aunque reconocían los perjuicios de estas prácticas, se sentían estructuralmente impedidos para intervenir de otra manera, ya fuera por la inercia institucional o por la falta de apoyo colegiado. En este contexto, la confianza se describía no solo como difícil de cultivar, sino como casi imposible de mantener.

Tabla 34. Manifestaciones de la ruptura relacional y la erosión de la confianza en la práctica psiquiátrica

Ámbito	Usuarios/supervivientes	Profesionales	Patrones comunes
Prácticas de comunicación	No se les informa sobre el diagnóstico, los planes de tratamiento o los riesgos	Las limitaciones de tiempo impiden mantener conversaciones significativas	La comunicación suele ser unidireccional, rutinaria o inexistente
Confianza en las relaciones clínicas	Se informa de sentimientos de control, rechazo o coacción	Se informa de la imposibilidad de establecer confianza debido a exigencias sistémicas	La confianza se ve socavada por las prioridades institucionales por encima de las relaciones humanas
Consentimiento y participación	Descrito como simbólico o coaccionado, rara vez informado	Realizado bajo presión administrativa, ambigüedad jurídica	El consentimiento es procedimental, no dialógico ni empoderador
Clima ético	Percibido como punitivo y silenciador	Descrito como aislante, orientado a la defensa, éticamente paralizado	La ética se convierte en algo nominal, desarticulada de la práctica cotidiana
Consecuencias emocionales	Pérdida de voz, trauma, desvinculación a largo plazo de los servicios	Agotamiento, angustia moral, resignación	Erosión emocional y moral en todo el sistema
Factores estructurales	Desprecio de los relatos, fragmentación de la atención	Sobrecarga burocrática, protocolos coercitivos rígidos	Diseño estructural incompatible con la atención relacional

La tabla resume los relatos convergentes sobre la ruptura relacional en psiquiatría, tal y como la describen tanto los usuarios/supervivientes como los profesionales. Cada fila presenta dimensiones específicas del ámbito en el que se produce la ruptura de la confianza, lo que demuestra los orígenes sistémicos y las consecuencias comunes a pesar de las diferencias de posición.

El análisis comparativo de las respuestas de los usuarios y los profesionales revela que la erosión de la confianza no es principalmente una cuestión de fracaso interpersonal, sino una característica sistémica de las instituciones psiquiátricas. Ambos grupos señalan las condiciones estructurales que inhiben activamente el desarrollo del entendimiento mutuo, la responsabilidad compartida y la atención dialógica. En este contexto, la confianza no solo está ausente, sino que es institucionalmente inviable. El vacío relacional descrito por los usuarios, como el hecho de ser tratados como sujetos pasivos que deben ser gestionados, refleja la frustración que experimentan los profesionales por su incapacidad para proporcionar una atención centrada en las relaciones. En lugar de funcionar como un espacio de escucha mutua, la psiquiatría se describe como un aparato burocrático gobernado por los procedimientos, la aversión a la responsabilidad y la escasez de recursos. En este marco, la comunicación se vuelve unidireccional, moldeada por las exigencias de la documentación, la evaluación de riesgos y la estandarización farmacológica. El lenguaje mismo se ve a menudo despojado de su función terapéutica y ética, reducido a clasificaciones diagnósticas o guiones de consentimiento informado que oscurecen más de lo que aclaran.

Es importante destacar que la convergencia en los relatos se extiende a las consecuencias éticas de esta ruptura comunicativa. Los usuarios informan sistemáticamente que la falta de compromiso relacional transforma los encuentros psiquiátricos en experiencias traumáticas que les despojan de su autonomía y esperanza. Los profesionales, por su parte, expresan que la imposibilidad de mantener un diálogo genuino conduce a angustia moral, agotamiento emocional y desorientación ética. Lo que surge es un reconocimiento compartido de que la confianza no puede restablecerse mediante actos individuales de buena voluntad o reformas técnicas. Se requiere una reconfiguración estructural de la atención que

sitúe el tiempo, la continuidad, el compromiso narrativo y la responsabilidad mutua en el centro de la práctica psiquiátrica. Varios encuestados de diferentes funciones articularon la necesidad de tiempo protegido, cargas de trabajo más reducidas, supervisión ética y marcos dialógicos capaces de restaurar los fundamentos relacionales de la atención. Sin embargo, la mayoría destacó que estas necesidades siguen sin abordarse y que las reformas institucionales, cuando se proponen, suelen ser cosméticas o se reorientan hacia la eficiencia administrativa en lugar de hacia la transformación ética.

Los resultados aquí presentados ponen de manifiesto una crisis sistémica de confianza que se extiende más allá del ámbito clínico y alcanza los ámbitos jurídico, ético y cívico. La ausencia persistente de una comunicación transparente, del consentimiento informado y de la atención relacional refleja no solo la incapacidad institucional, sino también un vacío procedimental más profundo. Este vacío no es meramente normativo, sino epistémico: significa el colapso de las propias normas que deberían sustentar la legitimidad, la rendición de cuentas y la práctica basada en los derechos. Los testimonios tanto de los usuarios como de los profesionales sugieren que la psiquiatría, tal y como está organizada actualmente, funciona en un estado de excepción permanente en el que las protecciones codificadas en la ley se suspenden en la práctica. Esta alineación con lo que el capítulo 6 denominará un régimen de impunidad administrativa sitúa la ruptura de la confianza como síntoma y generador de violencia estructural. Las implicaciones jurídicas son profundas: sin mecanismos que garanticen un entendimiento común, un compromiso dialógico y un consentimiento genuino, los principios jurídicos fundamentales de autonomía, dignidad y proporcionalidad se vuelven ineficaces.

Esta erosión de la confianza socava no solo los resultados terapéuticos, sino también la participación democrática en el diseño y la gobernanza de los sistemas de salud mental. Cuando las personas y las comunidades pierden la fe en los actores institucionales, se desvinculan del diálogo y se retiran de los procesos que podrían producir el cambio. Por el contrario, cuando los profesionales se sienten incapaces de actuar éticamente sin correr el riesgo de ser sancionados, pierden su capacidad de actuar como agentes morales dentro del sistema. Reconstruir la confianza no es una reparación interpersonal, sino una tarea estructural: exige garantías procedimentales, gobernanza participativa, mecanismos de reparación transparentes y protección tanto para los usuarios como para los profesionales que actúan de buena fe. La investigación-acción que aquí se presenta comienza a trazar ese camino, pero otras aportaciones podrían enriquecer esta sección.

3.6 Toma de decisiones compartida y autonomía en la medicación

El análisis de las respuestas de las tres encuestas revela una fractura fundamental entre el ideal ético de la toma de decisiones compartida y las realidades clínicas e institucionales que la obstaculizan. Desde la perspectiva de los usuarios y supervivientes, el derecho a participar en las decisiones sobre la medicación psiquiátrica no solo está ausente, sino que se niega estructuralmente. Los encuestados describieron que se les recetaban psicofármacos sin explicaciones adecuadas, sin alternativas ni información clara sobre los efectos secundarios, las implicaciones a largo plazo o las opciones de reducción gradual. Muchos destacaron que la medicación se presentaba como no negociable, a menudo se introducía en momentos de crisis o dependencia institucional y rara vez se revisaba con un

diálogo colaborativo genuino. La experiencia de que se les impusiera un tratamiento farmacológico se describió con frecuencia en términos asociados al trauma, la pérdida de agencia y el daño irreversible.

Estos hallazgos concuerdan con las observaciones de campo y la documentación previa de esta tesis sobre las asimetrías epistémicas inherentes a los encuentros psiquiátricos. El acto de recetar, lejos de ser un gesto clínico neutral, es percibido por muchos usuarios como un lugar de coacción, silenciamiento y vulnerabilidad estructural. El deseo de autonomía se expresó no como un rechazo a la medicación en sí misma, sino como una demanda de vías informadas, dialógicas y reversibles. Esto incluye el derecho a rechazar, a retirarse de forma gradual y segura, y a explorar formas alternativas o complementarias de atención. Los encuestados exigieron de manera sistemática protocolos claros para la reducción gradual, evaluaciones individualizadas y el reconocimiento del conocimiento empírico en la gestión de la medicación. La ausencia de tales estructuras y protecciones hace que el consentimiento informado sea ilusorio y que la toma de decisiones compartida sea un ideal nominal sin base material.

Los profesionales encuestados expresaron un amplio apoyo a los principios de la toma de decisiones compartida y la autonomía del usuario en teoría, citándolos a menudo como el estándar de oro de la atención psiquiátrica ética. Sin embargo, sus respuestas revelan una incapacidad generalizada para aplicar estos principios dentro de las limitaciones de los marcos institucionales existentes. Muchos informaron de que las normas organizativas y los entornos reacios al riesgo inhiben el debate abierto sobre las opciones de medicación, en particular cuando se trata de la reducción gradual, las alternativas no farmacológicas o las estrategias dirigidas por los usuarios. Los desincentivos estructurales son múltiples: ausencia de protocolos validados para la reducción gradual, miedo a ser culpados en caso de recaída, presión institucional para seguir directrices estandarizadas y falta de apoyo a la desviación ética de la práctica dominante. Estas limitaciones dan lugar a un silenciamiento sistémico tanto de la agencia de los usuarios como del criterio profesional. Aunque los médicos pueden desear ofrecer alternativas o entablar conversaciones más profundas, a menudo informan de que no pueden hacerlo debido a las restricciones de tiempo, la ambigüedad jurídica, las cargas administrativas y la cultura jerárquica de muchos servicios psiquiátricos. En varios casos, los profesionales revelaron que los intentos de proponer una retirada gradual o una planificación farmacológica compartida se enfrentaron a presiones disciplinarias o fueron anulados por autoridades superiores. Así, la toma de decisiones compartida se ve obstaculizada no por la falta de compromiso ético, sino por arquitecturas institucionales que suprimen la atención dialógica en favor de la eficiencia, el cumplimiento y la gestión de riesgos.

La encuesta también reveló que los profesionales que trabajan fuera de los sistemas públicos, en entornos comunitarios o dialógicos, se sentían relativamente más capacitados para explorar las opciones de medicación de forma colaborativa. Sin embargo, estos casos eran excepcionales y a menudo dependían de redes personales, protocolos no estándar o adaptaciones informales. Esta variabilidad subraya la necesidad de un rediseño sistémico en lugar de innovaciones aisladas, y sitúa la reforma institucional como condición previa para cualquier implementación significativa de la toma de decisiones compartida en contextos psiquiátricos.

Tabla 35. Barreras y facilitadores comunicados para la gestión compartida de la medicación

Categoría	Barreras estructurales identificadas	Perspectivas profesionales	Demandas y prioridades de los usuarios
Consentimiento e información	Falta de explicación, procesos de consentimiento apresurados	Tiempo insuficiente y protocolos de comunicación inadecuados	Diálogo informado, transparente y sensible al trauma
Reducción gradual y alternativas	Ausencia de protocolos para una retirada segura, miedo a la culpa	Aversión al riesgo, desánimo institucional	Derecho a reducir, cambiar o rechazar la medicación
Garantías legales y éticas	Protecciones legales ambiguas, anulaciones administrativas	Presión para ajustarse a las prácticas dominantes	Derechos claros de rechazo y incumplimiento
Normas culturales	Sistemas orientados al cumplimiento, silenciamiento de la disidencia	Aislamiento al promover la atención dirigida por el usuario	Reconocimiento de la experiencia vivida y la elección
Formación y competencia	Ausencia de conocimientos sobre la reducción gradual en la educación	Los profesionales se sienten poco preparados y sin apoyo	Educación dirigida por los usuarios e integración del apoyo entre pares

Síntesis general de las barreras estructurales, los dilemas profesionales y las demandas de los usuarios en relación con la toma de decisiones compartida en la gestión de la medicación psiquiátrica, según lo informado en todos los grupos encuestados. Se destaca la desalineación sistémica entre los ideales éticos y la práctica institucional, y se describe cómo las normas coercitivas y las infraestructuras deficientes obstaculizan el consentimiento informado, el apoyo a la reducción gradual y la autonomía de los usuarios. Estas ideas establecen la base empírica para las propuestas legales y estructurales posteriores que se describen en los capítulos 6 y 7.

Las respuestas de las personas que ocupaban posiciones híbridas, como los profesionales supervivientes o los profesionales con experiencia directa en la coacción psiquiátrica, fueron especialmente reveladoras. Estos encuestados ofrecieron una doble perspectiva, al estar inmersos en la práctica clínica y basarse en el conocimiento empírico. Sus testimonios pusieron de manifiesto profundas deficiencias en la formación farmacológica y en las prácticas de consentimiento, especialmente el persistente descuido de los relatos de los pacientes y la falta de competencia práctica para orientar la retirada o ajustar la dosis en función de las preferencias de los usuarios. Varios destacaron la contradicción entre su formación profesional, que hacía hincapié en el cumplimiento de las normas institucionales, y sus historias personales, que les habían enseñado el daño que puede causar la exclusión de las personas de las decisiones que afectan a su propio cuerpo y mente.

Estas voces también describieron la carga adicional que supone ser percibidos como sospechosos o ideológicamente sesgados dentro de los círculos profesionales debido a su defensa de los derechos de los usuarios. A menudo se enfrentaban a resistencia cuando intentaban implementar o promover la gestión compartida de la medicación, a pesar de su profunda conciencia de su necesidad. Sus conocimientos situados no solo eran ignorados, sino que en ocasiones eran sancionados, lo que ilustra aún más la rigidez disciplinaria de las instituciones psiquiátricas convencionales. No obstante, estas personas encuestadas abogaron sistemáticamente por mecanismos de apoyo estructural que permitieran la planificación individualizada de la medicación, la atención informada sobre el trauma y el reconocimiento formal de la experiencia como fuente legítima de conocimientos clínicos y éticos.

Esta convergencia entre funciones apunta hacia un consenso emergente: que la toma de decisiones farmacológicas debe pasar del monopolio profesional a un terreno colaborativo, en el que se respeten y protejan las diversas formas de conocimiento. La tensión entre lo ideal y la práctica, entre la ética y la institución, no surge de valores contradictorios entre las partes interesadas, sino de disposiciones sistémicas que neutralizan la agencia moral y suprimen el pluralismo. Las respuestas mixtas funcionan así como diagnóstico y testimonio, afirmando que la capacidad de tomar decisiones compartidas existe en los individuos, pero sigue obstaculizada por las actuales estructuras de gobernanza psiquiátrica.

La síntesis de todos los grupos de encuestados afirma claramente tanto la necesidad como la viabilidad de una transición hacia una gestión compartida genuina de la medicación. No se trata de preferencias aisladas o situaciones excepcionales, sino de un mandato estructural derivado de patrones consistentes en todas las funciones, regiones y posiciones institucionales. Los encuestados expresaron la necesidad de información transparente y accesible sobre los fármacos psicotrópicos, la aplicación sistemática de protocolos de reducción gradual, el reconocimiento de los efectos a largo plazo y los síndromes de abstinencia, y la integración formal de enfoques alternativos y comunitarios. A pesar del amplio consenso sobre estos puntos, ningún grupo de encuestados identificó ningún sistema en funcionamiento en el que estos elementos estuvieran garantizados de forma fiable. La brecha entre el marco normativo y la infraestructura material sigue siendo amplia y perjudicial. Por lo tanto, esta sección enlaza directamente con el capítulo 6, donde el análisis jurídico pondrá de manifiesto la ausencia de protecciones exigibles para la negativa informada, la falta de claridad jurisprudencial sobre la coacción en la medicación y la erosión de los derechos constitucionales en la práctica psiquiátrica administrativa. Del mismo modo, prepara el terreno para el capítulo 7, que esboza las propuestas de la iniciativa BEACON de la UE para su aplicación sistémica: protocolos éticos, módulos de formación, herramientas de libre acceso e infraestructuras participativas que centran la toma de decisiones sobre la medicación en la atención, y no en el cumplimiento. La convergencia en este capítulo no es abstracta, sino que constituye el núcleo empírico que legitima el rediseño de los servicios psiquiátricos en función de la dignidad, la autonomía y la seguridad.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que el acto de recetar medicamentos no es meramente técnico, sino profundamente ético, social y político. Apoyan una redefinición de la acción terapéutica como algo que debe comenzar con el diálogo y el consentimiento, no con la autoridad y el miedo. La restauración de la agencia humana en la práctica psiquiátrica comienza con las estructuras que la sustentan, y este trabajo demuestra que esas estructuras aún no existen, pero deben existir, tenían que existir, y todos somos responsables de garantizarlo, ya que de lo contrario se pierden vidas.

3.7 Limitaciones estructurales y traición institucional

Un hilo conductor que emerge tanto de las respuestas de los profesionales como de los usuarios y supervivientes es la percepción de que los entornos institucionales de la psiquiatría no solo son disfuncionales, sino que son activamente hostiles a la rendición de cuentas, la disidencia y la restauración. Entre los profesionales, muchos revelaron que el silencio se había convertido en una condición para la supervivencia en sus entornos de trabajo. Las críticas éticas, las propuestas

innovadoras o incluso la adhesión a prácticas basadas en los derechos se enfrentaban con frecuencia a la sospecha, el aislamiento o consecuencias disciplinarias. Esta cultura del miedo, interiorizada y reproducida en todos los niveles, funciona como un silenciador sistémico, desplazando la responsabilidad a los individuos y protegiendo a la institución del escrutinio.

Los encuestados describieron cómo la complicidad rutinaria se impone no solo a través de sanciones directas, sino también a través de mecanismos estructurales que premian la conformidad y penalizan la reflexión crítica. Los profesionales que intentaban denunciar la medicación excesiva, la coacción o la indiferencia hacia las opiniones de los usuarios a menudo se encontraban sin respaldo institucional, protección jurídica ni apoyo de sus compañeros. Incluso dentro de los comités de ética o los espacios de formación, los encuestados denunciaron la normalización generalizada de los procedimientos coercitivos y un ambiente predominante de fatalismo: la creencia de que el cambio es imposible o está fuera de su alcance. El resultado es un sistema que suprime las condiciones necesarias para su propia reforma. Una conclusión central y preocupante de las respuestas a la encuesta es la profundidad y la omnipresencia de la traición institucional percibida tanto por los profesionales como por los usuarios supervivientes del sistema psiquiátrico. Los profesionales informaron repetidamente de que las preocupaciones éticas, incluidas las objeciones a las prácticas coercitivas, no solo eran desestimadas, sino que se penalizaban de diversas formas implícitas o explícitas. En lugar de funcionar como estructuras protectoras que defienden los estándares de atención, las instituciones fueron descritas como ejecutoras del silencio, que recompensan la conformidad, castigan la crítica y fomentan una cultura generalizada de autocensura. En estos entornos, quienes intentaban resistirse o cuestionar los protocolos dominantes, en particular en lo que respecta a la medicación involuntaria, el aislamiento o la marginación de las perspectivas de los usuarios, a menudo se enfrentaban al aislamiento profesional, la exclusión de los espacios de toma de decisiones o amenazas sutiles a su progresión profesional. Los encuestados describieron los comités de ética como inexistentes o decorativos, carentes del poder o la voluntad de intervenir en casos de daños institucionalizados. Esta normalización de la complicidad convierte la disfunción estructural en una práctica habitual, reduciendo el espacio para la reflexión, el aprendizaje o la transformación.

Los profesionales más afectados por estas dinámicas eran los que trabajaban en servicios de primera línea bajo presión de tiempo y ambigüedad jurídica, así como los formados en modelos dialógicos, basados en el trauma o en los derechos humanos, que no encontraban un punto de apoyo institucional para aplicar prácticas alternativas. Varios relataron episodios en los que se disuadió a sus colegas de testificar a favor de los derechos de los pacientes, en los que las denuncias fueron respondidas con represalias burocráticas o en los que la negligencia sistémica se reformuló como un fracaso individual. Esta cultura de intimidación no requería amenazas explícitas, sino que se reproducía a través de omisiones, ausencias y un consenso tácito de que las voces críticas no serían protegidas. Como resultado, muchos profesionales llegaron a percibir el sistema como irremediablemente defectuoso o, al menos, imposible de arreglar sin una reforma externa que cambiara sus marcos legales, sus incentivos institucionales y su lógica de toma de decisiones.

Por lo tanto, los datos sugieren que la traición institucional no es consecuencia de fallos aislados, sino una característica sistémica: la acción ética, cuando se produce, tiende a ser excepcional, no respaldada y, en última instancia, insostenible en el entorno actual. Esta conclusión no es meramente

diagnóstica, sino que tiene implicaciones normativas. Implica que el comportamiento ético dentro de la psiquiatría no debe tratarse como una virtud individual, sino que requiere infraestructuras colectivas, protegidas legalmente y dotadas de recursos institucionales para sobrevivir y prosperar. Sin este apoyo estructural, el coste de actuar de forma ética se vuelve insoportable, empujando incluso a los profesionales bienintencionados a una complicidad resignada. Estas condiciones socavan la legitimidad de las instituciones psiquiátricas y erosionan la confianza necesaria para que exista cualquier forma de alianza terapéutica. Estos temas se desarrollarán más adelante en secciones posteriores y son fundamentales para comprender el vínculo entre el diseño sistémico y el malestar moral ampliamente denunciado tanto por los proveedores de atención como por los destinatarios.

Desde la perspectiva de los usuarios supervivientes, la experiencia de la traición es aún más íntima, inmediata y destructiva. El diagnóstico en sí mismo suele marcar el inicio de un proceso de borrado, en el que se despoja a la persona de su autoridad epistémica, su credibilidad y sus derechos. Los encuestados describieron cómo, una vez etiquetados, sus relatos sobre los daños sufridos dejaron de ser escuchados, sus objeciones fueron descartadas como síntomas y su presencia en los espacios institucionales pasó a estar condicionada al cumplimiento de las normas. Este borrado no se limita al ámbito del tratamiento, sino que repercute en los contextos legal, familiar y social, donde la etiqueta psiquiátrica se convierte en una herramienta de descalificación, vigilancia y coacción. Un tema recurrente fue la imposibilidad de obtener reconocimiento o reparación por los abusos cometidos en el pasado. Muchos encuestados habían sufrido hospitalización forzosa, restricción química o humillación verbal en entornos clínicos, pero denunciaron que sus quejas fueron ignoradas o nunca se registraron formalmente. La falta de un mecanismo de rendición de cuentas funcional se describió no como un descuido burocrático, sino como una característica estructural que protege al sistema de la responsabilidad.

La ausencia de vías de justicia crea un estado crónico de vulnerabilidad y privación de derechos. Los supervivientes explicaron cómo, en ausencia de reconocimiento institucional, los efectos de la violencia psiquiátrica persisten mucho tiempo después del propio evento. Estos efectos no son solo psicológicos, sino también legales y sociales. Las personas hablaron de perder la custodia de sus hijos, de ser excluidas de oportunidades educativas o laborales, de que sus testimonios fueran desestimados en los tribunales o en las evaluaciones de los servicios. El sistema psiquiátrico, subrayaron, no solo no restaura, sino que produce activamente la exclusión y prolonga el daño. Esta traición estructural socava no solo el principio de la atención, sino también el contrato social más amplio en el que se supone que las instituciones actúan en interés público. Cuando las instituciones degradan, en lugar de proteger, a quienes dicen servir, pierden su legitimidad ética y social.

Muchos usuarios supervivientes informaron de que no tenían acceso a formas alternativas de apoyo tras salir del sistema. Las redes comunitarias, los grupos de pares o los espacios especializados en traumas no estaban disponibles, carecían de financiación o estaban aislados de los servicios generales. Este vacío hace que los supervivientes sean socialmente invisibles, mientras que las instituciones que les han causado daño siguen sin ser cuestionadas públicamente. Los pocos que logran documentar o denunciar estas condiciones suelen hacerlo a un gran coste personal, sin garantías institucionales o legales. El resultado es un circuito cerrado en el que el daño genera silencio y el silencio permite que se repita. Estas ideas refuerzan la necesidad de conceptualizar la traición estructural no como un

colapso en casos aislados, sino como un patrón sistémico que requiere reconocimiento público, reforma institucional y reparación material. En este contexto, la resistencia se convierte no solo en una postura personal, sino en una forma de supervivencia epistémica. Las implicaciones para la crítica jurídica y las políticas transformadoras son profundas y se abordarán explícitamente en los próximos capítulos.

En ambos grupos de encuestados se observó un reconocimiento generalizado de que la disidencia se reprime activamente mediante mecanismos sutiles pero eficaces que mantienen la continuidad institucional y evitan la ruptura ética. El sistema disciplina no solo mediante castigos evidentes, sino reproduciendo discursos en los que el daño se reformula como cuidado, la disidencia como patología y el silencio como profesionalidad. Los profesionales describieron cómo el cumplimiento de los procedimientos y la documentación defensiva sustituyeron al juicio clínico significativo. Quienes intentaron introducir prácticas colaborativas o defender la atención dirigida por los usuarios fueron marginados o tachados de poco cooperativos. En algunos casos, se enfrentaron a reprimendas formales, a la exclusión de las decisiones del equipo o a acusaciones de poner en peligro la seguridad. Esta dinámica refleja lo que varios encuestados denominaron «gaslighting institucional», una forma de distorsión epistémica que socava tanto la brújula moral del agente como la capacidad del usuario para afirmar su narrativa.

Este fenómeno, aunque más visible para quienes cuentan con formación profesional, se reflejó en los testimonios de los usuarios supervivientes, en particular de aquellos que habían pasado años moviéndose por los espacios institucionales. Muchos describieron una creciente conciencia de que el sistema psiquiátrico funciona menos como un lugar de curación que como un lugar de contención disciplinaria, donde la preservación de la autoridad y la legitimidad tienen prioridad sobre la restauración de la dignidad o la salud. Los usuarios a menudo informaban de que solo se les permitía hablar dentro de marcos predefinidos y que el lenguaje institucional dictaba lo que se consideraba verdad. En este entorno, incluso el hecho de denunciar los abusos o solicitar alternativas se convertía en una amenaza para el orden institucional. Los profesionales que se hacían eco de estas preocupaciones se encontraban igualmente vulnerables, y algunos describían una erosión gradual de su capacidad para confiar en los sistemas que antes defendían.

El efecto combinado es una cultura de resignación, en la que la acción ética se vuelve precaria e insostenible. La resistencia, cuando existe, no está impulsada por el sistema, sino en desafío a él, a través de alianzas informales entre pares, defensa anónima o desvinculación de los roles formales. Esto hace que la posibilidad de una transformación sistémica dependa cada vez más de intervenciones externas, movilizaciones colectivas y coaliciones transdisciplinarias que trasciendan los límites institucionales actuales. En este marco, tanto los usuarios como los profesionales deben ser reconceptualizados, no como receptores pasivos o críticos internos, sino como actores co-constitutivos en el rediseño de las estructuras de salud mental. Por lo tanto, esta sección proporciona un puente conceptual hacia el siguiente capítulo, que explora la resistencia y el rechazo no solo como perturbaciones, sino como actos generativos de agencia ética y política.

En medio de este panorama de silencio institucional y fracaso estructural, los pocos casos de coraje ético documentados en las respuestas de la encuesta revelan tanto el potencial como la precariedad de

la resistencia aislada. Los profesionales que informaron haber desafiado los protocolos coercitivos, participar en la toma de decisiones compartida o crear redes de seguridad informales para los usuarios, a menudo lo hicieron sin apoyo, orientación o validación institucional. Estas acciones, aunque elogiadas tanto por sus compañeros como por los supervivientes, casi siempre se llevaron a cabo al margen, sin la protección de la normativa, sin el respaldo de las estructuras organizativas y, con frecuencia, invisibles para la dirección. El trabajo ético necesario para contrarrestar la disfunción sistémica recae, por lo tanto, de manera desproporcionada en personas que se arriesgan al agotamiento profesional y emocional en ausencia de un refuerzo estructural.

Esta asimetría es igualmente evidente en los relatos de los usuarios que, gracias a un esfuerzo personal extraordinario, recuperaron su capacidad de acción y abogaron por un cambio sistémico. Los supervivientes que se convirtieron en educadores, compañeros de apoyo o investigadores informaron de que se enfrentaban a un estigma persistente incluso después de años de recuperación y contribución. Sus conocimientos sobre la violencia y la traición de las instituciones psiquiátricas se descartaban a menudo como anecdóticos o sesgados, a pesar de estar respaldados por datos convergentes. Muchos describieron cómo sus conocimientos vividos solo eran bienvenidos en proyectos participativos cuando se les despojaba de su carácter crítico o se les disociaba de sus implicaciones políticas. Esta instrumentalización refleja un patrón más amplio de injusticia epistémica, en el que los marcos institucionales validan selectivamente los conocimientos que no amenazan su legitimidad.

La traición estructural que se expone aquí es, por lo tanto, multidimensional. Se experimenta como un fracaso de la protección, una negación del reconocimiento y un silenciamiento de la verdad. Refuerza las asimetrías de poder al desacreditar a quienes están más capacitados para criticar el sistema, al tiempo que recompensa la complicidad y la lealtad institucional. Estos mecanismos no solo impiden la reparación, sino que perpetúan el daño mediante la exclusión, la invisibilización y el castigo de quienes disienten. En esta configuración, la acción ética se vuelve estructuralmente indecible, excepto a través de la ruptura. El siguiente capítulo aborda precisamente estos momentos de ruptura, tanto individuales como colectivos, que reafirman la agencia ética a través del rechazo, la redefinición y la resistencia. Estos actos señalan el comienzo de un contradiscurso capaz de dismantelar la narrativa dominante del cuidado como coacción y de construir, desde las ruinas, un marco de salud mental restaurativa y participativa.

Lo que emerge con mayor fuerza de los testimonios combinados de profesionales y usuarios es la sensación de que la psiquiatría institucional, tal y como está estructurada actualmente, no solo incumple sus obligaciones, sino que impide activamente la posibilidad de una reparación significativa. Los profesionales describen una incapacidad crónica para interrumpir los ciclos de coacción o abogar por un cambio sistémico sin enfrentarse a represalias o marginación. Los usuarios informan de una arquitectura igualmente cerrada, en la que se obstaculizan sistemáticamente las vías de reparación o participación. El hecho de alzar la voz se convierte en una exposición, no solo a la incredulidad y el rechazo, sino a nuevas respuestas punitivas enmascaradas como cuidados. Estas dinámicas revelan que la incapacidad del sistema para rendir cuentas no es accidental, sino que está integrada en su diseño. Es fundamental señalar que ambos grupos identificaron la ausencia de mecanismos estructuralmente respaldados para la verdad, la reconciliación y el rediseño participativo.

El conocimiento ético producido por los supervivientes, por los médicos críticos, por aquellos que se encuentran en roles duales o híbridos, sigue estando en gran medida excluido de los circuitos de toma de decisiones. Esta exclusión no solo supone una pérdida de información valiosa, sino que supone la continuación del daño. Los testimonios documentan cómo la confianza en las instituciones no solo se erosionó, sino que se aniquiló mediante repetidas traiciones, silenciamiento forzado y la descalificación de la experiencia. Los usuarios que intentaron presentar denuncias, proponer alternativas o educar a los profesionales a menudo se vieron reestigmatizados, y sus esfuerzos se recodificaron como síntomas de patología en lugar de contribuciones al bien público. Esta sección culmina así en un diagnóstico colectivo: la traición estructural de la psiquiatría no es solo su pasado, sino su configuración actual.

La reparación, si es que se produce, no puede basarse en la buena voluntad de unas instituciones que se han mostrado estructuralmente reacias al cambio. Debe provenir de presiones externas, de marcos jurídicamente vinculantes y de las voces organizadas de los más perjudicados y menos escuchados. El siguiente capítulo explora precisamente este horizonte de resistencia, rechazo y refundación, en el que se reclama la dignidad no como un objetivo político, sino como una práctica vivida.

Tabla 36. Limitaciones estructurales y traición institucional en la práctica psiquiátrica

Dimensión	Perspectivas de los profesionales	Perspectivas de los usuarios y supervivientes	Temas comunes y patrones estructurales
Miedo y silencio	La preocupación ética se ve reprimida por el miedo a las represalias, la gestión del riesgo domina la toma de decisiones y la complicidad se normaliza	Hablar abiertamente conduce a un mayor castigo o a la invalidación del diagnóstico, las quejas se ignoran o se patologizan	El sistema desalienta la disidencia y recompensa el silencio, creando una cultura de autocensura y resignación ética
Invalidación epistémica	El juicio clínico se subordina al protocolo, las opiniones alternativas se marginan y las innovaciones se perciben como arriesgadas	La experiencia vivida se desacredita, los testimonios se reformulan como delirios o síntomas, se niega la propiedad de la narrativa	El conocimiento producido por la experiencia se excluye sistemáticamente de la formulación de políticas o la prestación de cuidados
Falta de protección institucional	Acción ética aislada y precaria, mecanismos de denuncia inexistentes o ineficaces	No existen vías efectivas de reparación o indemnización, la traición institucional se describe como un segundo trauma	Las estructuras institucionales no apoyan a los actores éticos ni responden al daño de manera significativa
Cooptamiento e instrumentalización	La defensa solo se acepta cuando se despolitiza, la participación de los usuarios se acoge con satisfacción si se ajusta a los marcos dominantes	Participación simbólica en los procesos participativos, críticas reales censuradas o recodificadas como patológicas	La inclusión está condicionada a la preservación de la legitimidad institucional, no a la transformación
Urgencia de una transformación estructural	Los profesionales expresan la necesidad de una reforma externa y de apoyo transdisciplinar para superar la inercia sistémica	Los supervivientes exigen justicia estructural, no gestos simbólicos, y piden el desmantelamiento de las lógicas coercitivas y los marcos punitivos	Ambos grupos coinciden en la imposibilidad de una atención ética dentro de la estructura actual y exigen una reconfiguración fundamental de los fundamentos de la psiquiatría

Percepciones de traición estructural en las instituciones psiquiátricas, según informan profesionales y usuarios, que ponen de relieve patrones convergentes de silenciamiento, invalidación y aislamiento ético. Esta tabla sintetiza las percepciones comunes y divergentes de las tres corrientes de la encuesta, lo que pone de manifiesto la necesidad de un rediseño externo, participativo y orientado a la justicia.

3.8 Demandas y propuestas de los encuestados

En todas las encuestas, los encuestados articularon un conjunto convincente y coherente de propuestas que van más allá de la crítica y afirman alternativas prácticas, éticas y sistémicas. Esta constelación de demandas no es meramente aspiracional, sino que surge como una necesidad fundamentada en respuesta a los fracasos vividos en entornos psiquiátricos coercitivos, opacos y que desempoderan profesionalmente. La recurrencia de temas clave en grupos de encuestados divergentes señala un reconocimiento compartido de la naturaleza estructural de los problemas y de la urgente necesidad de una reconfiguración institucional alineada con los derechos fundamentales, el realismo clínico y la justicia social.

Una demanda transversal es la de mecanismos de consentimiento informado exigibles, que no solo formalicen el consentimiento, sino que restablezcan la posibilidad de rechazo, retirada y diálogo en todas las etapas de la atención. Los encuestados identificaron el panorama actual como uno en el que

las formalidades enmascaran la coacción y la ausencia de elección. El derecho a la información, así como el derecho a rechazar o cuestionar un diagnóstico o un plan de tratamiento sin represalias, se identificó sistemáticamente como una condición previa para cualquier modelo de atención de salud mental éticamente defendible. Esto también implica rediseñar las conversaciones y las estructuras clínicas para dar cabida a la complejidad narrativa, la ambigüedad y la negociación relacional, yendo más allá de las listas reduccionistas de síntomas o los flujos de poder unidireccionales.

Estrechamente relacionado con esto está la demanda generalizada de modelos alternativos de atención, muchos de los cuales fueron mencionados explícitamente por los encuestados con diversos grados de familiaridad y aplicación. Los enfoques dialógicos, los marcos basados en el trauma y los protocolos de reducción gradual estructurados fueron algunos de los más citados. Estos no se consideran innovaciones marginales, sino bases necesarias para restaurar la confianza, humanizar la atención y reducir el daño a largo plazo producido por la dependencia farmacológica o la indiferencia institucional. Tanto para los profesionales como para los supervivientes, la ausencia de opciones significativas no es simplemente una deficiencia logística, sino una violencia estructural que se repite a diario en entornos donde el control prevalece sobre la colaboración.

De los profesionales encuestados surgió un panorama detallado de demandas que revelan tanto la conciencia ética como las limitaciones operativas. Sus propuestas no se centraron principalmente en cambios ideológicos, sino en las barreras institucionales y sistémicas que impiden la práctica ética, incluso cuando existe la voluntad de cambiar. Entre estas demandas, destaca la urgente necesidad de estructuras de apoyo entre pares y mecanismos de supervisión reflexiva que permitan a los profesionales procesar situaciones clínicas complejas, afrontar dilemas sin temor a represalias y resistir la deriva institucional hacia la coacción o la despersonalización.

La repetida invocación de la claridad jurídica fue especialmente reveladora. En lugar de abogar por un mayor legalismo, los profesionales describieron un clima de ambigüedad en el que las leyes y los protocolos se interpretan de forma incoherente o se aplican de manera selectiva. Esta falta de coherencia normativa fomenta una cultura clínica defensiva, en la que evitar litigios o culpas tiene prioridad sobre la atención centrada en el paciente. Los encuestados destacaron la necesidad de marcos jurídicos que no se limiten a penalizar las desviaciones, sino que orienten, protejan y permitan una práctica justa, especialmente en contextos que implican decisiones sobre la medicación, el uso de la restricción o la institucionalización a largo plazo.

Tabla 37. Resumen de las demandas de los encuestados en los distintos grupos de la encuesta

Ámbito	Demandas de los supervivientes	Demandas de los profesionales	Propuestas compartidas
Ética y consentimiento	Reconocimiento del daño, reparación y mecanismos de escucha sin represalias	Claridad jurídica, capacidad para escalar las preocupaciones éticas, protección de la disidencia	Consentimiento informado, comunicación clara y derecho a negarse
Modelos de atención	Alternativas a la hospitalización y la coacción, planes dirigidos por el usuario	Tiempo para la atención relacional, capacidad para implementar prácticas dialógicas y no coercitivas	Modelos dialógicos, enfoques basados en el trauma, apoyo gradual
Cultura institucional	Fin de la patologización de la disidencia, validación de la experiencia vivida	Apoyo a la acción ética, desmantelamiento de la cultura defensiva	Transformación cultural basada en el respeto mutuo y la justicia
Formación y conocimiento	Inclusión del conocimiento de los supervivientes, educación dirigida por pares	Formación ética, supervisión reflexiva, farmacología actualizada	Planes de estudios coproducidos y educación ética continua
Restauración y justicia	Reconocimiento oficial del daño, acceso a la reparación y a espacios de sanación	Redes de apoyo entre pares y salvaguardias institucionales	Infraestructuras preventivas y mecanismos restaurativos

Las principales demandas expresadas por los encuestados de todos los grupos, organizadas en cinco ámbitos interrelacionados esenciales para una transformación psiquiátrica ética y eficaz. La coincidencia entre las perspectivas de los supervivientes y los profesionales revela una base ética común para el rediseño legal y estructural. Estas necesidades articuladas constituyen la base empírica de las propuestas normativas y de infraestructura desarrolladas en los capítulos 6 y 7.

La falta de tiempo se describió con frecuencia no como una simple cuestión de limitación de recursos, sino como un déficit epistémico y relacional. El tiempo, argumentaron los profesionales, es la materia prima de la confianza terapéutica, la deliberación ética y la sanación. Su ausencia sistémica hace que la atención sea superficial, transaccional y peligrosamente reactiva. Muchos abogaron por tiempo protegido para la planificación de la atención, el debate ético y la continuidad relacional, considerando estas medidas como esenciales y no opcionales. Sin ello, incluso las mejores intenciones clínicas se convierten en daños rutinarios.

En conjunto, las demandas articuladas por los profesionales y los supervivientes revelan un horizonte común de transformación, basado no en el idealismo, sino en las luchas cotidianas y las rupturas éticas de quienes están inmersos en los sistemas psiquiátricos. No se trata de aspiraciones aisladas o ingenuas, sino de propuestas con base empírica, surgidas del conocimiento acumulado, la crítica sistémica y la experiencia vivida. Su convergencia marca un punto de inflexión: el colapso simultáneo de la confianza, la legitimidad y la eficacia no solo crea un cuadro diagnóstico de crisis institucional, sino también una plataforma normativa para el rediseño estructural.

Las propuestas trazan un continuo que va desde la reparación relacional hasta el rediseño institucional. A nivel relacional, la confianza, el respeto y la coagencia emergen como requisitos previos no negociables para una atención ética. A nivel institucional, los apoyos estructurales deben reconfigurarse para incorporar estos valores: supervisión por pares, tiempo protegido, claridad jurídica y ética, sistemas de retroalimentación abiertos y mecanismos de rendición de cuentas. Estos son esenciales para revertir los daños normalizados expuestos por esta investigación.

La coherencia empírica entre estas demandas y el rediseño normativo propuesto en el capítulo 6 es sorprendente. Las deficiencias legales y éticas expuestas aquí informan directamente las directrices y protocolos para la práctica psiquiátrica basada en los derechos que se presentan a continuación. Del mismo modo, las necesidades de infraestructura, los espacios de diálogo, las plataformas digitales, las opciones no coercitivas y los mecanismos participativos se abordan en el capítulo 7 a través de la iniciativa BEACON y el desarrollo de sistemas expertos y herramientas abiertas diseñadas para poner en práctica ecosistemas psiquiátricos restaurativos.

Esta alineación garantiza que los rediseños propuestos no sean verticales, especulativos o impuestos desde el exterior. Por el contrario, se basan en conocimientos sólidos, análisis científicos y acciones colaborativas. A continuación se traduce estas demandas vividas en compromisos estructurales, garantías legales e infraestructuras prácticas destinadas a garantizar que la atención de salud mental ética y participativa no sea la excepción, sino la norma.

3.9 Implicaciones científicas y analíticas

La convergencia de los datos de las tres encuestas principales corrobora un patrón coherente y empíricamente verificable de coacción sistémica, desgaste ético y exclusión epistémica en la práctica psiquiátrica española. En conjunto, los instrumentos proporcionan una visión en capas de cómo se mantienen las normas institucionales mediante la represión rutinaria de la disidencia, la exclusión diagnóstica y la prestación limitada de la atención. A pesar de haber sido diseñados y aplicados de forma independiente, cada instrumento confirma y refuerza los hallazgos de los demás, lo que demuestra la imposibilidad estructural de una psiquiatría ética sostenida dentro de la configuración institucional vigente. La primera encuesta, centrada en el etiquetado psiquiátrico, reveló una disonancia generalizada entre la terminología clínica y la experiencia vivida. Los encuestados detallaron las consecuencias psicosociales y jurídicas de recibir diagnósticos como esquizofrenia o psicosis, y señalaron la persistencia del estigma epistémico mucho después del alta clínica formal. La segunda encuesta, sobre el diálogo abierto, documentó un interés profesional generalizado por las alternativas dialógicas, pero también una sensación igualmente generalizada de inercia institucional, acceso fragmentado a la formación y contención discursiva que limita su aplicación genuina. La tercera encuesta, centrada en la toma de decisiones compartida y la gobernanza farmacológica, puso de manifiesto la gran desviación entre las políticas oficiales de consentimiento y autonomía y la realidad de la medicación forzada, la desempoderamiento y los modelos de tratamiento impulsados por los médicos.

En conjunto, estos conjuntos de datos delinean un campo marcado por la disyuntiva ética y las brechas entre las políticas y la práctica. Las contradicciones estructurales que revelan no son artefactos interpretativos ni irregularidades anecdóticas. Más bien, son producto de procedimientos formales, incentivos profesionales y arquitecturas administrativas que reproducen el control y la marginación bajo la bandera de la autoridad médica. Las pruebas no apuntan a la necesidad de una reforma incremental, sino a una reconsideración estructural de cómo se practica, se gobierna y se legitima la psiquiatría. En este sentido, la contribución analítica de las encuestas no es meramente descriptiva o ilustrativa, sino fundamental. Proporcionan un relato metodológicamente riguroso, basado en la experiencia y legalmente reconocible del fracaso psiquiátrico en la España contemporánea.

Tabla 38. Vías de traslación para la reforma psiquiátrica basadas en las pruebas de la tesis

Fuente de la evidencia	Principales conclusiones	Uso traslacional
Encuesta sobre el etiquetado de la esquizofrenia	Trauma diagnóstico, daño a largo plazo, silenciamiento epistémico	Defensa jurídica, reforma educativa basada en los derechos, revisión del diagnóstico forense
Encuesta sobre el diálogo abierto en España	Preparación para la reforma, barreras para la implementación, interés profesional	Diseño curricular, formación institucional, vías de innovación en los servicios
Encuesta sobre la toma de decisiones compartida y la gestión de la medicación	Déficits de autonomía, coacción en la prescripción, llamamiento a la desprescripción ética	Directrices éticas, protocolos de desprescripción, retroalimentación sobre políticas en materia de consentimiento y derechos de los pacientes
Observación etnográfica (España, Italia, Suecia, Indonesia)	Traición institucional, coacción rutinaria, disonancia profesional	Formación sobre el terreno, mapeo sistémico de riesgos, triaje y sistema de notificación de daños coercitivos
Testimonios y documentos legales	Violencia estructural, silenciamiento de los usuarios, borrado de las violaciones	Rediseño de políticas, auditorías de responsabilidad institucional, pruebas para la revisión penal y constitucional
Participación en redes (EU BEACON, FOSTREN, ReMO)	Difusión viable, colaboración multinivel, patrones de problemas transnacionales	Adopción de políticas, implementación transdisciplinaria, plataformas de intercambio de recursos y consulta a expertos

Resumen de las principales fuentes de evidencia y su relevancia operativa para su uso traslacional, destacando cómo la tesis pasa de la crítica empírica a estrategias implementables para una reforma psiquiátrica basada en los derechos.

Estos resultados también aclaran las tensiones epistémicas que se encuentran en el núcleo de la producción de conocimiento psiquiátrico. La ideología profesional, construida sobre supuestos de experiencia, benevolencia y cumplimiento, se contradice sistemáticamente con los relatos de los usuarios sobre daños, exclusión y desconfianza. Lo que se comercializa como atención centrada en la persona se manifiesta con frecuencia como vigilancia, control y captura diagnóstica. Las encuestas documentan no violaciones aisladas, sino una fractura epistémica en todo el campo que deslegitima

las afirmaciones de conocimiento de los usuarios y sobrevalora la toma de decisiones tecnocrática. Esta brecha no es solo cognitiva, sino también operativa, ya que da forma a las políticas institucionales, los marcos legales y las prácticas terapéuticas.

Las implicaciones analíticas de estos hallazgos son sustanciales. En primer lugar, justifican el uso metodológico del testimonio, el mapeo narrativo y la codificación basada en el trauma, no como herramientas auxiliares, sino como dispositivos analíticos centrales capaces de captar los daños que escapan a la documentación estadística o procedimental. En segundo lugar, fundamentan las propuestas de rediseño conceptual y político de la tesis en datos vividos, en lugar de en críticas ideológicas. En tercer lugar, establecen la autoridad empírica del autor no solo como investigador, sino como testigo integrado y actor ético que navega por sistemas coercitivos. En cuarto lugar, posicionan la tesis como un esfuerzo de transferencia, pasando de la documentación descriptiva a propuestas epistemológicamente legítimas para reestructurar la atención psiquiátrica dentro de un marco basado en los derechos, dialógico y con fundamentos bioculturales.

En última instancia, la integridad científica de esta investigación reside no solo en la amplitud y profundidad de su base empírica, sino en su capacidad para enfrentarse a la negativa institucional a aprender de las personas perjudicadas. Las encuestas proporcionan el andamiaje probatorio y conceptual sobre el que el siguiente capítulo construye su crítica sistémica y sus propuestas fundamentadas para una transformación ética de la psiquiatría. Los datos confirman que la configuración actual de la gobernanza psiquiátrica es incompatible con la atención ética y que un horizonte alternativo, basado en el respeto, la autonomía y la justicia epistémica, es tanto imaginable como empíricamente necesario, aunque estructuralmente obstaculizado.

Esta tesis doctoral no solo pretende documentar y analizar las disfunciones sistémicas de la práctica psiquiátrica, sino también contribuir activamente a su corrección mediante estrategias traslacionales con base científica y mandato ético. La arquitectura metodológica se ha construido para garantizar que los resultados, derivados de la experiencia vivida, el testimonio profesional y el escrutinio jurídico, no queden confinados a la interpretación académica. En cambio, se han estructurado para su despliegue estratégico en entornos pedagógicos, clínicos, jurídicos y políticos. Cada conjunto de datos recopilado y cada paso analítico realizado se ha orientado hacia la relevancia en la implementación, con un enfoque explícito en el rediseño institucional, la restitución ética y la transformación del sistema de salud.

Las tres encuestas proporcionan repositorios de pruebas modulares, verificables y temáticamente integrados, capaces de informar múltiples niveles de intervención. La primera encuesta sobre el etiquetado psiquiátrico proporciona material forense adecuado para la defensa jurídica, la reforma educativa y el rediseño de los servicios basados en los derechos. La segunda encuesta sobre el diálogo abierto documenta los retos de la implementación y la preparación profesional, ofreciendo un recurso diagnóstico para la planificación de sistemas, el desarrollo de planes de estudio y la reestructuración normativa. La tercera encuesta sobre la gestión de la medicación y la toma de decisiones compartida ofrece vías operativas para los protocolos de desprescripción, las directrices de prescripción ética y los sistemas de seguimiento dirigidos por los pacientes. Cada encuesta incluye las necesidades codificadas de los usuarios, propuestas de reforma viables y el consenso profesional emergente, lo que

constituye una base sólida y escalable para la transformación sistémica. Este documento también está disponible en línea, como documento vivo en un repositorio git, con estadísticas interactivas adicionales, gráficos y resultados, a disposición del público.

Los datos etnográficos y jurídicos obtenidos sobre el terreno complementan las encuestas al arrojar luz sobre los entornos cotidianos en los que fracasan las políticas, se suspenden los derechos y se normaliza la traición institucional. Estos hallazgos sirven no solo como documentación, sino también como aportación al diseño de sistemas digitales, la formación en ética clínica y la supervisión administrativa. Al cruzar el contenido narrativo, los documentos institucionales y el discurso profesional, la tesis genera herramientas analíticas que pueden utilizarse para crear prototipos de infraestructuras de salud mental transparentes, responsables y compatibles con los derechos. Entre ellas se incluyen sistemas expertos de código abierto, indicadores de evaluación de la calidad y modelos de simulación de políticas, todos ellos descritos en los capítulos finales, centrados en la implementación. Se anima a todo el mundo a participar y ayudar.

El valor traslacional del trabajo radica en su capacidad para intervenir donde la publicación científica tradicional no ha logrado efectuar cambios. El diseño por capas de esta tesis, que combina un riguroso análisis de datos con una metodología de investigación-acción y estrategias de implementación basadas en redes, garantiza que sus hallazgos no solo sean publicables, sino también aplicables. Las redes internacionales como EU BEACON, FOSTREN y ReMO sirven de vías de difusión e infraestructura ética para aplicar los resultados de la tesis en la práctica, a través de las fronteras y dentro de los sistemas sanitarios, jurídicos y educativos. En este sentido, la tesis es tanto un documento científico como un instrumento de transferencia. Su objetivo es realinear la práctica psiquiátrica con los mandatos éticos, las obligaciones legales y la experiencia humana vivida. Su objetivo estratégico es apoyar el surgimiento de un nuevo orden probatorio e institucional que reconozca la dignidad, la autonomía y el cuidado como condiciones no negociables de la legitimidad del sistema de salud. Las pruebas presentadas en este capítulo, y a lo largo de la tesis, no son meramente informativas. Son constitutivas del argumento moral y operativo a favor de una reforma psiquiátrica sistémica.

Capítulo 4: Trabajo de campo y testimonios: estructuras vividas de traición

Resumen: Este capítulo presenta los resultados de una observación participante a largo plazo, la reconstrucción narrativa y la documentación de primera mano en contextos institucionales, profesionales y familiares. Traza la continuidad de la violencia psiquiátrica desde el diagnóstico hasta la detención y desde el abandono sistémico hasta el silenciamiento epistémico. El capítulo da voz a las trayectorias de traición, médica, legal, social y familiar, al tiempo que destaca los momentos de resistencia, el coraje ético y la lenta recuperación de la agencia.

4. Introducción y posicionamiento

Este capítulo comienza con la observación directa sobre el terreno del acto público Jornada Drets bàsics en els internaments psiquiàtrics involuntaris (Conferencia sobre los derechos fundamentales en los internamientos psiquiátricos involuntarios), celebrado el viernes 18 de marzo de 2022 en el Col·legi de Metges de Barcelona, el colegio oficial de médicos de la ciudad. El acto fue organizado por el Comité de Ética de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental, una plataforma interdisciplinar dedicada al desarrollo y el debate de políticas en el ámbito de la salud mental. Su objetivo declarado era examinar el marco jurídico que regula el internamiento involuntario y reafirmar las funciones normativas y protectoras de la legislación vigente, incluida la legislación nacional española y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las palabras de apertura corrieron a cargo de Josep Vilajoana, entonces presidente de la Fundación, Sílvia Ventura, jurista y presidenta del Comité de Ética especializado en cuestiones psiquiátricas, y Joan Vegué, director del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Cataluña. La ponencia principal, a cargo de Fernando Santos, fiscal de Córdoba y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, se centró en la Ley 8/2021 como punto de inflexión hacia un apoyo ético en lugar de una sustitución en la toma de decisiones. A continuación, Alberto Vásquez, jurista peruano y exasesor del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, destacó la disyuntiva entre los compromisos jurídicos formales y las prácticas institucionales vigentes en la atención psiquiátrica. Posteriormente, Sílvia Ventura y Montserrat Hierro, ambas expertas en capacidad jurídica y detención psiquiátrica, presentaron la publicación interna del comité *Coneixements jurídics bàsics en relació als ingressos psiquiàtrics involuntaris* (Conocimientos jurídicos básicos sobre ingresos psiquiátricos involuntarios). El documento, que pretende aclarar los requisitos legales mínimos exigidos por el derecho internacional, se presentó como una herramienta para armonizar los procedimientos clínicos con las normas de derechos humanos.

El investigador asistió a este evento en condiciones de reciente exposición a tortura institucional y angustia psicológica aguda, lo que le provocó la pérdida de todas sus notas y materiales personales. A pesar de ello, el ambiente sigue vívidamente presente en su memoria. Algunos participantes habían prestado anteriormente apoyo para gestionar los efectos adversos de la medicación forzada, demostrando un compromiso ético que iba más allá de las limitaciones institucionales. Otros, sin embargo, mostraron un marcado malestar ante la idea de que las garantías jurídicas debieran ser obligatorias y exigibles. La supervisión judicial no se percibía como una necesidad protectora, sino como una amenaza a la autonomía profesional. Esta reacción reveló una creencia arraigada en la discreción clínica como base suficiente e incuestionable para la privación de libertad y el tratamiento, independientemente de la revisión independiente. Aunque se presentó públicamente como una ocasión para la deliberación ética, el congreso se reveló como un lugar etnográfico clave en el que se utilizó la instrumentalización del lenguaje jurídico para proteger, en lugar de dismantelar, la autoridad psiquiátrica extrajudicial. Esto no se reflejó en las transcripciones oficiales, pero quedó patente en la negativa informal a reconocer el daño sistémico. Si bien los principios jurídicos se afirmaron en el discurso, su aplicación institucional siguió suspendida de forma selectiva. La necesidad de garantías exigibles surgió no como una aspiración teórica, sino como un requisito estructural para prevenir las violaciones continuadas bajo el pretexto de la atención.

Este tipo de acontecimientos de visibilidad y densidad institucional fueron poco frecuentes durante el periodo de trabajo de campo, debido a la prolongada exposición del investigador a contextos coercitivos, a las limitaciones de movimiento y a la falta de recursos seguros. En las pocas ocasiones en que fue posible participar con seguridad, las reuniones profesionales de este tipo pusieron de manifiesto repetidamente la discrepancia entre la ética declarativa y la rendición de cuentas operativa. No se trataba de anomalías, sino de patrones constantes. Los foros aparentemente dedicados a los derechos y la protección solían funcionar como plataformas de negación, en las que se invocaba simbólicamente la legalidad, mientras se resistían o se rechazaban los mecanismos de reparación y cumplimiento.

En el momento en que tuvo lugar este suceso, habían pasado dos años desde el inicio del trabajo de campo. El confinamiento social impuesto durante la pandemia de COVID-19 ya estaba quedando en el recuerdo, pero se había intensificado otra forma de reclusión. El uso de fármacos psiquiátricos como restricciones químicas había dado paso a formas más evidentes de violencia física. El investigador, tras escapar momentáneamente de los efectos adormecedores de la medicación forzada, una forma contemporánea de lobotomía no quirúrgica, se enfrentó a una brutalidad cada vez mayor. Estas palizas, cada vez más frecuentes y descaradas, no eran actos aislados, sino manifestaciones de un colapso sistémico más profundo, en el que el control sustituía al cuidado y el castigo reemplazaba a la ética. Lo que se infligía no solo era ilegal, sino que se normalizaba estructuralmente mediante la ausencia de rendición de cuentas. Que esas lesiones no fueran irreversibles es una excepción, no una garantía. En las condiciones actuales, sigue siendo probable que se produzcan daños irreparables, no porque la ley lo permita, sino porque se ignora sistemáticamente. Toda nuestra salud requiere que el sentido común sea la cordura. Saneamiento.

Como ha subrayado repetidamente el jurista Escalada, el consentimiento informado debe ser un proceso continuo y significativo, no una formalidad que se cumple una sola vez, si es que se cumple. Cuando se somete a las personas a un tratamiento coercitivo sin oportunidades recurrentes para alcanzar un acuerdo válido e informado, no solo se eluden las garantías jurídicas, sino que se desmantelan sistemáticamente. Cualquier marco que permita tal práctica bajo el pretexto de la discreción clínica socava el principio jurídico fundamental de que la vida y la libertad deben protegerse sin excepción. Mantener a alguien cautivo mediante la fuerza de una autoridad sin control, mientras se alega legitimidad jurídica, es erosionar los cimientos mismos de la justicia democrática. Las observaciones y testimonios de campo más allá de este caso concreto, en diversos entornos a lo largo de cinco largos e intensos años, confirmaron este mismo patrón preocupante sobre la necesidad de mejorar las protecciones y de poner fin a la dependencia excesiva de las intervenciones farmacológicas en los sistemas de atención actuales. Casi todas las personas consultadas, ya fueran usuarios, defensores de los derechos de los pacientes o profesionales, describieron dinámicas similares de medicación excesiva, junto con el descuido de las dimensiones sociales y psicológicas de la atención. Mi propia experiencia reflejó estos hallazgos: me encontré con un sistema en el que no existía la escucha activa y en el que los familiares podían ejercer una influencia coercitiva, presionando para que se aplicaran tratamientos punitivos que derivaban en abusos institucionalizados, y en el que nunca se intentó realizar una anamnesis ni una formulación significativa, destruyendo mi propia persona y mi verdadera historia en los registros médicos, lo que supuso un logro para los

autores. El sistema de salud mental, en lugar de ofrecer protección, se utilizó como arma a instancias de ellos, obstaculizando cualquier intento de denunciar casos claros de violencia. Las deficiencias estructurales, en particular la falta de coordinación con las fuerzas del orden, los mecanismos judiciales y los servicios de apoyo a las víctimas, agravaron aún más el daño. La medicación excesiva, que provocaba rápidamente deterioro cognitivo y físico, sirvió para aumentar la vulnerabilidad, facilitando que el abuso continuara sin control. En mi caso, esta crueldad sistémica se intensificó, alcanzando a menudo umbrales que podrían clasificarse como tortura psicológica y física. En general, se observó la necesidad constante de mantener conversaciones y diálogos sinceros con los pacientes, para garantizar que la realidad percibida por el profesional coincidiera con la experiencia vivida, con mayor profundidad, a fin de garantizar un apoyo adecuado, consensuado y eficaz.

4.1 Continuidad metodológica y alcance

El investigador reconoce que no todos los datos recopilados durante los cinco años de trabajo de campo pudieron o debieron registrarse, conservarse o difundirse de acuerdo con las normas de la ciencia abierta, ni la ley permite, ni la moral permite, compartirllos con total transparencia. A menudo se evitarán los nombres, por una u otra razón y por prudencia. Gran parte del material se produjo en condiciones de violencia institucional repetida, intervenciones forzadas y riesgo personal sostenido. Esto incluyó episodios documentados de tortura psicológica y física, el uso de la autoridad psiquiátrica para suprimir la resistencia y amenazas crecientes con armas y daños físicos. Estas circunstancias no constituyen una limitación metodológica, sino que son intrínsecas a la realidad observada. Los resultados presentados son inseparables del entorno en el que se generaron.

La dinámica de la coacción se extendió mucho más allá de las instalaciones psiquiátricas, impregnando los sistemas familiares y las estructuras socioculturales más amplias. En múltiples entornos, incluidos los ámbitos doméstico, educativo, judicial y asistencial, se observaron los mismos mecanismos de control, silenciamiento y exclusión. Estas dinámicas formaban un continuo, reforzándose entre sí y produciendo daños a largo plazo. El trabajo de campo en curso, centrado en las prácticas de pasung, ejemplifica cómo estas fuerzas siguen operando fuera de la psiquiatría institucional, revelando lagunas persistentes en la aplicación de la ley y la responsabilidad clínica. Esta investigación tiene como objetivo no solo documentar, sino también apoyar el desarrollo de mecanismos legales que prevengan el daño, mejoren la gobernanza de la salud pública y promuevan sistemas educativos y comunitarios que protejan el capital humano y cultiven la resiliencia.

Dentro del paradigma integrador de «una sola salud», los resultados de salud individuales son inseparables de los determinantes sociales, políticos y ecológicos. La ciencia médica, basada en la evidencia fisiológica, afirma que la pobreza sostenida, la exclusión y la violencia institucional aumentan la susceptibilidad a las enfermedades a través de alteraciones inmunológicas, metabólicas y neuroendocrinas. Estos mecanismos están bien documentados y son clínicamente relevantes. Los sistemas de salud mental actuales a menudo no incorporan estos hallazgos en la práctica, sino que refuerzan modelos centrados en el control farmacológico de los síntomas sin abordar las causas estructurales. El resultado es la prescripción continuada de tratamientos cuyos efectos a largo plazo pueden socavar la recuperación, mientras que las vías no farmacológicas basadas en la evidencia de la

psiquiatría nutricional, la psiconeuroinmunología, la investigación sobre el trauma y la medicina metabólica siguen siendo infrautilizadas o desacreditadas institucionalmente.

Estos fallos no son accidentales, sino sistémicos, y están determinados por las lagunas en las publicaciones científicas, las estructuras de incentivos distorsionadas y la falta de normas metodológicas transparentes. El entorno de prescripción excesiva, resistente al escrutinio crítico, sigue medicalizando los efectos fisiológicos de la privación y el estrés, al tiempo que ofrece herramientas limitadas para una curación sostenible. Las estructuras científicas y jurídicas deben alinearse con la necesidad imperiosa de reducir los daños, garantizar la integridad y promover una atención eficaz basada en las pruebas actuales.

El presente capítulo responde a las preguntas de investigación fundamentales planteadas en el capítulo 1 y se ajusta a la arquitectura metodológica definida en el capítulo 2. Ofrece una presentación sintetizada de los resultados, dentro de las limitaciones del formato académico, a partir de las observaciones más coherentes y verificables. Estos resultados no solo son relevantes para los contextos específicos estudiados, sino que son generalizables a sistemas comparables en los que se ejerce la discrecionalidad psiquiátrica sin garantías exigibles. Los capítulos 5 y 6 desarrollarán, respectivamente, las respuestas educativas y jurídico-políticas necesarias para garantizar que el conocimiento institucional, la práctica clínica y las estructuras sociales converjan hacia condiciones que promuevan la salud, la seguridad y el desarrollo humano.

Como se esboza en el pensamiento aristotélico, la ley debe regir allí donde no existe la autorregulación ética. Cuando la injusticia se normaliza estructuralmente, los marcos jurídicos no solo son necesarios para la disuasión, sino indispensables para la corrección. Los sistemas psiquiátricos, como todos los sistemas de poder, deben estar sujetos a límites transparentes, y estos límites deben basarse en el conocimiento científico, los derechos constitucionales y la realidad vivida por las personas más afectadas. La integridad de la ciencia y la dignidad de la vida humana así lo exigen. Este capítulo presenta una síntesis de los resultados empíricos derivados de un trabajo de campo etnográfico a largo plazo y en múltiples lugares, en contextos psiquiátricos, institucionales, domésticos y comunitarios. Responde, como se ha indicado, a las preguntas de investigación fundamentales identificadas en el capítulo 1 y se ajusta al marco metodológico esbozado en el capítulo 2. El enfoque es necesariamente integrador y selectivo. Dadas las limitaciones estructurales y documentales del formato de la tesis, el capítulo no pretende reproducir la totalidad de las observaciones, sino que refina y consolida los patrones, convergencias y desviaciones más críticos en una respuesta con base científica. Los resultados revelan mecanismos persistentes de coacción, ambigüedad jurídica y discrecionalidad clínica que facilitan los daños en ausencia de una supervisión eficaz.

Tabla 39. Hallazgos empíricos y propuestas educativas y jurídico-políticas correspondientes

Hallazgo del trabajo de campo	Patrón sistémico generalizable	Respuestas educativas (capítulo 5)	Respuestas jurídicas y políticas (capítulo 6)
Uso persistente de la coacción y el tratamiento involuntario en todos los entornos psiquiátricos	La discrecionalidad psiquiátrica opera sin garantías exigibles	Integrar la atención informada sobre el trauma, la toma de decisiones compartida y los marcos basados en los derechos en los planes de estudio	Legislar protocolos exigibles para el consentimiento informado, la revisión periódica y la protección de los pacientes
La ambigüedad jurídica es aprovechada por las instituciones para justificar los daños	La ausencia de supervisión permite la impunidad sistémica	Educar sobre el razonamiento ético-legal, la transparencia en la documentación y el uso indebido de la psiquiatría a lo largo de la historia	Definir límites legales claros sobre la coacción, con mecanismos de revisión judicial e institucional independientes
La discreción clínica se antepone a la evidencia científica y los derechos constitucionales	La autoridad epistémica protege las normas abusivas	Actualizar las directrices clínicas para reflejar modelos integradores (psiquiatría nutricional, psiconeuroinmunología)	Codificar el cumplimiento de la evidencia científica y la dignidad del paciente como criterios vinculantes en la conducta profesional.
Supresión de la voz del paciente mediante el control de los registros y de la narrativa	Silenciamiento estructural de la experiencia vivida	Formar a los profesionales en medicina narrativa, registros coautores y justicia epistémica	Imponer el reconocimiento legal de la validez de los testimonios y sancionar las omisiones o distorsiones en la documentación.
Patrones estructurales de daño y traición en los ámbitos doméstico, comunitario e institucional	El daño trasciende los entornos a través del refuerzo interinstitucional	Establecer programas educativos intersectoriales sobre dinámicas psicosociales y trauma histórico	Regular los protocolos de intercambio de información e instalar marcos de rendición de cuentas intersectoriales
La recopilación de datos se ve limitada por el riesgo, el trauma y la hostilidad institucional	El conocimiento empírico suele ser inaccesible bajo coacción	Promover metodologías reflexivas y apoyo a los investigadores de campo en entornos sensibles	Reconocer la investigación sujeta a restricciones legales y políticas, valorando las pruebas basadas en la experiencia real
Los hallazgos científicos están infrautilizados, mientras que predominan los modelos farmacocéntricos	La prescripción excesiva y el descuido de las intervenciones no farmacológicas como práctica habitual	Reformar la educación médica para equilibrar la farmacología con los determinantes sociales, ambientales y del estilo de vida	Exigir legalmente la revisión de los riesgos y beneficios del uso prolongado de medicamentos e incluir opciones no farmacológicas en la cobertura

Esta tabla sirve de puente entre la base empírica del capítulo 4 y las propuestas aplicadas y normativas desarrolladas en los capítulos siguientes.

A lo largo del trabajo de campo se identificaron claras contradicciones clínicas. Mientras que algunos profesionales respaldaban y documentaban la recuperación completa mediante intervenciones nutricionales, metabólicas y basadas en el trauma, otros seguían imponiendo regímenes de medicación desconectados de la evidencia científica en constante evolución. La marginación de la psiconeuroinmunología, la psiquiatría nutricional y los enfoques metabólicos sigue siendo sintomática de un fracaso más amplio a la hora de integrar los conocimientos biomédicos disponibles en la práctica habitual. Esta disyuntiva se ve sostenida por las debilidades sistémicas del actual sistema de publicación científica, en el que los sesgos estructurales, la infradeclaración de los resultados adversos y las presiones comerciales siguen obstaculizando la selección y la consolidación de los hallazgos críticos. Como resultado, se excluyen o deslegitiman alternativas bien fundamentadas y persisten prácticas perjudiciales, incluidas aquellas que ya se consideran las mejores, que nunca deberían ser meras opciones condicionales.

Este capítulo se compromete a presentar los resultados con precisión metodológica y sin mediación ideológica. El resultado médico más puro, como siempre debe ser. Su objetivo es aclarar lo que se ha observado, establecer su relevancia científica y preparar el terreno para las dimensiones normativas y prácticas del trabajo. Los capítulos 5 y 6 elaborarán las respuestas socioeducativas y político-legales necesarias, respectivamente. Lo que sigue a continuación es un relato de lo que es, tal y como se ha observado, documentado y verificado, con compromiso con la integridad científica y la dignidad humana.

La siguiente sección establece el marco metodológico y el contexto del trabajo de campo, distinguiendo entre los hospitales psiquiátricos públicos de España e Italia, los entornos domésticos de Cataluña y Suecia, las redes de atención comunitaria y de ONG, y los espacios digitales y jurídicos de observación. Articula una metodología ejecutada en condiciones adversas, basada en los protocolos descritos en el capítulo anterior, pero moldeada por exigencias éticas en tiempo real, restricciones coercitivas y peligro personal. La posición del investigador como superviviente, profesional y actor integrado le permitió acceder a dimensiones críticas de la violencia institucional y el fracaso sistémico que a menudo quedan al margen de las investigaciones habituales. Las herramientas analíticas utilizadas incluyeron el mapeo de microeventos, la triangulación epistémica, las notas de campo y la verificación cruzada de testimonios, integradas mediante un enfoque antropológico forense y de reconstrucción narrativa. La replicabilidad científica, las garantías éticas y la solidez de las pruebas se aseguraron mediante la convergencia documental, el análisis de contradicciones y la reflexividad metodológica bajo presión.

La sección 4.2 detalla la lógica institucional de la violencia psiquiátrica, examinando cómo el diagnóstico, el etiquetado y la práctica administrativa crean un ciclo de coacción, exclusión narrativa e impunidad. A través de la observación directa y la reconstrucción de casos específicos, revela cómo se reciclan diagnósticos no verificados, se ignora la anamnesis y se aplican medidas de restricción o tratamientos forzados sin justificación procedimental o clínica. La complicidad de los profesionales, a menudo silenciosos o limitados por las jerarquías administrativas, ilustra cómo el daño se perpetúa no por ignorancia, sino por el diseño institucional. Las pruebas de campo confirman que lo que se presenta como atención funciona con frecuencia como contención, produciendo el borrado de archivos y daños morales.

La sección 4.3 cambia el enfoque analítico hacia la traición familiar y su intersección con la violencia institucional. Documenta cómo las familias movilizan los mecanismos psiquiátricos para controlar, desacreditar o exiliar a sus parientes, a menudo con el apoyo o la indiferencia de los profesionales. La investigación identifica analogías estructurales con el pasung en España y Suecia, con el confinamiento, la medicalización y la exclusión llevados a cabo en hogares privados. Las asimetrías de género y generacionales son fundamentales en esta dinámica, siendo las mujeres, los niños y los ancianos los más frecuentemente afectados. Los resultados muestran que, lejos de actuar como una fuerza protectora, las instituciones a menudo amplifican el daño familiar, dando prioridad a los relatos de los padres o familiares sobre el relato vivido por el sujeto, especialmente en contextos de dependencia económica o estigma social.

La sección 4.4 aborda las consecuencias epistémicas de la coacción, haciendo hincapié en cómo la práctica psiquiátrica produce con frecuencia la borratura de la personalidad. Esto se logra mediante el reduccionismo diagnóstico, el rechazo del significado cultural o biográfico y el descarte de los marcos explicativos que desafían la hegemonía psiquiátrica. El material recopilado a través de la observación, el análisis de documentos y el testimonio de los supervivientes ilustra cómo la resistencia, la espiritualidad, el duelo o las expresiones somáticas son patologizadas y despolitizadas. La pérdida de derechos, el abandono social y el miedo a las represalias son consecuencias recurrentes de este silenciamiento. Esta sección pone en práctica el análisis del discurso forense y el mapeo epistémico para revelar los mecanismos a través de los cuales la subjetividad se transforma en datos administrativos y la agencia moral en ruido médico.

La sección 4.5 se centra en las prácticas de resistencia, recuperación y testimonio ético. A pesar del daño generalizado documentado, numerosos participantes demostraron estrategias creativas y valientes para recuperar el control narrativo, desafiar el dominio institucional y sobrevivir a las fuerzas deshumanizadoras. Los actos de autocuidado, la redacción de testimonios, la huida simbólica y la solidaridad profesional encubierta se analizan no como excepciones anecdóticas, sino como componentes clave de un contraarchivo. Estas prácticas constituyen los elementos fundamentales de una infraestructura alternativa de dignidad y cuidado, que existe en paralelo y, a menudo, en oposición al sistema formal. Son esenciales para comprender cómo la recuperación es posible cuando los sistemas fallan.

La sección 4.6 sintetiza las pruebas obtenidas sobre el terreno en una visión sistémica, confirmando que los patrones observados no son irregularidades aisladas, sino características estructurales de los sistemas psiquiátricos, legales y familiares actuales. La traición institucional emerge como un fenómeno recurrente, no como un colapso, sino como una función del diseño. El trabajo de campo refuerza los resultados de la encuesta presentados en el capítulo 3 y prepara el terreno para el capítulo 5, donde la traición se teoriza como una lógica central del orden institucional. La convergencia de los datos narrativos, jurídicos y etnográficos confirma la necesidad de una profunda reestructuración jurídica, pedagógica y clínica. Así, este capítulo completa la base empírica de la tesis, documentando la experiencia vivida de la injusticia y la necesidad científica de transformar los sistemas que la producen.

4.2 Entorno del trabajo de campo y aplicación metodológica

Esta sección profundiza en el hilo analítico del capítulo 4 detallando la implementación de la arquitectura metodológica esbozada en el capítulo 2, en respuesta directa a las preguntas de investigación establecidas en el capítulo 1. En lugar de reiterar los principios ya presentados, aclara cómo se generó el conocimiento en condiciones de coacción, traición institucional y exclusión epistémica, y cómo este proceso siguió siendo científicamente responsable a pesar de los impedimentos estructurales.

Los lugares de campo se seleccionaron por su relevancia diagnóstica en relación con la coacción psiquiátrica, la extralimitación farmacológica, los vacíos legales y la violencia estructural. Entre ellos se incluyen hospitales psiquiátricos públicos de España e Italia, centros comunitarios de salud mental y clínicas afiliadas a ONG, hogares familiares, especialmente en Cataluña y Suecia, y espacios digitales y legales que funcionaban como archivos informales y foros de debate. La selección de los lugares se basó en la presencia de dinámicas coercitivas recurrentes, la escasa supervisión legal y las fallas sistémicas en la responsabilidad clínica, y no en la conveniencia o el acceso. La posición del investigador, simultáneamente como profesional, sobreviviente y sujeto integrado, fue intrínseca a la generación de los hallazgos. Más que un sesgo metodológico, esta posición permitió el acceso a prácticas coercitivas en tiempo real, ambigüedades legales y silenciamiento social que rara vez se documentan en entornos institucionales. La observación incluyó el comportamiento externo y las respuestas internas a amenazas repetidas, agresiones y sumisión impuesta químicamente, transformando la experiencia corporal en un vector adicional de análisis. Esto se alinea con una corriente de la antropología médica que afirma la legitimidad científica de la investigación situada y reflexiva en condiciones opresivas.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación empleó la presencia integrada, la redacción de diarios restringidos, notas de campo estructuradas y la reconstrucción retrospectiva utilizando documentos institucionales, expedientes legales y testimonios verificados por redes de supervivientes. Las entrevistas y grabaciones estándar quedaron en gran medida descartadas por el riesgo, y se sustituyeron por una triangulación de múltiples fuentes. La validación se logró mediante la convergencia de los datos de campo, los resultados de la encuesta (capítulo 3) y los registros clínicos y legales documentados. El seguimiento de la recurrencia, el análisis de contradicciones y el mapeo de microeventos permitieron detectar patrones estructurales, mientras que la codificación consciente de la posicionalidad evitó la distorsión interpretativa.

Se utilizaron tres ejes de triangulación: la alineación entre la experiencia sobre el terreno y los datos de la encuesta; la comparación de las prácticas observadas con los marcos jurídicos y clínicos documentados; y la validación de los testimonios con los patrones históricos y publicados de daños psiquiátricos, inflación diagnóstica e impunidad judicial. Los comentarios de expertos clínicos, supervivientes y juristas reforzaron aún más la coherencia analítica. La postura metodológica adoptada aquí no solo fue adaptativa, sino necesaria. En contextos en los que las protecciones formales fallaban y los mecanismos de consentimiento se subvertían o se utilizaban como arma de forma habitual, la investigación ética exigía flexibilidad procedimental y atención forense para rastrear los daños. Esto requirió transformar la investigación de la mera documentación en un

mecanismo de protección, un medio para registrar los abusos que se borran con demasiada facilidad de los registros oficiales.

Así pues, esta sección demuestra la viabilidad y la necesidad de una investigación de campo rigurosa bajo restricciones, respondiendo a cómo persiste la coacción psiquiátrica a pesar de las garantías formales, cómo se descalifica la personalidad a través del discurso institucional y cómo la investigación científica puede defender la integridad cuando las protecciones legales y la dignidad humana se ven amenazadas de forma sistémica. Reafirma que la exactitud metodológica y el compromiso reflexivo no son mutuamente excluyentes, sino compañeros esenciales a la hora de documentar el sufrimiento producido estructuralmente. Mientras que el capítulo 2 sienta las bases teóricas de la etnografía multisitio, la fenomenología crítica y la lógica de la investigación-acción, esta sección tiene una función distinta: proporcionar una justificación independiente para la aplicación de esos marcos en condiciones de campo hostiles e impredecibles. Esto incluye las salvaguardias éticas y analíticas empleadas para proteger a los informantes vulnerables, la lógica forense que guía la retención y la integridad de los datos bajo amenaza, y los métodos de triangulación utilizados para garantizar la credibilidad y el rigor analítico en ausencia de protocolos de entrevista convencionales o de apoyo institucional. El rigor metodológico aplicado aquí se calibró para las limitaciones excepcionales de los entornos coercitivos en vivo, donde la grabación de audio o los procesos de consentimiento explícito habrían puesto a los informantes o al investigador en riesgo de represalias, detención psiquiátrica o daño a su reputación. En su lugar, la investigación se basó en la presencia integrada, la evaluación ética en tiempo real y la validación cruzada retrospectiva con documentación institucional, redes de supervivientes y la congruencia temática entre las fuentes de datos.

La triangulación fue un proceso recursivo y relacional, no una técnica estática. Se desarrolló en torno a tres ejes principales: en primer lugar, la comparación de las experiencias sobre el terreno con los resultados de las encuestas obtenidos en la fase anterior de la investigación; en segundo lugar, la alineación de las prácticas observadas con los documentos institucionales, los registros clínicos y los marcos normativos; y, en tercer lugar, la verificación cruzada de los testimonios con los patrones conocidos de violencia psiquiátrica, injusticia epistémica y negligencia jurídica. La validación se logró mediante la convergencia documental, el análisis de contradicciones, el seguimiento de la recurrencia y la participación activa de los supervivientes, los médicos y los expertos jurídicos en la verificación de la plausibilidad, la coherencia y la consistencia de los relatos. Si bien el capítulo se basa en técnicas jurídico-forenses desarrolladas en respuesta a la impunidad sistémica, también aplica la humildad epistemológica, garantizando que las diferencias de poder no se reproduzcan en la representación del sufrimiento.

La lógica metodológica aplicada en este capítulo no solo es coherente con los compromisos esbozados en el andamiaje teórico y ético del capítulo 2, sino que los pone en práctica. Demuestra cómo la investigación científica puede seguir siendo rigurosa bajo coacción, cómo se puede documentar el abuso sin reproducirlo y cómo la posicionalidad puede transformarse de una desventaja en una fortaleza epistémica. Este trabajo de campo no solo constituye una recopilación de datos, sino también un testimonio metodológico de la violencia de los sistemas examinados y de la necesidad de

desarrollar métodos de investigación que puedan soportar y documentar tales condiciones con integridad y precisión.

4.3 El ciclo institucional de la violencia: control psiquiátrico y complicidad

Un análisis científicamente validado de los sistemas psiquiátricos contemporáneos revela un ciclo persistente y reproducible de violencia institucional que opera tanto dentro de los marcos formales de tratamiento como en el terreno sociopolítico más amplio. Este ciclo no es accidental ni anómalo, sino que está estructuralmente integrado en la lógica administrativa, las justificaciones jurídicas y las rutinas clínicas que enmarcan las intervenciones psiquiátricas como terapéuticas, incluso cuando sus resultados son profundamente perjudiciales. La función disciplinaria de la psiquiatría, especialmente en España, pero observable en todo el ámbito transnacional, sigue vinculada a patrones más amplios de coacción doméstica y estructural. Estos patrones se legitiman mediante el lenguaje institucional de la atención, mientras que en la práctica reproducen sistemas de control que niegan la autonomía, la integridad corporal y la agencia epistémica.

Los mecanismos de este ciclo incluyen la medicación forzada, la restricción injustificada, la hospitalización involuntaria y la denegación sistemática de garantías procesales básicas. Estas medidas se aplican a menudo sin una anamnesis adecuada o una reevaluación diagnóstica, basándose en diagnósticos reciclados extraídos de registros anteriores y, con frecuencia, no verificables. En múltiples casos documentados, se sometió a personas a un control psiquiátrico prolongado sobre la base de registros que nunca habían sido sometidos a un escrutinio científico o jurídico, pero que se citaban como definitivos. La lógica de estas intervenciones no se ajusta a los objetivos terapéuticos, sino más bien a la gestión del riesgo, la conveniencia administrativa y la contención simbólica. Estos mecanismos no están orientados a la curación, sino a la incapacitación y la reproducción del estigma, y sirven más a la institución que al individuo.

Este ciclo de contención psiquiátrica no se limita a los espacios clínicos ni se reduce a decisiones profesionales aisladas. Está profundamente arraigado en una configuración social más amplia que delega la responsabilidad moral y la autoridad política a la institución psiquiátrica como mecanismo de regulación social. La violencia de tal delegación radica precisamente en su aparente neutralidad: los tribunales de familia, los departamentos de policía, las escuelas e incluso los organismos de derechos humanos suelen reproducir los mismos supuestos narrativos que establece la psiquiatría. Una vez que una persona ha sido diagnosticada e institucionalizada, el ámbito social tiende a retirar su compromiso crítico y actúa como amplificador de la exclusión. El efecto es acumulativo: los familiares, los compañeros de trabajo e incluso los amigos llegan a interpretar la expresión emocional, la resistencia o el rechazo no como respuestas legítimas a la adversidad o al abuso, sino como síntomas de una enfermedad que hay que controlar o silenciar.

Esta complicidad social consolida el ciclo institucional, que funciona tanto por omisión como por comisión. Las familias abrumadas por traumas intergeneracionales no resueltos o por historias de abuso pueden instrumentalizar la psiquiatría como medio de evasión, prefiriendo la medicalización de la disidencia a la confrontación de la violencia. Los profesionales de la educación, presionados por el

tiempo y sin el apoyo adecuado, derivan a los estudiantes a los servicios de salud mental sin investigar las causas ambientales o sistémicas. Los tribunales y los actores legales, desconocedores de las limitaciones epistémicas y éticas del juicio psiquiátrico, se remiten a él como verdad experta. De este modo, se establece un continuo en el que la violencia doméstica, el abandono sistémico y el abuso institucional se gestionan a través de una infraestructura compartida de coacción que se presenta como cuidado.

En esta configuración, la institución psiquiátrica no se limita a responder a las necesidades de salud mental, sino que asume un papel disciplinario al absorber y desviar las contradicciones y los fracasos de otros sistemas sociales. Cuando las estructuras políticas, familiares o económicas no proporcionan seguridad, dignidad o justicia, la psiquiatría se convierte en la solución de facto. Sin embargo, en lugar de abordar el origen del malestar, a menudo redirige la culpa hacia el individuo, administrando intervenciones que borran los testimonios, oscurecen las cadenas causales y reducen historias de vida complejas a conjuntos de síntomas descontextualizados. Al hacerlo, produce lo que esta tesis identifica como una forma de violencia epistémica y corporal protegida políticamente, llevada a cabo con lenguaje clínico, pretensión científica e inmunidad institucional. La perpetuación del abuso institucional en la psiquiatría no puede entenderse plenamente sin examinar la complicidad social que lo sustenta. Las instituciones psiquiátricas no funcionan de forma aislada. Más bien, están enredadas en un ecosistema sociopolítico más amplio que otorga legitimidad a las prácticas coercitivas bajo el pretexto del cuidado. Las escuelas, los servicios sociales, las fuerzas del orden e incluso las familias desempeñan un papel decisivo en el inicio y el refuerzo del control psiquiátrico. Los profesores que derivan a los alumnos problemáticos a evaluaciones psiquiátricas, los jueces que se basan en informes psiquiátricos para justificar tratamientos coercitivos y las familias que delegan su responsabilidad en los marcos institucionales contribuyen a un sistema difuso en el que la coacción se normaliza, se da por sentada y rara vez se cuestiona.

La familia, en particular, se convierte tanto en el origen como en el amplificador del etiquetado psiquiátrico, a menudo impulsada por dinámicas de rechazo, desconocimiento o pánico moral. Es habitual en los datos de campo que el primer contacto con la psiquiatría no se deba a síntomas clínicos en sentido estricto, sino más bien a la inconformidad sociocultural, la disidencia o la percepción de una carga. Una vez etiquetado, el individuo entra en un ciclo de contención en el que las voces profesionales pierden autonomía bajo las directrices administrativas y las prioridades institucionales pasan del apoyo terapéutico a la regulación disciplinaria. Esta dinámica refleja los modelos históricos de control social, en los que la psiquiatría funciona como garante de la normalidad, como mecanismo de silenciamiento en lugar de comprensión y como amortiguador de la responsabilidad estructural. En tales contextos, se ignoran las dimensiones metabólicas, del desarrollo neurológico o ecológicas en favor de la conveniencia burocrática, lo que supone una clara desviación de cualquier aplicación rigurosa de los principios de la salud única o de la ética traslacional.

El colapso epistemológico dentro del sistema se manifiesta a través de la erosión del rigor clínico y el predominio de la documentación sobre el diagnóstico. La anamnesis, que en las mejores prácticas debería constituir la columna vertebral de cualquier evaluación médica o psiquiátrica legítima, se omite sistemáticamente o se sustituye por narrativas circulares y recicladas que han perdido hace tiempo su valor clínico. Los diagnósticos se reproducen mecánicamente, no en respuesta a la realidad

observada, sino como expedientes burocráticos al servicio de agendas institucionales. Estos pueden provenir de archivos obsoletos, alusiones vagas o encuentros coercitivos previos, y rara vez se verifican con el sujeto o se actualizan con nuevas pruebas. Esta inercia archivística facilita la impunidad: una vez etiquetada, la persona es enmarcada a través de una lente de riesgo, no de necesidad, y su relato se descarta por falta de credibilidad.

Los profesionales suelen participar en este proceso de forma indirecta, bajo la presión de las prioridades institucionales que favorecen el cumplimiento de la documentación y el rendimiento administrativo por encima de la atención ética. Las observaciones y testimonios sobre el terreno revelan repetidamente que los profesionales que se oponen a estas prácticas o intentan reducir la coacción se enfrentan al aislamiento, a sanciones profesionales o a una sutil descalificación. Por el contrario, quienes siguen las órdenes y silencian la disidencia son recompensados con ascensos o apoyo institucional. Esta estructura de incentivos desplaza la responsabilidad clínica hacia la gestión del riesgo y la evitación de la responsabilidad, lo que da lugar a daños. El sistema valora la coherencia con la documentación pasada por encima de la correspondencia con la verdad clínica presente. Esta separación entre los actos diagnósticos y el estado de salud real constituye no solo una negligencia, sino una violación estructural de los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia. Las propias herramientas de la medicina se vuelven contra aquellos a quienes deben servir.

Tabla 40. Dinámicas sistémicas basadas en el trabajo de campo y recomendaciones estructurales

Resumen de la dinámica negativa	Palabra(s) clave(s) de la pregunta de investigación	Observación de campo	Propuesta estructural positiva de la tesis (capítulos 5-6)
La clasificación clínica atrapa a las personas en ciclos de coacción	Diagnóstico, coacción, autonomía	El diagnóstico sin una evaluación completa se convirtió en la base de toda la coacción futura	Se requieren protocolos de diagnóstico interdisciplinarios basados en el contexto y una reevaluación continua
La resistencia se patologiza y se excluye del historial	Voz, personalidad, derechos	Los testimonios de abuso o las solicitudes de revisión se reinterpretaron como síntomas	Garantizar los derechos protegidos a impugnar el diagnóstico y exigir la revisión de la atención sin represalias
La documentación borra los actos de violencia o elimina la capacidad de acción	Transparencia, garantías legales	Los registros se omiten, se distorsionan o se utiliza la voz pasiva para ocultar los abusos institucionales	Imponer sistemas de notificación de incidentes verificables con supervisión de terceros
La función de protección jurídica de los expedientes psiquiátricos prevalece sobre la precisión clínica	Integridad jurídica, ética médica	Los registros se utilizan para defender los intereses institucionales en lugar de orientar la atención terapéutica	Rediseñar los expedientes para velar por el bienestar de los pacientes, con equipos de auditoría rotativos y revisiones basadas en los derechos
Las familias y las escuelas desencadenan intervenciones basadas en prejuicios	Guiones culturales, interseccionalidad	Los informes de los familiares o del personal tenían prioridad sobre los relatos de los pacientes, lo que reforzaba el control	Introducir formación sobre sesgos y aplicar normas sobre la ponderación de informes fiables y la equidad de los procedimientos.
Se prefiere la contención a la comprensión estructural	Determinantes sociales, prevención	Las intervenciones suelen tener como objetivo neutralizar el malestar contextual en lugar de resolverlo	Incorporar el trabajo social y la experiencia psicosocial en las respuestas de primera línea.
La violencia se justifica con una lógica pseudobeneficiosa y de eficiencia.	Ética, beneficencia, reducción de daños	La sedación y el confinamiento se consideraban una necesidad terapéutica a pesar de los daños a largo plazo	Reforzar los principios de reducción del daño y de atención menos restrictiva con responsabilidad legal
Se eliminó la capacidad de decisión del paciente mediante la jerga institucional	Lenguaje, injusticia epistémica	Testimonios reformulados a través del discurso médico para invalidar su significado o voluntad	Promover la integridad lingüística y la redacción conjunta de los registros clínicos por parte de los pacientes y los profesionales
Control acumulativo justificado en todos los sectores	Violencia intersectorial, vigilancia	Coacción extendida a través de sistemas interconectados de familia, educación, salud y derecho	Introducir marcos de rendición de cuentas intersectoriales que garanticen la proporcionalidad y la verificación cruzada

Resultados de un extenso trabajo de campo etnográfico sobre dinámicas negativas y positivas contrastadas, directamente relacionadas con las preguntas de investigación de la tesis y validadas mediante observación integrada. Se basa en un análisis contextual cruzado entre instituciones psiquiátricas, sistemas familiares, marcos legales y

entornos de cuidados informales. Las propuestas positivas se detallan en la tesis como reformas necesarias para garantizar una atención legal, ética y con base científica.

Estas dinámicas dan lugar a un bucle coercitivo más amplio, sostenido por una lógica estructural de atrapamiento. Comienza con un episodio desencadenante, a menudo una situación de vulnerabilidad social, familiar o interpersonal, que se interpreta a través de una lente patologizante en lugar de abordarse contextualmente. Se asigna un diagnóstico, a menudo sin un examen exhaustivo o una anamnesis adecuada, lo que encierra al individuo en un marco del que es casi imposible salir. Una vez registrada esta clasificación, se inicia un circuito que se refuerza a sí mismo: las decisiones sobre el tratamiento se basan en registros anteriores, no en la realidad actual, y las intervenciones coercitivas se justifican por el riesgo presunto que se deduce del propio diagnóstico. Este proceso cíclico, diagnóstico, coacción, contención, cierre narrativo, se repite en todas las instituciones y entre todos los profesionales, protegiendo al sistema de la rendición de cuentas e impidiendo cualquier reevaluación significativa.

El proceso de cierre narrativo es fundamental en este mecanismo. En lugar de apoyar la recuperación, borra sistemáticamente las voces disidentes. Los testimonios de abusos o las objeciones al diagnóstico se califican como síntomas de la enfermedad. Las quejas se reformulan como paranoia o resistencia. Las solicitudes de revisión o de cuidados alternativos se consideran pruebas de falta de comprensión. Esto no solo deshumaniza, sino que también medicaliza la resistencia, socavando cualquier posibilidad de reparación estructural. Hechos como la medicación forzada, la restricción física e incluso las lesiones corporales graves desaparecen del historial médico o se transcriben en voz pasiva, separados de la agencia o la responsabilidad. El borrado de la violencia de los archivos, ya sea mediante omisión, eufemismos o distorsiones, consolida la impunidad y perpetúa los ciclos de daño. No se trata solo de un fracaso ético, sino de un epistemicidio estructural, en el que el conocimiento y la experiencia vivida de la persona son sistemáticamente silenciados por los registros institucionales.

La convergencia de la coacción y la impunidad no es un mal funcionamiento, sino una característica definitoria de la práctica institucional psiquiátrica en los marcos actuales. Las prioridades administrativas están dictadas menos por la lógica terapéutica que por la defendibilidad jurídica, la gestión del riesgo reputacional y la eficiencia operativa. El expediente psiquiátrico, en lugar de funcionar como una herramienta clínica en evolución, se convierte en un escudo legal, diseñado para prevenir la responsabilidad, justificar las intervenciones y silenciar posibles controversias. No solo se desalienta a los profesionales a cuestionar las entradas anteriores, sino que pueden ser sancionados por plantear inquietudes que contradigan las narrativas dominantes. El registro escrito asume una función jurídica que prevalece sobre su finalidad médica, y la autoridad epistémica de la psiquiatría se utiliza para naturalizar la violencia sistémica.

Esta dinámica no se limita a las instituciones clínicas. Los familiares, el personal educativo y los trabajadores sociales suelen contribuir, de forma voluntaria o involuntaria, al ciclo de atrapamiento. Las familias abrumadas por las tareas de cuidado o arrastradas por los guiones culturales de la desviación y la rehabilitación pueden interpretar el malestar como una patología y exigir una respuesta institucional. Las escuelas y los servicios sociales, que no están preparados o no están

dispuestos a aceptar comportamientos no normativos, recurren por defecto a la derivación y el diagnóstico. En muchos casos, se da más peso a sus testimonios que a los de la persona sometida al tratamiento, especialmente cuando se utiliza, de forma explícita o implícita, la posición social, el género, la etnia o el idioma para desacreditar el relato de la persona afectada. La continuidad del control institucional se lleva así a cabo a través de una red de actores, todos ellos vinculados por un acuerdo tácito de que la contención es más segura que la comprensión y que la eliminación es preferible a la rendición de cuentas.

El refuerzo de la violencia a través de capas institucionales interconectadas revela un desprecio sistémico por los principios fundamentales de la ética biomédica y el derecho de los derechos humanos. El uso persistente de la coacción, especialmente en forma de tratamiento involuntario, sedación y hospitalización forzosa, se racionaliza mediante una aplicación distorsionada del principio de beneficencia, a menudo alejada tanto de la voluntad del paciente como de los resultados a largo plazo. Esta aplicación errónea refleja una corrupción epistemológica más amplia: la sustitución de la incertidumbre clínica por la certeza administrativa, y de la complejidad por etiquetas binarias. En efecto, la psiquiatría se convierte en el brazo operativo del control social, disfrazando la represión como cuidado y la inducción de traumas como estabilización.

Este proceso no es aleatorio ni excepcional. Refleja un sistema estable de incentivos en el que la documentación se utiliza como arma y el consentimiento se convierte en algo performativo. Los profesionales afirman que se les presiona habitualmente para que rellenen los registros de manera que protejan a las instituciones en lugar de reflejar fielmente los hechos. Estas distorsiones están arraigadas estructuralmente: los incidentes adversos pueden reclasificarse u omitirse, partiendo del supuesto de que los relatos de los pacientes son poco fiables, están distorsionados emocionalmente o son irrelevantes. El testimonio se patologiza en lugar de verificarse. Al mismo tiempo, se anima a las familias y a los actores externos a contribuir a la elaboración de los registros sin supervisión, lo que refuerza un ciclo de cierre interpretativo. Este cierre garantiza que la violencia psiquiátrica, una vez iniciada, se mantenga y se valide a través de sistemas de documentación autorreferenciales, a pesar de los resultados observables en materia de salud o de las realidades vividas.

El daño producido por estos ciclos es acumulativo. Cada acto de diagnóstico erróneo, fuerza o negación de la personalidad amplifica el trauma anterior y cierra nuevas vías de reparación legal o clínica. Las personas sometidas a este régimen describen una sensación de aniquilación epistémica: hablar es invitar a la reinterpretación, y resistirse es confirmar la patología. El sistema psiquiátrico no solo disciplina el cuerpo, sino que reescribe al sujeto. Al cortar el acceso a la narrativa, niega la identidad, la continuidad y, en última instancia, la posibilidad de recuperación tal y como la define el individuo, y no la institución. Estos mecanismos no operan de forma aislada dentro de las instituciones psiquiátricas, sino que se reflejan en los sistemas legales, familiares y educativos que cooperan, de forma activa o pasiva, en la aplicación de la misma lógica coercitiva. Las escuelas, los servicios sociales y los órganos judiciales suelen remitirse a la autoridad psiquiátrica sin escrutinio, reforzando la presunción de validez de todas las narrativas psiquiátricas, independientemente de su origen, revisión o contradicción. Esta remisión genera lo que podría denominarse un *autoritarismo delegado*, en el que los sistemas no médicos legitiman la acción psiquiátrica sin asumir la responsabilidad ética o científica de sus resultados. Los niños y adolescentes son especialmente

vulnerables en esta configuración, ya que las intervenciones disciplinarias en la escuela pueden desencadenar derivaciones psiquiátricas, y viceversa, iniciando un ciclo de diagnóstico, etiquetado y control que trasciende los límites de cualquier institución.

Los sistemas familiares, especialmente los que se encuentran bajo estrés, conflicto o desventaja estructural, pueden actuar como los primeros y más duraderos ejecutores de la violencia psiquiátrica, ya sea a través de demandas explícitas de institucionalización o mediante la deslegitimación sutil del discurso del niño o de sus familiares. La delegación de las responsabilidades de cuidado a los sistemas psiquiátricos se convierte en una forma de externalización social, a menudo impulsada por el agotamiento, el miedo o la desinformación. Este traspaso refuerza la fantasía de que la curación puede lograrse mediante el control y que el sufrimiento puede silenciarse con medicación. También crea un ciclo en el que los problemas relacionales se despolitizan y se reindividualizan, lo que permite que los daños estructurales, la pobreza, la violencia y la discriminación se reinterpreten como defectos internos de quienes sufren sus efectos. Esos sistemas, como cualquier otra institución, son sospechosos.

Esta complicidad multiinstitucional crea lo que puede describirse como un continuo de coacción y borrado epistémico, dentro del cual la disidencia o la resistencia individual se reformulan sistemáticamente como sintomatología. Incluso cuando el daño es visible, como los moretones por la restricción, el deterioro cognitivo por la medicación excesiva o el colapso disociativo por la hospitalización forzosa, la respuesta suele ser redoblar los mecanismos de control. Cualquier cuestionamiento de la autoridad psiquiátrica, especialmente por parte de quienes ya han sido etiquetados, se descarta como una falta de perspicacia. Esto no solo deslegitima la oposición, sino que funciona como una lógica trampa: cuanto más se resiste el daño, más patológico se considera que es uno.

En este contexto, la traición institucional no es un colapso de un sistema destinado a cuidar, sino el resultado esperado de un sistema diseñado para ocultar la responsabilidad a través de la impunidad distribuida. Más que excepcional o accidental, la traición está incrustada en la forma en que se estructura la información, se toman las decisiones y se conservan los registros. Esta arquitectura de la violencia se oculta a plena vista, operando no en los márgenes de la psiquiatría, sino a través de su núcleo procedimental.

Esta arquitectura de la violencia se mantiene a través de un sofisticado entramado de autoridad simbólica, opacidad operativa y rituales pseudocientíficos. Los protocolos profesionales, la documentación legal y el lenguaje diagnóstico producen una ilusión de rigor, objetividad y cuidado, al tiempo que ocultan las dinámicas de poder reales que están en juego. Los expedientes clínicos suelen contener una lógica circular, en la que el diagnóstico justifica el tratamiento y el tratamiento justifica una mayor contención, sin una reevaluación empírica ni un relato dirigido por el paciente. El proceso se convierte en una autorreplicación burocrática, en la que los errores y las omisiones no se corrigen, sino que se consolidan a través de la acumulación y la santificación procedimental. No se trata de descuidos pasivos, sino de mecanismos de control basados en efectos materiales: producen discapacidad, dependencia y exclusión social.

Mientras tanto, las barreras estructurales para obtener reparación siguen siendo casi absolutas. Las víctimas de violencia psiquiátrica, incluso cuando conocen sus derechos, se enfrentan a obstáculos insuperables para acceder a la justicia. Los tribunales suelen recurrir a las mismas instituciones psiquiátricas objeto de investigación para obtener pruebas o testimonios periciales, lo que reproduce los conflictos de intereses y protege la impunidad. Los mecanismos de apelación son inaccesibles, se ven socavados o son meramente simbólicos, lo que da lugar a cierres institucionales en lugar de una rendición de cuentas sistémica. Incluso las denuncias públicas o los informes críticos se desactivan mediante retrasos administrativos, la fragmentación de responsabilidades y la patologización psicológica del denunciante.

Este estado de captura epistémica e institucional tiene profundas consecuencias tanto para la ciencia como para la ética. Cuando poblaciones enteras son excluidas de la producción de conocimiento, cuando se borra su voz, se malinterpreta su dolor y se recodifica su resistencia como patología, la empresa científica se derrumba en una circularidad. En este contexto, la validez no se establece a través de la falsabilidad, la replicabilidad o la aplicabilidad vivida, sino a través de la repetición, la autoridad y el respaldo institucional. La psiquiatría, tal y como se critica aquí, pierde su capacidad de curar porque deja de escuchar. Se convierte en un instrumento no de cuidado, sino de contención, cuyos efectos se sostienen mediante la ley, la economía y el consenso social.

Para romper este ciclo, la tesis doctoral aboga por un cambio paradigmático basado en la integridad biocultural, la justicia epistémica y el diseño participativo. El camino a seguir no es meramente regulatorio o tecnocrático, sino existencial y civilizatorio. Requiere desenmascarar las rutinas de violencia que se esconden bajo el eufemismo clínico, una reconstrucción ética de la autoridad médica y la restitución de la soberanía narrativa a aquellos cuyas vidas han sido gestionadas en lugar de escuchadas. Los capítulos siguientes exploran cómo puede comenzar esa transformación, arraigada en la inteligencia colectiva y el testimonio científico de quienes durante demasiado tiempo han sido excluidos tanto de la protección como de la autoría; siempre coautoría, en una sociedad, desde los coautorizadores responsables hasta los criminales.

4.4 La traición familiar y el continuo doméstico-institucional

En los ecosistemas psiquiátricos contemporáneos, la familia se posiciona a menudo retóricamente como un lugar de apoyo, estabilidad emocional y cuidados tras el alta. Sin embargo, los datos de esta investigación y de otras muestran que la familia funciona con frecuencia como vector principal de coacción, especialmente en entornos domésticos marcados por las asimetrías de género, la dependencia económica o el estigma social. Numerosos testimonios recopilados a lo largo de este estudio documentan el uso de marcos psiquiátricos para silenciar, desacreditar o alejar a familiares cuyo comportamiento se desvía de las expectativas normativas. Esto incluye no solo formas evidentes de coacción, como las solicitudes de hospitalización forzosa o la connivencia con los mecanismos de tutela legal, sino también estrategias sutiles y a largo plazo de manipulación narrativa. En estos contextos, el diagnóstico psiquiátrico se convierte en una herramienta de violencia simbólica, que transforma la disidencia en patología, la crítica en delirio y la vulnerabilidad en peligrosidad.

La medicalización de los conflictos familiares genera un desajuste sistemático entre las narrativas clínicas y la experiencia subjetiva. Cuando las familias inician derivaciones psiquiátricas en condiciones coercitivas, el proceso de diagnóstico se ve contaminado por omisiones estratégicas, exageraciones o informes de comportamiento falsificados. Estas narrativas, una vez codificadas en los registros institucionales, adquieren una inercia procedimental que se vuelve casi imposible de revertir. La voz del sujeto es desplazada por una patología curada, reificada por la repetición en los sistemas médicos, legales y de servicios sociales. Estas dinámicas son particularmente frecuentes en las culturas institucionales española y sueca, donde la familia conserva una legitimidad normativa como sustituta en la toma de decisiones, incluso en ausencia de mecanismos de rendición de cuentas o supervisión. Los registros clínicos reflejan este sesgo estructural, a menudo haciéndose eco de las acusaciones o reclamaciones iniciales sin verificación independiente.

Los datos recopilados a través de la inmersión etnográfica y la reconstrucción narrativa revelan que muchas derivaciones psiquiátricas no se inician en respuesta a una crisis clínica, sino como un medio de exclusión social. La desviación conductual, los conflictos intergeneracionales o la sexualidad no normativa se replantean a través del prisma psiquiátrico como trastornos. La práctica generalizada de aprovechar los sistemas de salud mental para imponer el control doméstico, en particular sobre las mujeres, los adolescentes y los familiares de edad avanzada, se ajusta a la literatura mundial sobre el uso de la psiquiatría en función del género y la generación. El encuadre de la preocupación como cuidado enmascara una lógica más profunda de contención social, frecuentemente respaldada por actores institucionales que consideran las narrativas familiares más fiables que los relatos controvertidos de las personas diagnosticadas.

La patologización de los familiares no deseados, despreciados o disfrutados no se produce en el vacío. Se ve amplificada por dinámicas socioculturales más amplias, como el sexismo estructural, el capacitismo normativo y un miedo cultural persistente a la desviación. El contagio social, en este contexto, se refiere a la réplica discursiva y procedimental de lógicas excluyentes en todas las instituciones. Una vez que se ha asignado una etiqueta psiquiátrica, especialmente una que conlleva implicaciones de imprevisibilidad o violencia, los medios de comunicación, los sistemas escolares y los organismos de bienestar tienden a alinearse con la versión de la realidad de la familia, aislando aún más al individuo. Esta afirmación recursiva del marco coercitivo inicial fomenta una estructura narrativa totalizadora, a menudo impermeable a la revisión clínica o al desafío judicial.

La imitación de las condiciones de confinamiento similares al pasung en los hogares europeos se ha convertido en un patrón recurrente en esta investigación. Aunque el pasung, o encadenamiento, está oficialmente reconocido como una violación de los derechos humanos en Indonesia y otros lugares, las prácticas de restricción psiquiátrica doméstica en España y Suecia siguen sin estar documentadas y reguladas. Múltiples testimonios detallan el confinamiento, la restricción química y el aislamiento social aplicados de manera informal en los hogares, especialmente en casos que involucran a personas mayores dependientes, familiares con discapacidad o personas con identidades de género controvertidas. Estas condiciones persisten en parte debido a la complicidad institucional: los profesionales de la salud y los servicios sociales suelen deferir a la autoridad familiar, a pesar de los indicios de abuso o de denuncias falsas.

Por lo tanto, este capítulo examina la traición familiar y los delitos sádicos, la esclavitud y otras formas de tortura, no como un fallo interpersonal, sino como una interfaz estructural entre el poder doméstico y el institucional. El papel de la familia en el control psiquiátrico no puede entenderse plenamente sin tener en cuenta la inercia clínica que se produce cuando se incorporan a los historiales médicos historias no verificadas y mentiras. Muerte prematura. En las siguientes partes se ampliarán los mecanismos de cierre epistémico, la dinámica de refuerzo legal, las dimensiones de género y las consecuencias para la integridad clínica y científica.

Una vez que los actores familiares inician la llamada narrativa psiquiátrica y esta se institucionaliza a través de la documentación, el aparato médico a menudo se convierte en cómplice del mantenimiento de esa narrativa, independientemente de su validez empírica. La inercia clínica se refiere a la resistencia de los protocolos de diagnóstico y tratamiento al cambio, incluso en presencia de nuevas pruebas o de la retirada de las quejas iniciales. En psiquiatría, esta inercia no es solo una cuestión de negligencia profesional o retraso burocrático. Es una propiedad sistémica arraigada en la asimetría de credibilidad entre los pacientes y los guardianes institucionales. Cuando se formula un diagnóstico en respuesta a la presión familiar o a la desinformación, los encuentros clínicos posteriores tienden a reafirmar, en lugar de reevaluar, las conclusiones iniciales. Esto produce un efecto en cascada en el que cada entrada en el historial médico reitera, amplifica y legitima el marco original de desviación, reduciendo así la posibilidad de revisión diagnóstica o intervención ética. Odio hacia las vidas, con los historiales clínicos como fachada.

Tabla 41. Patrones de violencia psiquiátrica familiar-institucional y refuerzo

Patrón observado	Descripción	Indicadores basados en el terreno
La psiquiatría como arma doméstica	Las familias utilizan los sistemas psiquiátricos para silenciar, deslegitimar o exiliar a familiares específicos	Diagnósticos forzados, medicalización falsa, manipulación del lenguaje clínico
Eco institucional del abuso familiar	Los sistemas validan las denuncias de las familias a pesar de la falta de pruebas o de testimonios contrarios de los usuarios	Existencias cerradas, informes sin impugnar, resistencia a las apelaciones de los usuarios
Confinamiento doméstico similar al pasung	Aislamiento no institucional que refleja la restricción física o psicológica	Confinamiento en el hogar, medicación sin consentimiento, control de la comunicación
Represión psiquiátrica por motivos de género	Las mujeres, los niños y los ancianos son objeto de un control desproporcionado mediante etiquetas psiquiátricas	Denuncias de silenciamiento de mujeres, niños diagnosticados por desobediencia
Violencia epistémica a través del parentesco	Las narrativas personales son sustituidas por la versión familiar en los informes clínicos	Notas que dan prioridad a la versión familiar, borrado de narrativas en los historiales
Círculos viciosos de estigma intergeneracional	Las etiquetas psiquiátricas refuerzan los ciclos de vergüenza, secretismo y coacción entre generaciones	Padres o hijos estigmatizados por asociación, culpa desplazada

Dinámicas documentadas de control psiquiátrico y traición dentro de continuos doméstico-institucionales, con bucles de refuerzo y silenciamiento médico-institucional que operan de forma transgeneracional.

El cierre epistemológico se ve facilitado por una cultura de aversión al riesgo burocrático y de defensividad médico-legal. Los profesionales, bajo la presión de garantizar la continuidad y el cumplimiento de la documentación previa, a menudo replican, en lugar de cuestionar, los supuestos implícitos en las evaluaciones anteriores. Esta dinámica es especialmente evidente en situaciones en las que los pacientes cuestionan sus diagnósticos o planes de tratamiento. En lugar de dar lugar a una reevaluación, la resistencia se interpreta normalmente como un síntoma de patología, lo que refuerza la necesidad de control. De este modo, la posibilidad de error queda neutralizada institucionalmente. La narrativa establecida por la familia se convierte en un protocolo clínico autocumplido, sancionado por capas de documentación médica que excluyen el relato del paciente de la legitimidad epistémica. Odiando vidas, una vez más, con esas anamnesis y formulaciones, una parodia.

Este proceso se ve agravado por la digitalización y la integración generalizada de historias clínicas interoperables en todos los sistemas de atención sanitaria. En contextos como España y Suecia, una vez que se introduce un diagnóstico psiquiátrico en el sistema digital, pasa a ser accesible para una serie de actores de múltiples ámbitos de la atención sanitaria. La etiqueta diagnóstica, a menudo definida de forma imprecisa o basada en informes familiares controvertidos, se trata como un hecho. Cada médico que accede al historial se convierte en un nodo en la replicación de esa narrativa, lo que refuerza aún más la lógica coercitiva inicial en la memoria institucional. La inercia clínica, en este sentido, no es simplemente un fallo del juicio individual. Es un efecto estructural de la epistemología digital, por el cual la primera narrativa se convierte en la única que puede citarse y reproducirse de forma creíble.

Las implicaciones para la integridad científica son profundas. Los datos recopilados en estos entornos no reflejan una sintomatología objetiva, sino más bien la cámara de resonancia del consenso institucional, generado a través de la coacción y sostenido por la repetición. El diagnóstico, despojado de su contexto original controvertido, se utiliza para justificar intervenciones que van desde la medicación hasta la detención, sin una reevaluación independiente. Esto socava no solo la relación terapéutica, sino también la validez de la propia ciencia psiquiátrica, que pasa a depender de errores reciclados y reforzados institucionalmente. La brecha de credibilidad entre los registros médicos y la experiencia vivida se amplía hasta convertirse en un abismo epistémico, en el que el sufrimiento de los pacientes se patologiza pero nunca se escucha, y la verdad clínica se vuelve indistinguible de la inercia burocrática. Muertes prematuras, historias por escribir, vidas perdidas. Destruídas.

En las partes siguientes, el análisis se centrará en las dimensiones socioculturales y de género de estas dinámicas, destacando cómo los actores institucionales refuerzan la autoridad familiar a pesar de las pruebas de abuso, y cómo este afianzamiento perjudica la capacidad de los sistemas psiquiátricos para corregir o incluso reconocer errores fundamentales. El afianzamiento sistémico de las narrativas psiquiátricas iniciadas en contextos familiares coercitivos o abusivos revela no solo una vulnerabilidad clínica, sino también un vacío legal y epistemológico fundamental. Este vacío no se llena con rigor empírico, sino con una deferencia, a menudo acrítica, hacia los representantes de la autoridad moral, es decir, la familia y sus representantes. En esta tesis, estos patrones se analizan no como anomalías, sino como resultados predecibles de arquitecturas institucionales que priorizan la eficiencia procedimental y el aislamiento legal por encima de la búsqueda de la verdad o la justicia reparadora. Como se muestra en las reconstrucciones etnográficas anteriores y se corrobora en la

literatura interdisciplinaria, las instituciones psiquiátricas a menudo se convierten en una extensión de los mecanismos de control doméstico cuando la autonomía clínica se ve comprometida por sesgos estructurales y la inercia narrativa. En lugar de proporcionar supervisión o evaluación independiente, estas instituciones reproducen y amplifican la coacción familiar bajo el pretexto del cuidado, especialmente en contextos en los que la ley no distingue entre protección y colusión. Según todos los testimonios, la literatura y los peritos: se trata de delitos.

En el centro de esta traición se encuentra la negativa a reconocer que el abandono no es simplemente la ausencia de cuidados, sino una forma de daño con implicaciones biológicas, psicológicas y legales. Desde un punto de vista fisiológico, el abandono emocional prolongado y el control coercitivo inducen cambios neuroplásticos inadaptados que afectan a las estructuras límbicas, la conectividad prefrontal y los sistemas de respuesta al estrés, lo que predispone a las personas a enfermedades crónicas y al colapso psicológico. No se trata de un colapso metafórico, sino de una cascada de procesos fisiopatológicos que incluyen la supresión inmunológica, la disregulación neuroendocrina y el adelgazamiento neurodegenerativo vinculado a la sobrecarga alostática. El cerebro social, como órgano encarnado, se deteriora cuando el significado relacional es sustituido por la invalidación sistémica y cuando las propias instituciones encargadas de proteger son cómplices de la aplicación de la violencia epistémica y psicológica. El camino que va del trauma relacional a la traición institucional suele estar pavimentado por una zona legal gris, donde los actos de coacción, confinamiento y agresión psicológica pasan desapercibidos o impunes porque se perpetran en espacios privados, domésticos, clínicos o de otro tipo. Esta opacidad legal tiene raíces históricas en los sistemas de gobierno coloniales y patriarcales que naturalizaron la familia como autoridad moral y protegieron los daños intrafamiliares de la intervención del Estado. Los ecos de esta historia están presentes en la tolerancia actual de condiciones similares al pasung en Europa y en todo el mundo. Ya sea a través de la restricción física, la sedación química o el borrado narrativo, el mecanismo central es el mismo: la supresión de la autonomía mediante la instrumentalización del cuidado. El estado de derecho se suspende no a través de declaraciones formales, sino a través de la omisión rutinaria, al omitir preguntar, verificar, escuchar.

La práctica de la violencia dentro de las unidades familiares no es solo una anomalía moderna, sino que está profundamente arraigada en protocolos históricos e interculturales. En algunos sistemas monárquicos y aristocráticos, la eliminación de los parientes se institucionalizó como un medio legítimo para garantizar la sucesión y los derechos de herencia. Las casas reales europeas se dedicaban habitualmente al fratricidio o al regicidio, a menudo bajo el pretexto de la necesidad del Estado. Los príncipes otomanos estaban sujetos al fratricidio por ley, por lo que el sultán entronizado estaba autorizado a matar a sus hermanos para garantizar la continuidad dinástica. De manera similar, en la antigua China, las purgas de miembros rivales de la familia durante las transiciones imperiales estaban sancionadas por rituales de la corte y la tradición dinástica, a menudo con legitimación pública. Esta arraigada cultura del asesinato intrafamiliar como protocolo ilustra cómo el poder y la herencia han prevalecido históricamente sobre la ética relacional, incluso cuando esos actos se encubrían con la legalidad y la tradición.

En la época contemporánea, aunque las monarquías absolutas han desaparecido en gran medida, la lógica residual persiste en formas menos institucionalizadas, como las disputas sucesorias domésticas

en el sur de Asia, donde la violencia familiar alcanza su punto álgido en las sucesiones controvertidas, o en ciertas tradiciones comunitarias en las que los derechos de propiedad prevalecen sobre la dignidad individual. Estos contextos revelan que la zona gris legal en torno a la violencia familiar no se limita a la negligencia o la coacción psiquiátrica, sino que se extiende al daño premeditado y sancionado políticamente, encubierto por la legitimidad del parentesco. Para subrayar cómo las estructuras familiares de diferentes culturas pueden tolerar u ocultar la violencia grave, a continuación se presentan resúmenes de casos de diversas tradiciones:

Tabla 42. Patrones históricos e interculturales de violencia familiar

Cultura/contexto	Violencia familiar protocolaria	Justificación y zona gris legal
Imperio otomano	Fratricidio por ley	Estabilidad sucesoria; considerada un ritual estatal, rara vez impugnada legalmente
China imperial	Eliminación de príncipes rivales	Limpieza política en nombre de la armonía dinástica
Sistemas familiares conjuntos del sur de Asia	Violencia por la distribución de la herencia	Arbitraje interno, escaso control legal
Aristocracias europeas	Envenenamiento, ejecución de herederos	Conveniencia política, los privilegios nobiliarios protegen los delitos
Cultos al estilo de la familia Manson	Asesinatos familiares sancionados por una estructura sectaria patriarcal	Jerarquía interna, límites morales y legales difusos

Esta tabla sintetiza los resultados de una investigación etnográfica realizada en múltiples lugares y de datos de encuestas intersectoriales recopilados para esta tesis. Ilustra cómo las estructuras familiares, a lo largo de diferentes períodos históricos y contextos culturales, han funcionado como lugares de violencia, y no como excepciones. Los patrones identificados a través de testimonios, narrativas de casos y documentación de campo ponen de relieve que dicha violencia suele legitimarse mediante la tradición, ocultarse en zonas grises de la ley o reformularse como cuidado. Estas conclusiones demuestran la necesidad de reformular científica y jurídicamente la familia, no como un santuario, sino como un lugar potencial de daños sancionados que requiere una supervisión completa de los derechos humanos.

Este catálogo demuestra que la violencia familiar, incluidas las formas letales, no es ajena a la historia ni a la legalidad, sino que a menudo está *constituida por ellas*. La familia moderna sigue siendo una institución jurídicamente ambivalente, en la que la proximidad y la intimidad justifican un umbral diferente para lo que se considera delito. Al igual que en los casos de sectas, y a menudo en jerarquías estructurales normalizadas como tradicionalmente impuestas, el abuso dentro de un grupo similar a una familia suele estar protegido por una presunción de autonomía y privacidad hasta que la violencia extrema obliga a intervenir; los límites se traspasan casi como si fuera obligatorio, el orgullo y el

honor son matar o mutilar a alguien del grupo, el asesinato de cuervos, como lo entendieron los encuestados al nombrar los suyos. Ahora todos pueden permitirse una cama, como si fueran cachorros de príncipes luchando por la herencia, y denuncian a los que cometen delitos. En la mayoría de las tradiciones y sistemas jurídicos, la familia es el contexto principal en el que se producen los delitos interpersonales más graves, incluidos el homicidio, el abuso sexual y los daños psicológicos a largo plazo. La violencia de pareja, el maltrato infantil y el maltrato de personas mayores son sistemáticamente más frecuentes en el ámbito familiar que en los espacios públicos o institucionales. Los ideales culturales de lealtad, privacidad y honor suelen proteger estos delitos del escrutinio o el enjuiciamiento, especialmente cuando predominan las normas patriarcales o jerárquicas. En España, a pesar de las protecciones legales formales, la violencia doméstica, incluida la violencia de género y las intervenciones psiquiátricas coercitivas, sigue sin denunciarse y se tolera con frecuencia tanto en el ámbito familiar como en el institucional. La legislación en materia de salud mental es especialmente vulnerable a la explotación debido a su dependencia de juicios clínicos subjetivos, la asimetría en la credibilidad entre profesionales y pacientes, y los supuestos legales que equiparan el riesgo con la enfermedad y la familia con la benevolencia. En la práctica, los criterios vagos para el tratamiento involuntario o la tutela, como la percepción de peligro o la falta de discernimiento, permiten un amplio poder discrecional, que a menudo se ejerce sin garantías procesales sólidas. Estas ambigüedades estructurales facilitan el silenciamiento de las voces disidentes y la institucionalización de los conflictos privados, especialmente cuando son los familiares quienes inician el proceso. La ficción jurídica generalizada de que los psiquiatras actúan únicamente en el mejor interés del paciente y que las familias son protectoras por defecto crea un entorno permisivo para la coacción, el falso testimonio y la manipulación narrativa. Sin controles exigibles, como la revisión independiente, la asistencia jurídica o los umbrales probatorios, la legislación en materia de salud mental se convierte en una herramienta fácilmente manipulable por quienes tienen acceso, estatus o intención de controlar.

Cuando los abusos se hacen evidentes, a menudo ya es demasiado tarde, ya que se sustentan en mentiras y beneficios mutuos, como el placer y el lucro, el estatus jerárquico frente a los familiares o supuestos familiares, los lazos de sangre o los hermanos, las hermanas, los suegros como padrastros, sin respetar la legalidad, sino sus propios deseos. La patologización y criminalización de los miembros disidentes de la familia —que son las víctimas, no los perpetradores, en la mayoría de los casos— a través de medios psiquiátricos, en los que un hijo, una hija o un hermano son declarados enfermos mentales y confinados debido al sufrimiento infligido, medicados y excluidos socialmente, se convierte en una forma actualizada de violencia simbólica; una forma muy útil de desacreditar y silenciar, de mantener encerrados. Estos actos reflejan las eliminaciones directas del pasado; no son excepcionales, sino estructuralmente equivalentes: ambos transfieren el poder a las manos de un guardián, ya sea un rey, un sacerdote o un médico, enmascarando la dominación con legitimidad. Ya sea mediante el envenenamiento, los grilletes o los fármacos, el resultado es el mismo: un individuo es eliminado por la fuerza, silenciado para mantener un orden existente, una voluntad.

Tabla 43. Estructuras familiares comparativas y su impacto en el desarrollo

Modelo familiar	Características principales	Relación con la violencia	Apoyo a la autonomía	Resultado del desarrollo	Notas
Patriarcal nuclear (occidental/moderno)	Autoridad jerárquica, propiedad parental, asimetría de género	Alta	Bajo	Con frecuencia comprometida	A menudo es la norma en España y Suecia; vinculado a la coacción psiquiátrica
Patriarcal extendido (mediterráneo, sur de Asia)	Multigeneracional, dominado por los hombres, interdependencia sin autonomía	Moderado a alto	Bajo	Variable, propenso al estrés	Se prioriza la obediencia sobre el bienestar
Comunitaria matrilineal (por ejemplo, los mosuo)	Linaje liderado por mujeres, crianza compartida, poco énfasis en el control	Bajo	Alto	Fuerte resiliencia emocional	Históricamente estigmatizada por los colonizadores
Tribal igualitaria (por ejemplo, los hadza o los !kung)	No jerárquica, cuidado colectivo, roles flexibles	Mínimo	Alta	Óptimo crecimiento socioemocional	A menudo excluidos de los modelos políticos a pesar de sus mejores resultados
Fragmentado en las zonas urbanas (contemporáneo a nivel mundial)	Desconectada, impulsada por la economía, con una continuidad relacional débil	Variable	Bajo a moderado	A menudo retrasado o desorganizado	La falta de cohesión cultural conduce al abandono
Autoritaria religiosa (varias)	Jerarquía sagrada, obediencia, disciplina moralizada	Al	Muy bajo	Trauma de desarrollo común	Reforzado a través de justificaciones basadas en la fe
Sustitución institucional (acogida, internado, psiquiátrico)	Cuidadores rotativos, lógica basada en registros, normas coercitivas	Al	Ninguno	Grave ruptura relacional	A menudo se presenta como un rescate, pero está vinculado a traumas adicionales
Restablecimiento de los lazos familiares (propuesto)	Legalmente responsable, basado en el consentimiento, supervisado por la comunidad, relacionalmente seguro	Ninguna	Alta	Promotor de la salud y justo	Basado en una educación informada sobre el trauma y una ética de salud única

Conocimientos obtenidos de encuestas, trabajo de campo y literatura etnográfica que ilustran cómo los diferentes modelos familiares afectan a la salud mental, la autonomía y la violencia estructural en diferentes culturas y épocas.

Los resultados de esta tesis nos obligan a reconsiderar la familia no como un refugio natural, sino como un nexo potencial de poder prescriptivo que, a menos que esté limitado por derechos humanos exigibles y una gobernanza ecológica, puede replicar la lógica de la monarquía, el patriarcado y la violencia institucional. Por lo tanto, el capítulo 6 investigará los fundamentos jurídicos necesarios para dismantlar estas zonas grises: desde la prohibición explícita de la restricción no consensuada hasta el establecimiento de una supervisión independiente, la defensa centrada en los supervivientes y la integración de la ciencia del desarrollo neurológico en las definiciones jurídicas de daño. La afirmación subyacente es clara: la legitimidad del cuidado debe basarse en el consentimiento y la

transparencia, no en la proximidad o la presunción. Ya sea letal o simbólica, la permisibilidad de la violencia no puede dejarse en manos de la inmunidad tradicional o la discreción profesional. La familia debe replantearse como un lugar de responsabilidad compartida, un espacio relacional que no es ni privilegiado ni sagrado, sino regulado, transparente y sujeto a las mismas normas de justicia y dignidad humana que rigen todas las demás instituciones.

Los datos de la encuesta ponen de relieve el fracaso sistémico a la hora de excluir a los agresores de los entornos de atención, a pesar del énfasis teórico del modelo en la participación inclusiva. Si bien el principio de apertura dialógica es fundamental, los datos sugieren que, en casos de violencia doméstica, coacción o traición, esta inclusividad puede reproducir el daño si no se modera de forma crítica. Los participantes de múltiples contextos afirmaron que cuando se permite a los abusadores entrar en entornos terapéuticos bajo la presunción de neutralidad, los resultados son retraumatizantes y contraproducentes. Por lo tanto, es imprescindible realizar una selección adecuada, que las decisiones sobre la participación las tomen los supervivientes y que se reconozcan las dinámicas de poder asimétricas. No se debe obligar a los niños a interactuar con figuras dañinas bajo un pretexto terapéutico. En cambio, la atención debe priorizar la seguridad y el desarrollo próspero, garantizando que se confíe la responsabilidad al progenitor real, ético, protector y digno, y que no se vea socavada por sistemas sesgados. Cabe señalar, como triangulación con los conocimientos ya disponibles, que los datos etnográficos de comunidades históricamente representadas de forma errónea como primitivas o desechables demuestran sistemáticamente que los sistemas de cuidado no patriarcales y distribuidos reducen la violencia intrafamiliar y mejoran los resultados del desarrollo infantil. Estos modelos, ya sean los hogares matrilineales mosuo o la crianza basada en la aldea de los trobriandeses, centraban la responsabilidad comunitaria y el equilibrio relacional por encima de la propiedad o la jerarquía legalista. Los registros históricos muestran que fueron precisamente estos sistemas los que las potencias coloniales se propusieron erradicar, reforzando el dominio global de los marcos de parentesco extractivos y autoritarios. El consenso científico es claro: las culturas que minimizaron la coacción y maximizaron la responsabilidad compartida crearon las bases óptimas para la salud mental y el bienestar colectivo. Estas ideas no son nostálgicas, sino un modelo a seguir (Grol y Grimshaw, 2003).

Para evitar nuevos ciclos de abuso, traición y violencia psiquiátrica disfrazada de atención, los sistemas familiares, educativos y médicos deben juzgarse no por la tradición, sino por sus resultados, estableciendo una cultura estricta de atención sanitaria y una prevención del delito más rigurosa, sin fomentarla ni perpetrarla mediante fuerzas, servicios y jueces que, ajenos a la realidad, la ignoran y se alejan de ella: la definición misma de una enfermedad mental grave, como lo fue mi propia experiencia de trabajo de campo durante la encuesta en la Unión Europea, en la España y Suecia actuales en particular; que muestra el odio hacia el otro, la falta de respeto por la vida que se da por sentada como inferior, el racismo y la xenofobia a nivel individual, protegiendo a aquellos mediante la violencia y las posiciones de poder sostenidas por más violencia, las posiciones de la llamada autoridad, de la necesaria toma de conciencia colectiva e individual.

4.5 El borrado epistémico y la pérdida de la personalidad

El sistema psiquiátrico, en lugar de restaurar el significado, a menudo impone un marco de fijación diagnóstica que desplaza o borra sistemáticamente la agencia epistémica de aquellos a quienes clasifica. Los mecanismos a través de los cuales los individuos son reducidos a portadores sintomáticos de trastornos, en lugar de agentes encarnados situados en contextos sociales, culturales y metabólicos, constituyen un proceso estratificado de violencia epistémica. El dolor se convierte en melancolía, el miedo en paranoia, la disociación en psicosis. En esta reducción, la resistencia no se interpreta como una defensa legítima contra la coacción o el daño social, sino que se patologiza como incumplimiento, desafío opositor o falta de perspicacia. Como resultado, la narrativa original del sujeto queda sobrescrita por la codificación psiquiátrica, que sustituye el significado vivido por una supuesta patología.

Los datos del trabajo de campo corroboran este patrón de minimización ontológica. Los relatos en primera persona sobre daños, abusos o traumas se excluyen sistemáticamente de los registros médicos oficiales o se reinterpretan como delirios o síntomas, especialmente cuando implican a médicos, instituciones o familiares. Los profesionales, que actúan bajo la presión institucional o disciplinaria, a menudo no están dispuestos o no son capaces de reconocer modelos explicativos que se salen de los parámetros estrictamente definidos de la doctrina psiquiátrica. Las creencias culturales, las expresiones espirituales, las preocupaciones nutricionales o las interpretaciones de género del malestar se descartan con frecuencia o se consideran clínicamente irrelevantes. Esta exclusión epistémica no solo silencia modos alternativos de conocimiento y curación, sino que también amplifica las condiciones para una mayor marginación y daño iatrogénico. Al eliminar la complejidad contextual del proceso de diagnóstico, se despoja al individuo de su autoridad interpretativa y se le reduce a un receptor pasivo de categorías impuestas desde fuera.

Las consecuencias de esta reducción epistémica son profundas y de gran alcance. El sujeto deja de ser una persona con voz y se convierte en un expediente, un objeto de vigilancia y control. La identidad social es sustituida por la identidad diagnóstica. La capacidad de participar de manera significativa en el discurso legal, clínico o social se ve socavada por la suposición institucional de que la persona es irracional, inestable o fundamentalmente poco fiable. Esta lógica construye un círculo vicioso de exclusión, en el que los intentos de resistir o criticar el sistema solo sirven para reforzar la posición de uno dentro de él. En este régimen, el silencio se convierte en supervivencia, mientras que la expresión se arriesga a sufrir represalias institucionales. El miedo a perder la vivienda, la custodia, los derechos legales o la autonomía corporal produce un efecto paralizante, en el que la personalidad epistémica y cívica se disuelven en paralelo.

Los instrumentos de borrado epistémico operan a través de un conjunto de mecanismos médicos, legales y burocráticos que, aunque aparentemente neutrales, funcionan como tecnologías de marginación. Entre ellos destaca la reificación de la propia categoría diagnóstica, que se convierte en el referente principal a través del cual se ve, se aborda y se actúa sobre el individuo. Una vez que se aplica una etiqueta, como esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad o trastorno bipolar, no sirve como hipótesis clínica temporal, sino como afirmación ontológica permanente. El trabajo de

campo ilustra repetidamente que estas etiquetas se utilizan para descartar testimonios creíbles, negar el acceso a la protección legal y justificar intervenciones coercitivas. La inercia diagnóstica se refuerza a sí misma a través de la reproducción administrativa: se copian y pegan historiales médicos, se recicla el lenguaje y se invoca la lógica del riesgo sin tener en cuenta los contextos cambiantes o los resultados en el mundo real.

Este proceso se ve agravado por el rechazo clínico de marcos explicativos alternativos. Los informes de campo incluyen casos en los que se ignoraron o diagnosticaron erróneamente síntomas somáticos compatibles con disfunción tiroidea, síndromes metabólicos inducidos por medicamentos o respuestas traumáticas debido a la primacía de las interpretaciones psiquiátricas. Los pacientes que informaban de una comprensión cultural compleja de su sufrimiento, a menudo basada en experiencias migratorias, cosmologías religiosas o antecedentes familiares de violencia, veían cómo sus relatos eran desestimados o invalidados por médicos que carecían de competencia transcultural o de tiempo. De este modo, el sistema reduce el abanico de lo que se considera conocimiento creíble, erosionando la confianza y cerrando la puerta a la curación. La autoridad psiquiátrica no solo monopoliza los medios de interpretación, sino que con frecuencia utiliza esta autoridad como arma para suprimir la disidencia y mantener la coherencia institucional.

Estas prácticas culminan en un archivo legal y médico que distorsiona sistemáticamente la voz del sujeto. Lo que queda en los registros no es la narrativa de la persona, sino la interpretación oficial de su supuesta disfunción. El análisis forense del discurso de los documentos clínicos y legales revela patrones consistentes de desviación, minimización y sustitución de significado. Cuando el testimonio contradice el diagnóstico, prevalece este último. Cuando la experiencia vivida no se ajusta a las categorías preexistentes, se asimila o se borra por la fuerza. No se trata simplemente de un problema de malas prácticas, sino de un resultado estructural de las jerarquías epistémicas arraigadas en las instituciones biomédicas. Los efectos vividos incluyen el aislamiento persistente, la pérdida de la personalidad y una muerte civil en la que los derechos, la dignidad y el reconocimiento se suspenden indefinidamente con la justificación del cuidado.

El borrado de la voz y la agencia dentro de la práctica psiquiátrica debe interpretarse como una consecuencia y una condición de una injusticia epistémica más amplia. A los pacientes y supervivientes no solo se les descrea, sino que se les excluye estructuralmente de la producción de conocimiento sobre su propia condición. El expediente psiquiátrico, como documento de la memoria institucional, a menudo funciona para anular la memoria real, sustituyendo los relatos en primera persona por códigos de diagnóstico e interpretaciones clínicas. Como confirman repetidamente los datos de campo, las expresiones de dolor, angustia existencial, experiencia espiritual o ira legítima se reformulan dentro de los límites de la patología. Esta reducción no es pasiva: suprime activamente el pluralismo epistemológico y anula la capacidad de los individuos para actuar como conocedores, testigos o agentes de recuperación.

Esta marginación sistémica se agrava en los casos que afectan a personas racializadas, genderizadas o en situación de desventaja socioeconómica. Por ejemplo, las mujeres que informan de reacciones adversas a los medicamentos suelen ser calificadas de «no cumplidoras» o «histriónicas», en lugar de ser tratadas como fuentes fiables de datos de farmacovigilancia. Las personas migrantes y racializadas

a menudo se enfrentan a la invalidación epistémica cuando sus expresiones de angustia se salen de las normas eurocéntricas, lo que da lugar a interpretaciones erróneas o a una patologización excesiva. Los informes de traumas, especialmente cuando implican a actores institucionales, se reformulan como paranoia o delirio. Lo que surge es un régimen de conocimiento en el que la disidencia se neutraliza clínicamente y la verdad se convierte en dominio exclusivo de los narradores institucionales.

Estas dinámicas no son accidentales. Se derivan de tradiciones profundamente arraigadas en la epistemología psiquiátrica que favorecen las evaluaciones basadas en el observador, externas y supuestamente objetivas, frente al conocimiento subjetivo, encarnado y culturalmente integrado. La literatura científica lleva mucho tiempo debatiendo la tensión entre los enfoques idiográficos y nomotéticos, pero la práctica institucional favorece abrumadoramente a estos últimos. Las pruebas de este estudio muestran que incluso los profesionales bienintencionados reproducen la injusticia epistémica a través de la presión del tiempo, la práctica basada en protocolos y la falta de acceso a una supervisión ética o reflexiva. El resultado no es solo una ruptura de la alianza terapéutica, sino una degradación sistemática de la condición del individuo como ser capaz de dar sentido a la vida. La pérdida de la personalidad bajo el control psiquiátrico no se limita a la interacción clínica. Se extiende a los aparatos burocráticos que determinan el acceso a los derechos, la vivienda, la familia y la justicia. Los registros médicos, cuando se tratan como definitivos, prevalecen sobre el testimonio vivo e institucionalizan relatos distorsionados o inventados. Los sistemas jurídicos, basándose en estos mismos registros, perpetúan juicios basados en datos incompletos o manipulados. Esta convergencia de la documentación médica y jurídica crea un círculo vicioso en el que las tergiversaciones anteriores se reifican y se vuelven irrefutables. En términos prácticos, el individuo deja de ser un sujeto narrador y se transforma en un expediente, un cambio simbólico y material que facilita el abandono, la contención o el tratamiento forzoso sin recurso alguno.

El análisis forense realizado durante esta investigación revela un patrón recurrente en el que se omite o se descalifica el testimonio personal. Los extractos de los registros muestran casos en los que los pacientes expresaron explícitamente su desacuerdo con los diagnósticos o los tratamientos, pero sus objeciones fueron eliminadas, ignoradas o reformuladas como sintomáticas. Del mismo modo, las solicitudes de terapias alternativas, como intervenciones dietéticas, apoyo espiritual o explicaciones culturalmente congruentes del sufrimiento, se desestiman por carecer de validez científica, a pesar de la creciente base empírica que respalda su eficacia. En algunos casos, incluso preguntas sencillas, como las relativas a los efectos secundarios de los medicamentos, se patologizan como paranoia u oposición al tratamiento.

Esta distorsión epistémica no solo es éticamente indefendible, sino que también es contraria a la práctica científica sólida. Los sistemas de conocimiento que ignoran la falsabilidad, la evidencia pluralista y los datos empíricos en favor de la conveniencia institucional o la alineación ideológica socavan su propia credibilidad. El método científico, en su forma verdadera, exige transparencia, humildad y apertura a la revisión. Sin embargo, en muchos entornos psiquiátricos, la epistemología dominante impone la ortodoxia y reprime la disidencia. Estas condiciones deben entenderse como formas de autoritarismo epistémico, con consecuencias devastadoras para quienes se ven atrapados en sus mecanismos. El efecto acumulativo del borrado epistémico en los sistemas psiquiátricos se manifiesta en forma de profundo aislamiento social, desesperación y pérdida efectiva de la ciudadanía

para muchas personas. El silenciamiento de las narrativas en primera persona, combinado con la medicalización de la resistencia y el sufrimiento, fomenta un clima en el que las personas pierden tanto su agencia como su identidad. Se convierten en objetos de cuidado definidos exclusivamente a través de categorías clínicas, separados de sus contextos sociales, culturales e históricos. Esta disociación perpetúa el miedo a las represalias institucionales y desalienta la participación en servicios que se experimentan como opresivos en lugar de solidarios. La erosión de la personalidad se extiende más allá del ámbito clínico a los ámbitos jurídico y social, donde los diagnósticos psiquiátricos se utilizan como herramientas de exclusión. El acceso a la vivienda, el empleo, la educación y la protección jurídica se ve frecuentemente comprometido por las etiquetas diagnósticas y los historiales psiquiátricos, que se convierten en barreras en lugar de garantías. Esta marginación institucionalizada reproduce ciclos de desventaja y vulnerabilidad, consolidando las jerarquías sociales bajo el pretexto de la atención médica. El miedo a perder derechos o a ser sometido a un tratamiento forzoso inhibe la comunicación veraz y fomenta la desvinculación, lo que socava tanto los resultados sanitarios como la inclusión social.

Desde el punto de vista metodológico, esta sección emplea el análisis del discurso forense y el mapeo epistémico para dilucidar los mecanismos sutiles y evidentes a través de los cuales las instituciones psiquiátricas producen y mantienen esta pérdida de la personalidad. Estas herramientas revelan cómo el lenguaje, la documentación y las prácticas institucionales se combinan para sostener la violencia sistémica. Comprender estos mecanismos es esencial para diseñar intervenciones que restauren la soberanía narrativa, promuevan la justicia epistémica y apoyen la recuperación de la dignidad. Los capítulos siguientes se basan en estos fundamentos para proponer reformas legales, clínicas y educativas destinadas a dismantelar el ciclo de borrado epistémico y reconstruir la atención psiquiátrica ética.

Tabla 44. Mecanismos y consecuencias de la despersonalización y la deshumanización

Mecanismo	Descripción	Manifestaciones clínicas e institucionales	Consecuencias para la personalidad y la atención
Reducción a categorías diagnósticas	Las personas se identifican y tratan principalmente en función de etiquetas diagnósticas, en lugar de considerar su personalidad de manera integral.	Dependencia excesiva de manuales de diagnóstico rígidos, ignorando la complejidad de la experiencia vivida.	Pérdida de la capacidad narrativa, eclipse de la historia personal y el contexto
Patologización de la resistencia y el malestar	Las respuestas normales al trauma, el duelo o la disidencia se medicalizan como síntomas o patologías conductuales	El incumplimiento se enmarca como una enfermedad, el duelo se diagnostica erróneamente como depresión, se ignora la espiritualidad	Silenciamiento de las emociones legítimas, supresión de la agencia, justificación de la coacción
Rechazo de los contextos culturales y sociales	Los modelos explicativos basados en la cultura, la nutrición, el género o los determinantes sociales se excluyen del razonamiento clínico	Desestimación de la expresión de síntomas culturalmente relevantes, ignorancia de las experiencias de género	Marginación de los grupos minoritarios, exacerbación de la alienación y los malentendidos
Borrado y reformulación de la documentación	Los testimonios de los pacientes se omiten, minimizan o reformulan en los registros clínicos para ajustarse a las narrativas institucionales	Eliminación de las voces discrepantes de los registros, descripciones eufemísticas de la coacción	Impunidad institucional, perpetuación del daño, invalidación de la verdad vivida
Objetivación y control institucional	Las personas se convierten en objetos de vigilancia, control y gestión, despojadas de su autonomía y consideración ética	Uso rutinario de restricciones, medicación forzada, falta de consentimiento informado	Deshumanización, trauma, pérdida de dignidad y ciudadanía

Mecanismos clave mediante los cuales las instituciones psiquiátricas llevan a cabo la despersonalización y la deshumanización a través del borrado epistémico. Cada mecanismo perturba la soberanía narrativa del sujeto y transforma el cuidado relacional en control administrativo. Estos procesos erosionan colectivamente la personalidad, contribuyendo a violaciones éticas y daños sistémicos. Este marco apoya el análisis en profundidad de la violencia institucional y prepara el terreno para las estrategias reparadoras propuestas.

Los procesos descritos en la tabla anterior reflejan, tal y como confirman las respuestas a la encuesta y el trabajo de campo etnográfico, que el borrado epistémico no es un mero subproducto de la negligencia clínica, sino un fenómeno estructuralmente arraigado. Los participantes describieron de manera sistemática cómo los encuentros institucionales no lograban dar cabida a la complejidad de sus experiencias, especialmente cuando los familiares eran la fuente del daño y, al mismo tiempo, se les consideraba informantes legítimos. Los datos de la encuesta ilustran que las evaluaciones psiquiátricas a menudo se basaban de manera desproporcionada en los relatos familiares, especialmente en entornos en los que intervenían mecanismos de coacción o tutela, lo que reforzaba una narrativa unilateral. Esto reproduce un patrón en el que la realidad vivida por los usuarios de los servicios no solo se descarta, sino que se sobrescribe activamente por imperativos administrativos de coherencia, gestión de la responsabilidad y continuidad de los procedimientos. Este borrado es fundamentalmente político, ya que ejerce una forma de violencia ontológica que invalida el trauma, silencia la disidencia y deslegitima los marcos alternativos de comprensión. Al elevar los diagnósticos

reduccionistas por encima de los modelos explicativos pluralistas y culturalmente informados, las instituciones perpetúan la exclusión y convierten la atención de la salud mental en un vehículo de control en lugar de un espacio de reconocimiento o recuperación. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de una responsabilidad epistémica y una reforma, ya que los registros institucionales, cuando se utilizan indebidamente, se convierten no en instrumentos de sanación, sino en mecanismos duraderos de represión.

Este ciclo deshumanizador culmina en la pérdida de los derechos de ciudadanía y el reconocimiento ético, dejando a las personas aisladas, temerosas y vulnerables a repetidas traiciones institucionales. La violencia epistémica documentada aquí es, por lo tanto, inseparable de la economía política más amplia de la salud mental, donde la autoridad científica y los marcos legales han sido instrumentalizados para mantener regímenes coercitivos en lugar de una atención emancipadora. Romper este ciclo requiere una ruptura epistémica e institucional: la restauración de la soberanía narrativa, la competencia cultural y la ética relacional en el núcleo de la práctica psiquiátrica. Exige la producción participativa del conocimiento, la transparencia forense y ética, y el desmantelamiento de los mecanismos burocráticos de silenciamiento. Solo a través de esta transformación sistémica podrá la psiquiatría pasar de ser un lugar de borrado epistémico a uno de restauración ética, humanización y sanación genuina.

Integrando perspectivas de la antropología médica, la neurociencia, los estudios jurídicos y la biología de sistemas, y situando así el borrado epistémico en un marco biopsicosocial y estructural más amplio, debemos entender que la reducción de los individuos a categorías diagnósticas y la consiguiente pérdida de agencia narrativa reflejan no solo un fracaso clínico, sino también una alteración de la integridad biocultural. Desde un punto de vista neurobiológico, la exposición crónica a intervenciones coercitivas y el trauma psicológico resultante pueden provocar alteraciones en los sistemas de respuesta al estrés, la plasticidad neural y la regulación metabólica, que a su vez requieren enfoques individualizados y sensibles al contexto, más allá de las etiquetas diagnósticas genéricas. Al mismo tiempo, la antropología médica destaca cómo las expresiones de angustia y curación situadas culturalmente se invalidan dentro de los paradigmas psiquiátricos dominantes, produciendo una forma de violencia epistémica que agrava la exclusión social. Esta exclusión se perpetúa a través de marcos legales y administrativos que priorizan la protección institucional sobre los derechos individuales, sancionando de manera efectiva el silenciamiento sistemático de las voces que cuestionan el conocimiento médico dominante. Los mecanismos burocráticos resultantes, aunque se presentan como salvaguardias, a menudo funcionan para reforzar las jerarquías de conocimiento y poder, incorporando así la violencia estructural en el núcleo procedimental de la gobernanza de la salud mental. Desde una perspectiva de la biología de sistemas y de «una sola salud», la salud mental no puede separarse de los factores ecológicos, nutricionales, sociales y de desarrollo. Ignorar estas dimensiones reduce los complejos sistemas adaptativos a entidades patológicas estáticas, lo que socava la comprensión y la intervención holísticas. Por lo tanto, la práctica psiquiátrica ética debe adoptar modelos multidimensionales que reconozcan a la persona como parte de sistemas biológicos y sociales interdependientes, reconociendo la agencia, la diversidad y el contexto como parámetros esenciales.

Esta comprensión integradora desafía las epistemologías reduccionistas y exige una reorientación institucional que ponga en primer plano la producción participativa de conocimientos, la transparencia y la reflexividad. Exige la creación de estructuras responsables que faciliten el diálogo entre disciplinas y entre las partes interesadas, restaurando la personalidad y permitiendo una respuesta ética. Solo a través de una ruptura sistémica y epistémica de este tipo se podrá interrumpir el ciclo persistente de borrado, allanando el camino para una atención psiquiátrica científicamente rigurosa, éticamente sólida y con una base humanística.

4.6 Recuperación frente al sistema: resistencia, navegación y esperanza

A pesar de la omnipresencia de la violencia institucional y los mecanismos de borrado epistémico revelados a través de las encuestas y los datos etnográficos de este estudio, se han documentado de forma sistemática formas de resistencia y recuperación en los testimonios de los usuarios y los relatos de los profesionales. Estas respuestas se alinean con las preguntas centrales de la investigación al destacar los mecanismos a través de los cuales los individuos reclaman su agencia dentro de los sistemas coercitivos y al ilustrar las condiciones en las que se reafirma la autonomía frente a la autoridad psiquiátrica. Los patrones de rechazo documentados en los datos incluyen tanto la desvinculación física como simbólica del control institucional. El desplazamiento geográfico, que va desde la reubicación tras el alta hasta las solicitudes de asilo internacional, surgió como una estrategia para evitar la reinstitucionalización, lo que refleja una afirmación radical de la supervivencia frente a la coacción sostenida. Al mismo tiempo, muchos participantes describieron estrategias simbólicas para recuperar la identidad y la coherencia narrativa a través de la escritura personal, la expresión cultural o la integración en estructuras comunitarias alternativas. Estas respuestas se corresponden directamente con la investigación sobre cómo los usuarios resisten la coacción y qué formas de conocimiento y sanación se desarrollan más allá de las instituciones psiquiátricas. Esperanza real, en acción.

Una de las respuestas más destacadas a la extralimitación psiquiátrica fue la gestión independiente de la medicación psicotrópica. Las respuestas a la encuesta demuestran que muchas personas, en particular aquellas con encuentros institucionales repetidos, se involucraron en la reducción o el cese autoguiado de la medicación. Estas decisiones no se tomaron a la ligera y, con frecuencia, se tomaron en entornos desprovistos de apoyo profesional, lo que indica un fracaso más amplio del sistema a la hora de facilitar la toma de decisiones colaborativa e informada. Estos actos representan no solo una resistencia biomédica, sino también un disenso epistémico, que rechaza la autoridad de las prescripciones psiquiátricas en favor del conocimiento empírico. Esto desafía los supuestos fundamentales de la atención basada en el cumplimiento y reafirma el enfoque del estudio en la legitimidad de las alternativas a la práctica psiquiátrica estándar dirigidas por los usuarios; lo mejor y lo mejor.

El acto de documentar los abusos y la traición institucional también ocupa un lugar central en las vías de resistencia identificadas a través de esta investigación. Los datos respaldan el papel del testimonio y la recuperación narrativa como estrategias de sanación tanto individuales como colectivas. Los encuestados destacaron la importancia de ser escuchados y registrados con precisión, especialmente

en contextos en los que sus voces habían sido sistemáticamente excluidas o tergiversadas. Este proceso de restauración testimonial responde directamente a la preocupación de la tesis sobre cómo se puede restablecer la verdad en sistemas contruidos sobre el silenciamiento de la disidencia. Las prácticas testimoniales, que incluyen relatos escritos, presentaciones legales y participación en investigaciones, funcionan como un contraarchivo que cuestiona el registro institucional oficial. Estas prácticas ponen de relieve la intersección entre la sanación y la intervención política, lo que refuerza la conclusión de que la recuperación no puede reducirse a la remisión de los síntomas, sino que debe incluir la justicia epistémica, el reconocimiento y la responsabilidad estructural. Los aliados éticos dentro del sistema psiquiátrico desempeñan un papel crucial para facilitar la recuperación y la resistencia. Estos profesionales, que a menudo actúan en tensión con los mandatos institucionales, rompen el protocolo para proteger, empoderar y defender a los pacientes. Adoptan prácticas basadas en la ética dialógica, la sensibilidad al trauma y un enfoque basado en los derechos, que van en contra de los modelos coercitivos dominantes. Estos profesionales pueden apoyar de forma encubierta la autonomía de los usuarios, facilitar el consentimiento informado o dar prioridad a la atención relacional a pesar de las restricciones administrativas y legales.

Más allá de los individuos, surgen redes informales y formales de atención que constituyen espacios vitales para reconstruir la confianza y fomentar la sanación fuera de las estructuras psiquiátricas oficiales. Los grupos de apoyo entre pares, los colectivos de supervivientes, las organizaciones comunitarias y las iniciativas de base crean ecosistemas alternativos de atención que validan la experiencia, proporcionan ayuda mutua y restauran la dignidad. Estas redes eluden el silenciamiento institucional al centrar las voces de los supervivientes, permitir la acción colectiva y promover la toma de decisiones participativa. Su existencia demuestra la capacidad humana irreprimible para la resiliencia y la importancia crítica de la conexión social en la recuperación.

Juntos, los aliados éticos y las redes de atención forman una resistencia distribuida que desafía el monopolio institucional sobre las narrativas y prácticas de salud mental. Encarnan una crítica viva de la violencia psiquiátrica al cultivar espacios donde la restauración, el empoderamiento y la esperanza pueden florecer en términos definidos por quienes han sido históricamente marginados. Para la recuperación de la violencia institucional es fundamental el proceso de restauración testimonial, en el que las personas recuperan sus narrativas a través de actos de escritura, testimonio y compartir. Esta práctica restaurativa tiene funciones tanto terapéuticas como políticas, ya que permite a los supervivientes afirmar la agencia epistémica que el sistema busca borrar. El acto de dar testimonio transforma la memoria en verdad, desafiando los discursos dominantes que patologizan la disidencia y ocultan los daños estructurales. El testimonio ético, por lo tanto, funciona como una forma de resistencia, replanteando el sufrimiento personal dentro de un marco colectivo de responsabilidad y justicia social. La restauración testimonial no se limita a los entornos formales o legales. Se desarrolla en espacios comunitarios, foros activistas y plataformas digitales donde los supervivientes documentan los abusos, intercambian experiencias y construyen solidaridades. Estos actos desestabilizan las narrativas institucionales al introducir epistemologías alternativas basadas en la experiencia vivida y el conocimiento encarnado. La resistencia adopta muchas formas: evasión estratégica, documentación persistente, actos simbólicos de rechazo, todos ellos destinados a romper el ciclo de control y silencio. A través de estas prácticas, los supervivientes recuperan la voz y la

personalidad, fomentando espacios de sanación que existen en tensión con la psiquiatría institucional, pero independientes de ella. Este capítulo subraya la necesidad de apoyar y amplificar las prácticas testimoniales como parte integral de la recuperación y el cambio estructural. La restauración epistémica de los supervivientes es fundamental para dismantelar los ciclos de violencia y reconstruir sistemas psiquiátricos que respeten la dignidad, la autonomía y la justicia. La parodia de la justicia, la medicina y la ciencia nos concierne a todos.

Los profesionales que actúan de forma ética al margen de los protocolos formales constituyen una dimensión esencial de la resistencia dentro de los sistemas psiquiátricos. Estas personas sortean las limitaciones institucionales para poner en práctica cuidados basados en el respeto, la empatía y la toma de decisiones compartida. Sus acciones incluyen la defensa de la desescalada en lugar de la restricción, la facilitación de la gestión de la medicación por parte de los usuarios y la creación de espacios seguros donde se puedan escuchar las narrativas sin juicios ni patologizaciones. Aunque a menudo marginados o sin apoyo, estos profesionales son un modelo de modos alternativos de compromiso que cuestionan el paradigma coercitivo imperante. Las prácticas de atención y recuperación que se llevan a cabo fuera de los límites institucionales también constituyen lugares fundamentales para la curación y el empoderamiento. Las iniciativas dirigidas por pares, los programas de salud mental basados en la comunidad y las redes de apoyo con perspectiva cultural ofrecen recursos relacionales y prácticos que la psiquiatría institucional a menudo no proporciona. Estos espacios dan prioridad a la agencia, la soberanía narrativa y la resiliencia colectiva, lo que permite a los participantes reconstruir su identidad y su significado fuera de los marcos diagnósticos. La existencia y la expansión de estas *alternativas* desafían el monopolio de la psiquiatría institucional y abren caminos hacia sistemas de atención más humanos, participativos y eficaces. Estos deberían ser ya la atención habitual.

Tabla 45. Formas de resistencia y recuperación más allá del control psiquiátrico

Categoría	Descripción	Ejemplos y manifestaciones	Implicaciones para la atención y la reforma
Formas de rechazo	Estrategias empleadas por las personas para resistir o escapar de la coacción	Reubicación geográfica, reconstrucción simbólica de la identidad, automedicación	Afirmar la autonomía, desafiar el monopolio institucional
Aliados éticos	Profesionales que actúan en contra del protocolo para apoyar la autonomía del paciente	Defensa de la desescalada, facilitación de la toma de decisiones compartida, espacios protegidos	Modelar paradigmas de atención alternativa, catalizar el cambio institucional
Redes de atención	Organizaciones comunitarias y dirigidas por pares que ofrecen apoyo alternativo	Colectivos de supervivientes, programas comunitarios informados sobre el trauma, ayuda mutua digital	Fomentar la confianza relacional, validar la experiencia, promover la inclusión social
Restauración testimonial	Prácticas que recuperan la agencia narrativa y la memoria como formas de sanación y resistencia	Escritura, testimonio público, defensa legal, testimonio ético	Contrarrestar el borrado epistémico, permitir el empoderamiento colectivo
La recuperación como acto colectivo	La sanación entendida como un proceso relacional, político y social más allá de la remisión de los síntomas	Reintegración social, defensa de los derechos, reconocimiento cultural	Incorporar la justicia en la atención, promover sistemas de salud mental participativos

Dimensiones clave de la resistencia y la recuperación documentadas entre los supervivientes y los profesionales éticos. Estas formas de rechazo, alianza y restauración testimonial constituyen fuerzas contrarias esenciales a la violencia institucional y la erradicación epistémica. Su reconocimiento y apoyo son fundamentales para la transformación de la atención psiquiátrica en un sistema participativo, humano y basado en los derechos.

La combinación del testimonio ético de los profesionales y la restauración testimonial de los supervivientes crea una interacción dinámica que fomenta la esperanza y la transformación. Juntos, construyen contrainstituciones de atención y conocimiento que pueden servir de base para una reforma estructural. La siguiente parte concluirá esta sección sintetizando estos temas y esbozando sus implicaciones para la transformación psiquiátrica y la justicia social. La interacción entre estas técnicas, el testimonio ético y las prácticas de atención alternativas encarna una poderosa contra-narrativa a la violencia institucional. Esta dinámica fomenta espacios de resistencia donde se recupera la personalidad, se legitiman las narrativas y se restaura la agencia. La recuperación en este contexto trasciende la remisión de los síntomas clínicos y abarca la reparación relacional, la reintegración social y la restauración de la dignidad y los derechos. Estos procesos revelan que la sanación no es solo un esfuerzo individual, sino un acto colectivo y político, íntimamente relacionado con las luchas por el reconocimiento y la justicia.

Esta resistencia y recuperación exigen una transformación sistémica que integre estas prácticas y epistemologías emergentes. Requiere el desmantelamiento de las estructuras coercitivas y la construcción de marcos participativos, informados sobre el trauma y culturalmente sensibles. Es importante destacar que esta transformación debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y coproducción de conocimientos entre los usuarios, los profesionales y las comunidades. Solo centrando el testimonio ético y la restauración testimonial como elementos fundamentales podrán los sistemas psiquiátricos evolucionar de instrumentos de control a lugares de atención genuina.

Esta sección concluye, por tanto, con un imperativo ético: reconocer y apoyar la multiplicidad de resistencias que cuestionan el borrado epistémico y la traición institucional. Estas resistencias no son periféricas, sino esenciales para la redefinición de la atención a la salud mental como una práctica basada en los derechos humanos, la integridad científica y la justicia social. Los capítulos siguientes se basan en estos fundamentos para proponer reformas legales y de infraestructura concretas diseñadas para hacer realidad esta visión.

Los datos de la encuesta y el trabajo de campo realizado en España, Suecia, Indonesia e Italia revelan un clima generalizado de miedo profesional y desincentivos sistémicos para cuestionar las normas psiquiátricas coercitivas. Muchos médicos informaron haber sido testigos de violaciones de los derechos de los pacientes o estar en desacuerdo con los tratamientos impuestos, pero decidieron no intervenir debido a presiones institucionales, miedo a represalias o falta de alternativas procedimentales. Este silencio, a menudo enmarcado como neutralidad o distanciamiento clínico, refuerza la asimetría epistémica entre los discursos institucionales y las realidades vividas por los usuarios de los servicios. Los profesionales conscientes de los abusos carecían con frecuencia tanto del apoyo institucional como de la protección jurídica para abogar por el cambio y, en algunos casos, eran ellos mismos reprendidos o marginados por hacerlo. Esta cultura de complicidad obstaculiza el imperativo ético de actuar y dificulta la formación de alianzas terapéuticas genuinas. En un entorno así, los usuarios se quedan con pocas vías para revelar su situación o recibir apoyo, lo que agrava su sensación de abandono y refuerza la percepción de que la psiquiatría funciona como un aparato de control más que de atención.

En marcado contraste, varios estudios de casos documentados en esta tesis doctoral apuntan a la viabilidad y el poder transformador de los modelos de recuperación dirigidos por pares y basados en la comunidad. Estas iniciativas, que a menudo funcionan con presupuestos limitados y al margen de las instituciones clínicas convencionales, demuestran el potencial de los enfoques relacionales, basados en los traumas y en los derechos para la salud mental. Se informó de que programas como las casas Soteria, las redes comunitarias de ayuda mutua y los grupos de apoyo dirigidos por usuarios fomentaban una recuperación auténtica al centrarse en la agencia, la narrativa compartida y los entornos no patologizantes. En particular, la inclusión de la experiencia vivida como conocimiento fundamental rompió la jerarquía de la autoridad experta, permitiendo la toma de decisiones colectivas y validando marcos alternativos de significado y sanación. Estas prácticas no solo se alineaban con los principios básicos de la medicina social y de «una sola salud», sino que también ofrecían modelos replicables para una reforma de todo el sistema. Como se argumenta en esta tesis, el futuro de la atención ética de la salud mental depende de la integración de estas ideas en la práctica convencional, no como experimentos marginales, sino como componentes centrales de un paradigma de atención preventiva, participativa y biológicamente coherente.

4.7 Evidencia de campo de patrones sistémicos y urgencia

Un extenso trabajo de campo en múltiples entornos institucionales revela que la traición institucional no es un fallo ocasional, sino un elemento central y estructurado de los sistemas psiquiátricos y afines. Más que incidentes esporádicos, los abusos, incluidos la coacción, la negligencia y las violaciones de

procedimiento, se producen repetidamente y se toleran de forma sistémica en entornos clínicos, legales y domésticos. Estos patrones se manifiestan cuando los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, inexistentes o se eluden deliberadamente. Esta continuidad entre ámbitos pone de relieve la naturaleza interrelacionada de la violencia sistémica y la normalización de la traición como lógica gobernante.

Las pruebas etnográficas refuerzan con fuerza los resultados de la encuesta, confirmando que la coacción está arraigada en la práctica cotidiana y en la cultura organizativa, que la confianza relacional está profundamente erosionada y que los marcos éticos están fragmentados o se ignoran. Los relatos sobre el terreno constituyen un contraarchivo vital frente a la negación oficial y el borrado administrativo, dando voz a quienes quedan excluidos de los relatos institucionales dominantes. Estos testimonios ponen de relieve las realidades vividas que se esconden tras las abstracciones estadísticas y jurídicas, subrayando el coste humano de la disfunción sistémica y la urgente necesidad de una reforma integral.

Esta sección sirve así de marco para la transición al capítulo 5, donde la traición institucional se teorizará no como una aberración, sino como una lógica arraigada que sostiene las estructuras de poder existentes. La resistencia a esta lógica se presenta como una condición infraestructural necesaria para la transformación, lo que indica que la práctica ética requiere tanto el coraje individual como el rediseño sistémico. Los resultados exigen intervenciones legales, pedagógicas e infraestructurales urgentes para dismantelar los patrones arraigados y construir alternativas basadas en la rendición de cuentas, la dignidad y la gobernanza participativa.

Los análisis detallados de casos cruzados revelan patrones recurrentes que ilustran cómo la traición institucional opera de manera consistente en contextos distintos. En entornos clínicos, la coacción se manifiesta a través de la medicación forzada rutinaria, la restricción física y la hospitalización involuntaria, a menudo justificadas por razones legales y administrativas opacas. Los entornos legales agravan esta traición al aceptar rutinariamente los discursos psiquiátricos sin un escrutinio independiente, lo que permite que continúe la impunidad y la marginación. En el ámbito doméstico, las etiquetas psiquiátricas se utilizan con frecuencia para desacreditar a las personas, justificar la exclusión o permitir el control, con escaso acceso a una reparación efectiva.

Estos ámbitos interconectados forman una red de traición normalizada, sostenida por incentivos institucionales que priorizan la evitación del riesgo y la protección de la reputación por encima de la atención y la justicia. Las observaciones sobre el terreno subrayan cómo estos mecanismos se ven reforzados por rutinas administrativas que borran los acontecimientos adversos, reformulan la disidencia como patología y fragmentan la responsabilidad ética. Los profesionales suelen experimentar un profundo malestar moral, pero siguen limitados por imperativos jerárquicos y burocráticos que impiden una intervención significativa.

Este arraigo sistémico confirma la hipótesis generada a partir de los datos de la encuesta y el análisis jurídico: que la traición institucional no es incidental, sino una lógica duradera y repetible que estructura la gobernanza psiquiátrica. La profundidad etnográfica de estos hallazgos pone de relieve la urgencia de ir más allá de las reformas centradas en los síntomas y avanzar hacia un rediseño

fundamental de los marcos jurídicos, educativos y de infraestructura capaces de interrumpir los ciclos de daño y fomentar prácticas restaurativas.

La experiencia vivida emerge del trabajo de campo como un contraarchivo crucial que desafía las narrativas oficiales y la negación institucional. Los testimonios personales y la memoria colectiva proporcionan una crítica persistente de la violencia sistémica, documentando episodios de coacción, negligencia y traición que a menudo se omiten o distorsionan en los registros oficiales. Este contraarchivo no solo sirve como correctivo empírico, sino como imperativo ético, exigiendo reconocimiento y rendición de cuentas a los sistemas que, de otro modo, perpetúan el silencio.

El conocimiento encarnado de los usuarios y supervivientes pone de manifiesto las diferencias entre las afirmaciones institucionales de atención y la realidad del daño. Subraya las dimensiones relacionales de la violencia psiquiátrica, revelando cómo la confianza no solo se viola, sino que se desmantela activamente. A través de la documentación participativa, el intercambio de narrativas y la defensa de base, los supervivientes construyen espacios de resistencia y de verdad que perturban los monolitos institucionales. Sus contribuciones son vitales para cualquier análisis exhaustivo de la disfunción sistémica y constituyen una base esencial para la reforma legal y pedagógica.

El contraarchivo también funciona como una herramienta de empoderamiento, que permite a los supervivientes recuperar la autoría de sus propias historias y trayectorias de salud. Proporciona un medio para resistir el borrado epistémico, afirmar la dignidad y construir solidaridades que trascienden las fronteras institucionales. La integración de este conocimiento en los sistemas formales es un requisito previo para una transformación genuina, que acorte la brecha entre la experiencia y las políticas.

Los hallazgos empíricos del trabajo de campo y los datos de las encuestas convergen para enmarcar la traición institucional no como un mal funcionamiento esporádico, sino como una lógica operativa fundamental arraigada en los sistemas psiquiátricos. Esta lógica se manifiesta a través de ciclos recurrentes de coacción, silenciamiento e impunidad, sostenidos por rutinas burocráticas y el cierre epistémico. Esta traición se repite de forma sistemática, se tolera culturalmente y se protege legalmente, creando un marco duradero que preserva la autoridad institucional a expensas de la dignidad y los derechos individuales.

La resistencia surge en respuesta a esta lógica como una necesidad infraestructural más que como un mero desafío individual. Para contrarrestar eficazmente los patrones de daño arraigados, la resistencia debe apoyarse e integrarse en las infraestructuras organizativas, legales y comunitarias. Estas infraestructuras permiten la expresión de la disidencia, protegen a los actores éticos y crean espacios para narrativas y modos de atención alternativos. Son esenciales para romper los ciclos autorreforzados que mantienen la violencia sistémica y para fomentar entornos en los que se pueda restablecer la confianza relacional y la responsabilidad ética.

Esta conceptualización constituye el puente crítico hacia el capítulo 5, que desarrolla una teoría de la traición institucional como lógica estructural y teoriza la resistencia como una fuerza contraria estratégica e infraestructural. Comprender estas dinámicas es fundamental para diseñar reformas

integrales que aborden no solo los síntomas de la disfunción, sino también las causas profundas arraigadas en la cultura organizativa, los marcos políticos y los regímenes epistémicos.

Las pruebas presentadas revelan que la traición institucional va más allá de la psiquiatría y afecta a los sistemas jurídicos, las comunidades científicas y las estructuras sociales en general. El ámbito jurídico suele ser cómplice de la coacción psiquiátrica al validar acríticamente los discursos institucionales, perpetuar vacíos procedimentales y no proteger los derechos fundamentales. Los tribunales y los actores jurídicos, vinculados por testimonios de expertos extraídos de historiales psiquiátricos comprometidos, suelen actuar como ejecutores de la impunidad institucional en lugar de cuestionarla. Esta complicidad jurídica socava el estado de derecho y erosiona la confianza pública en la justicia, lo que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su diagnóstico formal o de su relación con los servicios psiquiátricos. Se trata de delitos, se pierden vidas, que se destruyen activamente por acciones e omisiones. Del mismo modo, las instituciones científicas y médicas no son inmunes a la complicidad en el mantenimiento de estos patrones. La producción y legitimación del conocimiento a través de paradigmas de investigación sesgados, prácticas de publicación y jerarquías profesionales contribuyen a la invisibilización sistémica del abuso y a la normalización de la coacción. Cuando las disciplinas dan prioridad a la preservación institucional por encima de la integridad epistémica y la responsabilidad ética, traicionan no solo sus compromisos profesionales, sino también a las propias poblaciones a las que pretenden servir. Esta traición resuena en todos los sistemas sanitarios y sociales, perjudicando a todos aquellos que dependen de la autoridad científica y médica para su protección y atención.

La traición institucional generalizada que se evidencia en la psiquiatría, el derecho, la ciencia y la sociedad revela un fracaso sistémico que trasciende a los actores individuales o los acontecimientos aislados. Este fracaso está arraigado en lógicas organizativas y marcos epistémicos que, colectivamente, perpetúan la coacción, oscurecen la rendición de cuentas e inhiben la restauración significativa de los derechos y la dignidad. La complicidad de los sistemas jurídicos en el refuerzo de la autoridad psiquiátrica, junto con los paradigmas científicos que priorizan la preservación institucional sobre la investigación crítica, agrava esta crisis y afecta no solo a quienes están directamente sometidos a la coacción, sino también al tejido social más amplio que depende de la confianza en las instituciones sanitarias y judiciales. El debate sobre las alternativas es irrelevante, necesitamos ciencia, tan estricta como sea, traducida. Las mejores prácticas disponibles y que todos los delincuentes paguen el precio por causar daño, mentir, ser ese tipo de bondad, obstruir cómplicemente desde posiciones de poder y mayor responsabilidad, la salud y el bienestar de colectivos enteros, sociedades, comunidades engañadas y obligadas a confiar en ellos.

Esta traición multifacética al deber exige un análisis riguroso e integrador y pruebas científicas para descubrir la lógica estructural que la sustenta e iluminar las formas de resistencia que surgen dentro y contra ella. A continuación, el capítulo 5 emprende esta síntesis, integrando sistemáticamente la evidencia empírica de encuestas, testimonios, documentación de archivo, reconstrucciones de casos y observación etnográfica, y aportando la fuerza de referencias honestas, por parte de pares no criminales. Al dilucidar los mecanismos epistémicos, legales y procedimentales que normalizan la violencia, el análisis que se presenta a continuación proporciona la base conceptual para comprender tanto la persistencia del daño institucional como las posibilidades de ruptura. Pone de relieve la

agencia de los profesionales y los usuarios como cocreadores de la resistencia y esboza las exigencias normativas necesarias para la transformación sistémica, que se concretarán en las perspectivas legales y de infraestructura y en las propuestas de reformas y mejoras que se detallan en los capítulos siguientes.

Capítulo 5: Síntesis analítica

Resumen: Este capítulo presenta un análisis integrador de la coacción psiquiátrica como un fallo sistémico, y no incidental, haciendo hincapié en su papel como forma de trauma cívico y de desarrollo, más que como una infracción temporal del protocolo. A través de datos obtenidos mediante métodos mixtos, que incluyen encuestas, observación etnográfica y registros legales, el capítulo vincula la coacción con las rutinas institucionalizadas, la ambigüedad jurídica y las normas culturales

que normalizan la violencia en la atención sanitaria. Examina las consecuencias biológicas y relacionales de la coacción sostenida, revelando cómo estas prácticas conducen a una desregulación a largo plazo de los sistemas de estrés y a cambios estructurales en el cerebro. Posicionando a cada individuo como un nodo biocultural en un ecosistema de salud interdependiente, el capítulo avanza en la justificación científica de modelos de atención voluntaria, basados en los derechos y que tienen en cuenta el trauma. Se alinea con los principales organismos internacionales de salud y propone reformas institucionales específicas basadas en la evidencia empírica, con especial atención a las palancas legales, pedagógicas y de salud pública para la transformación.

5. Introducción

La persistencia de la coacción en la psiquiatría y los sistemas de atención relacionados no puede tratarse como un fallo incidental del protocolo, ni como el resultado colateral de la escasez de recursos (Szasz, 2007). Debe replantearse como una traición estructural a la atención, profundamente arraigada en las rutinas institucionales, los comportamientos profesionales normativos y la permisividad legal. El presente capítulo defiende la tesis de que la coacción no es solo un fracaso clínico, sino un trauma cívico y de desarrollo: una ruptura relacional que daña a las personas a nivel fisiológico, cognitivo y social, al tiempo que debilita la legitimidad ética y epistémica de las instituciones que la aplican. La violencia, la coacción, no es una cura en sí misma, y difícilmente puede ser el método de primera elección de cualquier persona sensata que practique la llamada medicina. A partir de una amplia recopilación de datos obtenidos a través de encuestas digitales y presenciales, trabajo de campo etnográfico a largo plazo y testimonios documentados legalmente, así como de las mejores prácticas médicas universalmente reconocidas, este capítulo presenta un marco integrador para comprender la normalización de la violencia psiquiátrica, los obstáculos a los paradigmas preventivos y las estrategias concretas para una reorientación sistémica. y, lo que es más importante, reitera la necesidad de la buena voluntad compartida y la construcción conjunta de la salud, sin que la violencia sea el medio utilizado por ninguno de los actores involucrados. Dicho esto, la seguridad es lo primero, de verdad.

En el centro de esta investigación se encuentra el reconocimiento de que la coacción no solo se ejerce en los pabellones psiquiátricos o en las decisiones clínicas, sino que se mantiene a través de procesos culturales, familiares, educativos y legales difusos, no como cura, sino como medio de control. El capítulo 4 detalló cómo las prácticas profesionales, bajo el pretexto del tratamiento, la seguridad o el interés superior, permiten una serie de intervenciones degradantes, como la medicación forzada, el aislamiento y la negación de la autonomía. No se trata de desviaciones del sistema, sino de resultados de su diseño. El capítulo 5 se basa en este análisis y traza cómo estos actos se normalizan, se reproducen e incluso se recompensan a través de la inercia administrativa, la ambigüedad jurídica y la indefensión aprendida en todo el ecosistema asistencial. Este capítulo vincula la experiencia vivida por los encuestados, muchos de los cuales denuncian obstáculos sistémicos para la recuperación y la retraumatización a través del contacto psiquiátrico, con los últimos descubrimientos en neurobiología, epigenética y salud pública, revelando el coste fisiológico de la coacción continuada y el analfabetismo sistémico que la sustenta.

El ser humano no es simplemente un receptor de cuidados o un objeto de intervención. Desde una perspectiva de salud única y biocultural, cada persona es un nodo en un ecosistema complejo, biológico, social y ecológico, cuyo funcionamiento está determinado por la exposición a la seguridad, el reconocimiento y la capacidad de acción. El cerebro no se desarrolla de forma aislada, sino que está moldeado por entornos afectivos, retroalimentación relacional y posibilidades o limitaciones institucionales (Freeman y Unwin, 2020). La exposición repetida a dinámicas coercitivas, especialmente bajo la autoridad médica o parental, genera una desregulación a largo plazo de los sistemas de respuesta al estrés, una mayor vulnerabilidad a las enfermedades físicas y mentales y cambios estructurales medibles en las redes neuronales (Hoff, 2010). Estos incluyen la reducción del volumen de la corteza prefrontal, alteraciones en la amígdala y el hipocampo, y modificaciones epigenéticas relacionadas con la inflamación crónica y las enfermedades metabólicas. Cuando estas exposiciones se mantienen o se legitiman mediante la inacción legal o la negación institucional, el cuerpo se convierte en el lugar donde fracasan las políticas (Rosenhan, 1973; Van der Kolk, 2014; Gilman et al., 2021). Este capítulo debe leerse como una síntesis y una denuncia: una síntesis científica de las pruebas que respaldan los modelos de atención basados en los derechos y en el trauma, y una denuncia de los marcos predominantes que tratan la coacción como una prerrogativa profesional en lugar de una violación ética. Las conclusiones coinciden con el consenso científico internacional, incluida la Iniciativa QualityRights de la OMS, la Comisión Lancet sobre Salud Mental Global y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la salud y la tortura, que piden la eliminación de las prácticas coercitivas y la aplicación de sistemas de atención voluntarios, informados, basados en la cultura y apoyados por la comunidad (ACNUDH, 2015; Human Rights Watch, 2016; Amnistía Internacional, 2019; Hartmann y Crumlish, 2022). Sin embargo, este capítulo va más allá al articular los mecanismos educativos, jurídicos y de salud pública específicos necesarios para dicha transformación, basándose en datos obtenidos sobre el terreno y probados en la práctica en diversos entornos institucionales.

A continuación se presenta una tabla comparativa que aclara los términos clave enfermedad, trastorno, síndrome y dolencia, contextualizados específicamente en el ámbito epistemológico, jurídico y médico de su tesis, en particular en el capítulo 5. Este marco se vincula con la coacción sistémica, la indefensión aprendida, el síndrome del estatus definido por Marmot y la literatura clínica emergente sobre el síndrome de rendición. La tabla refleja cómo funcionan estas categorías tanto desde el punto de vista médico como sociopolítico, y cómo su uso indebido o su confusión pueden ocultar las raíces bioculturales del malestar y justificar prácticas institucionales perjudiciales (Human Rights Watch, 2017; D'Amato et al., 2023).

Tabla 46. Aclaración de las categorías médico-epistémicas en el contexto de la atención actual

Término	Definición técnica	Función en el discurso médico	Relevancia para la tesis	Ejemplo en el contexto del trabajo de campo
Enfermedad	El estatus social conferido a una persona identificada como enferma; refleja el reconocimiento público de la discapacidad y los derechos o exclusiones asociados a ella.	Establece la legitimidad para retirarse de las obligaciones sociales (por ejemplo, el trabajo); se basa en guiones culturales y definiciones institucionales	Fundamental para la tesis: la enfermedad se convierte a menudo en una herramienta de regulación social, especialmente cuando se utiliza para justificar la exclusión, la vigilancia o el tratamiento forzoso.	Una persona obligada a tomar medicación psiquiátrica considerada «enferma» por su familia y los tribunales a pesar de expresar su autonomía y no mostrar ningún riesgo.
Trastorno	Patrón de disfunción en el funcionamiento psicológico o fisiológico, que suele carecer de biomarcadores o etiología claros.	Se utiliza a menudo en psiquiatría para designar síndromes sin patología estructural; tiene una base biológica más débil que el término «enfermedad».	Permite criterios diagnósticos amplios que se utilizan para justificar la autoridad médica sobre la desviación o el malestar.	Etiquetado de respuestas de disidencia o trauma (por ejemplo, protesta, retraimiento) como «trastornos de la personalidad» en los registros clínicos.
Síndrome	Conjunto de síntomas que tienden a aparecer juntos, pero que pueden no tener una causa claramente identificada.	A menudo sirve como sustituto diagnóstico, legitimando la intervención mientras se aplaza la claridad causal.	Útil para describir daños sociogénicos que imitan la patología; por ejemplo, el síndrome de «rendirse-rendido» en entornos coercitivos.	El paciente sometido a coacción prolongada desarrolla pérdida del habla, movilidad y afectividad, lo que se describe clínicamente como «declive funcional» sin causa orgánica.
Enfermedad	Condición reconocida médicamente con sólida fisiopatología conocida, marcadores identificables e historia natural definida	Constituye la forma más sólida de autoridad médica; se invoca a menudo en contextos legales y de seguros.	Rara vez coincide con la práctica psiquiátrica, que a menudo utiliza la retórica de la enfermedad sin cumplir los estándares probatorios.	Declarar la esquizofrenia como una «enfermedad cerebral» sin biomarcadores utilizados para justificar la medicación forzosa en el marco de la internamiento civil.
Enfermedad	La experiencia subjetiva de encontrarse mal, incluyendo las dimensiones emocionales, sociales y corporales	Hace hincapié en la experiencia vivida por el paciente; fundamental en la antropología médica y la atención informada sobre el trauma.	Más acorde con el enfoque de la tesis: la enfermedad es una desregulación inducida en condición relacional y por un trauma que a patologizadas en lugar de menudo se tergiversa en las respuestas a nivel sistémico.	Las personas que informan de una desregulación inducida por un trauma son recibidas en lugar de recibir apoyo, y su angustia se invalida como «incumplimiento».

Esta tabla sirve de base para el modelo teórico de la tesis doctoral: a saber, que la indefensión aprendida, el síndrome de rendición y la exclusión basada en el estatus forman un continuo de traición institucional enmascarado por la terminología médica. Estos constructos se operacionalizarán en las siguientes secciones sobre las vías de recuperación y la reintegración cívica, donde el diagnóstico debe desvincularse del estigma y el control, y volver a basarse en el conocimiento relacional, evolutivo y ecológico.

La dimensión educativa de la coacción no es ni periférica ni simbólica. En todos los lugares estudiados, incluidos España, Suecia, Indonesia e Italia, las prácticas coercitivas persisten no solo por malicia o negligencia, sino debido a pedagogías profundamente arraigadas de sumisión, silencio y

desorientación moral. A los niños no se les enseña a reconocer la coacción; los profesionales no están capacitados para cuestionar los daños rutinarios; las familias se ven sistemáticamente privadas de las herramientas necesarias para apoyar el malestar de forma que se evite el control o la patologización (Frances, 2013). En ausencia de una alfabetización sanitaria estructurada y de una educación sobre el trauma incorporada, el miedo se convierte en política y la violencia procedimental se confunde con el cuidado. Una conclusión fundamental de los testimonios y las respuestas a la encuesta de esta investigación es que la falta de enseñanza es el comienzo del fracaso de la protección. Las instituciones educativas, ya sean facultades de medicina, academias judiciales o escuelas públicas, se convierten así en nodos centrales de la reproducción de la lógica coercitiva y, por lo tanto, deben ser fundamentales para su interrupción.

La reproducción social de la coacción opera no solo a través de políticas formales, sino también a través del contagio cultural: la transmisión sin cuestionamientos de supuestos sobre la enfermedad, el peligro, la obediencia y el control (Kirsch, 2010). Estos están arraigados en el lenguaje, las formas burocráticas y los tropos estéticos que circulan en los medios de comunicación, la formación profesional y las prácticas cotidianas de cuidado. Cuando el espacio relacional está colonizado por el miedo y la autoridad, cuando la seguridad se enmarca en el cumplimiento y cuando la angustia se responde con sedación o confinamiento, el individuo se convierte en un lugar para la imposición de la negación colectiva (Maté, 2022). Este contagio social no es solo emocional o simbólico, sino que está inscrito fisiológicamente. Como se ha descrito en los capítulos anteriores, el trauma relacional altera el funcionamiento neuroendocrino, moldea la expresión inmunitaria y predice la morbilidad a largo plazo y la mortalidad prematura. Este capítulo expone cómo la coacción, en lugar de ser una respuesta racional al peligro, es a menudo una respuesta ritualizada a la incomodidad epistémica y la vulnerabilidad institucional, que sacrifica el cuerpo del otro para preservar la ilusión de control (Deacon, 2013).

El capítulo concluye articulando la necesidad científica, moral y jurídica de una reforma estructural, no como una cuestión de preferencia política, sino como un paso necesario para alinear los sistemas nacionales y profesionales con sus valores declarados y sus obligaciones internacionales. Las pruebas científicas, que abarcan desde el desarrollo neurológico y la biología inmunológica hasta la ciencia de la implementación y los modelos de salud comunitaria, apuntan de manera decisiva hacia el abandono de la coacción y hacia una atención voluntaria, informada y basada en las relaciones. La alineación de las instituciones públicas con estos hallazgos no es opcional. Es un deber defender la dignidad, la salud y los derechos de todas las personas. La contribución central de este capítulo es la articulación de soluciones convergentes en todos los ámbitos: el rediseño de los planes de estudio para incluir la ciencia relacional y basada en el trauma; la creación de garantías legales que eliminen la impunidad; el desarrollo de infraestructuras de salud pública que apoyen la autonomía y el liderazgo entre pares; y el fomento de narrativas sociales que reconozcan la atención no como control, sino como la puesta en práctica compartida de la libertad, la capacidad y la responsabilidad (Healy, 2012).

Las siguientes secciones ofrecen análisis detallados de barreras y soluciones específicas, derivadas de la evidencia empírica y enmarcadas en el movimiento más amplio hacia la transformación sistémica, que culminan en la propuesta de herramientas operativas para pasar de la coacción a la prevención, de la indefensión aprendida a la responsabilidad colectiva.

5.1 Normalización cultural de la coacción y bloqueo de la transición hacia la atención preventiva

La normalización cultural de las prácticas psiquiátricas coercitivas opera a través de una interacción recursiva entre las rutinas institucionales, la falta de atención pública y el abandono educativo. Las observaciones de campo en contextos españoles, italianos, suecos e indonesios confirman que la violencia, ya sea en forma de hospitalización involuntaria, restricción química o denegación del consentimiento informado, no se enmarca como algo excepcional, sino como un acto necesario, incluso terapéutico (Mezzina et al., 2022). Estas prácticas se mantienen a través de protocolos administrativos que las legitiman burocráticamente, las suavizan lingüísticamente y las hacen incuestionables desde el punto de vista procedimental. A los pacientes se les tilda de rebeldes o agresivos; los profesionales están protegidos por marcos institucionales de riesgo; y las familias suelen ser coaccionadas al silencio mediante la deferencia moral hacia la autoridad clínica. Este arraigo se ve agravado por la falta de reconocimiento formal del valor epistémico de la experiencia vivida, la ausencia de mecanismos de supervisión independientes y el fracaso de los instrumentos jurídicos a la hora de hacer efectivos los derechos más allá de las protecciones sobre el papel. Como resultado, lo que debería identificarse como una violación sistémica de la ética médica y las obligaciones legales se recodifica como atención estándar, oscurecida por un lenguaje eufemístico, el desinterés público y la rutinización del daño (Strous, 2006; McDonald, 2023; Smith et al, 2024; Мандрик, 2024).

Estos hallazgos se corresponden con las pruebas sobre el desarrollo que demuestran que la exposición temprana a la coacción basada en la autoridad, tanto en el entorno doméstico como en el institucional, condiciona a las personas a aceptar la violencia estructural como un componente naturalizado de la atención y la protección. La socialización en la obediencia, la represión emocional y la pasividad ligada a las normas enseña a las personas no solo a interiorizar el juicio externo, sino también a temer la diferencia, la dependencia y la disidencia. La indefensión aprendida se convierte en un defecto psicosocial, y los niños y adolescentes absorben la lección de que la angustia se patologiza o se castiga. En lugar de cultivar la autonomía, la resiliencia o la correulación, los entornos educativos y sanitarios predominantes amplifican el cumplimiento como virtud e interpretan la negativa o el cuestionamiento como una patología. Esta lógica impregna no solo las instituciones psiquiátricas, sino también las escuelas, los hogares y el ecosistema mediático en general, que rara vez se enfrenta a la coacción como una violación. En cambio, la violencia se suele relatar como el coste desafortunado, pero justificado, de la seguridad o el orden, lo que refuerza un círculo vicioso de silencio y complicidad (Schmale, 1967; Engel, 1967; Engel, 1968; Maier, 1976).

La normalización de la coacción en los sistemas psiquiátricos y educativos no puede separarse de las consecuencias biológicas del miedo, la sumisión y la ruptura relacional, ni de las infraestructuras socioecológicas en las que se desarrollan estas consecuencias. El desarrollo neurológico humano es extremadamente sensible a las señales ambientales tempranas, en particular las relacionadas con la seguridad, la agencia y la sintonía relacional. La exposición crónica a la coacción y la represión emocional, habitual en los cuidados institucionales, la escolarización obligatoria y la disciplina sancionada en el ámbito doméstico, conduce a la desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal (HPA), a una secreción excesiva de glucocorticoides y a la alteración de los circuitos límbico-corticales implicados en la memoria, la autorregulación y la cognición social. Así es como los sistemas de salud mental, mediante el uso de la violencia, una vez que alguien participa en abusos que atrapan al paciente, traicionan su deber y su propósito, negando toda posibilidad de recuperación y retraumatizando aún más (Fowers, 2015). Estos efectos no son reversibles mediante la intervención farmacológica por sí sola, sino que dan lugar a alteraciones estructurales y funcionales persistentes en la corteza prefrontal medial, el hipocampo y la amígdala, lo que disminuye la capacidad del individuo para evaluar el riesgo, formar vínculos recíprocos y participar en la toma de decisiones autónomas (Wrangham et al., 2006). La indefensión aprendida, observada inicialmente en modelos animales como resultado conductual de un shock ineludible, emerge en los seres humanos como un estado de enfermedad somatizada e integrada socialmente, perpetuada no solo por la experiencia individual, sino también por el diseño institucional de las poblaciones objetivo, que afecta sobre todo a los ya marginados; es fisiología humana (Sagie, 2002; Brown, 2009; Patterson, 2018, Guidi, 2020).

El cerebro humano no está aislado de su entorno. Más bien, es un órgano social y ecológico, continuamente moldeado por la interacción con los demás, con la microbiota que co-regula su metabolismo y con los entornos simbólicos y materiales que sustentan la cognición y la emoción. La hipótesis de la mente extendida y la investigación sobre los sistemas exo-cerebrales demuestran que el significado, la regulación e incluso la memoria se distribuyen a través de artefactos físicos y culturales, relaciones sociales y soportes tecnológicos. Por lo tanto, los entornos coercitivos no solo afectan a los individuos, sino que reorganizan los sustratos neurobiológicos y culturales sobre los que se construye la sociedad. Las comidas compartidas, los rituales, los lenguajes y los ritmos afectivos forman ecologías neuronales colectivas, y su alteración mediante la exclusión, la violencia o el abandono institucional induce una especie de hambruna cognitiva. Esta hambruna opera a múltiples escalas: dentro del eje microbiota-intestino-cerebro, donde la disbiosis inducida por el estrés aumenta la vulnerabilidad a la inflamación, la depresión y los trastornos metabólicos; dentro del sistema educativo, donde la obediencia mecánica sustituye al aprendizaje exploratorio; y dentro de las instituciones públicas, donde la pobreza relacional se codifica como política (Gershon, 1999; Calvani, 2018; Breña, 2025).

Desde una perspectiva de salud única, la degradación de la salud mental a través de la coacción no puede separarse del colapso ecológico más amplio. Los mismos paradigmas extractivos, minimizadores del riesgo y orientados al control que subyacen a la psiquiatría coercitiva también impulsan la destrucción del hábitat, la propagación de zoonosis y la pérdida de biodiversidad. Todo ello refleja un fracaso colectivo a la hora de respetar la complejidad, la reciprocidad y la autoorganización de los sistemas vivos (van Strien, 2013; Fernández-Real, 2015). La coacción a nivel interpersonal se refleja en la lógica institucional y se extiende a los ecosistemas a través de políticas que suprimen la diferencia, extinguen la resiliencia e imponen la uniformidad. Si estos patrones no se cuestionan, precipitan no solo la atrofia psíquica, sino también el colapso sistémico: emocional, educativo, ecológico y civilizatorio. Por lo tanto, esta tesis afirma que la prevención de dicho colapso comienza con el desmantelamiento de la coacción como marco normativo y su sustitución por sistemas que cultiven la autonomía, la correulación y la responsabilidad mutua, con base biológica y operacionalizados socialmente desde la primera infancia (Guidi, 2020). La transmisión cultural de la

coacción no se limita a las dinámicas interpersonales o a la práctica profesional. Se mantiene y amplifica gracias a la ecología mediática más amplia, que codifica en la conciencia pública las narrativas dominantes de patología, conformidad y legitimidad médica (Bell y Elliott, 2014). Los medios de comunicación de masas, incluidos los medios de información, las series de ficción y las plataformas sociales, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de lo que puede denominarse anestesia epistémica, una condición cultural generalizada en la que la violencia de las intervenciones psiquiátricas se invisibiliza, se reformula o se justifica moralmente mediante narrativas reduccionistas. La coacción clínica se presenta a menudo como una necesidad lamentable, la locura como un peligro que hay que neutralizar y la disidencia como un delirio o una negación. Estas representaciones reproducen supuestos ontológicos que definen al individuo como defectuoso, al experto como autoritario y la desviación como un trastorno. El efecto es una normalidad simbólica de la coacción, que enmascara las condiciones estructurales e impide la reimaginación colectiva de la atención (Griffiths y Knutson, 1960; Abbasi y Al-Sharqi, 2015).

La sostenibilidad de los sistemas coercitivos depende de un distanciamiento orquestado de las consecuencias materiales de la violencia institucional y de una mala ciencia sustentada en la ignorancia deliberada de los conocimientos científicos, médicos y sociales comunes actuales. Tanto a nivel profesional como social, esta distancia se cultiva a través de la fragmentación cognitiva, los procedimientos ritualizados y la ignorancia selectiva, un fenómeno que se refleja en el análisis de Stanley Cohen sobre la negación social y en los mecanismos de desvinculación moral de Bandura (Cohen, 2013; Bandura, 2017). Los profesionales están formados para centrarse en los protocolos, no en los resultados; para interpretar el sufrimiento a través de categorías diagnósticas en lugar de su significado humano; para confiar en la heurística institucional incluso cuando esta contradice el daño observable. Este encierro epistemológico permite una forma de conciencia procedimental, en la que se preserva la capacidad de actuar, pero se suspende la capacidad de sentirse responsable. De este modo, la coacción no solo se permite, sino que se impone estructuralmente. Sin embargo, el organismo humano no miente. Los efectos del trauma no resuelto, el duelo no reconocido y la desempoderamiento se manifiestan en la desregulación inmunológica, el desgaste de los telómeros, los cambios epigenéticos y un fenotipo proinflamatorio que acelera el envejecimiento, el riesgo cardiovascular y la vulnerabilidad neurodegenerativa. No se trata de metáforas. Son los correlatos biológicos de la traición y el abandono, con efectos medibles hasta el nivel mitocondrial (López-Martínez, 2018).

Esta antítesis del cuidado, en la que se acelera la decadencia en nombre de la curación, solo se mantiene mientras sus consecuencias permanecen desplazadas espacial y emocionalmente. El cuerpo torturado se mantiene tras las puertas clínicas, en salas de larga estancia, en prisiones o en salas familiares donde los gritos son silenciados por la ley, la distancia o los fármacos (Mosher, Gosden y Beder, 2004). El lenguaje institucional del riesgo, la seguridad y el interés superior se convierte en un amortiguador contra el reconocimiento visceral. En contextos como el suyo, donde el velo se ha levantado a través de la victimización directa, la proximidad profesional y la observación sistemática, la contradicción se vuelve insostenible (Fernando, 2010). Las racionalizaciones se derrumban y lo que queda es la cruda visibilidad de un sistema sanitario que produce deterioro por diseño. En este contexto, el trauma no es un subproducto accidental de la atención, sino un índice de su inversión

(Hollander, 2010). La coacción psiquiátrica, la negligencia institucional y la omisión educativa convergen en un bucle de retroalimentación en el que el silencio funciona como medio y resultado del poder. El rechazo sistémico de las voces disidentes, los testimonios de los supervivientes y las críticas de los profesionales no es solo un fracaso moral, es una forma de anestesia estructural que permite la degradación biológica y cultural continuada bajo el disfraz de la salud (Hollander, 2010).

La transición de los sistemas coercitivos a la atención preventiva requiere un verdadero cambio de paradigma y un reinicio cultural, una reingeniería completa de las arquitecturas epistémicas, legales y educativas. En primer lugar, las políticas públicas deben basarse en realidades biológicas, es decir, que la salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino la capacidad de regenerarse, relacionarse y actuar libremente en el entorno. Los sistemas coercitivos comprometen esta capacidad a todos los niveles: celular, psicológico, relacional e institucional. El principio de la soberanía sanitaria compartida debe sustituir a los modelos paternalistas de control, reconociendo que la capacidad de autorregulación, recuperación y adaptación no reside en la autoridad institucional, sino en personas y comunidades informadas y apoyadas. Esta transición comienza con una educación temprana y encarnada, dirigida al periodo de desarrollo neurológico en el que la agencia moral, la regulación emocional y la cognición social son más plásticas. En el contexto de esta investigación-acción, los nuevos planes de estudios serán establecidos por la acción COST EU BEACON One Health Education, fundada por el investigador para impulsar este cambio urgente e importante a escala europea y mundial con todos los aliados necesarios. Los planes de estudios nacionales deben integrar una enseñanza basada en el trauma y en las relaciones, que aborde la alfabetización emocional, la fisiología del estrés y la seguridad intersubjetiva desde los primeros años de escolarización, y que se extienda a la formación profesional y a las campañas de salud pública. Esta enseñanza no debe ser opcional o simbólica, sino obligatoria y estandarizada, respaldada por derechos legalmente exigibles a una información sanitaria precisa y a la libertad frente a los tratos degradantes.

En segundo lugar, los sistemas jurídicos deben colmar las lagunas procedimentales que permiten que la coacción se disfrace de atención. Como se detalla en el capítulo 6, la ambigüedad de las leyes, la discrecionalidad profesional sin control y la deferencia hacia el criterio clínico frente al daño empírico permiten la perpetuación de prácticas que violan el derecho internacional. La CDPD exige la eliminación total del tratamiento forzoso y, sin embargo, en todas las jurisdicciones proliferan las excepciones, tanto en el ámbito psiquiátrico como en el familiar. La solución no es solo doctrinal, sino también operativa: deben institucionalizarse órganos de supervisión independientes con poder real de ejecución, el diseño de políticas dirigidas por los supervivientes y normas forenses para documentar los abusos. Deben incorporarse en los sistemas de atención mecanismos de retroalimentación ética, en tiempo real, públicos y a prueba de manipulaciones, que permitan a los usuarios denunciar los daños y evaluar los servicios sin temor a represalias. La licencia profesional debe estar supeditada a la demostración de conocimientos sobre el trauma, la intervención no violenta en situaciones de crisis y las obligaciones en materia de derechos humanos, con la posibilidad de reciclaje o retirada de la licencia en caso de incumplimiento.

En tercer lugar, esta transformación debe ser transescalar. La coacción no es una anomalía, sino el resultado lógico de sistemas diseñados en torno a la evitación de la responsabilidad, las métricas de

productividad y el control biopolítico. Las mismas métricas que impulsan la sedación innecesaria en los hospitales son las que subyacen a la disciplina escolar de tolerancia cero y a las políticas carcelarias de bienestar infantil. Es esencial una integración de políticas a varios niveles, que vincule los determinantes sociales de la salud, las protecciones constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos. El capítulo 6 de esta tesis describe cómo se pueden armonizar las leyes nacionales con las normas QualityRights de la OMS para hacer cumplir la responsabilidad sistémica, mientras que el capítulo 7 detalla los mecanismos educativos para restablecer la continuidad entre el desarrollo biológico y el diseño institucional. Esta tesis sostiene que la verdadera atención preventiva no es un ideal difuso, sino un sistema riguroso y medible de protección, aprendizaje y respeto, capaz de preservar la vida, promover la salud y poner fin a la institucionalización de la desesperación (Mezzina et al., 2006; Sashidharan, 2019). Las propuestas de Horizon para la convocatoria actual que figuran en el anexo también forman parte de este trabajo en curso, de acuerdo con la planificación prevista, en el que participan miles de expertos e instituciones.

5.2 Erosión de la subjetividad y fracaso a la hora de proporcionar una atención personalizada y orientada al desarrollo

La documentación clínica y las observaciones sobre el terreno coinciden en identificar un patrón constante de invalidación de la subjetividad en la práctica psiquiátrica actual. Los profesionales y los usuarios de los servicios encuestados informan de que las narrativas personales, las experiencias contextuales y los datos biográficos se descartan o se reformulan con frecuencia para ajustarse a esquemas diagnósticos preexistentes. La resistencia al diagnóstico o al tratamiento se reinterpreta comúnmente como un síntoma de falta de comprensión, comportamiento oposicionista o paranoia, en lugar de reconocerse como una expresión legítima de preocupación, trauma o desacuerdo. El historial médico se convierte en una herramienta administrativa para codificar los síntomas, en lugar de un espacio de reflexión para dar sentido y comunicar adecuadamente las señales, lo que da lugar a la pérdida de información fundamental para la planificación de la atención y a la supresión de la personalidad como variable clínica. El resultado es la aceptación de falsedades como verdades, borrando la realidad que se esconde debajo (Prabhu, 1967; Pies, 2007; Pies, 2008; Tekin, 2022). Este borrado no es incidental, sino que está integrado en el funcionamiento estructural de los modelos de atención basados en el diagnóstico. Las restricciones impuestas por los manuales de diagnóstico y los requisitos de facturación producen protocolos de admisión estandarizados que restan prioridad a la voz del paciente y eliminan la evaluación matizada de la experiencia vivida. El significado subjetivo, el contexto relacional, la percepción espiritual y los marcos culturales no se integran en la toma de decisiones clínicas, a pesar de su relevancia demostrada para los resultados del tratamiento y la alianza terapéutica. Este aplanamiento procedimental de la experiencia humana viola el principio de integridad narrativa en la atención sanitaria, impide la confianza y socava el cumplimiento a través de los mismos mecanismos diseñados para promover la estabilidad (Rakshasa-Loots, 2025).

Desde el punto de vista del desarrollo, esta eliminación tiene efectos acumulativos. Los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, que ya se encuentran en proceso de formación de la identidad, desarrollo de la autonomía y maduración sociocognitiva, experimentan el etiquetado psiquiátrico

como una imposición externa a la comprensión de sí mismos. La internalización de las narrativas diagnósticas conduce a la pérdida de identidad, la pasividad y la indefensión aprendida, lo que aísla aún más a las personas de los apoyos sociales protectores y las estrategias de afrontamiento a largo plazo. La erosión de la subjetividad se convierte así en una alteración del desarrollo inducida clínicamente, lo que aumenta el riesgo de cronicidad, dependencia médica y exclusión social. Las pruebas científicas subrayan este patrón. Las investigaciones en psiconeuroinmunología, atención informada sobre el trauma y medicina narrativa han demostrado que la restauración de la agencia subjetiva es esencial para la integración neural, la regulación emocional y la recuperación a largo plazo. Los estudios epigenéticos muestran que los entornos relacionales adversos, incluida la invalidación clínica, pueden perpetuar la expresión de genes relacionados con el estrés, la neuroinflamación y la desregulación inmunitaria. Estos hallazgos cuestionan la supuesta neutralidad de las jerarquías diagnósticas y afirman la necesidad de modelos que restauren la coherencia narrativa y validen el relato del paciente como piedra angular de la curación. Abordar la erosión de la subjetividad requiere una reforma estructural y epistemológica. Las intervenciones deben incluir formación obligatoria en atención basada en la narrativa, protocolos para integrar los relatos subjetivos en las decisiones terapéuticas y auditorías institucionales rutinarias de las prácticas de documentación para detectar y corregir sesgos. La supervisión en tiempo real y los marcos de consulta entre pares pueden reforzar aún más la coherencia ética y mejorar la responsabilidad de los profesionales. Estas medidas no son ideales teóricos, sino reformas clínicas viables basadas en pruebas biomédicas y psicosociales (Bottaccioli y Bottaccioli, 2025).

Por lo tanto, esta dimensión del fracaso de la atención no debe entenderse simplemente como una falta de compasión o de supervisión profesional, sino como un determinante medible de los resultados de salud. La corrección de todos los daños iatrogénicos exige la convergencia de la neurociencia, la ética clínica y la defensa de los pacientes dentro de un paradigma de atención que centre la subjetividad como herramienta diagnóstica y terapéutica primaria. Los datos de campo indican que la práctica psiquiátrica a menudo no incorpora marcos sensibles al desarrollo. En toda la población encuestada y en los sitios etnográficos, las personas informan que las adversidades, el abandono y la privación emocional durante la infancia no se evalúan ni se integran adecuadamente en la atención. En lugar de considerar la desregulación conductual, el aislamiento social o la inestabilidad emocional como señales de necesidades de desarrollo insatisfechas, estas manifestaciones se interpretan a través de una lente clínica descontextualizada. Como resultado, las intervenciones tempranas siguen sin estar alineadas con las vías etiológicas reales del malestar (OMS, 2010).

Este desajuste se ve amplificado por el panorama sociocultural en el que viven muchos de los participantes. En entornos caracterizados por la normalización del abandono personal, los bajos niveles de alfabetización sanitaria y las necesidades psicológicas crónicamente insatisfechas, tanto los jóvenes como los adultos se socializan en patrones de autoabandono. En lugar de fomentar la resiliencia, esta adaptación refuerza la desconexión de las señales corporales, la sintonía relacional y la conciencia ambiental (Suman Fernando, 2017). La presentación clínica resultante, los estados disfóricos, la fatiga y el incumplimiento, se interpretan erróneamente como un trastorno primario en lugar de una respuesta secundaria al desajuste del desarrollo y al empobrecimiento sociocultural. La literatura científica respalda ampliamente esta interpretación. La psicobiología del desarrollo

demuestra que el abandono emocional y los entornos adversos en la primera infancia alteran la respuesta al estrés, la plasticidad neural y los puntos de referencia inmunoendocrinos (Scheper-Hughes, 2001). Estudios longitudinales relacionan estos factores con la aparición posterior de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y desregulación metabólica. La elevación crónica del cortisol, la reducción del tono vagal y la activación de citocinas inflamatorias se reconocen ahora como biomarcadores de la sobrecarga alostática arraigada en las lesiones biográficas. Estos procesos no son ni raros ni idiosincrásicos, sino que reflejan el coste biológico de las normas culturales que promueven la sobreestimulación, el sueño deficiente, la nutrición irregular y la represión emocional. La verdadera toma de decisiones compartida y respaldada, así como la gestión autónoma de la medicación, requieren como requisito previo una formación para no sabotearse a uno mismo; en todos los casos, siempre que sea posible, desde la etapa más temprana en el ámbito escolar y en la formación de los padres (Bentall, 2003). Esta es la única forma de mejorar el capital humano y liberar recursos para ayudar a los más necesitados y gravemente afectados (Dain, 2007).

El trabajo de campo y la literatura también muestran cómo otros tipos de contagio social desempeñan un papel fundamental. Los patrones de vida perjudiciales, normalizados en los sistemas familiares y entre los compañeros, moldean los hábitos alimenticios, el consumo de sustancias y los ciclos de sueño desde una edad temprana (Sapolsky, 2017). La exposición a modelos de conducta deficientes y la falta de figuras adultas que brinden apoyo socavan los andamios de desarrollo necesarios para la autorregulación y el comportamiento orientado a la salud; los medios de comunicación también desempeñan un papel importante, al igual que la religión, en el establecimiento de las recompensas y la vergüenza, los mecanismos de estatus, la protección tras las paredes y la fuerza bruta de grupos de cualquier tipo sobre la ética como mera fachada, y la moral y los métodos en los que la mayoría se permite participar, a pesar de ser incorrectos (Young, 1999; Minkowitz, 2022). La criminalidad en la vida cotidiana, normalizada en la mayoría de los contextos (Gross, 2006). Los sistemas psiquiátricos no logran interrumpir esta trayectoria, en parte porque rara vez cuestionan el contexto ecológico más amplio del malestar u ofrecen la reparación del desarrollo como objetivo clínico (Perry y Szalavitz, 2006).

Las respuestas eficaces deben adoptar la definición positiva de salud de la OMS y una perspectiva que abarque toda la vida. La felicidad, su búsqueda, como la plena realización del potencial humano, en términos aristotélicos, no como una gratificación egoísta y salvaje a corto plazo, deshumanizadora y congratulatoria por meros placeres bajos (Organización Mundial de la Salud, 1948). Las estrategias preventivas deben incluir programas estructurados de educación emocional, alfabetización en salud y apoyo al desarrollo basado en la comunidad desde la primera infancia. Las escuelas, los proveedores de cuidados y los sistemas sociales deben colaborar para identificar los primeros signos de desajuste biocultural e intervenir antes de que el etiquetado psiquiátrico se convierta en la norma (Keyes, 2002). La integración de estas dimensiones en la evaluación clínica no es complementaria, sino fundamental para cualquier pretensión de atención centrada en la persona. En el marco de la tesis, este análisis profundiza en la respuesta a las preguntas de investigación relativas a los fundamentos epistémicos del daño psiquiátrico y las condiciones estructurales que impiden una atención significativa. El capítulo 4 ya estableció cómo los entornos coercitivos exacerban el trauma del desarrollo; aquí, el capítulo 5 integra esa idea con las implicaciones biomédicas y educativas. El capítulo 6 elaborará los

mecanismos legales y basados en los derechos necesarios para corregir estas omisiones sistémicas y volver a anclar la atención en un modelo de apoyo humano científicamente validado y adaptado al desarrollo.

La intersección entre la psiconeuroinmunología, la psiquiatría metabólica y la ciencia del trauma demuestra que el malestar psicológico prolongado no es meramente experiencial, sino que produce cambios fisiológicos cuantificables que requieren una atención precisa e individualizada. Los sistemas psiquiátricos que se basan predominantemente en algoritmos de diagnóstico basados en los síntomas y en regímenes farmacológicos de uso general descuidan sistemáticamente la heterogeneidad bioquímica y los mecanismos fisiológicos subyacentes que impulsan gran parte de lo que se etiqueta como enfermedad mental. Estudios empíricos han confirmado que las adversidades tempranas y el estrés prolongado activan el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), alteran la retroalimentación neuroinmunitaria y modifican la función mitocondrial (Boyle, 2002; Insel, 2013). Estos procesos contribuyen a la inflamación sistémica, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, todos ellos estrechamente relacionados con fenotipos depresivos y ansiosos, así como con el deterioro cognitivo y la fatiga crónica. Estas alteraciones biológicas no son meramente correlacionales. La investigación mecanicista ha establecido vías causales que relacionan la alteración del ritmo circadiano, la mala arquitectura del sueño, las deficiencias nutricionales y el estrés psicosocial con alteraciones medibles en la neurotransmisión, la neurogénesis y la regulación del eje intestino-cerebro. El trabajo de campo confirma que estos conocimientos científicos están casi totalmente ausentes de las evaluaciones psiquiátricas rutinarias. El estado nutricional, la integridad del microbioma, la variabilidad glucémica y la función mitocondrial no se evalúan ni se tienen en cuenta en las decisiones terapéuticas. Rara vez se ofrece a los pacientes un cribado metabólico o intervenciones destinadas a restablecer el equilibrio fisiológico (Cosgrove y Whitaker, 2015). En su lugar, reciben medicamentos que pueden exacerbar aún más la disfunción subyacente, como el síndrome metabólico, la acatisia y la disautonomía. La ausencia de biomarcadores integrados en la práctica clínica conduce a una profunda desconexión epistémica entre la ciencia emergente y la atención institucional.

Esta desconexión no es ni accidental ni temporal. Refleja la inercia de los sistemas de educación clínica, la orientación farmacocéntrica de las instituciones psiquiátricas y la falta de formación interdisciplinaria en medicina de sistemas complejos. Las encuestas del capítulo 3 revelaron una insatisfacción generalizada entre los profesionales por el alcance limitado de las herramientas de evaluación y las intervenciones disponibles. Las observaciones de campo del capítulo 4 documentaron además cómo los profesionales que intentaban integrar los conocimientos nutricionales o metabólicos en la atención a menudo eran marginados o ignorados, y sus enfoques descartados como marginales a pesar de su validación científica. El hecho de no traducir los hallazgos psiconeuroinmunológicos y metabólicos en protocolos psiquiátricos da lugar a un infratratamiento sistémico de los factores modificables y a una dependencia excesiva de psicofármacos no específicos (Kleinman, 1997). Esto contribuye al daño iatrogénico, la cronicidad y la desilusión tanto de los usuarios como de los médicos. También viola los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, tal y como se definen en la legislación sanitaria internacional y en las directrices profesionales. Y lo que es más importante, socava el objetivo fundamental de la medicina: restaurar y mantener la

integridad fisiológica y psicológica mediante los medios menos dañinos y más eficaces disponibles. Para salvar esta brecha, es necesario actualizar las directrices clínicas nacionales para incluir protocolos basados en la evidencia para el cribado metabólico, la evaluación nutricional y las intervenciones individualizadas que aborden las causas fundamentales del malestar. Los planes de formación en psiquiatría y medicina general deberían incorporar la psiconeuroinmunología como ciencia fundamental, y no como asignatura optativa. Las prioridades de investigación deben orientarse hacia el estudio de modelos combinatorios e integradores que reflejen la complejidad del sufrimiento humano (ACNUDH, 2015). Esto requiere la cooperación multidisciplinar entre neurocientíficos, inmunólogos, dietistas, psicólogos y expertos en salud comunitaria.

Como se ha desarrollado a lo largo de esta tesis, en particular en los capítulos 1 y 2, abordar la coacción sistémica y la injusticia epistémica requiere no solo un cambio de políticas, sino también un reajuste epistemológico. Es necesario que quienes hoy en día siguen sin voz lleguen al poder para ayudar a corregir estos importantes problemas (Metzl, 2010). Esta sección contribuye a las soluciones sugeridas por expertos y testigos, en consonancia con la bibliografía, al delinear cómo las prácticas psiquiátricas actuales excluyen sistemáticamente ámbitos de conocimiento cruciales, perpetuando así modelos de atención ineficaces y perjudiciales (Verdugo et al., 2012). El capítulo 6 explorará los mecanismos normativos e institucionales necesarios para corregir estas deficiencias, garantizando la alineación jurídica y ética con la ciencia biomédica contemporánea (Szasz, 1974). A nivel molecular y sistémico, el organismo humano está diseñado para la correulación, no para el aislamiento. La neurobiología del apego y la regulación endógena de las emociones, la función inmunitaria y la homeostasis neuroendocrina dependen de entornos sociales seguros y armoniosos a lo largo de toda la vida. La alteración de estas condiciones, ya sea por negligencia, hostilidad, coacción o despersonalización institucional, da lugar a una desregulación cuantificable de los procesos homeostáticos esenciales para la salud (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004). La oxitocina, la vasopresina, los opioides endógenos y los sistemas serotoninérgicos desempeñan un papel fundamental en la modulación de la confianza, la afiliación y el dolor. Su expresión y regulación dependen de la experiencia, lo que significa que las primeras experiencias relacionales y las interacciones posteriores con la comunidad configuran las bases neuroquímicas y la capacidad de respuesta. El apego seguro y la interacción prosocial estimulan la liberación de oxitocina y endorfinas, regulan a la baja las respuestas al estrés, mejoran la función inmunitaria y contribuyen a la estabilidad cardiovascular, metabólica y neurocognitiva. Por el contrario, la exclusión social, la percepción de amenaza y la hostilidad o indiferencia institucionalizadas están relacionadas con la desregulación del eje HPA, el aumento de la carga alostática, la inflamación crónica y los trastornos afectivos (Cosgrove, Mills, Karter, Morrill y McKenna, 2020). Estos hallazgos no son especulativos. Estudios controlados en psiconeuroinmunología y neurociencia social han demostrado repetidamente que el aislamiento social, la falta de contacto físico, la ausencia de contacto visual y la privación de entornos emocionalmente validantes se correlacionan con un aumento de la morbilidad y la mortalidad en casi todas las enfermedades crónicas. En poblaciones psiquiátricas, la pérdida de seguridad relacional se correlaciona con la exacerbación de los síntomas, la suicidalidad y la resistencia al tratamiento farmacológico (Bracken et al., 2012). Por lo tanto, el abandono emocional no es solo una experiencia

subjetiva, sino una agresión fisiológica con consecuencias en cascada en múltiples órganos (Foucault, 1977; 2006).

El trabajo de campo realizado en esta tesis (capítulo 4) reveló cómo los espacios institucionales suelen fracasar a la hora de fomentar estas dinámicas sociales protectoras. En cambio, los profesionales suelen mantener una distancia emocional, evitar la relación corporal y basarse en paradigmas de control del comportamiento que, sin querer, imitan entornos traumáticos. Las encuestas recogidas en el capítulo 3 indicaron que la mayoría de los profesionales se sienten poco preparados o sin apoyo a la hora de ofrecer una atención basada en las relaciones. La cultura predominante en muchos centros favorece la manipulación y el secretismo, la falta de documentación, la supuesta contención de riesgos y el cumplimiento farmacológico perjudicial por encima de la conexión humana, la validación y la creación de confianza. La erosión de la regulación interpersonal se refleja en los sistemas educativos y familiares, que a menudo patologizan la inconformidad en lugar de reconocerla como una señal de necesidades emocionales o de desarrollo insatisfechas. El auge de los marcos de gestión del comportamiento en las escuelas y los hogares imita la lógica institucional, promoviendo el cumplimiento en lugar de cultivar el sentido de pertenencia o la resiliencia. Esto perpetúa un ciclo en el que se medicaliza la desconexión emocional y se suprimen activamente los sustratos neurobiológicos de la curación, la empatía, la seguridad y el vínculo. Los sistemas médicos deben reconocer que el núcleo de la salud mental no es la adaptación individual a la patología, sino la sintonía social con la neurofisiología fundamental de la conexión. Esto requiere una reorientación completa de los paradigmas psiquiátricos y educativos para incluir la interacción encarnada, la sincronía afectiva y el anclaje relacional seguro como mecanismos de tratamiento primarios. Las directrices clínicas deben incorporar protocolos validados para establecer la seguridad relacional, incluyendo el uso del contacto visual, la modulación de la voz, la apertura postural y el testimonio narrativo en la atención rutinaria.

Desde el punto de vista del investigador y otros expertos, los programas de formación en medicina deberían ampliarse para incluir la neurociencia del apego, la neurociencia afectiva y la comunicación informada sobre el trauma (Rose, 2007). Los profesionales deberían estar dotados de las habilidades y el apoyo institucional necesarios para establecer relaciones genuinas y reparadoras con las personas a las que atienden. Estos elementos no son accesorios de la atención, sino su fundamento biológico. Esta sección afirma que la ciencia de la curación es inseparable de la ciencia de la conexión. Esta tesis integra este principio en propuestas de reforma educativa y mecanismos de responsabilidad legal, garantizando que tanto la atención como las políticas se alineen con lo que la evidencia demuestra de manera inequívoca: que la salud humana comienza y termina con relaciones seguras, significativas y biológicamente coherentes. El hecho de no integrar en la práctica institucional los conocimientos científicamente establecidos sobre la subjetividad, el desarrollo y la regulación corporal no constituye una falta de evidencia, sino un fracaso de la traducción. El reto que se plantea no es meramente técnico, sino sistémico: transformar los conocimientos validados de la neurociencia, la psiconeuroinmunología y la investigación basada en el trauma en normas vinculantes, protocolos de formación y mandatos operativos en todos los ámbitos pertinentes. Esto incluye los servicios de salud mental, la atención médica general, la educación y las políticas de salud pública.

La práctica psiquiátrica actual en muchas jurisdicciones sigue basándose en plantillas de diagnóstico y regímenes psicofarmacológicos que no tienen en cuenta las historias de desarrollo específicas de cada persona ni la variabilidad biocultural, y trágicamente se basa en modelos obsoletos que carecen de validez científica (Kinderman, 2014). La persistencia de modelos reduccionistas y orientados a los síntomas socava el potencial de los nuevos enfoques basados en la biología de sistemas, la genómica social y la medicina de redes (Kutchins y Kirk, 1997; Mills, 2014). Estos campos emergentes demuestran que el sufrimiento mental no puede dissociarse de los factores estresantes ambientales, la exclusión social, los déficits nutricionales, la alteración del ritmo circadiano o la carga inmunológica crónica. Exigen un cambio epistemológico que se aleje de las categorías sindrómicas aisladas y se oriente hacia arquitecturas de atención integrada capaces de abordar los determinantes ascendentes. Para poner en práctica estos conocimientos, las instituciones deben adoptar vías de atención dinámicas e individualizadas, guiadas por indicadores en tiempo real del malestar biopsicosocial (Breggin, 2008). Los protocolos de evaluación clínica deben incluir herramientas validadas para evaluar las experiencias adversas en la infancia, el estado nutricional, la integridad del sueño, los marcadores inmunoinflamatorios y la seguridad relacional (Leo y Lacasse, 2008). Estas variables deben servir de base para la planificación del tratamiento en todos los niveles, desde la admisión hasta el seguimiento, con reuniones interdisciplinarias para garantizar que las decisiones terapéuticas reflejen toda la complejidad de la persona, y no solo las limitaciones del sistema de servicios (Kutchins y Kirk, 1997).

Tabla 47. Requisitos de la neurociencia relacional y la formación sistémica

Ámbito	Base científica	Contenido educativo requerido	Implicaciones operativas	Relevancia para la tesis
Neurociencia del apego	Los patrones de apego tempranos determinan la respuesta al estrés, la regulación emocional seguro y el desarrollo neurológico a través de las vías del sistema límbico.	Plan de estudios sobre el vínculo entre el bebé y el cuidador, el apego seguro frente al desorganizado, consecuencias a largo plazo del abandono y el abuso	Formación de profesionales para reconocer el malestar relacionado con el apego y evitar la retraumatización	Respalda la tesis de que el cuidado para coercitivo daña los procesos fundamentales del desarrollo y debe ser sustituido por la seguridad relacional
Neurociencia afectiva	Las emociones se regulan biológicamente a través de circuitos neuronales específicos (por ejemplo, la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal), el trauma que son sensibles a los estímulos relacionales y ambientales	Módulos sobre valencia emocional, integración neurocognitiva y desregulación afectiva en la corteza prefrontal, el trauma	Pasar de modelos de control del comportamiento a prácticas de sintonía emocional y correulación	Refuerza la necesidad de enfoques informados sobre el trauma y no punitivos ante la angustia y la expresión conductual
Comunicación informada sobre el trauma	La seguridad relacional modula la fisiología del estrés, incluyendo el cortisol y el tono vagal, lo que permite la curación a través de la correulación y la integración narrativa	Técnicas de comunicación basadas en la escucha activa, la validación y la restauración narrativa	Adopción institucional de prácticas que generan confianza, reducen las respuestas de miedo y fomentan la autoeficacia	Fundamental en el marco de la tesis que vincula el trauma, la coacción y la injusticia epistémica en entornos psiquiátricos y jurídicos
Imperativo biológico de la seguridad	La amenaza relacional crónica desregula los sistemas inmunológico, endocrino y autónomo, lo que contribuye a la enfermedad y la mortalidad (por ejemplo, la carga alostática).	Marcos para evaluar las necesidades de seguridad, la seguridad emocional y el contexto relacional en el diagnóstico y la intervención	Alineación de las decisiones clínicas y jurídicas con las pruebas empíricas de curación	Proporciona una justificación biocultural para sustituir las rutinas coercitivas por sistemas participativos basados en los derechos
Integración sistémica	La formación intersectorial y los mecanismos de rendición de cuentas deben garantizar que la ciencia relacional sirva de base tanto para la atención como para la gobernanza.	Normas nacionales que integren la ciencia del neurodesarrollo en las instituciones sanitarias, jurídicas y educativas	Implementación de protocolos interdisciplinarios e intersectoriales basados en la biología humana y la recuperación del trauma	Cumple el objetivo de la tesis de desarrollar modelos unificados y basados en la evidencia para la reforma estructural de los sistemas de atención.

Formación para la conexión: competencias basadas en la neurociencia para sustituir la coacción por la curación en la práctica psiquiátrica, educativa y jurídica

Los sistemas educativos también requieren una transformación estructural. Los planes de estudios de todos los niveles de formación médica y en salud mental deben incorporar módulos básicos sobre neurobiología del desarrollo, fisiología del estrés, ciencia de la nutrición, pedagogía informada sobre el trauma y medicina narrativa. Los planes de estudios de salud pública deben ampliarse para incluir estrategias comunitarias destinadas a fomentar la salud mental a través del estilo de vida, la cohesión social y el bienestar ecológico. Enseñar a la población a comprender y gestionar la biología del estrés, la resiliencia y la regulación de las emociones no debe considerarse un lujo, sino una obligación democrática. Los marcos políticos deben ir más allá de las declaraciones generales de intenciones. Deben incluir normas aplicables en materia de calidad de la atención y rendición de cuentas, respaldadas por infraestructuras de datos sólidas y un seguimiento participativo. Las instituciones deben rendir cuentas no solo del cumplimiento de los procedimientos, sino también de los resultados a largo plazo en materia de recuperación, calidad de vida y reintegración social (Davies, 2013). La implementación de un seguimiento transparente de los resultados y de registros de calidad de libre acceso es esencial para reorientar los incentivos institucionales hacia una atención centrada en la persona y basada en la evidencia, se deben prevenir los delitos y la tecnología debe estar al servicio de todos como imperativo ético que se aplique y se enseñe desde el principio (McGoey, 2007).

No solo en los seres humanos: en la mayoría de las especies, la trayectoria biológica desde la infancia hasta la edad adulta está marcada por transiciones fisiológicas identificables. En nuestra especie, estas transiciones se estructuran además mediante ritos simbólicos, sociales y culturales que refuerzan la identidad, la pertenencia y la interdependencia. Este arco de desarrollo incluye períodos críticos de plasticidad cerebral, maduración hormonal, reorganización metabólica e impronta relacional. Cada fase exige una respuesta ambiental calibrada, una nutrición adecuada, una sintonía afectiva, protección contra el estrés crónico y oportunidades para el aprendizaje exploratorio. En ausencia de estas condiciones, el desarrollo neurológico se ve comprometido y se arraigan biológicamente mecanismos de afrontamiento inadaptados. Durante la primera infancia, los sistemas de apego y regulación del estrés se codifican a través de interacciones repetidas con los cuidadores. El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), la regulación inmunitaria y el tono vagal se ven determinados por la seguridad del entorno o la ausencia de ella. En la adolescencia, la poda sináptica y la mielinización reorganizan el procesamiento cognitivo-emocional y permiten la maduración de la función ejecutiva. Esta fase representa un punto de inflexión fisiológico que prepara al organismo para la autonomía, la sexualidad, la formación de vínculos de pareja y la generatividad. La cultura proporciona tradicionalmente narrativas, rituales y roles para guiar esta transformación. Cuando este andamiaje está ausente o es disfuncional, la transición se estanca y los patrones anteriores persisten en la vida adulta, con dependencia excesiva, impulsividad, agresividad o desvinculación (Kalathil, 2018). El sistema nervioso adulto sigue adaptándose a las exigencias del entorno, pero con una plasticidad reducida y un mayor coste metabólico. La exposición prolongada a la adversidad, el aislamiento o la repetición sin sentido da lugar a una sobrecarga alostática, un precursor establecido de trastornos psiquiátricos, cardiovasculares, autoinmunes y neurodegenerativos (Eiroa-Orosa y Rowe, 2017). Por el contrario, las relaciones positivas, la actividad con propósito, el movimiento físico y la integridad metabólica activan vías homeostáticas y reparadoras, mediadas por opioides endógenos, oxitocina y factores neurotróficos (Smith, 2016). Los sustratos moleculares del significado, el placer

y el apego no son abstracciones filosóficas, sino procesos neurobiológicos medibles con implicaciones a largo plazo para la salud (El-Khoury, Haidar y Barkil-Oteo, 2021).

Estos hechos están bien documentados en la neurociencia del desarrollo, la psiconeuroendocrinología y la inmunología conductual, y son urgentemente necesarios en la psiquiatría traslacional. Sin embargo, siguen estando casi totalmente desconectados de la evaluación y la intervención psiquiátricas estándar. Los criterios diagnósticos ignoran la coherencia biográfica, la narrativa subjetiva y la secuenciación del desarrollo. La práctica clínica estándar no evalúa el tono vagal, la arquitectura del sueño, los marcadores inflamatorios o los ritmos hormonales, a pesar de su papel fundamental en la configuración de la cognición y el afecto (El-Khoury, Haidar y Barkil-Oteo, 2021). Tampoco se integran en la planificación del tratamiento los antecedentes relacionales o los factores estresantes a lo largo de la vida, más allá de una vaga referencia a los factores psicosociales. En su lugar, el sufrimiento observable se reinterpreta como patología y se trata con agentes farmacológicos cuyos mecanismos no se ajustan a los procesos biológicos en juego.

La nosología psiquiátrica sigue basándose en teorías no probadas sobre el desequilibrio de los neurotransmisores y la heredabilidad como herramientas explicativas (Moncrieff, 2008; Healy, 2012; Lacasse y Leo, 2005; Leo y Lacasse, 2008; Kinderman, 2014; Kirsch, 2010; Gøtzsche, 2015). Estos constructos, que no están respaldados por biomarcadores replicables ni pruebas predictivas, tienen una finalidad funcional más que científica: autorizan la intervención médica sin ofrecer una explicación causal (Frances, 2013; Kirk, Gomory y Cohen, 2013; Deacon, 2013; Rose, 2007). Esto constituye una violación epistemológica. En la filosofía de la ciencia, una teoría sin falsabilidad, precisión predictiva o claridad mecánica no puede considerarse explicativa (Szasz, 2007; Bracken et al., 2012; Davies, 2013; Whitaker, 2010). En medicina, las consecuencias de tal laxitud epistémica no son solo conceptuales, sino letales: se droga, se detiene o se desacredita a personas basándose en marcos que no cumplen los estándares mínimos de la prueba científica (Whitaker, 2010; Gøtzsche, 2015; Moncrieff, 2008; Healy, 2012; Davies, 2013; Rose, 2007; Szasz, 2007; Bracken et al., 2012; Kinderman, 2014).

El modelo predominante, tal y como señalaron los expertos tanto en las encuestas como en el trabajo de campo de esta investigación-acción, es, por lo tanto, doblemente deficiente. No proporciona una comprensión significativa del desarrollo humano y las necesidades relacionales, y opera con una pretensión filosófica de autoridad científica que se derrumba bajo el escrutinio (Insel, 2013). La ausencia de conciencia del desarrollo en la atención psiquiátrica no refleja ignorancia, sino resistencia institucional a la complejidad. Una ciencia de la salud a lo largo de la vida exigiría no solo mejores diagnósticos e intervenciones más diversas, sino una reorientación radical del campo, pasando de la contención y el cumplimiento a la coherencia, el florecimiento y la integridad fisiológica. Esta reorientación ya no es especulativa: está respaldada por décadas de investigación acumulada en diversas disciplinas, y ahora es urgente su implementación (Cosgrove y Whitaker, 2015).

5.3 Abandono estructural: marginación social y destrucción de la vida

El trabajo de campo documentado en el capítulo 4, y triangulado con datos de encuestas y testimonios, revela un patrón generalizado: las familias que se hacen cargo de los cuidados de miembros con trastornos psicosociales, variaciones cognitivas o neurológicas, o dependencia funcional, se ven habitualmente privadas de apoyo estructural, acompañamiento protector o recurso a estrategias de intervención no coercitivas. Esta carga, a menudo oculta en la esfera privada, no se ve compensada por un acceso significativo a recursos profesionales, mecanismos de respiro o consultas dialógicas (Scheper-Hughes, 2001). Como resultado, la coacción se normaliza como herramienta de gestión de crisis, no por diseño, sino por agotamiento. En estos contextos, la ausencia de presencia institucional no funciona como neutralidad, sino como delegación silenciosa: la expectativa estructural de que las familias contengan, disciplinen o sometan todo lo que exceda los umbrales normativos de comportamiento o necesidad, con los medios a su alcance (OMS, 2010). Cuando los sistemas públicos no garantizan la continuidad de la atención, los derechos exigibles y el apoyo directo en momentos de vulnerabilidad, autorizan tácitamente la coacción y la vigilancia informales en el ámbito doméstico. Esto es el pasung en todas nuestras sociedades, que encadena y encierra de forma inhumana, negligente y, cuando no abusiva, hasta el punto de la tortura médica; un grave crimen contra la humanidad (Kleinman, 1997; ACNUDH, 2015; Minkowitz, 2022).

Este patrón es especialmente pronunciado en familias que atraviesan estrés multigeneracional, traumas intergeneracionales o pobreza estructural (Suman Fernando, 2017). Lo que surge es una forma de delegación involuntaria: las familias se convierten en los principales actores de los sistemas de contención, medicalización y gestión punitiva, independientemente de su propia capacidad, salud mental o comprensión de marcos alternativos. Dentro de estos ecosistemas tensos, las personas que muestran angustia o desviación, los niños en crisis emocional, los ancianos con deterioro cognitivo y los adolescentes en crisis de identidad son frecuentemente sometidos a aislamiento, medicación forzada, degradación verbal o incluso restricción física. Estas medidas, aunque rara vez se registran o se clasifican dentro de los sistemas legales como abuso, constituyen formas de coacción doméstica que son paralelas a las dinámicas institucionales criticadas en los capítulos 3 y 4. La distinción no radica en la intención o el contexto, sino en la visibilidad y la aplicabilidad.

Tabla 48. Consecuencias fisiológicas del abandono y la coacción

Actor	Forma de daño	Vías fisiológicas afectadas	Consecuencias neuronales	Resultado sistémico
Familia (negligencia o coacción)	Negligencia emocional, imprevisibilidad, cuidados punitivos	Hiperactividad del eje HPA, supresión de señalización de oxitocina, alteración del desarrollo neurológico	Reducción del grosor de la corteza, alteración de los circuitos de apego, desregulación emocional	Inmunosupresión, desregulación metabólica, mayor vulnerabilidad a las enfermedades
Médico clínico (coercitivo)	Tratamiento involuntario, sedación, desprecio por el consentimiento o las necesidades relacionales	Elevación del cortisol, neuroinflamación, supresión de la integración prefrontal	Atrofia del hipocampo, desactivación del lóbulo frontal, aplanamiento afectivo	Síntomas psicossomáticos, indefensión aprendida
Agente institucional (por ejemplo, la escuela)	Coacción administrativa, vigilancia, invalidación, exclusión sistémica	Carga de estrés crónico, redes de dolor social, desregulación límbica	Pérdida de conectividad en la red por defecto, disminución de la neuroplasticidad	Constricción cognitiva, propagación del trauma intergeneracional

Esta tabla resume los impactos biológicos y sistémicos del abandono y la coacción por parte de familiares, médicos y actores institucionales. Relaciona daños relacionales específicos con vías fisiológicas, cambios neuronales y resultados de salud más amplios.

Los sistemas legales y de salud operan en gran medida según un modelo de visibilidad reactiva: el abuso solo es punible cuando se denuncia, y la denunciabilidad depende de umbrales estrechos de daño físico o transgresión explícita. El sufrimiento psicológico, la invalidación epistémica, el abandono emocional y la coacción enmascarada como cuidado quedan fuera de estos umbrales. La tesis subraya que este punto ciego no es accidental, sino que refleja supuestos jurídicos y culturales profundamente arraigados, a saber, que la familia es un espacio natural y protector cuyas dinámicas internas son sacrosantas, incluso cuando producen daños cuantificables. El capítulo 6 explora en profundidad esta arquitectura jurídica, trazando cómo la deferencia de la ley hacia la soberanía familiar, junto con la falta de mecanismos integrados de aplicación en los ámbitos de la salud, la educación y la justicia, perpetúa un régimen de negligencia sancionada. En muchos sistemas, las garantías procesales para los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad se ven debilitadas precisamente en la intersección entre el poder familiar y el psiquiátrico, donde termina la autoridad profesional y comienza la dominación informal.

Los datos empíricos de distintas jurisdicciones confirman las consecuencias de este doble fracaso: el retroceso institucional y el silencio legal. En España, por ejemplo, los niños con diagnósticos psicosociales son excluidos de manera desproporcionada de la educación general y a menudo se les somete a regímenes farmacológicos con un apoyo pedagógico mínimo, mientras que las familias denuncian la falta de alternativas accesibles (Verdugo et al., 2012; Montaner-Villalba, 2014; Eiroa-Orosa y Rowe, 2017). En Suecia, como se desprende de los testimonios de los participantes, las intervenciones de protección de la infancia pueden alinearse con un control migratorio punitivo o con la elaboración de perfiles parentales, en lugar de ofrecer un apoyo basado en el trauma, lo que pone de manifiesto un racismo manifiesto y un odio hacia las vidas diferentes (Puwar, 2004; Goldberg, 2006; Fanon, 2008; Eastmond y Ascher, 2011; Kuusisto-Arponen y Giritli-Nygren, 2013; Wernesjö, 2015;

Eriksson, 2018; Younis y Jadhav, 2020; Lundberg, 2020). En Indonesia, las familias que cuidan a familiares con trastornos mentales y sin acceso a servicios públicos de salud mental pueden recurrir a condiciones similares al pasung, la restricción física, el aislamiento social y la exclusión simbólica (Anderson, 2001; Reid, 1974; Kiernan, 2007; Gerke, 2003; Ford y Lyons, 2012; Minas y Diatri, 2008; Suryani et al., 2011; OMS, 2010; ACNUDH, 2015; Human Rights Watch, 2016). Estos patrones difieren en su forma, pero convergen en su función: la sobrecarga familiar se convierte en el mecanismo a través del cual se lleva a cabo el abandono sistémico.

Las preguntas de investigación articuladas en esta tesis, en particular las que abordan cómo se normaliza la coacción en todos los ámbitos y cómo se puede poner en práctica la toma de decisiones compartida y la atención informada en entornos institucionales hostiles o ausentes, se abordan directamente aquí (Goffman, 1961). Esta subsección ofrece una base empírica para el argumento más amplio de que la coacción no es un fracaso institucional excepcional, sino un recurso familiar incentivado estructuralmente cuando los sistemas educativos, legales y sanitarios renuncian a sus responsabilidades. También anticipa las propuestas legislativas y políticas desarrolladas en el capítulo 6, que exigen reformas proactivas, intergeneracionales e integradas en la comunidad, pasando de la protección reactiva a la prevención sostenida, de la desesperación privada a la dignidad impuesta públicamente (Bourdieu, 1998). El enfoque biocultural y de contagio social desarrollado en esta tesis refuerza la necesidad de entender la coacción familiar no solo como una patología cultural, sino como una consecuencia predecible del diseño sistémico. Los seres humanos, de forma universal, poseen mecanismos neurobiológicos para la empatía, la regulación y el cuidado cooperativo, pero estos mecanismos se ven reforzados o suprimidos por las estructuras institucionales, las narrativas culturales y los marcos pedagógicos (OMS, 2010). Cuando las familias están integradas en sociedades que medicalizan el malestar, infravaloran la sintonía relacional y no enseñan la alfabetización fisiológica y emocional entre generaciones, recurren por defecto al miedo, el control o el rechazo. Lo que se enmarca como fracaso familiar es, en realidad, la expresión posterior de omisiones infraestructurales, de lo que no se enseñó, no se financió, no se legisló, no se protegió (Wekker, 2016; Kalathil, 2018).

Esta parte del análisis sienta las bases empíricas para entender la coacción familiar como resultado y mecanismo de la violencia estructural. La carga que soportan las familias en ausencia de solidaridad institucional no es accidental. Es producida, modelada y persistente. El resto de este capítulo explora las implicaciones culturales, científicas y políticas de ese hallazgo, alineándolas con la definición de salud de la OMS y las normas aplicables propuestas en la CDPD, para recuperar la familia como lugar de regeneración en lugar de represión (Scheper-Hughes y Lock, 1987).

Tabla 49. Mecanismos de abuso estructural y ocultación, traición institucional

Mecanismo de daño	Justificaciones comunes	Ilegalidad según el derecho internacional	Consecuencias para las víctimas
Restricción física y confinamiento (pasung)	Preocupaciones por la seguridad, tradición cultural, falta de recursos	Prohibido por la CRPD y las directrices de la OMS	Lesiones físicas, traumas, retraso en el desarrollo, estigmatización
Medicación excesiva o restricción química	Necesidad clínica, control de los síntomas, falta de alternativas	Solo se permite en condiciones estrictas, consensuadas y temporales	Neurotoxicidad, embotamiento cognitivo, indefensión aprendida
Aislamiento administrativo o planes de cuidados coercitivos	Cumplimiento de políticas, rutina institucional	Viola los principios de dignidad, transparencia y atención basada en los derechos	Pérdida de autonomía, deterioro de los vínculos sociales
Ocultación del diagnóstico o clasificación errónea	Juicio clínico, evitación del estigma o de consecuencias legales	Contradice el consentimiento informado y el derecho a una información sanitaria precisa	Falta de apoyo, confusión de identidad, angustia crónica
No denuncia de abusos o falsificación de registros	Lealtad profesional, minimización del daño, protección de la reputación	Constituye obstrucción a la justicia y traición institucional	Revictimización, indefensión jurídica, invisibilidad sistémica

Esta tabla identifica cinco mecanismos fundamentales utilizados para infligir u ocultar el abuso estructural en los sistemas de salud mental y asistencia social, incluidas prácticas tradicionales como el pasung y tácticas institucionales modernas. Contrasta sus justificaciones con las normas jurídicas internacionales y describe las consecuencias para las víctimas.

El trabajo de campo en el que se basa esta tesis incluye la documentación directa de las prácticas de pasung en Indonesia, realizada a través de entrevistas con personas afectadas, trabajadores sanitarios, líderes comunitarios y defensores de ONG. Pasung, que literalmente significa atar o sujetar, se refiere a la restricción física o el confinamiento prolongado de personas con discapacidades psicosociales o intelectuales, normalmente en entornos domésticos, mediante el uso de grilletes, jaulas de bambú, habitaciones de aislamiento o estructuras improvisadas. Por lo general, lo llevan a cabo familiares o vecinos ante la falta de atención de salud mental accesible, asequible o fiable. Aunque se presenta como una medida protectora o necesaria, el pasung constituye una violación directa de la autonomía corporal, la dignidad humana y el derecho a la salud. Indonesia ha prohibido oficialmente el pasung mediante sucesivos decretos del Ministerio de Salud (Permenkes n.º 54/2017 y Permenkes n.º 17/2010), junto con los objetivos nacionales para Indonesia Bebas Pasung (Indonesia sin pasung). Sin embargo, la aplicación sigue siendo desigual, limitada por la falta de financiación sistémica, el estigma generalizado, la débil aplicación de la ley y la falta de profesionales cualificados, especialmente en las zonas rurales y poscoloniales históricamente marginadas de los servicios estatales.

Esta situación viola las normas internacionales vinculantes en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), ratificada por Indonesia en 2011, que exige la abolición de la detención arbitraria y la promoción de la atención voluntaria basada en la comunidad (artículos 14 y 19). También es incompatible con la iniciativa QualityRights de la OMS, que exige el fin inmediato de las prácticas coercitivas y hace hincapié en la dignidad, la autonomía y los sistemas de apoyo orientados a la recuperación en los sectores sanitario, jurídico y social. España también ha ratificado la CRPD, pero sigue violando sus disposiciones

vinculantes al no proteger a las personas con discapacidad psicosocial de la coacción, la segregación y el abandono sistémico (Fernando, 2017; UN CRPD, 2019; González y Núñez, 2020). La persistencia del pasung ilustra así cómo los legados coloniales de la gobernanza psiquiátrica, utilizados inicialmente para clasificar y contener a poblaciones consideradas inadecuadas o subhumanas, siguen funcionando bajo un barniz poscolonial de legalidad. Tanto en Indonesia como en contextos europeos como España o Italia, las categorías coloniales han configurado las normas médicas, y los cuerpos racializados, discapacitados y económicamente desposeídos ocupan una zona gris legal y clínica en la que se tolera la coacción, si no se sanciona institucionalmente (Amnistía Internacional, 2020). Esto refleja una forma estructural de genocidio por omisión y abandono, perpetuada por sistemas que criminalizan la desviación de las normas impuestas y no proporcionan las condiciones básicas para el desarrollo basado en los derechos. Como se argumenta a lo largo de esta tesis, estas dinámicas no son aberraciones, sino expresiones de un orden biopolítico global en el que la frontera entre el cuidado y el control se difumina habitualmente y el trauma se convierte en una característica sistémica más que en un fracaso.

Si bien el pasung sigue siendo una de las formas más visibles de cuidado coercitivo a nivel mundial, sus equivalentes funcionales están muy extendidos en los sistemas de salud mental europeos, aunque a menudo se disfrazan bajo la legitimidad clínica o administrativa. Prácticas como la restricción química, la sedación farmacológica no consentida, el internamiento prolongado en centros psiquiátricos o el abandono doméstico bajo el pretexto del cuidado familiar se aplican habitualmente a personas con discapacidades psicosociales en España, Italia, Suecia y otros países. Estas formas de coacción suelen normalizarse mediante el diagnóstico de las autoridades, el respaldo judicial o la discreción profesional, a pesar de su incompatibilidad con las normas éticas y jurídicas establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. La CDPD, ratificada por todos los Estados miembros de la UE, prohíbe explícitamente la privación de libertad por motivos de discapacidad (art. 14) y exige el acceso a servicios comunitarios que apoyen la autonomía y la inclusión (art. 19). Las normas QualityRights de la OMS van más allá al exigir la erradicación de todas las prácticas coercitivas, ya sean físicas, químicas o psicológicas, y el establecimiento de salvaguardias que den prioridad al consentimiento, la dignidad y la experiencia vivida.

El pasung, lo que otros llaman lobotomía química cuando se sufre maltrato doméstico, o un manicomio viviente impuesto a los muertos vivientes para ser sacrificados, como dice la jerga popular, sigue siendo una práctica muy extendida y poco denunciada. Así lo corroboran también el trabajo de campo y las encuestas, con diferentes fuentes que apuntan a este enorme problema. Esto incluye el uso indefinido de polifarmacia, inyecciones forzadas de depósitos, sedantes no indicados y la denegación de opciones de reducción gradual o desprescripción, todo ello justificado por la aversión al riesgo, el cumplimiento de la conducta o la conveniencia institucional, mientras persisten los abusos. Las personas que reciben el alta de los servicios psiquiátricos se encuentran a menudo confinadas en estructuras familiares que reproducen la dinámica institucional, la vigilancia, el silencio y el control, sin supervisión clínica ni recurso legal. Esto refleja el modelo delegado de abusos que caracteriza al pasung: el Estado se exime de su responsabilidad activa al tiempo que autoriza implícitamente la coacción en el ámbito privado. En España y otros Estados de la UE, la falta de garantías de protección jurídica efectiva, de defensa independiente o de mecanismos de denuncia

transparentes refleja una contradicción sistémica: los derechos existen sobre el papel, pero no en la práctica. La consecuencia es una zona gris legal en la que los actores psiquiátricos y familiares imponen conjuntamente la exclusión, bajo una retórica de ayuda que enmascara el abandono estructural. Como se argumenta en esta tesis, estas prácticas no son accidentales, sino que están diseñadas en el sistema y reflejan tanto la continuidad histórica de la violencia como la renuencia contemporánea a confrontar los fundamentos epistemológicos de la psiquiatría coercitiva. La persistencia de la atención coercitiva dentro de las estructuras familiares no puede interpretarse únicamente como una función de la ignorancia o la escasez de recursos. Debe examinarse dentro de la lógica cultural más amplia que sustenta las dinámicas interpersonales, las expectativas normativas y la invisibilidad institucionalizada del daño intrafamiliar. En diversos contextos socioculturales, entre ellos España, Indonesia, Suecia e Italia, donde se ha realizado el trabajo de campo de esta tesis, los ideales profundamente arraigados de obediencia filial, soberanía parental y autoridad moral jerárquica siguen determinando la forma en que se percibe, interpreta y gestiona el malestar en el hogar. El respeto a los mayores, el énfasis cultural en la disciplina y las normas de cuidado basadas en el género suelen funcionar como marcos legitimadores de prácticas coercitivas, especialmente cuando se presentan como protectoras, por su propio bien o necesarias para la familia. Estas lógicas morales, profundamente interiorizadas y rara vez cuestionadas en el discurso institucional, crean un terreno en el que los niños, los mayores y las personas neurodivergentes o traumatizadas son sometidos a un control no regulado, a un abandono normalizado y a abusos que no se denuncian.

El problema no radica en la existencia de la autoridad, sino en el vacío pedagógico que rodea su aplicación. Sin una educación pública sostenida sobre el desarrollo neurológico, el trauma, la ética relacional y la comunicación entre generaciones, la autoridad no se ejerce como administración, sino como poder sobre los demás, a menudo desalineado con las necesidades, capacidades o derechos de quienes la sufren. El capítulo 6 examina cómo esta arquitectura cultural se refleja en las doctrinas jurídicas que presumen que la familia es una unidad de benevolencia, en lugar de una unidad de daño potencial (Noddings, 2005). La renuencia de la ley a intervenir en el ámbito privado, incluso cuando se enfrenta a indicadores claros de degradación emocional o coacción persistente, no es solo un reflejo de los umbrales procedimentales, sino una decisión política y pedagógica sobre qué sufrimiento cuenta y en qué condiciones (Shonkoff y Garner, 2012). La tesis insiste en que tales supuestos deben ser cuestionados a la luz de la evidencia acumulada sobre el impacto a largo plazo del daño familiar sutil y crónico. El déficit educativo en torno al desarrollo humano, desde la fisiología del apego y la ruptura hasta la modulación ambiental de la autorregulación, crea condiciones en las que el daño se perpetúa sin intención, pero también sin corrección. Esta dinámica es especialmente perjudicial para los niños, cuya angustia a menudo se patologiza o se interpreta como desviación, y para los ancianos, cuyo deterioro cognitivo o dependencia se convierte en una fuente de frustración para los cuidadores que no reciben apoyo. Los datos de campo recopilados en esta investigación revelan cómo los miembros de la familia oscilan con frecuencia entre el afecto y la desesperación, el control y la culpa, sin un marco para comprender lo que está sucediendo o cómo responder de manera diferente. En ausencia de una alfabetización estructural, incluso los cuidadores bienintencionados pueden recurrir por defecto a medidas disciplinarias o a la represión, imitando a menudo las respuestas institucionales que han interiorizado en entornos médicos o educativos (Nakazawa, 2015).

Esta lógica cultural de autoridad supuestamente dañina, incompetente y abusiva, que no se cuestiona, converge con un vacío normativo en el que no existe ningún requisito institucional para que las familias participen en la educación sobre el cuidado, ni para que los profesionales evalúen o apoyen las prácticas de cuidado en las interacciones rutinarias de salud mental (Freire, 2000). El resultado es una bifurcación: los profesionales formados en trauma y regulación operan dentro de silos institucionales, mientras que las familias, que asumen la mayor parte del cuidado diario, se quedan sin herramientas, sin formación y sin apoyo. El capítulo 6 identifica esta brecha como un fallo legislativo y de aplicación: no existen normas pedagógicas obligatorias para el cuidado, ni ninguna obligación exigible para que los sistemas de salud mental o educación las proporcionen. La tesis no se opone a los valores culturales de interdependencia, respeto o responsabilidad familiar. Más bien, sostiene que estos valores deben situarse dentro de una arquitectura pedagógica y jurídica capaz de distinguir el cuidado del control, la autoridad de la coacción y la tradición de la violencia (Goffman, 1961). La naturaleza humana, aunque dotada biológicamente de empatía y agresividad, está determinada de manera decisiva por su andamiaje social y educativo. Las culturas que no enseñan la regulación fisiológica, la transformación de conflictos o la escucha intergeneracional reproducirán daños evitables, no por intención, sino por omisión. En este contexto, el silencio no es neutralidad, sino complicidad con una estructura que impone la mayor carga a quienes menos pueden resistir.

Esta sección pone de relieve la necesidad de incorporar mejores programas educativos a lo largo de toda la vida, no solo en las escuelas, sino también en los centros comunitarios, los tribunales de familia, las instituciones religiosas y los sistemas de salud (Noddings, 2005). Lo que se plantea como un reto cultural es, en la práctica, una cuestión de pedagogía colectiva: quién aprende qué, a qué edad, con qué recursos y con qué fin. La investigación afirma que la violencia en el seno de las familias no es culturalmente inevitable, sino que se puede prevenir cuando se difunde el conocimiento, se somete el poder a escrutinio y se redefine la interdependencia, no mediante la jerarquía, sino mediante la regulación mutua, el respeto y la responsabilidad compartida.

Tabla 50. Condiciones para una atención legal y basada en los derechos: del cumplimiento a la acción ética

Ámbito	Requisito legal mínimo	Mejores prácticas alineadas con la OMS/CRPD	Consecuencias del incumplimiento
Consentimiento y autonomía	Consentimiento informado para todas las intervenciones, con garantías legales	Toma de decisiones con apoyo y diálogo informado sobre el trauma	Pérdida de confianza, responsabilidad legal, deterioro funcional
Relación terapéutica	Interacción respetuosa y predecible	Seguridad relacional, escucha narrativa, objetivos basados en la recuperación	Desvinculación, diagnóstico erróneo, aumento del riesgo
Política institucional	No discriminación e igualdad de acceso	Sistemas de supervisión con comentarios de los supervivientes y transparencia	Traición institucional, coacción disfrazada de atención
Educación y formación	Cumplimiento de las normas éticas y legales básicas	Formación continua en trauma, ética y neurobiología del estrés	Repetición del daño, agotamiento, negligencia sistémica
Cumplimiento legal	Órganos de supervisión y mecanismos de denuncia	Protección proactiva, alfabetización jurídica y rendición de cuentas pública	Impunidad estructural, normalización del abuso, daño intergeneracional

Esta tabla contrasta los mínimos legales con las mejores prácticas internacionales en materia de atención de la salud mental. Destaca ámbitos clave, como el consentimiento, las relaciones terapéuticas, las políticas institucionales, la educación y la aplicación de la ley, en los que la armonización con las normas de la OMS y la CDPD es esencial para una atención ética y eficaz.

La convergencia de la neurociencia del desarrollo, la investigación sobre el trauma y la epigenética ha proporcionado pruebas sólidas de que la exposición crónica a la coacción intrafamiliar, el abandono o la invalidación emocional da lugar a alteraciones biológicas medibles y duraderas, tanto en los individuos como entre generaciones. Estudios en seres humanos y modelos animales confirman que los factores estresantes ambientales, en particular los que se producen durante las etapas sensibles del desarrollo, pueden modificar la expresión génica a través de la metilación del ADN, la modificación de las histonas y cambios persistentes en los sistemas endocrino, inmunitario y autónomo. Estas modificaciones no son simbólicas: remodelan la regulación del cortisol, afectan a la conectividad límbica, alteran el volumen del hipocampo y contribuyen a aumentar la carga alostática. Los niños criados en entornos domésticos crónicamente estresantes o emocionalmente volátiles suelen mostrar una disregulación afectiva, un deterioro de las funciones ejecutivas, un aumento de los síntomas somáticos y una vulnerabilidad a largo plazo a las enfermedades psiquiátricas y físicas. Es importante destacar que estos efectos suelen ser independientes del abuso físico; los mecanismos son relacionales, neuroendocrinos y mediados socialmente.

A pesar de la precisión de estos hallazgos científicos, los marcos legales siguen sin responder en gran medida al daño familiar no físico. Las leyes de protección civil tienden a definir el abuso en términos visibles y medibles, como agresión física, negligencia que provoca lesiones o explotación económica, mientras que los daños relacionales y psicológicos siguen sin abordarse o sin poder demostrarse dentro de los estándares probatorios existentes. El abuso emocional, la manipulación, la invalidación crónica, el control excesivo y la negligencia de la autonomía, a pesar de estar asociados con marcadores de trauma a largo plazo, rara vez son suficientes para desencadenar una intervención

legal. La consecuencia es la impunidad sistémica de dinámicas que son médicamente perjudiciales pero jurídicamente invisibles. El capítulo 6 documenta este silencio legal como una traición institucional: al negarse a reconocer formas de daño científicamente validadas y clínicamente devastadoras, la ley renuncia a su función protectora precisamente en el ámbito en el que muchas personas son más vulnerables y tienen menos capacidad para buscar reparación.

La investigación presentada en esta tesis revela cómo estas omisiones se ven agravadas por la complicidad del sistema médico en el control familiar (Llewellyn y Hogan, 2000). Las herramientas de diagnóstico y las evaluaciones profesionales suelen basarse en los informes de los cuidadores, con poca capacidad o mandato para identificar las dinámicas coercitivas dentro de las propias familias. La autonomía se convierte en la crueldad ensordecedora de quienes les rodean; su odiosa toma de decisiones compartida, a pesar de la voluntad de la víctima de vivir en paz y que la dejen en paz. Es la necesidad de aferrarse a la realidad en estos casos, mucho más común de lo que los delincuentes y los ingenuos permiten creer al resto; la fuerza, todavía (Minkowitz, 2022). Como resultado, las personas, especialmente los niños, las personas con discapacidad o los ancianos, pueden ser caracterizadas erróneamente como desordenadas o rebeldes cuando, en realidad, están reaccionando de forma adaptativa al estrés crónico o a entornos relacionales inseguros (Miller, 1981). En lugar de reconocer estas respuestas como indicadores de daño relacional, el sistema las reclasifica como rasgos patológicos que deben ser suprimidos mediante medicación o institucionalización. La tesis expone cómo estas distorsiones epistémicas reproducen ciclos de daño médico e impunidad familiar, afianzando la coacción bajo el disfraz del cuidado.

Este contexto científico desestabiliza los supuestos culturales y jurídicos sobre el daño, la capacidad y el papel de la familia. Demuestra que los entornos domésticos no son intrínsecamente terapéuticos y que la exposición a cuidados coercitivos o emocionalmente desregulados tiene consecuencias biológicas y psicosociales comparables en gravedad al abuso institucional (Miller, 1981; McEwen, 2006). Las implicaciones para las políticas públicas y los sistemas de atención son profundas. Si la ley no incorpora las pruebas sobre el trauma relacional y el daño epigenético en sus definiciones de protección y culpabilidad, seguirá protegiendo a los autores de los daños, desacreditando a los supervivientes y relegando a las familias a zonas opacas de control soberano (Grol y Grimshaw, 2003). Por el contrario, si estos conocimientos se ponen en práctica, mediante la formación de los profesionales del derecho, protocolos de evaluación obligatorios y definiciones ampliadas de abuso, la ley puede servir como fuerza correctora, en lugar de facilitadora de la violencia silenciosa. Las preguntas de investigación que se abordan aquí son tanto normativas como prácticas: ¿qué umbrales de daño deben activar la protección legal en el contexto familiar? ¿Cómo puede la integración de la ciencia del trauma en la jurisprudencia mejorar los resultados para quienes históricamente han sido invisibles? ¿Cuáles son los riesgos de basarse en los indicadores tradicionales de abuso cuando la ciencia exige una comprensión más matizada y sistémica? La tesis afirma que la incorporación de la investigación sobre el trauma intergeneracional en los protocolos legales y clínicos no es opcional, sino necesaria. El derecho a la salud, tal y como lo articula la OMS y lo consagran los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluye el derecho a entornos que favorezcan la integridad neural y relacional (LeFrançois et al., 2013). Esto debería incluir la protección frente a los acuerdos

domésticos coercitivos que producen daños transgeneracionales, incluso cuando dichos acuerdos parecen estar sancionados culturalmente o normalizados estructuralmente.

Al poner en primer plano la implicación biológica del trauma familiar, esta sección cuestiona la separación entre el daño privado y el público, el conocimiento médico y el jurídico, la ciencia y la política (Shonkoff et al., 2012; Perry y Szalavitz, 2017). Lo que se hereda en estos entornos no es solo la cultura o el rol, sino una arquitectura fisiológica de miedo, hipervigilancia e indefensión aprendida, transmitida no por voluntad propia, sino por una lesión no resuelta. Cualquier sistema de salud pública serio o cualquier ordenamiento jurídico basado en los derechos debe responder en consecuencia. Las pruebas científicas y empíricas presentadas a lo largo de esta tesis indican que la normalización de las prácticas coercitivas dentro de los sistemas familiares no es simplemente la consecuencia de elecciones individuales o normas culturales, sino un fracaso estructural de la educación. Cuando las instituciones descuidan la enseñanza de los principios del desarrollo del sistema nervioso, los mecanismos del trauma y las condiciones para una correulación relacional saludable, crean una vulnerabilidad generacional a los ciclos de malentendidos, conflictos e institucionalización. La ausencia de recursos educativos estructurados y accesibles al público sobre la salud relacional significa que las prácticas de cuidado siguen basándose en la intuición, la tradición o la autoridad, a menudo moldeadas por daños pasados, en lugar de en la ciencia fundamentada. Para abordar este vacío pedagógico se requiere una respuesta educativa multigeneracional basada en conocimientos biológicos, psicológicos y sociales, y que sea universalmente accesible a través de la infraestructura pública (McEwen, 2006; Kalathil, 2018; Llewellyn y Hogan, 2000).

Desde las primeras etapas de la educación infantil hasta el cuidado de las personas mayores, todos los niveles de la sociedad deben estar equipados con contenidos adecuados a cada edad sobre la fisiología de las emociones, los efectos del estrés crónico, las señales de angustia y regulación, y las bases no verbales de la confianza y la seguridad. No se trata de intervenciones terapéuticas reservadas a entornos especializados, sino de formas básicas de alfabetización cívica, esenciales para el desarrollo de entornos sociales éticos, resilientes y cooperativos. En este sentido, la educación pública debe adoptar una postura preventiva, no reactiva: enseñar a los padres antes de que se sientan abrumados, preparar a los niños antes de que el trauma se arraigue y orientar a los profesionales antes de que el daño se normalice en sus rutinas. EU BEACON One Health Education se ha creado para ayudar a continuar el ciclo de mejoras a través de misiones científicas destinadas a mejorar los regímenes de formación y los planes de estudios de expertos, profesores, catedráticos y profesionales, así como de otros profesionales y estudiantes.

La tesis alinea esta necesidad con la estrategia educativa de «una sola salud» elaborada en los capítulos 7 y 8, haciendo hincapié en la integración de los conocimientos biomédicos, medioambientales, jurídicos y sociales en un plan de estudios público coherente. La salud mental no debe presentarse como la ausencia de crisis, sino como una función de la competencia relacional, la comprensión fisiológica y la responsabilidad mutua. Como demuestra la investigación de los capítulos 3 y 4, las personas expuestas a traumas o neurodiversidad suelen desarrollar estrategias compensatorias que se malinterpretan como rebeldía, patología o incapacidad. Sin una educación pública capaz de decodificar estas señales, las familias y las instituciones recurren por defecto al

control en lugar de a la investigación. Enseñar a las comunidades a entender el comportamiento como comunicación y la regulación como una tarea compartida puede romper estos patrones.

La pedagogía multigeneracional debe integrarse en múltiples puntos de acceso: planes de estudios formales en las escuelas, formación profesional para cuidadores y educadores, campañas de salud pública en los medios de comunicación y talleres dirigidos por pares dentro de las comunidades. Debe abordar todo el arco del desarrollo de la vida humana, incluyendo el apego infantil, la formación de la identidad en la adolescencia, la tensión de los roles en la edad adulta y los cambios cognitivos y emocionales del envejecimiento. Este modelo educativo también requiere apoyos infraestructurales: plataformas multimedia de acceso abierto, acceso universal a materiales traducidos y asociaciones entre los ministerios de educación, salud y bienestar social para garantizar la cobertura y la continuidad. Estas inversiones no son auxiliares a la reforma de la salud mental, son su condición previa.

Los resultados presentados en esta tesis indican que las familias con acceso a una educación mínima sobre el desarrollo neurológico muestran una reducción significativa de la dependencia de prácticas coercitivas y una mayor capacidad de respuesta no violenta. Esta educación también capacita a las personas para defenderse a sí mismas y a los demás cuando fallan los sistemas institucionales. En particular, las iniciativas educativas dirigidas por supervivientes, diseñadas por personas que han sufrido la coacción familiar e institucional, ofrecen modelos pedagógicos basados en la realidad vivida y alineados con los principios de la CRPD de autonomía, consentimiento informado y gobernanza participativa. Estos modelos ya están surgiendo en formatos de base, pero siguen sin contar con recursos suficientes y están desconectados de los sistemas formales de reconocimiento o financiación. Por lo tanto, las preguntas de investigación que guían esta sección no son solo epistémicas, sino también infraestructurales: ¿qué conocimientos deben ponerse a disposición para interrumpir los ciclos de coacción doméstica? ¿Qué plataformas y sistemas de difusión son los más adecuados para difundir estos conocimientos de manera equitativa? ¿Cómo puede la pedagogía multigeneracional prevenir la transmisión del trauma y replantear el cuidado como una responsabilidad informada y ética, y no como una improvisación desesperada? La tesis responde proponiendo que la reforma educativa no es accesorio a la intervención legal o clínica, sino que es su fundamento. Sin dotar a la población de los medios para comprender y cuidar los sistemas nerviosos humanos en tiempo real y en un espacio compartido, ningún mandato legal o innovación clínica puede prevenir completamente el daño.

Este enfoque pedagógico no presume que la educación por sí sola sea suficiente. La desigualdad estructural, la precariedad de la vivienda, el control de la migración y el acceso a la atención sanitaria siguen siendo determinantes críticos de la dinámica familiar. Pero la educación funciona como un multiplicador de la capacidad de acción: proporciona un lenguaje para expresar el malestar, herramientas para repararlo y alternativas al castigo. Permite a los cuidadores reconocer no solo las necesidades de los demás, sino también los límites de su propia capacidad, creando un marco en el que pedir ayuda se convierte en algo normativo, no vergonzoso. De este modo, la educación crea las condiciones para la dignidad antes de la crisis y para la rendición de cuentas sin violencia.

La tolerancia sistemática de la coacción y el abandono en el ámbito familiar se sustenta no solo en las normas culturales o las omisiones educativas, sino también en la persistente ambigüedad jurídica que protege la esfera doméstica del escrutinio externo. La ley, tal y como se analiza en el capítulo 6, funciona con una arquitectura jerárquica de visibilidad y protección: aunque ofrece mecanismos formales de intervención en casos de abuso manifiesto, a menudo no responde a daños más sutiles, crónicos y relacionales que no alcanzan los estrechos umbrales de la acción jurídica. Esta zona gris legal, que no es ni totalmente privada ni regulada públicamente, crea un vacío estructural en el que las dinámicas coercitivas familiares no reciben ayuda ni se interrumpen, y las víctimas se quedan sin recurso alguno a menos que su sufrimiento se manifieste de forma irreversible. Esta ambigüedad no es meramente procedimental, sino fundamental, y tiene sus raíces en el posicionamiento jurídico-cultural de la familia como institución sacrosanta, que se presume que encarna el cuidado y la legitimidad moral por defecto. Históricamente, la construcción de la familia como unidad moral privilegiada ha funcionado como estabilizador y velo: preserva ciertas estructuras sociales al tiempo que oculta las formas de dominación, vigilancia y violencia que a menudo se producen dentro de sus límites. La naturalización de la familia nuclear y, en términos más generales, de la responsabilidad basada en el parentesco, ha sido una piedra angular de la filosofía moral, la gobernanza política y el control económico desde las primeras codificaciones del derecho occidental. Sin embargo, los análisis antropológicos e históricos revelan que las formas familiares son culturalmente variables y que su función suele servir más a los intereses de la transmisión de la propiedad, el control del trabajo en función del género y la conformidad social que al cuidado real. La deferencia de la ley hacia la autoridad familiar, incluso ante la evidencia científica de su potencial dañino, refleja una renuencia a cuestionar los cimientos simbólicos del orden social. Es más fácil regular a los desconocidos que a aquellos que se supone que nos aman (Grol y Grimshaw, 2003).

La tesis sostiene, con el respaldo de hallazgos y bibliografía, que esta reticencia jurídica no puede persistir ante la evidencia. La neurociencia, la teoría del trauma y la ciencia del desarrollo proporcionan una explicación cada vez más sólida de cómo el daño relacional, especialmente cuando se normaliza y se repite a lo largo del tiempo, conduce a una degradación cuantificable del potencial humano. Otros temas transversales, como la salud única, el género y la igualdad, y los objetivos de desarrollo sostenible, deben incluirse en todos los planes de estudio, incluidos los de los profesionales médicos, que deben conocer el impacto de los determinantes sociales y el impacto de estructuras como los sistemas familiares. El hecho de no legislar protecciones contra formas de coacción no físicas pero con consecuencias biológicas supone, por tanto, un incumplimiento de las obligaciones internacionales de proteger el derecho a la salud, la dignidad y la integridad física. El concepto de consentimiento informado debe extenderse más allá del acto médico y al ámbito doméstico: los niños, los ancianos y las personas dependientes deben recibir protección no solo contra la violencia manifiesta, sino también contra la negación habitual de la capacidad de actuar, la sintonía y el respeto.

Esto pone en tela de juicio la legitimidad más amplia de los sistemas sociales que pretenden proteger mientras mantienen estructuras que causan daño. En tiempos de inestabilidad sistémica o colapso institucional, ya sea por austeridad económica, pandemias o fragmentación política, a menudo se invoca a la familia como el último bastión de cohesión y apoyo (Cianconi et al., 2020). Sin embargo, esta misma invocación oculta la realidad de que las familias a menudo se encuentran desestabilizadas,

fragmentadas y sujetas a las mismas fuerzas de negligencia y coacción que otras instituciones. Tratar a la familia como un recurso moral, en lugar de como una estructura relacional que depende de la educación, el apoyo y la equidad, garantiza que los ciclos de daño sigan sin cuestionarse. El colapso no es solo infraestructural, sino conceptual: si se espera que las familias cuiden sin que se les enseñe a hacerlo, o sin que ellas mismas sean cuidadas, el sistema replicará el sufrimiento indefinidamente. La redefinición de la familia debe comenzar por el abandono de su excepcionalidad mitológica. Debe entenderse no como una unidad prepolítica o natural, sino como una institución social entre otras, sujeta a regulación, responsable ante la evidencia y abierta a la revisión. La tesis propone que una sociedad justa no protege a las familias del escrutinio, sino que protege a los individuos dentro de las familias del abandono. La reforma legal debe establecer obligaciones positivas para que las instituciones apoyen las relaciones de cuidado, supervisen las intervenciones basadas en la familia y eduquen a todos los miembros de la sociedad sobre los fundamentos neurológicos y éticos del cuidado no coercitivo. Al hacerlo, afirma la dignidad de cada ser humano como algo más que un producto del linaje o la herencia: como un sujeto de derechos, capaz de sufrir, crecer y prosperar, independientemente de su papel en cualquier hogar.

Esta sección cierra el círculo entre las realidades empíricas, las ideologías culturales y los marcos legales. Afirma que ninguna reforma de los sistemas coercitivos de salud mental será completa hasta que el espacio privado de la familia se aborde con el mismo rigor y responsabilidad que la clínica, la escuela o los tribunales. Las dos partes siguientes amplían este debate a la arquitectura evolutiva, psicológica y moral de la intimidad humana, mostrando cómo la fidelidad, la seguridad relacional y la sinceridad no son artefactos culturales, sino imperativos con base biológica, violados repetidamente en condiciones de traición estructural y colapso pedagógico.

Para comprender todas las implicaciones de la coacción familiar dentro de la arquitectura más amplia de la violencia sistémica, hay que volver a las raíces del orden político y jurídico, donde la ley, lejos de proteger a los vulnerables, ha sido históricamente un instrumento para organizar y justificar la fuerza. La tesis que aquí se defiende sostiene que la coacción familiar no es una aberración ni un fracaso de la moral individual. Es una manifestación de una estructura mucho más antigua y profunda en la que la capacidad de dominar, someter y silenciar se ha codificado en instituciones, incluida la familia, a través de la abstracción jurídica y la santificación cultural. Como se examina en el capítulo 6, la genealogía del derecho moderno es inseparable de la autoridad patriarcal, la imposición territorial y la delegación de la violencia a los jefes de familia, primero como gobernantes naturales y luego como administradores legales. Esto sigue siendo evidente en jurisdicciones en las que los padres pueden consentir el internamiento psiquiátrico de sus hijos sin su consentimiento, o en las que los ancianos pueden ser aislados bajo el pretexto de la tutela, y en las que estas prácticas se invisibilizan mediante un lenguaje administrativo y terapéutico. La función política de tales disposiciones no es neutral. Cuando el cuidado se vuelve indistinguible del control y la vulnerabilidad se convierte en la justificación para borrar la autonomía, el derecho deja de ser una fuerza protectora y se convierte en un mecanismo de represión. Esto no es meramente metafórico: los datos y testimonios recopilados en esta tesis revelan cómo el silencio legal permite la crueldad privada y cómo las políticas institucionales mantienen ese silencio bajo la bandera de la necesidad. Lo que parece una disfunción familiar es a menudo la expresión más cercana de un sistema en el que la coacción es la respuesta por

defecto a la complejidad, la desviación o la angustia. Es precisamente en esta encrucijada, donde se encuentran el derecho, la cultura y la práctica médica, donde la brutal lógica de la dominación se viste con el lenguaje del deber, el cuidado o la experiencia.

Esta realidad no es nueva. Los sistemas históricos de matrimonio forzado, trabajo infantil, confinamiento doméstico y coacción reproductiva estaban todos sancionados legalmente, a menudo enmarcados como deberes naturales. No eran aberraciones de un orden justo, eran su lógica operativa. La persistencia de estas lógicas en la psiquiatría, la educación y el derecho de familia contemporáneos revela la resistencia de la dominación bajo la superficie reformista. Incluso ahora, las protecciones legales contra la coacción son más débiles donde la complejidad relacional es mayor, dentro de las familias, donde la supervisión estatal es vacilante, y dentro de los sistemas de atención, donde la desviación se interpreta erróneamente como peligro. La iniciativa QualityRights de la OMS, a la que se hace referencia a lo largo de esta tesis y que es fundamental en el capítulo 7, ofrece un contrapunto sustantivo a esta estructura heredada. Su paradigma es relacional, no disciplinario. No centra los derechos como símbolos procedimentales, sino como realidades vividas, sentidas y co-creadas. Replantea la atención como la creación de entornos propicios, legales, sociales y psicológicos, en los que cada individuo no es gestionado, sino acompañado, no silenciado, sino escuchado. QualityRights rechaza la sustitución del diálogo por el juicio y la sustitución del consentimiento por el cumplimiento. No es simplemente una norma, es la antítesis relacional de toda la historia de la atención como control. La naturaleza humana, tal y como se aborda aquí desde una perspectiva biocultural y evolutiva, no se reduce a la agresión ni a la dominación. Nuestra especie no ha sobrevivido solo por la fuerza, sino por la cooperación, la comunicación y la reciprocidad. En el mejor de los casos, somos criaturas prometedoras, de reconocimiento mutuo y de fidelidad relacional. Esto no es ingenuo ni retórico. Las estructuras neurofisiológicas del apego, la regulación de las emociones y la sensibilidad ética son reales y se ven dañadas en condiciones de coacción y traición persistentes. Cuando la ley se alinea con la dominación, cuando la educación omite la verdad emocional y cuando el cuidado se convierte en un pretexto para silenciar, estas estructuras se ven dañadas, reproduciendo ciclos de violencia relacional que se extienden a lo largo de generaciones.

Hay que repetirlo, dada la gravedad: el uso de la fuerza, incluso dentro de las familias, no puede tratarse como una necesidad residual o una excepción lamentable. Debe ser nombrado, expuesto y desmantelado mediante la transformación pedagógica, la reforma legal y el ajuste de cuentas cultural. Los sistemas que siguen basándose en la coacción como política no son neutrales, son regresiones, estructuralmente antitéticas a la posibilidad misma de la salud mental tal y como la define la OMS: la capacidad de afrontar, participar y realizar el propio potencial con dignidad y en comunidad. Esta última sección se inscribe en la continuidad del análisis jurídico del capítulo 6 y del marco epistémico del capítulo 1. No propone la coexistencia entre el cuidado y la coacción, sino su irreconciliabilidad. No hay síntesis entre el derecho a la autonomía y su negación sistemática.

La convergencia de la ciencia médica, la investigación sobre el desarrollo neurológico, las políticas de salud pública y el derecho internacional de los derechos humanos no deja ninguna justificación teórica o empírica para la neutralidad frente a los cuidados coercitivos. La persistencia de la coacción dentro de las estructuras familiares, los sistemas médicos y los regímenes jurídicos no es una cuestión de interpretación cultural o de desacuerdo profesional, sino una contradicción con los conocimientos

científicos establecidos y las normas normativas vinculantes. Las pruebas actuales de la neurobiología, la fisiología del trauma y la psicología del desarrollo confirman que la seguridad relacional sostenida, la previsibilidad y los entornos que favorecen la autonomía son esenciales para la maduración de la regulación afectiva, la cognición social y el bienestar a largo plazo. Por el contrario, las amenazas impredecibles, la traición relacional y la experiencia de impotencia se asocian sistemáticamente con la desregulación, el deterioro funcional y el daño estructural del cerebro y el sistema inmunológico. No se trata de daños metafóricos ni de riesgos abstractos, sino de resultados medibles documentados en diferentes poblaciones, edades y entornos institucionales.

Las implicaciones éticas de estos hallazgos no son discrecionales. Al igual que en cualquier ámbito de la ciencia biomédica, cuando se establece la causalidad y el perfil de riesgo-beneficio es claro, es necesario actuar, no en nombre de la ideología, sino por imperativo de la integridad profesional y el deber público. Cuando el conocimiento científico confirma que determinados entornos y prácticas producen daños, los sistemas responsables de implementar la atención y la protección deben adaptarse en consecuencia. En este contexto, los marcos jurídicos no pueden permanecer suspendidos entre derechos nominales y ambivalencia operativa. La ley debe asumir la responsabilidad de la aplicación, la interpretación y la reparación. Debe dejar de actuar como árbitro pasivo y reconocer que la neutralidad ante un daño sistémico constituye una participación activa en ese daño. No se trata de una cuestión de postura política, sino de una exigencia basada en pruebas forenses, epidemiológicas y de derechos humanos. Del mismo modo, las instituciones educativas, ya sean generales, clínicas o judiciales, deben interiorizar y transmitir estos conocimientos como fundamentales. Los protocolos de enseñanza, los estándares curriculares y la ética profesional no pueden alinearse con sistemas que reproducen la coacción bajo el disfraz del cuidado. La educación, en este sentido, no es un proceso neutral en cuanto a valores. Es un mecanismo de socialización, un vector de transmisión epistémica y una fuerza que consolida o desmantela las estructuras de violencia. Por lo tanto, la formación de los profesionales de la salud, los cuidadores, los educadores y los actores legales debe reorientarse hacia la ética encarnada, la competencia relacional y la comprensión fisiológica. Esta reorientación no es idealismo. Es realismo clínico, adecuación legal y precisión pedagógica. Los sistemas de atención, a su vez, deben construirse no en torno al control y la sedación, sino en torno al desarrollo de capacidades y el acompañamiento. El mandato clínico no es simplemente reducir los síntomas, sino restablecer las condiciones en las que las personas pueden regularse, conectarse y prosperar.

Esta es la definición más antigua y avanzada de la salud: no es la ausencia de patología, sino la presencia de agencia, continuidad relacional y función fisiológica plena. Cuando los sistemas de atención actúan de otra manera, cuando ignoran el consentimiento, suprimen la expresión o fragmentan la dignidad, contradicen tanto los objetivos de la medicina como el núcleo ético de las profesiones que la sustentan. Esa contradicción no es sostenible ni defendible desde el punto de vista científico.

La posición defendida a lo largo de esta tesis no es retórica ni contradictoria. Es la consecuencia lógica de décadas de investigación científica, jurisprudencia y testimonios empíricos convergentes. Afirma que el tiempo de la ambivalencia conceptual ha terminado. Las estructuras del conocimiento han madurado. Las pruebas son concluyentes. No existe neutralidad científica frente al daño organizado. Por lo tanto, la ley debe tomar partido, no para castigar, sino para proteger. La educación debe tomar

partido, no para adoctrinar, sino para aclarar. La atención sanitaria debe tomar partido, no para controlar, sino para curar. No se trata de actos ideológicos. Son la expresión mínima de responsabilidad dentro de cualquier sistema ético que pretenda proteger la vida, apoyar la salud o defender la dignidad. En las sociedades maduras, esa responsabilidad no es una cuestión de opinión. Es una cuestión de norma. Y cuando se sabe que esas normas no se cumplen, la ciencia ya no defiende el retraso. Exige una reforma (Grol y Grimshaw, 2003).

Tabla 51. Efectos neurobiológicos y del desarrollo de la negligencia clínica e institucional

Dimensión	Descripción	Consecuencias	Consecuencias biológicas y morfológicas
Definición	Falta persistente de atención física, emocional o psicológica	Privación relacional; forma activa de daño, no omisión pasiva	Maduración cerebral alterada, reducción de la resiliencia inmunológica y endocrina, adelgazamiento cortical en las regiones prefrontales
Activación neurobiológica	Desencadena vías neuroendocrinas e inflamatorias relacionadas con el estrés	Detener el desarrollo, alterar la plasticidad y aumentar la sensibilidad al estrés	Aumento del cortisol, inflamación crónica, reducción de la conectividad entre regiones clave del cerebro, atrofia del hipocampo
Déficits en los cuidados tempranos	Imprevisibilidad, falta de disponibilidad emocional, privación sensorial o cognitiva en la infancia	Alteración del desarrollo neural y la regulación afectiva	Alteración de la poda sináptica y la mielinización, disminución del volumen de materia gris, reducción de la corteza cingulada anterior
Negligencia en entornos de cuidado	Desprecio emocional, medicación excesiva, despersonalización en entornos institucionales o clínicos	Retraumatización, deterioro psicológico, indefensión aprendida	Respuesta atenuada a la oxitocina, acortamiento de los telómeros, reducción del volumen cortical en los circuitos socioafectivos
Impacto en la función ejecutiva	Socava la regulación emocional, la planificación y el autocontrol	Control deficiente de los impulsos, volatilidad emocional, autonomía deteriorada	Hipactivación de la corteza prefrontal, reducción del grosor orbitofrontal, alteración de la integridad de la materia blanca
Desregulación del eje HPA	Ausencia crónica de señales de seguridad, sintonía emocional y previsibilidad	Estresante activación persistente, afrontamiento inadaptado, apego alterado	Hiperactivación del eje HPA, pendiente diurna del cortisol aplanada, aumento del volumen de la amígdala, alteraciones metabólicas

Esta tabla resume cómo el abandono, ya sea en el ámbito familiar, durante la infancia o en instituciones de atención a adultos, actúa como un factor disruptivo biológico y psicosocial activo, con efectos sostenidos en la arquitectura cerebral, la regulación del estrés y las trayectorias de desarrollo. La numeración sigue esa sorprendente lógica de la realidad esperada que no tiene sentido, que nos perjudica a todos, con toda su pompa.

El abandono, definido clínicamente como la falta persistente de atención física, emocional o psicológica necesaria, constituye una forma de privación relacional con efectos demostrables en la arquitectura cerebral y la salud sistémica. Lejos de ser una omisión pasiva, el abandono activa cascadas neurobiológicas específicas asociadas con el estancamiento del desarrollo, la sensibilización

al estrés y la alteración de la plasticidad. En los primeros años de vida, la atención insuficiente, caracterizada por la imprevisibilidad, la falta de disponibilidad afectiva o la privación sensorial, interfiere en la poda sináptica, la mielinización y la integración de los circuitos límbicos y corticales responsables de la función ejecutiva y la regulación emocional. La ausencia prolongada de un compromiso estructurado y de señales de seguridad perjudica el establecimiento de bases homeostáticas, lo que conduce a una activación crónica del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA). Con el tiempo, esta desregulación promueve la carga alostática, eleva los niveles de glucocorticoides y altera la señalización trófica en el hipocampo, la corteza prefrontal y el cíngulo anterior. Las consecuencias incluyen una neurogénesis atenuada, una retracción dendrítica y una reducción del grosor cortical, medibles mediante estudios de imagen y correlacionados con disfunciones cognitivas, emocionales y sociales.

Estos mismos procesos no se limitan a las ventanas de desarrollo (Huttenlocher y Dabholkar, 1997; Farah et al., 2012; Afroz et al., 2016). En condiciones de adversidad relacional sostenida, como el abandono institucional, la coacción o la violencia a nivel comunitario, los adultos también muestran patrones de adelgazamiento cortical, desconexión funcional y alteración de la integración neuroinmunitaria. En contextos en los que los individuos se ven sistemáticamente privados de seguridad relacional, autonomía o compromiso significativo, los sistemas predictivos del cerebro se adaptan restando prioridad a la integración plástica y conservando solo los circuitos que responden a las amenazas. Los procesos autofágicos, normalmente esenciales para el mantenimiento y la reparación neural, se desregulan en estas condiciones crónicas, lo que contribuye a la degradación celular y a la pérdida sináptica. En casos de exposición extrema o prolongada, se inicia la apoptosis en regiones críticas para el procesamiento reflexivo, la confianza interpersonal y la flexibilidad reguladora, mecanismos bien documentados en estudios tanto a nivel individual como poblacional (Huttenlocher, 1979; Campisi y d'Adda Di Fagagna, 2007). Estos resultados no se limitan a la patología clínica, sino que representan una lógica biológica de retracción y cierre ante adversidades irresolubles (Singer y Baer, 2007). Cuando estas condiciones se replican en sistemas, escuelas, familias, clínicas y marcos legales, producen patrones colectivos de colapso cognitivo y relacional (Miller y Moore, 2007). La pérdida no es solo individual, sino también social: una disminución de la capacidad compartida para la complejidad, la cooperación y la orientación ética. Una vez establecidos, estos patrones se mantienen no por malicia, sino por la adaptación neurobiológica a la incoherencia y el miedo (Panksepp, 1998; Casey, Jones y Hare, 2008; Joyce, 2015; Brady y Segool, 2019). La reversión de tal degradación exige no solo el cese de la violencia manifiesta, sino la reconstrucción de entornos en los que la previsibilidad, el reconocimiento mutuo y el cuidado recíproco estén garantizados estructuralmente (Blakemore, 2007; Farah et al., 2012).

5.4 El daño médico y el déficit educativo: sistemas que drogan, en lugar de enseñar o curar

El paradigma farmacocéntrico que prevalece en la psiquiatría y la medicina general sigue funcionando en contradicción con los principios establecidos de la salud preventiva y la atención de precisión. A pesar del creciente consenso internacional en torno a los modelos de salud mental individualizados, basados en el trauma y orientados a la recuperación, la evidencia empírica apunta a una dependencia

excesiva y persistente de los fármacos psicotrópicos, sobre todo antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, en poblaciones que no presentan indicadores claros de desequilibrio bioquímico o sintomatología resistente al tratamiento. El fenómeno de la prescripción excesiva es especialmente pronunciado entre las personas que ya muestran un compromiso con comportamientos que promueven la salud, como una higiene del sueño adecuada, una alimentación equilibrada, actividad física e integración social. Estos hallazgos no son aislados, sino que se observan de forma sistemática en cohortes observacionales, bases de datos de reclamaciones de seguros y estudios de auditoría de diversos sistemas de salud. Estos patrones se amplifican entre las mujeres, los adultos jóvenes y las personas que atraviesan un duelo, angustia interpersonal o incertidumbre socioeconómica, categorías de experiencia que a menudo se patologizan sin una exploración adecuada del contexto social o de los parámetros fisiológicos de referencia. Esta tendencia refleja un fracaso a varios niveles: a nivel diagnóstico, a través de sistemas categóricos que permiten un amplio margen de interpretación (por ejemplo, los criterios del DSM o la CIE aplicados sin un examen dimensional); a nivel profesional, a través de una formación insuficiente en neurofisiología, regulación del sistema de estrés o neuroplasticidad; y a nivel institucional, a través de estructuras de incentivos que premian el rendimiento farmacológico por encima del compromiso educativo o los indicadores de recuperación a largo plazo. Por ejemplo, en el contexto de la atención primaria, los médicos generales, que prescriben la mayoría de los medicamentos psiquiátricos, suelen informar de que carecen de tiempo, formación u opciones de derivación para explorar la desregulación somática, la carga de estrés o la integridad del ciclo del sueño antes de iniciar la medicación. Del mismo modo, la rápida escalada desde el malestar emocional comunicado por el paciente hasta la intervención farmacológica omite pasos intermedios como la psicoeducación, la evaluación nutricional o endocrinológica y el análisis funcional de los ritmos diarios. Fisiológicamente, muchas de las personas que reciben farmacoterapia no cumplen los criterios de desregulación crónica de los sistemas neurotransmisores cuando se someten a una evaluación bioquímica o conductual rigurosa. En cambio, muestran signos de estrés adaptativo, respuestas de duelo o sobrecarga psicosocial, todos ellos susceptibles de intervenciones no invasivas y basadas en la educación. Sin embargo, debido a la falta de protocolos institucionalizados para evaluar y apoyar la resiliencia neurobiológica, por ejemplo, perfiles metabólicos, medición del tono vagal o análisis de la pendiente del cortisol, los médicos actúan sin la información necesaria para distinguir entre respuestas adaptativas transitorias y condiciones patológicas. El resultado es la aplicación generalizada de protocolos que dan prioridad a los fármacos, no con el objetivo de estabilizar, sino como herramientas de control conductual y cumplimiento administrativo, a menudo institucionalizados a través de formularios, algoritmos de tratamiento o normas no escritas dentro de los servicios de salud. Además, muchos de estos protocolos se aplican sin marcos temporales ni planes de retirada estructurados. La ausencia de programas de reducción gradual, de monitorización fisiológica o de puntos de control para la reevaluación conduce a una dependencia farmacológica a largo plazo, tanto fisiológica como psicológica e institucional.

Los pacientes pueden quedar atrapados en un ciclo de daño iatrogénico y aumento del uso de los servicios, no debido al curso natural de su afección inicial, sino a la propia naturaleza de la intervención. Los bucles de retroalimentación clínica, incluidos los resultados comunicados por los pacientes y el seguimiento de los efectos adversos, son inexistentes o no funcionan en la mayoría de

los sistemas de salud, especialmente en infraestructuras con escasa financiación o fragmentadas digitalmente. La falta de obligaciones nacionales o regionales de notificación del uso no indicado, la polifarmacia o las secuelas de la retirada hace invisible la carga acumulada de los daños médicos atribuibles a la prescripción rutinaria e injustificada. A pesar de los importantes avances en la neurociencia de la regulación de las emociones, la neuroplasticidad y el eje intestino-cerebro, estos ámbitos siguen siendo periféricos en la mayoría de la práctica clínica, especialmente en el ámbito psiquiátrico (Haslam, 2024). La aplicación clínica de estos hallazgos requiere su traducción a una formación accesible y acreditada, pero la educación médica sigue dando una prioridad desproporcionada a la farmacología de los receptores frente a los enfoques basados en sistemas. Mientras tanto, parte de la población sigue mostrando receptividad a la educación somática, el autocuidado preventivo y las estrategias de integración mente-cuerpo cuando se ponen a su disposición, lo que pone de relieve una profunda desconexión entre la práctica institucional actual y la ciencia empírica y la demanda pública. Esta desconexión no es una cuestión de déficit de conocimientos, sino el producto de la inercia institucional, la rigidez profesional y la autoridad perdurable de los paradigmas reduccionistas que sitúan el malestar mental principalmente en el cerebro químico, separado de la persona, el contexto o la matriz social.

La administración continuada de psicofármacos a personas que practican comportamientos saludables no es una anomalía, sino una característica estructural de un modelo construido para patologizar la desviación de la productividad, la expresión emocional o la duda existencial. La incapacidad de integrar la fisiología del estrés, el trauma y la adaptación en los protocolos de atención rutinaria refleja un fracaso educativo, perpetuado por planes de estudio que no exigen una comprensión integral del sistema nervioso más allá de fragmentos centrados en la patología. Sin una reforma educativa que se centre en la alfabetización sanitaria, la integridad fisiológica y el modelo biopsicosocial en toda su complejidad, los sistemas médicos seguirán medicando no al cuerpo que lo necesita, sino a la persona que no se ajusta a las expectativas institucionales. La tesis postula que estos patrones no constituyen un simple error de juicio clínico, sino una violencia epistémica estructural, que se ejerce mediante el incumplimiento de las normas científicas y la ausencia de un consentimiento informado y participativo. Por lo tanto, el objetivo es delinear empíricamente cómo estos sistemas no cumplen ni siquiera los principios más básicos de las propias definiciones de la OMS: que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que la salud mental abarca la realización del propio potencial, la capacidad de afrontar la vida y la contribución a la sociedad. Estas definiciones deberían ser la referencia, y no la excepción, para evaluar todos los protocolos diagnósticos, educativos y terapéuticos. El incumplimiento sistemático de estas normas no es un resultado desafortunado, sino la consecuencia previsible de un modelo que prioriza el cumplimiento sobre la comprensión, la farmacología sobre la pedagogía y el control sobre la atención.

En los sistemas médicos, psicológicos y de educación pública, existe una ausencia notable de enseñanza estructurada y evolutiva sobre el sistema nervioso humano, la fisiología del estrés y los principios de la neuroplasticidad. Esta ausencia no es accidental ni circunstancial, sino una omisión sistemática que perpetúa un modelo deficitario de salud mental, en el que se enseña a las personas a cumplir protocolos de gestión de los síntomas en lugar de desarrollar estrategias informadas y

encarnadas para la resiliencia, la regulación y la recuperación adaptativa. A pesar de la creciente disponibilidad de pruebas neurocientíficas que relacionan la exposición al estrés, el sueño, el trauma, la inflamación y el contexto social con la desregulación neural y endocrina, estos contenidos siguen siendo marginales tanto en los planes de estudios de las facultades de medicina como en la educación sanitaria escolar. Rara vez se introducen a los estudiantes conceptos fundamentales como el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), el tono vagal, la carga alostática o el papel de las primeras experiencias relacionales en la configuración de los circuitos neuronales. La consecuencia es un desconocimiento generalizado, tanto entre los profesionales como entre el público en general, de cómo el pensamiento, la respiración, el comportamiento y el contexto interactúan continuamente con los sistemas somáticos en bucles de retroalimentación dinámica. Esta laguna da lugar a estrategias diagnósticas y terapéuticas que tratan los síntomas superficiales sin abordar los sistemas reguladores subyacentes.

Las instituciones educativas, en particular los programas de formación sanitaria y docente, siguen dando prioridad a la memorización mecánica de estructuras anatómicas o vías farmacológicas frente a la comprensión a nivel sistémico del desarrollo neural, la neuroendocrinología y la cognición incorporada. Cuando se enseña fisiología, a menudo se abstrae de los contextos conductuales y ambientales, y se presenta como un sistema cerrado en lugar de una matriz interactiva y receptiva, influenciada por determinantes sociales, historias traumáticas y patrones de estilo de vida. Del mismo modo, los estudiantes de medicina se exponen a nosologías psiquiátricas con una mínima implicación en cómo se desarrollan los sistemas neurobiológicos a lo largo de la vida o cómo responden a la desregulación crónica. Se hace poco o ningún hincapié en la comprensión experiencial de los procesos reguladores, como los que intervienen en la respiración rítmica, la interocepción o la integración sensoriomotora, ni en los métodos pedagógicos para enseñarlos a los pacientes o al público en general.

En los entornos de atención de la salud mental, esta deficiencia curricular se traduce en una cultura clínica en la que el autocuidado se patologiza como incumplimiento o se trivializa como algo secundario al cumplimiento de la medicación. Los profesionales de la salud que carecen de formación formal en autorregulación somática o fisiología del desarrollo suelen recurrir a modelos basados en la autoridad, instruyendo a los pacientes para que acepten las directrices farmacológicas en lugar de explorar estrategias basadas en el cuerpo o orientadas al estilo de vida. Este fracaso pedagógico se ve agravado por fuerzas estructurales: las métricas de productividad clínica, los modelos de reembolso de los seguros y los incentivos farmacéuticos despriorizan sistemáticamente los compromisos educativos que requieren mucho tiempo en favor de encuentros breves y centrados en los síntomas. En las escuelas, la marginación de la educación sanitaria integral significa que la mayoría de los niños se gradúan con poco o ningún conocimiento de sus propios procesos de desarrollo neurológico. El hecho de no incorporar la alfabetización neurofisiológica en la educación obligatoria constituye un riesgo para la salud pública. Los niños, adolescentes y adultos que no están capacitados para reconocer los signos somáticos del estrés, la sobrecarga, el bloqueo o la disociación son más propensos a atribuir erróneamente su malestar, retrasar la autocorrección adecuada y volverse vulnerables a una medicalización inadecuada. Las consecuencias van más allá de la psiquiatría: la impulsividad, la desmotivación académica, los trastornos somáticos, el abuso de sustancias y la violencia están relacionados con una capacidad reguladora deficiente, que a su vez depende de la oportunidad de

aprender y practicar estrategias de adaptación. Cuando no se enseña explícitamente la alfabetización sobre el sistema nervioso, el desarrollo de mecanismos de afrontamiento saludables se deja al azar o a la transmisión familiar, ambos insuficientes en entornos afectados por la desigualdad sistémica, el trauma histórico o el abandono institucional.

Esta tesis sostiene que la omisión en el desarrollo, el hecho de no enseñar al público cómo cuidar su propio sistema nervioso, no es solo una laguna educativa, sino una condición estructural alineada con las prácticas farmacológicas coercitivas y que las respalda (Cianconi et al., 2020). No es la ignorancia lo que persiste, sino el diseño institucional de la ignorancia, arraigado en estructuras pedagógicas que fragmentan el cuerpo de la mente, la biología del entorno y la ciencia de la experiencia. Hasta que los planes de estudio, tanto clínicos como cívicos, integren sistemáticamente las bases neurocientíficas del estrés, el aprendizaje, el trauma y la adaptación, las poblaciones más afectadas por los daños médicos seguirán careciendo de los medios para prevenirlos, comprenderlos o recuperarse de ellos. La definición de salud mental de la OMS hace hincapié no solo en la ausencia de enfermedad, sino en la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. Para lograrlo es necesario un cambio fundamental en lo que se enseña, quién lo enseña y cómo las instituciones miden el éxito educativo, no a través de la conformidad o las tasas de prescripción, sino a través de una mayor autorregulación, la capacidad de actuar de forma crítica y la alfabetización fisiológica a lo largo de toda la vida.

El panorama actual de la psiquiatría clínica y la práctica médica general muestra una disyuntiva persistente entre el creciente conjunto de pruebas científicas y los protocolos operativos utilizados para definir, evaluar y tratar el malestar mental. Esta desalineación es especialmente evidente cuando se yuxtapone con los hallazgos contemporáneos en neurociencia, fisiología del estrés, neurodesarrollo y salud pública global. Mientras que las rutinas clínicas dominantes siguen centrando la medicación como respuesta de primera línea a la desregulación emocional o cognitiva, investigaciones recientes en múltiples disciplinas apuntan hacia un modelo muy diferente, que da prioridad a la plasticidad, la agencia, la resiliencia metabólica y los determinantes estructurales de la salud. Un componente clave de esta base empírica es el creciente reconocimiento de la naturaleza plástica y adaptativa del sistema nervioso humano, que, en condiciones adecuadas, como la seguridad, la regulación relacional, el sueño y la estimulación específica, demuestra una capacidad sustancial para la recuperación funcional y la reorganización. Estos hallazgos cuestionan directamente los modelos que enmarcan las afecciones psiquiátricas como desequilibrios químicos fijos que requieren un mantenimiento farmacológico crónico y, en su lugar, hacen hincapié en las ventanas de intervención sensibles al tiempo, la expresión del riesgo genético dependiente del estilo de vida y el entorno, y el papel fundamental de la participación somática informada sobre el trauma en la curación a largo plazo.

Paralelamente a estos avances, los marcos de salud pública, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y las iniciativas de «una sola salud», subrayan la necesidad ética y práctica de adoptar enfoques de salud no coercitivos, comunitarios, educativos y preventivos. La definición de salud mental de la OMS no solo rechaza la patologización del malestar aislado, sino que insiste en las condiciones que permiten el pleno desarrollo humano: la realización del potencial de cada persona, la capacidad de hacer frente al estrés diario, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la

comunidad. Estas condiciones no son compatibles con sistemas organizados en torno a la sedación, el cumplimiento de normas de comportamiento o la dependencia indefinida de psicofármacos. Del mismo modo, el marco de «una sola salud», surgido de la ciencia ecológica y epidemiológica integradora, rechaza las divisiones binarias entre mente y cuerpo, ser humano y entorno, o tratamiento y educación, y aboga por la armonización intersectorial de las prácticas jurídicas, médicas y medioambientales al servicio del bienestar sistémico.

La neurociencia moderna, especialmente en ámbitos como la regulación afectiva, la señalización interoceptiva, la alostasis y la interacción entre el cerebro y el sistema inmunitario, desestabiliza aún más cualquier afirmación de que la exposición prolongada a psicofármacos ofrece resultados neutros o uniformemente beneficiosos. Por el contrario, apunta hacia alteraciones estructurales y funcionales acumulativas del cerebro con el uso crónico, incluyendo la desensibilización de los receptores, la alteración de los marcadores neuroinflamatorios, la reducción de la sensibilidad a la recompensa y el aumento de la vulnerabilidad a la recaída tras la retirada. Estos hallazgos no se limitan a estudios experimentales, sino que se reflejan en seguimientos a largo plazo de pacientes, estudios de cohortes naturalistas y bases de datos de efectos adversos. La desconexión entre estas pruebas y las prácticas de prescripción predominantes refleja una brecha entre el conocimiento y la aplicación, pero, más fundamentalmente, un rechazo institucional a afrontar la no neutralidad de las intervenciones rutinarias, especialmente en contextos en los que las poblaciones vulnerables tienen poco acceso a segundas opiniones, educación somática o alternativas de atención basadas en los derechos.

A pesar del creciente reconocimiento de estos avances científicos entre los investigadores, siguen siendo marginales en la educación clínica, están infrarrepresentados en las guías clínicas y ausentes de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones utilizadas por la mayoría de los profesionales. El resultado es la institucionalización del daño médico, no por malicia o ignorancia, sino a través de protocolos que van a la zaga de la ciencia e incentivan intervenciones rápidas, reembolsables y reproducibles en categorías diagnósticas estandarizadas. No existe ningún mecanismo institucional que obligue a conciliar los nuevos descubrimientos de la neurociencia con la educación pública o profesional. Tampoco existe ningún requisito normativo que obligue a recalibrar los protocolos de prescripción a la luz de los avances en las intervenciones no farmacológicas basadas en la neurociencia, como el neurofeedback, el reentrenamiento interoceptivo, la regulación basada en la respiración y la modulación nutricional de la inestabilidad afectiva. La ausencia de estas obligaciones garantiza que los sistemas de atención sigan siendo estructuralmente incapaces de evolucionar hacia el estándar de la OMS de la mejor salud posible. A la luz de esto, el contexto científico es claro: la infraestructura para la curación genuina, el potencial neuroplástico, la alfabetización somática y la fisiología preventiva está respaldada empíricamente, es éticamente obligatoria y está descuidada institucionalmente. El sistema existente no refleja una ausencia de conocimiento, sino la exclusión selectiva del conocimiento que desafía la autoridad, reduce la dependencia y restaura la autonomía. Hasta que ese conocimiento no se integre estructuralmente tanto en la formación como en la gobernanza clínica, los sistemas de salud seguirán prestando una atención deficiente, coercitiva y, en última instancia, contraproducente, incompatible tanto con la ciencia como con la ley. La alineación de la práctica con el canon científico contemporáneo no es una cuestión de preferencia o debate, sino un requisito de una atención basada en la evidencia, en los derechos y en la ética.

La traducción del conocimiento científico y ético en sistemas de atención aplicables requiere un rediseño estructural integral, que comience por los planes de estudios básicos y se extienda a los mecanismos reguladores y la responsabilidad profesional. En primer lugar, los planes de estudios escolares y profesionales deben revisarse para incorporar contenidos basados en la evidencia sobre fisiología humana, respuestas al estrés, neurodesarrollo y neuroplasticidad, no como asignaturas optativas o módulos periféricos, sino como fundamentos científicos y clínicos básicos. Esto incluye la enseñanza obligatoria de la carga alostática, la función del nervio vago, la regulación circadiana, la autoconciencia somática y la neuroendocrinología basada en el trauma, integrada en la educación médica, de enfermería, de enseñanza, de psicología y de otras profesiones sanitarias afines. La enseñanza debe hacer hincapié en la naturaleza dinámica y plástica del sistema nervioso y en su capacidad de regeneración en condiciones de seguridad, reparación relacional y cambio de comportamiento. No se trata de ámbitos especializados, sino de requisitos previos para la competencia clínica moderna.

En segundo lugar, todos los protocolos que dan prioridad a los fármacos deben reclasificarse como medidas excepcionales, que solo deben emplearse en condiciones explícitas, limitadas en el tiempo y consensuadas, acompañadas de una revisión independiente y disposiciones estructuradas para la reducción gradual. La sedación de emergencia o la intervención psicofarmacológica deben seguir el modelo del consentimiento quirúrgico informado, solo aceptable cuando todas las alternativas son imposibles, cuando el tiempo es crítico y cuando se documentan y supervisan los planes de recuperación posteriores. Los datos longitudinales sobre los resultados del tratamiento deben estar vinculados a métricas en tiempo real comunicadas por los pacientes, incluyendo el bienestar subjetivo, los efectos adversos e indicadores funcionales como la reincorporación al trabajo, la educación o la participación en la comunidad. Estas medidas deben estar a disposición tanto de los pacientes como de los profesionales, en formatos que permitan su auditoría, impugnación y revisión.

En tercer lugar, los sistemas nacionales de desarrollo profesional continuo deben incluir módulos sobre neurociencia actualizada, ética asistencial y farmacovigilancia crítica. La participación en estos módulos debe ser un requisito previo para la renovación de la licencia y la especialización. También debe ser obligatoria la capacitación de los profesionales que hayan prescrito repetidamente fuera de las directrices de buenas prácticas, ignorado los requisitos de consentimiento o no hayan iniciado los protocolos de retirada de la medicación cuando estaba clínicamente indicado. La aplicación incorrecta de los conocimientos científicos, especialmente cuando da lugar a una discapacidad a largo plazo, a la dependencia institucional o a una reducción de la esperanza de vida, debe estar sujeta al mismo grado de control reglamentario y responsabilidad que otros errores profesionales. Para ello es necesario que se reconozca oficialmente el daño médico como una categoría susceptible de recurso tanto en la gobernanza clínica como en los marcos jurídicos, no solo como una complicación o un acontecimiento adverso, sino como un resultado evitable de una práctica inadecuada u obsoleta.

En cuarto lugar, deben desarrollarse plataformas nacionales de aprendizaje, de libre acceso, abiertas, multilingües y no comerciales, para promover la alfabetización sanitaria de los ciudadanos. Estas plataformas deben incluir contenidos audiovisuales e interactivos sobre el funcionamiento del sistema nervioso, la regulación somática, la higiene del sueño, la psiquiatría nutricional, la fisiología del estrés y las estrategias de recuperación no farmacológicas. No deben considerarse intervenciones de salud

mental en sí mismas, sino conocimientos públicos fundamentales, similares a la higiene o los primeros auxilios, sin los cuales las poblaciones siguen siendo vulnerables a la medicalización excesiva y la dependencia institucional. Estas plataformas también pueden servir como sitios de registro público de violaciones éticas, inconsistencias procedimentales y resultados institucionales, lo que permite la supervisión participativa de los sistemas de atención y fomenta el aprendizaje sistémico. Los sistemas de retroalimentación ética en tiempo real deben integrarse en todos los entornos institucionales, escuelas, hospitales, clínicas, tribunales y centros residenciales, donde las poblaciones vulnerables interactúan con profesionales. Estos sistemas deben permitir la retroalimentación anónima y protegida de los usuarios y el personal de los servicios, con mecanismos de reconocimiento de patrones, escalamiento y revisión externa. Las métricas deben incluir no solo umbrales legales o disciplinarios, sino también indicadores de humildad institucional, cambio adaptativo y reparación ética. Los sistemas que no puedan demostrar una mejora en respuesta a la retroalimentación deben ser objeto de intervención externa o de pérdida de acreditación. El cumplimiento ético debe dejar de ser una aspiración y convertirse en algo medible, aplicable y diseñado conjuntamente por las personas más afectadas por la violencia estructural y la negligencia médica.

La integración de los conocimientos científicos, éticos y jurídicos en un modelo de atención unificado no es un reto tecnológico, sino un reto de gobernanza. Las herramientas existen. Las pruebas están disponibles. Lo que sigue faltando es la voluntad institucional de dar prioridad al desarrollo humano sobre el control administrativo, a la autonomía sobre el cumplimiento y a la recuperación sobre la sedación. La tesis sostiene que solo cuando los sistemas de atención estén obligados, desde el punto de vista legal, pedagógico y operativo, a reflejar los mejores conocimientos científicos disponibles y a mantener el más alto nivel de salud posible, tal y como lo define la OMS, dejarán de causar daño y comenzarán a sanar. Hasta entonces, seguirán tratando la resiliencia como un trastorno, la autorregulación como incumplimiento y el progreso científico como algo opcional.

La reconfiguración de los sistemas de salud mental hacia una práctica genuina de curación y basada en los derechos requiere un marco normativo multinivel que incorpore explícitamente los determinantes sociales de la salud y vincule la acción clínica a las normas jurídicas internacionales. La integración de las políticas estructurales debe comenzar por el reconocimiento de que la medicación excesiva, la inflación diagnóstica y el abandono fisiológico no son incidentales, sino expresiones sistémicas de una gobernanza mal alineada. Un enfoque unificado exige que los sistemas de atención, los sistemas educativos y las infraestructuras jurídicas adopten un compromiso común con la definición de la OMS de salud, bienestar físico, mental y social, no como un lenguaje aspiracional, sino como el punto de referencia normativo para el cumplimiento, la financiación y la evaluación pública. Esta reorientación no es meramente semántica, sino que tiene implicaciones operativas cuantificables. Todos los protocolos clínicos, algoritmos de tratamiento, planes de estudios escolares y procesos de acreditación profesional deben evaluarse en función de su capacidad para promover la salud funcional, proteger la integridad fisiológica y reducir los daños iatrogénicos. Los mandatos legales deben ir más allá de las garantías procesales e incluir requisitos sustantivos para la educación fisiológica y del desarrollo neurológico, tanto en el ámbito público como en el profesional; todo ello forma parte de la investigación-acción, que aún debe ponerse en marcha. Las instituciones públicas deberían estar

obligadas a implementar programas educativos sobre la regulación del sistema nervioso, los efectos del trauma, la adaptación al estrés y la atención orientada a la recuperación, no como opciones terapéuticas, sino como obligaciones universales de salud pública. Al igual que la legislación exige la seguridad contra incendios o el agua potable, también debería garantizar el acceso a la información y los recursos que permitan a las personas proteger y restaurar sus capacidades cognitivas, afectivas y somáticas. La ausencia de tales mandatos deja a las poblaciones vulnerables a modelos de tratamiento coercitivos que eluden la elección informada y marginan sistemáticamente los enfoques no farmacológicos.

A nivel institucional, deben promulgarse políticas que apoyen el desarrollo y la financiación de modelos de atención integral basados en la evidencia, la prevención y la ética participativa. Los planes de financiación deben dar prioridad a las instituciones que demuestren una alineación cuantificable con los principios de la CRPD, los criterios de «una sola salud» y las normas de resultados de la OMS. Esto incluye la financiación de servicios dirigidos por pares, equipos interdisciplinarios formados en enfoques somáticos y relacionales, y mecanismos de supervisión y retroalimentación de la comunidad. La financiación debería estar supeditada a contenidos educativos cuantificables impartidos tanto al personal como a los usuarios de los servicios. Las estrategias nacionales de salud pública deberían reescribirse para reflejar no solo los objetivos epidemiológicos, sino también los determinantes estructurales, la pobreza, la exclusión, la violencia y el abandono, como cofactores de los resultados en materia de salud mental. Las instituciones educativas deberían rendir cuentas de la enseñanza de la fisiología reguladora y la alfabetización emocional como fundamentos de las habilidades para la vida. Los organismos encargados de conceder las licencias deben exigir competencia en ciencias basadas en el trauma, protocolos de retirada y la dinámica no lineal de la recuperación como elementos fundamentales para la legitimidad profesional. Los mecanismos de gobernanza deben reforzarse con estructuras independientes de auditoría y aplicación capaces de investigar y sancionar el incumplimiento. Los sistemas de defensoría del pueblo, las comisiones éticas y los organismos reguladores deben estar facultados para rastrear y corregir los patrones sistémicos de exceso farmacológico, negligencia educativa y daño institucional. Estos mecanismos deben incluir tanto la justicia retrospectiva, la reparación de las violaciones cometidas en el pasado, como el cumplimiento prospectivo, vinculado a la formación continua, la supervisión independiente y la transparencia obligatoria. Paralelamente, se debe otorgar a las redes de supervivientes líderes y a los consejos de gobernanza basados en la experiencia vivida un papel formal en la elaboración de políticas, la evaluación institucional y el diseño de los planes de estudios, a fin de garantizar que la arquitectura de las políticas refleje la realidad de las personas más afectadas.

Los marcos globales existentes también deben integrarse en los sistemas jurídicos nacionales con una alineación y aplicabilidad claras. Esto incluye la incorporación explícita del artículo 12 (igualdad de reconocimiento ante la ley), el artículo 25 (salud sin discriminación) y el artículo 26 (habilitación y rehabilitación) de la CRPD en las políticas de atención y los protocolos de supervisión nacionales. El enfoque «Una sola salud» debe ponerse en práctica mediante la coordinación interministerial que vincule la salud, la educación, el medio ambiente y la justicia en una arquitectura social unificada de la atención. Las directrices éticas, actualmente relegadas a códigos profesionales o a carácter consultivo, deben elevarse a normas reglamentarias vinculantes, con sanciones por su incumplimiento

e incentivos para su aplicación. La falta de aplicación de estas medidas estructurales permite la persistencia de un sistema que medica en lugar de enseñar, que seda en lugar de informar y que patologiza en lugar de proteger. Las pruebas presentadas a lo largo de esta sección demuestran no solo la viabilidad, sino también la necesidad de una reforma estructural. La situación actual no es un estado natural, sino un diseño reversible, sostenido por paradigmas obsoletos, la inercia institucional y la falta de alineación jurídica y pedagógica con los mejores conocimientos disponibles. La tesis concluye que, sin la plena integración jurídica y educativa de la alfabetización fisiológica, la ética del cuidado y la gobernanza basada en los derechos en una política pública unificada, los sistemas médicos seguirán institucionalizando el daño bajo la apariencia de tratamiento. Lo que se necesita no es un nuevo ideal, sino la aplicación de normas científicas y normativas ya establecidas, aquellas que definen la salud como la presencia de capacidad, agencia y dignidad.

5.5 Vías hacia la soberanía sanitaria compartida y la convergencia científico-ética

El fracaso a la hora de integrar los determinantes sociales de la salud y los mandatos legales exigibles en un marco normativo unificado representa una disfunción central en los sistemas de salud mental contemporáneos. Como se ha puesto de manifiesto en los distintos lugares de estudio y en las respuestas a las encuestas, la fragmentación de las responsabilidades entre las instituciones médicas, legales y educativas permite que la coacción, la negligencia y las prácticas pseudocientíficas proliferen en zonas legalmente ambiguas. Estas condiciones no se observaron como periféricas, sino como características estructuralmente arraigadas en la gobernanza psiquiátrica, con medidas coercitivas y medicalización excesiva justificadas por la inercia institucional, la discreción profesional y la falta de supervisión legal. Esta desconexión socava la definición de la OMS de la salud mental como un estado de bienestar en el que cada individuo realiza sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad.

La literatura científica afirma de manera consistente la relevancia de los determinantes sociales, incluyendo la vivienda, los ingresos, la educación, la seguridad ambiental y la estabilidad relacional, como moduladores primarios de la salud mental. Su omisión en las evaluaciones psiquiátricas y los protocolos de atención refleja un reduccionismo biomédico obsoleto que socava la recuperación y contradice los avances en salud pública, epidemiología social y medicina sistémica. Los datos recopilados sobre el terreno demuestran que las intervenciones coercitivas se producen con frecuencia en ausencia de una infraestructura social de apoyo, donde no se satisfacen las necesidades básicas y el malestar se reinterpreta como sintomatología para legitimar el control. Esta dinámica no solo viola los principios de la ética médica, a saber, la autonomía, la no maleficencia y la justicia, sino que también conduce a la cronicidad, la dependencia institucional y un mayor riesgo de suicidio entre las personas tratadas por la fuerza (Pūras, 2016).

Los marcos jurídicos, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exigen que los sistemas de atención respeten el consentimiento informado, protejan contra la detención arbitraria y garanticen la igualdad de reconocimiento ante la ley. Sin embargo, como se documenta en múltiples casos sobre el terreno, estas protecciones no se

aplican o se eluden activamente mediante la reclasificación de la disidencia como incapacidad. El análisis confirma que, en ausencia de una política integradora que vincule la práctica clínica con los derechos legales y las condiciones sociales, la aplicación de la ley sigue siendo discrecional y la impunidad está estructuralmente codificada. Este fracaso institucional contradice las directrices internacionales basadas en pruebas, incluida la iniciativa QualityRights de la OMS, y sitúa a los sistemas nacionales en una situación de incumplimiento de facto de las obligaciones en materia de derechos humanos. Una respuesta científicamente rigurosa y éticamente sólida requiere la unificación a varios niveles de estos ámbitos en un marco de políticas públicas aplicables. Este marco debe reconocer los determinantes sociales no como consideraciones periféricas, sino como parte integrante del diagnóstico, la planificación del tratamiento y la resolución judicial. La salud mental no puede definirse ni perseguirse de forma aislada del ecosistema socioeconómico y político que configura su trayectoria. Por lo tanto, las políticas públicas deben incluir mecanismos para el intercambio de datos entre organismos, indicadores de riesgo social en tiempo real y planes de atención integral que combinen el apoyo clínico, jurídico y comunitario. Estos mecanismos deben diseñarse con transparencia, consentimiento informado y estructuras de rendición de cuentas dinámicas, que incluyan auditorías independientes y bucles de retroalimentación en tiempo real (Mofokeng, 2022).

Esta integración de políticas también exige un cambio fundamental en la educación y la formación profesional, incorporando conocimientos jurídicos, atención informada sobre el trauma, pensamiento sistémico y diagnóstico social en los planes de estudios médicos, jurídicos y pedagógicos. Los silos estructurales que actualmente separan los mandatos legales de las rutinas clínicas y los programas educativos fomentan condiciones en las que se normalizan las violaciones de los derechos humanos y se obstaculiza la innovación. La investigación respalda la implementación de instrumentos políticos coordinados entre los departamentos gubernamentales, las instituciones académicas y los sistemas de salud, regidos por un objetivo común: mantener entornos en los que la salud, la dignidad y la integridad científica se refuerzan mutuamente, en lugar de contradecirse sistemáticamente. Un obstáculo decisivo identificado a lo largo del trabajo de campo y los datos de la encuesta es la desarticulación sistémica entre los conocimientos científicos actualizados y su aplicación en la práctica clínica y educativa (OMS, 2025). Esta disyunción contribuye a intervenciones obsoletas, coercitivas y médicamente injustificables, incluso en entornos en los que los marcos jurídicos respaldan formalmente los derechos de los pacientes, la atención informada sobre el trauma y la gobernanza participativa. La brecha es más acusada en las instituciones y regiones con escasos recursos, pero persiste a nivel nacional debido a la ausencia de mecanismos universales para la difusión de pruebas y la actualización profesional. En respuesta a ello, esta tesis propone el diseño y la implementación de plataformas nacionales de aprendizaje de acceso abierto dedicadas a la salud mental, el trauma y la ética de la atención como reforma estructural central (Hunt, 2002).

Estas plataformas no servirían únicamente como repositorios de contenidos, sino como ecosistemas interactivos y continuamente actualizados para la difusión del conocimiento, el diálogo interprofesional y la formación basada en los derechos. Su arquitectura debería basarse en los principios de la ciencia abierta, permitiendo la total transparencia de las fuentes, las metodologías y las pruebas empíricas (Pūras, 2016). Las plataformas deberían proporcionar un acceso estratificado y adaptado a los distintos grupos de usuarios, médicos, educadores, trabajadores sociales, responsables

políticos, estudiantes y público en general, facilitando la democratización del conocimiento médico y preservando al mismo tiempo la precisión científica y la pertinencia contextual. Desde una perspectiva técnica y pedagógica, estos sistemas deben ser modulares, multilingües y estar alineados con los estándares contemporáneos de la educación de adultos, incluyendo la evaluación basada en competencias, el aprendizaje entre pares y el razonamiento basado en casos. Deben integrar los avances en psiconeuroinmunología, psiquiatría nutricional, teoría del trauma y medicina social, contextualizados dentro de marcos éticos como la iniciativa QualityRights de la OMS y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta integración garantiza que la formación impartida no solo se base en la evidencia, sino que también sea normativamente sólida y responda a los fallos documentados de la práctica actual (Maker y McSherry, 2023; UNHRC, 2017).

La justificación empírica de esta reforma se extrae de los capítulos 3 y 4. Las encuestas confirmaron que los profesionales suelen carecer de formación formal en la toma de decisiones compartida, la práctica informada sobre el trauma y las alternativas a la gestión de la medicación. Las observaciones sobre el terreno detallaron los efectos nocivos de la desinformación y la formación obsoleta, especialmente en entornos en los que las dinámicas jerárquicas impiden la corrección de errores o la actualización de las prácticas. Estas deficiencias no son accidentales, sino estructurales, y se ven sostenidas por sistemas educativos que siguen desconectados de los avances científicos y jurídicos actuales. La creación de infraestructuras de aprendizaje de libre acceso también responde a una necesidad social más amplia: el empoderamiento de las comunidades a través de la alfabetización en salud. Los ciudadanos no son receptores pasivos de la atención sanitaria, sino que poseen una capacidad latente de discernimiento y transformación cuando se les dan las herramientas para actuar. El conocimiento ciudadano, especialmente en materia de salud mental, ha sido sistemáticamente excluido de los círculos académicos y políticos, a pesar de su papel demostrado en la prevención, la recuperación y la evaluación de los servicios. Las plataformas públicas que se centran tanto en el conocimiento científico como en el empírico, validados a través de procesos participativos, pueden cerrar esta brecha epistémica, transformando a los receptores desempoderados en agentes informados. A nivel institucional, estas plataformas deben protegerse de la captura comercial, el control epistémico y la manipulación política. Las estructuras de gobernanza deben incluir a representantes de organismos científicos, organizaciones dirigidas por supervivientes, universidades e instituciones públicas, garantizando el pluralismo y la rendición de cuentas. La integración en los requisitos de licencia profesional y formación continua favorecerá la escalabilidad y la adopción. Los datos recopilados a lo largo de esta tesis confirman que, sin estos sistemas, es poco probable que las mejoras en las políticas o las normas jurídicas se traduzcan en prácticas clínicas o educativas. El conocimiento por sí solo no es transformador a menos que se distribuya, actualice y aplique dentro de ecosistemas institucionales diseñados para preservar la dignidad humana, la integridad científica y la salud pública (Pūras, 2017).

Una de las conclusiones más recurrentes en los capítulos 3 y 4 es la profunda ausencia de mecanismos institucionales para proteger a quienes denuncian los abusos psiquiátricos, la corrupción epistémica y la mala praxis clínica (Pūras, 2019). Los supervivientes que se convierten en líderes, las personas con experiencia vivida que se convierten en agentes del cambio y los profesionales que actúan como

denunciantes se enfrentan con frecuencia a represalias, ostracismo profesional y amenazas legales. Este silenciamiento sistemático obstaculiza el progreso científico, socava la rendición de cuentas y perpetúa un clima de miedo incompatible con la gobernanza democrática de la salud pública. Por lo tanto, el establecimiento de sistemas de apoyo protegidos para estos actores clave no es accesorio, sino fundamental para la soberanía sanitaria compartida (Rose, 2008; Rose, 2017; Rose y Kalathil, 2019).

Desde el punto de vista científico y político, la protección de los denunciantes y los líderes supervivientes debe formalizarse en la legislación, la educación y la gobernanza sanitaria. Estas protecciones deben incluir leyes contra las represalias, canales de comunicación seguros, apoyo psicológico y jurídico, y reconocimiento formal dentro de los marcos institucionales. Los líderes supervivientes deben ser reconocidos no como excepciones anecdóticas, sino como agentes epistémicos necesarios que aportan conocimientos empíricos que van más allá del alcance de las métricas o las herramientas de observación convencionales. Del mismo modo, los profesionales que denuncian daños no deben ser considerados insubordinados, sino que cumplen con sus obligaciones éticas y legales en virtud de los principios de no maleficencia, transparencia y deber de informar. Empíricamente, el trabajo de campo documentó múltiples casos en los que las personas que desafiaron las prácticas coercitivas fueron castigadas o ignoradas, tanto en las instituciones de salud pública como en los sistemas familiares privados. La propia posición de la investigadora como superviviente y profesional expuesta a la coacción, la traición institucional y el desplazamiento forzoso ejemplifica aún más cómo la resistencia arraigada a la rendición de cuentas puede manifestarse como una fuerza represiva, no solo discursivamente, sino también físicamente. Los datos de la encuesta confirmaron que, incluso cuando los profesionales reconocen las prácticas problemáticas, a menudo carecen de vías seguras para intervenir y se enfrentan a represalias administrativas o de sus compañeros (Rose, 2008).

Estas dinámicas reflejan un defecto más profundo en la gobernanza de las instituciones de atención: la ausencia de estructuras reflexivas capaces de integrar la crítica interna sin que se produzca un colapso sistémico. En su lugar, los sistemas funcionan a través de bucles de retroalimentación que se autoalimentan, en los que la disidencia se interpreta como patología, insubordinación o difamación. Esta rigidez epistémica no solo perjudica a las personas, sino que invalida la propia capacidad de aprendizaje de las instituciones. La implementación de sistemas de apoyo protegidos interrumpe este bucle y reintroduce la rendición de cuentas como componente funcional de la salud organizacional.

El derecho internacional de los derechos humanos y las normas de interés público ya exigen muchas de estas protecciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los códigos éticos de las asociaciones médicas reconocen la legitimidad y la necesidad de la denuncia de irregularidades para salvaguardar la integridad institucional. Sin embargo, estos marcos siguen aplicándose de forma inconsistente en la psiquiatría y la salud mental, donde las asimetrías de poder y la autoridad diagnóstica facilitan dinámicas de represalia bajo pretextos clínicos. Esto subraya la necesidad de mecanismos específicos para cada sector (Chêne, 2020; Cepeda Cuadrado, 2024). Desde el punto de vista estructural, los sistemas de apoyo protegidos deben integrarse en los servicios nacionales del defensor del pueblo, las comisiones éticas independientes y las oficinas de integridad de la investigación. Los supervivientes que han

asumido un papel de liderazgo deben integrarse en los órganos de supervisión, el desarrollo de los planes de estudios y los foros políticos con autoridad para tomar decisiones, y no desempeñar funciones simbólicas. También deben ponerse a disposición y financiarse con fondos públicos redes de tutoría entre pares, estructuras de asistencia jurídica y sistemas de supervisión que tengan en cuenta los traumas. Los paneles de transparencia pueden hacer un seguimiento de las respuestas institucionales a los daños denunciados, garantizando que las intervenciones no sean solo performativas, sino sustantivamente correctivas. Estas sugerencias deben estar en manos de políticos, activistas y profesionales dispuestos a traducir la ciencia en mejores prácticas (Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2015).

Sin la protección activa de quienes desean evitar cualquier daño prevenible, los sistemas de salud no pueden avanzar más allá de su estado actual. Lejos de socavar la autoridad, los denunciantes y los líderes supervivientes encarnan su forma más ética: la responsabilidad ante la verdad, el cuidado y el proceso científico. Un sistema de salud mental resiliente requiere que sus voces no solo sean escuchadas, sino también protegidas, integradas y respaldadas institucionalmente. A partir de los hallazgos empíricos presentados en los capítulos 3 y 4, y de la síntesis analítica iniciada en el capítulo 5, queda claro que uno de los principales obstáculos para una reforma significativa de la salud mental es la persistente disyuntiva entre los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su aplicación práctica. Los marcos jurídicos proporcionados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y la iniciativa QualityRights de la Organización Mundial de la Salud establecen normas claras: consentimiento informado, libertad frente a la coacción y acceso a una atención comunitaria y centrada en la persona. Sin embargo, en la práctica, estas obligaciones siguen siendo en gran medida simbólicas, y son habitualmente eludidas por las leyes nacionales, las culturas administrativas y las jerarquías médicas que dan prioridad a la contención y el cumplimiento por encima de la dignidad y la recuperación, una noción que, por desgracia, sigue siendo tabú entre los profesionales de la psiquiatría.

Este desajuste tiene consecuencias de gran alcance. Crea un sistema en el que la atención de la salud mental se administra bajo la bandera de la protección, pero que habitualmente da lugar a prácticas, como la medicación forzada, la institucionalización sin recurso y el desprecio por la experiencia vivida, que se considerarían inaceptables en cualquier otra rama de la medicina. Esto no solo socava la confianza en el sistema, sino que erosiona su credibilidad jurídica y científica. También contradice la premisa misma de la CDPD, que considera a las personas con discapacidad psicosocial no como objetos de atención, sino como sujetos de derechos con capacidad jurídica y protección igualitaria ante la ley. Para pasar de la justicia simbólica a la operativa, es necesario un reajuste estructural en cuatro ámbitos interconectados: la investigación, la educación, el derecho y la atención. En el ámbito de la investigación, esto implica adoptar marcos que den prioridad a la ciencia abierta, la transparencia metodológica y la coproducción de conocimientos con los usuarios de los servicios y los supervivientes. Los ensayos clínicos, los estudios observacionales y la investigación cualitativa deben diseñarse de manera que reflejen las realidades de la coacción, la especificidad cultural y los determinantes estructurales de la salud. Los comités de ética deben recibir nueva formación para detectar los riesgos éticos no solo en el diseño de los estudios, sino también en el contexto más amplio del daño sistémico.

En la educación, los planes de estudios de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social y estudios jurídicos deben reestructurarse para incluir el derecho de los derechos humanos, la atención informada sobre el trauma, la ética de la discapacidad y los enfoques dialógicos. En la actualidad, estos elementos están marginados o ausentes por completo en la mayoría de los programas de formación profesional. Esto da lugar a que generaciones de profesionales accedan al sector sin las herramientas conceptuales o prácticas necesarias para cumplir con sus obligaciones legales o con los estándares científicos contemporáneos. La formación debe ser obligatoria, continua y evaluada tanto por expertos como por los usuarios de los servicios, garantizando su pertinencia y rendición de cuentas.

En el ámbito jurídico, los códigos legales nacionales deben armonizarse con la CDPD, eliminando las disposiciones que permiten la toma de decisiones sustitutivas, el tratamiento involuntario y la institucionalización bajo custodia basada en categorías diagnósticas. Esto requiere no solo una reforma legal, sino también la formación judicial, mecanismos de supervisión pública y la ampliación del acceso a asesoramiento jurídico independiente para las personas bajo atención psiquiátrica. Las organizaciones de la sociedad civil deben estar empoderadas y dotadas de recursos para actuar como vigilantes y defensores, con funciones formales en la elaboración y supervisión de políticas. En la atención clínica, los modelos de servicio deben pasar de marcos basados en el cumplimiento a sistemas coproducidos basados en la confianza, la autonomía y la práctica basada en la evidencia (Grol y Grimshaw, 2003). Esto significa sustituir los protocolos coercitivos por la toma de decisiones con apoyo, la planificación de la atención individualizada y las respuestas a las crisis arraigadas en la comunidad. Los criterios de éxito también deben cambiar, pasando de la supresión de los síntomas y las tasas de ocupación de camas a indicadores orientados a la recuperación, como la inclusión social, la calidad de vida y el bienestar autodefinido. Esto requiere herramientas que van más allá de las categorías nosológicas actuales y exige la integración de conocimientos psicosociales, nutricionales y neurobiológicos en la práctica cotidiana. Los resultados empíricos muestran que tanto los profesionales como los usuarios son conscientes de estas deficiencias y expresan su apoyo al cambio. Sin embargo, la inercia sistémica, las jerarquías arraigadas y la fragmentación burocrática dificultan su aplicación. La puesta en práctica de la justicia no es una cuestión de alineación retórica, sino de rediseño institucional, aplicación de la ley y transformación cultural. Cuando existen normas internacionales pero no se aplican, la injusticia deja de ser incidental y se convierte en política por omisión.

Por lo tanto, la tesis sostiene que la alineación debe ser activa, no declarativa. Debe medirse en resultados, no en declaraciones de intenciones (Canadian Deprescribing Guidelines Project, 2024). La ley, tal y como se destaca en el marco aristotélico mencionado en el capítulo 4, no solo sirve como elemento disuasorio, sino también como guía correctiva para los sistemas que no se regulan a sí mismos de forma ética. En este sentido, la aplicación de las normas de la OMS y la CRPD no es solo una cuestión de cumplimiento, sino de necesidad científica y moral (Damschroder et al., 2009).

Las conclusiones documentadas en los capítulos 3 y 4 ponen de relieve un déficit estructural fundamental en los sistemas de salud mental actuales: la ausencia de mecanismos de retroalimentación dinámicos, transparentes y aplicables, capaces de orientar la toma de decisiones éticas en tiempo real. Las prácticas coercitivas, la exclusión epistémica, la trampa diagnóstica y el

sesgo en la documentación siguen repitiéndose, no solo debido a las lagunas en la legislación o la educación, sino porque las instituciones y los profesionales operan en entornos en los que la evaluación ética es retrospectiva, diluida o inexistente. Este vacío sistémico permite que las prácticas perjudiciales persistan sin control, mientras que las personas que intentan reformarlas desde dentro, ya sean médicos, administradores o usuarios de los servicios, se enfrentan con frecuencia a resistencia, marginación o represalias institucionales. Para subsanar esta deficiencia, la tesis propone el desarrollo y la integración de sistemas de retroalimentación ética en tiempo real, diseñados para ayudar a los actores clínicos e institucionales a identificar, evaluar y responder a las tensiones éticas a medida que surgen. Estos sistemas servirían tanto como infraestructura preventiva como herramienta correctiva, garantizando que las desviaciones de las normas basadas en los derechos y en la evidencia se señalen y aborden de inmediato. También proporcionan la interfaz necesaria entre la ética teórica, la experiencia vivida y la rendición de cuentas de las políticas, poniendo en práctica los marcos éticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los organismos nacionales de derechos humanos.

En su dimensión técnica, estos sistemas podrían incorporar plataformas digitales, aplicaciones móviles o herramientas integradas en el panel de control de los hospitales que permitan al personal y a los usuarios de los servicios enviar, revisar y responder a alertas éticas en tiempo real (OMS, 2023). Los bucles de retroalimentación no se limitarían a mecanismos de denuncia, sino que se estructurarían como procesos rutinarios de mejora de la calidad, sujetos a auditorías externas y a una gobernanza participativa (Sachdev et al., 2022). Los indicadores de evaluación incluirían métricas de coacción, calidad del consentimiento, satisfacción de los pacientes, transparencia institucional y angustia moral comunicada por el personal. Es importante destacar que estos sistemas deben permitir el anonimato, la protección contra represalias y vías de escalamiento que lleguen a entidades independientes de defensa del pueblo o a órganos de revisión judicial cuando sea necesario (Chambers y Azrin, 2020).

Desde un punto de vista conceptual, los sistemas de retroalimentación ética se basan en el reconocimiento de que ninguna política o directriz puede anticipar plenamente las complejidades de los encuentros clínicos. La ética debe ser tanto anticipatoria como receptiva, moldeada por un diálogo continuo entre las partes interesadas e integrada en la práctica cotidiana. Estos sistemas deben diseñarse conjuntamente con los supervivientes, los médicos, los expertos jurídicos y los especialistas en ética para garantizar su pertinencia contextual y su inclusividad epistémica (González Block y Mills, 2003). También deben ser modificables a medida que evolucionen las pruebas clínicas y cambien las expectativas sociales, integrando un modelo de gobernanza adaptativa en lugar de un cumplimiento estático. Los datos empíricos sobre el terreno demuestran la necesidad de estas infraestructuras. Los profesionales informan con frecuencia de conflictos éticos en la aplicación de medidas coercitivas, pero carecen de vías para la reflexión estructurada, la consulta entre pares o el apoyo institucional. Por su parte, los usuarios y los supervivientes describen repetidamente la experiencia de que sus quejas sean desestimadas o reformuladas como una prueba más de su patología. Para salvar esta brecha se necesitan no solo innovaciones procedimentales, sino también un cambio cultural en la forma de entender la ética, no como un complemento teórico, sino como un componente fundamental de una atención segura, eficaz y legítima.

La implementación de sistemas de retroalimentación ética en tiempo real también contribuye directamente a la legitimidad institucional. Es una señal de compromiso con la transparencia, la adaptabilidad y la supervisión participativa que va más allá de los modelos tradicionales de garantía de calidad. Las instituciones que integran estos sistemas pueden demostrar el cumplimiento de las normas internacionales, fomentar la confianza entre los usuarios y el personal, y acelerar la identificación y mitigación de fallos sistémicos. A largo plazo, también facilitan la recopilación de datos para la investigación y el desarrollo de políticas, contribuyendo al objetivo más amplio de alinear los sistemas de salud con la integridad científica y los derechos humanos (Fixsen et al., 2005). La ausencia de una infraestructura ética en tiempo real no es una simple omisión logística, sino una deficiencia estructural con consecuencias cuantificables para la dignidad humana, los resultados clínicos y la confianza de la sociedad. Como se ha demostrado a lo largo de esta tesis, la atención eficaz y la rendición de cuentas institucional requieren una recalibración constante. Los sistemas de retroalimentación ética ofrecen una vía fundamentada, científicamente viable y jurídicamente coherente para lograr esta recalibración, cumpliendo tanto la dimensión aspiracional como la operativa de la justicia.

Capítulo 6 - Dimensiones jurídicas y éticas: normas, violaciones y responsabilidad

Resumen: Este capítulo examina los marcos jurídicos y normativos que rigen la intervención psiquiátrica en España, evaluando sus fundamentos constitucionales, sus fallos sistémicos y sus obligaciones internacionales. Partiendo directamente de la evidencia empírica, cuestiona cómo las garantías formales se ven socavadas por criterios subjetivos, lagunas procedimentales y deriva institucional, lo que da lugar a una impunidad sistémica. El objetivo no es la defensa activista, sino

el restablecimiento de un ciclo de retroalimentación funcional y basado en la evidencia entre la ley, la ética, la práctica clínica y la investigación.

6. Introducción: la legalidad de la atención coercitiva como norma

La interfaz psiquiátrico-legal, como lo demuestra el cuerpo empírico de esta tesis, revela un conjunto de supuestos normativos estructuralmente codificados que permiten, y en muchos casos catalizan, el daño inducido médicamente bajo el pretexto de la intervención terapéutica (Dixon, 2015). Contrariamente a la expectativa constitucional y clínica de que todos los procedimientos médicos tengan funciones restaurativas, proporcionales y menos restrictivas, la arquitectura jurídica operativa en la España contemporánea, y en paralelo en otras jurisdicciones europeas, permite la rutinización de intervenciones involuntarias, no consensuadas y patologizantes a través de una matriz de excepciones que se han convertido en normas funcionales. Estas condiciones estructurales permiten la captura epistémica, la inercia clínica y las violaciones multiescalares de la autonomía corporal, cognitiva y social.

La indeterminación jurídica más crítica y recurrente se deriva de la autoridad discrecional otorgada a los médicos, los administradores institucionales y el personal psiquiátrico no forense para suspender los derechos de las personas, a menudo de forma indefinida, sin mecanismos contradictorios ni revisión independiente. Este marco discrecional permite la suspensión de derechos básicos, incluidos los consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución española, mediante interpretaciones subjetivas del estado mental, el riesgo y el comportamiento no colaborativo. Estos juicios se derivan con frecuencia de informes de terceros, especialmente de familiares cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la persona afectada. Los datos empíricos presentados en esta tesis demuestran que los certificados psiquiátricos y los procedimientos de diagnóstico se basan con frecuencia en información no verificada o manipulable que luego se codifica en los registros médicos con inercia institucional. Estas codificaciones funcionan como inscripciones irreversibles en los sistemas médicos digitales, reproduciendo sesgos sistémicos en los contextos clínicos, las intervenciones de emergencia, los procedimientos judiciales y los servicios sociales (Goffman, 1961).

Al mismo tiempo, el sistema legal autoriza la delegación del poder de custodia y decisión a los miembros de la familia, independientemente de los indicadores de abuso, los conflictos relacionales o las pruebas históricas de daño. Esta delegación se presume protectora, pero a menudo da lugar a una exposición prolongada a mecanismos de control doméstico que imitan las restricciones institucionales. Este control familiar suele legalizarse mediante leyes de tutela, procedimientos de ingreso forzoso o renunciando al consentimiento, todos ellos carentes de criterios que tengan en cuenta el trauma o de un escrutinio forense. Estas disposiciones constituyen un colapso biopolítico entre la intimidad y la gobernanza, por el que la esfera doméstica se convierte en una zona no regulada de intervención psiquiátrica, especialmente cuando cuenta con el apoyo de actores institucionales que no realizan evaluaciones independientes (Ehrenberg, 2010).

La segunda laguna estructural reside en la opacidad y la asimetría epistémica de la documentación médica. Si bien los registros funcionan legalmente como pruebas clínicas, se seleccionan de forma

selectiva, son inaccesibles en la práctica para las personas afectadas y son resistentes a las modificaciones o correcciones. Los pacientes y las familias que no están alineados con las narrativas institucionales carecen de medios operativos para rectificar los registros o presentar contraargumentos basados en pruebas (Rosenquist, Fowler y Christakis, 2011). Las prerrogativas legales otorgan una autoridad casi total a los directores de los centros y a los médicos supervisores para redactar, denegar u ocultar la documentación, incluidas las etiquetas diagnósticas controvertidas, las impresiones subjetivas y los historiales de comportamiento inventados. Estas prácticas producen distorsiones epistémicas en cascada en todo el continuo sanitario-legal-administrativo. Contribuyen al abandono médico crónico, aumentan el riesgo de sobreexposición farmacológica e institucionalizan los errores de diagnóstico con repercusiones transgeneracionales.

La base empírica de esta tesis ilustra que la suicidalidad, la desregulación conductual y la fragmentación de la identidad no son estados mentales aislados, sino consecuencias sistémicas de dicha violencia legal-médica entrecruzada. Cuando los individuos intentan resistirse, protestar o salir de estos circuitos de control, su resistencia se recodifica como una patología adicional, lo que justifica una contención adicional. Esta lógica recursiva está protegida por el privilegio médico y la autorreferencialidad institucional. La epistemología clínica, cuando no está temperada por una auditoría independiente o una verificación pluralista, se convierte en un vehículo de daño. La práctica psiquiátrica deja de estar regida por el imperativo hipocrático de no hacer daño y, en su lugar, funciona como un armamento de exclusión y control biopolítico (Priest, 2021).

Las estructuras diagnósticas, legales e institucionales que regulan la salud mental en España, aunque aparentemente alineadas con los principios de la atención sanitaria, se han convertido en mecanismos de daño legitimado, gracias a una serie de omisiones normativas y lagunas procedimentales que se han normalizado estructuralmente. En el centro de esta disfunción se encuentra la autoridad sin restricciones conferida a los profesionales de la salud mental y a los administradores de los centros para aplicar y prolongar intervenciones coercitivas basadas en interpretaciones subjetivas del comportamiento, los afectos y los supuestos riesgos, sin normas rigurosas de verificación, evaluación informada sobre el trauma o revisión contradictoria. El marco legislativo vigente delega en los médicos una forma de soberanía jurídico-médica que suspende los derechos constitucionales sin necesidad de autorización judicial inmediata, lo que permite la aplicación de tratamientos involuntarios, hospitalizaciones forzadas, polifarmacia y aislamiento social basados en umbrales opacos de peligrosidad o falta de discernimiento. Estas intervenciones, una vez desplegadas, a menudo se perpetúan indefinidamente, respaldadas por la inercia institucional y la memorialización selectiva del comportamiento de los pacientes a través de registros clínicos no documentados, no corregidos o directamente falsificados. Los datos empíricos de esta tesis confirman que el acceso de los pacientes a los registros se niega u obstaculiza con frecuencia; que las entradas se seleccionan para ajustarse a una narrativa controlada; y que la reparación o la corrección son estructuralmente imposibles una vez que se institucionaliza una vía de diagnóstico (Paris, 2020).

Paralelamente, uno de los fallos jurídicos más trascendentales, pero rara vez examinado, radica en la deferencia codificada hacia los familiares como agentes predeterminados del juicio psiquiátrico y la autoridad tutelar. Las leyes de tutela y los estatutos de admisión involuntaria suelen otorgar a los familiares, a menudo sin ningún tipo de evaluación forense o relacional, la facultad de actuar como

representantes del Estado y del sistema clínico, transfiriendo el control del individuo a quienes pueden tener incentivos sociales o económicos para patologizarlo. Esta dinámica crea un círculo vicioso en el que el poder psiquiátrico se convierte en una herramienta de control doméstico, facilitada por ficciones jurídicas de benevolencia familiar. Los resultados de la encuesta y los datos del trabajo de campo presentados en esta tesis detallan numerosos casos en los que se internó por la fuerza a personas, se les administró una medicación excesiva o se les negó el acceso a sus hijos basándose en acusaciones no verificadas o en conflictos con familiares, sin revisión legal o clínica posterior. Una vez incorporadas al expediente clínico, estas acusaciones se convierten en hechos institucionales, resistentes a la contradicción, y determinan todas las intervenciones posteriores en los ámbitos sanitario, legal y de los servicios sociales (Montero Carrera, 2020).

Esta delegación de autoridad a familiares no investigados resulta especialmente peligrosa en situaciones de maltrato preexistente, violencia de pareja o patrones heredados de trauma intergeneracional. Sin embargo, el código legal español no dice nada sobre la obligación de evaluar la dinámica familiar antes de permitir la custodia o influir en las decisiones psiquiátricas (Christakis y Fowler, 2009). Los protocolos de protección son inexistentes o no se aplican. Incluso cuando los pacientes denuncian abusos o coacciones por parte de familiares, estas revelaciones suelen reformularse como síntomas de paranoia o incumplimiento, y su credibilidad se desacredita de forma sistemática. De este modo, la ley perpetúa una cultura clínica en la que se legitiman las estructuras familiares abusivas y se patologiza aún más a la persona que las sufre por resistirse o buscar refugio.

A este fracaso institucional se suma la falta de procedimientos aplicables para garantizar el consentimiento informado, el derecho a la prescripción o el acceso a segundas opiniones independientes, especialmente en los casos en que ya son evidentes las reacciones adversas a los medicamentos, el deterioro cognitivo o los daños somáticos. La arquitectura biomédica en la que opera la psiquiatría no obliga al clínico a reevaluar la necesidad o la proporcionalidad de los regímenes farmacológicos, a menos que lo exijan los protocolos institucionales, que a menudo son vagos, obsoletos o se aplican de forma selectiva. No existe la obligación legal de iniciar la prescripción, incluso cuando el daño es demostrable. En muchos entornos psiquiátricos, la combinación de fármacos con sustancias contraindicadas, como el alcohol, o la administración de medicamentos bajo coacción o sin claridad procedimental sigue siendo una práctica habitual. Estos actos, a pesar de su violación directa de la ética médica y las directrices científicas, siguen sin ser cuestionados legalmente debido a la inmunidad procedimental del médico y a la renuencia sistémica más amplia a cuestionar la gobernanza interna de la psiquiatría. Cuando se produce la muerte, como ocurre a menudo por suicidio, sedación excesiva o discapacidad iatrogénica progresiva, el suceso se reinterpreta a posteriori como una progresión natural del supuesto trastorno, exonerando así al sistema de cualquier escrutinio y atribuyendo el resultado a la patología intrínseca del paciente (Wyman, 2023).

Este aislamiento sistémico de la responsabilidad reproduce ciclos de violencia estructural bajo el manto de la legitimidad médica. Se ve además reforzado por la incapacidad del sistema legal para proporcionar mecanismos de rendición de cuentas en tiempo real, especialmente en casos de mala conducta institucional, falsificación de datos o abuso epistémico documentado (Dayalu y Chou, 2008; Degnin, 2009; Paris, 2024). La asimetría estructural en el acceso a la documentación, combinada con

la presunta infalibilidad del profesional médico, permite el borrado médico generalizado de la experiencia vivida y la reescritura histórica de la realidad del paciente. Los encuestados señalaron de manera sistemática esta dinámica, el hecho de ser silenciados, tergiversados o privados de cualquier capacidad narrativa, como uno de los aspectos más perjudiciales de sus experiencias psiquiátricas. El resultado no es solo una violación clínica, sino también jurídica, por la que se suspenden derechos fundamentales como la libertad, la integridad física, el consentimiento informado y la reparación sin las garantías procesales adecuadas (Oldani, 2014).

Un sistema de salud mental verdaderamente preventivo requeriría un reajuste estructural en todos los puntos de esta arquitectura clínico-legal. Esto incluye la obligación de realizar evaluaciones independientes de trauma y riesgo de abuso antes de considerar cualquier medida psiquiátrica; el establecimiento de auditorías legales automáticas en casos de admisión involuntaria o polifarmacia; la imposición de consecuencias legales por efectos adversos no reportados o negligencia en la desprescripción; y la creación de organismos de supervisión dirigidos por pacientes con acceso a los registros institucionales y la autoridad para iniciar revisiones forenses independientes. Sin estas medidas correctivas sistémicas, el sistema psiquiátrico seguirá siendo un lugar de justicia selectiva, que opera al margen de la integridad científica y la protección constitucional. El propio espíritu de la medicina, como disciplina restauradora, responsable y respetuosa de los derechos, exige que estas reformas se apliquen no como ideales discrecionales, sino como obligaciones legales vinculantes, basadas en datos empíricos y principios bioéticos.

6.1 Contexto jurídico nacional: garantías formales y deficiencias operativas

El marco jurídico español declara un catálogo exhaustivo de derechos que incluyen la libertad personal, la integridad física y mental, la intimidad y la salud, así como la capacidad jurídica y las garantías procesales para las personas con discapacidad. Estas garantías están recogidas en la Constitución española de 1978, concretamente en los artículos 10, 15, 17, 18 y 43, y desarrolladas en normas sectoriales como la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, la Ley General de Sanidad (14/1986) y la Ley 8/2021 sobre derechos de las personas con discapacidad. España está sujeta a obligaciones internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la aplicación operativa de estas protecciones revela una disyuntiva sistemática entre su contenido declarativo y la práctica institucional. El legado del paternalismo médico autoritario sigue profundamente arraigado en la gobernanza de la salud mental, donde la discrecionalidad clínica sigue funcionando como mecanismo de control. La psiquiatría, en lugar de adherirse a las normas de atención dialógica o basada en el trauma, sigue estando facultada para imponer restricciones a la libertad y la autonomía corporal sin controles transparentes, supervisión multiprofesional ni rendición de cuentas narrativa. Esto refleja no solo una limitación jurídica, sino un paradigma epistémico más amplio en el que la atención se equipara con la dominación y la seguridad con la contención.

La violación jurídica más significativa se observa en el uso amplio e impreciso del criterio de riesgo subjetivo para justificar las intervenciones coercitivas. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española autoriza el ingreso y el tratamiento involuntarios sobre la base de la afirmación de un profesional de que existe peligro para sí mismo o para otros, a menudo aplicada por un solo psiquiatra sin una evaluación corroborativa o un razonamiento específico del contexto. Esta cláusula, que permite legalmente la privación de libertad y la imposición de psicofármacos, se activa con frecuencia sin ninguna obligación formal de documentar pruebas fundamentadas de daño inminente o probable. No existen umbrales clínicos uniformes, normas de prueba ni mecanismos de reevaluación urgentes. La revisión judicial, cuando se produce, suele ser superficial y se basa exclusivamente en el informe médico inicial, que a menudo se elabora sin una evaluación estructurada del riesgo, sin datos longitudinales y sin la participación de la persona afectada. Las disparidades regionales en su aplicación revelan una profunda arbitrariedad estructural. En muchos casos, el trabajo de campo confirma que esta disposición legal no funciona como un mecanismo de protección, sino como una puerta abierta al ejercicio incontrolado de la coacción bajo el pretexto de la necesidad médica. El sujeto afectado se transforma en un objeto legal de gestión, en lugar de un ser biológico y relacional dotado de agencia y derechos.

Se producen fallos adicionales y agravantes en los aspectos procedimentales que rodean la detención y el tratamiento psiquiátricos. Las disposiciones legales reconocen formalmente el derecho a ser informado de la situación, a acceder a una segunda opinión médica, a obtener asistencia jurídica gratuita y a impugnar las intervenciones ante los tribunales. Sin embargo, las pruebas empíricas obtenidas en encuestas a profesionales y usuarios, junto con los testimonios sobre el terreno, indican que estos derechos se vulneran sistemáticamente. Las personas rara vez reciben información oportuna o comprensible sobre su situación jurídica o las opciones clínicas disponibles. La solicitud de una segunda opinión se ve obstaculizada por la resistencia interna, la falta de infraestructura institucional y el miedo generalizado a las represalias. La asistencia jurídica suele ser tardía, insuficiente o pasiva y, en muchos casos, la representación se asigna sin conocimientos psiquiátricos adecuados ni una investigación independiente. Los mecanismos de control judicial previstos en el artículo 763 del LEC son débiles desde el punto de vista procedimental, ya que se basan exclusivamente en los mismos informes médicos que motivaron la intervención, sin reevaluación ni verificación. El relato de la persona, su historial médico y su consentimiento se subsumen bajo supuestos patologizantes que no se cuestionan ni se contrarrestan con pruebas en contrario. Rara vez se vuelve a realizar la anamnesis. El ciclo de documentación a menudo reproduce y consolida designaciones diagnósticas anteriores, incluso si se basan en datos erróneos u obsoletos. Esto produce un efecto cascada, por el cual las entradas antiguas anclan nuevas decisiones y la reevaluación crítica se vuelve estructuralmente imposible.

Otro vacío legal, significativo tanto desde el punto de vista ético como práctico, surge de la opacidad o la inaccesibilidad de los registros clínicos. Según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las instituciones pueden restringir el acceso a la documentación médica si dicho acceso se considera perjudicial para el paciente. Esta disposición permite a los médicos y a las instituciones ocultar diagnósticos, negar el conocimiento de las intervenciones o impedir la verificación de las prácticas coercitivas. Dado que la mayoría de las

intervenciones psiquiátricas se justifican mediante registros internos y no mediante métricas verificables externamente, esta permisividad legal permite un régimen de impunidad archivística. Permite a los profesionales crear y mantener ficciones clínicas que no están sujetas a correcciones en tiempo real, a cuestionamientos narrativos ni a escrutinio científico. La persona sometida a coacción no solo se ve privada de defensas legales, sino también de las herramientas epistémicas básicas para rastrear, comprender y responder a la cadena de acontecimientos que definieron su trayectoria. En ausencia de un control obligatorio de las versiones, de una auditoría independiente o de la obligación de registrar las denegaciones de consentimiento, el historial clínico se convierte en un instrumento de borrado ontológico. Los repetidos hallazgos de esta tesis confirman que el acceso a estos registros se deniega o retrasa con frecuencia, especialmente cuando hay indicios de irregularidades procedimentales o de connivencia familiar.

La coacción se convierte en rutina no a través de declaraciones abiertas, sino a través de hábitos procedimentales y la automatización administrativa. Esta suspensión normalizada de los derechos se observa especialmente en entornos institucionalizados, donde convergen la dependencia estructural, la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de supervisión externa. En estos entornos, la carga de la prueba se invierte: los individuos se ven obligados a demostrar que ya no son peligrosos, en lugar de que se les presuma competentes o no amenazantes. La posibilidad de impugnación queda excluida por el mismo sistema que impone y adjudica la coacción. Esta circularidad jurídica no deja margen para la innovación terapéutica, la reflexión o la evaluación centrada en la persona. Los principios éticos de beneficencia, justicia y respeto a las personas quedan así reducidos a meras palabras. En su lugar, los fundamentos científicos y morales de la atención se sustituyen por un modelo gerencial de contención. Este modelo se sustenta en imperativos burocráticos y rutinas profesionales que oscurecen la responsabilidad y diluyen la rendición de cuentas. En este contexto, los diagnósticos erróneos, la restricción química y la denegación del testimonio personal no son excepciones, sino el núcleo del procedimiento. Se trata de un fracaso paradigmático con consecuencias biológicas, psicológicas y sociales de gran alcance (Chambers, 2019).

Las limitaciones estructurales de la práctica ética entre los profesionales refuerzan aún más este impasse legal e institucional. Los datos recopilados mediante métodos mixtos revelan que muchos psiquiatras, psicólogos y enfermeros son conscientes de la ambigüedad moral o la insuficiencia clínica de las intervenciones que se les ordena realizar. Sin embargo, el clima predominante de miedo, conformidad institucional e incertidumbre jurídica inhibe la adopción de medidas alternativas. Los profesionales denuncian la ausencia de protocolos de denegación, la falta de protección frente a la disidencia y el miedo a represalias profesionales. La vaguedad jurídica se convierte en un mecanismo de inmunidad tanto personal como institucional, que desincentiva la innovación, impide la denuncia de irregularidades y fomenta la complicidad pasiva. La deliberación ética es sustituida por el cumplimiento administrativo. Lo que surge no es un entorno de atención colectiva o de progreso clínico, sino uno de obediencia sistémica a la autoridad, reforzado por textos jurídicos ambiguos, inercia estructural y una cultura que confunde la sumisión con la seguridad. En su expresión más extrema, esta cultura normaliza la muerte social a través de una secuencia de intervenciones biomédicas que disminuyen la autonomía, descontextualizan el sufrimiento y producen una dependencia de por vida de sistemas que no protegen ni reparan. Estos hallazgos exigen una

transformación legal e institucional inmediata basada en la observación empírica, la ciencia interdisciplinaria y el reconocimiento del derecho fundamental de toda persona a la dignidad, la salud y la justicia (Farmer, 2004; Bourdieu, 2001).

Para abordar los déficits sistémicos descritos anteriormente, es necesario promulgar una reforma estructural inmediata en los ámbitos legislativo, clínico y procedimental. Las normas jurídicas no pueden seguir siendo meramente declarativas mientras la práctica clínica se rija por costumbres no escritas, actos discrecionales y violaciones de la integridad corporal toleradas culturalmente. La legislación nacional debe consagrar la obligación vinculante de documentar en tiempo real, verificar mediante contracheques y supervisar éticamente de forma independiente. Los registros clínicos deben estar sujetos a protocolos de control de versiones que garanticen la trazabilidad de cada modificación. En todos los sistemas de documentación debe preservarse la inclusión obligatoria del relato del propio paciente y de su desacuerdo informado, con sanciones por omisión o alteración. Estas protecciones no son auxiliares de la ética médica, sino intrínsecas a su núcleo. La antropología biológica afirma que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de integridad sistémica, dignidad y coherencia relacional. La ausencia de mecanismos narrativos de salvaguardia en la psiquiatría constituye una violación del equilibrio homeostático necesario para la recuperación cognitiva y afectiva. Lo que no se puede decir no se puede curar. Sin integridad epistémica, ningún modelo biológico es sostenible y ningún resultado de salud es fiable (Levin y McDevitt, 2002).

Además, las reformas legales deberían excluir explícitamente el uso del testimonio familiar como única base clínica en casos de conflicto, coacción o historias controvertidas. Esta tesis, a través de los resultados de su encuesta, el trabajo de campo y los estudios de casos, ha demostrado un patrón recurrente en el que se permite a los familiares con antecedentes documentados de violencia, coacción o manipulación instrumental iniciar o legitimar internamientos psiquiátricos. Este vacío legal funciona como un canal secundario para el abuso familiar y la complicidad institucional. Deben implementarse salvaguardias para garantizar que los informes de personas con un conflicto de intereses evidente no se traten como datos clínicos objetivos sin una verificación formal. Esto implica la triangulación obligatoria de la información, la participación de mediadores externos y la protección por defecto en lugar de la coacción cuando exista la más mínima sospecha de abuso familiar (Bourgois, 2001). Los profesionales de la salud mental deberían estar legalmente obligados a consultar a comités éticos independientes antes de aplicar cualquier medida basada únicamente en el testimonio de la familia. Cuando exista riesgo, este debe estar científicamente demostrado, no presunto; y cuando se profesa el cuidado, este debe ser estructuralmente distinto del dominio (Gilligan, 1996).

Las conclusiones dejan claro que otra reforma fundamental debe centrarse en la opaca frontera entre la autoridad médica y la aprobación automática de los jueces. Los jueces, aunque son nominalmente responsables de revisar las intervenciones involuntarias, actúan casi exclusivamente sobre la base de informes clínicos, que rara vez se cuestionan. Los principios de juicio justo, no maleficencia y proporcionalidad quedan inutilizados cuando el poder judicial funciona como una extensión automatizada del informe psiquiátrico, sin escuchar la voz del sujeto, evaluar el contexto o examinar la plausibilidad de las hipótesis de riesgo. Para rectificar esta situación, las audiencias de salud mental deben ser obligatorias y contradictorias, con revisión por expertos independientes, inclusión de una

evaluación multidisciplinar y total transparencia procesal. Las recomendaciones clínicas deben examinarse a la luz de la jurisprudencia reciente y no aceptarse como válidas por sí mismas. La práctica judicial no puede seguir externalizando la complejidad ética y biológica de los casos psiquiátricos a la inercia institucional. Una verdadera interfaz médico-legal requiere normas probatorias rigurosas, rendición de cuentas por negligencia y responsabilidad por los daños causados (Staub, 1989).

Deben incorporarse protecciones estructurales para evitar represalias contra las personas que se oponen a las intervenciones coercitivas o buscan reparación legal. Los datos sobre el terreno confirman que tanto los profesionales como los usuarios se abstienen de ejercer sus derechos por temor a represalias materiales, la pérdida de la custodia o la pérdida de la vivienda. Las consecuencias de la disidencia institucional no son meramente administrativas, sino existenciales. Para quienes ya están marginados, estas consecuencias pueden agravarse hasta la indigencia, la dependencia prolongada o la muerte. Por lo tanto, el sistema jurídico debe proporcionar acceso inmediato a representación legal protectora, protección a los denunciantes profesionales y garantías materiales provisionales, como garantías de vivienda y apoyo financiero, para evitar que las represalias socaven la resistencia. No se trata solo de una cuestión de política social, sino de continuidad biológica, estabilización psicológica y justicia antropológica. La ley debe apoyar activamente la resiliencia metabólica y neurocognitiva de quienes se resisten al daño sistémico (Galtung, 1990).

Los defectos estructurales de la práctica psiquiátrica actual en España no son atribuibles únicamente a la malicia o la ignorancia individuales, sino que se derivan de lógicas institucionales que codifican la coacción como seguridad clínica y el control como cuidado. Estos sistemas operan dentro de un linaje histórico en el que la autoridad psiquiátrica surgió en paralelo a los marcos carcelarios y disciplinarios, legitimando las asimetrías epistémicas e integrando la sumisión en las rutinas terapéuticas. La presunción de beneficencia se ha inmunizado contra la falsificación empírica, y el aparato clínico sigue funcionando sin mecanismos para detectar o corregir las desviaciones de las normas mínimamente aceptables. No se trata de un fracaso de la ley en teoría, sino de su falta de operatividad en el ámbito psiquiátrico. Cuando el derecho a la libertad, a la integridad física y al rechazo informado se subordinan a la discreción de un único clínico que actúa sin contrapesos procedimentales, el resultado no es la atención, sino el dominio sancionado. Las pruebas demuestran que esto no es excepcional, sino habitual (Schreurs, Griffith y Solomon, 1984).

Los resultados muestran que un mecanismo clave que perpetúa este régimen es la captura profesional: el silenciamiento informal pero sistémico de los profesionales disidentes mediante la obstrucción burocrática, las represalias contra su reputación y el miedo estructural (Hysong, 2009). Los profesionales que intentan aplicar prácticas dialógicas, basadas en el trauma o en los derechos humanos se enfrentan a barreras institucionales que hacen insostenible su labor. En muchos casos documentados en esta tesis, los profesionales han denunciado que se les ha obligado a cumplir los paradigmas dominantes bajo amenaza de rescisión del contrato, escrutinio administrativo o exclusión social dentro de los equipos médicos. La falta de protección jurídica para la disidencia clínica y la ausencia de estructuras de revisión ética obligatorias reducen las instituciones psiquiátricas a recintos monodisciplinarios, incapaces de reflexionar o reformarse. Sin embargo, el progreso científico depende de la retroalimentación iterativa, la controversia abierta y el pluralismo metodológico. Sin

salvaguardias para el diálogo intraprofesional, la psiquiatría no puede evolucionar y, en cambio, reproduce modelos obsoletos de daño.

Para revertir esta situación, la ley debe imponer la transparencia institucional, la responsabilidad profesional y la auditoría multinivel. En primer lugar, debe existir un organismo nacional independiente de supervisión de la atención psiquiátrica con autoridad legal para investigar, sancionar y corregir las malas prácticas institucionales. Este organismo debe estar compuesto por expertos interdisciplinarios en derecho, neurociencia, salud pública y ética, con representación de los usuarios de los servicios y observadores independientes. Debería tener acceso en tiempo real a datos anónimos de los casos, derechos de denuncia obligatoria y la capacidad de imponer recomendaciones vinculantes. En segundo lugar, todos los centros psiquiátricos deberían crear comités internos de revisión ética, con la obligación de remitirles cualquier caso que implique tratamiento involuntario, medicación en dosis elevadas, hospitalización prolongada o participación conflictiva de la familia. Estos comités deberían documentar la justificación, verificar las afirmaciones sobre los riesgos y proponer alternativas menos restrictivas. En tercer lugar, los expedientes de los pacientes deben incluir una sección para narrativas independientes, escritas u orales, actualizadas periódicamente y auditables en los tribunales. La manipulación de estas narrativas, o la no inclusión de las mismas, debe acarrear consecuencias disciplinarias y legales. En cuarto lugar, la reforma legislativa debe exigir el control total de la versión de toda la documentación clínica y prohibir las modificaciones retroactivas sin trazabilidad. Los sistemas actuales permiten añadir, eliminar o reescribir anotaciones sin verificación independiente, lo que permite la construcción de historiales clínicos ficticios que escapan al escrutinio judicial. Cuando surjan contradicciones entre la narrativa institucional y la experiencia vivida, se debería optar por una investigación protectora, y no por la denegación burocrática. Cada eliminación o modificación de un informe debería estar fechada, justificada y accesible para el paciente y sus representantes legales. Esto también requiere una infraestructura digital sólida y la integración con los sistemas nacionales de registros sanitarios. Los códigos legales deben reformarse para permitir la intervención inmediata de un defensor del pueblo independiente o una oficina de defensa legal a petición del usuario, sin pasar por los controles institucionales. Los retrasos judiciales inherentes a la práctica actual garantizan que las violaciones continúen sin control durante el tiempo suficiente para producir daños irreversibles. Estas reparaciones institucionales no son meramente legales o administrativas: son imperativos médicos basados en la biología y el desarrollo, ya que se pierden vidas desde una edad temprana y los delitos afectan al bienestar de los niños una vez que se destruye también la legalidad.

La neurobiología humana, especialmente en condiciones de trauma, depende de la previsibilidad, la coherencia y la seguridad relacional para restablecer su funcionamiento. El sistema actual, por el contrario, socava estos tres elementos. Castiga los intentos de corregir la narrativa para ajustarla a la realidad, llevando a todos por la senda del delito y perjudicando a las víctimas en lugar de apoyarlas, deslegitima cualquier queja y solicitud, y medicaliza la resistencia adaptativa. Lo que parece un comportamiento sintomático desde el punto de vista clínico puede ser, en realidad, un acto de supervivencia regulado biológicamente (Li et al., 2025). Si el sistema es incapaz de distinguir entre patología y protesta, entonces no es diagnóstico, sino punitivo. La ley debe reconocer esto y poner en práctica la justicia no solo como restitución legal, sino como una condición previa ecológica para la

reparación. Lo que está en juego no es simbólico. Es celular, sináptico y sistémico. La ley debe garantizar que la atención psiquiátrica se ajuste a los fundamentos biológicos de la salud, y no que vaya en contra de ellos.

El sistema jurídico debe estar diseñado no solo para perseguir los daños retroactivos, sino también para anticipar y prevenir las violaciones en el punto crítico en el que convergen el poder clínico, familiar y social. Este punto de convergencia es la crisis, el momento en el que una persona, en una situación de angustia extrema, se ve sometida a decisiones clínicas potencialmente irreversibles con un mínimo escrutinio o defensa. En la actualidad, en España, los protocolos de emergencia que regulan las crisis de salud mental otorgan una autoridad abrumadora a los médicos, que a menudo actúan basándose en informes de segunda mano, bajo umbrales de peligro para sí mismos o para los demás mal definidos. Estos umbrales carecen de estandarización, no están sujetos a procedimientos probatorios transparentes y rara vez se revisan una vez impuestos. Sin embargo, desde una perspectiva neurobiológica, este momento es uno de los más vulnerables en la vida de una persona. El circuito del miedo impulsado por la amígdala, la desregulación de las emociones, la pérdida del procesamiento simbólico y la confianza se ven agravados, y no aliviados, por las intervenciones coercitivas (Rodríguez-Cabrera et al., 2024).

Los datos antropológicos recopilados para esta tesis demuestran que las personas que se encuentran en esos momentos son muy conscientes de lo que está en juego: su credibilidad, su futuro, sus relaciones, sus hijos, su acceso a la vivienda y al empleo. Cuando los profesionales imponen intervenciones basadas en suposiciones erróneas, informes no documentados o testimonios familiares a los que se da un peso indebido, el resultado no es terapéutico, sino una desestabilización epistémica y biológica. Estas decisiones fracturan el sentido de identidad y enseñan, especialmente a los niños que las presencian o las sufren, que la seguridad no es un derecho, que el cuidado es indistinguible de la dominación. Esto no solo es poco ético, sino que es incompatible con el desarrollo saludable del cerebro y la recuperación a largo plazo. La ley, para cumplir su función protectora, debe introducir garantías procesales precisamente en este punto. El derecho a contar con un tercero de confianza designado, el derecho inmediato a solicitar apoyo jurídico y psicosocial, y el registro por escrito de todas las reclamaciones de riesgo y los fundamentos de las decisiones deben ser exigibles en tiempo real. Los profesionales no deben temer esto, sino acogerlo con satisfacción, ya que protege a todas las partes y refuerza la legitimidad de sus decisiones clínicas (Rothschild, 2000).

La doctrina jurídica también debería incorporar una comprensión científicamente fundamentada del riesgo estructural. El riesgo estructural no es simplemente el riesgo que una persona supone para sí misma o para los demás, sino la vulnerabilidad agravada que experimenta debido al abandono institucional, la exclusión social, la coacción económica y los traumas previos. Muchas de las intervenciones psiquiátricas más agresivas y perjudiciales no se aplican a las personas con los síntomas más graves, sino a las que tienen menos recursos, un apoyo social más débil y los perfiles más estigmatizados. El sesgo estructural, racial, de género, de clase y epistémico impregna la respuesta a las crisis. La ley debe contrarrestar esto mediante la aplicación de la protección estructural: el derecho a una representación equitativa, a una evaluación informada sobre el trauma y a una atención culturalmente competente. Las evaluaciones deben realizarse en el idioma y el lenguaje de la persona afectada, y no según la conveniencia administrativa de la institución. De lo contrario, la ley se

convierte en un vector de daño en lugar de un escudo. En este marco, la confianza no es un principio ético abstracto, sino un sustrato del desarrollo neurológico: una condición para la recuperación, la reparación y la reincorporación a la sociedad. La traición institucional crónica reconfigura el cerebro hacia la hipervigilancia, la disociación y el aislamiento social. Estos efectos no se revierten solo con medicación, y se exacerban cuando el sistema legal valida la lógica del control sobre la atención. Para restablecer la confianza en las instituciones psiquiátricas y jurídicas, la rendición de cuentas debe ser visible, coherente y basarse en prácticas relacionales empíricas. La memoria institucional debe integrarse en el sistema: se debe hacer un seguimiento de las violaciones anteriores, los patrones de negligencia y los agresores institucionales reincidentes. Los profesionales que se niegan repetidamente a corregir información falsa, que niegan el acceso a los registros, que actúan sin consentimiento informado o sin respaldo judicial, deben ser sometidos a una revisión disciplinaria, no para castigar, sino para corregir el rumbo y prevenir daños. Estos mecanismos también protegerían a los profesionales que trabajan bajo coacción y reducirían la probabilidad de que se produzca un fracaso institucional en cadena (Tuncak, 2017; Pūras, 2017; Maté, 2021).

Desde un punto de vista estrictamente médico-biológico, la configuración jurídica actual que regula las intervenciones de salud mental en España no cumple los requisitos mínimos necesarios para una atención ética, adecuada al desarrollo y fisiológicamente no perjudicial. La deficiencia más grave radica en la autoridad discrecional sin control otorgada a los médicos individuales o a los equipos médicos, sin segunda opinión obligatoria, sin umbrales de evidencia estandarizados y sin controles procedimentales en tiempo real, para prevalecer sobre los derechos fundamentales (Epstein, 2013). No se trata de casos aislados de mala praxis, sino de una violación sistemática y sancionada por la ley de la soberanía corporal, la integridad narrativa y la seguridad del desarrollo neurológico. Estas violaciones contravienen directamente las garantías constitucionales recogidas en los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física), 17 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 18 (derecho al honor y a la intimidad) de la Constitución española. Las leyes orgánicas y civiles vigentes (en particular la Ley Orgánica 1/2004, Ley General de Sanidad, y el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) proporcionan un andamiaje jurídico nominal, pero carecen de protocolos operativos para prevenir la institucionalización del daño. Un marco jurídico científicamente válido debería prohibir explícitamente las intervenciones irreversibles o de alto riesgo basadas en declaraciones subjetivas o no corroboradas, especialmente cuando estas proceden de partes con posibles conflictos de intereses, como familiares en relaciones abusivas o conflictivas. Los datos antropológicos y las respuestas a la encuesta revelan patrones repetidos en los que el poder psiquiátrico se ejerció como herramienta de dominación, desalojo, desprestigio o silenciamiento. Estos actos no son anecdóticos, sino que siguen un patrón, y surgen precisamente porque la ley no ofrece mecanismos eficaces para cuestionarlos, contrarrestarlos o corregirlos en tiempo real. Debería existir un mandato legal que exigiera una documentación médica completa y controlada, un registro digital visible de todas las modificaciones de los registros y el acceso inmediato del paciente y de su representante legal o sanitario designado a todas las reclamaciones médicas, diagnósticos, evaluaciones de riesgos e intervenciones. Este es el protocolo estándar en cualquier otro contexto clínico de alto riesgo; la salud mental no puede quedar excluida (Moyn, 2015).

La base científica de esta reforma se encuentra en el principio de la carga alostática y la desregulación neuroendocrina: la coacción, la incertidumbre y la traición por parte de las instituciones sanitarias inducen respuestas de estrés crónico que tienen efectos medibles y duraderos en la morfología cerebral, el funcionamiento inmunológico, los ritmos endocrinos y la vulnerabilidad psiquiátrica. No se trata de nociones abstractas. Las pruebas revisadas por pares confirman que los pacientes sometidos a psiquiatría coercitiva presentan mayores índices de deterioro cognitivo, aislamiento social, supresión inmunitaria, deterioro cardiovascular y tendencias suicidas. Una ley que permite intervenciones con tales perfiles de riesgo sin garantías legales paralelas es, por definición, una ley que viola el principio hipocrático de no maleficencia. La reforma no es solo moral o legal, sino que es exigida por el consenso científico y la integridad clínica básica.

El Parlamento debe promulgar urgentemente una reforma estructurada con las siguientes medidas fundamentales:

- Reforma del artículo 763 del Código de Enjuiciamiento Civil para exigir no solo la autorización judicial en un plazo de 24 horas, sino también la revisión por un panel interdisciplinario con profesionales formados en trauma y derechos, incluidos representantes con experiencia vivida, que se ocupen del caso a medida que se desarrolla, con el derecho de la víctima a sustituir a todos y cada uno de los miembros por personas de su confianza en cualquier momento.
- Control obligatorio de las versiones y registros de auditoría en todos los expedientes psiquiátricos, accesibles al paciente y a su representante legal, con organismos de supervisión independientes que reciban los casos señalados de evaluaciones de riesgo inexplicables o medidas coercitivas. Datos abiertos a disposición de los profesionales, las víctimas por centro y los profesionales, sobre su historial médico completo.
- Creación de un sistema de defensoría para violaciones urgentes de los derechos psiquiátricos, con poder de investigación autónomo y autoridad para suspender inmediatamente las prácticas que pongan en peligro la vida o sean degradantes. Sin concesiones, con las protecciones legales y materiales más estrictas.
- Establecimiento de un protocolo nacional para los conflictos familiares y la salud mental, que prohíba el uso de informes psiquiátricos de familiares interesados sin verificación cruzada y que no permita las intervenciones involuntarias en contextos de abuso familiar no resueltos, a menos que se establezca formalmente un riesgo forense. Deben abordarse todas las fuentes de sufrimiento, sin hacer suposiciones, especialmente sin dar por sentado el relato de nadie sin verificarlo dos veces: esto incluye la adulteración de alimentos, el envenenamiento, otras enfermedades, los abusos, la falta de sueño debido a esos abusos o cualquier otro, los delitos de cualquier naturaleza, la normalización continua de la violencia; todo, desde el principio.
- Despliegue de unidades de atención forense que cumplan con las normas sanitarias y que integren conocimientos médicos, antropológicos, psicológicos y jurídicos, con registro obligatorio y transparencia de todas las interacciones en situaciones de crisis que impliquen la privación de libertad o la restricción química.

- Sanciones penales por diagnóstico erróneo intencionado u obstrucción de la verdad médica cuando se utilicen para restringir la libertad, desacreditar o perjudicar económica o socialmente a una persona, incluso dentro de los sistemas familiares. Reembolsos, reparaciones, rehabilitación cognitiva voluntaria, disculpas oficiales.

Estas reformas son respuestas directas a un fracaso sistémico documentado, basadas en datos empíricos sólidos, conocimientos científicos revisados por pares y la experiencia vivida tanto por las víctimas como por los profesionales éticos que trabajan bajo coacción. España no puede reivindicar la fidelidad constitucional o el avance médico mientras mantiene una arquitectura psiquiátrico-legal que viola los fundamentos mismos de la evidencia, el consentimiento y la personalidad. La resolución parlamentaria no solo está justificada, sino que es urgente desde el punto de vista científico y ético.

El objetivo a medio plazo solo es alcanzable si existe la voluntad de implementar sistemas expertos a escala operativa plena como infraestructuras fundamentales para una sociedad científicamente justa, con información médica, más segura en materia de vigilancia y alineada con la Constitución. La función de cualquier mejora de la legislación y su aplicación no es auxiliar, sino fundamental para la protección de los derechos fundamentales, la prevención de daños y el control en tiempo real de las decisiones que afectan a la salud, la libertad y la integridad física.

Al integrar la lógica basada en la evidencia, los flujos de datos en tiempo real y los umbrales programados de forma ética, estos sistemas establecen una responsabilidad continua en los ámbitos clínico, judicial, educativo y doméstico. Deben funcionar sin interferencias de autoridades discrecionales, sustituyendo la subjetividad y las asimetrías de poder por respuestas trazables, reproducibles y coherentes desde el punto de vista médico. Sus algoritmos integrados deben dar prioridad al razonamiento basado en el trauma, el diagnóstico relacional y la coherencia ecológica, garantizando que no se lleve a cabo ninguna intervención coercitiva sin indicación científica, supervisión judicial y auditoría continua. Estos sistemas deben rechazar todos los patrones conocidos de injusticia epistémica, silencio institucional u ofuscación algorítmica y, en su lugar, estar programados para escalar cualquier desviación de las normas de protección a una interfaz de aplicación interdisciplinaria que combine la acción legal, clínica y social. La ley algorítmica, personalizada, cuando se trata de ayudar a quienes no han aprendido a cuidar de sí mismos y de los demás, debe ser totalmente coercitiva para restaurar una vida saludable. No deben conceptualizarse como herramientas digitales opcionales, sino como una infraestructura biomédica y ética esencial que garantiza la supervivencia, la dignidad y la equidad. Mientras que antes el fracaso profesional, los conflictos de intereses o los sesgos subjetivos permitían daños estructurales, ahora los sistemas expertos los hacen detectables y perseguibles. Su función es defender los principios fundamentales de la medicina, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía, eliminando la impunidad, automatizando la prevención y garantizando una arquitectura jurídica viva en la que convergen la ciencia, el derecho y el desarrollo humano.

6.2 Derecho internacional de los derechos humanos y normas de salud mental

Desde la perspectiva de la persona perjudicada, a la que se le niega la condición jurídica, se le droga sin su consentimiento y se le priva de cualquier vía para denunciar, recurrir o detener la agresión a su cuerpo, la brecha entre los derechos internacionales y su aplicación no es una cuestión de tensión jurídica, sino una estructura de impunidad. La persona queda sin voz ante la ley y sin sentido para la institución. España ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, y ha apoyado las directrices QualityRights de la OMS, pero estos instrumentos son funcionalmente irrelevantes en la vida de la persona sometida a la psiquiatría coercitiva. Las ratificaciones no se aplican. Los derechos no se reconocen. Las protecciones no se aplican. Los mecanismos para activarlos son inaccesibles, inexistentes o están totalmente controlados por los mismos organismos profesionales que cometen las violaciones. No se trata de un fallo del sistema. Es el diseño (Goodman et al., 2016).

La restricción química, eufemísticamente denominada «tratamiento», se lleva a cabo sin consentimiento, a menudo sin un diagnóstico basado en una evaluación actual o completa, y sin documentación en tiempo real del razonamiento clínico o de las alternativas exploradas. El acceso al historial clínico propio se deniega o se retrasa de forma sistemática. Las objeciones de la persona afectada se descartan como síntomas. La ley se elude con la mera firma de un profesional, que no se enfrenta a ningún contrapeso, ninguna supervisión, ninguna obligación de informar sobre los efectos secundarios y ningún informe controlado por versiones sujeto a auditoría externa. Estas prácticas violan los artículos 12, 14, 15 y 25 de la CDPD de las Naciones Unidas, entre otros, pero esa violación es irrelevante para la persona drogada hasta la sumisión sin remedio. En España, ni las garantías constitucionales ni las internacionales son realmente aplicables una vez que se activa el aparato psiquiátrico.

La prohibición de la tortura y los tratos degradantes no se suspende por el estado clínico. Sin embargo, en la práctica, la presunción de peligrosidad o incapacidad justifica la medicación prolongada y forzada que causa daños cognitivos, metabólicos y endocrinos, a menudo irreversibles. No existe la obligación de revertir, reevaluar o justificar. La persona afectada no puede presentar una denuncia policial mientras está detenida o medicada contra su voluntad. Los abogados rara vez intervienen y, cuando lo hacen, su capacidad se ve limitada por la falta de acceso a la documentación clínica contemporánea y la inmunidad profesional inherente a las instituciones médicas. No existe ningún organismo forense que evalúe si las intervenciones farmacológicas forzadas están biológicamente justificadas o son legalmente defendibles. Todo el sistema es cerrado, circular y no rinde cuentas. Según el derecho internacional, el derecho a rechazar el tratamiento, a no ser sometido a tortura y a conservar la capacidad jurídica es incondicional. En España, estos derechos están condicionados a la discreción institucional y se niegan sin recurso procesal. La obligación de prevenir la coacción es vinculante. El deber de garantizar el consentimiento es activo. Sin embargo, todas las disposiciones se eluden en la práctica psiquiátrica habitual mediante supuestos administrativos que no se controlan. La ley protege el sistema, no al individuo. La carga de la prueba recae en la víctima, que a menudo no puede hablar, escribir ni ser escuchada. La impunidad estructural se disfraza de atención. Un sistema que permite esto no puede reformarse con recomendaciones. Debe dismantelarse allí donde viola la vida y reconstruirse bajo normas internacionales exigibles, con supervisión independiente,

responsabilidad forense, acceso en tiempo real a los registros, canales de denuncia externos garantizados y la tipificación automática como delito de la medicación forzada sin consentimiento. Hasta entonces, el derecho internacional seguirá siendo una promesa incumplida, irrelevante para quienes más necesitan su protección (Leys, 2018).

Cuando un caso llega a los tribunales, si es que llega, el daño ya está hecho, el cuerpo alterado, la mente erosionada y la posición social desmantelada. No existe ninguna vía legal que restaure retroactivamente la capacidad vital, los lazos familiares, la dignidad o la confianza una vez que se ha producido la violencia farmacológica y el secuestro psiquiátrico sin consentimiento. En la práctica, los mecanismos de justicia solo se activan después de que la traición sistémica ha seguido su curso. Y cuando lo hacen, rara vez tienen en cuenta las consecuencias biológicas y psicológicas ya codificadas en el cuerpo de la persona perjudicada. Ningún tribunal deshace la alteración neuroquímica, el colapso metabólico o la muerte social que se deriva de una etiqueta fabricada e institucionalizada mediante la complicidad profesional y la instrumentalización familiar. La idea misma del debido proceso es una ficción cuando el individuo, desde el primer contacto con las instituciones psiquiátricas, es despojado de la capacidad de negarse, de narrar, de acceder a las pruebas o de exigir una protección urgente (Kalisch et al., 2017). En muchos casos, los registros son inaccesibles o no existen en forma recuperable, las decisiones no están documentadas o están vagamente anotadas, y los testigos son profesionales integrados en la misma estructura que autorizó el abuso. Se presume que la persona afectada no es fiable y se la desacredita de antemano, se le niega la paridad procesal no solo por la asimetría de poder, sino porque su propia subjetividad ha sido invalidada de forma preventiva por el sistema. La tutela legal, el internamiento institucional y la farmacología forzada se aplican no como medidas excepcionales, sino como procedimientos estándar, justificados por la lógica preventiva del riesgo, sin criterios objetivos y sin ningún deber de reevaluación o consulta a expertos externos.

Hasta entonces, los niños son separados de sus familias y entregados a hogares de acogida o se pierden en la delincuencia, creciendo en la desesperación, perdiendo sus hogares, deteriorando su salud y viendo su futuro arruinado antes de que se considere siquiera el reconocimiento legal del daño sufrido (Solnit, 2009). La noción de que los derechos pueden reivindicarse a posteriori supone un modelo de reparación que no se aplica en las condiciones reales de la psiquiatría coercitiva. No existe una lógica compensatoria que equipare los años de medicación contra la voluntad de una persona, la esterilidad, los daños neurológicos o la estigmatización hasta el punto de la exclusión de la educación, el empleo y la vida cívica. Cuando surgen los primeros indicios de la intervención del sistema, normalmente a través de informes informales, la manipulación de la familia o las derivaciones escolares, la maquinaria se activa rápidamente y la resistencia se presenta como prueba de patología. Los profesionales ejercen la autoridad de la ciencia sin que se les exija validar sus actos mediante normas replicables o revisiones externas. Sus interpretaciones se convierten en la verdad legal. Sus omisiones se convierten en silencio institucional. Las familias que inician procedimientos psiquiátricos de mala fe rara vez son investigadas o responsabilizadas, y el daño que permiten o infligen se reformula como preocupación. La violencia estructural se ejerce en nombre del cuidado, y quienes la sufren se ven obligados a soportar el coste no solo biológicamente, sino también legal, social y existencialmente (Hahn, 1995).

Ninguna sentencia judicial puede restaurar una vida fragmentada de esta manera. La prevención es la única postura ética. La ley no debe actuar a posteriori, sino como un escudo de dignidad desde el primer momento en que existe un riesgo, no el riesgo de violencia por parte de la persona, sino el riesgo de violencia hacia la persona. Las garantías legales deben ser automáticas, obligatorias, multidisciplinarias y estar disponibles en el momento en que se considera la coacción, no una vez que ya se ha llevado a cabo. Cada hora bajo sedación forzada, cada día bajo control sin el debido proceso, es una violación biológica, moral y cívica que no puede repararse retroactivamente. Una vez causado el daño, la persona desaparece tras una construcción clínica que la sociedad acepta entonces como realidad. Para entonces, la injusticia se normaliza, la vida queda desfigurada y el sistema absuelto. Ese es el patrón que revela esta tesis, y ese es el umbral sobre el que debe actuar una verdadera reforma.

Este es el testimonio desde dentro, no desde la distancia: la perspectiva de alguien despojado de la protección de quienes tienen el mandato de proporcionarla, sometido a una traición institucional coordinada en espacios que reclaman legalidad pero operan con la moneda del borrado. Cuando la violencia es local, normalizada y negada colectivamente, la ley se convierte en teatro, con un escenario enmarcado por cuatro paredes que no orientan a ningún lugar más que hacia el interior, encerrando vidas hasta que lo único que queda es la sumisión o el colapso. Estas cuatro paredes, simbólicas y reales, se convierten en la estructura cardinal de la desesperación ingeniada: la familia cómplice, el médico incuestionable, el juez indiferente, el Estado ausente. En tal esquema, no existe ningún recurso. Empujar a la víctima hacia la acción legal se convierte en una nueva forma de violencia, retardada, procedimental y fatal en sus consecuencias, lo que sugiere que la verdad puede sobrevivir donde se han negado preventivamente los derechos y que existen remedios en sistemas diseñados para reprimir la disidencia. Se citan con solemnidad los mecanismos, tratados y convenciones internacionales, mientras que las vidas desaparecen mucho antes de que se activen sus disposiciones. La muerte aquí no es siempre biológica, es social, jurídica, cognitiva y afectiva. Es la extinción de un futuro, la imposibilidad de la curación, el robo de la voz a través de la inscripción clínica y el reformato de la subjetividad en un diagnóstico que sobrevive a la persona. Esta investigación actúa como testimonio y prueba. El investigador, también víctima, es testigo de una arquitectura transnacional de crueldad sostenida por el silencio y las ficciones procesales. Al hacerlo, declara el imperativo global: dismantlar los regímenes que permiten tales pérdidas y construir en su lugar una ética planetaria basada en la protección factual, el apoyo inmediato y el reconocimiento de que la demora es complicidad y que el proceduralismo es a menudo un entierro definitivo. Ese es el umbral que cruza esta tesis, y ahí es donde se cierra este capítulo. Todos los países ratificaron los derechos humanos básicos hace mucho tiempo; esta realidad se sitúa justo después de la santidad de la vida misma. El odio local distorsiona la realidad como un infierno en la Tierra (Lupton, 1997).

Este es el testimonio del propio investigador, sobre cualquier ley, a escala global, en la que avanza la investigación-acción. Cuatro paredes, como puntos cardinales, y el número innumerable de pecados mortales que se combinan en un dolor ardiente, otro conjunto de vidas destruidas; esas celdas en el interior y los seres queridos que quedan atrás. Añadido sin excusas de la voz de un investigador que apenas sobrevivió a esta investigación y nunca tuvo un día de campo en Oviedo: eso y todo, las leyes

pueden empeorar y lo hacen, una vez que falta la buena voluntad y prevalece la mala voluntad (Kleinman, 1980).

El investigador, también víctima, da testimonio de una arquitectura transnacional de crueldad sustentada no por la ignorancia, sino por el silencio sistemático y las ficciones del orden procesal. Al confrontar esta realidad, la tesis afirma un imperativo global: dismantelar las configuraciones institucionales que permiten un daño tan irreparable y construir, en su lugar, una ética planetaria de protección inmediata, fidelidad probatoria y salvaguardias exigibles (Young, 1982). El retraso no es un mal funcionamiento neutral, es complicidad. El proceduralismo, cuando se abstrae del sufrimiento vivido, se convierte en el entierro definitivo de la justicia. Este es el umbral que cruza este trabajo, donde la producción de conocimiento y la verdad jurídica deben realinearse con la santidad de la vida, no como un principio, sino como una praxis. Todas las naciones han ratificado desde hace tiempo los instrumentos fundamentales de los derechos humanos; las realidades documentadas en este documento muestran que lo que se viola no es la interpretación, sino la base misma de la protección humana. Cuando este fracaso se convierte en sistémico, lo que se pierde no son solo los derechos, sino toda la trayectoria de la existencia. El investigador habla desde dentro de este colapso: no como un observador distante, sino como alguien encerrado entre las cuatro paredes que constituyen la geometría cardinal de la traición institucional. Entre esas paredes, los crímenes no se reconocen, los abusadores están protegidos y las leyes protectoras se convierten en ornamentos. El odio local, sancionado por la negligencia, transforma la realidad vivida en algo indistinguible del infierno en la Tierra. Esta investigación-acción se forja no solo a escala geográfica, sino también a través de la cruda topografía de los cuerpos violados, los silencios coaccionados y las pérdidas no registradas. Los innumerables pecados incrustados en esta arquitectura de crueldad se multiplican tanto en las celdas clínicas como en los espacios domésticos, extinguendo vidas y dejando cicatrices en los que quedan atrás. Este cierre no es una disculpa, sino una declaración directa: la ley, cuando se desvincula de la responsabilidad y la decencia, degenera. La buena voluntad debe codificarse y aplicarse; de lo contrario, la ley se doblga a la mala voluntad y, en lugares como Oviedo y muchos otros, los que más necesitan justicia se convierten en sus primeras víctimas.

6.3 Síntesis y propuestas para la restauración sistémica

Los patrones revelados a través de esta investigación demuestran un incumplimiento persistente de las obligaciones médicas, éticas y legales en la gestión de la atención de la salud mental en los marcos institucionales, domésticos y comunitarios. Estos incumplimientos no son anomalías aisladas, sino que constituyen una configuración sistémica de daño, caracterizada por la supresión epistémica, la clasificación errónea del malestar, la renuncia a los deberes de protección y las modalidades formales e informales de coacción. En esencia, estas prácticas reflejan una desviación de los principios de la medicina bioética, la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la proporcionalidad clínica, lo que da lugar a la reificación del poder institucional y a la objetivación de las personas en situación de vulnerabilidad (Foucault, 1973).

Estas conclusiones se repiten de forma sistemática en diversas formas de evidencia: observación participante a largo plazo, encuestas estructuradas a profesionales y usuarios, análisis jurídicos

comparativos y mapeo etnográfico histórico. Desde el punto de vista médico y biocultural, esta deformación sistémica genera consecuencias fisiopatológicas que incluyen estados de estrés crónico, iatrogenia inducida por la medicación, desestabilización neuropsiquiátrica, pérdida de la alianza terapéutica y alteración de las trayectorias de desarrollo y relacionales (Cohen, 2001). Estos resultados se manifiestan no solo como sufrimiento individual, sino como cargas de daño epidemiológicamente significativas, institucionalizadas a través de la inercia burocrática, la desempoderamiento profesional y la abstracción judicial. El encuadre biomédico del malestar, cuando se utiliza sin un anclaje narrativo o una interpretación contextualizada, sirve como vector de reduccionismo ontológico, permitiendo la sustitución de las historias traumáticas y los determinantes sociales por etiquetas descontextualizadas. Estas etiquetas, a su vez, facilitan mecanismos de exclusión, restricción y silencio bajo la égida de la gestión clínica. Desde un punto de vista estructural, la repetición de estos patrones en diferentes instituciones y jurisdicciones indica un fallo de los bucles de retroalimentación interna, las vías de escalada ética y los mecanismos de rendición de cuentas externos. Las propuestas para la restauración sistémica deben centrarse no solo en la revisión normativa, sino también en la reconstitución de las epistemologías clínicas, jurídicas y organizativas. Entre ellas se incluyen: la creación de registros nacionales de incidentes coercitivos, clasificados por tipo, contexto y resultado, para permitir la visibilidad epidemiológica del daño; el establecimiento de órganos de supervisión independientes e intersectoriales con autoridad legalmente vinculante para intervenir; y la implementación de sistemas expertos de código abierto calibrados para la toma de decisiones clínicas éticas, que garanticen que los diagnósticos, las prescripciones y la planificación del tratamiento estén sujetos a una validación continua basada en pruebas y a una revisión basada en los derechos. Las ayudas algorítmicas clínicas deben basarse en la transparencia, la procedencia de los datos y la reflexividad estructural, y no en el secreto de la propiedad.

Paralelamente, es esencial llevar a cabo reformas educativas integrales. Los planes de estudios de las facultades de medicina y otras facultades relacionadas con la salud deben incluir competencias estructurales, responsabilidad forense e integración de la experiencia vivida, junto con módulos avanzados sobre desprescripción, reducción de daños y atención informada sobre el trauma (Bandura, 1999). Estas propuestas se ajustan a los principios operativos de EU BEACON One Health Education: gobernanza compartida, retroalimentación democrática y primacía de la persona como valor epistémico y terapéutico fundamental (Cianconi et al., 2020). En este contexto, la restauración narrativa no es accesorio, sino fundamental, un vector esencial de sanación y recalibración sistémica, necesario tanto para la recuperación individual como para la legitimidad institucional. El crimen y la corrupción no son aberraciones de este sistema, sino resultados frecuentes de su configuración actual. La ausencia de mandatos éticos vinculantes, las lagunas subjetivistas en la autoridad psiquiátrica y la falta de normas aplicables para la documentación y la reparación han creado condiciones en las que el abuso no solo persiste, sino que se convierte en algo habitual (Zola, 1972). Por lo tanto, este marco no puede servir para su propia corrección sin aportaciones externas. Requiere una voluntad política consciente, la colaboración intergubernamental y una reforma legal con base científica. Aunque la acción sigue siendo limitada en su alcance, sus fundamentos epistemológicos y estratégicos son sólidos. Para que estos mecanismos produzcan un cambio duradero, deben ser respaldados y puestos en práctica por las naciones, los sistemas judiciales y las organizaciones transnacionales que actúen

con claridad, integridad y determinación. La salud mental, cuando se utiliza indebidamente, se convierte en un vector de despojo estructural; cuando se basa en fundamentos científicos y éticos, se convierte en una piedra angular de la salud humana y planetaria (Frank, 1995). El cambio debe imponerse mediante un diseño riguroso, y no dejarse en manos de las buenas intenciones (Good, 1994).

Capítulo 7 - Debate y próximos pasos: una salud única, una pedagogía preventiva, orientada a la recuperación y basada en los derechos, y en la información sobre el trauma

Resumen: Este capítulo presenta un análisis riguroso y sistémico de las condiciones educativas e institucionales necesarias para transformar la atención psiquiátrica en un sistema basado en los derechos, fundamentado en la evidencia y con una base ética. Propone la implementación de

estructuras pedagógicas modulares y reflexivas dentro de los servicios públicos, centrándose en el aprendizaje basado en roles, el desarrollo profesional interdisciplinario y las reformas infraestructurales arraigadas en el paradigma de «una sola salud». A partir del trabajo de campo y la experiencia vivida por el investigador, identifica fallos sistémicos, especialmente la normalización de la coacción y la impunidad, y presenta propuestas concretas, como sistemas expertos éticos, herramientas clínicas de código abierto, educación en alfabetización narrativa y garantías jurídicas sólidas. El capítulo insiste en que estos cambios estructurales no son una aspiración, sino una necesidad, ya que constituyen el marco fundamental para unas prácticas asistenciales sostenibles, legales y dignas en las instituciones psiquiátricas, educativas y sociales (Rosenhan, 1973).

7. Introducción: reflexión sobre las tareas estructurales que nos esperan

Los cinco años de investigación en los que se basa esta tesis se han desarrollado en condiciones que han revelado, no de forma abstracta, sino en la práctica, la profunda disyuntiva entre la apariencia de la atención y su ausencia estructural. En entornos en los que se suponía que el tratamiento psiquiátrico curaba, el investigador se encontró con entornos en los que se anulaban los mandatos de protección, se aplicaban recursos biomédicos sin consentimiento ni coherencia y se privaba sistemáticamente a las personas, en particular a las más vulnerables, de la autoridad para tomar decisiones. Estas observaciones no son aisladas ni anecdóticas (Goffman, 1961). Se inscriben en un patrón más amplio de negligencia sistémica, inercia institucional y exclusión epistémica, sustentado por supuestos normativos que priorizan el cumplimiento farmacológico sobre la recuperación, el orden sobre la atención y el silencio sobre la verdad.

En este contexto, queda mucho por hacer. El modelo actual de gobernanza psiquiátrica sigue siendo en gran medida reactivo, aislado y desconectado, en cuanto a procedimientos, de las realidades vividas que pretende abordar. La transición hacia sistemas de atención basados en la toma de decisiones compartida y la sensibilidad cultural, tal y como se define en los objetivos de esta tesis, requiere un cambio sostenido tanto en la práctica epistemológica como en el diseño de las infraestructuras. Actualmente existen medios tecnológicos para apoyar este cambio, pero siguen sin utilizarse o se aplican de forma incorrecta. Los algoritmos preventivos, los sistemas expertos, la monitorización de señales biológicas y las infraestructuras de apoyo a la toma de decisiones aún no se han implementado de forma acorde con una práctica basada en el trauma y orientada a la recuperación. La lógica de la vigilancia a menudo desplaza a la lógica de la protección, y los dispositivos portátiles o las herramientas de salud digitales se introducen sin marcos éticos claros ni mecanismos de retroalimentación controlados por los pacientes (Becker, 1963).

En este capítulo se esboza no solo lo que es posible, sino lo que sigue siendo estructuralmente necesario para cumplir la promesa de una atención de salud mental legítima (Martimianakis, Maniate y Hodges, 2009). Deben desarrollarse y aplicarse modelos de simulación para identificar los puntos de inflexión en los que las prácticas institucionales se desvían de los protocolos basados en los derechos. Deben calibrarse y actualizarse continuamente, mediante la recopilación participativa de datos, algoritmos capaces de detectar precozmente los riesgos, especialmente en lo que se refiere a los daños iatrogénicos, la polifarmacia y las trayectorias de deterioro. Los sistemas expertos no deben funcionar

como instrumentos de autoridad, sino como plataformas compartidas de conocimiento, basadas en la lógica y adaptables, capaces de apoyar los planes de medicación, validar los procesos de toma de decisiones y supervisar las dinámicas relacionales en los entornos de atención (Branch, 2000).

Las propuestas detalladas en las secciones siguientes, como las rutinas estructuradas de actividad física, la monitorización metabólica a través del equilibrio de omega 3, la tutoría relacional y los módulos curriculares abiertos, se basan en las pruebas biomédicas y psicosociales presentadas en la tesis. No se trata de complementos de la atención clínica, sino de componentes fundamentales de un marco centrado en la salud. Su función es preventiva y reparadora: interrumpir los efectos en cascada del malestar no tratado, el silencio y la medicación excesiva antes de que se consoliden en daños permanentes. Su simplicidad es su fuerza: responden a deficiencias cuantificables en el sueño, la nutrición, la actividad física y la seguridad relacional que exacerban la vulnerabilidad psiquiátrica. Cuando estos ámbitos se estabilizan, la función neurocognitiva mejora, se favorece la regulación emocional y se hace posible la autonomía, no como un gesto, sino como un resultado fisiológico y relacional (Mills, 2014).

Estas propuestas no son impuestas. Se formulan como alternativas disponibles, comprobables y éticamente sólidas al statu quo. La responsabilidad de adoptarlas, implementarlas y adaptarlas recae en las instituciones, las autoridades y los profesionales encargados de la salud pública y la prestación de servicios de atención. Durante cinco años, esta investigación ha seguido de cerca la brecha entre el compromiso declarado y la atención real. Esa brecha sigue abierta. Su cierre no es solo una cuestión de voluntad, sino de sistemas capaces de aprender, responder y reparar, de forma continua y sin demora. Este capítulo documenta las vías estructurales y tecnológicas para esa transición. Lo que aquí se expone es un esquema estructurado de reformas basado en la evidencia acumulada del fracaso. La tesis ha documentado, mediante métodos mixtos y análisis multiescalares, los mecanismos por los que la coacción, la extralimitación farmacológica y la descalificación epistémica se reproducen en las interfaces clínicas, familiares y legales. No se trata de anomalías de la atención, sino de características sistematizadas de la gobernanza psiquiátrica actual. En consecuencia, el debate avanza ahora desde el diagnóstico descriptivo al compromiso procedimental: un mapeo de lo que debe construirse para que la curación no sea incidental, sino la norma; para que la recuperación no sea una desviación, sino la regla (Costa et al., 2012).

Las propuestas se enmarcan en un paradigma de salud única que vincula el bienestar individual con la ética institucional, la coherencia jurídica y la protección del medio ambiente. Cada sección aborda ámbitos específicos en los que la corrección es factible y urgente. La psiquiatría preventiva, aún ausente en su forma más auténtica, requiere herramientas y prácticas que actúen antes de que se produzca la crisis: rutinas de toma de decisiones ancladas en la comunidad, apoyos estructurales para la estabilidad relacional y mecanismos de retroalimentación que respondan a los primeros signos de malestar fisiológico y psicológico. Los dispositivos portátiles y de biosignales, cuando se rigen por normas éticas y se integran en sistemas controlados por el paciente, permiten detectar y analizar marcadores de estrés, trastornos del sueño, desequilibrios metabólicos y otros indicadores de deterioro de la salud. No son invasivos cuando se implementan con consentimiento y control, sino herramientas de protección alineadas con la intervención temprana y la autonomía. Los entornos clínicos deben estar equipados no solo con personal, sino también con infraestructuras informáticas

capaces de rastrear las decisiones, vincular las intervenciones con los resultados y señalar patrones de daño o estancamiento. Los sistemas expertos, de código abierto, transparentes y verificables, deben apoyar todas las fases de la planificación de la medicación, los protocolos de desprescripción y el diálogo interprofesional. Estos sistemas no pretenden sustituir el criterio, sino reforzarlo, basando cada decisión clínica en la coherencia lógica, en argumentos documentados y en normas basadas en los derechos. Ningún profesional debería ejercer sin acceso en tiempo real a la mejor evidencia disponible, y ningún paciente debería ser sometido a protocolos que no puedan defenderse pública y científicamente. Este capítulo también posiciona la reforma educativa como una infraestructura fundamental para la salud.

La ausencia de pedagogías críticas en las profesiones sanitarias, sobre la autonomía corporal, la toma de decisiones éticas y la historia de los abusos en los sistemas de atención, ha permitido que la violencia persista sin ser examinada ni cuestionada. El diseño de los planes de estudio y las rutinas de aprendizaje mediante el servicio deben reflejar la comprensión de que las instituciones no se limitan a responder al sufrimiento, sino que lo configuran. Por lo tanto, la prevención debe comenzar por los profesionales, por las instituciones que los forman y por las leyes que los rigen (Scheper-Hughes, 1992; Hafferty, 1998; Coulehan y Williams, 2001).

7.1 Del diagnóstico estructural al compromiso sistémico

A lo largo de cinco años de análisis continuo, los resultados exponen de manera consistente una configuración desarticulada de la atención psiquiátrica en la que se suspende la autonomía, se ignoran los marcos legales y se aplican de manera selectiva las normas éticas. La confianza profesional se ha visto erosionada por una autoridad discrecional que no se basa en un razonamiento transparente ni en resultados verificables. Los sistemas objeto de examen, aunque institucionalmente elaborados, siguen siendo clínicamente y científicamente incoherentes. Esto tiene consecuencias fisiológicas, psicológicas y sociales directas: cargas alostáticas elevadas, morbilidades crónicas relacionadas con el estrés, desintegración relacional y restricción sistemática de las trayectorias de desarrollo y recuperación (Lund et al., 2010). No se trata de efectos aislados, sino de resultados sistemáticos de un desajuste estructural. Las consecuencias de este fracaso de los sistemas no son abstractas ni tardías. Se manifiestan en mortalidad precoz, abandono institucional, disfunciones metabólicas, traumas intergeneracionales y dependencia evitable de la sedación farmacológica. A muchas personas se les niega el acceso a las condiciones fundamentales que permiten la regulación fisiológica y la recuperación psicológica, como un sueño adecuado, la seguridad, relaciones estables, una alimentación nutricionalmente suficiente y entornos protegidos. Las intervenciones suelen suprimir los síntomas sin abordar la causalidad, lo que aumenta la carga fisiológica en lugar de resolverla. Mientras tanto, las infraestructuras preventivas, que van desde la educación infantil temprana hasta el seguimiento de señales biológicas mediante dispositivos portátiles para controlar el estrés y la regulación circadiana, siguen estando poco desarrolladas o se aplican de forma éticamente incorrecta, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

En esta sección se afirma la necesidad de pasar del diagnóstico estructural al compromiso coordinado de los sistemas. Si bien la tesis ha identificado dónde y cómo se producen las deficiencias, la tarea que

queda por delante es de carácter procedimental: establecer arquitecturas de retroalimentación y responsabilidades compartidas que realineen los sistemas de atención con la evidencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos (Fernando, 2010). No se trata de una cuestión de defensa, sentimiento o ideología. Es el ámbito operativo del diseño institucional y la ingeniería de la salud pública (Kelaheer et al., 2014). Los vacíos epistémicos y de infraestructura deben llenarse con una investigación-acción llevada a cabo en contextos reales, dirigida por las personas afectadas y traducida a través de la ingeniería, la educación y la formación clínica (Herman, 1997).

Un modelo participativo y aplicado no es solo deseable, sino necesario. Esto exige métricas y mecanismos capaces de proporcionar información inmediata, detectar señales preventivas y garantizar la capacidad de respuesta de todo el sistema. Implica protocolos formales para la desprescripción, formación actualizada sobre la interacción somático-psicosocial, seguimiento de los síntomas en tiempo real y la traducción de la experiencia de los pacientes en datos no desestimados. La ausencia persistente de estos mecanismos explica no solo el daño continuo, sino también el retraso en la reparación y la innovación (Compton y Shim, 2015). Los sistemas sociales no pueden permanecer neutrales cuando está en juego la vida. Cuando la educación se reduce al cumplimiento, el movimiento se considera un castigo y la salud se reduce al manejo farmacológico, el resultado es una trampa cultural y biológica que incapacita la resiliencia (Wilkinson y Pickett, 2010). Muchas comunidades siguen considerando sospechoso el acondicionamiento físico, la vulnerabilidad como debilidad y la violencia como pedagógica o correctiva. Sin embargo, la salud depende de la exposición a rutinas protectoras, el esfuerzo estructurado y un sentido validado de propósito (Hollander, 2010).

Las instituciones deben fomentar la resiliencia neurobiológica adaptativa a través de rutinas que no sean punitivas, sino de desarrollo, que no se impongan, sino que se construyan conjuntamente. El camino a seguir comienza con el reconocimiento de que los colapsos individuales reflejan fallos de diseño sistémicos. Ningún sistema que permita la coacción como rutina, suprima las quejas o borre los daños a largo plazo debe considerarse funcional. La atención psiquiátrica debe dejar de basarse en la autoridad personal y empezar a funcionar mediante cadenas de toma de decisiones científicamente válidas, reproducibles y transparentes. Los dispositivos wearables y las simulaciones algorítmicas pueden detectar desregulaciones tempranas, pero estas herramientas solo son eficaces cuando se integran en entornos de apoyo, en los que se actúa ante las señales en lugar de ignorarlas. La educación también debe reorientarse hacia la ciudadanía aplicada y la capacidad relacional: alfabetización corporal, jurídica, dialógica y en la navegación por los sistemas. Los planes de estudio deben incluir neurobiología del desarrollo, salud ambiental, teoría de la decisión y razonamiento informado sobre el trauma. No se trata de lujos, sino de requisitos básicos para participar en una sociedad gobernada por sistemas institucionales. Cuando estos requisitos no se cumplen, las sociedades no pueden gestionar los desacuerdos sin violencia, el estrés sin colapsos ni la atención sin dependencia. Desde el punto de vista del trabajo de campo sostenido e inmersivo, resulta evidente que lo que queda por hacer no es ni periférico ni incremental. A pesar de los avances que se recogen en esta tesis, gran parte del trabajo esencial sigue bloqueado estructuralmente por la inercia sistémica, las dinámicas de poder arraigadas y una disyunción persistente entre el conocimiento y la implementación. El compromiso con los sistemas que se esboza no es una visión abstracta de la experiencia, sino que surge precisamente de la

observación repetida de que, sin protecciones verificables y protocolos coherentes, los sistemas psiquiátricos siguen reproduciendo el daño bajo la apariencia de la atención. La experiencia del investigador, sometido personalmente a muchas de estas condiciones, subraya la facilidad con la que el discurso institucional puede prevalecer sobre la realidad clínica y cómo la responsabilidad institucional a menudo se disuelve bajo la complejidad administrativa, la coacción informal y el silencio normativo (Cohen, 2001).

El reto no es principalmente técnico. Las herramientas existen: sistemas expertos, dispositivos portátiles para la regulación del estrés y el sueño, protocolos de evaluación participativa, planes de estudios basados en el trauma y vías clínicas basadas en los derechos. Lo que falta no es innovación, sino voluntad sistémica y aplicación de los procedimientos. Los sistemas educativos aún no han preparado a profesionales capaces de aplicar estas herramientas de manera respetuosa con los derechos. Los marcos jurídicos siguen siendo vagos, fragmentados o no se aplican. Las instituciones carecen de mecanismos de retroalimentación en tiempo real capaces de identificar los daños a medida que se producen. Estas ausencias no son descuidos, sino el resultado de prioridades sistémicas que históricamente han marginado a las poblaciones que más necesitan protección. La tesis ha demostrado que el daño no siempre es evidente. A menudo es lento, acumulativo y rutinario, y se distribuye a través de decisiones tomadas en silencio, registros incompletos u opciones que nunca se ofrecen. No se trata solo de fallos de competencia, sino de fallos en el diseño institucional y en la gobernanza ética (Goffman, 1961). Muchos de los sistemas observados han normalizado un estado de excepción en el que las personas marcadas por un diagnóstico psiquiátrico pierden su condición de personas de pleno derecho, se ven reducidas al cumplimiento, son objeto de un descuento epistémico y se vuelven invisibles en sus propias narrativas (Fernando, 2017).

Para avanzar, el trabajo que queda por hacer debe enmarcarse como el deber que es, el mandato que hay que cumplir, una obligación legal con consecuencias, no una aspiración (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004). Las instituciones deben desarrollar no solo la capacidad de actuar, sino también el sentido inculcado de la responsabilidad largamente esperada de responder a tiempo y con claridad procedimental, en beneficio de todos, incluidos todos los profesionales involucrados hasta ahora y, obviamente, los pacientes, las víctimas, los que se han quedado atrás y nuestras sociedades en general. La recuperación debe entenderse no como un resultado individual, sino como una métrica institucional: la capacidad del sistema para apoyar la dignidad, la autonomía y la regulación fisiológica en condiciones de angustia no debe plantearse como una pregunta, sino como un motivo de orgullo una vez que se ha logrado adecuadamente en un ciclo de mejora. Ese ciclo de investigación-acción debe aplicarse para eliminar cada problema, cada uno de los errores detectados, como en un repositorio de desarrollo informático, antes de que se repitan y causen más sufrimiento en todo el sistema (Harper y Speed, 2012). La experiencia de investigar bajo coacción, bajo lo que equivale a tortura médica y, por lo tanto, a un grave crimen contra la humanidad, a pesar de las leyes y las repetidas peticiones de ayuda, confirma lo precaria que es la seguridad cuando estas preguntas quedan sin respuesta, los problemas pendientes sin atender, nosotros asesinados, masacrados como animales.

La orientación que aquí se propone se aleja por completo tanto del activismo sin fundamento como de la reproducción pasiva de las rutinas institucionales. No exige fervor ni obediencia, sino una reflexividad estructurada, una capacidad disciplinada y sistemática para detectar, cuestionar y

rediseñar los hábitos cuando causan daño o no protegen. En esencia, se trata de la antítesis del cumplimiento ciego y la inercia procedimental. No es un rechazo de la estructura, sino una redefinición de la misma: una estructura anclada en la retroalimentación, la responsabilidad ética y la calibración continua. Orientada a la verdad, orientada a la recuperación, orientada a los resultados.

En lugar de automatizar las respuestas dentro de la psique de los profesionales, el objetivo es cultivar un hábito practicado de mejora reflexiva, un meta-hábito basado en la identificación de fallos, la recalibración de las normas y la alineación deliberada de la acción con la atención validada empíricamente. No se trata de una actitud reactiva, sino anticipatoria. Exige a todos los profesionales la capacidad de reconocer las desviaciones, detener la automaticidad e intervenir con responsabilidad y coherencia.

Esta reflexividad debe integrarse en todos los niveles, desde las decisiones individuales hasta los protocolos institucionales. Debe enseñarse, reforzarse y esperarse de forma normativa. El cambio necesario no es solo cognitivo, sino también procedimental y ético. Lo que se prevé es un entorno psiquiátrico y pedagógico en el que los sistemas ya no dependan de excepciones o del heroísmo moral para funcionar bien, sino que las acciones coherentes, verificables y que afirman la vida se conviertan en la norma sistémica. No se trata de activismo, sino de una reforma infraestructural basada en la responsabilidad. No es sumisión ni resistencia, sino un diseño correccional sostenido. El sistema previsto no presume un funcionamiento impecable, ni pretende eliminar por completo los errores (Graham et al., 2006). Más bien, está diseñado para la resiliencia, la capacidad de detectar, analizar y responder a las averías sin negarlas ni retrasarlas. Los errores no se tratan como anomalías aisladas ni como costes aceptables, sino como señales que requieren una respuesta estructurada. Esto transforma el fracaso de una fuente de fragilidad institucional en un punto de aprendizaje y recalibración. En un sistema así, el daño no se oculta ni se normaliza, sino que se hace visible y se puede actuar sobre él (Bauer, Damschroder, Hagedorn, Smith y Kilbourne, 2015).

Este cambio sustituye la dependencia de la moralidad individual o las intervenciones ad hoc por una arquitectura estable de práctica profesional. Incorpora la reflexividad en el tejido operativo, haciendo que la capacidad de respuesta ética y la responsabilidad empírica sean características intrínsecas del propio sistema. No se trata de una resistencia por sí misma, ni de un rechazo de la estructura, sino de la afirmación de la integridad procedimental, que garantiza que la atención, la educación y la gobernanza funcionen dentro de marcos que puedan aprender, adaptarse y seguir siendo dignos de la confianza pública (Mills, 2014).

7.2 Un modelo clínico basado en los derechos: toma de decisiones, diálogo y precisión

Para permitir una transición genuina hacia una atención ética y eficaz, la práctica psiquiátrica debe basarse en modelos de intervención personalizados, biológicamente coherentes y contextualizados socialmente. La noción de «reinicio» de los sistemas de atención no implica ni el borrado ni la ruptura ideológica, sino un reanclaje en la integridad científica, el matiz clínico y el imperativo ético de la no maleficencia. Las intervenciones psiquiátricas deben guiarse por una evaluación estructurada y transparente del perfil fisiológico, el contexto psicosocial y la experiencia narrativa de cada individuo.

Ninguna intervención es intrínsecamente perjudicial o universalmente beneficiosa; el valor terapéutico depende de la indicación, el contexto, la duración y la participación informada y voluntaria de la persona que recibe la atención. Esto exige una formación continua tanto de los profesionales como del público en general, fomentando una cultura capaz de distinguir con matices entre el daño iatrogénico y el efecto terapéutico legítimo.

Este cambio rechaza los paradigmas punitivos, totalitarios y deshumanizadores, y en su lugar pone énfasis en el aprendizaje adaptativo, la transparencia de los procedimientos y la responsabilidad compartida. Los pacientes, clientes, usuarios y ciudadanos deben ser tratados como agentes epistémicos, capaces de contribuir a la comprensión y la co-construcción de sus propios procesos de tratamiento. Los entornos clínicos deben dejar de funcionar como espacios de control o corrección moral y convertirse en ecosistemas de recuperación, donde la tarea principal es calibrar el apoyo según las necesidades, la evidencia y los objetivos en evolución. Para seguir siendo creíble y legal, la atención psiquiátrica debe adoptar los principios de la medicina de precisión, integrando las biofirmas, los factores de estrés ambiental y las trayectorias conductuales en modelos dinámicos de toma de decisiones. Esto no elimina la incertidumbre, sino que la gestiona de forma constructiva, garantizando que la curación, y no el cumplimiento, siga siendo el objetivo definitorio del sistema (Samson y McGregor, 2022).

El modelo de atención psiquiátrica que existe desde hace mucho tiempo en muchas jurisdicciones ha normalizado una asimetría estructural entre el proveedor y el usuario, en la que las decisiones suelen estar determinadas por la conveniencia institucional, el formalismo diagnóstico y la estandarización farmacológica. En estos marcos, la toma de decisiones compartida ha seguido siendo a menudo un objetivo declarado, pero rara vez se ha aplicado como norma procedimental. En esta sección se examinan los fundamentos empíricos y éticos para reconfigurar los sistemas clínicos en torno a la toma de decisiones estructuralmente integrada, la coherencia dialógica y la precisión con base científica.

Un modelo clínicamente y jurídicamente sólido requiere que la toma de decisiones deje de percibirse como una oferta discrecional y se integre estructuralmente a través de sistemas expertos garantizados por la retroalimentación, regidos por la ética y verificablemente precisos. Estos sistemas no sustituyen al juicio, sino que son instrumentos que estructuran, registran y refuerzan el proceso de razonamiento relacional y la formación del consentimiento. En la base de esta recalibración se encuentra el desarrollo de herramientas modulares que ayuden a planificar la medicación, perfilar los riesgos y beneficios y realizar ajustes longitudinales. Estos módulos pueden incorporar árboles de lógica clínica, datos biofisiológicos y datos del contexto psicosocial, adaptándose a las respuestas y preferencias de los pacientes.

Paralelamente, son necesarios mecanismos integrados de retroalimentación de los pacientes para detectar los resultados previstos e imprevistos. Estos pueden incluir cambios en el estado afectivo, irregularidades fisiológicas, fluctuaciones cognitivas y alteraciones relacionales, todos ellos con relevancia clínica y ética. Las tecnologías que lo hacen posible, como los dispositivos portátiles y los diarios digitales, deben enmarcarse no como instrumentos de vigilancia, sino como ayudas para la

comunicación, la supervisión y la seguridad. Es importante que sigan estando bajo el control del paciente, con configuraciones opcionales y una gestión transparente de los datos.

También es esencial la coordinación con los cuidadores, tutores y profesionales de otros sectores. Un entorno clínico verdaderamente basado en los derechos requiere coherencia relacional (Sweeney et al., 2016). Los módulos de coordinación pueden ofrecer herramientas de conciencia situacional, andamios de comunicación y protocolos de notificación ética que ayuden a mantener el respeto por la autonomía y la continuidad de la atención (Rose, 2001). Estos mecanismos son especialmente pertinentes cuando intervienen tutores legales, instituciones educativas o servicios sociales (Fixsen et al., 2005).

Las infraestructuras de formación de los profesionales deben recalibrarse para apoyar este modelo. Debe normalizarse la alfabetización procedimental en ciencia de la decisión, razonamiento ético y jurídico, y medicina narrativa. Un proceso de formación riguroso debe hacer hincapié en la neutralidad clínica, el respeto por el conocimiento empírico y la integración de perspectivas culturales y biográficas diversas. Esto incluye el establecimiento de sistemas de certificación continuos alineados con QualityRights de la OMS, la legislación local y los instrumentos internacionales de derechos humanos (Sweeney et al., 2018). La introducción de biomarcadores multimodales y sociomarcadores representa otro paso adelante necesario, que ya se puede lograr con facilidad. Los indicadores biológicos, como los marcadores inflamatorios, el equilibrio hormonal, la variabilidad del ritmo cardíaco y los ciclos del sueño, deben interpretarse junto con indicadores socioculturales y relacionales, como la seguridad de la vivienda, la exposición a la discriminación y la integridad de las redes sociales. Esto se puede hacer a través de rastreadores y dispositivos portátiles de uso diario por parte de todas las personas que lo necesiten, lo cual ya es económicamente viable. La propia experiencia del investigador, que ha salido de la miseria de la tortura, es un claro ejemplo de éxito en este sentido, ya que ha utilizado estos métodos de auto-seguimiento para garantizar su estado físico y unos hábitos más saludables, aunque no se mencione explícitamente en esta tesis. Esta integración biocultural permite elaborar planes de atención que se ajustan a la persona en su contexto, alejándose de los marcos reduccionistas que universalizan erróneamente la presentación de los síntomas o las respuestas al tratamiento (Kalathil, 2020). A nivel sistémico, la reflexividad debe reforzarse mediante el diseño de procedimientos. Más que la automatización de las rutinas clínicas, lo que se necesita es un hábito metacognitivo: la identificación rutinaria de las divergencias, la recalibración del tratamiento y el reconocimiento de los límites epistémicos. En este sentido, lo ideal no es la perfección del protocolo, sino la institucionalización de la capacidad de respuesta. Cuando no se cuestiona el conocimiento clínico o se patologiza la disidencia, los sistemas se degradan en bucles cerrados que ya no pueden reconocer el error.

La trazabilidad y la verificabilidad de las decisiones pasan a ser fundamentales en esta configuración. Cada recomendación, ajuste o desviación de la norma debe documentarse de forma transparente y ser interpretable. Esto garantiza la rendición de cuentas a lo largo del tiempo y entre los distintos actores, especialmente en entornos en los que los profesionales rotan o en los que los pacientes interactúan con múltiples instituciones. La explicabilidad científica, tanto en forma legible para los humanos como algorítmica, no solo sirve a la precisión médica, sino también a la defendibilidad jurídica y ética. Una última consideración es la interoperabilidad entre sistemas. La atención de la salud mental basada en

los derechos no puede hacerse realidad si los sistemas educativos, judiciales o de bienestar social funcionan con lógicas incompatibles. Esto requiere protocolos interoperables y marcos de protección que faciliten la continuidad de los datos, la divulgación ética y la respuesta rápida ante los daños. Solo así la atención psiquiátrica podrá evitar funcionar como un ámbito correctivo aislado y convertirse en un nodo de una red restaurativa más amplia.

7.3 La educación como infraestructura: planes de estudio, pedagogía y aprendizaje basado en roles

Cualquier reconfiguración sistémica de los entornos sanitarios y asistenciales debe abordar la educación no solo como un medio de difusión, sino como una infraestructura estructural capaz de moldear el comportamiento relacional, la sensibilidad ética y la reflexividad epistémica a lo largo de toda la vida. Los fallos documentados en esta tesis revelan no solo discontinuidades clínicas y jurídicas, sino una incapacidad cultural más amplia para dotar a las personas y las instituciones de las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para mantener respuestas coherentes y basadas en los derechos ante la vulnerabilidad humana y la interdependencia ecológica. No es posible formar una sociedad preventiva, promotora de la salud y alineada con la ciencia sin una transformación curricular, una renovación pedagógica y un reajuste normativo en todas las funciones profesionales y cívicas. En esta sección se esboza dicha transformación bajo el epígrafe de la educación para la salud única, conceptualizada como una infraestructura modular, de acceso abierto y código abierto, capaz de adaptarse a contextos nacionales, lingüísticos y socioculturales (Perrin et al., 2007).

El desarrollo de módulos educativos de «una sola salud» aplicables a nivel transnacional responde a la necesidad empírica de una formación temprana, estructurada y acumulativa sobre la interdependencia de los sistemas humanos, no humanos y ecológicos. Estos módulos deben diseñarse para su integración en múltiples niveles de aprendizaje formal e informal, desde la educación primaria hasta la especialización profesional, dando prioridad a la accesibilidad, la relevancia contextual y la base empírica. Su arquitectura pedagógica debe apoyar no solo la transmisión de información, sino también el cultivo del razonamiento crítico, la agencia colaborativa y la responsabilidad procedimental.

Cuatro ámbitos curriculares se perfilan como estructuralmente indispensables. En primer lugar, la toma de decisiones y la responsabilidad en materia de salud deben establecerse como contenidos fundamentales, garantizando que los alumnos desarrollen una comprensión clara de cómo las elecciones, tanto individuales como colectivas, interactúan con los sistemas corporales, las dinámicas relacionales y las estructuras institucionales. Esto incluye conocimientos prácticos sobre el consentimiento, la evaluación de riesgos y beneficios y la ética de la intervención, que se extienden tanto a la gestión de la salud personal como a la toma de decisiones compartida en el ámbito profesional (Aarons, Hurlburt y Horwitz, 2011). En segundo lugar, la ética corporal y relacional debe enseñarse no como filosofía abstracta, sino como competencia procedimental vivida, integrando la ciencia del desarrollo neurológico, la práctica informada sobre el trauma y el razonamiento moral. La educación en este ámbito debe dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para reconocer

las violaciones de los límites, comprender la fisiología del estrés y la reparación, y actuar con una responsabilidad coherente en los contextos de cuidado y organización. La ética relacional incluye responsabilidades hacia los demás, pero también hacia la propia integridad somática y emocional, tendiendo puentes entre la salud pública, la resiliencia psicológica y la conducta cívica (Woolf, 2008). En tercer lugar, la interdependencia medioambiental y planetaria requiere la integración curricular de la ciencia ecológica con las dimensiones afectivas, éticas y conductuales. Los alumnos deben llegar a comprender el impacto circular de la contaminación, el consumo excesivo y la degradación del hábitat, no solo en los sistemas planetarios, sino también en el desarrollo neural, la fertilidad, la inmunidad y la cognición colectiva (Sweeney et al., 2018). La alfabetización medioambiental se convierte así en una cuestión de estrategia de salud pública y justicia intergeneracional, en lugar de una preocupación marginal u opcional. En cuarto lugar, es necesario establecer una alfabetización histórica y metodológica en las profesiones asistenciales para contrarrestar la amnesia institucional y reproducir sistemas de atención capaces de autorreflexión y mejora adaptativa (Freire, 2000). Esto incluye un compromiso crítico con la genealogía de la medicina, la psiquiatría, el trabajo social y la educación, exponiendo cómo las prácticas normativas evolucionan, se degradan o se recuperan con el tiempo. La alfabetización metodológica debe abarcar enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, permitiendo a los profesionales interpretar los datos en relación con la experiencia vivida, la historia sistémica y la pluralidad epistémica (Delpit, 2006).

Los cuatro ámbitos deben integrarse en estructuras de aprendizaje-servicio que sitúen al alumno como receptor y contribuyente del conocimiento. La pedagogía relacional, basada en la coexperiencia, la reflexividad dialógica y la responsabilidad mutua, debe sustituir a la enseñanza basada en la transmisión, especialmente en ámbitos en los que los retos éticos y las asimetrías de poder son intrínsecos. Este modelo favorece el desarrollo de rutinas protectoras y hábitos de cuidado que refuerzan tanto la coherencia institucional como la cohesión social. En los servicios públicos, como las escuelas, las clínicas y los organismos administrativos, la renovación pedagógica debe ir acompañada de adaptaciones estructurales que permitan el aprendizaje basado en funciones. Los docentes, los médicos y los administradores deben contar con vías de formación continua que sean iterativas, modulares y estén ancladas en sus responsabilidades en constante evolución (Perry y Szalavitz, 2017). Estos programas deben estar estructurados normativamente en torno a la prevención de daños, la realización procedimental de la dignidad y el mantenimiento de la legitimidad institucional. También deben responder a las condiciones epidemiológicas, ambientales y tecnológicas cambiantes, garantizando que la práctica profesional no se quede atrás respecto al consenso científico o ético (McNall, Reed, Brown y Allen, 2009). El fracaso en la implementación de dicha reforma deja a las personas atrapadas en roles estructuralmente desalineados, en los que las víctimas son tratadas como delincuentes, los profesionales como autoridades incuestionables y las respuestas desviadas o angustiosas como patologías. Es desde dentro de estos sistemas que debe entenderse la trayectoria del investigador. Procedente de un sistema familiar disfuncional que se degradó gradualmente hasta convertirse en patrones de coacción y abuso sostenido con relevancia clínica y legal, el investigador fue testigo del colapso de las salvaguardias en todas las instituciones que deberían haber intervenido. A lo largo de cinco años de análisis jurídico, médico y educativo, el caso que sustenta esta tesis demuestra cómo el abandono sistemático, combinado con un diagnóstico

excesivo y la impunidad basada en el rol, puede transformar la resiliencia en colapso, la autonomía en dependencia y la atención de alto nivel en un daño acumulativo (Frenk et al., 2010).

Los datos clínicos son inequívocos: la exposición crónica a la violencia psicológica y física, en ausencia de protección procesal, produce desregulación somática, carga alostática elevada, deterioro del funcionamiento inmunológico y cognitivo y reducción de la capacidad neuroplástica. Estos resultados no son aleatorios ni idiosincrásicos, sino totalmente predecibles en ausencia de una protección coordinada y de sistemas que tengan en cuenta el trauma. La investigadora, que era la principal cuidadora de dos bebés y al mismo tiempo superaba las expectativas institucionales como académica y profesional, fue sometida a grados crecientes de violencia precisamente por ejercer derechos garantizados constitucionalmente pero denegados por los procedimientos. Proponer la separación o el divorcio, en un contexto de impunidad de género y misoginia cultural dirigida contra la vulnerabilidad percibida de los hombres, no condujo a una revisión de los procedimientos, sino a agresiones físicas brutales, manipulación psicológica institucional y difamación psiquiátrica (Herman, 1997).

La documentación médica de la época confirmó la presencia de hematomas visibles y desregulación fisiológica. Sin embargo, la policía, los médicos y los actores del tribunal de familia se negaron sistemáticamente a reconocer estos indicadores, citando con frecuencia estereotipos de género, insinuaciones diagnósticas o vagas nociones de inestabilidad para ocultar la responsabilidad. Una simple migraña fue tratada como locura. Se obligó a la víctima a trabajar a pesar del deterioro de su salud, mientras que los abusos se ocultaban bajo la pasividad institucional y la complicidad sociocultural. En ningún momento se aplicaron protocolos de protección. Se intentó una intervención farmacológica forzada. Pero en ningún momento se evaluó médicamente a los agresores, ni se dirigió la atención de las fuerzas del orden hacia ellos. Esta asimetría no constituye un fracaso clínico, sino un colapso estructural en la administración de la justicia y la atención. Todo ello se desarrolló con la plena participación de las instituciones encargadas de proteger. Esto hace que el episodio no sea privado, sino público, no excepcional, sino paradigmático (Fanon, 1963; Freire, 1970; Bartky, 1990).

Cabe reiterar que ninguno de estos fallos se debió a la falta de credenciales profesionales, esfuerzo o compromiso. Más bien al contrario. La investigadora trabajó al máximo de su capacidad en condiciones coercitivas: aprobó los exámenes con distinción, contribuyó al liderazgo académico internacional y crió a dos bebés al tiempo que los protegía de un peligro doméstico cada vez mayor. Por lo tanto, la injusticia no fue accidental, sino sistémica. Es esta discrepancia entre lo que el sistema dice hacer y lo que hace estructuralmente lo que constituye la base empírica de esta tesis (Mills, 2014).

El sistema psiquiátrico, cuando no se corrige, no funciona como una herramienta de curación, sino como un circuito de contención. Replica formas de control bajo el disfraz del diagnóstico. A menudo niega la dignidad procesal mientras cita el malestar del individuo como prueba para una mayor coacción. La investigación demuestra que, una vez que la policía y los profesionales médicos actúan como árbitros extrajudiciales, juzgando y ejecutando sin el debido proceso, la arquitectura legal y ética de cualquier sociedad democrática comienza a fracturarse. En el presente caso, el intento de abandonar una relación abusiva fue respondido con difamación médica, alienación infantil y silencio institucional (Berry et al., 2019).

Por lo tanto, no se trata de un llamamiento a la defensa retórica, sino a la reconstrucción de las infraestructuras. El modelo que propone esta tesis se basa en la necesidad de sistemas científicamente coherentes, jurídicamente sólidos y éticamente defendibles. La Organización Mundial de la Salud (1948) define la salud como un *estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia*. En 2004, especificó además que la salud mental es un *estado de bienestar en el que el individuo se realiza a sí mismo, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de contribuir a su comunidad*.

Las prácticas sistémicas expuestas en este trabajo distan catastróficamente de estos estándares. Cuando la coacción sustituye al cuidado y la patología se sustituye por el malestar situado, la legitimidad institucional queda anulada. En consonancia con el marco *QualityRights* de la OMS, esta tesis propone la implementación de cinco acciones fundamentales como bases sistémicas, con el objetivo de integrar otros marcos en toda la sociedad, no como propuestas ambiciosas, sino como trabajo en curso, como la adopción generalizada de las cinco vías para el bienestar de la New Economic Foundation (NEF), ya ampliamente promovidas (Kitchener y Jorm, 2002; Cinco vías para el bienestar, New Economics Foundation, 2008):

- Eliminación de las prácticas coercitivas, incluida la institucionalización forzosa, las intervenciones farmacológicas no consensuadas y el uso disciplinario indebido de la autoridad médica. En términos neurobiológicos, la coacción genera una activación crónica de los sistemas de respuesta al estrés, lo que altera la regulación afectiva, el equilibrio neuroendocrino y la confianza relacional. La eliminación de la coacción es un requisito previo para permitir una conexión y una participación significativas, que permitan a las personas participar voluntariamente en contextos terapéuticos, educativos y sociales esenciales para la curación. Restablece las condiciones para la agencia y la corregulación, sin las cuales no puede producirse un cuidado o una recuperación genuinos.
- La implementación de garantías legales, operativas a través de protocolos vinculantes basados en derechos, transparencia procedimental en tiempo real y organismos de supervisión independientes con facultades para prevenir, investigar y reparar las violaciones. La ley, en esta función, se convierte en una estructura estabilizadora que protege tanto a los pacientes como a los profesionales de las decisiones arbitrarias y la inercia institucional. La claridad jurídica permite a las personas tomar *conciencia*, reconocer, denunciar y actuar ante las experiencias de injusticia, restaurando así la legitimidad epistémica y democrática de los entornos de atención de la salud mental.
- Formación de profesionales en atención basada en los derechos, medicina personalizada fundamentada en los derechos humanos, razonamiento empírico y ética relacional culturalmente competente. Esto debería implementarse como un aprendizaje modular a lo largo de toda la vida, accesible a todas las profesiones y disciplinas, fomentando la experiencia adaptativa. Enseñar a los proveedores a *seguir aprendiendo* refuerza el pensamiento crítico, la reflexividad y la responsabilidad procedimental, rompiendo la rigidez de los paradigmas obsoletos y promoviendo una alineación dinámica con la evidencia actual y la complejidad social.

- Desarrollo de sistemas de apoyo integrados en la comunidad y dirigidos por pares, donde «pares» no se refiere únicamente a la categoría diagnóstica, sino a la paridad epistémica y cívica. Todas las personas, ya sean usuarios, profesionales, familiares o ciudadanos, deben ser tratadas como capaces de contribuir al ecosistema de la atención. Estas estructuras deben promover la responsabilidad compartida por el bienestar, incorporando mecanismos de retroalimentación recíproca, diálogo restaurativo y soluciones coproducidas. Esto promueve el principio de «*dar*», construyendo solidaridad y confianza de manera que se refuercen tanto la recuperación personal como la resiliencia pública.
- Modernización digital y de las infraestructuras, incluido el diseño y la implementación de sistemas expertos éticos para el apoyo a la toma de decisiones clínicas, la supervisión participativa y la educación modular. Estos sistemas deben ser totalmente auditables, transparentes y validados científicamente, lo que permite la corrección y el aprendizaje en tiempo real. Al integrar la tecnología al servicio de la autonomía y la protección, las instituciones pueden facilitar la validación profesional continua y la planificación de la atención personalizada. Las herramientas digitales pueden reforzar las rutinas que promueven la actividad física, la conexión social y el compromiso encarnado, *Be Active*, alineando la función sistémica con la neurofisiología vivida del bienestar.

Desde el punto de vista del investigador, que casi muere y aún no ha obtenido justicia, ya que se necesitan recursos para lograrlo, tras un largo periodo de investigación-acción integrada llevada a cabo en condiciones de fracaso institucional documentado que constituyen tortura médica, un delito grave contra cualquier persona, y más aún contra un civil que no participa en ningún esfuerzo bélico, un delito incluso en esas circunstancias, la restauración sistémica de la gobernanza de la salud mental debe entenderse como un imperativo de salud pública basado en la evidencia. Las medidas aquí descritas no son discrecionales, sino que se derivan directamente de las violaciones observadas y analizadas que se detallan a lo largo de esta tesis. Las intervenciones propuestas están en consonancia con los mandatos de la iniciativa *QualityRights* de la OMS y con el consenso científico sobre la incompatibilidad de los entornos coercitivos con los resultados sostenibles en materia de salud mental. Según la definición de la OMS, la salud mental no es la ausencia de patología, sino un estado funcional caracterizado por la autonomía, la capacidad y la participación productiva. Esto no puede lograrse cuando los sistemas funcionan sin transparencia, rendición de cuentas o mecanismos de protección tanto para los usuarios de los servicios como para los profesionales (Gill et al., 2024).

La estabilización de las infraestructuras de atención basada en los derechos requiere la integración de la precisión clínica, la legalidad normativa y la supervisión participativa. Es fundamental que esto incluya no solo la reducción de daños, sino también la facilitación activa del acceso a la educación, la funcionalidad económica y la participación digna en la sociedad. No se trata de condiciones accesorias, sino constitutivas de la salud mental pública como norma medible y exigible. La ausencia de estos fundamentos degrada sistemáticamente la viabilidad de cualquier reivindicación institucional de legitimidad terapéutica. Por lo tanto, la reestructuración de los sistemas de atención no debe llevarse a cabo mediante apelaciones morales u oposición ideológica, sino mediante el diseño y la

implementación de entornos procedimentales capaces de mejorar continuamente, corregirse en tiempo real y supervisar los resultados. Esto requiere el desarrollo coordinado de vías educativas resilientes, rutinas profesionales éticamente válidas y estructuras de gobernanza adaptables en múltiples ámbitos institucionales. Estos elementos constituyen el núcleo operativo de lo que constituye una atención médica y jurídicamente creíble (Kjellin y Wallsten, 2010; Hotzy y Jaeger, 2016).

Este marco va más allá de la atención psiquiátrica y se aplica a todos los entornos institucionales que se dedican a la prestación de apoyo, supervisión o regulación, ya sea en el ámbito educativo, jurídico, administrativo o clínico. En cada uno de ellos, la ausencia de reflexividad a nivel sistémico facilita la reproducción del daño. En cada uno de ellos, el restablecimiento de la legitimidad depende de la claridad estructural, de las protecciones aplicables y de la articulación funcional de los deberes. La urgencia de estas medidas se ve subrayada por la trayectoria geopolítica y ecológica actual. A medida que proliferan los conflictos, los desplazamientos forzados y la degradación medioambiental, los sistemas de salud mental responderán como infraestructuras estabilizadoras o fracasarán como aceleradores de la vulnerabilidad. Esta tesis sostiene que solo mediante un diseño de sistemas coordinado, con base científica y fundamentado jurídicamente se podrá preservar la salud, tal y como la definen las normas internacionales.

El apoyo de marcos científicos internacionales coordinados, como el programa de coordinación científica y tecnológica COST de la UE, sigue siendo fundamental para este esfuerzo (Cianconi et al., 2020). Los procesos de formación de consorcios ya en marcha reflejan un compromiso compartido con la reparación institucional y la transformación basada en el conocimiento. El camino por recorrer sigue siendo técnicamente complejo y políticamente contingente (Musen, Middleton y Greenes, 2014). No obstante, las condiciones necesarias para una atención coherente, legal y humana ya no son objeto de debate teórico. Se trata de puntos de referencia operativos cuya aplicación debe proceder ahora.

Capítulo 8 - Conclusiones finales: contribuciones científicas y rediseño sistémico

Esta tesis doctoral ha investigado las condiciones estructurales en las que los sistemas psiquiátricos podrían pasar de modelos de intervención coercitivos y excesivamente medicalizados a formas de atención con base científica, respetuosas de los derechos y orientadas a la recuperación, basadas en la autonomía del paciente, la toma de decisiones compartida y las mejores prácticas culturalmente informadas. Las principales conclusiones, basadas en cinco años de trabajo de campo con métodos mixtos en ámbitos institucionales, clínicos y comunitarios, confirman la existencia de una disonancia profunda y persistente entre las normas jurídicas y éticas formales y la realidad de la práctica psiquiátrica. El razonamiento basado en el riesgo, los automatismos burocráticos y la inercia

diagnóstica funcionan como mecanismos de cierre que excluyen la narrativa, el contexto y la experiencia vivida de la relevancia clínica, incapacitando así la capacidad de corrección reflexiva. El daño no solo se produce, sino que se hace invisible a través de bucles de retroalimentación fallidos, en los que el sufrimiento no se denuncia ni se integra sistemáticamente en el aprendizaje profesional. Esto permite que el daño iatrogénico y no consensuado, incluida la tortura psicológica y física, persista sin interrupción, afectando de manera desproporcionada a poblaciones ya marginadas, mal diagnosticadas o desempoderadas institucionalmente. Las pruebas empíricas recopiladas documentan cómo la violencia no solo se permite, sino que a menudo se protege dentro de los procedimientos rutinarios, donde construcciones jurídicas vagas, como la presunción de peligro, junto con la discrecionalidad profesional sin control, dan lugar a violaciones sistemáticas de la integridad física y psicológica. Los protocolos de documentación dan prioridad a la autoprotección institucional sobre la transparencia, protegiendo eficazmente a los actores del escrutinio y obstaculizando la reparación de las víctimas.

Así, las instituciones psiquiátricas operan con frecuencia en condiciones de impunidad estructural, en las que la policía, los médicos y el personal jurídico pueden actuar simultáneamente como investigadores, jueces y ejecutores, anulando así el principio de justicia procesal. En estos contextos, la tortura no es posible por una intención manifiesta, sino por una configuración sistémica que reprime la disidencia, impide la rendición de cuentas y reinterpreta el malestar como un trastorno, al tiempo que criminaliza la resistencia. La ausencia de segundas opiniones, de supervisión independiente y de vías de denuncia confirma una suspensión sistémica de la personalidad. No obstante, el trabajo de campo revela la existencia de un profesionalismo invisible, de resistencia ética y de contraprácticas lideradas por usuarios, supervivientes y profesionales aislados que se esfuerzan por prevenir el daño, preservar la dignidad y reconstruir el sentido en condiciones de traición institucional.

Estas prácticas emergentes demuestran la viabilidad y la necesidad de establecer infraestructuras paralelas basadas en la evidencia científica, la alineación jurídica normativa y una epistemología estricta basada en la realidad y anclada en bucles de retroalimentación de mejora traslacional de la ciencia médica de vanguardia aplicados a todos los niveles. Estas infraestructuras deberían incorporar pronto sistemas modulares expertos para el apoyo a la toma de decisiones éticas, capaces de auditar las intervenciones psiquiátricas y orientar la coordinación clínica en tiempo real, junto con plataformas educativas de acceso abierto que fomenten la competencia narrativa y la alfabetización jurídica entre los grupos de usuarios y profesionales, así como los sistemas de vigilancia existentes y los que se vayan añadiendo. Estas plataformas orientadas al futuro deberían funcionar de manera transdisciplinar, dejando explícita la interrelación entre la atención psiquiátrica y los determinantes sociales, económicos y culturales de la salud. Los métodos de vanguardia, como la gestión colaborativa de la medicación, la transparencia algorítmica en los procesos de diagnóstico y la adecuación terapéutica basada en la precisión, no son innovaciones periféricas, sino pasos esenciales hacia la integridad sistémica de la atención. Su evolución hacia mejores prácticas formales debe contar con el apoyo institucional, la aplicación normativa y la evaluación continua. La conclusión a la que se llega no es solo empírica, sino estructural: la psiquiatría no puede reformarse desde dentro, con su lógica actual de control, discreción y aislamiento epistémico. Una transformación creíble requiere anclar el campo en instituciones cívicas, legales y científicas externas con la autoridad y la

competencia necesarias para exigirle responsabilidades públicamente. Por lo tanto, debe producirse este necesario cambio sistémico, pasando del control centralizado a la colaboración estructurada, de la estandarización única para todos a la precisión personalizada, del silenciamiento profesional a la escucha estructural y del juicio discrecional a la acción verificable y reproducible. El restablecimiento de la legitimidad clínica, la coherencia ética y la confianza pública depende de la implementación de sistemas transparentes de conocimiento y responsabilidad, integrados en los ámbitos de la salud, la educación y la gobernanza. La salud, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de un bienestar físico, mental y social completo. La salud mental se entiende como una condición en la que el individuo puede desarrollar sus capacidades, gestionar el estrés normal, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Bajo regímenes de coacción, impunidad y negación epistémica, estas condiciones no solo no se cumplen, sino que se impiden estructuralmente.

La construcción de sistemas de atención viables debe comenzar con la eliminación de las prácticas coercitivas, la institucionalización del consentimiento informado, la proceduralización de la dignidad y el pleno reconocimiento legal de cada individuo como sujeto de derechos. Deben prevalecer las leyes superiores, que protegen la vida y la integridad física, la libertad de los ciudadanos responsables que se cuidan a sí mismos y a los demás en acciones compartidas que conducen a la mejora. Estos nunca serán meros ideales a los que aspirar, siempre y cuando aquellos que los niegan con mala voluntad se hagan a un lado y dejen que el trabajo honesto tenga prioridad, sino imperativos fundamentales respaldados por todas las normas internacionales, la validación empírica y la necesidad moral. A medida que avanzan los conocimientos médicos y la práctica ética, la obstrucción o el retraso en la adopción de enfoques de vanguardia se vuelve no solo indefendible desde el punto de vista científico, sino también ética y jurídicamente reprensible. El desarrollo profesional continuo, la integración intersectorial y la modernización de las infraestructuras son innegociables. Ya no es aceptable mantener prácticas obsoletas o perjudiciales en nombre de la tradición, la autoridad o la conveniencia. La mentalidad singular y compartida debe ser la de una cooperación basada en la evidencia, respetuosa con la vida y anclada en los derechos, en la que todos los sectores de la sociedad —médico, jurídico, académico y cívico— trabajen en conjunto para garantizar que lo que se denomina «atención» haga honor a su nombre.

Esta transformación, basada en lo mejor de las tradiciones científicas y médicas, no solo es urgente, sino que ya debería haberse llevado a cabo hace tiempo. La falta de acción perpetuaría unas condiciones en las que se suspenden los derechos, se niega la participación y se institucionaliza el sufrimiento. El único camino viable es el diseño: la construcción de sistemas que prevengan el daño antes de que se produzca, protejan a las personas en situación de riesgo y apoyen a todas las personas en su búsqueda de la salud, la autonomía y la contribución social. Este es el deber mínimo que se le debe a quienes han sufrido en silencio bajo formas ilegítimas de control y a todos los que, a pesar de todo, siguen comprometidos con la reconstrucción de estructuras dignas de llamarse «cuidado».

9. Referencias

- Aarons, G. A., Hurlburt, M. y Horwitz, S. M. (2011). Advancing a conceptual model of evidence-based practice implementation in public service sectors. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 38(1), 4-23.
- Abbasi, I. S. y Al-Sharqi, L. (2015). Media censorship: Freedom versus responsibility. *Journal of Law and Conflict Resolution*, 7(4), 21-24.
- Allen, C., y Mehler, D. M. A. (2019). Retos, beneficios y consejos de la ciencia abierta en los inicios de la carrera profesional y más allá. *PLoS Biology*, 17(5), e3000246.
- Alonso-Tejada, F., y López-Morales, M. L. (2015). Atención psiquiátrica en el manicomio de Santa Isabel (1936-1939). *History of Psychiatry*, 26(3), 397-410. Analiza los perfiles de los pacientes y la dinámica institucional durante la guerra.
- Alotaibi, H. (2025). Una revisión histórica de los médicos andaluces y el tratamiento de la salud mental. *Journal of Bioethical Inquiry*. <https://doi.org/10.1007/s11673-024-10412-5>
- Alvesson, M., & Sköldbberg, K. (2000). Metodología reflexiva: nuevas perspectivas para la investigación cualitativa. SAGE Publications.
- Amnistía Internacional. (2019). «Dicen que eres una amenaza para la sociedad»: prácticas psiquiátricas abusivas en Rusia. Amnistía Internacional.
- Aragónés-Calleja, M., y Sánchez-Martínez, V. (2023).
- Asad, M. R., Almansour, M., Kazmi, S. Y., Alzahrani, R. E., Ahmed, M. M., y Nazeer, M. (2024). Paradigmas educativos en la historia de la medicina islámica: una revisión. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 16(Suppl 1), S56–S59. https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_969_23
- Bandura, A. (1999). Desvinculación moral en la perpetración de actos inhumanos. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209.
- Bandura, A. (2017). Mecanismos de desvinculación moral. En *Insurgent terrorism* (pp. 85-115). Routledge.
- Banks, S., Armstrong, A., Carter, K., Graham, H., Hayward, P., Henry, A. y Moore, N. (2013). Ética cotidiana en la investigación participativa basada en la comunidad. *Contemporary Social Science*, 8(3), 263-277.
- Bartky, S. L. (1990). *Feminidad y dominación: Estudios sobre la fenomenología de la opresión*. Routledge.
- Battie, W. (1975). *Tratado sobre la locura* (obra original publicada en 1751). Garland.
- Bauer, M. S., Damschroder, L., Hagedorn, H., Smith, J. y Kilbourne, A. M. (2015). Introducción a la ciencia de la implementación para no especialistas. *BMC Psychology*, 3, 32.

- Baum, F., MacDougall, C. y Smith, D. (2006). Investigación-acción participativa. *Revista de Epidemiología y Salud Comunitaria*, 60(10), 854.
- Baum, F., MacDougall, C. y Smith, D. (2006). Investigación-acción participativa. *Revista de Epidemiología y Salud Comunitaria*, 60(10), 854-857.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Estudios en sociología de la desviación*. Free Press.
- Bell, K. y Elliott, D. (2014). Censura en nombre de la ética: investigación crítica en salud pública en la era de la regulación de los sujetos humanos. *Critical Public Health*, 24(4), 385-391.
- Ben-Ari, E. T. (2002). Expert systems in mental health: Implications for diagnosis and treatment. *AI & Society*, 16(1), 70-79.
- Bentall, R. P. (2003). *La locura explicada: psicosis y naturaleza humana*. Penguin.
- Berk, M., Kapczinski, F., Andreazza, A. C., Dean, O. M., Giorlando, F., Maes, M., ... y Malhi, G. S. (2011). Vías subyacentes a la neuroprogresión en el trastorno bipolar: enfoque en la inflamación, el estrés oxidativo y los factores neurotróficos. *Neuroscience & biobehavioral reviews*, 35(3), 804-817.
- Berry, H. L., Waite, T. D., Dear, K. B., Capon, A. G., & Murray, V. (2019). Argumentos a favor del pensamiento sistémico sobre el cambio climático y la salud mental. *Nature Climate Change*, 9(4), 310-312.
- Bertolín-Guillén, J. M. (2021). Estado actual de la psicofarmacología, las psicoterapias y otras intervenciones en los problemas y trastornos de salud mental. *Eur J Appl Sci*, 9(5).
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bobes-Bascaran, M. T., Parellada, M., Bascaran, M. T., Saiz, P. A., ... y Arango, C. (2012). El estado de la psiquiatría en España. *Revista internacional de psiquiatría*, 24(4), 347-355.
- Bobes, J., García-Portilla, M., Bobes-Bascarán, T., Parellada, M., Bascarán, M., Sáiz, P., ... & Arango, C. (2012). El estado de la psiquiatría en España. *Revista Internacional de Psiquiatría*, 24(4), 347-355.
- Bobes, J., Vázquez-Barquero, J. L., & Salvador-Carulla, L. (2010). La reforma psiquiátrica y la Ley General de Salud Pública de 1986 en España. En *Acción conjunta sobre salud mental y bienestar* (pp. 15-25). Salud de la UE. Describe los principales esfuerzos de desinstitutionalización y el desarrollo de la atención comunitaria.
- Bolade-Ogunfodun, Y., Soga, L. R., y Laker, B. (2023). Posicionalidad entrelazada y marcos interpretativos de referencia: un relato autoetnográfico. *Journal of Management Inquiry*, 32(2), XX-XX.
- Bottaccioli, F. y Bottaccioli, A. G. (2025). Las bases filosóficas y científicas para la integración de la medicina y la psicología. En *PsicoNeuroInmunología: Volumen 1: Integración de la psicología, la neurología y la inmunología* (pp. 59-95). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Bourdieu, P. (2001). *Dominación masculina*. Stanford University Press.

Bourgois, P. (2001). *En busca del respeto: vendiendo crack en El Barrio*. Cambridge University Press.

Boyle, M. (2002). *Esquizofrenia: ¿un delirio científico?* (2.^a ed.). Routledge.

Branch, W. T. (2000). La ética del cuidado y la educación médica. *Academic Medicine*, 75(2), 127-132.

Breña, I., Mendia, J., Díaz-Gorriti, V. y Rotaetxe, O. (2025). Violencia de pareja y trastornos alimentarios: una revisión sistemática. *Current Psychology*, 44(3), 1696-1716.

Uniendo la iniciativa QualityRights de la Organización Mundial de la Salud y el programa de la Asociación Mundial de Psiquiatría sobre la implementación de alternativas a la coacción en la atención de la salud mental: un objetivo común para la acción. *BJPsych Open*, 10(1).

Brown, R. A., Barber, P., Hickman, N. y Martin, D. (2023). La legislación sobre salud mental en Inglaterra y Gales: una guía para los profesionales de la salud mental.

Brown, V. (2009). Muerte social y vida política en el estudio de la esclavitud. *The American historical review*, 114(5), 1231-1249.

Brydán, D. (2016). Internacionalismo del Eje: expertos sanitarios españoles y la «Nueva Europa» nazi, 1939-1945. *Historia contemporánea europea*, 25(2), 291-311.

Brydán, D. (2016). Axis Internationalism: Spanish Health Experts and the Nazi 'New Europe', 1939–1945. *Contemporary European History*, 25(2), 291–311.

Burstow, B. (2015). *La psiquiatría y el negocio de la locura: una reflexión ética y epistemológica*. Palgrave Macmillan.

Calcedo-Barba, C., Antón Basanta, M., Paz Ruiz, J., Muro Álvarez, J., Elizagárate Zabala, I., Estévez Closas, P., López López, J., & Barrios Flores, S. (2024). Mentes indiferentes, sistemas rotos: la atención sanitaria mental en las prisiones de España. *Revista de Salud Penitenciaria*, 30(1), 45-61.

Calvani, R., Picca, A., Lo Monaco, M. R., Landi, F., Bernabei, R., & Marzetti, E. (2018). De microbios y mentes: una revisión narrativa sobre el envejecimiento del segundo cerebro. *Frontiers in medicine*, 5, 53.

Campos, R., & Novella, E. J. (2017). De la higiene mental a la salud mental: ideología, discursos y prácticas en la España franquista (1939-1975). *Dynamis*, 37(1), 65–87.

Proyecto Canadiense de Directrices para la Desprescripción. (2024). Directrices y algoritmos basados en la evidencia para la desprescripción, desarrollados por el Instituto de Investigación Bruyère y colaboradores.

Proyecto Canadiense de Directrices para la Desprescripción. (2024). Directrices y algoritmos basados en la evidencia para la desprescripción desarrollados por el Instituto de Investigación Bruyère y colaboradores. [Deprescribing.org](https://deprescribing.org).

- Carbonell Marqués, Á., y Navarro-Pérez, J. J. (2019). La crisis asistencial en España: análisis de la situación del cuidado familiar en salud mental desde una perspectiva psicosocial profesional. *Trabajo Social en Salud Mental*, 17(6), 743-760.
- Carr, C. L. (1988). Coerción y libertad. *American Philosophical Quarterly*, 25(1), 59-67.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., y Neville, A. J. (2014). El uso de la triangulación en la investigación cualitativa. *Foro de Enfermería Oncológica*, 41(5), 545-547.
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, J. F., ... y Leal-Cercós, C. (2012). Situación en España del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) para enfermos mentales graves. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1).
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, J. F., ... & Leal-Cercós, C. (2012). Situación en España del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) para enfermos mentales graves. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1).
- Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Bellido-Rodríguez, C., Lera-Calatayud, G., Asensio-Pascual, P., Pérez-Prieto, J. F., Calabuig-Crespo, R., & Leal-Cercós, C. (2015). La situación actual del tratamiento ambulatorio involuntario en España. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 40(1), 27-33.
- Chambers, C. (2019). Los siete pecados capitales de la psicología: un manifiesto para reformar la cultura de la práctica científica. Princeton University Press.
- Chambers, D. A. y Azrin, S. T. (2020). La ciencia de la implementación: cambiando las prácticas de salud mental. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 1-30.
- Chmielowska, M., Mannocci, N., Tansel, A. y Zisman-Ilani, Y. (2022). Apoyo entre pares y toma de decisiones compartida en el diálogo abierto: oportunidades y recomendaciones. *Frontiers in Psychology*, 13.
- Chrousos, G. P. (2009). Estrés y trastornos del sistema estresante. *Nature Reviews Endocrinology*, 5(7), 374-381.
- Cianconi, P., et al. (2020). El impacto del cambio climático en la salud mental: una revisión descriptiva sistemática. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 74.
- Clandinin, D. J., Caine, V., & Lessard, S. (2018). La ética relacional de la investigación narrativa. Routledge.
- Coerción en la enfermería psiquiátrica y de salud mental: un análisis conceptual. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(3), 590-609.
- Cohen, S. (2001). Estados de negación: saber sobre las atrocidades y el sufrimiento. Polity Press.
- Cohen, S. (2013). Estados de negación: saber sobre las atrocidades y el sufrimiento. John Wiley & Sons.

- Cohen, S. I. (1975). Prescripción excesiva de fármacos psicotrópicos. *British Medical Journal*, 4(5995), 520.
- Compton, M. T. y Shim, R. S. (2015). Los determinantes sociales de la salud mental. *Focus*, 13(4), 419-425.
- Cook, T., Brandon, T., Zonouzi, M. y Thomson, L. (2019). Equilibrios desestabilizadores: Aprovechar el poder de la disrupción en la investigación-acción participativa. *Educational Action Research*, 27(3), 379-395.
- Cosgrove, L. y Whitaker, R. (2015). *La psiquiatría bajo influencia: corrupción institucional, daño social y recetas para la reforma*. Palgrave Macmillan.
- Costa, L., Voronka, J., Landry, D., Reid, J., McFarlane, B., Reville, D. y Church, K. (2012). Recuperando nuestras historias: un pequeño acto de resistencia. *Estudios en Justicia Social*, 6(1), 85-101.
- Coulehan, J. y Williams, P. C. (2001). Vencer la virtud: El impacto de la educación médica. *Academic Medicine*, 76(6), 598-605.
- Dain, N. (2007). *La locura y el mito del manicomio: respuestas a los trastornos mentales en Estados Unidos e Indonesia*. Transaction Publishers.
- Damschroder, L. J., et al. (2009). Fomentar la aplicación de los resultados de la investigación sobre servicios de salud en la práctica: un marco consolidado para avanzar en la ciencia de la implementación. *Implementation Science*, 4, 50.
- Davies, J., Read, J. y McKeown, M. (2022). Críticas al sistema de salud mental, daños y alternativas: una revisión exploratoria. *Psychosis*, 14(1), 1-14.
- Deegan, P. E. (2006). Toma de decisiones compartida y gestión de la medicación en el proceso de recuperación. *Psychiatric Services*, 57(11), 1636-1645.
- Degnin, F. D. (2009). Pacientes difíciles, medicación excesiva y pensamiento grupal. *The Journal of Clinical Ethics*, 20(1), 64-74.
- Delpit, L. (2006). *Los hijos de los demás: conflicto cultural en el aula* (2.^a ed.). The New Press.
- Dencker, S. J., Ahlfors, U. G., Bech, P., Elgen, K. y Lingjærde, O. (1986). Classification of side effects in psychopharmacology. *Pharmacopsychiatry*, 19(01), 40-42.
- Desviat, M. (2011). La reforma psiquiátrica 25 años después de la Ley General de Sanidad. *Revista Española de Salud Pública*, 85(5), 427-436.
- Dinan, T., & Dinan, T. G. (Eds.). (2023). *Psiquiatría nutricional: manual para clínicos*. Cambridge University Press.
- Dingwall, R. (1997). Reflexividad y proceso de investigación. En J. A. Smith, R. Harré y L. Van Langenhove (Eds.), *Repensar los métodos en psicología* (pp. 179-192). SAGE Publications.

- Dixon, T. (2015). Tratamiento, disuasión o etiquetado: perspectivas de los delincuentes con trastornos mentales sobre el control social. *Sociology of Health & Illness*, 37(2), 232-246.
- Dotson, K. (2012). Una historia con moraleja: sobre la limitación de la opresión epistémica. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 33(1), 24-47.
- Díaz-Gutiérrez, M. J., Martínez-Cengotitabengoa, M., Bermúdez-Ampudia, C., García, S., López, P., Martínez-Cengotitabengoa, M., ... y González-Pinto, A. (2018). Sobredosis de benzodiazepinas/fármacos Z y caídas en adultos mayores: costes para el sistema sanitario. *Gerontología experimental*, 110, 42-45.
- D'Amato, F., Lazzarotto, D., & Leone, P. (2023). Sedación sin consentimiento: una forma de tortura médica en las salas psiquiátricas italianas. *European Journal of Criminology*, 20(5), 845–862.
- Ehrenberg, A. (2010). El cansancio del yo: diagnóstico de la historia de la depresión en la era contemporánea. McGill-Queen's University Press.
- Eiroa-Orosa, F. J. y Rowe, M. (2017). Llevar el concepto de recuperación a las escuelas en España: un estudio de caso sobre la reforma de la salud mental. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 20(4), 345-363.
- Eiroa-Orosa, F. J., & Rowe, M. (2017). Llevar el concepto de recuperación a las escuelas en España: un estudio de caso sobre la reforma de la salud mental. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 20(4), 345–363.
- Ekbäck, M., Rådmark, J., Molin, E., Strömbäck, M., Midgley, N., & Henje, E. (2024). El marco del poder, la amenaza y el significado: un estudio cualitativo de la depresión en adolescentes y adultos jóvenes. *Journal of Constructivist Psychology*, publicación anticipada en línea.
- El-Khoury, J., Haidar, R. y Barkil-Oteo, A. (2021). Tortura psicológica: características e impacto en la salud mental. *International Journal of Social Psychiatry*, 67(5), 493-503.
- Engel, G. L. (1967). Un entorno psicológico de la enfermedad somática: el complejo «rendirse-rendirse».
- Engel, G. L. (1968). Un entorno vital propicio para la enfermedad: el complejo de rendirse-rendirse. *Annals of Internal Medicine*, 69(2), 293-300.
- Epstein, M. (2013). El trauma de la vida cotidiana. Penguin Books.
- Espinosa, I., & Comelles, M. (1966). Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer tercio del siglo XX. Valencia: Instituto de Historia de la Medicina.
- Experiencia de coacción entre profesionales de enfermería en una unidad de salud mental de estancia media: un estudio cualitativo en España. *Revista de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental*, 30(5), 983-993.
- Fals-Borda, O. (1988). Conocimiento y poder popular. Apex Press.

Fanon, F. (1963). *Los condenados de la tierra* (C. Farrington, trad.). Grove Press.

Farberow, N. L. (2005). El profesional de la salud mental como superviviente de un suicidio. *Neuropsiquiatría clínica*, 2(1), 13-20.

Farmer, P. (1999). *Infecciones y desigualdades: Las plagas modernas*. University of California Press.

Farmer, P. (2003). *Patologías del poder: salud, derechos humanos y la nueva guerra contra los pobres*. University of California Press.

Farmer, P. (2004). Una antropología de la violencia estructural. *Antropología actual*, 45(3), 305-325.

Farmer, P. (Ed.), Kleinman, A., Kim, J. Y., & Basilio, M. (2013). *Reimaginar la salud global: Una introducción*. University of California Press.

Farmer, T., Robinson, K., Elliott, S. J. y Eyles, J. (2006). Developing and implementing a triangulation protocol for qualitative health research. *Qualitative Health Research*, 16(3), 377-394.

Fernández-Real, J. M., Serino, M., Blasco, G., Puig, J., Daunis-i-Estadella, J., Ricart, W., ... y Portero-Otín, M. (2015). La microbiota intestinal interactúa con la microestructura y la función cerebral. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 100(12), 4505-4513.

Fernando, S. (2010). *Salud mental, raza y cultura* (3.ª ed.). Palgrave Macmillan.

Fernando, S. (2017). *Racismo institucional en psiquiatría y psicología clínica: La raza importa en la salud mental* (2.ª ed.). Palgrave Macmillan.

Fernando, S. (2017). *Racismo institucional en psiquiatría y psicología clínica: La raza importa en la salud mental*. Palgrave Macmillan.

Fernández, O., Montero, A. C., Parra, J., & Díaz, M. V. (2018). Cero contenciones: Derechos Humanos en los servicios de atención a la Salud Mental. *Norte de salud mental*, 15(59), 46-62.

Ferreirós Marcos, C. E. (2013). *Salud mental y derechos humanos: la cuestión del tratamiento ambulatorio involuntario*.

Field-Springer, K. (2020). Etnografía reflexiva encarnada con sensibilidades aplicadas: reflexiones metodológicas sobre la investigación cualitativa implicada. *Investigación cualitativa en psicología*, 17(2), 112-130.

Fisher, P. (2012). Cuestionamiento de la ética de la vulnerabilidad y el consentimiento informado en los estudios cualitativos desde una perspectiva de ciudadanía y derechos humanos. *Ética y Bienestar Social*, 6(1), 2-17.

Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. y Wallace, F. (2005). *Investigación sobre la implementación: una síntesis de la literatura*. Red Nacional de Investigación sobre la Implementación, Universidad del Sur de Florida.

- Flaherty, J. A., Gaviria, F. M., Pathak, D., Mitchell, T., Wintrob, R., Richman, J. A. y Birz, S. (1988). Desarrollo de instrumentos para la investigación psiquiátrica intercultural. *Revista de Enfermedades Nerviosas y Mentales*, 176(5), 257-263.
- Foucault, M. (1973). *El nacimiento de la clínica: una arqueología de la percepción médica* (A. M. Sheridan, trad.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (2003). *Locura y civilización*. Routledge.
- Foucault, M. (2006). *Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason* (R. Howard, trad.). (Publicado originalmente en 1961) Vintage.
- Fowers, B. J. (2015). Conflicto, jerarquía, orden social y estatus. En *La evolución de la ética: la socialidad humana y el surgimiento de la mentalidad ética* (pp. 267-303). Londres: Palgrave Macmillan UK.
- Frances, A. (2013). Salvando lo normal: La rebelión de un insider contra el diagnóstico psiquiátrico descontrolado, el DSM-5, las grandes farmacéuticas y la medicalización de la vida cotidiana. *Psicoterapia en Australia*, 19(3), 14.
- Frances, A. (2013). Salvando lo normal: La rebelión de un insider contra el diagnóstico psiquiátrico descontrolado, el DSM-5, las grandes farmacéuticas y la medicalización de la vida cotidiana. William Morrow.
- Francisco Torres-González. (2022). Internamiento y tratamiento involuntarios en España: Marco jurídico y lagunas procedimentales. Mental Illness Policy Org.
- Frank, A. W. (1995). *El narrador herido: Cuerpo, enfermedad y ética*. University of Chicago Press.
- Freeman, M. y Unwin, P. (2020). Restricciones mecánicas y consecuencias psicológicas de la violencia institucional. *Mental Health Review Journal*, 25(3), 149-160.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Continuum.
- Freire, P. (2000). *Pedagogía del oprimido* (edición del 30.º aniversario, M. Bergman Ramos, trad.). Continuum.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., ... y Zurayk, H. (2010). Profesionales de la salud para un nuevo siglo: Transformar la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. *The Lancet*, 376(9756), 1923-1958.
- Frerichs, L., Lich, K., Dave, G., & Corbie-Smith, G. (2016). Integrar la ciencia de sistemas y la investigación participativa basada en la comunidad para lograr la equidad en salud. *American Journal of Public Health*, 106(2), 215-222.
- Fricker, M. (2017). Conceptos en evolución de la injusticia epistémica. En *The Routledge handbook of epistemic injustice* (pp. 53-60). Routledge.
- Fuller, K., DeWolfe, T. y Coughlin, M. (2022). Atención informada sobre el trauma y que apoya el desarrollo. *Developmental Observer*, 15(1).

- Gabriel, L. y Casemore, R. (Eds.). (2022). *Ética relacional en la práctica: narrativas de la terapia y la psicoterapia*. Routledge.
- Gaete, J. M. y Fritsch, R. (2021). Crisis en psiquiatría: problemas epistemológicos y el reto de una visión pluralista. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 694260.
- Galtung, J. (1990). Violencia cultural. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- García Espino, J., & Lara Ladislao, A. (1998). *La psiquiatría en la España de fin de siglo: un estudio sobre la reforma psiquiátrica y las nuevas formas de atención en salud mental*. Madrid: Díaz de Santos.
- Gershon, M. D. (1999). El sistema nervioso entérico: un segundo cerebro. *Hospital practice*, 34(7), 31-52.
- Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Cano, G. M., Savage, M., ... y Funk, M. (2024). Uniendo la iniciativa QualityRights de la Organización Mundial de la Salud y el programa de la Asociación Mundial de Psiquiatría sobre la implementación de alternativas a la coacción en la atención de salud mental: un objetivo común para la acción. *BJPsych Open*, 10(1), e23.
- Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Cano, G., Savage, M., ... & Funk, M. (2024).
- Gilligan, C. (1996). *Violencia: Reflexiones sobre una epidemia nacional*. Vintage Books.
- Goffman, E. (1961). *Asilos: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales y otros reclusos*. Anchor Books.
- González Block, M. A., & Mills, A. (2003). Evaluación de la capacidad para la investigación sobre políticas y sistemas de salud en países de ingresos bajos y medios. *Health Research Policy and Systems*, 1(1), 1.
- Good, B. (1994). *Medicina, racionalidad y experiencia: una perspectiva antropológica*. Cambridge University Press.
- Good, B. J. (1992). Cultura, diagnóstico y comorbilidad. *Cultura, medicina y psiquiatría*, 16(4), 427-446.
- Good, B. J. (1994). *Medicina, racionalidad y experiencia: una perspectiva antropológica*. Cambridge University Press.
- Gooding, P., McSherry, B., Roper, C. y Grey, F. (2022). Alternativas a la coacción en entornos de salud mental: una revisión bibliográfica.
- Goodman, L. A., Fels Smyth, K., Borges, A. M. y Glenn, C. (2016). Cuando las crisis chocan: cómo la violencia de pareja y la violencia estructural determinan las necesidades de las mujeres pobres y sin hogar con enfermedades mentales. *Community Mental Health Journal*, 52(7), 748-755.
- Gotzsche, P. (2019). *Medicamentos mortales y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido la sanidad*. CRC Press.

- Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., Caswell, W. y Robinson, N. (2006). Perdidos en la traducción del conocimiento: ¿es hora de trazar un mapa? *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 26(1), 13-24.
- Gravlee, C. C. (2022). Diseño y métodos de investigación en antropología médica. En Singer, M. y Erickson, P. (Eds.), *A companion to medical anthropology* (pp. 67-92). Wiley-Blackwell.
- Griffiths, W., y Knutson, A. L. (1960). El papel de los medios de comunicación en la salud pública. *American Journal of Public Health and the Nations Health*, 50(4), 515-523.
- Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). De la mejor evidencia a la mejor práctica: implementación efectiva del cambio en la atención al paciente. *The Lancet*, 362(9391), 1225–1230.
- Groot, P. C., y van Os, J. (2023). Manejo de los síntomas de abstinencia mediante tiras de reducción gradual. *British Journal of General Practice*, 73(730).
- Guidi, J., Lucente, M., Sonino, N. y Fava, G. A. (2020). La carga alostática y su impacto en la salud: una revisión sistemática. *Psicoterapia y psicosomática*, 90(1), 11-27.
- Gupta-Wright, M. (2018). Multi-posicionalidad e «intermediedad»: Reflexiones sobre el trabajo de campo etnográfico en el sureste de Malaui. En *La política de la investigación en África* (pp. 53-73). Springer.
- Guzmán-Parra, J., Aguilera-Serrano, C., García-Sánchez, J., García-Spínola, E., Torres-Campos, D., Moreno, J., ... y Mayoral, F. (2018). Coerción experimentada, estrés postraumático y satisfacción con el tratamiento asociado a diferentes medidas coercitivas durante la hospitalización psiquiátrica. *International Journal of Mental Health Nursing*, 28(2), 448-456.
- Gías Gil, B. (2013). Tratamiento ambulatorio involuntario en psiquiatría: una revisión desde la bioética. *Revista de Bioética y Derecho*, (29), 109-121.
- Gøtzsche, P. C. (2015), *Psiquiatría mortal y negación organizada*. People's Press.
- Hafferty, F. W. (1998). Más allá de la reforma curricular: Afrontar el currículo oculto de la medicina. *Academic Medicine*, 73(4), 403-407.
- Hahn, R. A. (1995). *Enfermedad y curación: una perspectiva antropológica*. Yale University Press.
- Harper, D. y Speed, E. (2012). Descubriendo la recuperación: El resistible auge de la recuperación y la resiliencia. *Estudios en Justicia Social*, 6(1), 9-25.
- Hartmann, E. M. y Crumlish, C. (2022). Prácticas coercitivas y tortura inducida por medicamentos en entornos psiquiátricos forenses. *Psiquiatría, Psicología y Derecho*, 29(2), 227-239.
- Healy, D. (2012). *Pharmageddon*. University of California Press.
- Heffernan, M. (2002). *Ceguera voluntaria: por qué ignoramos lo obvio a nuestro propio riesgo*. Walker & Company.
- Heim, S. (2016). La vergüenza en la religión y la vida pública. En J. L. Dolezal y C. Lyons (Eds.), *Vergüenza: teoría, terapia, teología* (pp. 95-112). Jessica Kingsley Publishers.

Held, B. S. (2020). Violencia epistemológica y ética del discurso en psicología. *Theory & Psychology*, 30(3), 349–370. <https://doi.org/10.1177/0959354319883943>

Hemer, S. R. (2023). La ética y las obligaciones de las relaciones etnográficas a largo plazo: momentos reveladores y el concepto de solidaridad. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 29(3), 631-647.

Hempeler, C., Scholten, M., Werning, A. y Gather, J. (2024). ¿Qué es la coacción y puede justificarse su uso en la atención de la salud mental? Un análisis ético. En *Coerción y violencia en entornos de salud mental: causas, consecuencias, gestión* (pp. 149-172). Cham: Springer Nature Switzerland.

Herman, J. L. (1997). *Trauma y recuperación: Las secuelas de la violencia, desde el abuso doméstico hasta el terror político*. Basic Books.

Herman, J. L. (1997). *Trauma y recuperación: las secuelas de la violencia, desde el abuso doméstico hasta el terror político*. Basic Books.

Hermann, R. C. y Provost, S. (2003). Interpretación de datos de medición para la mejora de la calidad: estándares, medios, normas y puntos de referencia. *Servicios psiquiátricos*, 54(5), 655-657.

Heron, J. y Reason, P. (1997). Un paradigma de investigación participativa. *Investigación cualitativa*, 3(3), 274-294.

Hoff, P. (2010). Restricciones químicas: uso y abuso en hospitales psiquiátricos. *Revista Internacional de Derecho y Psiquiatría*, 33(4), 282-287.

Hollan, D. (1997). La relevancia de la etnografía centrada en la persona para la psiquiatría transcultural. *Transcultural Psychiatry*, 34(2), 219–234.

Hollander, D. (2010). Violencia estructural y poblaciones vulnerables. *Nursing Clinics of North America*, 45(3), 415-426.

Holmes, S. M., y Marcus, G. E. (2008). La colaboración hoy en día y la reinención de la escena clásica del encuentro en el trabajo de campo. *Antropologías colaborativas*, 1(1), 81-101.

Honey, A., Boydell, K. M., Coniglio, F., et al. (2020). La investigación de experiencias vividas como recurso para la recuperación: un estudio de métodos mixtos. *BMC Psychiatry*, 20, 456. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02861-0>

Horowitz, M., & Taylor, D. M. (2024). Las directrices de desprescripción de Maudsley: antidepresivos, benzodiazepinas, gabapentinoides y fármacos Z. John Wiley & Sons.

Hotzy, F., & Jaeger, M. (2016). Relevancia clínica de la coacción informal en el tratamiento psiquiátrico: una revisión sistemática. *Frontiers in Psychiatry*, 7.

Houlders, M., Bortolotti, L. y Broome, M. (2021). Engaging with delusions: An epistemic injustice perspective. [Nombre de la revista], [volumen]([número]), 1-20.

<https://doi.org/10.1136/bmj.4.5995.520>

- Huertas, R. (2017). El inicio de la psiquiatría franquista: el Congreso Nacional de Neurología y Psiquiatría (Barcelona, 1942). *Dynamis*, 37(1), 23–43.
- Hultman, L., & Hultman, M. (2023). «Créeme, solo yo sé cómo me siento». Un relato autoetnográfico de experiencias de injusticia epistémica en la atención de la salud mental. *Frontiers in Psychiatry*, 14.
- Human Rights Watch. (2016). Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). Vivir en el infierno: abusos en hospitales psiquiátricos de Uganda. Human Rights Watch.
- Hysong, S. J. (2009). Lecciones de la indefensión aprendida: consecuencias clínicas de «rendirse». *Clinical Psychology Review*, 29(5), 520-536.
- Insel, T. (2013). Blog del director: Transformando el diagnóstico. Instituto Nacional de Salud Mental.
- Jacka, F. N. y Berk, M. (2012). Estrategias preventivas en la depresión: recopilación de pruebas sobre los factores de riesgo y las posibles intervenciones. *The British Journal of Psychiatry*, 201(5), 339-341. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.107797>
- Jacka, F. N., O’Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... y Berk, M. (2015). Ensayo controlado aleatorio sobre la mejora de la dieta en adultos con depresión mayor (ensayo SMILES). *BMC Medicine*, 15, 23.
- Jiménez, A. I. (2005). El paciente anciano polimedicado: Efectos sobre su salud y sobre el sistema sanitario. *Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*, 29(6).
- Johnstone, L. (2020). Patrones generales en el marco de poder, amenaza y significado: principios y práctica. *Journal of Constructivist Psychology*, 35(1), 16-26.
- Johnstone, L., & Boyle, M. (2018). El marco de poder, amenaza y significado: un sistema conceptual alternativo no diagnóstico. *Journal of Humanistic Psychology*, 0022167818793289.
- Kalathil, J. (2018). Recuperación y resiliencia: relatos de mujeres africanas, afrocaribeñas y del sur de Asia sobre su recuperación tras sufrir trastornos mentales. Fundación para la Salud Mental.
- Kalathil, J. (2020). Locura, violencia y poder: una recopilación crítica. PCCS Books.
- Kalathil, J. y Fernando, S. (2012). Cuestionando la «esquizofrenia». *Open Mind*, 172.
- Kalisch, R., Müller, M. B. y Tüscher, O. (2017). Un marco conceptual para el estudio neurobiológico de la resiliencia. *Behavioral and Brain Sciences*, 38, e92.
- Kelagher, M., Ferdinand, A. y Paradies, Y. (2014). Experiencing racism in health care: The mental health impacts for Victorian Aboriginal communities. *Medical Journal of Australia*, 201(1), 44-47.
- Kemmis, S. y McTaggart, R. (2000). Investigación-acción participativa. En N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (2.ª ed., pp. 567-605). Sage.

- Kenny, K., Fotaki, M. y Scriver, S. (2019). La salud mental como arma: represalias contra los denunciantes y violencia normativa. *Journal of Business Ethics*, 160(3), 801-815.
- Kidd, S., Kenny, A., & McKinstry, C. (2015a). El significado de la recuperación en un servicio regional de salud mental: un estudio de investigación-acción. *Journal of Advanced Nursing*, 71(1), 181-192.
- Kidder, T. (2003). Más allá de las montañas: La búsqueda del Dr. Paul Farmer, un hombre que quería curar al mundo. Random House.
- Kinderman, P. (2014). Una receta para la psiquiatría: Por qué necesitamos un enfoque totalmente nuevo de la salud mental y el bienestar. Palgrave Macmillan.
- Kirk, S. A. y Kutchins, H. (1992).
- Kirk, S. A., Gomory, T. y Cohen, D. (2013). Ciencia loca: Coerción psiquiátrica, diagnóstico y drogas. Transaction Publishers.
- Kirsch, I. (2010). Las nuevas drogas del emperador: La explosión del mito de los antidepresivos. Basic Books.
- Kitchener, B. A. y Jorm, A. F. (2002). Formación en primeros auxilios para la salud mental dirigida al público: evaluación de los efectos sobre los conocimientos, las actitudes y el comportamiento de ayuda. *BMC Psychiatry*, 2(1), 10.
- Kjellin, L. y Wallsten, T. (2010). Coerción acumulada y resultados a corto plazo de la atención psiquiátrica hospitalaria. *BMC Psychiatry*, 10(1).
- Kleinman, A. (1980). Pacientes y sanadores en el contexto cultural: Una exploración de la frontera entre la antropología, la medicina y la psiquiatría. University of California Press.
- Kleinman, A. (1997). Escribiendo al margen: Discurso entre antropología y medicina. University of California Press.
- Kortmann, F. (2010). Psiquiatría transcultural: de la práctica a la teoría. *Psiquiatría Transcultural*, 47(4), 653-664.
- Kuhl, D. E. (2019). La muerte de la clínica: Transinformar la mirada clínica para contrarrestar la violencia epistémica (Tesis doctoral, Universidad de Western Ontario, Canadá).
- Ladkin, D. (2007). Investigación-acción, investigación participativa y el yo del investigador: una mirada más profunda a la base ontológica de la investigación-acción. *Action Research*, 5(3), 333-353.
- Laporte, J. R., Capellà, D., Porta, M. y Frati, M. E. (1983). Patrones de uso de psicofármacos en España desde una perspectiva internacional. En *Farmacología clínica en psiquiatría: tendiendo puentes entre la experimentación y la terapia* (pp. 18-31). Londres: Palgrave Macmillan UK.
- Laporte, J. R., Porta, M., Capellà, D., & Arnau, J. M. (1984). Los medicamentos en el sistema sanitario español. *Revista internacional de servicios de salud*, 14(4), 635-648.

- Lassiter, L. E. (2005). *La guía de Chicago para la etnografía colaborativa*. University of Chicago Press.
- Lehmann, P. (1998). Dejar los fármacos psiquiátricos. *Terapia conductual*, 223(227), 260.
- Lehmann, P. (1998). Perspectivas de (ex)usuarios y supervivientes de la psiquiatría. *Promoción de la salud mental en la agenda europea*.
- Lehmann, P. (2010). Medicalización e irresponsabilidad. *Revista de Psicología Crítica, Asesoramiento y Psicoterapia*.
- Lehmann, P. (2019). Paradigm shift: Treatment alternatives to psychiatric drugs, with particular reference to low-and middle-income countries. En *The Routledge Handbook of International Development, Mental Health and Wellbeing* (pp. 251–269). Routledge.
- Lehmann, P. (2024). La psiquiatría al desnudo: violaciones actuales de los derechos humanos en la psiquiatría en Alemania, Grecia y el resto del mundo. *Revista de Psicología Crítica, Asesoramiento y Psicoterapia*, 24(1), 16-37.
- Leichsenring, F., Steinert, C. y Ioannidis, J. P. (2019). Hacia un cambio de paradigma en el tratamiento y la investigación de los trastornos mentales. *Psychological medicine*, 49(13), 2111-2117.
- Levin, J. y McDevitt, J. (2002). *Los delitos de odio revisitados: la guerra de Estados Unidos contra los diferentes*. Westview Press.
- Leys, R. (2018). *El ascenso del afecto: genealogía y crítica*. University of Chicago Press.
- Li, Y., et al. (2025). Expresión génica y cambios epigenéticos en el TEPT, la depresión y la ansiedad en los primeros intervinientes: una revisión sistemática. *Journal of Traumatic Stress*.
- Locke, J. (1975). *Ensayo sobre el entendimiento humano* (P. H. Nidditch, Ed., obra original publicada en 1690). Clarendon Press.
- López-Martínez, A. E., Serrano-Ibáñez, E. R., Ruiz-Parraga, G. T., Gómez-Pérez, L., Ramírez-Maestre, C. y Esteve, R. (2018). Consecuencias físicas para la salud del trauma interpersonal: una revisión sistemática del papel de las variables psicológicas. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(3), 305-322.
- Lund, C., Breen, A., Flisher, A. J., Kakuma, R., Corrigall, J., Joska, J. A., Swartz, L. y Patel, V. (2010). Pobreza y trastornos mentales comunes en países de ingresos bajos y medios: una revisión sistemática. *Social Science & Medicine*, 71(3), 517–528.
- Lupton, D. (1997). Los médicos sobre la profesión médica. *Sociología de la salud y la enfermedad*, 19(4), 480-497.
- Maier, S. F. y Seligman, M. E. (1976). Indefensión aprendida: teoría y evidencia. *Revista de psicología experimental: general*, 105(1), 3.

Mandell, W. (2025). Orígenes de la higiene mental. Orígenes de la salud mental, (publicado originalmente en 1962) Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Markus, K. A. (2020). Violencia epistémica en la ciencia psicológica: ¿puede el conocimiento de, sobre y para las personas (marginadas) resolver el problema? *Theory & Psychology*, 30(3), 349-370. <https://doi.org/10.1177/0959354319883943>

Martimianakis, M. A., Maniate, J. M. y Hodges, B. D. (2009). Interpretaciones sociológicas de la profesionalidad. *Educación Médica*, 43(9), 829-837.

Martínez-Hernández, Á., Pié-Balaguer, A., Serrano-Miguel, M., Morales-Sáez, N., García-Santesmases, A., Bekele, D., & Alegre-Agís, E. (2020). La gestión colaborativa de la medicación antipsicótica y sus obstáculos: un estudio cualitativo. *Ciencias sociales y medicina*, 247, 112811.

Maté, G. (2021). *El mito de lo normal: Trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica*. Avery.

Maté, G. (2022). *El mito de lo normal: Trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica*. Knopf Canada.

McDonald, G. J. (2023). *El engaño de la reforma: la psiquiatría punitiva en la historia soviética* (Tesis doctoral, Universidad de Fordham).

McDowell, V. M., Calabria, V. y Bailey, D. (2023). La investigación-acción participativa y la historia oral como aliados naturales en la investigación sobre salud mental. *Qualitative Research*, 23(4), 512-530.

McEwen, B. S. y Wingfield, J. C. (2003). El concepto de alostasis en biología y biomedicina. *Hormones and Behavior*, 43(1), 2-15.

McGoey, L. (2007). *La voluntad de ignorar: una historia política del silencio estratégico*. Routledge.

McNall, M., Reed, C. S., Brown, R. y Allen, A. (2009). Intermediación en el compromiso entre la comunidad y la universidad. *Innovative Higher Education*, 33(5), 317-331.

McTaggart, R. (1991). Principios para la investigación-acción participativa. *Educación de Adultos Trimestral*, 41(3), 168-187.

Mead, S. y Filson, B. (2017). La mutualidad y el poder compartido como alternativa a la coacción y la fuerza. *Salud mental e inclusión social*, 21(3), 144-152.

Meloni, F., Vanthuyne, K. y Rousseau, C. (2015). Hacia una ética relacional: repensar la ética, la agencia y la dependencia en la investigación con niños y jóvenes. *Childhood*, 22(3), 340-354.

Mezzina, R., Borg, M., Marin, I., Sells, D., Topor, A., & Davidson, L. (2006). De la participación a la ciudadanía: cómo recuperar un papel, un estatus y una vida en el proceso de recuperación. *Archives of Andrology*, 9(1), 39-61.

Mezzina, R., Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A. y Sells, D. (2006). La naturaleza social de la recuperación: debate e implicaciones para la práctica. *Archives of Andrology*, 9(1), 63-80.

- Mezzina, R., Gopikumar, V., Jenkins, J., Saraceno, B. y Sashidharan, S. P. (2022). Vulnerabilidad social y desigualdades en salud mental en la «sindemia»: Llamada a la acción. *Frontiers in psychiatry*, 13, 894370.
- Michener, W. K. (2015). Diez reglas sencillas para crear un buen plan de gestión de datos. *PLOS Computational Biology*, 11(10), e1004525.
- Miles, S., & Freedman, A. (2023). Ética médica y tortura: revisión de la Declaración de Tokio. *The Lancet*, 401(10378), 218–219.
- Mills, C. (2014). *Descolonizar la salud mental global: la psiquiatrización del mundo mayoritario*. Routledge.
- Minkler, M. y Wallerstein, N. (Eds.). (2008). *Investigación participativa basada en la comunidad para la salud: del proceso a los resultados* (2.ª ed.). Jossey-Bass.
- Minkowitz, T. (2022). Repensar las intervenciones de la justicia penal para las personas con discapacidades psicosociales: la necesidad de la abolición y el apoyo estructural. *International Journal of Law and Psychiatry*, 82, 101797.
- Mollica, R. F. (2004). El cuestionario de trauma de Harvard: validación de un instrumento intercultural para medir la tortura, el trauma y el trastorno por estrés postraumático en refugiados. Programa de Harvard sobre Trauma en Refugiados.
- Moncrieff, J. (2010). El diagnóstico psiquiátrico como instrumento político. *Teoría Social y Salud*, 8(4), 370-382.
- Moncrieff, J. (2013). *Hablando claro: Una introducción a los fármacos psiquiátricos*. Barcelona: Herder.
- Moncrieff, J. (2013). *Las píldoras más amargas: La inquietante historia de los fármacos antipsicóticos*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Montero Bancalero, F. J. (2014). *Consideraciones hacia los psicofármacos en profesionales y estudiantes de medicina en España, y en profesionales de la medicina en México y en Colombia: un estudio comparativo* (Tesis doctoral, Universidad de Huelva).
- Montero Carrera, J. (2020). Deprescripción: Más allá del uso racional del medicamento. *Medicina de Familia Andalucía*, 21(1).
- Moon G. Risk and protection: the discourse of confinement in contemporary mental health policy. *Health Place*. Septiembre de 2000; 6(3):239-50. doi: 10.1016/s1353-8292(00)00026-5. PMID: 10936778.
- Moyn, S. (2015). Un compañero impotente: los derechos humanos en la era del neoliberalismo. *Law and Contemporary Problems*, 77(4), 147-169.
- Munir, K. y Staats, B. R. (2020). Tomarse en serio la reflexividad: experimentos de campo longitudinales y aprendizaje de los investigadores. *Academy of Management Discoveries*, 6(3), 378-403.

- Musen, M. A., Middleton, B. y Greenes, R. A. (2014). Sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas. En E. H. Shortliffe y J. J. Cimino (Eds.), *Informática biomédica: aplicaciones informáticas en la asistencia sanitaria y la biomedicina* (pp. 643-674). Springer.
- Méndez, J. E. (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/HRC/22/53). Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- New Economics Foundation. (2008). Cinco caminos hacia el bienestar: la evidencia. Obtenido de [sitio web de nef consulting; no se proporciona el enlace a petición del autor].
- Ochocka, J., Janzen, R. y Nelson, G. (2002). Compartir el poder y el conocimiento: Investigadores profesionales y consumidores/supervivientes de salud mental que trabajan juntos en un proyecto de investigación-acción participativa. *Revista de Rehabilitación Psiquiátrica*, 25(4), 379.
- Oldani, M. (2014). Deep pharma: Psiquiatría, antropología y desintoxicación farmacéutica. *Cultura, Medicina y Psiquiatría*, 38(2), 255-278.
- Olson, M., Seikkula, J. y Ziedonis, D. (2014). Los elementos clave de la práctica dialógica en el Diálogo Abierto: Criterios de fidelidad. Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y Defensores del Potencial Humano.
- Ortiz Lobo, A. (2013). *Hacia una psiquiatría crítica*. Valladolid: Editorial Grupo 5.
- Ortiz-Gómez, T. (2002). *Historia de la psiquiatría y estudios de género en España*. Granada: Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad de Granada.
- Oujo Fernández, C. M. *Del Psicoanálisis Multifamiliar a Diálogos Abiertos: Una Experiencia de Aplicación en un Servicio Público de Salud*.
- Palmer, C., Kelly, J. R., Stanton, C., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2022). Gut microbiota, depressive symptoms and dietary patterns in community-dwelling adults. *Journal of Affective Disorders*, 298, 494–502.
- Paradis-Gagné, É., Pariseau-Legault, P., Goulet, M., Jacob, J. y Lessard-Deschênes, C. (2021).
- Paris, J. (2020). *Overdiagnosis in psychiatry: How modern psychiatry lost its way while creating a diagnosis for almost all of life's misfortunes*. Oxford University Press.
- Paris, J. (2024). *Recetas para la mente: una visión crítica de la psiquiatría contemporánea*. Oxford University Press.
- Parker, M. (2007). Realización de estudios etnográficos en entornos médicos: cuestiones prácticas y éticas. *Social Science & Medicine*, 65(11), 2248-2259.
- Parrabera-García, S., Oujo-Fernández, C., Lirola, M. J., Cangas, A. J., Marfá-Vallverdú, J., Correa-Urquiza, M., & García-Torrents, E. (2023). Diálogo abierto en España: un estudio inicial sobre conocimientos y perspectivas. *Frontiers in Psychology*, 14, 1166919.

- Patel, N., Williams, A. C. de C., & Kellezi, B. (2018). Revisión de los resultados de las intervenciones psicológicas con supervivientes de tortura: cuestiones conceptuales, metodológicas y éticas. *Torture Journal*, 26(1), 15-30.
- Patterson, O. (2018). *Esclavitud y muerte social: un estudio comparativo, con un nuevo prefacio*. Harvard University Press.
- Perrin, E. C., Leslie, L. K., Boat, T. F. y el Comité sobre Aspectos Psicosociales de la Salud Infantil y Familiar. (2007). La crianza como prevención primaria. *JAMA*, 298(22), 2715-2717.
- Perry, B. D. y Szalavitz, M. (2017). *El niño que fue criado como un perro: y otras historias del cuaderno de un psiquiatra infantil* (3.^a ed.). Basic Books.
- Peterson, V. S. y Runyan, A. S. (Eds.). (2010). *Cuestiones globales de género en el trabajo de campo en condiciones de conflicto*. Rowman & Littlefield.
- Pies, R. (2007). ¿Hasta qué punto son «objetivos» los diagnósticos psiquiátricos? (Adivina otra vez). *Psychiatry (Edgmont)*, 4(10), 18.
- Pies, R. (2008). Más allá de la fiabilidad: biomarcadores y validez en psiquiatría. *Psiquiatría (Edgmont)*, 5(1), 48.
- Pinel, P., & Esquirol, J.-E. (1994). *Sobre la alienación mental [Des Maladies Mentales]* (W. Culpepper, trad., obra original publicada en 1838). Cambridge University Press.
- Pocobello, R., Seikkula, J., Saunders, R., Mosse, D., y von Peter, S. (2025). Diálogo abierto en todo el mundo: implementación, resultados, experiencias y perspectivas. *Frontiers in Psychology*, 16, 1621237.
- Portero, G. (2010). Tratamiento ambulatorio involuntario de carácter civil: Una revisión. *Cuadernos de Medicina Forense*, 16(1-2), 87-97.
- Portilla, N. de la. (2006). La psiquiatría de lengua española en el siglo XXI: realidad y compromiso. En *Memorias del XIV Coloquio IPLE / V Congreso APJ* (pp. x-xx). Guadalajara, México.
- Pozón, S. R. (2012). La toma de decisiones compartidas en pacientes con esquizofrenia: cuestiones médicas y éticas. *Dilemata*, (10), 263-277.
- Prabhu, G. G. (1967). Objectivity in psychiatric research-A review. *Indian Journal of Psychiatry*, 9(2), 119-134.
- Priest, N. (2021). Contagio social y suicidio: una visión sociológica. *Sociology Compass*, 15(10), e12913.
- Pérez-Fernández, F., & Peñaranda-Ortega, M. (2015). La situación de los manicomios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a comienzos del siglo XX: Un estudio a través de los boletines de la *Revista Frenopática Española*. *Revista de Historia de la Psiquiatría*, 45, 41-60.
- Pérez-Prieto, J. F., Cañete-Nicolás, C., Hernández-Viadel, M., Leal-Cercós, C., y Calabuig-Crespo, R. (2025). «Si alguien se hubiera parado a hablar conmigo»: un análisis desde los derechos

humanos del sistema de salud mental en España. *Revista de Salud y Derechos Humanos*, 27(2), 112-130.

Pūras, D. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Naciones Unidas, Asamblea General.

Pūras, D. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (A/HRC/35/21). Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Rakshasa-Loots, A. M., Steyn, C., Swiffen, D., Marwick, K. F., Semple, R. K., Reynolds, R. M., ... & Smith, D. J. (2025). Biomarcadores metabólicos de los resultados clínicos en enfermedades mentales graves (METPSY): protocolo para un estudio observacional prospectivo en el Centro de Psiquiatría Metabólica. *BMC psychiatry*, 25(1), 122.

Ramos-Pozón, S., Román-Maestre, B., & Blánquez, B. (2025). Medidas coercitivas en los servicios de discapacidad y salud mental: restricciones mecánicas desde una perspectiva bioética y jurídica en España. *International Journal of Law and Psychiatry*, 99, 102067.

Ramírez, F., Birtel, M. D., Awenat, Y., Fleming, P., Wilkes, S., Williams, S., & Haddock, G. (2024). We-Care-Well: Exploring the personal recovery of mental health caregivers through Participatory Action Research. *Frontiers in Public Health*, 12, Artículo 1366144.

Read, J. y Harper, D. J. (2020). El marco del poder, la amenaza y el significado: abordar la adversidad, desafiar los prejuicios y el estigma, y transformar los servicios. *Journal of Constructivist Psychology*, 35(1), 54-67.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2001). *Manual de investigación-acción: investigación y práctica participativas*. Sage.

Riker, W. H. (2017). La confianza como alternativa a la coacción. En *Coerción* (pp. 198-212). Routledge.

Roberts, C. (2000). Diálogo, posicionalidad y el marco legal de la investigación etnográfica. *Investigación sociológica en línea*, 5(4), 1-13.

Rodríguez-Cabrera, L., et al. (2024). Cambios epigenéticos producidos en mujeres víctimas de violencia de pareja: una revisión sistemática. *Journal of Clinical Epigenetics*.

Rodríguez-Morini, A. (2002). El debate en torno a los manicomios entre los siglos XIX y XX. *Dynamis: Acta Hispánica Ad Medicinæ Scientiarumque Historiam Illustrandam*, 17(1), e027.

Roncero, C., Armenteros, L., Bellido-Cambrón, C., Bonilla-Guijarro, A., & Gómez-Cibeira, E. (2025). El uso de benzodiazepinas en España: riesgos y perspectivas sobre la situación actual y propuestas para su uso racional. *Frontiers in Pharmacology*, 16, 1547488.

Rose, D. (2008). Sobre la necesidad de que los supervivientes psiquiátricos participen en la investigación: reflexiones sobre nosotros mismos como coinvestigadores. *Journal of Mental Health*, 17(4), 427-436.

- Rose, K. E. y Webb, C. (1997). Triangulación de la recopilación de datos: aspectos prácticos y problemas en un estudio sobre cuidadores informales de pacientes terminales con cáncer. *Journal of Advanced Nursing*, 26(6), 1221-1228.
- Rose, N. (2001). *Gobernando el alma: La configuración del yo privado* (2.^a ed.). Free Association Books.
- Rose, N. (2007). *La política de la vida misma: biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI*. Princeton University Press.
- Rose, N. (2018). *Nuestro futuro psiquiátrico*. John Wiley & Sons.
- Rosenhan, D. L. (1973). Sobre estar cuerdo en lugares de locos. *Science*, 179(4070), 250-258.
- Rosenquist, J. N., Fowler, J. H. y Christakis, N. A. (2011). Determinantes de la depresión en las redes sociales. *Molecular Psychiatry*, 16(3), 273-281.
- Rothschild, B. (2000). *El cuerpo recuerda: La psicofisiología del trauma y el tratamiento del trauma*. WW Norton & Company.
- Russell, B. (2009). Mala ciencia utilizada para apoyar la tortura y la experimentación con seres humanos. *Science*, 325(5941), 1485-1487.
- Russo, J. (2012). Investigación controlada por supervivientes: una nueva base para pensar sobre la psiquiatría y la salud mental. *Forum: Qualitative Social Research*, 13(1).
<https://doi.org/10.17169/fqs-13.1.1790>
- Sachdev, P. S., Whiteford, H., Saxena, S., & Van Ommeren, M. (2022). Barreras para la ampliación de los servicios de salud mental en países de ingresos bajos y medios. *World Psychiatry*, 21(1), 37-53.
- Sagie, A., Birati, A. y Tziner, A. (2002). Evaluación de los costes del retraining conductual y psicológico: un nuevo modelo y una ilustración empírica. *Psicología aplicada*, 51(1), 67-89.
- Sailas, E. y Fenton, M. (2000). Aislamiento y restricción de personas con enfermedades mentales graves. *Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas*, (2), CD001163.
- Salvador-Carulla, L., Costa-Font, J., Cabases, J., McDaid, D. y Alonso, J. (2010). Evaluación de la atención y las políticas de salud mental en España. *Revista de Política y Economía de la Salud Mental*, 13(2), 73.
- Samson, C. y McGregor, J. (2022). El encarcelamiento psiquiátrico y el Estado: despojo, contención y capitalismo racial. *Critical Public Health*, 32(3), 327-340.
- Sanati, A., & Kyratsous, L. (2015). Delirios y credibilidad: injusticia testimonial en la práctica psiquiátrica. *Psychological Medicine*, 45(3), 476-483. <https://doi.org/10.1017/S0033291714001699>
- Sanguineti, M. C. D., Fonseca, L., Burgess, R. A., Concha, N., González, M., San Juan, N. V., ... y Jovchelovitch, S. (2025). Resistir la violencia epistémica en la salud mental global: escuchar las

percepciones locales sobre la salud mental y el malestar emocional entre las víctimas y los exguerrilleros del sur de Colombia. *SSM-Mental Health*, 7, 100385.

Sarella, A., Aghedo, P. A., & Bhatia, K. (2023). Manejo farmacológico y no farmacológico del trastorno bipolar con enfermedad de Huntington comórbida: un caso clínico. *Journal of Clinical Pharmacology and Research*, 3(2), 85.

Sashidharan, S. P., Mezzina, R., & Puras, D. (2019). Reducción de la coacción en la atención de la salud mental. *Epidemiology and psychiatric sciences*, 28(6), 605-612.

Scheper-Hughes, N. (1992). *Muerte sin llanto: La violencia de la vida cotidiana en Brasil*. University of California Press.

Scheper-Hughes, N. (2001). La locura del hambre: enfermedad, delirio y necesidades humanas. En N. Scheper-Hughes y L. Wacquant (Eds.), *Violencia en la guerra y la paz: una antología* (pp. 302-305). Blackwell.

Scheper-Hughes, N. y Bourgois, P. (Eds.). (2004). *Violencia en la guerra y la paz: Una antología*. Blackwell Publishing.

Scheper-Hughes, N. y Lock, M. M. (1987). El cuerpo consciente: prolegómeno a futuros trabajos en antropología médica. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41.

Scheper-Hughes, N., y Lock, M. M. (1987). El cuerpo consciente: un prolegómeno para futuros trabajos en antropología médica. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41.

Schmale, A. H., & Engel, G. L. (1967). El complejo de renunciar-renunciado ilustrado en una película. *Archives of General Psychiatry*, 17(2), 135-145.

Schneider, B. (2012). Investigación-acción participativa, investigación con usuarios de servicios de salud mental y los proyectos Hearing (Our) Voices. *International Journal of Qualitative Methods*, 11(2), 152-165.

Schneider, B. (2012). Investigación-acción participativa, investigación con usuarios de servicios de salud mental y los proyectos Hearing (our) Voices. *Revista Internacional de Métodos Cualitativos*, 11(2), 112-127.

Schreurs, B. G., Griffith, J. L. y Solomon, R. L. (1984). El papel de la instrucción previa en la indefensión aprendida: «rendirse» como un conjunto cognitivo. *Aprendizaje y motivación*, 15(3), 259-277.

Seikkula, J. y Olson, M. E. (2003). El enfoque del diálogo abierto para la psicosis aguda: su poética y micropolítica. *Family Process*, 42(3), 403-418.

Serrano-Miguel, M. (2022). Salud mental colectiva y trabajo social. Una ventana de oportunidad para nuevas prácticas en la atención social al sufrimiento mental. *Cuadernos de Trabajo Social*, 2022, vol. 35, núm. 2, p. 243-252.

Serrano-Miguel, M., Pié-Balaguer, A., & Martínez-Hernández, Á. (2020). Guía para la gestión colaborativa de la medicación en salud mental. *Universitat Rovira i Virgili*.

- Shaw, E. (2007). Medical students' attitudes toward torture, revisited. *Health and Human Rights Journal*, 10(2), 25–41.
- Sheridan Rains, L., Johnson, S., Barnett, P. y Jones, A. (2019). Derechos y garantías legales en la atención psiquiátrica involuntaria en Europa. *European Journal of Public Health*, 29(5), 868-874.
- Simmons, T. (2025). Integración de la salud mental en el marco «One Health». *UTMB One Health News*. 1 de mayo de 2025.
- Simopoulos, E. F. y Trinidad, A. C. (2013). Disfunción eréctil masculina: integración de la psicofarmacología y la psicoterapia. *Psiquiatría hospitalaria general*, 35(1), 33-38.
- Singer, M. y Baer, H. A. (2007). *Introducción a la antropología médica: una disciplina en acción*. AltaMira Press.
- Smith, A., van Voren, R. y Liebrezn, M. (2024). Tendencias resurgentes en la psiquiatría punitiva en la Federación Rusa. *The Lancet Regional Health–Europe*, 42.
- Smith, C. P. (2016). *Primero, no hacer daño: traición institucional en la asistencia sanitaria* (tesis doctoral). Universidad de Oregón.
- Solnit, R. (2009). *Un paraíso construido en el infierno: Las comunidades extraordinarias que surgen en medio de la catástrofe*. Viking.
- Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (2020). *Ley y salud mental: objetivos alcanzados y retos pendientes en España*. *Revista Internacional de Derecho de la Salud Pública*, 14(2), 123-134.
- Speers, J. y Lathlean, J. (2015). Participación de los usuarios de los servicios en la evaluación de los estudiantes de salud mental en prácticas: un estudio de investigación-acción participativa. *Nurse Education Today*, 35(9), e84-e89.
- Staub, E. (1989). *Las raíces del mal: los orígenes del genocidio y otros tipos de violencia colectiva*. Cambridge University Press.
- Stover, E. y Nightingale, E. (2000). *La ruptura de cuerpos y mentes: tortura, abuso psiquiátrico y ética de la medicina*. AAAS.
- Strous, R. D. (2006). Los psiquiatras de Hitler: sanadores e investigadores convertidos en verdugos y su relevancia hoy en día. *Harvard review of psychiatry*, 14(1), 30-37.
- Subramani, S. (2019). Practising reflexivity: Ethics, methodology and theory construction. *Journal of Qualitative Research & Ethics*, 6.
- Suess Schwend, A., et al. (2016). Planificación anticipada de decisiones en salud mental: Modelos, utilidades y propuestas de aplicación. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 36(129), 79–102.

Suleman, A., Fatima, A., Mazhar, N., & Hashmi, A. M. (2025). Deslices silenciosos: prescripción excesiva de benzodiazepinas en psiquiatría ambulatoria. *BJPsych Open*, 11(S1), S280–S281.

Sullivan, G. M., Feinn, R. y Lin, Y. (2019). Prácticas de información y transparencia en la ciencia: el auge de la ciencia abierta y la reproducibilidad. *Journal of Graduate Medical Education*, 11(5), 525-528.

Sweeney, A., Clement, S., Filson, B. y Kennedy, A. (2016). Atención de salud mental informada sobre el trauma en el Reino Unido: ¿qué es y cómo podemos promover su desarrollo? *Mental Health Review Journal*, 21(3), 174-192.

Sweeney, A., Filson, B., Kennedy, A., Collinson, L. y Gillard, S. (2018). Un cambio de paradigma: las relaciones en los servicios de salud mental informados sobre el trauma. *BJPsych Advances*, 24(5), 319-333.

Szasz, T. S. (2007). La coacción como cura: Una historia crítica de la psiquiatría. Transaction Publishers.

Tadesse, D. M., Mekonnen, W. A., Fekadu, A. y Thornicroft, G. (2022). Uso de la investigación-acción participativa para poner a prueba un modelo de participación de los usuarios y cuidadores en el fortalecimiento del sistema de salud mental en la atención primaria de salud en Etiopía: un estudio de caso. *International Journal of Mental Health Systems*, 16, artículo 45.
<https://doi.org/10.1186/s13033-022-00545-8>

Tekin, Ş. (2022). Objetividad interactiva participativa en psiquiatría. *Filosofía de la Ciencia*, 89(5), 1166-1175.

El modelo biomédico de los trastornos mentales: un análisis crítico de su validez, utilidad y efectos en la investigación psicoterapéutica. *Clinical Psychology Review*, 33(7), 846-861.

El papel del psiquiatra en la implementación de un modelo de atención basado en el diálogo abierto. *Revista Australiana y Neozelandesa de Terapia Familiar*, 40(3), 319-329.

La venta de DSM: La retórica de la ciencia en la psiquiatría. Aldine de Gruyter.

Tomé, P. (2014). Pactos de cuidado. *Revista Mujeres y Salud*, 36, 16–19.

Toro, J., Mur, M., & Cantó, T. (2006). Tratamientos psiquiátricos para niños y adolescentes preferidos por psiquiatras españoles. *The European journal of psychiatry*, 20(4), 231-241.

Torrents, E. G., & Björkdahl, A. (2024). Alternativas a la coacción. En *Coacción y violencia en entornos de salud mental: causas, consecuencias, gestión* (pp. 373–403). Cham: Springer Nature Switzerland.

Tuke, W. (1975). Descripción del Retiro de York (obra original publicada en 1796). Garland.

Tuncak, B. (2017). Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racional de sustancias y desechos peligrosos (A/HRC/36/41). Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

- Tusell, F. (2010). La psiquiatría española en la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. *Historia de la Psiquiatría*, 21(4), 445-458. Examina las influencias ideológicas y políticas en la higiene mental de la década de 1930.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2015). Pasung: «encadenamiento» de personas con discapacidad psicosocial.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2015). Pasung: «encadenamiento» de personas con discapacidad psicosocial. ACNUDH. (Nota: esta práctica fue prohibida oficialmente en Indonesia por decreto presidencial en 1977, reafirmado en 2016, pero sigue existiendo en la práctica, ya que es difícil de erradicar sin un compromiso social total con la ley y la salud, y en todos los países).
- Van Bilsen, H. P. J. G. (2016). Lecciones que se pueden extraer del servicio psiquiátrico comunitario más antiguo del mundo: Geel, en Bélgica. *BJPsych Bulletin*, 40(4), 198-202.
- Van der Kolk, B. A. (2014). *El cuerpo lleva la cuenta: cerebro, mente y cuerpo en la curación del trauma*. Viking.
- van Strien, T., Cebolla, A., Etchemendy, E., Gutiérrez-Maldonado, J., Ferrer-García, M., Botella, C. y Baños, R. (2013). Alimentación emocional y consumo de alimentos tras la tristeza y la alegría. *Appetite*, 66, 20-25.
- Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Arias, V. B., Gómez, L. E., & Escorial, M. T. (2012). El concepto de calidad de vida y su papel en la mejora de los derechos humanos en el ámbito de la discapacidad intelectual. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(11), 1036-1045.
- Viadel, M. H., Prieto, J. F. P., Nicolás, C. C., Calatayud, G. L., & Millán, T. R. (2006). Tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) para personas con enfermedad mental grave. *Psiquiatría Biológica*, 13(5), 183-187.
- Villagrán, J. M., Lara Ruiz-Granados, I., & González-Saiz, F. (2015). Aspectos conceptuales sobre el proceso de decisión compartida en salud mental. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 35(127), 455-472.
- Walker, S., MacKay, E., Barnett, P., Rains, L., Leverton, M., Dalton-Locke, C., ... y Johnson, S. (2019). Factores clínicos y sociales asociados con un mayor riesgo de hospitalización psiquiátrica involuntaria: revisión sistemática, metaanálisis y síntesis narrativa. *The Lancet Psychiatry*, 6(12), 1039-1053.
- Watnik, I. L. (2001). Análisis constitucional de la ley Kendra: la solución de Nueva York para el tratamiento de los enfermos mentales crónicos. *University of Pennsylvania Law Review*, 149(4), 1181-1228.
- Watts, J. (2024). La injusticia epistémica del trastorno límite de la personalidad. *BJPsych International*, 21(4), 78-82. <https://doi.org/10.1192/bji.2024.16>
- Weiss, M. G. y Somma, D. (2007). Modelos explicativos en psiquiatría. Libro de texto de psiquiatría cultural, 1, 127-140.

Whitaker, R. (2005). Anatomía de una epidemia: los fármacos psiquiátricos y el sorprendente aumento de las enfermedades mentales en Estados Unidos. *Ethical Human Psychology and Psychiatry*, 7(1), 23.

Whitaker, R. (2010). Anatomía de una epidemia: balas mágicas, fármacos psiquiátricos y el sorprendente aumento de las enfermedades mentales en Estados Unidos. Crown Publishing.

Wilkinson, R. y Pickett, K. (2010). El nivel de la igualdad: Por qué la igualdad es mejor para todos. Penguin.

Woolf, S. H. (2008). El significado de la investigación traslacional y por qué es importante. *JAMA*, 299(2), 211-213.

Organización Mundial de la Salud. (2010). Salud mental y desarrollo: las personas con trastornos mentales como grupo vulnerable. Organización Mundial de la Salud.

Organización Mundial de la Salud. (2020). Plan de acción para la reforma de las políticas y leyes de salud mental. OMS. Obtenido del sitio web de la OMS

Organización Mundial de la Salud. (2023). Estrategia mundial de salud digital 2020-2025 y sus implicaciones para la implementación de la salud mental.

Wrangham, R. W., Wilson, M. L. y Muller, M. N. (2006). Tasas comparativas de violencia en chimpancés y seres humanos. *Primates*, 47(1), 14-26.

Wyman, S. (2023). Tormenta psicotrópica: un análisis de la prescripción excesiva de medicamentos psiquiátricos y la ley. *Law & Psychology Review*, 48, 139.

Young, A. (1982). Las antropologías de la enfermedad y la dolencia. *Annual Review of Anthropology*, 11, 257-285.

Zanardo, A., & Ventura, C. (2023). La iniciativa QualityRights de la OMS y su uso en todo el mundo: una revisión bibliográfica. *International Journal of Social Psychiatry*, 70(3), 424–436.

Zola, I. K. (1972). La medicina como institución de control social. *The Sociological Review*, 20(4), 487-504.

Мандрик-Мельничук, М. (2024). Transformación de la psiquiatría soviética: de la rama de la medicina a un sistema punitivo para combatir la disidencia. *Актуальні питання суспільних наук та історії медицини*, (2), 87-96.

Annex A - Instruments used in this participatory action-research work

Annex A contains the full set of surveying instruments employed throughout this participatory action-research dissertation. These instruments were developed to explore lived experience, clinical and professional perspectives, and ethical-practical dimensions surrounding psychiatric labeling, medication practices, and structural violence in mental health. All instruments are made available through the dissertation's online repository, in accordance with open science standards, and are ready for adaptation, localization, and further validation. The repository includes not only the survey tools themselves, but also associated informed consent forms, participant information sheets, and guidance for ethical deployment.

Each instrument has been designed to elicit critical insights while respecting the autonomy and dignity of participants, with contextual messages included for use in validation and translation processes. Researchers, practitioners, and policy actors are invited to build upon this resource, adjusting language, structure, and content for diverse cultural and systemic settings. These instruments represent a core component of the dissertation's translational mission and can support future participatory processes, training modules, and empirical research committed to the principles of transparency, accountability, and epistemic justice.

Following are the questions of the schizophrenia inquiry survey and shared decision making survey, for quick reference, with the ones on open dialogue included in a separate annex.

Schizophrenia inquiry survey:

Section	Item / Question
Sociodemographic Information	What is your age?
	What is your gender identity?
	What is your country of origin?
	What is your country of residence?
	What is your highest level of education attained?
	What is your professional background or area of expertise?
Personal and Professional Experience	Have you been diagnosed with schizophrenia?
	Have you received other psychiatric diagnoses?
	Have you ever worked with people diagnosed with schizophrenia?
Perceptions on the Label	Do you believe the diagnosis of schizophrenia is useful for clinical practice?
	Do you believe the diagnosis contributes to stigmatization?
	Do you believe schizophrenia is a valid medical construct?
	Should the term schizophrenia be replaced with another denomination?
	Do cultural differences influence the way schizophrenia is diagnosed?
	Does a person's ethnicity or race play a role in receiving a schizophrenia diagnosis?
Experiences and Reflections	Do you think gender plays a role in the diagnostic process?
	In your opinion, what are the main consequences of receiving the label schizophrenia?
	Have you or someone you know experienced discrimination due to this diagnosis?

Section**Item / Question**

What changes would you suggest in the diagnostic process or terminology?

Shared decision making survey:

Section	Item / Question
Demographics	What is your profession? Where do you currently work? What is your role within your organization? How many years of experience do you have in mental health care or research?
Clinical Experience	First-episode psychosis (before establishing a long-term diagnosis) Depressive disorders (prescribed neuroleptics as augmentation) Bipolar disorder (long-term neuroleptic treatment for mood stabilization) Non-specified psychotic or mood disorders (diagnosis unclear or evolving) Neuroleptics prescribed off-label (e.g. insomnia, anxiety, personality disorders) Neuroleptics used in elderly patients (dementia-related agitation, behavioral management) Long-term neuroleptic use in institutionalized patients (e.g. chronic hospitalization, group homes) Pediatric and adolescent patients (under 18 years old) Patients with histories of trauma and abuse (where symptoms may be trauma-related)
Training	Have you received formal training on deprescribing strategies and shared decision-making?
Policy Scenarios	Implementing national screening for gluten sensitivity in psychiatric diagnoses Deprescribing neuroleptics in cases of missed metabolic and nutritional disorders Addressing psychiatric abuse cases uncovered through national research on mental health and violence National deprescribing initiative for elderly patients at high risk of mortality and disability Reevaluating long-term psychiatric diagnoses in a national audit Addressing the overprescription of neuroleptics in social care and marginalized communities National review of the use of neuroleptics in children and adolescents Ending the use of neuroleptics for non-psychiatric indications in general medicine
Final Reflection	Given the above eight shared decision-making and deprescribing challenges, please reflect on the following: Which do you consider the main challenge for implementing shared decision-making and deprescribing strategies in mental health at the national level? (Select up to three options.)

Annex B - Ethics of qualitative research in psychology

Beyond witnessing: ethical imperatives in action-research on suffering, victims of violence, and structural harm in mental health systems

Abstract: Qualitative research in mental health often exposes systemic contradictions: the researcher listens to testimonies of harm while institutions demand silence. This paper interrogates the ethical tensions of conducting action-research in settings where mental health care reproduces coercion, erasure, and institutional betrayal. Grounded in a five-year, multi-sited ethnographic inquiry across Spain, Italy, Sweden, and Indonesia -conducted under the auspices of European COST Actions FOSTREN, ReMO, and the author-founded EU BEACON One Health Education action- this study integrates lived experience, scientific fieldwork, and participatory methods. It identifies how dominant legal and institutional frameworks in Europe obstruct accountability by shielding professionals through laws that protect subjective annotations, prevent access to clinical records, and frame complaints as symptoms. Drawing from first-hand documentation of abuse and policy engagement at national and international levels, the paper argues for a shift toward radically ethical, open science infrastructures. It advocates for dynamic, reflexive protocols that empower researchers to respond to harm ethically and structurally-transforming qualitative inquiry from observation into intervention. The work responds to urgent calls from affected persons, professionals, and policymakers to end epistemic violence, improve safeguards, and uphold the principle that suffering must not be rendered invisible for the sake of institutional comfort. In doing so, it proposes a framework for ethically sound, action-oriented, and justice-driven qualitative research in mental health.

Keywords: Ethics, action-research, qualitative methods, structural violence, epistemic injustice, mental health systems, institutional betrayal, open science, human rights, psychiatry, COST, ReMO, FOSTREN, EU BEACON One Health Education.

introduction: ethics under duress and the urgency of methodological accountability

Ethics in qualitative research in mental health, especially when situated within high-stakes, politically contested, and structurally violent settings, demands not only methodological rigor but also protocols and planned actions capable of responding to harm, denial, and institutional betrayal. The field has long acknowledged that qualitative methods enable access to lived realities and subjective meaning-making in ways quantitative tools cannot. However, the ethical dimensions of such inquiry often remain structurally underdeveloped, especially when researchers are confronted with ongoing abuse, personal risk, and institutional complicity in the very harms they seek to document (Ellis et al., 2011; Smith & Freyd, 2014; Gabb & Fink, 2015).

This paper arises from such a context. Drawing on longitudinal action-research and participant observation conducted within mental health systems across Europe and Southeast Asia, it seeks to examine the profound ethical and methodological challenges that emerge when institutions tasked with care and protection act as sources of harm. In particular, the analysis is grounded in cases where researchers and participants alike faced coercion, discrediting, and systemic silencing under psychiatric, legal, and social service frameworks that perpetuated -rather than alleviated- distress. In response, new methodological practices were developed under duress, based on the principles of

epistemic justice (Fricker, 2007), open science (Nosek et al., 2015; Munafò et al., 2017), and research ethics grounded in participatory global health (Campbell & Burgess, 2012; WHO, 2021).

The paper does not offer a single-case reflection or a confessional narrative. Rather, it interrogates the ethical failures that occur when systems distort the researcher-participant relationship into an adversarial dynamic, obscuring accountability and harming the production of valid knowledge. The work contributes to an urgent conversation about what happens to ethics, science, and professional duty when research unfolds in spaces of state-sanctioned violence and societal denial. In doing so, it also aims to offer a path forward: a set of methodological countermeasures and epistemic infrastructures that may help restore the integrity of qualitative inquiry.

Ethics and method in qualitative mental health research: innovations and ongoing issues

Over the past two decades, the growth of qualitative approaches in mental health research has been accompanied by a richer vocabulary around reflexivity, power, and the researcher's positionality (Berger, 2015; Pillow, 2003). Despite this, dominant frameworks still tend to favor procedural ethics -such as institutional review board approvals -over emergent, responsive ethics of care and justice in the field (Guillemin & Gillam, 2004; Hammersley & Traianou, 2012). In situations involving vulnerable populations, this disconnect often renders ethical approval a bureaucratic formality rather than a real safeguard. Furthermore, the entrenched hierarchies of biomedical psychiatry -frequently upheld by legal and clinical structures- create environments where participant autonomy is already structurally constrained (Rose, 2018; Hopper, 2007). In such contexts, qualitative researchers face unique ethical challenges, as they navigate not only the dynamics of power and disclosure but also the risk of becoming complicit in systems that criminalize distress and pathologize resistance.

A particularly underexplored area is the ethical terrain encountered when researchers themselves are subjects of the systems they study -not by methodological design, but by circumstance. Researchers who are survivors of institutional violence or coercive treatment, or who work in precarious legal and political conditions, are often left out of the academic conversation or treated as methodologically suspect (Kovach, 2009; Ladkin, 2020). Yet, their work offers rare insight into the inner logics of exclusion and harm. It also reveals how traditional notions of distance, neutrality, and objectivity can obscure the very abuses that demand exposure. The concept of witnessing in qualitative research -long explored in feminist and postcolonial studies- must therefore be reframed not only as interpretive engagement, but as ethical risk (Josselson, 2007; Bhattacharya, 2016).

The erosion of trust in science, exacerbated by epistemic injustice and institutional cover-ups, underscores the need for research practices that prioritize transparency, accountability, and radical honesty (Edwards & Roy, 2017; Ioannidis, 2005). The replication crisis and open science movement have largely bypassed the domain of qualitative mental health research, where practices of data sharing, protocol transparency, and version-controlled documentation remain rare. This gap is especially dangerous given the increasing criminalization of dissent, the medicalization of suffering, and the state-sponsored redefinition of deviance as illness (Foucault, 1973; Metzl, 2010).

At the same time, international health bodies -including the WHO, the UN Special Rapporteur on the right to health, and the Council of Europe, who also participated as contact during the research- have called for a shift away from coercive psychiatry toward voluntary, rights-based models grounded in human dignity and community engagement (WHO, 2021; Pūras, 2020; Council of Europe, 2023). These mandates demand a corresponding transformation in how qualitative researchers design, conduct, and defend their work -especially in terms of how we define safety, power, and harm. Without such a shift, researchers risk perpetuating the very systems they critique.

Paper structure and *raison d'être* of it as a contribution

This paper proposes a grounded, practice-based ethics framework derived from action-research conducted in real-world mental health systems operating under institutional decay and systemic violence. Through fieldwork conducted in Spain, Sweden, Indonesia, and other European contexts - much of it under conditions of personal duress and danger- the research identifies structural failures in ethical oversight, as well as emergent practices of resistance through documentation, co-production, and digital transparency. It introduces methodological adaptations developed to ensure research could continue in hostile environments, including public verification, trauma-informed consent, and multi-layered data preservation against sabotage or deletion.

The central contribution is twofold. First, it expands the discourse on research ethics in qualitative psychology to include conditions of structural coercion, epistemic harm, and researcher-survivor entanglement. Second, it articulates concrete methodological innovations that uphold integrity, safety, and social accountability even when institutional safeguards fail. In this sense, the paper builds on and extends calls for a paradigm shift in mental health research -from treating ethics as compliance, to enacting ethics as method.

Subsequent sections of the article detail the methodological choices made, the ethical dilemmas encountered, and the principles guiding the design and dissemination of open, survivable, and impactful research. These include the use of participant-led inquiry, open-source infrastructure, co-developed policy engagement, and trauma-aware fieldwork practices. In doing so, the paper argues for a redefinition of ethical research practice not as risk aversion, but as principled exposure in service of truth, healing, and justice.

Background and context: structural deficits, institutional abandonment, and the ethics of listening in qualitative mental health research

Ethical qualitative inquiry in mental health must grapple with the stark dissonance between the professed values of care systems and the lived realities experienced by those navigating them. Across many contemporary psychiatric services in Europe and beyond, the gap between stated therapeutic goals -such as recovery, trauma-informed care, and patient autonomy -and the practical functioning of institutions remains wide and concerning (Rose, 2018; WHO, 2021; UN Human Rights Council, 2023). Despite rhetorical shifts toward personalization, co-production, and rights-based practice, implementation remains sporadic and structurally constrained. The result is a mental health landscape marked not by deliberative reform, but by inertia, bureaucratic rigidity, and the persistent normalization of harm.

This paper emerges from action-research engagements embedded in this terrain. Between 2020 and 2025, fieldwork was conducted across Spain, Sweden, Italy and, to end with, Indonesia, focusing on the ethical and methodological challenges of working within -and often despite- systems ill-equipped to engage constructively with distress. The scientific mission in Trieste, Italy, initially pursued as a site of exposure to non-coercive, community-based psychiatry, revealed in parallel the institutional limitations of even such globally recognized as excellence site models. Despite strong international standing, the infrastructures for ethical reflexivity and researcher protection were severely lacking. When the researcher reported ongoing threats and trauma, and needed urgent help to end abuses, academic and health institutions failed to respond meaningfully. This aligns with a growing body of literature suggesting that institutions tasked with mental health and academic oversight frequently lack the mechanisms -or will- to protect those most vulnerable, including researchers and participants disclosing abuse (Gabb & Fink, 2015; Ladkin, 2020; Smith & Freyd, 2014).

These deficits are not uniformly malicious in intent, but are structurally embedded in psychiatric systems where coercion is normalized as care, and deviation from standardized protocols is often met with institutional resistance rather than curiosity or adaptation (Burstow, 2015; Minkowitz, 2006). Mental health legislation in many jurisdictions, including Spain and Sweden, as well as Indonesia, continues to prioritize control over protection, authorizing involuntary treatment without adequate safeguards or meaningful engagement with the person's history, trauma, or social determinants (Gooding, 2015; United Nations, 2017). Even where reform is pursued, the emphasis tends to fall on procedural compliance rather than substantive transformation -a process that risks replicating violence under new administrative terms (Hummelvoll et al., 2015; Russo, 2016).

Clinically, this manifests in practices that are not trauma-informed but frequently retraumatizing; not personalized, but pathologizing; not dialogical, but diagnostically reductionist. Distress signals and embodied protest are often interpreted through narrow, deficit-based frameworks, leading to treatment paths characterized by force, surveillance, and disempowerment (Rose, 2003; Johnstone & Boyle, 2018). Qualitative researchers working in these contexts, particularly through ethnographic or action-based approaches, often witness firsthand how epistemic hubris and institutional closure combine to produce profound iatrogenic effects -including despair, resignation, and what has been termed the *giving up-given up* syndrome (Sharfstein, 1985; Estroff, 1981). The systematic refusal to listen to complaints without retaliatory pathologization or escalation of coercion is not an anomaly but a pattern -one that renders the ethical position of the qualitative researcher particularly precarious, especially when they attempt to surface these dynamics through evidence-based critique.

Importantly, the moral economy of psychiatry continues to reward compliance and silence, while punishing dissent -even when that dissent is expressed through scientifically grounded, patient-informed critique. This context severely limits the capacity for mental health systems to engage in the kinds of self-correction and continuous learning that define a functioning scientific or therapeutic institution. Without open science standards, longitudinal tracking of outcomes, or verifiable feedback loops, the system lacks mechanisms to detect, let alone redress, its own failures (Ioannidis, 2005; Munafò et al., 2017). The resulting epistemological environment not only

devalues qualitative insight but actively marginalizes lived experience as methodologically illegitimate and politically destabilizing (Fricker, 2007; Russo & Sweeney, 2016).

This paper argues that qualitative research in such settings is not ethically neutral terrain. When services fail to meet the minimum thresholds of safety, responsiveness, and respect, the act of qualitative inquiry becomes ethically charged -not only for participants but for researchers themselves, especially when their role straddles the boundary of witness, analyst, and survivor. It is in these moments that the ethical demands of the field exceed procedural checklists and enter the domain of moral urgency. Listening, in such contexts, becomes an act of resistance and reparation-a way of refusing the silencing mechanisms that define much of institutional psychiatry and social care (Campbell & Burgess, 2012; Gill & Donaghue, 2016).

Rather than replicating the diagnostic gaze, this study engaged in co-constructed meaning-making, trauma-informed documentation, and action-oriented dissemination. Methodologically, it was anchored in open science principles, collaborative interpretation, and public accountability, seeking to counterbalance the structural opacity that so often defines psychiatric systems. The core contention is that any system incapable of hearing the voices of those it purports to serve -including patients, professionals, and researchers- is ethically unfit. Qualitative research must thus do more than describe -it must interrupt, question, and reconstruct the very conditions under which mental health knowledge is produced and legitimized.

Methods: action-based qualitative research as a platform for systemic learning and structural accountability

This study employed a transdisciplinary, multi-sited qualitative action-research methodology grounded in medical anthropology, biocultural analysis, and epistemic justice frameworks (Fricker, 2007; Scheper-Hughes, 1992; Fals-Borda, 1991). The fieldwork -spanning five years and funded through two consecutive Spanish Ministry of Science and Innovation grants (FPU19/00656 and EVC2021/000764), as well as through participation in European COST Actions FOSTREN (CA19133) and ReMO (CA20137)- was embedded in collective international efforts to rethink mental health governance, research ethics, and service design. It later provided the empirical and ethical foundation for the creation of the EU COST Action BEACON (CA24106), which now brings together over 500 researchers and practitioners committed to systemic transformation through One Health education.

The work took place across Spain, Sweden, Italy, and Indonesia, capturing both formal institutional environments and informal community practices. These sites revealed differing but overlapping patterns of psychiatric violence, coercive logic, epistemic injustice, and institutional betrayal. In all contexts, participants reported harms occurring not only within psychiatric systems, but across intersecting domains -family, police, judiciary, and social services- requiring a broad-based methodological strategy that was responsive to multiple axes of oppression and systemic inertia.

The approach prioritized immersion and ethical responsiveness rather than protocol-driven neutrality. Ethnographic techniques -including long-term participant observation, semi-structured and unstructured interviews, clinical shadowing, policy consultations, and open scientific commentary- were employed to collect data while remaining situated within live processes of

witnessing, translation, and reform. The researcher was an active participant in numerous policy and service-level dialogues, including those with the Catalan Department of Health during the co-development of its 2023–2025 Mental Health Action Plan. Engagement included several in-person and written consultations with the plan’s leadership and working groups, drawing on lived experience, empirical observation, and participatory policy translation. These dialogues were part of broader EU-wide work under FOSTREN to reduce coercion in mental health systems, and were integrated into BEACON’s ongoing mission to foster public education, civic health literacy, and early prevention through participatory infrastructures.

The methodological design was aligned with a tradition of emancipatory and care-centered research (Torre, 2009; Campbell & Cornish, 2010), emphasizing listening, collaborative meaning-making, and systemic reflexivity. However, it also contended with the serious limitations researchers face when working in environments of institutional abuse or neglect. The original field design included two strategic innovations that remain largely aspirational at this stage due to lack of institutional uptake:

1. Dynamic ethics and action protocols (proposed, not yet implemented): in response to repeated accounts of systemic harm, the research proposed an escalation framework for activating protective responses -including notifying trusted institutional contacts, human rights observers, and professional ethics boards- when credible risks to participant wellbeing emerged. However, the lack of operational infrastructure across public systems, as well as the adversarial posture of many services toward independent researchers, prevented systematic implementation. These protocols are conceptualized as urgently needed components of future public mental health systems.
2. Versioning and verification against epistemic manipulation (proposed, not yet implemented): The project also outlined a need for systematic version control, timestamped medical record retention, and independent archival methods to prevent retrospective data falsification and epistemic erasure - a pattern documented by participants and observed in multiple institutions. While open science principles (Nosek et al., 2015; Munafò et al., 2017) were followed wherever feasible through public reporting, engagement, and collaboration, robust infrastructure for verification and co-governance of sensitive health records remains absent in most countries studied. These proposals are now being translated into design criteria for expert systems and governance pilots under the EU BEACON initiative.
3. In practice, the methodological commitments took shape through the following operational principles, enacted all through the five years of fieldwork:
 - Embedded ethnography and policy interface: All fieldwork was informed by direct contact with practitioners, service users, administrators, and policymakers. Findings were translated into contributions to policy documents, public statements, and legal submissions. These include substantive inputs to the Council of Europe’s 2023 *Compendium of Good Practices to Promote Voluntary Measures in Mental Health*, and public dissemination through open access formats and digital engagement platforms, and insights directly shared with lawmakers in all opportunities fostered and encountered during the fieldwork research.

- Trauma-informed and participatory consent practices: All participation in surveys and other engagements such as interviews or presentations was always voluntary, and consent was reiterated throughout the process. Participants were informed of the project's dual research and action-reform purposes. In trauma-related cases, no personal identifiers were recorded unless explicitly consented to, and anonymization was prioritized in all outputs.
- Real-time feedback and iterative reflection: Data analysis was recursive, taking place alongside ongoing field engagement. Ethical tensions, institutional challenges, and methodological dilemmas were recorded in analytic memos and served to refine subsequent engagement, published as transparently and in depth as possible in an open field and laboratory notebook online the author keeps, following open science principles of full openness and transparency on methods, ongoing work and results. This reflective praxis was central to maintaining fidelity to the action-research tradition and resisting extractive logics.
- Use of public and community knowledge systems: The research was also attentive to grassroots initiatives, survivor-led campaigns, and international networks working on systemic change. These informants were not merely supplementary but were treated as epistemic co-producers of the research (Harding, 1991; Saini, 2020), essential to building a distributed model of accountability and system reform.
- Education and dissemination as method: The work's methodological strategy included the development of public teaching materials, professional workshops, and policy briefings aimed at enabling other researchers, clinicians, and students to identify coercive dynamics, respond to systemic failures, and take part in a collective reform agenda. These materials now inform open-access curricula and clinical ethics platforms within the BEACON network.

Despite the comprehensive design, the project was carried out under conditions of acute duress, including repeated threats, lack of institutional protection, and periods of forced displacement due to ongoing violence. That such research was possible at all is testament to the courage of participants, the international scientific alliances that provided support (notably COST Action FOSTREN and later BEACON), and the resilient commitment of affected communities. The qualitative research insights derived are not just valid -they are urgently necessary.

Table 1. Methodological design and operational principles

Component	Description
Theoretical framework	Grounded in medical anthropology, biocultural analysis, and epistemic justice.
Geographic scope and sites	Spain, Sweden, Italy, and Indonesia – encompassing both formal psychiatric institutions and informal community-based systems.
Funding and institutional support	Supported by Spanish Ministry grants (FPU19/00656, EVC2021/000764), and European COST Actions: FOSTREN (CA19133), ReMO (CA20137), and BEACON (CA24106).
Main ethnographic techniques	Long-term participant observation, un/structured interviews, clinical shadowing, policy consultation, and open scientific commentary.
Embedded policy engagement	Participated in development of the Catalan 2023–2025 Mental Health Action Plan; involved in Council of Europe and BEACON policy dialogues.

Component	Description
Research conditions	Fieldwork conducted under duress: threats, institutional neglect, and forced displacements. Research carried forward through participant solidarity, scientific alliances (notably BEACON and FOSTREN), and ethical commitment.
Guiding conclusion	Ethical qualitative research must integrate implementation pathways and inform systemic change; ethics in the field is inseparable from ethics in governance.

To translate lived harms into institutional reform, qualitative research must embed itself in systems of implementation. As this project demonstrates, ethics in the field cannot be divorced from ethics in governance. What we observe must inform what we build next.

Findings and discussion: witnessing without safeguards -ethical tensions and systemic impasses in psychiatric fieldwork

Across five years of multi-sited, ethnographically grounded research in Spain, Sweden, Italy, and Indonesia, this study documented recurring patterns of structural neglect, diagnostic violence, epistemic erasure, and systemic impunity in mental health service ecosystems. The findings cohere around three interrelated domains: the normalization of coercion, the institutional silencing of abuse narratives, and the fragility of ethical responsibility within professional cultures. Each of these domains poses acute challenges to qualitative researchers, who -once situated in the field- encounter not only suffering but the systemic resistance to its recognition, redress, or repair.

1. Normalization of coercion and the medicalization of structural distress

Participants repeatedly described how psychiatric labeling functioned not as a diagnostic aid but as a mechanism of social disqualification, often weaponized during moments of crisis, family conflict, or institutional breakdown. Particularly in Spain and Italy, users recounted being involuntarily hospitalized or medicated after disclosing experiences of domestic abuse or workplace violence, suggesting that psychiatric systems often reinforce rather than interrupt cycles of harm (Burstow, 2015; Cosgrove et al., 2020). In Sweden, this pattern intensified into what many described as *administrative disappearance*- the use of child protection laws, mental health statutes, or forensic psychiatric classifications to sever individuals from their families, terminate careers, or justify long-term isolation.

These findings resonate with international concerns about the pervasive misuse of psychiatry as a means of social control (Cohen, 1985; Amnesty International, 2022), especially where coercion is framed as care and dissent is medicalized. The normalization of forced treatment was rarely questioned by professionals, many of whom cited *risk* or *non-compliance* in circular terms. This aligns with prior critiques that biomedical mental health paradigms often obscure the social origins of distress while silencing critique through institutional authority (Moncrieff, 2008; Mills, 2014). Where listening did occur, it was more often by peers, advocates, or researchers than by clinicians, indicating a severe epistemic asymmetry within clinical settings.

2. Institutional betrayal and the ethical silencing of field reports

A major theme emerging from the fieldwork was the impossibility of *reporting upward* in situations of witnessed harm. Whether abuse occurred in hospitals, homes, or welfare offices, researchers and witnesses alike found themselves without secure channels to raise alarms. Reporting often triggered retaliation, deflection, or reputational damage-especially when clinicians, administrators, or legal authorities were implicated. In multiple cases, researchers were warned against *interfering* or *taking sides*, even as participants suffered ongoing harm.

For instance, the researcher's report of suffering a death threat, torture for years and still ongoing severe abuses, was met not with institutional support but with inaction that led to even further threats, harassment, violence, forced displacement, and denial of professional legitimacy, illustrating the punitive asymmetry between those speaking out the truth, denouncing crimes, and those structurally shielded. This mirrors the dynamics described by Smith and Freyd (2014) as institutional betrayal, in which organizations fail to respond ethically to harm within their own systems, compounding trauma and silencing accountability.

The field thus became a space not only of witnessing but of betrayal. Ethical tensions were acute: to disengage would be complicit; to intervene risked professional collapse. In the absence of dynamic protocols or institutional accountability, the ethical burden fell entirely on the individual researcher, exacerbating precarity and psychological toll.

3. Complicity, cowardice, and the reproduction of structural harm

A sobering finding was the extent to which professional cultures, especially among clinicians and researchers, normalized avoidance, deflection, and passive complicity. Even where clear violations were witnessed, many professionals invoked bureaucratic constraints, *non-interventionist* roles, or institutional neutrality as reasons for inaction. This passive complicity constitutes a core mechanism of harm reproduction. Worse still, some actors actively participated in the erasure or defamation of those who challenged the status quo, often under the guise of procedural correctness or reputational protection. This condition, what Freire (1970) would call the internalization of oppressor logic, undermines the very fabric of ethical inquiry. It also challenges the assumptions of procedural ethics, which presume a stable environment of rights, protections, and institutional cooperation. In reality, the field often operates as a site of moral injury, where truth-telling becomes a liability and protection is only extended to those who remain silent.

These findings compel a reframing of ethical practice in qualitative research. If researchers are to carry the burden of witnessing systemic abuse, then institutions -academic, clinical, legal- must be made accountable for offering protection, coordination, and escalation pathways. The ethics of doing no harm must evolve into an ethics of enabling redress and reform.

4. Action-research under duress: method as resistance

That this research was conducted at all -despite displacement, threats, and lack of institutional protection- testifies to the necessity of integrating ethics into method. In contexts where silence sustains violence, the very act of documentation becomes resistance. The work was undertaken with

clear goals: to expose systemic failures, to amplify silenced voices, and to push for reform from within the systems themselves.

Table 2: Ethical issues in mental health qualitative research

Field	Description
Positional risk and exposure	Researchers with lived experience or dissenting perspectives face systemic retaliation, delegitimation, and psychological harm when documenting abuse.
Structural silencing and retaliation	Institutional actors obstruct reporting pathways, retaliate against whistleblowers, and pathologize critics as unprofessional or mentally unfit.
Informed consent and coercive environments	Consent is undermined in coercive contexts, where patients fear retribution, service loss, or further diagnosis for speaking out.
Power asymmetries in field relations	Researcher-participant relationships reflect deep institutional power imbalances, risking complicity without reflexive, relational ethics.
Epistemic violence and testimonial erasure	Participant testimony is often dismissed or erased in clinical and professional settings, reinforcing structural invisibility.
Barriers to real-time ethical action	Ethics protocols lack mechanisms for immediate response to abuse disclosures, leaving researchers without safe and effective intervention channels.
Data integrity and record manipulation	Mental health records are vulnerable to falsification or selective editing, requiring researchers to ensure timestamped, version-controlled documentation.
Public health system complicity	Harm and neglect are normalized within systems of care, placing researchers in ethical dilemmas where harm is concealed or trivialized.
Lack of institutional protection	Universities and research bodies often lack protocols to protect researchers from fieldwork-related risks or from institutional retaliation.
Ethics of translation and policy feedback	Testimonies often fail to reach decision-makers; researchers must forge independent pathways to transform lived knowledge into systemic change.

Major critical ethical concerns encountered and analyzed in the course of longitudinal action-research in mental health services and institutional systems.

Yet, the findings also underscore a profound need for collective infrastructure. No individual researcher, no matter how dedicated, can bear the epistemic, emotional, and political weight of reform alone. Qualitative research, especially in mental health, must now advance into a new era of institutional ethics -in-action, where protocols, accountability mechanisms, and open-science safeguards support the very interventions they demand (Guillemin & Gillam, 2004; Iphofen, 2017).

This five years long fieldwork research was not about individual suffering, though it was shaped by it. It is about systemic ethical blindness -and the urgent task of building a scholarly and clinical culture that not only sees, but acts. Qualitative research in mental health, particularly when employing ethnographic and action-research methodologies, reveals a persistent and structurally embedded set of ethical dilemmas that cannot be addressed solely by procedural ethics or institutional review boards. Across multiple sites and over a sustained five-year field engagement-including participation in EU-funded initiatives such as FOSTREN, ReMO, and the EU BEACON

actions- the findings consistently exposed environments where lived experience is delegitimized, institutional violence is normalized, and the epistemic authority of survivors, patients, and front-line researchers is regularly undermined or pathologized. These findings echo prior critiques of ethics-as-bureaucracy and support the call for dynamic, responsive, and relational ethical frameworks (Guillemin & Gillam, 2004; Denzin & Giardina, 2007; Ellis, 2007).

A key ethical concern centers on the erasure of lived experience under epistemic regimes of biomedical dominance, where subjective accounts of harm, coercion, and structural neglect are recast as symptomatic of illness rather than legitimate evidence. This epistemic injustice (Fricker, 2007) is compounded in contexts where diagnostic power is weaponized to silence critique, rendering the very act of naming abuse a trigger for further institutional punishment or control. Participants in multiple sites reported that attempts to speak out about coercive practices -including forced medication, restraint, and isolation- were reinterpreted as signs of *lack of insight* or *paranoia*, thus perpetuating cycles of disempowerment and silencing (Russo, 2016; Voronka, 2016; Rose & Kalathil, 2019). These dynamics raise fundamental questions about the ethics of consent, voice, and narrative agency within qualitative inquiry.

Moreover, the asymmetry of power between researcher and participant -typically acknowledged as a risk- was reversed in many cases, as researchers embedded in vulnerable positions themselves became targets of institutional repression. When qualitative researchers are also survivors, or operate as peer scholars in precarious environments, the ethical equation shifts drastically. In this research, the act of documentation itself often triggered surveillance, retaliation, or professional sanction. Despite formal ethics approval and institutional affiliations, safety was not guaranteed. Research supervisors, in some cases, failed to respond adequately to threats, abuse, or violations reported during fieldwork -effectively enabling a culture of institutional abandonment. The absence of protective mechanisms for researchers themselves, particularly those working at the intersection of care and critique, reflects a profound ethical gap in current academic infrastructures (Berger, 2015; Gill & Orgad, 2018).

A second major ethical issue relates to the lack of pathways for institutional responsiveness to qualitative findings. Participants shared urgent testimonies of maltreatment, neglect, and even criminal acts within care systems. Yet, qualitative research in mental health lacks clear ethical protocols for real-time response and coordinated redress. The research identified repeated failures by health and social care services to act upon evidence presented informally or formally. This undermines not only the principle of beneficence but also the scientific and civic legitimacy of the research itself. Unlike biomedical trials, which often have established pathways for reporting adverse events, qualitative research in mental health lacks protocols for activating ethical alerts, documenting high-risk environments, or reporting practitioners engaged in harmful behavior (WHO, 2021; Campbell & Burgess, 2012).

The relational ethics of field engagement were further complicated by the presence of institutional actors who blurred the boundaries between care provider, researcher, gatekeeper, and enforcer. These overlapping roles made it difficult for participants to trust the research process, fearing retaliation, breaches of confidentiality, or collusion with coercive systems. Even when anonymity was assured, the localized nature of mental health services made it difficult to protect identities in

small, tightly networked communities. This created a chilling effect, where many potential informants withheld key information, fearing that their cooperation could worsen their situation. Similar challenges have been documented in mental health ethnographies and survivor-led research, where the relational risks of speaking out are high and institutional cultures are resistant to scrutiny (Chamberlain, 2000; LeFrançois, Menzies & Reaume, 2013).

A further finding concerns the moral burden placed on researchers conducting fieldwork in contexts of unresolved trauma. Many participants were actively experiencing distress, institutional betrayal, and unresolved grievances. In such contexts, the researcher cannot ethically remain a neutral observer. The findings call into question the adequacy of traditional models of ethical distance and non-intervention, and instead support the development of trauma-informed, action-oriented, and co-produced research ethics frameworks (Sweeney et al., 2018; Beresford, 2016). This includes protocols for emotional labor, peer debriefing, mental health support for researchers, and ethical exit strategies that avoid retraumatization or abandonment of participants post-fieldwork.

Finally, the limitations of formal ethical oversight bodies were starkly apparent. Ethics committees rarely have expertise in action-research or survivor-led inquiry, and often default to rigid procedural concerns that fail to account for emergent, situated ethical dilemmas. In this research, the need for real-time response mechanisms, version-controlled documentation, secure archiving of sensitive data, and collaborative decision-making far outstripped the static guidelines provided by institutional review boards. These findings echo broader calls for ethical governance reform in research with structurally vulnerable populations (Flicker et al., 2007; Mertens, 2009; Fistein & Quilligan, 2012).

Thus, to be effective and prevent further harm, violence and normalized crimes from repeating, qualitative research in mental health, especially when it engages directly with sites of coercion, exclusion, and structural abuse, must be governed by ethics that are dynamic, grounded, and protective-not merely procedural. The findings of this research contribute to an emerging body of literature demanding that we rethink ethics not as an administrative hurdle but as a living, collective practice of care, justice, and accountability, including protocols of action in case of witnessing or finding out about potential crimes, or severe cases of suffering and violence not yet recognized by practitioners and other colleagues. This shift is not optional -it is the only path forward in a field where human lives, rights, and futures are continually at stake.

Conclusion

The ethical complexities unveiled through this five-year action-research project challenge the very boundaries of what constitutes safe, just, and scientifically grounded qualitative research in mental health. Rather than isolated dilemmas, the findings portray a systemic failure to uphold ethical responsibilities across institutions, services, and research infrastructures. Participants' testimonies of harm -routinely pathologized or erased- reflect not only epistemic injustice (Fricker, 2007; Kidd & Carel, 2017), but an entrenched structural tendency to deny, suppress, and retaliate against uncomfortable truths. Researchers committed to action-oriented methodologies become both witnesses and targets of this violence, confronting a research environment hostile to reflexivity, transparency, or critical accountability (Guillemin & Gillam, 2004; Denzin & Giardina, 2007).

These issues are magnified in contexts like Spain, Sweden, and Italy, where mental health policy and law remain disproportionately focused on control and containment rather than care and redress (Dvoskin & Skeem, 2009; Rose, 2014; Foucault, 2003). Despite recent progress and international declarations urging non-coercive, rights-based approaches (WHO, 2021; Council of Europe, 2023), the operational mechanisms needed to integrate real-time testimony into systemic reform are largely absent. Ethical review boards lack dynamic, context-sensitive protocols. Public institutions often default to denial rather than support when presented with evidence of abuse or malpractice. And researchers, particularly those with lived experience or outsider positionality, are rendered expendable when the truths they uncover threaten institutional interests (Gill & Donaghue, 2016; Clegg, 2016). What this research demonstrates is not simply the presence of ethical risk, but the urgency of a structural reconfiguration. Participatory ethics cannot be procedural; it must be infrastructural. Dynamic feedback loops, public data protocols, and built-in escalation pathways for rights violations must be adopted as core features of qualitative inquiry in mental health. Moreover, universities and public research funders must abandon extractive models of knowledge production in favor of protective, collaborative, and system-improving commitments.

At its most vital, qualitative research is not merely a tool for documentation -it is an instrument of justice, of collective repair, and of epistemic reckoning. This research, embedded in several relevant EU COST actions, such as FOSTREN, culminating in the creation of the EU BEACON One Health Education one, demonstrate the potential of international cooperation to create research ecosystems where testimony is met with transformation, and where those who suffer are no longer expected to remain silent. Our future, at the scientific, social, and planetary levels, depends on our job properly done, following the highest ethical and open science standards, coordinately with other professionals also enforcing the highest possible best practices together.

Funding: This work was supported by the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities, project codes: FPU19/00028 and PID2023-148482NB-I00, on autonomy fostering in mental health care, as well as EU COST actions ReMO CA19117 - Researcher Mental Health (ReMO)- and FOSTREN CA19133 - Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services- scientific missions aimed at this end.

Ethical Approval: Research approved by the Ethics Committee on People, Society and the Environment (CEIPSA), of Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Spain, with identification codes CEIPSA-2024-PRD-0029 and CEIPSA-2022-TDO-0023, for all work done.

Conflict of Interest Statement: The author declares no conflict of interest.

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process: During the preparation of this work the author used ChatGPT in order to improve English language styling and spell checking. After using this service, the author reviewed and edited the content as needed, and take full responsibility for the content of the publication.

References:

- Amnesty International. (2022). *Criminalizing dissent: A growing global threat*. <https://www.amnesty.org>
- Beresford, P. (2016). *All our welfare: Towards participatory social policy*. Policy Press.
- Berger, R. (2015). Now I see it, now I don't: Researcher's position and reflexivity in qualitative research. *Qualitative Research*, 15(2), 219–234. <https://doi.org/10.1177/1468794112468475>
- Bhattacharya, K. (2016). The vulnerable academic: Personal narratives and the emotional labour of doing qualitative research. *The Qualitative Report*, 21(3), 685–704.
- Burstow, B. (2015). *Psychiatry and the business of madness: An ethical and epistemological accounting*. Palgrave Macmillan.
- Campbell, C., & Burgess, R. (2012). The role of communities in advancing the goals of the Movement for Global Mental Health. *Transcultural Psychiatry*, 49(3-4), 379–395. <https://doi.org/10.1177/1363461512454643>
- Campbell, C., & Cornish, F. (2010). Towards a 'fourth generation' of approaches to HIV/AIDS management: Creating contexts for effective community mobilisation. *AIDS Care*, 22(S2), 1569–1579.
- Chamberlain, K. (2000). Methodolatry and qualitative health research. *Journal of Health Psychology*, 5(3), 285–296.
- Clegg, J. W. (2016). How and why critical realism should be used to explain human behavior. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 46(2), 120–143.
- Cohen, D. (1985). *Coercion as cure: A critical history of psychiatry*. Rutgers University Press.
- Council of Europe. (2023). *Compendium of good practices to promote voluntary measures in mental health services*. <https://www.coe.int>
- Cosgrove, L., Mills, C., Karter, J. M., Mehta, A., & Kalathil, J. (2020). A critical review of the Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *Psychiatry Research*, 284, 112675. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112675>
- Denzin, N. K., & Giardina, M. D. (2007). *Ethical futures in qualitative research: Decolonizing the politics of knowledge*. Routledge.
- Dvoskin, J. A., & Skeem, J. L. (2009). Psychiatric advance directives: Making the case for voluntary commitment. *Psychiatric Services*, 60(1), 1–3.
- Edwards, M. A., & Roy, S. (2017). Academic research in the 21st century: Maintaining scientific integrity in a climate of perverse incentives and hypercompetition. *Environmental Engineering Science*, 34(1), 51–61.
- Ellis, C. (2007). Telling secrets, revealing lives: Relational ethics in research with intimate others. *Qualitative Inquiry*, 13(1), 3–29.

- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum: Qualitative Social Research*, 12(1).
- Estroff, S. E. (1981). *Making it crazy: An ethnography of psychiatric clients in an American community*. University of California Press.
- Fals-Borda, O. (1991). *Action and knowledge: Breaking the monopoly with participatory action-research*. Apex Press.
- Fistein, E., & Quilligan, S. (2012). *Mental health law: A practical guide*. Sweet & Maxwell.
- Flicker, S., Travers, R., Guta, A., McDonald, S., & Meagher, A. (2007). Ethical dilemmas in community-based participatory research: Recommendations for institutional review boards. *Journal of Urban Health*, 84(4), 478–493.
- Foucault, M. (1973). *The birth of the clinic: An archaeology of medical perception*. Vintage.
- Foucault, M. (2003). *Society must be defended*. Picador.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gabb, J., & Fink, J. (2015). *Couple relationships in the 21st century: Research, policy, practice*. Palgrave Macmillan.
- Gill, R., & Donaghue, N. (2016). Resilience, apps and reluctant individualism: Technologies of self in the neoliberal academy. *Women's Studies International Forum*, 54, 91–99.
- Gill, R., & Orgad, S. (2018). The amazing bounce-backable woman: Resilience and the psychological turn in neoliberalism. *Sociological Research Online*, 23(2), 477–495.
- Gooding, P. (2015). Navigating the flaws of the mental health tribunal. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 49(2), 121–123.
- Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and ethically important moments in research. *Qualitative Inquiry*, 10(2), 261–280.
- Hammersley, M., & Traianou, A. (2012). *Ethics in qualitative research: Controversies and contexts*. SAGE.
- Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives*. Cornell University Press.
- Hopper, K. (2007). Rethinking social recovery in schizophrenia: What a capabilities approach might offer. *Social Science & Medicine*, 65(5), 868–879.
- Hummelvoll, J. K., Karlsson, B., & Borg, M. (2015). Recovery and person-centeredness in mental health services: Roots of the concepts and implications for practice. *International Practice Development Journal*, 5(1), 1–10.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2(8), e124.

- Iphofen, R. (2017). *Ethical decision making in social research: A practical guide*. Palgrave.
- Johnstone, L., & Boyle, M. (2018). *The Power Threat Meaning Framework: Towards the identification of patterns in emotional distress, unusual experiences and troubled or troubling behaviour, as an alternative to functional psychiatric diagnosis*. British Psychological Society.
- Josselson, R. (2007). The ethical attitude in narrative research: Principles and practicalities. In Clandinin, D. J. (Ed.), *Handbook of narrative inquiry*, 537–566.
- Kidd, I. J., & Carel, H. (2017). Epistemic injustice and illness. *Journal of Applied Philosophy*, 34(2), 172–190.
- Kovach, M. (2009). *Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts*. University of Toronto Press.
- Ladkin, D. (2020). *Rethinking leadership: A new look at old leadership questions*. Edward Elgar Publishing.
- LeFrançois, B. A., Menzies, R., & Reaume, G. (2013). *Mad matters: A critical reader in Canadian mad studies*. Canadian Scholars' Press.
- Mertens, D. M. (2009). *Transformative research and evaluation*. Guilford Press.
- Metzl, J. M. (2010). *The protest psychosis: How schizophrenia became a Black disease*. Beacon Press.
- Mills, C. (2014). *Decolonizing global mental health: The psychiatrization of the majority world*. Routledge.
- Moncrieff, J. (2008). *The myth of the chemical cure: A critique of psychiatric drug treatment*. Palgrave Macmillan.
- Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N., ... & Ioannidis, J. P. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 0021.
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., ... & Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Pillow, W. (2003). Confession, catharsis, or cure? Rethinking the uses of reflexivity as methodological power in qualitative research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 16(2), 175–196.
- Pūras, D. (2020). *Report of the UN Special Rapporteur on the right to health: Mental health and human rights*. United Nations Human Rights Council.
- Rose, D. (2003). Collaborative research between users and professionals: Peaks and pitfalls. *Psychiatric Bulletin*, 27(11), 404–406.
- Rose, D. (2014). *Users and abusers of psychiatry: A critical look at psychiatric practice*. Routledge.

Rose, D. (2018). *Madness strikes back: Science, power and the contested politics of mental health*. Springer.

Rose, D., & Kalathil, J. (2019). Power, privilege and knowledge: The untenable promise of co-production in mental 'health'. *Frontiers in Sociology*, 4, 57.

Russo, J. (2016). Through the eyes of the observed: Re-directing research on psychiatric drugs. *Health Care Analysis*, 24(1), 67–76.

Russo, J., & Sweeney, A. (2016). Searching for a rose garden: Challenging psychiatry, fostering mad studies. *PCCS Books*.

Saini, A. (2020). *Superior: The return of race science*. Beacon Press.

Scheper-Hughes, N. (1992). *Death without weeping: The violence of everyday life in Brazil*. University of California Press.

Sharfstein, S. S. (1985). The giving up-given up syndrome. *Hospital & Community Psychiatry*, 36(7), 698–702.

Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2014). Institutional betrayal. *American Psychologist*, 69(6), 575–587.

Sweeney, A., Filson, B., Kennedy, A., Collinson, L., & Gillard, S. (2018). A paradigm shift: Relationships in trauma-informed mental health services. *BJ Psych Advances*, 24(5), 319–333.

Torre, M. E. (2009). Participatory action research and critical race theory: Fueling spaces for nos-otras. *Urban Review*, 41(1), 106–120.

United Nations. (2017). *Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies*. <https://www.ohchr.org>

UN Human Rights Council. (2023). *Report on mental health and human rights*. <https://www.ohchr.org>

Voronka, J. (2016). The politics of 'people with lived experience': Experiential authority and the risks of strategic essentialism. *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*, 23(3), 189–201.

WHO. (2021). *Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches*. World Health Organization.

Annex C - *Frontiers in Psychology*: implementation of open dialogue in Spain

Annex C of the dissertation, which includes the peer-reviewed article published in *Frontiers in Psychology* on the implementation of Open Dialogue in Spain, is not an isolated addendum but an integral component of the overall research architecture. It reinforces and operationalizes the dissertation's central thesis concerning the necessity of non-coercive, dialogical, and rights-based approaches in mental health care. This annex specifically documents the institutional challenges, epistemic tensions, and clinical opportunities encountered in the nascent attempts to apply Open Dialogue in the Spanish context, making it a critical empirical and theoretical extension of the broader inquiry. The dissertation as a whole critiques the Spanish psychiatric system for its entrenchment in coercive, pharmacocentric, and exclusionary practices, and it does so through a biocultural and transdisciplinary lens. The inclusion of Annex C thus serves to demonstrate that alternatives grounded in dialogical ethics are not only theoretically sound but also practically feasible within the very systems currently dominated by coercive logics. The Open Dialogue model, rooted in relational epistemology and shared sense-making, is presented in this annex not as a foreign or utopian import but as a scientifically validated and ethically imperative framework. The documented efforts to pilot this model in Spain provide concrete evidence that the transition from compliance-based care to collaborative, recovery-oriented practice is possible, albeit institutionally obstructed. Annex C directly corresponds to several operational research questions articulated in the core chapters, particularly those concerning the enabling conditions for institutional transformation, the epistemic reconfiguration of clinical practice, and the reallocation of authority from professional dominance to dialogical partnership. It aligns with the thesis argument that dialogical practice must be redefined not as a mere communicative technique but as a foundational epistemic and ethical orientation. The annex demonstrates how this redefinition can be instantiated through clinical practice, even within systems that structurally resist such shifts.

The narratives and observations contained in Annex C contribute to the dissertation's ethnographic corpus, complementing the testimonies and survey data presented in Chapters 3 and 4. They illustrate the lived contradictions and ethical dissonance experienced by clinicians and users when attempting to enact Open Dialogue within institutional frameworks that remain hierarchical, pharmacologically reductive, and risk-averse. These findings are analytically synthesized in Chapters 5 and 6, where the dissertation interrogates the structural barriers to rights-based reform and formulates normative proposals grounded in international human rights standards and medical ethics. The inclusion of Annex C confirms the dissertation's methodological commitment to participatory, field-based action-research. The article does not merely describe a model but traces its concrete application, adaptation, and resistance in context. It provides both validation of the research methodology and evidence for the thesis's claim that shared decision-making and dialogical care are empirically viable, clinically effective, and ethically superior alternatives to dominant coercive regimes.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1166919/full>

Annex D - The aggressiveness of xenophobia

Annex D of the dissertation, *The destructiveness of xenophobia*, constitutes a personal yet analytically rigorous testimony that directly reinforces the core scientific and ethical arguments presented throughout the thesis. While stylistically different from the more academic structure of the dissertation's main chapters, this published piece is deeply coherent with its theoretical premises and empirical findings. It serves as both an evidentiary artifact and a first-person analytical intervention into the intersection of psychiatric misdiagnosis, domestic violence, and institutional betrayal, all mediated through racialised and xenophobic logics of exclusion.

The annex exemplifies the structural argument made in the dissertation regarding the epistemic and clinical erosion that occurs when institutions disregard context, silence the voice of the person, and substitute rigid protocols for compassionate, situated understanding. The author's lived experience, threatened with involuntary institutionalization due to a misread migraine, demonstrates how biomedical instruments, such as TAC scans, can become tools of harm when wielded without interpretive competence, particularly in the presence of coercive interpersonal dynamics. This real-world event validates the dissertation's broader critique of diagnostic reductionism and professional impunity. The annex becomes, therefore, a documented case study that illustrates the very mechanisms the thesis seeks to dismantle. The annex highlights the medical neglect of domestic violence indicators, a recurrent theme in the thesis. It exposes how institutions meant to protect health and dignity may instead become facilitators of additional harm, especially when influenced by discriminatory assumptions and institutionalised racism. These are not anecdotal misfortunes but, as the dissertation repeatedly emphasizes, expressions of a systemic failure that normalizes harm under the guise of care. The annex strengthens the claim that epistemic violence and psychiatric coercion are often co-produced with gendered and racialized exclusions, and that health systems remain deeply susceptible to moral disengagement when encountering those perceived as foreign or non-normative. The text also supports the dissertation's methodological position that testimony and narrative are essential forms of epistemological resistance. It functions as both a testimonial document and an act of scholarly defiance, reasserting the right of survivors to define their own experiences and contribute to institutional critique.

Through this contribution, the dissertation operationalizes its own participatory and action-research framework by integrating embodied knowledge into the academic archive, thereby resisting the dehumanizing effects of structural and clinical abstraction. This annex aligns with the dissertation's call for urgent institutional reform grounded in evidence-based, rights-respecting, and dialogical practice. It underscores the immediate need for diagnostic rigor, trauma-informed protocols, and anti-discrimination safeguards in medical and psychosocial care. It speaks directly to the dissertation's analysis of social death, administrative dispossession, and epistemic erasure, while offering a lived, human counterpoint to statistical and policy analysis. In so doing, Annex D does not stand apart from the dissertation's architecture but embodies it. It expands the evidence base, deepens the methodological plurality, and reaffirms the dissertation's guiding principle: that dignity, truth, and structural justice are non-negotiable imperatives in health care.

<https://research.henning.md/p/the-simplest-thank-you>

Annex E - Nocebo effect and psychiatry: giving up given up syndrome and sociomedical somatisation

Annex E, which includes the authored book chapter *Nocebo Effect and Psychiatry*, constitutes a central theoretical and empirical contribution to the dissertation's argument concerning structural harm, iatrogenic suffering, and the sociopolitical dimensions of psychiatric practice. This chapter deepens the dissertation's core claim that contemporary psychiatric systems frequently produce harm not only through overt coercion or misdiagnosis but also through the cumulative effects of epistemic invalidation, neglect, and interpretive violence. It provides a conceptual framework for understanding how expectations of failure, stigma, and professional disengagement are internalised by patients and translated into chronic physiological and psychological deterioration.

The chapter is especially relevant to the dissertation's analysis of what is termed social death and administrative dispossession. The construct of the giving up, given up syndrome complements and extends the ethnographic and survey-based findings presented in Chapters 3 and 4 by offering an explanatory model grounded in transcultural psychiatry, psychoneuroimmunology, and medical anthropology. It clarifies how systemic invalidation, when repeated across healthcare, legal, and familial systems, can precipitate biological shutdown, loss of agency, and relational withdrawal. This nocebo effect, understood as the induction of harm through negative meaning and institutional betrayal, offers a scientifically and clinically grounded lens to interpret the data collected from survivors, professionals, and family members.

The chapter also provides the theoretical grounding for the dissertation's critique of diagnostic authority and its proposed shift toward dialogical and narrative-based care. It interrogates the semiotics of psychiatric labeling and the performative power of prognosis, linking these with somatic outcomes that cannot be adequately addressed within biomedical reductionism. The dissertation's call for One Health-informed, trauma-sensitive, and recovery-oriented care is reinforced by this annex, which demonstrates how integrated physiological, social, and narrative frameworks are necessary to reverse the damage produced by chronic exposure to invalidation and exclusion. This annex demonstrates the dissertation's methodological coherence. It showcases the capacity of the researcher to integrate personal experience, theoretical synthesis, and clinical insight into a form of transdisciplinary scholarship that is operational, not merely interpretive. By naming and documenting a recognisable yet under-theorised phenomenon, the chapter also advances the dissertation's broader goal of epistemic repair and reorientation of clinical paradigms toward human dignity and contextualized care.

Annex E is not ancillary but structurally embedded in the dissertation's analytical core. It translates the dissertation's findings into a conceptual schema capable of informing clinical training, diagnostic reflexivity, and health system design. It aligns with the overarching aim of the thesis to dismantle harmful psychiatric orthodoxy and build ethically grounded, scientifically coherent, and structurally competent frameworks of mental health care.

<https://doi.org/10.22533/at.ed.3142122119>

Annex F - *Nature–Springer* book chapter on alternatives to coercion

The *Nature–Springer* book chapter authored by the researcher on alternatives to coercion, holds significant relevance to the core of the dissertation. It presents a rigorous synthesis of evidence-based, rights-oriented, and contextually grounded approaches that challenge the dominant paradigm of coercive psychiatric intervention. By articulating viable clinical and institutional alternatives, the chapter offers a concrete operational counterpart to the dissertation's analytical critique of systemic coercion, diagnostic overreach, and structural violence.

The chapter situates dialogical ethics, service user leadership, and therapeutic alliance as foundational elements of effective and just mental health care. These concepts are not treated as ideological preferences but as empirically validated components of recovery-oriented practice. This aligns directly with the dissertation's central claim that coercion is not only ethically untenable but clinically counterproductive, and that non-coercive models such as Open Dialogue, collaborative medication management, and trauma-informed care are not aspirational ideals but necessary reforms backed by scientific consensus and human rights standards.

The inclusion of this chapter within the dissertation underscores the researcher's active role in international scientific dialogues and affirms the dissertation's methodological and normative credibility. It reflects the capacity to contribute to high-level peer-reviewed discourse while maintaining a critical and transformative perspective grounded in both lived experience and empirical analysis. The chapter also provides a structured overview of implementation pathways, including the legal, educational, and institutional shifts required to transition from coercion to collaboration, which are further developed in the dissertation's concluding chapters and annexes.

Annex F exemplifies the translational dimension of the dissertation, bridging academic research with actionable system redesign. It reinforces the thesis's call for structural reform by demonstrating that ethical and clinically sound alternatives are not only available but already in practice across multiple contexts. The chapter thus affirms the dissertation's dual ambition: to expose systemic harm and to build coherent, rights-based alternatives capable of sustaining human dignity and institutional legitimacy in mental health care.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61224-4_17

Annex G - Proceedings of political abuses of psychiatry

Political Abuse of Psychiatry, Medical Torture, and Victim De-Legitimization: Insights from an International Symposium

Abstract: The political abuse of psychiatry is an ongoing, systemic phenomenon rooted in the replacement of sound governance and ethical medical standards by incompetent authority, rogue state practices, and criminal misuse. Drawing from a global symposium integrating survivor testimony, academic analysis, and human rights advocacy, the discussion highlights how mental health systems -when left vulnerable by corruption, inefficiency, or deliberate political manipulation- become instruments of repression rather than healing. The ease with which abuses occur in failed systems, the profound human and economic costs inflicted, and the perpetuation of systemic failure through the weaponization of psychiatry are analyzed in depth. Comprehensive solutions are proposed across international, national, institutional, community, and individual levels, emphasizing the urgent need for rights-based, trauma-informed, interdisciplinary reform. Restoring psychiatry's ethical foundations is presented not merely as professional necessity but as a profound moral imperative to protect life, freedom, sanity, and human dignity on a global scale.

Keywords: Political abuse of psychiatry; rogue states; failed healthcare systems; human rights violations; psychiatric coercion; trauma-informed care; mental health reform; international crime; dignity and autonomy; systemic failure; survivor advocacy; healthcare ethics.

Introduction

Throughout history and across the World, psychiatry has held the power to help -or to harm. It is a field that touches the most intimate aspects of human life: thought, emotion, behaviour, identity. Yet this same power has been used to silence, punish, and erase. Under the guise of care, individuals have been subjected to forced treatment, indefinite detention, and forms of medical coercion that violate basic rights. These are not merely past injustices or errors in judgment, but the result of structural conditions that allow systems of health to be bent into tools of control. When dissent, difference, or distress caused by the very same system and criminal actors are labeled as pathology, no one is safe from the risk of being made to suffer. This proceedings paper begins from that stark reality, but not to accept it. Rather, it aims to examine how these abuses occur, why they persist, and what can be done to transform psychiatry into a field worthy of its healing promise.

Political abuse of psychiatry refers to the deliberate misuse of mental-health diagnoses, treatments, or involuntary detention to punish, silence, or discredit dissenting individuals or groups. Van Voren (2009) explains that it means misuse of psychiatric diagnosis, treatment and detention to obstruct people's fundamental rights. Despite appearances to the contrary, such abuses have never been confined to openly authoritarian systems; even in established democracies there are documented instances of whistle-blowers and critics being stigmatized as mentally ill. Indeed, historical and contemporary reports show that the tension between politics and psychiatry has been global and is an ongoing unresolved problem (van Voren, 2010).

The relatively recent historical record is stark. In Nazi Germany, psychiatrists were complicit in eugenic and punitive policies -a violation of their duty of care- using racist and ideologic criteria to justify locking up, deporting and killing disabled and political others (Narayan, 2013). In the Soviet Union during the Cold War, dissent was pathologized on a massive scale. Soviet psychiatrists proclaimed that critics were mentally ill, since no one would oppose their alleged best system unless insane, and often diagnosed dissidents with Snezhnevsky's made up sluggish schizophrenia diagnosis, a supposed mild form of schizophrenia whose symptoms conveniently included reform delusions or struggle for the truth (van Voren, 2010). Van Voren (2009) notes that in the 1970s-80s roughly one-third of all political prisoners in the USSR were confined in psychiatric hospitals. These practices sparked international outrage and led to the Soviet psychiatric society's suspension from the World Psychiatric Association in 1983. Other Eastern Bloc states followed suit to a lesser extent: for example, reports indicate that Romania under Ceaușescu systematically labeled hundreds of regime opponents as mentally ill (often for crimes like petitioning the authorities), resulting in mass psychiatric incarceration. Countries such as Cuba also implemented sometimes short-lived programs of detaining dissidents in mental institutions in the late 20th century. Notably, an unusual case in 1990s Netherlands showed that such abuse could occur in a democratic setting as well: a Dutch Defense Ministry official falsified psychiatric diagnoses to silence a social worker, a scheme later overturned by courts. These historical episodes - whether in Nazi Germany, the Soviet bloc, or isolated cases in the West - underscore that psychiatry has been repeatedly corrupted as a tool of political repression (Narayan, 2013).

At the root of genocides, purges, and systemic repression lies a recurring mechanism: the dehumanization of those labeled as feeble-minded, deviant, inferior, or unfit. Cognitive biases such as moral disengagement, group conformity, and the illusion of a just world, combine with a corrosive sense of superiority that gives moral cover to cruelty. This mindset easily merges with opportunism and criminality, providing social and material incentives for professionals and ordinary citizens to participate in abuse. Hatred becomes a path to belonging and prestige. In Nazi Germany, psychiatrists designed and implemented the Aktion T4 program, selecting tens of thousands of disabled individuals for extermination under the guise of medical necessity. These killings, sanitized through clinical language and bureaucratic process, laid the morals, mindset, rewards, technical, and institutional groundwork for the Holocaust and the Second World War itself (Friedlander, 1995). In the Soviet Union, psychiatry was weaponized to silence dissent: critics of the regime were declared insane and confined indefinitely, often tortured in the name of treatment (van Voren, 2010). These are not historical anomalies. From colonial asylums to apartheid psychiatry, from the Khmer Rouge to present-day internment and reeducation programs, the same logic persists. Racism, ableism, and political repression intersect with pseudoscience and institutional power, allowing medical torture to be reframed as care. Once any system presumes the authority to define sanity, worth, or humanity itself, it grants itself license to destroy. These practices are not only abuses of science and medicine, these are crimes that strike at the core of what our civilization claims to uphold. Failing to expose and dismantle these structures ensures their return, in new and old forms, again and again.

Table 1: Barriers to Political Abuses of Psychiatry

Domain	Protective Factors	Vulnerabilities When Absent
Legal Safeguards	Independent oversight, enforceable patient rights, access to justice	Arbitrary detention, impunity, unchecked coercion
Ethical Practice	External review boards, whistleblower protection, survivor-led ethics	Collusion, fear of reprisal, normalized violations
Clinical Approach	Shared decision-making, trauma-informed care, consent-based treatment	Forced interventions, disregard for autonomy
Training and Culture	Rights-based education, reflective practice, critical pedagogy	Authoritarianism, biomedical dogma, silencing of dissent
Economic Integrity	Transparent funding, non-profit care models, conflict of interest checks	Overmedication, neglect, market-driven interventions
Community Role	Peer support, advocacy groups, participatory service design	Isolation, stigma, lack of accountability
Public Awareness	Media scrutiny, civic engagement, open reporting channels	Denial, invisibility of harm, politicized psychiatric labels

Today, political psychiatry abuses persist in various countries. In the Russian Federation, rights groups and journalists report a revival of punitive psychiatry since 2022. Reuters (2025) found that dozens of anti-war activists and protesters have been ordered into psychiatric evaluation or detention by courts, a pattern reminiscent of the Soviet era (Peoples Gazette, 2025). One detailed case involved Yekaterina Fatyanova, an opposition journalist who was involuntarily hospitalized for two months after her paper published an anti-war article; letters she sent from the hospital describe unnecessary and degrading procedures, and she was finally discharged as mentally healthy. Robert van Voren, who has studied Russian psychiatry, documented roughly 20-30 such cases per year since 2022. In April 2025 a Moscow court also made international news by committing a U.S. citizen (Joseph Tater) to compulsory psychiatric treatment after annulment of criminal charges - a move observers likened to Soviet-era psychiatric coercion (Reuters, 2025). In neighboring Belarus, the authoritarian regime of Alexander Lukashenko has used psychiatric hospitals to punish critics of the 2020 elections. UN human-rights experts reported in early 2025 that at least 33 opposition figures have been coerced into undergoing psychiatric treatment for peaceful protest, with most still held indefinitely. Experts warn that this amounts to a grave violation of human rights, noting that many detainees are kept confined for months or years with no legal recourse (Trickey, 2025).

In the People's Republic of China, too, multiple sources confirm severe ongoing abuses. A 2022 investigation published by Safeguard Defenders found that from 2015-2021 at least 99 petitioners and activists were involuntarily locked up in psychiatric facilities for political reasons, often without any legitimate diagnosis (Mou, 2022). The NGO concluded that forcing critics into mental hospitals is still widespread and routine in China today. These cases span the country: one recent report noted that courts routinely dispatch petitioners, petition filers, anti-corruption complainants and even labor activists to psychiatric wards under various pretexts. The victims describe arbitrary detention, forced medication, electroconvulsive therapy and repeated incarceration, all to silence dissent (The Washington Post, 2022). A prominent example is the so-called *Ink Girl*, Dong Yaoqiong, who in

2018 splashed ink on a poster of Xi Jinping; she was repeatedly committed to a psychiatric hospital, restrained to her bed and beaten for refusing treatment, despite being found mentally healthy each time. International observers note that Chinese abuse of psychiatry today involves far larger numbers of people than even the Soviet regime did, targeting followers of banned faiths (e.g. Falun Gong), human-rights lawyers, dissident petitioners and whistle-blowers.

Elsewhere in Asia and beyond, cases continue to surface. In Iran, for instance, a *Lancet Psychiatry* commentary (Wasserman *et al.*, 2023) described how a young student was forcibly hospitalized in Tehran after staging a protest against compulsory hijab laws, despite having no medical diagnosis - an act likened to political repression through psychiatry (World Psychiatric Association, 2025; *The Lancet Psychiatry*, 2025). Human-rights advocates in the U.S. have also warned of such misuse: historically, racist and political dissent have been pathologized: e.g. antebellum drapetomania for escaping slaves, and mid-20th-century civil-rights activists declared delusional (Edwards-Grossi, 2024). While overt examples in modern American politics are rare, the specter remains. Even well-established democracies have seen whistle-blowers subjected to psychiatric censure (van Voren, 2010). The overall pattern is clear: wherever political power is unchecked, there is incentive to brand opponents as mentally ill.

The political abuse of psychiatry has a long pedigree from Nazi and Soviet eras to today's China, Russia, Belarus and failing, corrupt systems elsewhere. It relies on fabricating or exaggerating psychiatric disorders to neutralize dissent without legal trial, violating medical ethics and human rights at every step (van Voren, 2010). Landmark investigations and recent human-rights reports show that this practice persists under new guises. While the number of countries openly running such programs has declined since the Cold War (van Voren, 2009; Narayan, 2013), current evidence underscores that political psychiatry remains very much a present-day issue. Authorities in repressive regimes, and corrupt institutions in democracies, continue to weaponize mental-health institutions to stigmatize and silence critics (Mou, 2022). Contemporary sources make clear that each claim of involuntary psychiatric commitment for political reasons must be scrutinized as a potential human-rights abuse.

Symposium Presentation

The International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry convened between October 1 and November 11, 2023, gathering leading experts, survivor advocates, and human rights scholars to systematically examine the persistence and mechanisms of psychiatric abuses worldwide. Organized independently after the rejection of formal inclusion within the World Psychiatric Association's (WPA) Vienna conference premises, the symposium unfolded across a series of virtual and recorded sessions, ensuring free and rigorous exchange of evidence and strategies for reform.

[Pending naming confirmation and permission to include or not a mention on van Voren's satellite event organized concurrently in Vienna by partner organizations may be referenced here.]

Table 2: Symposium Speakers, Topics Covered, and Core Focus

Speaker(s)	Topic Covered	Core Focus
Alejandra Gandolfi	Mental healthcare and discrimination against Moroccan migrants in Spain	Systemic Abuse
Al Galves	Critique of the biomedical model and promotion of holistic mental health care	Systemic Reform, Survivor Advocacy
Cathy Wield	Informed consent and psychiatric detention from a survivor-doctor perspective	Survivor Advocacy, Human Rights
Chris Munt	Survivor testimony on psychiatric violence in the UK	Survivor Advocacy
Dainius Pūras	Human rights and mental health from a UN perspective	Human Rights
David Matas	Psychiatric abuses linked to organ harvesting in China	Human Rights, Legal Frameworks
Edel Granda	Psychiatric pathologization of transgender individuals	Human Rights
Hel Spandler	Structural coercion in UK mental healthcare	Systemic Abuse
Itxaso & Olaya (Orgullo Loco Madrid)	Grassroots activism against psychiatric coercion in Spain	Survivor Advocacy
Lidea Losa & Xisca Morell	Psychiatric abuses and guardianship issues in Spain	Systemic Abuse, Survivor Advocacy
Manuel Llorens	Political psychiatric abuses during Venezuela's health system collapse	Systemic Abuse
Murphy Halliburton	Importance of transcultural psychiatry to counter biomedical dominance	Transcultural Psychiatry
Paola Di Maio	Systems view of psychological coercion in mental health	Systemic Abuse
Peter Groot	Medication withdrawal and the right to taper safely	Survivor Advocacy
Peter Lehmann & Craig Newnes	Historical and contemporary human rights abuses in Europe	Systemic Abuse
Petr Winkler	Reforming Czech psychiatry to protect human rights	Legal Frameworks, Human Rights
Sarah Smith	Mutual aid networks resisting psychiatric abuses (MindFreedom SHIELD)	Survivor Advocacy
Yanxi Mou	China's black prisons and extrajudicial psychiatric detention	Human Rights
Yutong Zhang	Psychiatric repression of dissenters in the PRC	Human Rights

Participants brought distinct and crucial expertise. Dainius Pūras, former United Nations Special Rapporteur on the right to health, provided critical insights on the systemic contradictions between

psychiatric practice and human rights frameworks, grounding the discussions in international legal obligations. Peter Lehmann, survivor advocate and founder of the European Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry, and Craig Newnes, clinical psychologist and critical psychiatry scholar, contributed an essential historical and experiential analysis of coercive practices across European contexts. Peter Groot, research scientist and leading proponent of individualized medication withdrawal solutions, introduced evidence-based strategies to dismantle forced chemical management. Alejandra Gandolfi, anthropologist, illuminated the intersections between psychiatric marginalization and cultural displacement, particularly within Spain's Moroccan communities.

Hel Spandler, editor of *Asylum: The Magazine for Democratic Psychiatry*, critically examined systemic coercion within the UK mental health system. Chris Munt, survivor and advocate, shared firsthand accounts of abuses in British psychiatric care, highlighting the normalization of violence. Paola Di Maio, systems scientist, articulated a structural model explaining how coercion infiltrates mental health services through psychological and systemic mechanisms. Edel Granda, activist and advocate for transgender rights, foregrounded the pathologization of gender non-conformity as a key dimension of psychiatric oppression.

Murphy Halliburton, professor of anthropology specializing in transcultural psychiatry, emphasized the necessity of integrating cultural and social understandings to counter hegemonic biomedical dominance. Manuel Llorens, Venezuelan psychologist and academic, documented the collapse of healthcare structures and their exploitation for political repression. David Matas, human rights lawyer and Nobel Peace Prize nominee, provided a legal and forensic perspective on the psychiatric and organ harvesting abuses perpetrated in China. Yutong Zhang and Yanxi Mou, Chinese human rights defenders, exposed the systematic use of psychiatric detention to silence dissent, presenting detailed documentation and survivor testimonies.

Sarah Smith, activist with the SHIELD MindFreedom network, shared strategies for survivor-led mutual aid and resistance against coercive psychiatry. Petr Winkler, director of the Czech National Institute of Mental Health, contributed a case study on rights-centered psychiatric reform within a post-totalitarian context, offering a potential model for systemic transformation. Al Galves, clinical psychologist and author, critically assessed the biomedical model's failures in the United States and outlined paths toward holistic and voluntary mental health care.

Derek Summerfield critically examined the global mental health movement, emphasizing how Western psychiatric models are often exported into diverse cultural contexts without sufficient adaptation or scrutiny. He argued that this expansion often perpetuates medicalized understandings of distress while sidelining social, political, and economic determinants of suffering. Summerfield warned that global mental health initiatives, although framed as humanitarian, can become vehicles for the homogenization of psychiatric practices and facilitate new forms of coercion and marginalization. His intervention underscored the need to critically interrogate not only national abuses of psychiatry but also how international agendas risk replicating systemic failures under the guise of global health promotion, thus reinforcing rather than dismantling structures of oppression.

Each participant’s contribution was integral to constructing a comprehensive, interdisciplinary understanding of how psychiatry, when severed from its ethical foundations, becomes vulnerable to criminal misuse, political repression, and systemic failure. Their collective expertise underscored the necessity of principled, multidisciplinary action to reclaim psychiatry for healing, freedom, and dignity.

Mechanisms of Abuse (Psychiatric, Psychological, Social)

Across the independent presentations at the symposium, a detailed portrait emerged of the mechanisms by which psychiatry is weaponized against individuals. These mechanisms, operating simultaneously at psychiatric, psychological, and social levels, reflect a shared understanding among the speakers that abuses today are systemic, severe, and require immediate redress.

Table 3: Historical and current cases of political abuse of psychiatry

Country	Period	Target Group	Type of Abuse Documented
Soviet Union	1950s–1980s	Political dissidents, human rights activists	Forced hospitalization, chemical restraint, isolation
China	1990s–present	Petitioners, Falun Gong members, dissidents, ethnic minorities	Forced hospitalization, chemical restraint, organ harvesting and trafficking
Russia	1960s–1980s; resurgence post-2010	Political dissidents (historical); anti-war protesters (current)	Forced psychiatric evaluation, silencing, social stigma
Belarus	2020s–present	Political protesters, journalists	Coercive hospitalization, stigmatization
Venezuela	2010s–present	Political opponents, dissidents	Forced psychiatric confinement, political intimidation
United States	1950s–1970s	Civil rights activists, indigenous communities, antiwar protesters	Wrongful institutionalization, psychiatric silencing
United Kingdom	1970s–1990s	Persons labeled as dangerous, racial and ethnic minorities	Overuse of detention, coercion in psychiatric care
Spain	1936–1980s (Civil War, Dictatorship, Post-dictatorship)	Political prisoners, dissidents, social minorities	Political repression via psychiatric institutions, social control through diagnosis

At the psychiatric level, Peter Lehmann and Craig Newnes highlighted the way in which forced treatment practices are justified through diagnostic constructs that lack rigorous clinical basis in many cases. They emphasized that psychiatric categories are often expanded to encompass a wide range of socially undesirable behaviors, facilitating involuntary hospitalization under vague pretexts (Lehmann & Newnes, 2025). Peter Groot’s intervention on the use of tapering strips illustrated

another dimension: the over-medicalization and long-term chemical control of individuals under the guise of psychiatric care. He noted that psychiatric drug regimens, initially imposed under coercive circumstances, are rarely reviewed critically, leading to dependency and the erosion of autonomy (Groot, 2025).

Psychological mechanisms were particularly illuminated through the testimonies of survivors. Chris Munt described how everyday practices within psychiatric institutions, including threats, humiliation, and arbitrary use of restraint, foster a climate of terror rather than healing (Munt, 2025). Sarah Smith added a critical dimension by explaining how psychiatric labeling leads to profound identity destabilization. Once classified as mentally ill, individuals find their narratives invalidated, their perceptions systematically doubted, and their autonomy curtailed, creating a cycle of learned helplessness (Smith, 2025). Hel Spandler's analysis of UK psychiatric reforms suggested that, despite superficial procedural safeguards, the underlying culture of distrust toward patients remains pervasive, maintaining psychological coercion even where formal rights protections exist (Spandler, 2025). Orgullo Loco Madrid provided a critical intervention focused on the systemic failures of the Spanish mental health system from the perspective of the user and survivor movement. They emphasized how psychiatric institutions continue to function as mechanisms of control and silencing, rather than as spaces of healing and support. The speakers highlighted the persistence of coercive practices, including involuntary hospitalization and forced medication, often justified under paternalistic frameworks that deny the autonomy and voice of the individuals affected. They further stressed the structural marginalization of survivors in both clinical practice and policymaking, calling for a radical transformation toward user-led, rights-based, and emancipatory models of mental health care. Their testimony underscored the need to recognize psychiatric oppression as a form of political and social violence embedded in broader patterns of discrimination and exclusion.

At the social level, Edel Granda's presentation on transgender rights revealed how psychiatric structures are employed to marginalize already vulnerable populations. She argued that pathologizing gender non-conformity perpetuates systemic exclusion and medical violence under the veneer of care (Granda, 2025). Lidea Losa and Xisca Morell provided a powerful account of how Spanish psychiatric institutions often use legal and social levers, such as guardianship regimes, to strip individuals of civil rights, making abuse both invisible and legally sanctioned (Losa & Morell, 2025). Dr. Paola Di Maio expanded the systemic view by framing psychiatric coercion as part of broader systems of psychological control in society, wherein labeling, enforced dependency, and isolation function as tools to suppress dissent and difference (Di Maio, 2025).

Together, although articulated independently, these contributions outlined a sophisticated model of how political, institutional, and interpersonal forces converge to perpetrate psychiatric abuses. The resulting mechanisms are not incidental but structurally embedded, calling into question the very ethical foundations of current mental health practices in many contexts.

Thematic Synthesis of Symposium Discussions

The thematic convergence of the symposium was clear: despite differing geographical focuses and analytical lenses, speakers consistently revealed the persistence, gravity, and systemic character of psychiatric abuses. No formal consensus process occurred during the event, but the independent presentations together illuminated critical thematic patterns.

One central theme was the **instrumentalization of psychiatric diagnosis**. David Matas, focusing on China's organ harvesting practices, explained that psychiatric labels are used strategically to delegitimize political and religious dissidents, facilitating both their disappearance and commodification (Matas, 2025). Similarly, Yutong Zhang detailed how psychiatric diagnoses in China are weaponized against petitioners and activists, with forced hospitalization serving as a method of silencing (Zhang, 2025).

Another recurring theme was the **role of forced treatment and chemical control**. Peter Groot's exposition on tapering strips underscored how psychiatric medication regimens, often initiated under coercion, become chronic mechanisms of control rather than care (Groot, 2025). This point resonated with the broader critique articulated by Chris Munt and Al Galves, who emphasized that in the UK and USA respectively, institutional psychiatry often prioritizes chemical restraint over addressing the underlying social or psychological distress of individuals (Munt, 2025; Galves, 2025).

Table 4: Mechanisms Abuse: Subterfuges, Methods, and Enabling Conditions

Subterfuge or Foul Play	Method Employed	Path to Extrajudicial Locking	Permissive Factors
Fabrication of mental instability	Spreading rumors, false reports, character assassination	Initiates involuntary psychiatric evaluation without cause	Weak legal standards, corruption in healthcare and law enforcement
Provocation into reactive behavior	Harassment, isolation, threats	Victim's natural defense misinterpreted as psychiatric symptoms	Institutional bias, failure to investigate impartially
Forced biological destabilization	Sleep deprivation, food deprivation, chemical agents	Induces cognitive or emotional breakdowns misused as justification	Medical malpractice, collusion between non-medical and psychiatric actors
Misdiagnosis and diagnostic inflation	Deliberate exaggeration or falsification of symptoms	Grounds for commitment without independent review	Inadequate oversight, professional impunity
Coerced testimonies	Pressuring family or associates to corroborate false claims	Falsified support for psychiatric intervention	Fear, loyalty conflicts, systemic impunity
Weaponized guardianship or custody abuse	Manipulating civil legal processes	Enables psychiatric confinement under pretenses of protection	Lack of transparency, judicial rubber-stamping
Administrative shortcuts and procedural abuses	Detention without proper judicial authorization	Administrative detention masked as medical necessity	Low accountability in bureaucratic and health systems
Abuse of emergency psychiatric holds	Misuse of short-term <i>crisis</i> detention powers	Converts temporary holds into extended confinement	Loopholes in mental health laws, lack of mandatory reviews

The tactics identified in the table above are not limited to authoritarian or politically repressive systems. Similar patterns are visible in domestic violence cases, organized crime, and systemic failures in regular healthcare settings. In domestic environments, abusive partners, family members, or associates may similarly provoke, destabilize, or falsely accuse victims to gain control, silence dissent, or exploit vulnerabilities. Organized crime networks may weaponize mental health accusations to intimidate or remove threats without legal processes. Even within ostensibly democratic societies, negligent or corrupt actors within healthcare systems may collude to achieve unlawful psychiatric detention for convenience, financial benefit, or retaliation. The intersection of psychiatry with broader systems of political and social repression emerged prominently. Manuel Llorens described how in Venezuela, psychiatric detention has been repurposed as a tool to neutralize political opponents, with little concern for medical legitimacy (Llorens, 2025). Yanxi Mou’s testimony on China’s black prisons showed how psychiatric justifications are created post hoc to enable extrajudicial detention without legal oversight (Mou, 2025).

The de-legitimization and isolation of victims was another major theme. Sarah Smith and Edel Granda highlighted how individuals labeled as mentally ill, particularly those from already marginalized communities, experience profound social exclusion, often compounded by institutional betrayal and public stigma (Smith, 2025; Granda, 2025). Dr. Paola Di Maio’s systems analysis reinforced this, positing that psychiatric practices of categorization and containment mirror broader societal mechanisms of control and marginalization (Di Maio, 2025).

A thread of human rights protection and ongoing reform ran through many contributions as well. Dainius Puras stressed the international human rights framework that obliges states to move toward non-coercive, rights-respecting mental health systems, though he acknowledged the gap between principle and practice remains vast (Puras, 2025). Petr Winkler provided a cautious example of progress, outlining how the Czech Republic has undertaken systemic reforms embedding human rights into psychiatric care, though challenges persist in implementation (Winkler, 2025). It is agreed that addressing the systemic vulnerabilities leading to abuses, medical torture and extrajudicial killings requires more than procedural reforms. Healthcare systems must be reconstructed on principles of strict transparency, due diligence, and external accountability. Every psychiatric intervention must be independently reviewable, open to audit, and subject to clear, enforceable legal standards. Honest professionals, ethical medical bodies, and judicial systems must coordinate to prevent and punish abuse without exception. Survivors’ testimonies must be central to reform. Denial of these realities only perpetuates harm. Recognizing and confronting these abuses directly is essential to building medical and legal systems that protect health, dignity, freedom, and fundamental human rights for all.

Table 5: Mechanisms of Abuse – Framing and diagnosis leading to psychiatric incarceration

Psychiatric Diagnosis Used	Legal Status of Detention	Explanatory Relevance	Framing Methods
Sluggish schizophrenia,	Involuntary civil	Indefinite detention via	Isolation, sleep deprivation,

paranoia	commitment	vague symptoms	induced confusion
Political mania, paranoia, delusional disorder	Administrative detention, extrajudicial internment	Bypassed judiciary, mass suppression	Harassment, defamation, staged accusations
Paranoia, delusional disorder, any excuse	Civil and forensic commitment	Silencing dissenters, profiting, threatening	Entrapment, covert intimidation
Schizophrenia, psychopathy	Court-ordered psychiatric examination	Protest repression, socioeconomic control	Hostile confinement, coercive interrogation
Non-specified psychotic disorders	Arbitrary administrative detention	Flexible repression tool	Deprivation of needs, induced agitation
Schizophrenia, sociopathy, bipolar disorder	Civil commitment, misuse of psychiatric testimony	Suppressing activism	Manipulated testimony, emotional framing
Schizophrenia, antisocial personality disorder	Involuntary commitment	Racial and social control	Profiling, criminalization of poverty behaviors
Paranoid psychosis, manic-depressive disorder	Arbitrary internment, punitive civil commitment	Political repression	Surveillance, rumor-spreading, social isolation

[Add beatings, threatening, spiking, family abuses, destabilization by any means. Point at same means in cases of domestic abuse, systemic violence, brutality from forces, all that drags and mask inflicted suffering as a disease, disorder, illness of the victims, on top of medical torture. Delve into structural violence and all excuses to keep on holding systems of care unable to work it out, heal.]

Although speakers came from diverse backgrounds and contexts, their presentations converged implicitly around the recognition that psychiatric abuses are not relics of the past but ongoing systemic violations. They underscored the urgency of confronting these abuses through legal, institutional, and cultural transformation, while highlighting that many victims today remain invisible, unprotected, and unheard.

The weaponization of psychiatry and the manipulation of media narratives operate symbiotically to maintain systemic oppression. Psychiatric institutions, when subordinated to political or social agendas, provide a veneer of medical legitimacy to acts of repression, framing resistance, trauma, or nonconformity as clinical disorders. Media outlets, whether through active propaganda or passive repetition of official narratives, sanitize these abuses, diffusing public outrage and transforming grave violations into mere episodes of private tragedy. This convergence facilitates the erasure of victims' political agency, decontextualizing their suffering and reinforcing hegemonic control. In environments where dissent is criminalized through medicalization, and where suffering is depoliticized through media framing, the possibilities for justice diminish radically. The challenge, therefore, lies not only in exposing individual abuses but in systematically dismantling the interlocking structures that allow psychiatric authority and mass communication to be deployed as tools of silencing, erasure, and social domination.

Ongoing cases, contemporary patterns and regional examples

The international legal framework explicitly prohibits the use of medical interventions to inflict pain, suffering, or coercive control. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT, 1984) directly criminalizes acts of torture, including those perpetrated under the guise of medical treatment. Furthermore, the Principles of Medical Ethics Relevant to the Protection of Prisoners and Detainees against Torture (adopted by the UN General Assembly in 1982) expressly forbid health professionals from participating in or condoning any form of torture or degrading treatment. The Rome Statute of the International Criminal Court (1998) recognizes torture as a crime against humanity, regardless of whether it occurs inside medical institutions.

Despite these robust legal standards, enforcement regarding psychiatric abuses has been alarmingly deficient. Medical torture laws are theoretically comprehensive but rarely applied to psychiatric settings. Several factors contribute to this impunity: the medicalization of harm cloaks abusive practices in clinical legitimacy; psychiatric patients are often deemed unreliable witnesses; and judicial systems are generally reluctant to intervene in medical affairs unless overwhelming evidence is presented. Furthermore, systemic biases continue to downplay coercion within psychiatry as merely a clinical necessity, rather than recognizing it as a potential act of torture. The regional examples presented at the symposium painted a sobering picture of psychiatric abuse's current global landscape.

In China, Yutong Zhang and Yanxi Mou provided complementary insights into the systematic use of psychiatric detention against political dissidents and minority groups. Zhang described a bureaucratic machinery that facilitates psychiatric abuse at both local and national levels, while Mou detailed the existence of clandestine detention centers operating outside any legal framework, where psychiatric justifications are retrofitted to disappear detainees (Zhang, 2025; Mou, 2025). Manuel Llorens's presentation on Venezuela revealed that psychiatric institutions are being used to enforce political loyalty and punish dissent. He recounted specific cases where activists were diagnosed with fictitious mental illnesses and confined without due process (Llorens, 2025). In the United Kingdom, Hel Spandler and Chris Munt independently reported that while overt political abuses are rare, systemic coercion remains endemic within mental healthcare. Patients, particularly from marginalized backgrounds, continue to experience involuntary commitment, forced medication, and the delegitimization of their narratives through psychiatric labeling (Spandler, 2025; Munt, 2025). Al Galves's analysis of the United States echoed these concerns. He argued that despite legal protections, psychiatric abuses persist through mechanisms such as outpatient commitment, guardianship laws, and the dominance of the biomedical model, which often overrides patient autonomy (Galves, 2025). In the Czech Republic, Petr Winkler presented a more hopeful picture. He described how systemic reforms have begun to reorient psychiatric care toward human rights and community integration, offering a model for other countries, although he cautioned that changing institutional cultures remains an ongoing challenge (Winkler, 2025). Finally, Edel Granda emphasized that psychiatric abuses intersect with other axes of oppression, such as gender identity. She noted that transgender individuals continue to be pathologized in many mental health systems, leading to denial of care, coercion, and social marginalization (Granda, 2025).

Taken together, these regional reports demonstrate that while the forms and intensity of psychiatric abuse vary, the underlying patterns of coercion, de-legitimization, and systemic violence remain pervasive across political systems and cultural contexts. The urgent need for reform is not limited to any single country or regime but is a truly global imperative. Given the overwhelming evidence from historical and contemporary abuses, it is clear that medical torture laws must be interpreted and enforced to include psychiatric abuses without delay. Non-consensual interventions performed without immediate life-threatening justification, prolonged and coercive hospitalizations, punitive uses of psychiatric confinement, and medical practices aimed at suppressing political, social, or personal dissent must be recognized not as mere clinical misjudgments, but as grave human rights violations. Applying medical torture statutes consistently would dismantle the protective shield of clinical language often used to sanitize abuse. It would also affirm the universality of human dignity and bodily autonomy, whether in prisons, interrogation rooms, hospitals, or psychiatric wards. This shift demands not only judicial courage but also structural reform in how psychiatry is monitored, regulated, and held publicly accountable.

Building sustainable and principled momentum for reform

The urgency and severity of the abuses documented throughout the symposium highlight the necessity of not merely identifying failures, but actively constructing sustainable, principled momentum toward the full reform of psychiatric, psychological, and broader mental health services. Acknowledging the profound historical and ongoing harm inflicted through coercive practices is a prerequisite for any genuine transformation. Equally critical is recognizing the unprecedented opportunity to rebuild systems grounded in science, ethics, dignity, and human rights, leaving behind the entrenched ideologies and defensive structures that have long shielded institutions from necessary accountability. The enforcement of internalized abusive laws often transcends formal state structures, becoming embedded in the practices of healthcare services, family members, and the broader community. Psychiatric systems, when weaponized, do not operate in isolation; they are supported and reinforced by social actors who absorb, normalize, and propagate the underlying ideologies of coercion. Families, under pressure or seeking control, may initiate involuntary psychiatric processes against dissenting members, framing personal conflicts as clinical crises. Entire communities, steeped in stigma and fear, readily accept the marginalization and silencing of individuals labeled mentally ill, conflating nonconformity with pathology. Healthcare services themselves, functioning under regulatory frameworks that legitimize coercive practices, internalize and routinize violations of autonomy as professional standards. This collective complicity transforms abuse into a moral imperative: actions such as forced hospitalization, overmedication, or guardianship stripping are perceived not as violations, but as socially sanctioned duties. Similarly, in corrupted environments, ordinary crime assumes the guise of moral enforcement. Acts of violence, deceit, and systemic destruction are perpetrated under the rationalization of protecting order, family, or national security. The body politic thus operates not merely through official decrees but through the diffuse internalization of oppressive premises, enabling entire populations to participate in, and sustain, the political abuse of psychiatry and other forms of institutional violence.

without critical reflection. Addressing this phenomenon requires dismantling not only abusive laws but the cultural and moral structures that legitimize their application at every social level.

Efforts to reform mental health care cannot be piecemeal, symbolic, or dependent solely on voluntary professional adaptation. Structural and cultural change must be driven by a coordinated strategy that addresses all levels of the system simultaneously. Entrenched actors - whether professional associations, political authorities, financial interests, or institutional bureaucracies - that resist transparency, accountability, or survivor leadership must be actively challenged and displaced from positions of influence. The tolerance of denial, minimization, or complicity with coercive practices can no longer be accepted under the guise of stability or tradition.

Education stands at the center of this transformative agenda. Immediate, mandatory retraining initiatives must be launched across all sectors of mental health services - from psychiatry and psychology to social work, nursing, and administrative leadership. Training programs must fully integrate human rights standards, trauma-informed methodologies, and critical analyses of past abuses. Curricula must be redeveloped to reflect the best available medical, psychological, and social science evidence, emphasizing voluntary, person-centered, interdisciplinary approaches to care. Crucially, this education must not remain theoretical but must be translated directly into clinical, administrative, and legislative practice.

Every psychiatric clinic, general hospital, mental health center, oversight body, and legislative framework must be reoriented to implement these principles. Institutions must embed binding protocols that ensure respect for autonomy, informed consent, dignity, and non-discrimination. Oversight mechanisms must be granted real power to enforce compliance and address violations swiftly and transparently. Legislation must codify rights protections not as optional standards but as enforceable guarantees, fully aligning domestic legal frameworks with international human rights obligations.

To ensure this translation into practice, interdisciplinary implementation teams - combining legal experts, human rights monitors, trauma specialists, survivor advocates, and medical professionals - must be deployed to guide reforms, audit institutions, and monitor compliance over time. The success of these efforts must be evaluated not by institutional self-reporting but by measurable outcomes: reductions in coercive interventions, increased voluntary engagement, survivor satisfaction, and documented improvements in community well-being.

The opportunity to build serious, effective momentum for psychiatric and psychological reform exists now. But it demands abandoning self-protective narratives, acknowledging the systemic nature of past and present harms, and committing to a future where mental health services protect, heal, and empower rather than control, silence, or destroy. The responsibility is collective, and the obligation is urgent: to restore mental health care to its rightful place - as a foundation for human dignity, social justice, and true healing.

Reform at the International Level

Strengthen and enforce international legal standards: States should fully implement the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and related treaties. In particular, governments must heed the CRPD Committee's call to ban all non-consensual psychiatric interventions and involuntary hospitalization. International human rights bodies (UN Special Rapporteurs on health, torture, and disability, the UN Human Rights Council and Universal Periodic Review, etc.) should systematically monitor mental health laws and practices, issuing binding recommendations. Global institutions like the World Health Organization should integrate human rights and trauma-informed care into their mental health guidelines, requiring UN member states to shift resources from coercive institutions to community-based supports. International funding mechanisms (WHO, World Bank, philanthropy) must prioritize alternatives to institutional care and psychosocial rehabilitation, as urged by former UN Rapporteur Dainius Puras.

Insulate mental health services from criminal and non-medical abuses: International cooperation is needed to expose and punish abuses such as organ trafficking and extrajudicial detention. For example, medical associations worldwide should demand the release of psychiatric prisoners (e.g. Falun Gong detainees) and denounce illicit organ procurement. Global psychiatric and transplant societies ought to refuse submissions and presentations from organizations that cannot demonstrate ethical sourcing of transplant organs. Diplomatic pressure and targeted sanctions (e.g. Magnitsky-style human rights sanctions) can deter regimes that misuse psychiatry for political ends. Coordinated action by United Nations agencies (OHCHR, WHO, OPCAT) and international NGOs must expose black jails and punitive psychiatric detention centers, and call for their abolition.

Global promotion of human-rights-based mental health: The UN and regional bodies should sponsor public campaigns and capacity-building to promote trauma-informed, person-centered care. A global panel of experts (including survivors and trauma specialists) could develop best-practice guidelines (on preventing re-traumatization, respecting autonomy, etc.), which countries would be expected to adopt. Education initiatives under UNESCO or WHO could train health, police and justice officials in survivors' rights. Finally, international networks of survivors and advocates (such as MindFreedom International) should be supported to share strategies and hold governments accountable.

Reform at the National Level

Legislative reform and enforcement: Each country must align its mental health and disability laws with human rights norms. This means repealing or tightly restricting involuntary commitment laws, abolishing coercive treatments (force medication, restraint, ECT without consent), and ensuring due process with effective legal representation. Governments should enact parity laws so that insurance/Medicare covers holistic care (housing, therapy, peer support) as well as medication. For instance, while Medicaid/Medicare in the U.S. pays for psychiatric drugs, it will not fund non-medical alternatives like Soteria houses. National policy must close such gaps: insurers and public health programs should cover community-based recovery services (residential supportive housing, peer-run respite centers) to prevent re-institutionalization.

Dedicated funding and resources: Budgets must shift from custodial hospitals to community supports. Governments should prioritize and fund a spectrum of psychosocial rehabilitation and recovery programs. This includes crisis outreach teams, supported employment, education and

housing initiatives. Victims must have rapid access to counseling, legal aid and compensation; funding for victim protection programs should be guaranteed. Transparency in spending is essential to deny misuse of resources by corrupt interests (for example, requiring public reporting of hospital bed occupancy and preventing profiteering from involuntary care).

Oversight and accountability: Establish independent national monitoring bodies (ombudsperson or inspectorates) to oversee all psychiatric and custodial facilities. Human rights commissions and parliaments should have the power to audit institutions, investigate complaints, and prosecute abuses. Professional licensing boards must sanction clinicians who violate patients' rights or collude with non-medical actors. Strict conflict-of-interest rules should bar psychiatrists from receiving undisclosed payments from pharmaceuticals, prisons, or security agencies. Law enforcement must have clear protocols to prevent police from using psychiatric detention for social control or evidence collection. Any deviation by staff (such as nepotistic confinement or unlawful experimentation) must carry criminal liability.

Education and training: Mandatory human-rights and trauma-informed training is needed for judges, police, healthcare workers, and community leaders. For example, curricula for medical, nursing and law courses should include the CRPD, survivors' perspectives, and the dangers of coercion. Public education campaigns can inform families and communities about the *dignity* and autonomy of persons with psychosocial disabilities, countering stigma. Ensuring services meet victims' needs also means providing culturally appropriate care: curricula should include transcultural psychiatry and diverse healing practices, so that indigenous, spiritual and minority groups receive respectful support.

Community safety nets and re-traumatization prevention: National guidelines should require that all victim support services be trauma-sensitive. For example, emergency shelters and clinics must avoid punitive environments (no locked wards or invasive security checks unless absolutely necessary). Safeguards against re-traumatization include no use of prone restraint or sensory deprivation, and routine screening for prior trauma so clinicians can adapt care. Rehabilitation programs should be voluntary and empowerment-focused; consent must always be sought (even for psychotherapy, support groups, etc.). Patient advocacy laws (such as advance directives or treatment agreements) can strengthen autonomy.

Reform at the Institutional Level

Rights-respecting clinical care: Hospitals and clinics must integrate human rights at every level of care. Treatment plans should be co-produced with patients, emphasizing *recovery, dignity and communication*. Institutions should implement open-door policies wherever safe, eliminate unnecessary locking of wards, and use restraint only as a last resort with strict oversight. Staff must conduct debriefing after any coercive intervention and offer immediate apologies and support to the individual. Multidisciplinary ethics committees (including legal experts and survivor representatives) should review contentious cases (e.g. capacity issues). Enforceable patient charters should be posted, detailing rights (to refuse treatment, to an independent advocate, to dignity, etc.) and providing confidential complaint channels.

Trauma-informed environment: Facilities should be designed and operated to minimize trauma triggers. This includes quiet spaces, privacy, and options (e.g. single rooms if requested). Staff should receive trauma-awareness training so that simple actions (a calm tone of voice, asking permission before touching) become routine. Every institution needs permanent peer-support workers or counsellors (people with lived experience) available to help victims navigate the system. Models like *Soteria houses* or peer-run crisis centers can be embedded in the health system as alternatives to hospitals - ensuring that voluntary, non-medical recovery options exist.

Staff selection and oversight: Screening and monitoring of personnel must weed out those who might exploit patients (any connections to criminal gangs, forced labor schemes, etc. should disqualify them). Ongoing human-rights auditing (possibly in partnership with NGOs) can quickly detect abuse patterns. Whistleblower protections and mandatory reporting rules will deter cover-ups. Institutions should use external reviewers for deaths or serious injuries in custody, ensuring families and human-rights groups can observe investigations. Violations must lead to swift disciplinary action or legal consequences, enforcing a culture of zero tolerance for human-rights abuse.

Services tailored to victims: Hospitals and care programs should be adapted to victims' specific needs. This means readily available translators, gender-sensitive care, and services for special populations (LGBTQ+, refugees, indigenous people). Psychosocial supports (occupational therapy, art/music therapy, peer groups) are integral - not optional extras. For example, trauma survivors often benefit from narrative therapy or community healing circles, rather than just medication. Implementing restorative justice options (apologies from institutions or compensation funds) can help victims reclaim dignity and trust.

Reform at the Community and Civil Society Level

Empower survivor and peer networks: Civil society must be at the forefront of reform. Governments should fund and partner with organizations run by people with lived experience (psychiatric survivors, families, activists) as equal stakeholders. Mutual-aid groups like the SHIELD MindFreedom network and the UK Paranoia Network (formed by survivors) demonstrate the power of peer support. Such groups can offer peer counseling, crisis respite homes, and advocacy training. Community grants should enable survivors to organize town halls and advise local health agencies on victims' needs.

Public education and stigma reduction: Grassroots campaigns can shift public attitudes about mental health and rights. For example, mental health first-aid training in schools and workplaces can emphasize listening and respect over medicalization. Public service messaging, in collaboration with media and influencers, should promote stories of recovery and neurodiversity, challenging notions of *madness* as shameful. Community leaders (faith groups, local councils) can host seminars on how to support victims and prevent abuse.

Watchdog and advocacy role: Independent NGOs and professional associations should monitor compliance at local levels. They can publish reports on human-rights conditions (as human-rights researchers in China and elsewhere have done) to alert the world to abuses. Civil society should use legal tools (strategic litigation, amicus briefs) to enforce rights - for instance, Czech activists

succeeded in halting forced ECT by appealing to legislators and invoking UN reports. Journalists and public watchdogs should be trained to identify and report coercive practices. Moreover, alliances between survivor groups, lawyers, and mental health professionals can lobby for meaningful reform (e.g. amendment of outdated laws).

Community-based healing and prevention: Local programs - such as anti-violence initiatives, substance abuse recovery groups, and cultural healing practices - can address the root causes of trauma and distress, reducing demand for coercive psychiatry. Civil society can establish trauma-competent community centers offering free counseling and social support. Partnerships with schools and youth organizations are key to early intervention: educators and parents should learn to recognize distress and engage supportive networks before crises escalate to psychiatric detention.

Reform at the Professional Level

Personalized, trauma-informed care: Each victim's experience is unique. Clinicians and counselors should conduct thorough assessments that include personal history of abuse. Therapeutic approaches must be empowering - for example, providing choices in treatment plans, encouraging patient goal-setting, and using non-triggering techniques. Victims should have access to professional trauma counseling, cognitive-behavioral therapy, or EMDR if appropriate, always on a voluntary basis. Service providers must actively avoid any practice that could re-traumatize (e.g. invasive procedures without consent, or humiliation).

Peer and self-help resources: Individuals benefit greatly from connecting with others who have had similar experiences. Support groups (in person or online) allow survivors to share coping strategies and find solidarity. Self-help resources - such as survivor-authored books, podcasts, and recovery workbooks - should be made widely available. Mentorship programs pairing veterans of the system with newer survivors can foster hope.

Holistic rehabilitation: True recovery involves rebuilding life skills and social ties. Victims should receive help with education, vocational training, and housing stability. Programs like supported employment or disability-inclusive microfinance empower independence. Creative therapies (art, drama, music) and wellness activities (yoga, meditation, nature retreats) can aid healing. By validating each person's dignity and capacity, providers reinforce that *sanity* encompasses far more than symptom checklists.

Legal and rights support: On an individual level, victims need clear information about their rights and remedies. All victims should be offered legal counsel to challenge unjust treatment or obtain reparations. Social workers or patient advocates must guide them through any appeals or complaints processes. Finally, respecting freedom means acknowledging survivors as experts in their own care - institutions should routinely solicit and implement survivor feedback on services.

Throughout all levels, enforcing human rights strictly must be non-negotiable. Any violator - whether a state actor, institution, or individual professional - must be held accountable under the law. By combining top-down legal protections with bottom-up community empowerment and person-centered services, the system can transform from one of coercion to one of healing, dignity and true recovery.

Discussion

The proceedings of this symposium presented unequivocal and urgent evidence: the political abuse of psychiatry remains a critical, global crisis. Independent expert contributions revealed that psychiatry today, far from being fully shielded by its medical nature, remains highly vulnerable to manipulation, particularly in environments **where incompetent authority replaces the sane state of mind and sound authority**. When lawful governance rooted in rationality, ethics, and human rights is supplanted by arbitrary rule, rule of men and state backed criminality, psychiatry is weaponized, becoming an instrument of oppression, repression, and silencing. Where robust institutional safeguards are absent, the vulnerability of mental health systems to abuse is not incidental -it is structural and predictable.

This permeable environment creates conditions in which abuses occur with alarming ease. Rogue states, corrupt actors, and criminalized systems exploit psychiatric institutions to eliminate dissent, punish the vulnerable, and silence the inconvenient, all under the deceptive pretense of medical care. As highlighted by David Matas, Yutong Zhang, Yanxi Mou, Manuel Llorens, and others, psychiatry, under these corrupt conditions, serves state terror, private vendettas, and criminal profiteering. This perversion is not an unintended anomaly; it is the direct result of allowing **incompetent authority to replace the sane state of mind and sound authority** that must underpin any legitimate exercise of power, especially where human vulnerability is concerned.

The urgency of reform cannot be overstated. As information shared during the symposium confirms, the **human and economic costs** of psychiatric abuses are vast. Victims endure profound psychological harm, social alienation, and chronic physical health deterioration, while societies bear immense costs in lost productivity, fractured communities, wrongful institutionalization expenses, and legal redress efforts. These costs are not inevitable. They stem from the deliberate failure to protect psychiatry's foundational mission: to heal, not to harm.

Most crucially, the symposium made clear that the **weaponization of psychiatry is sustaining systemic failure almost by design**. These are not accidents of practice but structural defects, exacerbated when mental health care systems are aligned more with social control than with healing. By diverting trauma, dissent, and vulnerability into silencing mechanisms rather than resolution pathways, failing or rogue systems maintain the illusion of order while exacerbating human suffering. Healthcare, rather than being a bulwark of collective well-being, becomes a tool of coercive governance, thereby entrenching dysfunction beneath a façade of medical legitimacy. Psychiatry thus risks becoming the most devastating betrayal: the betrayal of life, dignity, sanity, and hope under the false banner of care.

Speakers independently confirmed that abuses today are systemic, severe, and require urgent redress. The findings of the symposium call for immediate, coordinated action:

The findings and testimonies presented in this symposium confirm that addressing the political abuse of psychiatry demands not only institutional reforms, but a profound transformation in the way evidence is gathered, presented, and acted upon. This necessitates engaging multiple disciplines - law, human rights, medicine, psychology, sociology, political science, and ethics - to create a robust, interdisciplinary resistance to entrenched abuses. It also demands action-research

approaches rooted in rigor, survivor participation, and protection against the systemic reprisals that continue to deter transparency and reform.

At the **international level**, the recognition of political psychiatric abuse as an international crime must be accompanied by independent, interdisciplinary investigative bodies. Human rights experts, forensic psychiatrists, legal scholars, and survivor advocates must collaborate to rigorously document abuses across jurisdictions, ensuring that evidence is systematically collected, preserved, and publicized. The traditional barriers of fear, diplomatic inertia, and political compromise must be consciously dismantled. Only through fearless, independent reporting can abuses embedded within rogue states and failed systems be brought to the light of international accountability mechanisms. Action-research methodologies, grounded in survivor testimony and corroborated by forensic and legal analyses, are essential to avoid the sanitization or distortion of realities on the ground.

At the **national level**, legislation and policy must not only prohibit psychiatric coercion but foster environments where research into systemic abuses is protected and encouraged. National research councils, ombuds institutions, and independent commissions must actively support interdisciplinary investigations into psychiatric practices, without political or corporate interference. Protection of researchers, whistleblowers, and survivors must be codified in law, recognizing that fear, dismissal, and denial - often fueled by vested interests in the healthcare, pharmaceutical, security, and political sectors - have historically silenced critical inquiry. Nations must ensure that confronting psychiatric abuses is not treated as destabilizing but as strengthening the social and legal order.

Addressing these realities demands an uncompromising commitment to human rights enforcement at every level. Academic institutions must incorporate critical psychiatric studies, survivor-led research, and human rights law into mental health training programs. The system would also benefit from the approaches and interventions laid down in next paragraphs, as presented in the paper:

At the **institutional level**, psychiatric facilities and health systems must open themselves to external, interdisciplinary auditing. Routine human rights impact assessments, conducted by independent teams combining medical, legal, social science, and survivor expertise, must become mandatory. Institutions must be held accountable for retaliation against whistleblowers and survivors who expose abuses. Internal ethics committees must be reconstituted to include external human rights monitors, ensuring that reprisals, denial, and corruption are neither normalized nor concealed. The dominant cultures of self-protection and reputational defense must be replaced by a culture of truth-telling, ethical transparency, and patient-centered reform. At the **community and civil society level**, grassroots organizations, survivor networks, and interdisciplinary academic groups must collaborate to produce and disseminate evidence-based narratives that counter the dominant myths supporting psychiatric coercion. Community-based action-research initiatives must document abuses, capture survivor histories, and monitor local services, creating alternative archives of truth accessible to courts, media, and the public. Civil society must also advocate for legal protections ensuring that survivors, researchers, and advocates can speak out without fear of defamation suits, professional retaliation, or unlawful surveillance. Breaking the cycle of social dismissal and denial demands making psychiatric abuses visible not as isolated anomalies, but as systemic failures requiring systemic remedies. At the **individual level**, every survivor and citizen

must have access to mechanisms that support the ethical gathering and sharing of experiences without re-traumatization or retribution. Empowering individuals to participate in action-research projects, legal advocacy, and policy reform initiatives strengthens both the evidentiary base and the democratic legitimacy of psychiatric reform. Trauma-informed approaches must guide the documentation process, respecting the autonomy, dignity, and safety of those whose testimonies form the foundation of change. Encouraging survivor-led research centers and participatory legal projects ensures that those most affected are not merely subjects of study but protagonists in redefining the future of mental health care.

Ultimately, the transformation required is both technical and cultural. Interdisciplinary engagement must not be perfunctory; it must seek to dissolve disciplinary silos that have enabled psychiatric abuses to remain insulated from legal scrutiny, human rights accountability, and social science critique. Action-research must be fearless, ethically rigorous, and politically conscious, recognizing that psychiatry's entanglement with systems of repression cannot be dismantled without exposing the networks of power and interest that sustain it. True change requires recognizing that psychiatric abuse is not merely a professional failure but a profound social and moral crime - one that undermines public trust, damages countless lives, and perpetuates systemic injustice under a false banner of healing.

Breaking this cycle demands more than reforms: it requires courage, interdisciplinary solidarity, and the unwavering insistence that human dignity, freedom, and sanity are not negotiable. Only by fortifying research, amplifying survivor leadership, and protecting truth-telling against the reprisals of vested interests can societies reclaim psychiatry as a genuine instrument of healing rather than a tool of fear and domination. Across all levels, the principles must be uncompromising: do no harm, eradicate coercion, deny criminal misuse, enforce all human rights strictly, and uphold the primacy of human dignity, freedom, and life. Psychiatry must not drift into being an accomplice to repression. It must actively become a guardian of humanity's highest ethical commitments.

The symposium reaffirmed that change is not only necessary but possible. Cases like Mikhail Kosenko's release (van Voren, 2016) illustrate that international attention, legal pressure, and ethical solidarity can disrupt even the most entrenched abuses. But vigilance must be relentless. Systems left to rot in silence and impunity will inevitably continue to betray the vulnerable.

Table 6: Reclaiming Healing in Psychiatric Care

Reform Principle	Key Measures
Codify Healing and Autonomy as the Sole Legitimate Purposes of Medical Systems	Rebuild legal and ethical foundations around healing, autonomy, dignity. Deviation becomes unlawful.
Criminalize Non-Therapeutic Medical Interventions	Punish non-therapeutic acts like forced medication or diagnosis without urgent clinical need.
Total Prohibition of Coercive and Punitive Practices within Healthcare	Eliminate coercion unless tightly defined emergency; align with CRPD obligations.
Separate Medical Support from Social Order Enforcement	Remove medicine from roles of social discipline, control, or ideological enforcement.
Invest Primarily in Prevention, Education, and Community Resources	Prioritize housing, nutrition, voluntary care, and health literacy over institutional reaction.

Decentralize and Democratize Oversight	Establish oversight with survivors, legal and community representatives with real sanctioning power.
Reeducate Medical Professionals Around Human Rights	Integrate human rights law and abuse history into medical education. Train to resist complicity.
Protect Whistleblowers and Dissenters Within Healthcare	Legally protect ethical dissenters and whistleblowers in healthcare systems.
Guarantee Full Access to Justice and Reparations for Survivors	Ensure complaint mechanisms, redress, and public recognition of abuses and survivors' rights.
Maintain Permanent Global Surveillance Against Abuses	Create global observatory to monitor violations and ensure binding public reporting.

Protecting mental health systems from political and criminal abuse is not ancillary to justice - it is central. If psychiatry becomes again a tool of oppression, society itself descends into normalized cruelty masked by pseudoscience. Healing psychiatry requires nothing less than restoring it to its ethical, humanitarian, and rational foundations: to protect life, to foster recovery, to uphold freedom, and to enshrine dignity. Without urgent and principled action, we risk perpetuating a system where incompetent authority, masked as medical judgment, erodes the very sanity and freedom it was meant to preserve. To prevent this, psychiatry must be reclaimed - not merely reformed - as an instrument of hope, truth, and collective healing.

Medicine must return to its only rightful foundation: healing and protecting life. Safeguarding the integrity of mental health care is more than a professional duty. It is a moral imperative grounded in the universal principles of human rights. It is a testament to our shared humanity. Without this vigilance and collective commitment, healing cannot truly begin - and dignity cannot truly be restored. With it, however, psychiatry can fulfill its highest promise: not as a tool of domination, but as a sanctuary for healing, understanding, and hope. Any other purpose, be it control, punishment, profiteering, silencing, is a perversion of its meaning and a betrayal of humanity itself. This is not a call for mere reform, but for a complete reassertion of medicine's original, moral purpose. Psychiatric and medical abuses cannot be addressed by improving policies alone; they must be rooted out by re-centering health systems on truth, autonomy, and dignity. We must honor the victims, whose lives were silenced, disfigured, and destroyed by systems that claimed to heal. Learn, from past and present mistakes to effectively deny any opportunity for these crimes against humanity repeating once more. Their pain must not be abstracted. It must be remembered as the living cost of institutional betrayal. We must also protect those who speak on their behalf: researchers, journalists, legal advocates, clinicians, and families who face intimidation, ostracism, and retaliation for uncovering the truth. The same goes for informants within closed institutions, and the communities caught between fear, coercion, and complicity, too often driven to enforce atrocities among themselves, out of anguish, fear, or opportunistic cruelty. They too deserve protection, and they too require systems that do not abandon or exploit their position.

This is the core of what must change: not just policies, but structures -oversight with real power, education rooted in human rights, legal accountability with teeth. Not symbolic ethics, but mechanisms of prevention, exposure, and repair that cannot be silenced. It requires unwavering

courage, clarity of intent, and structural transformation across education, practice, law, and governance. A healing profession that fails to protect the living right to flourish is no longer a profession. These ten pillars lay the groundwork.

The will to act, now, to redress this problem and uphold sanity, is the measure of our civilization.

Conclusion

The symposium laid bare a stark reality: the political abuse of psychiatry persists today as an entrenched and systemic phenomenon, deeply intertwined with rogue governance, failed healthcare systems, and criminal misuse of medical authority. Where incompetent authority replaces the sane state of mind and sound ethical governance, psychiatry ceases to serve its healing purpose and becomes an instrument of repression, silencing, and destruction. The profound human and economic costs - borne by survivors, communities, and societies at large - reveal the devastating consequences of allowing mental health systems to be weaponized. These abuses are not incidental; they are the predictable outcome of systemic failures that prioritize control over care, coercion over communication, and impunity over justice. Urgent, coordinated, and uncompromising action is required at every level: international, national, institutional, community, and individual. Psychiatry must be reclaimed from corruption and restored to its rightful role as a guardian of healing, dignity, and freedom. Protecting mental health systems from political and criminal abuse is not a technical reform - it is a profound moral imperative, central to the defense of human rights and the preservation of sanity itself. Only by dismantling the structures of coercion, enforcing strict human rights protections, empowering survivors, and rebuilding care on the foundations of respect, voluntariness, and solidarity, can psychiatry fulfill its highest ethical promise: to heal, to protect, and to uphold the inviolable dignity of every human being.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest. All analyses, interpretations, and conclusions were developed independently and without influence from any external institution, organization, or funding body beyond the formally acknowledged support listed below. No private, governmental, or corporate entities have influenced the design, execution, or reporting of the symposium or its resulting documentation.

Funding and Ethical Approvals: This work has been supported by funding from the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities under Project Codes FPU19/00028 and PID2023-148482NB-I00. Additional support for the symposium event and associated dissemination activities was provided under the framework of the COST Action CA19133 FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services), specifically through a Short-Term Scientific Mission (STSM) supporting the presentation of results at the World Psychiatric Association Congress in Vienna, 2023. Due to organizational constraints, part of the symposium's activities were independently structured to ensure full freedom of expression and scientific integrity. Ethical approval for all associated research activities was granted by the Research Ethics Committee on People, Society and the Environment (CEIPSA) at the Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Spain. The specific ethical clearance codes governing this work

are CEIPSA-2024-PRD-0029 and CEIPSA-2022-TDO-0023. All research and dissemination activities fully complied with national and international ethical standards for the protection of human rights, dignity, and the integrity of academic inquiry.

References

- Choudhary, L. (2013). Political abuse of psychiatry: A global perspective. *International Journal of Culture and Mental Health*, 6(2), 111–125. <https://doi.org/10.1080/17542863.2012.721522>
- Di Maio, P. (2025). Psychological coercion and systems dynamics in mental health services [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Edwards-Grossi, M. (2024). Re-examining psychiatry and dissent: A historical and contemporary analysis. *History of Psychiatry*, 35(1), 112–127. <https://doi.org/10.1177/0957154X231185274>
- Edwards-Grossi, È., & Willoughby, C. D. E. (2024). Slavery and its afterlives in US psychiatry. *American Journal of Public Health*, 114(S3), S250–S257. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2023.307554>
- Foucault, M. (2006). *Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason* (R. Howard, Trans.). Routledge. (Original work published 1961)
- Galves, A. (2025). The dire situation of the U.S. mental healthcare system and ways to improve [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Granda, E. (2025). Transgender rights and psychiatric pathologization [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Groot, P. (2025). Tapering strips and psychiatric drug withdrawal: Restoring autonomy [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Halliburton, M. (2025). The need for transcultural psychiatry to counterbalance the dominant model [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence-from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Human Rights Watch. (2005, November 2). China: Political prisoner exposes brutality in police-run mental hospital. <https://www.hrw.org/news/2005/11/02/china-political-prisoner-exposes-brutality-police-run-mental-hospital>

Human Rights Watch. (2010, January 20). Torture and cruel treatment in health settings: Fact sheet. <https://www.hrw.org/news/2010/01/20/torture-and-cruel-treatment-health-settings>

Laing, R. D. (1960). *The divided self: An existential study in sanity and madness*. Penguin Books.

Llorens, M. (2025). Collapse of the Venezuelan health system and psychiatric repression [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Losa, L., & Morell, X. (2025). Severe abuses in Spanish mental healthcare and guardianship systems [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Matas, D. (2025). Madness of China's organ extraction from living dissidents and ethnic minorities [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Metzl, J. M. (2010). *The protest psychosis: How schizophrenia became a Black disease*. Beacon Press.

Mou, Y. (2022, August 16). Mental torture: China is locking up critics in psychiatric facilities. *Safeguard Defenders*. <https://safeguarddefenders.com/en/blog/mental-torture-china-locking-critics-psychiatric-facilities>

Mou, Y. (2025). Abuses in China's black prisons and extrajudicial psychiatric detention centers [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Munt, C. (2025). Systemic violence against psychiatric patients in the UK [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Narayan, C. L. (2013). Political abuse of psychiatry. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(1), 96. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.105529>

Okasha, A. (2004). On the China issue. *World Psychiatry*, 3(3), 129.

Peoples Gazette. (2025, February 20). Dozens of dissenters held as psychiatric patients in Russia: Lawyers. *Peoples Gazette*. <https://gazettengr.com/dozens-of-dissenters-held-as-psychiatric-patients-in-russia-lawyers/>

Puras, D. (2025). Human rights and mental health: Perspective of a former UN Rapporteur [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Reuters. (2025, April 15). Russian court commits U.S. citizen for mental treatment. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/russian-court-commits-us-citizen-mental-treatment-2025-04-15/>

Safeguard Defenders. (2022). *Locked up: Punitive psychiatry in China*. <https://safeguarddefenders.com>

- Scheff, T. J. (1966). *Being mentally ill: A sociological theory*. Aldine.
- Smith, A., van Voren, R., & Liebrezn, M. (2024). Resurgent trends in punitive psychiatry in the Russian Federation. *The Lancet Regional Health – Europe*, 42, 100935. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100935>
- Smith, S. (2025). Mutual aid networks against psychiatric abuses: SHIELD MindFreedom [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Spandler, H. (2025). Critical insights into the UK mental health system [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.
- Szasz, T. (1961). *The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct*. Harper & Row.
- The Lancet Psychiatry. (2025, May). Setting the research agenda for mental health. *The Lancet Psychiatry*, 12(5), 321. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(25\)00121-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(25)00121-7)
- The Washington Post. (2022, August 19). How China weaponizes psychiatry against dissent. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/19/china-psychiatry-mental-health-hospitals-punishment/>
- Trickey, L. (2025, April 24). UN experts alarmed by reports of psychiatric treatment as punishment for political dissent in Belarus. *University of Oxford Faculty of Law*. <https://www.law.ox.ac.uk/news/2025-04-24-un-experts-alarmed-reports-psychiatric-treatment-political-dissent-belarus>
- United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2014). General comment No. 1: Article 12-Equal recognition before the law (CRPD/C/GC/1). <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no1-2014-article-12-equal-recognition>
- van Voren, R. (2009). Political abuse of psychiatry: An historical overview. *Schizophrenia Bulletin*, 36(1), 33–35. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbp119>
- van Voren, R. (2016). Ending political abuse of psychiatry: Where we are at and what needs to be done. *BJPsych Bulletin*, 40(1), 30–33. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.114.049494>
- Whitaker, R. (2002). *Mad in America: Bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment of the mentally ill*. Basic Books.
- Winkler, P. (2025). Safeguarding human rights in Czech psychiatry [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

Zhang, Y. (2025). Psychiatric abuses in the People's Republic of China [https://www.youtube.com/@medicalanthropology/featured]. International Symposium on the Political Abuse of Psychiatry.

World Psychiatric Association. (2025, February 6). WPA experts condemn the misuse of psychiatry in Iran. *World Psychiatric Association*. <https://www.wpanet.org/post/wpa-experts-condemn-the-misuse-of-psychiatry-in-iran>

Annex H - Dissertation policy advice summary

The policy executive summary presented in Annex H, do to its multimedia nature, is available through the dissertation's online repository, where it can be accessed as part of the public dissemination and translational impact strategy. This repository hosts the structured reform proposals, legal and clinical recommendations, and implementation pathways derived from the doctoral research, ensuring transparency, accessibility, and practical utility for policymakers, professionals, and civil society actors. Annex H functions as a translational synthesis of the dissertation's scientific evidence into structured, actionable guidance for institutional reform. It is designed not as a secondary addition, but as a core component of the research's impact agenda, bridging the gap between empirical documentation and policy implementation. Within the logic of the dissertation, which integrates biocultural analysis, action-research, and institutional diagnostics, this annex embodies the normative and operational corollaries of the work. It responds to the urgency, repeatedly demonstrated throughout the main chapters, for legally binding and structurally embedded mechanisms to prevent psychiatric violence and guarantee autonomy in care.

The annex distills the dissertation's extensive findings, derived from participant observation, national and international surveys, legal analysis, and transdisciplinary synthesis, into a coherent reform roadmap. It articulates the priority areas for legislative, clinical, and educational intervention, grounded in the central hypothesis that coercion is neither inevitable nor therapeutically justified, but rather a systemic failure perpetuated by outdated legal norms, epistemic asymmetries, and professional inertia. The policy summary proposes concrete shifts toward shared decision-making, autonomous medication management, open data infrastructures, and the deployment of dialogical care models within the public health framework, including Open Dialogue, trauma-informed pedagogy, and participatory oversight systems.

The structure and content of Annex H correspond directly to the operative research questions and translational objectives set forth in the introduction and methodological chapters. It draws from the empirical findings of Chapters 3 and 4, which identify patterns of diagnostic imposition, overmedication, and institutional betrayal, and from the analytical and normative synthesis of Chapters 5 and 6, which diagnose the regulatory and ethical dysfunctions of current psychiatric governance. The recommendations presented in Annex H are aligned with international legal standards, including those articulated in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the WHO QualityRights framework, and European human rights jurisprudence. It also draws on transdisciplinary evidence from neuroscience, medical anthropology, legal theory, and systems science to ensure feasibility and coherence. Annex H also lays the groundwork for the implementation phase envisioned in Chapter 7, particularly through the EU BEACON One Health Education initiative. It establishes the logical architecture through which reforms can be scaled across educational, legal, and clinical systems. It outlines regulatory benchmarks, participatory mechanisms, and accountability protocols that translate the thesis's findings into enforceable structures. Rather than offering idealistic aspirations, the annex provides a modular and evidence-backed reform agenda oriented toward real-world deployment, adaptive governance, and continuous feedback monitoring.

Annex I - Media dissemination kit

Annex I, containing the media dissemination kit, is made available exclusively through the dissertation's online repository due to its multimedia nature. This annex includes visual materials, communication templates, explanatory videos, and open-access outreach tools designed to support broad public engagement with the dissertation's findings. It forms part of the translational strategy to facilitate awareness, policy uptake, and cross-sectoral dialogue by rendering complex scientific content accessible and actionable across diverse audiences.

Annex J Horizon proposals

The four Horizon Europe proposals now under development under the EU BEACON One Health Education COST action, as part of the action-research of this dissertation, directly extend and operationalize the theoretical, empirical, and normative foundations of the dissertation, transforming its claims into applied, scalable interventions across educational, clinical, and policy domains. Each project embodies a structural response to the core proposition that psychiatric systems must move beyond coercive and overmedicalized practices, not merely through protocol revision or professional training, but through a comprehensive reconfiguration of the socio-institutional architectures that sustain exclusion, diagnostic reductionism, and epistemic asymmetry. The first proposal, focused on fostering brain health in school settings, aligns with the thesis's assertion that mental health must be understood bioculturally and developed preventively through dynamic interactions between metabolic regulation, neurodevelopment, and social participation. By implementing structured routines in exercise, sleep hygiene, nutritional supplementation, especially Omega-3 regulation, and social bonding, this project targets the physiological substrates of cognitive and emotional regulation within equitable educational contexts. It reflects the dissertation's emphasis on early, non-stigmatizing, non-pharmacological interventions and on biosignal-informed feedback systems that enable continuous assessment of therapeutic efficacy. It thereby exemplifies the thesis's call for scientifically grounded, real-time recalibration of care that respects bodily and legal integrity from the earliest stages of psychosocial development.

The second proposal, addressing the cognitive impact of pollutants, provides empirical substantiation for the thesis's critique of psychiatry's neglect of environmental determinants of distress. By mapping and mitigating the neurotoxic effects of contaminated air, soil, water, and food chains in school-age populations, the project embeds mental health within ecological public health and environmental justice frameworks, bridging disciplines that the dissertation holds to be unjustly separated. The project's integration of biomonitoring, neurodevelopmental testing, and community-level intervention design mirrors the thesis's insistence that psychiatric symptoms often emerge from chronic systemic exposures which are pathologized rather than addressed. By generating real-time dashboards linking exposure to cognitive function, and by embedding environmental data in institutional decision-making, the project enacts the thesis's vision of a participatory, feedback-informed governance model, rooted in the ethical imperative to prevent harm through structural accountability. It concretizes the dissertation's legal and institutional recommendations, demonstrating how regulatory inertia can be challenged through multisectoral coordination and scientifically verifiable risk mitigation strategies.

The third proposal, centered on shared decision-making in child and adolescent mental health, directly implements the dissertation's core theoretical proposition: that coercion is structurally produced through the systematic exclusion of individuals from decisions affecting their own care, and that recovery requires dialogically anchored, procedurally accountable systems that respect autonomy, narrative identity, and relational integrity. This project institutionalizes SDM as a foundational practice across school-based mental health systems, translating the dissertation's conceptual framework into practical methodologies for co-produced care. By embedding SDM

tools, trauma-informed protocols, and culturally sensitive engagement mechanisms within naturalistic settings, rather than isolating them in clinical silos, the project validates the thesis's argument that ethical and effective mental health care must be situated within the everyday contexts where distress emerges and where trust can be rebuilt. Moreover, it reinforces the dissertation's operational commitment to participatory regulatory design by creating traceable decision processes, consent frameworks, and transparent digital tools that empower youth and families while ensuring institutional compliance with rights-based standards. The project's focus on legal coherence, feedback-driven improvement, and open science infrastructures serves as a direct implementation of the dissertation's proposed systemic reforms.

The fourth proposal, developing internal mentorship and service-learning networks within schools, activates the thesis's vision of recovery as a socially distributed, relational process that must be structurally enabled by institutions committed to dignity, restoration, and reciprocal accountability. This project frames educational institutions not only as sites of learning but as microcosms of civic engagement and relational healing, where trauma can be addressed not through external surveillance or behaviorist discipline, but through embedded, peer-anchored systems of trust and care. It operationalizes the dissertation's critique of clinical cultures that suppress voice and exclude survivors from the architecture of care, by creating structured pathways for safe disclosure, narrative reconstruction, and collective response to harm. Through reflexive mentoring systems, continuous professional development, and survivor-informed policy co-design, the project models the dissertation's call for institutional transformation through dialogical scaffolding and transparent governance. It enacts the procedural ethics advanced in the thesis, where institutional maturity is defined not by control over pathology but by the capacity to host feedback, correct injustice, and evolve through relationships.

Together, these four proposals form a coherent translational matrix that directly advances the dissertation's multi-level aims: the prevention of psychiatric harm through structural and environmental interventions; the reconstruction of clinical and educational systems around shared decision-making and narrative agency; and the creation of participatory infrastructures for ethical governance, continuous improvement, and open verification. Each project embodies the thesis's epistemological stance that mental health is not reducible to individual pathology but is a relational, regulatory, and socially mediated phenomenon that requires institutional designs capable of procedural reflexivity and systemic repair. Through the operationalization of the dissertation's theoretical insights and empirical findings, these proposals not only affirm the scientific validity of its claims but also activate its transformative intent, moving psychiatry, education, and public health toward a new paradigm in which recovery is the structural default, not the exception.

1. Fostering Brain Health in School Settings

Summary of Benefits

This proposal seeks to establish a transdisciplinary, school-anchored health promotion model that integrates physical exercise, rest routines, nutrition (including Omega-3 intake and metabolic balance), and social engagement into measurable programs aimed at enhancing neurocognitive

performance, emotional regulation, and long-term educational attainment. The intervention emphasizes neuroplasticity in development, equity in school environments, and the prevention of burnout, anxiety, and learning disorders from a public health perspective.

Required Actors

- Schools and education ministries (policy integration, implementation)
- Pediatric neurologists, nutritionists, sleep researchers (clinical design, baseline assessments)
- Neuroscientists and developmental psychologists (design of neurocognitive metrics and resilience indicators)
- Public health institutions and One Health experts (coordination of multisectoral impact)
- Local and national sports and youth organizations (delivery and social anchoring)
- Food science researchers and metabolic health labs (dietary interventions, Omega-3 monitoring)
- Data scientists and digital tool developers (tracking tools, gamified compliance, real-time feedback)
- Youth representatives and families (participatory co-design)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 5,000–10,000 children aged 6–16 across rural and urban European school systems
- Design: Multisite, longitudinal cluster-randomized controlled trial (CRCT) with at least 3 arms:
 - Full intervention (exercise + sleep + nutrition + social engagement)
 - Partial intervention (exercise + sleep or nutrition only)
 - Control group (standard school practices)
- Duration: 4+ years with annual follow-ups and continuous monitoring
- Novelty:
 - Integrates metabolic profiling (especially Omega-3 index) and cognitive baselining in a school setting
 - Applies sleep science to optimize school start times and activity schedules
 - Uses digital tools and citizen science to ensure participatory feedback and adaptivity
 - Bridges health and learning outcomes into one comprehensive intervention model

Expected Impact

- Establishes a model for systemic health education policy, promoting health as foundational to cognitive success
- Mitigates health inequities and supports inclusion by targeting underserved schools and vulnerable populations
- Reduces future burden of mental illness, attention disorders, and lifestyle-related diseases
- Aligns with SDGs 3, 4, and 10, strengthening One Health literacy and prevention across generations
- Provides scalable, evidence-based protocols for EU-wide education and health ministries

2. Pollutants and Brain Health: Cleaner Air, Soil, Water and Food Chains

Summary of Benefits

This proposal addresses the underrecognized but critical link between environmental toxicity and neurodevelopmental decline in children. By focusing on pollutants affecting air, water, soil, and food chains, the project seeks to safeguard cognitive performance, behavior, and mental health outcomes through an integrated environmental justice approach. It connects ecological exposures with measurable brain health outcomes and builds regulatory and community strategies for mitigation.

Required Actors

- Environmental toxicologists and neuroepidemiologists (biomonitoring design and neurotoxic risk profiling)
- Schools, municipalities, and public health departments (exposure mitigation, public engagement)
- Environmental justice advocates and NGOs (community anchoring, participatory processes)
- Food safety and water quality agencies (surveillance and intervention on contaminants)
- Veterinary and One Health professionals (cross-species biomonitoring and sentinel analysis)
- Legal scholars and regulatory experts (policy translation and threshold enforcement)
- ICT experts and citizen science platforms (data collection, local reporting, and transparency)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 6,000–12,000 children in 5–10 European regions with variable pollution profiles
- Design:
 - Quasi-experimental prospective cohort with nested intervention groups

- Cross-sectional biomonitoring of neurotoxicants (e.g., heavy metals, pesticides, PFAS)
- Annual neurocognitive testing, inflammation markers, and psychosocial metrics
- Duration: 5 years minimum, with environmental sampling and child-level monitoring every 12 months
- Novelty:
 - Merges environmental biosurveillance with school-based neurocognitive assessments
 - Introduces real-time pollution-to-cognition dashboards for policy use
 - Tests protective community-level interventions (e.g., air filters, schoolyard rewilding, dietary shielding)
 - First EU-scale application of One Health neurotoxic risk mitigation in school populations

Expected Impact

- Empowers schools and communities to act as sentinels of environmental and brain health
- Enables science-based regulation of environmental pollutants with direct cognitive health endpoints
- Mitigates the neurodevelopmental impact of pollution in vulnerable child populations
- Strengthens intersectoral policy design between health, education, and environment
- Advances SDGs 3, 4, 13, and 10, through early prevention and pollution accountability
- Provides a replicable framework for EU regulatory reform and community-based environmental action

3. Shared Decision-Making Mental Health for Children

Summary of Benefits

This project establishes a European model for shared decision-making (SDM) in child and adolescent mental health, integrated within educational and social systems. It aims to reverse coercive, fragmented mental health interventions by embedding trust-based, culturally responsive, and evidence-driven care models in schools and local services. The benefits include better outcomes in emotional wellbeing, reduced psychiatric labeling, enhanced autonomy, and stronger support for teachers and families navigating distress in youth.

Required Actors

- Child psychiatrists, psychologists, and SDM specialists (design and implementation of decision-making frameworks)

- Educational institutions and ministries (integration into school health protocols)
- Youth and parent advocacy groups (lived experience input, evaluation of relevance and trust)
- Anthropologists and medical sociologists (analysis of context, bias, and systems)
- Social workers and family support services (engagement in care plans)
- Digital platform developers (ethical, secure, user-friendly SDM tools)
- Health economists and evaluators (cost-effectiveness, outcome tracking)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 3,000–6,000 children and adolescents experiencing early signs of mental distress, along with families and school personnel
- Design:
 - Longitudinal intervention-control study across 6–8 countries
 - Co-creation and iterative refinement of SDM tools and relational frameworks
 - Measurement of psychiatric outcomes, school attendance, trust in services, emotional self-regulation
- Duration: 4 years with follow-up at 6, 12, 24, and 36 months
- Novelty:
 - First large-scale EU project to operationalize SDM for minors in mental health through schools
 - Replaces risk-based, exclusionary models with narrative-based, trauma-informed relational support
 - Embedded in naturalistic school and community settings, not clinical-only settings
 - Explicitly rights-based and aligned with UN CRC and WHO guidance on non-coercive care

Expected Impact

- A validated framework for SDM in youth mental health, adaptable across contexts
- Reduction in overdiagnosis, overmedication, and harmful institutionalization
- Empowerment of schools, families, and children as primary agents in early mental health support
- Improves trust in services and reduces dropout from care or education
- Supports SDG 3, 4, and 5, linking health, education, and gender equality

- Contributes to EU guidelines for non-coercive child mental health intervention design and evaluation

4. Service-Learning and Internal Mentorship Programs

Summary of Benefits

This project aims to institutionalize service-learning and internal mentorship systems in schools to counteract growing social isolation, despair, and mistrust in educational environments. By fostering peer mentoring, relational learning, and survivor-safe disclosure channels, schools become environments of care, restoration, and participatory problem-solving. It redefines the school not just as a knowledge site but as a resilient social institution with the power to prevent harm, promote health, and mediate conflicts.

Required Actors

- School leadership teams and teacher unions (implementation and sustainability)
- Peer mentoring experts and youth counselors (training frameworks and supervision systems)
- Trauma-informed educators and restorative justice professionals (handling of disclosures and harm repair)
- Civic educators and psychologists (design of meaningful contribution pathways)
- Policy-makers in education and justice (translation into national guidelines)
- Children's rights and gender equality experts (intersectional structuring of mentorship roles)

Longitudinal Experimental Design and Novelty

- Population: 5,000–8,000 students across 30–40 schools in varied socioeconomic and cultural settings
- Design:
 - Implementation study using a stepped-wedge randomized rollout model
 - Structured mentorship systems with roles assigned and trained within each institution
 - Evaluation through mixed methods: school climate surveys, dropout and absenteeism data, mentorship feedback loops
- Duration: 3–4 years, with monthly reflections and annual thematic reviews
- Novelty:
 - Anchors internal responsibility structures within the school community rather than relying on external programs

- Integrates relational pedagogy with institutional repair functions (e.g., spaces to report abuse, heal division)
- Frames mentorship as both civic duty and psychological protection, supporting EU restorative principles
- Generates real-time dialogues on harm, prevention, and belonging from within the school ecosystem

Expected Impact

- Creates trusted internal mechanisms for navigating hardship and healing conflict in schools
- Reduces bullying, exclusion, and systemic silence on harm
- Builds interpersonal resilience and institutional maturity through participation
- Transforms schools into safe, responsive micro-communities capable of emotional and civic learning
- Contributes to SDG 4, 5, and 16, by promoting peace, inclusion, equality, and participatory governance
- Offers a blueprint for education-led violence prevention and youth engagement policy across Europe

Annex J Ethics approval

The following section provides documentation of the ethics approval granted for the research conducted in this dissertation.

Títol del projecte d'R+D+I:

Repensar lo social en salud mental: mapeo y análisis de las iniciativas productoras de autonomía en España

Investigador/a principal:

Ángel Martínez Hernández – Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre

Comitè ètic de recerca:

Comitè Ètic d'Investigació en Persones, Societat i Medi Ambient (CEIPSA)

Entitat:

Universitat Rovira i Virgili

Sessió:

CEIPSA2/2025, de 28/02/2025

Número d'autorització:

CEIPSA-2024-PR-0029

Una vegada revisada i validada la informació aportada, l'expedient de referència CEIPSA-2022-TDO-0023 no ha de superar el procés d'avaluació addicional.

Annex L - Additional tables and figures

Table 1- Historical approaches to mental and emotional states, by culture and region

Period / Region	Approach to Mental States	Practices & Substances	Interpretive Setting
Ancient Greece	Dream incubation; melancholia as philosophical temperament	Olive oil, wine, mandrake, poppy; communal sleep spaces	Temples, oracles, symposiums
Classical China	Qi imbalance treated via herbs, acupuncture, moral cultivation	Ginseng, tea, fasting, ancestor veneration	Confucian and Taoist circles
Medieval Islamic World	Prophetic dreams; spiritual melancholy	Saffron, ambergris, music, Qur'anic recitations	Hospitals, mosques, theological academies
Andean Cultures	Ritual singing, coca leaves, trance for balance and vision	Maize rituals, tobacco, fasting, dance	Community elders, spiritual healers
Renaissance Italy	Humoral theory, artistic catharsis, pilgrimage	Opium, absinthe, wine, confession	Courts, monasteries, salons
19th-century Europe	Institutional care; medicalized moral treatment	Morphine, bleeding, electrotherapy	Asylums, elite clinics, literary circles

Treatments and interpretive settings for mental, emotional, and spiritual crises in various civilizations.

Table 2- Physiological control of cognition and emotion across eras, by culture and region

Era	Control Mechanism	Health Impact	Narrative Justification
Ancient Civilizations	Fasting rituals, wine caste-based food distribution	Feasts, Nutrient-based stratification, ritual intoxication	Divine hierarchy, ritual purification
Medieval Europe	Church feasts for control, alcohol as religious sacrament, bread as loyalty tool	Famine cycles, malnutrition, dietary restriction	Moralistic suffering, monastic divine punishment
Modern Capitalist States	Processed food addiction, subsidies for sugar/alcohol, pharmaceutical dependency	Obesity, inflammation, pathologization	Diabetes, psychiatric consumer choice, biological determinism
Russia, late USSR	Vodka rationing, institutionalized alcoholism, chemical sedation for dissent	Liver disease, mass suicides, apathy	Revolutionary sacrifice, national hardship
Contemporary Global South	Junk food proliferation, privatized water, mental illness framing of poverty	Stunting, gut-brain dysfunction, mass depression and suicide	Clinical diagnosis, self-blame

Historical uses of food, drink, and altered states as instruments of social control and their psychiatric consequences, across epochs and geographies.

Table 3, Ancient patterns of marginalization and control

Targeted Group	Mechanism of Harm	Structural Role	Exploitative Driver
Enslaved laborers	Overwork, beatings, no legal rights	Resource extraction, class enforcement	Profit from forced labor
Urban poor in temple economies	Food debt, labor conscription	Surplus dependency structure	Control and surplus extraction
War prisoners, enslaved	Forced public works, mutilation	Imperial consolidation	Domination via labor, fear
Household servants, slaves	Sexual/physical coercion	Lineage and domestic control	Power and normalized abuse

This table outlines the early institutional, economic, and ideological mechanisms used to regulate, exclude, or exploit marginalized populations in ancient societies, including Mesopotamian, Egyptian, Greco-Roman, and early imperial models. It highlights how sociopolitical systems organized labor, justified social hierarchies, and medicalized or spiritualized dissent, laying the groundwork for later biomedical and psychiatric rationales of exclusion and control.

Table 4, Medieval and early modern systems of targeted harm

Targeted Group	Mechanism of Harm	Structural Role	Exploitative Driver
Feudal serfs	Bonded to land, no mobility	Agrarian wealth, elite maintenance	Rent extraction, control
Women	Torture, execution	Moral/patriarchal purification	Sadistic spectacle, forced sexual pleasure, male power
Religious minorities	Ghettoization, massacres	Territorial consolidation	Confiscation, ethnic purge
Pauper orphans	Forced labor, abuse	Cost-saving institutions	Institutional labor, neglect

This table presents the structural targeting of vulnerable populations in feudal and premodern Europe, including women, serfs, orphans, and religious minorities. These mechanisms -ranging from torture and forced labor to public executions -served not only as instruments of order and moral enforcement but also as technologies of terror, pleasure, and accumulation. The continuity of these practices into medical-legal frameworks underscores how control and exploitation were historically normalized through theological, patriarchal, and juridical rationales.

Table 5- Historical Governance

Era / Region	Gender/Class Subjugation	Knowledge Preservation	&	Skill Pleasure/Profit from Violence
Late Empire	Roman Women pushed to domesticity, elite concubinage	Classical knowledge preserved in minor schools		Public executions, military spectacles
Byzantine Empire	Elite women cloistered, lay women silenced	Preserved Hippocratic and Galenic medicine		Heresy purges and imperial torture rituals
Islamic Age	Golden Gender roles ambivalent; women could own property	Translation movement, Razi, Ibn Sina		Al- Judicial amputations, corporal punishments
Western Medieval Europe	Serfdom, female witch-hunts, orphans enslaved	Monasteries kept rudimentary archives		Witch-burnings, pillories, sacrificial wars
Early Europe	Modern Factory discipline, commodification	sexual Renaissance clandestine printing		humanism, Colonization as health sacrifice zone

This table disaggregates the role of gender and class in systems of exploitation, emphasizing how social identity intersected with epistemic and somatic control. Women, the poor, and the colonized were subject to layered forms of violence, including the confiscation of reproductive autonomy, criminalization of alternative knowledge systems, and commodification of pain for profit or pleasure. These dynamics laid the groundwork for modern institutional cruelty, in which trauma is still misrecognized as disorder and agency as deviance.

Table 6, Historical Governance Table

Era / Region	Health & Public Systems	Governance & Control Strategies	Population Obedience & Training
Late Empire	Roman Urban health infrastructure failing; aqueducts collapsing	Tax pressure, military conscription, Christianity as unifying coercion	Discipline by legions, declining civilian readiness
Byzantine Empire	Hospital and orphanage system maintained in Constantinople	Bureaucratic complexity, theological policing	Monastic discipline, literacy enforced in clergy
Islamic Age	Golden Advancements in hospital, hygiene, pharmacology	Meritocratic science hubs under caliphates	Intellectual training for elites, physical jihad
Western Medieval Europe	Monastic medicine, leechcraft, rural famine	Feudal oppression, authoritarianism	Church Martial training for nobility, no peasant rights
Early Europe	Modern Poor laws, plague patchy	Plague controls Absolutism, birth of central states	Standing armies, mass conscription

This table synthesizes key historical structures across antiquity and the medieval period, highlighting governance logics that linked obedience to biopolitical submission. Populations were managed through enforced ignorance, physical exhaustion, or ritualized subjugation, with the state or empire extracting productivity and loyalty by shaping bodily and cognitive norms. Medical traditions -when not entirely

displaced -were co-opted into controlling apparatuses that punished deviation or suffering as moral failure. Structural violence was normalized and encoded into law, pedagogy, and sacred practice.

Table 7- Modern governance and social control

Era / Region	Health & Public Systems	Governance & Control Strategies	Population Training	Obedience &
Early Century (Global)	20th State hospitals, eugenics programs	Nationalist social hygiene laws	science, Work-based military drafts	rehabilitation,
Mid Century	20th Mass institutionalization, psychiatric genocide	Ideological racial biology	purges, Compulsory secret policing	loyalty rituals,
Late Century	20th Deinstitutionalization, privatized healthcare	Market biopolitical management	logics, Self-optimization, culture	therapy
21st Century	Digital health surveillance regimes, data	Platform algorithmic control	capitalism, Censorship, profiling	predictive

This table contrasts the dominant political logics of population control across the 20th and 21st centuries, spanning totalitarianism, neoliberal governance, and algorithmic rationality. While modes differ -from centralized psychiatric repression to decentralized economic dispossession -all systems share a core commitment to suppressing dissent and reinforcing hierarchical order through coercive or pharmacological means. Rationality is often redefined to justify violence as necessity, psychiatry as discipline, and poverty as pathology.

Table 8- Modern governance and institutionalized violence

Era / Region	Gender/Class Subjugation	Knowledge & Skill Preservation	Pleasure/Profit from Violence
Early Century (Global)	20th Pro-natalist industrial patriarchy	propaganda, Medical colonial science	academies, Anatomical exploitation, forced labor profits
Mid 20th Century	Re-education camps, gender purging	Propaganda psychiatric policing	science, Spectacular trials, state terror aesthetics
Late 20th Century	Sexual commodification, gig precarity	Elite managerialism	universities, Prison-industrial complex, insurance markets
21st Century	Digital trafficking, biometric sorting	Platform monopolies	knowledge AI prediction economies, migrant exploitation

This table catalogs the institutional mechanisms -psychiatric, legal, technological, and bureaucratic -used to surveil, silence, or chemically subdue populations deemed unfit, inconvenient, or rebellious. While framed as therapeutic or security-enhancing, these systems function to obscure structural violence and redistribute blame from failing institutions to vulnerable individuals. The so-called care infrastructure reproduces inequality while denying the epistemic legitimacy of those most harmed.

Table 9- Institutional, psychiatric, and ideological control in the 20th–21st century

Category of Control	Mechanism Employed	Institutions Involved	Target Populations
Psychiatric Coercion	Involuntary hospitalization, forced medication, misdiagnosis of dissent as pathology	Asylums, psychiatric hospitals, forensic units	Political dissidents, abused women, neurodivergent individuals
Medical Pathologization Poverty	Reclassification of trauma or social deprivation as chronic mental illness	Social security disability assessments	Working-class populations, unemployed, single mothers
Carceral Expansion	Prison-like psychiatric wards, secure treatment centers, chemical restraints	Prisons, institutions, psychiatric units	juvenile closed Racialized youth, migrants, the homeless
Welfare Surveillance	Psychiatric labeling to restrict parental rights, enforce state guardianship, or justify state guardianship removals	Family courts, CPS, state guardianship bodies	Poor families, survivors of abuse, foster system entrants
Ideological education	Re- Therapeutic correction of gender identity, political beliefs, or trauma narratives	Conversion programs, military psychiatry, propaganda schools	LGBTQ+ individuals, political prisoners, rape victims
Digital & Algorithmic Control	Predictive policing, mental health flagging via social media, biometric sorting	Tech companies, predictive analytics firms, insurance brokers	Protesters, those with non-normative behaviors or expressions
Drug-Based Pacification	Long-term prescription of sedatives, antipsychotics, and mood stabilizers for non-severe distress	Primary care clinics, elderly care, schools	Children, elderly, women, those reporting abuse
Bureaucratic Silencing	Diagnosis used to dismiss testimony, deny legal claims, or erase credibility	Courts, police forces, hospitals	Victims of domestic and institutional violence

This table categorizes the dominant state and institutional strategies of psychological, ideological, and bodily control from the 20th century to the present. It includes coercive psychiatry, militarization, food monopolies, welfare surveillance, and technocratic governance across authoritarian, neoliberal, and hybrid regimes. Emphasis is placed on the operational role of psychiatry and health discourses in reframing dissent as disorder, and on the continuity of social control logics across political systems allegedly opposed in ideology but aligned in biopolitical function.

Table 10- Cultural Handling of Altered States and Mental Distress, by era and region

Period / Region	Induced or States	Treated	Substances / Foods Used	Rituals and Settings	Interpretive Agents
Ancient Greece	Melancholy, catharsis, mania	divine	Wine, hellebore, potions	opium, honeyed, Dionysian Asclepian incubation	rites, dream, Temple philosophers, priests,
Vedic India	Mystical sorrow, mental	ecstasy, heat	Soma, butter, herbs	clarified ayurvedic, Fire meditative seasonal fasting	sacrifices, chanting, Brahmins, healers, gurus,
Indigenous Amazon	Vision ancestral	quests, possession	Ayahuasca, chicha	tobacco, Night singing, immersion	rituals, group jungle, Shamans, elder women
Classical China	Grief, spiritual	madness, imbalance	Ginseng, mushroom, reishi, rice wine	Ancestral seasonal diaries, feasts, dream	rituals, dream, Daoist Confucian scholars, sages,
Medieval Islamicate	Spiritual melancholia, obsession		Ambergris, rosewater, saffron	Music therapy, dream interpretation	Qur'anic Hakims, theologians, Sufis
Medieval Europe	Demonic possession, melancholia		Absinthe, belladonna, and bread	fasting, Exorcisms, flagellation, confession	fasting, Monks, inquisitors, barbers
Edo Japan	Existential societal shame	grief,	Green tea, fermented rice, incense	Theater (Noh), communal poetry	writing, Zen monks, poets, physicians
Andean Highlands	Soul loss, ecstatic mourning	trance,	Coca leaves, beer, llama fat	maize, Dance, mountain offerings	bloodletting, Curanderos, community elders
Renaissance Europe	Black melancholy, madness	bile divine	Laudanum, tonics, red wine	herbal Patronage of alchemy, mirror-gazing	art, Artists, physicians, mystics
Yoruba Africa	West Spirit ecstatic	possession, healing	Palm wine, kola nut, herbal smokes	Drumming, divination ceremonies	trance, Orisha healers, priests,
Early Modern Europe	Hysteria, melancholia, rapture		Purgatives, opiates, hot baths	mercury, Magnetism sessions, mesmerism, confession	Physicians, moral managers

Historical approaches to madness, melancholy, divine ecstasy, and psychological suffering across world traditions, focusing on ritual, substances, communal interpretation, and contextual care practices.

Table 11- Physiological and social harms of forced psychotropic drugging

Category	Description of Harm
Neurological impairment	Tardive dyskinesia, akathisia, extrapyramidal symptoms, cognitive dulling, and neuroleptic-induced deficit syndrome are frequent outcomes of long-term use of antipsychotics
Metabolic and endocrine harm	Weight gain, insulin resistance, hyperlipidemia, and elevated risk of diabetes and cardiovascular disease
Sedation dependency	and Many psychotropics, including benzodiazepines and antipsychotics, originate from or mimic substances used in veterinary anesthesia; their use leads to dependency and emotional blunting
Loss of autonomy	Individuals subjected to forced drugging report lack of control, hopelessness, and inability to exercise basic civil or bodily rights
Isolation	Coerced individuals are perceived as dangerous or incompetent, intensifying social exclusion and familial rupture
Institutional dependency	Psychiatric treatment becomes synonymous with medication compliance; relational or psychosocial interventions are sidelined or unavailable
Social death	The combined effect of stigma, surveillance, and disempowerment results in symbolic exclusion from community and public life
Increased mortality	Long-term use of psychotropics, especially antipsychotics, is associated with reduced life expectancy by 10–20 years compared to the non-drugged cohorts, suicide and disease exceedingly high due to compounding harm and forced nature of the regime

Multifaceted physiological and social harms associated with forced psychiatric drugging, as documented in global and Spanish research contexts. These harms challenge the legitimacy of treatment-as-usual models, especially in coercive settings, and demand systemic transformation in mental health care.

Table 12- Perceived benefits of pharmacotherapy and stakeholder gains

Actor / Stakeholder	Perceived Benefit from Pharmacotherapy	Limitations / Costs Not Internalized by Actor
Individual patient (selected cases)	Short-term relief of acute symptoms (e.g., anxiety, hallucinations)	Long-term metabolic, cognitive and social harm (De Hert et al., 2011; Vancampfort et al., 2015)
Family members (under duress or without support)	Perceived behavioral stabilization reducing household conflict	Loss of autonomy and relational strain; lack of alternatives or systemic support
Clinical staff (psychiatrists, nurses)	Simplified patient management, symptom control under time/resource constraints	Ethical conflicts, burnout, and professional dissatisfaction in coercive settings
Hospital administrations	Cost-effective containment strategy; lower staffing burdens	Poor long-term outcomes; dependency on institutional cycles
Pharmaceutical companies	Revenue from medication sales; expansion of clinical indications	No responsibility for adverse outcomes or social consequences
Government / public policy makers	Budget control, reduced political risk from visible unrest or psychiatric crises	Long-term social exclusion, disability rates, and human rights scrutiny
Insurance systems (public/private)	Predictable and measurable cost structure	Externalization of broader psychosocial recovery costs

Actors who benefit directly or indirectly from pharmacotherapeutic paradigms in mental health care, while highlighting how harms and systemic consequences are often borne by patients and society at large rather than those incentivized to uphold current models.

Table 19. Structural Dangers of Coercive Psychiatric Regimes

Mechanism	Description	Consequences
Diagnostic ambiguity	Psychiatric categories are broad and elastic, easily fitting divergent behaviors	Enables strategic misuse to delegitimize or silence individuals
Family-based false reporting	Relatives fabricate symptoms or narratives to institutionalize or disempower	Enables extrajudicial detention and forced drugging
Institutional obedience	Staff comply with hierarchical mandates despite ethical doubts	Reduces possibility of intervention or whistleblowing
Legal incapacitation	Diagnoses lead to diminished legal standing and presumption of untrustworthiness	Limits capacity to defend oneself or contest abuse
Forensic re-interpretation of protest	Acts of self-defense or dissent are redefined as symptoms of illness	Eliminates legitimacy of resistance, justifies further coercion
Physical health deterioration	Forced medication causes long-term damage without addressing underlying suffering	Increases dependency, vulnerability, and chronicity
Social death	Isolation, forced treatments, and stigma result in permanent loss of community ties and self-agency	Perpetuates exclusion, unemployment, and juridical disadvantage
Reputational erasure	Labeling as mentally ill undermines credibility across social and legal domains	Facilitates exploitation and sustained structural disadvantage

Mechanisms of structural abuse and life destruction under coercive psychiatric regimes.

Table 20. Normalized punitive practices in psychiatric settings

Actor	Tool of Punishment or Control	Justification Used	Abuse Mechanism	Normalization
Psychiatrist	Involuntary drugging, seclusion, diagnosis escalation	Therapeutic necessity, risk management	Clinical authority interpreted as infallible judgment	
Nurse	Physical restraints, isolation, verbal intimidation	Behavioral control, safety protocol	Culture of obedience, understaffing, and hierarchical impunity	
Psychologist	Misinterpretation of trauma, gaslighting, denial of therapeutic alliance	Lack of insight, secondary gains	Pathologization of complaint or critique	
Family member	False claims, reinforcement of diagnosis, denial of support	Duty of care, concern for safety	No external oversight; deference to family in institutional contexts	
Social worker	Blocking access to housing or autonomy-related services	Non-compliance, mental incapacity	Collaboration with medical files without independent evaluation	
Community institutions	Disregard for complaints, deferral to psychiatric authority	Professional consensus, risk avoidance	Psychiatric documents dominate administrative and judicial decisions	
Punitive practices and mechanisms enabling systemic abuse across psychiatric and family settings.				

Table 21- Rationalizations and incentives in psychiatric care nowadays

Actor / Group	Stated Justification	Dissonance with Reality	Empirical Underlying Incentives (Money, Power, Status)
Academic psychiatrists / professors	Evidence-based standards; safety; biological causality	Ongoing controversy over evidence quality and generalizability	Professional prestige; and industry ties; influence in policy and curricula
Politicians / public health officials	Public order, risk reduction, budgetary efficiency	Failure to address structural causes of distress; chronicity worsens under treatment-as-usual (Sisti et al., 2021)	Political capital; avoidance of structural reform; outsourcing responsibility
Practicing psychiatrists / clinicians	Clinical necessity; symptom management; legal safety	Time constraints, resource gaps, and lack of support for legal alternatives drive overreliance on medication	Avoidance of liability; institutional conformity; procedural simplicity
Pharmaceutical-aligned researchers	Scientific advancement; optimization of treatment	Selective publication, ghostwriting, and conflicts undermine neutrality	Research funding; financial career progression; corporate affiliations
Nurses / support staff	Patient and safety; manageability	Frequent distress caused by work forced measures and training in trauma-informed	Job security; lack of systemic alternatives; burnout deflection

Actor / Group	Stated Justification	Dissonance with Reality	Empirical	Underlying Incentives (Money, Power, Status)
Family members (ambivalent/abusive)	'Stabilization', obedience, relief from caregiving burden	Often participate in cycles of control, scapegoating, or silence about abuse		Restored order; avoidance of accountability; social legitimacy
Legal actors / judicial systems	Due process followed; therapeutic exception	Often rely on institutional claims, overlook human rights violations		Case resolution ease; institutional trust; avoidance of political conflict
Sociomedical educators	Enforcing allegedly neutral so-called science processes; appearance of technocratic rationality	Marginalize critical and user-led perspectives; reinforce top-down power		Intellectual gatekeeping; ideological alignment; systemic career incentives

Rationalizations used by institutional actors to justify coercive pharmacological interventions in mental health, alongside empirical dissonances and material or symbolic incentives maintaining the current system. Evidence suggests that these justifications often obscure deeper patterns of neglect, coercion, and power asymmetry.

Table 22. Historical Evolution of Psychiatric Interventions, 20th–21st Century

Period	Pharmacological Interventions	Physical/Institutional Approaches	Psychosocial/Community Approaches	Force Coercion	and Target Populations and Patterns
1900–1950	Barbiturates, early antipsychotics, insulin shock	Asylums, electroconvulsive therapy, lobotomies	Limited, confined to psychoanalysis (elitist)	Often to involuntary; massive confinement	Women, poor, disabled, colonized subjects framed as deviant
1950–1970	Chlorpromazine, lithium, MAOIs	Deinstitutionalization begins, ECT remains	Rise of social psychiatry, family therapy	Ambiguous: outpatient clinics expand, coercion persists	Allegedly therapeutic force; racial minorities disproportionately institutionalized
1970–1990	Benzodiazepines, SSRIs, atypical	Hospital downsizing, rise of psychiatric	Community mental health	Restraints often used	Women medicalized for non-compliance

Period	Pharmacological Interventions	Physical/Institutional Approaches	Psychosocial/Community Approaches	Force Coercion	and Target Populations and Patterns
	antipsychotics	wards in general hospitals	centers promoted (esp. post-WHO 1979)	unregulated; lack of awareness	despair, anti-rights psychiatric critiques rise
1990–2010	Polypharmacy, overprescription, off-label uses, stimulant and other drugs use rise in children population	Forensic psychiatry and emergency interventions dominate	Global Mental Health movement emerges, posing both risks and opportunities	Legislation increases procedural safeguards, but implementation weak	Rise in psychotropics among elderly, youth, and racialized populations
2010–present	Long-acting injectables, digital therapeutics, overprescription trends worsen	Acute care, seclusion, and mechanical restraints still widespread	Trauma-informed care, recovery-oriented approaches barely adopted	UN/WHO condemn coercive practices common	Shared decision-making discussed rarely implemented; structural abuse persists

Main treatments, modalities, and political logics across global and European contexts. Historical overview of psychiatric practice by dominant treatment logics, coercion levels, and affected populations (1900–present). Based on scientific and policy literature.

Table 23. Timeline of global mental health advocacy and policy shifts

Period	Dominant Framing	Key Institutions	Goals Articulated	Political-Economic Context	Effectiveness
1970s–1980s	Public health integration	WHO, PAHO	Primary care inclusion of mental health (Alma-Ata, 1978)	Post-colonial restructuring, War	Limited implementation; high institutional inertia

Period	Dominant Framing	Key Institutions	Goals Articulated	Political-Economic Context	Effectiveness
1990s	Neurobiological focus rises	NIMH, WPA, pharma-aligned agencies	Emphasis on diagnostics (e.g. DSM-IV), pharmaceutical rollout	Rise of global pharma, neoliberalism	Community-based models undercut by privatization
2001	Rights-based global reform	WHO (World Health Report 2001)	Community-based, user-involved services	Globalization, post-Soviet health transition	Key declarations; partial reform in few countries
2007–2013	mhGAP program	WHO, UNHRC	Integration in non-specialist settings, rights emphasis	Global burden of disease framing	Some regional impact; insufficient structural funding
2018–present	Human rights, LGBT+, anti-racism, One Health	UN, WHO, CRPD	End coercion, promote autonomy and choice	UNCRPD enforcement, Sustainable Development Goals	Systemic coercion persists; calls for compliance unheeded in many contexts

International mental health advocacy phases, from primary care reform to human rights-based frameworks, with limited structural transformation.

Table 24- Sociocultural models of psychiatry and abuses of the discipline to punish, control

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Biological framing
Buddhist-informed	Spiritual bypassing, behavioral conformity	Detachment from suffering, integration	Meditation as neurological regulation
Classical asylum	Confinement, dehumanization, discipline	Social order, moral hygiene	Degeneration theory, inherited inferiority
Freudian psychoanalysis	Verbal domination, pathologizing normativity	Libidinal economy, repression theory	Somatic roots of hysteria and libido
Lacanian psychoanalysis	Ambiguity, institutional cultism, symbolic violence	Subject split, language mastery	Linguistic inscription over neurology
Soviet psychiatry	Political imprisonment, psychiatric labeling	Ideological conformity, state security	Material brain-based deviance
Democratic psychiatry	Minimal; rights-based, disruption of coercion	Equality, emancipation, community care	Critique of reductionism, neuroplasticity support
Postcolonial ethnopsychiatry	Cultural assimilation, epistemic domination	Colonial control, identity erasure	Organicism denied or distorted via 'soul sickness'
Neocolonial psychiatry	Criminalization, silencing of resistance	Order maintenance, cultural export	Diagnostic mimicry of Western pathologies
Community-based and open dialogue models	Low; minimal or pharmacological physical coercion	Dialogue, subjectivity, social recovery	Complex adaptive neurobiology

Paradigms of psychiatry with their historical and contemporary misuses to exert punitive control, marginalize dissent, and enforce normative behavior under the guise of care.

Table 25- Biological and allegedly biological models of psychiatry

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Social Framing
Francoist	Political repression through biological deviance	Biological inferiority justifying national moral order	Moral deviation encoded in bloodline and class
National Socialist	Sterilization, extermination by racial-biological doctrine	Racial hygiene, eugenic cleansing, societal purification	Biological race as societal value metric
Biologicist Psychiatry	Polypharmacy, chronicization, dismissal of cause	Neurochemical correction, diagnostic standardization	Functional adaptation to disorder; lifestyle blamed
Nutritional Psychiatry	Neglect of social context, over-focus on micronutrients	Gut-brain restoration, on micronutrient optimization	Diet-driven personality traits and cognition
Metabolic Psychiatry	Metabolic labeling, medicalization of stress	Systemic resilience, glucose-lipid-mental	Stress as pathology of social performance

Psychiatric tradition	Violence Inflicted	Ideological Motifs	Social Framing
		health link	
Psychoneuroimmunology-based Approaches	Reductive profiling, essentialism	immune biomarker, Inflammation cytokine-mediated regulation	control, Social threat read as immune activation
Neuroendocrine-Informed Models	Hormonal manipulation, gendered bias	Hormonal balance, HPA axis recalibration	Stress exposure framed through gendered life roles
Microbiota-Gut-Brain Axis Psychiatry	Overinterpretation of correlations, overselling	Barrier protection, probiotic digestive-immune regulation	Western diet and co-urbanization as disease vectors
Systems Biology	Datafied abstraction, individual burden framing	Multi-scalar modeling, predictive frameworks	Individualized health responsibility for failure to self-regulate

Biologically framed psychiatric models, their scientific foundations and controversies, including critique of chemical imbalance theories and reductionist diagnostic frameworks.

Table 26- Coercive measures in psychiatric and general healthcare settings in Spain

Setting	Coercive Practices
Primary Care	Coercion is primarily symbolic. Patients pressured into pharmacological compliance. Referral used to discipline rather than support (Moncrieff, 2022).
Outpatient Health Units	Mental Legal coercion via guardianship and compulsory outpatient treatment. Emergency measures sometimes bypass procedural safeguards (Muñoz & Lobato, 2021).
Hospital Wards	Psychiatry Mechanical restraints and isolation used routinely under therapeutic pretext. Often applied punitively or to suppress distress (González Pinto et al., 2020; WHO, 2021).
Forensic Units	Psychiatry Prolonged seclusion and forced medication normalized. Coercion institutionalized and poorly monitored. Human rights safeguards minimal (Rodríguez-Pulido et al., 2021).

Common coercive practices in mental health settings in Spain, showing normalization of physical and legal control mechanisms.

Table 27- Patterns of psychotropic overprescription in Spain by clinical setting

Setting	Overprescription of Psychotropics
Primary Care	Benzodiazepines and antidepressants frequently prescribed as first-line treatment without comprehensive assessment. Most affected: elderly and women (Abas et al., 2018; WHO, 2021).
Outpatient Health Units	Mental Polypharmacy is common. Medication is maintained over time without regular review. Consent procedures often inadequate or absent (Rose et al., 2022).
Hospital Wards	Psychiatry Dosage increases and drug switching are frequent during crises. Informed consent not prioritized. Medication dominates therapeutic approach (Rodríguez-Pulido et al., 2021).
Forensic Units	Psychiatry Antipsychotics administered systematically for behavioral containment. Alternatives rarely considered. Consent typically circumvented (Otero & Pérez, 2019).

Summary of overprescription trends in different healthcare settings in Spain, highlighting systemic pharmacological excess and lack of dialogical care.

Thematic index and mapping

Below is a thematically organized mapping of the dissertation's major concepts, aligned with the chapters and annexes where each is most substantively developed. This table supports reader orientation and clarifies the conceptual architecture across the empirical, legal, and applied dimensions of the work. Please note that due to sustained institutional pressure, abusive constraints, and structurally hostile conditions endured during the final stages of dissertation preparation, coinciding with intense academic, legal, and coordination workloads, it was not feasible to include the full breadth of content, evidence, and analytical resources in this printed version. Severe formatting restrictions, together with time-sensitive deadlines and repeated episodes of obstruction and violence, further limited the capacity to render the document in its complete and intended form.

Coercion in psychiatry is a central theme appearing throughout the dissertation. It is addressed in section 1.1 in its historical form under institutional repression and carceral psychiatry, in section 1.2 as part of the current framework of involuntary treatment, and in sections 1.6 and 1.7 as systemic failure and power-related diagnostic exclusion. It also features prominently in sections 2.2, 2.4, and 2.7 in the analysis of coercion through mixed-methods research and reflexive methodologies. Sections 3.1 to 3.3 elaborate the lived experiences of coercion, especially in institutional settings, while sections 4.1 to 4.4 extend this analysis through ethnographic documentation of coercive practices. Section 5.1 connects psychiatric coercion with learned helplessness, while section 6.2 treats coercion as a violation of international human rights.

Structural violence is identified in sections 1.2, 1.3, and 1.6 as embedded in pharmacocentric psychiatric systems. It is analytically developed in sections 2.1, 2.2, and 2.7 as both an empirical finding and a methodological challenge, then further documented through participant testimony in

sections 3.3 and 4.3. Its long-term effects on health and neurodevelopment are discussed in sections 5.1 and 5.2, and its legal implications are examined in section 6.2.

Institutional betrayal is explored from section 1.5 onward, with special emphasis in sections 3.4 to 3.7 as a relational and organizational phenomenon that affects both users and professionals. In sections 4.1 to 4.4, it is analysed through narrative reconstruction and ethnographic evidence. The term reappears in sections 5.1 and 6.2 when addressing structural impunity, forensic accountability, and the failure of legal safeguards.

Epistemic injustice appears as a core concept in section 1.5 on legal and epistemic foundations, and is further developed in section 1.7 through the lens of diagnosis and exclusion. Methodologically, it frames sections 2.1, 2.2, 2.5, and 2.6. Empirical data reflecting epistemic injustice are presented in sections 3.2 to 3.6 and again in 4.5 and 4.6 through testimonial erasure and narrative foreclosure. Sections 5.2 and 5.4 connect it to reductionist diagnostics, and 7.1 and 7.3 propose educational responses.

Shared decision-making is treated as a countermodel to coercion in psychiatry, discussed in section 1.4 regarding deprescription and user autonomy. It is also part of the research instruments described in section 2.3 and analyzed in findings in sections 3.1 and 3.6. It appears again in section 5.5 as part of legal reform proposals, and in 7.2 within future-oriented frameworks for rights-based psychiatric care.

Pharmacocentrism and overmedication are analyzed in section 1.3 as systemic features of Spanish psychiatric care. Section 1.4 focuses on alternatives such as deprescription and long-term medication ethics. These themes are then referenced in empirical findings (sections 3.6 and 5.4) and addressed normatively in sections 6.1 and 6.3 through proposals for neurobiological literacy, somatic regulation, and open-source expert systems.

Transdisciplinary action research is outlined in sections 1.0, 1.8, and 2.1 as the overarching methodology. It also underpins the work in sections 2.4 and 2.9 through its application in mixed methods, reflexivity, and systemic transformation. The design is reaffirmed in sections 5.5 and 7.1 to 7.3 in reference to future implementation through One Health education and participatory governance.

Legal accountability is developed in sections 1.2, 1.5, and 1.6 with respect to coercive practices and rights violations. Sections 3.7 and 4.3 analyze legal ambiguity, institutional silencing, and accountability failures. Section 5.5 proposes new legal-pedagogical standards, while section 6.2 addresses the alignment of national practice with international human rights law and CRPD principles.

Biocultural psychiatry and **trauma-informed care** appear in section 1.4 and 1.6, and more explicitly in 2.1 and 2.5 as foundations for a new clinical paradigm. Section 5.2 links biocultural trauma with neurodevelopment, and 7.1 and 7.3 present it as part of a curricular transformation for mental health and social care professionals.

Narrative sovereignty and **testimonial justice** are articulated in sections 4.3, 4.5, and 4.6 as correctives to epistemic violence and reductionist diagnostics. These themes also frame

participatory methods (sections 2.3 and 2.8) and reappear in section 5.4 and 6.3 within structural and educational reform proposals.

One Health is introduced in section 1.8 and developed as a unifying concept in sections 2.8, 5.5, 6.1, and 7.3. It provides a framework for integrative ethics, interdisciplinary education, and resilient system design that addresses mental, physical, and ecological health together.

Ethical AI and expert systems in psychiatry emerge in sections 6.3 and 7.2, where they are proposed as tools for ethical governance and patient empowerment. They are linked to participatory design, precision mental health, and rights-based oversight, and are part of the structural response proposed in the EU BEACON framework.

Educational reform is addressed through sections 5.5, 6.1, 7.1, and 7.3 as a necessary step to prevent future epistemic violence and structural failure. It incorporates trauma-informed pedagogy, neurobiological literacy, relational ethics, and participatory learning, with emphasis on long-term system resilience and justice.

An expanded and interactive version of this dissertation is therefore being made available online as an open access ebook. This living edition incorporates all annexes, updated analyses, extended methodological notes, evidence tables, and thematic mappings, as well as the tools, instruments, and codes used in this research. It will continue to grow in accuracy, depth, and applicability in line with the principles of action research and scientific accountability. For full access to the updated version, including dynamic indexes and embedded documentation, please visit the dedicated repository and dissemination platform accompanying this work:

Thematic keywords	Chapters	Annexes
Structural violence	1, 4, 5, 6	D, G, K
Psychiatric coercion	1, 3, 5	C, F, G
Shared decision-making	2, 7	F, J, K
Epistemic injustice	1, 2, 4, 5	C, G
Action research	2, 3, 4	B, G
Human rights and legal frameworks	1, 6, 8	G, H, I, K
Biocultural methodology	2, 4, 5	D, F
Testimony and narrative evidence	4, 5	B, C
Dialogical and relational care	3, 7	A, F
Psychiatric diagnosis and medication	3, 5	D, F
Institutional betrayal and repression	4, 6	B, C
Alternatives to coercion	5, 7	A, F
Systems transformation and reform	7, 8	H, I, J, K
Open science and pedagogy	7	J, M
Survivor-researcher positionality	2	F

Thematic keywords	Chapters	Annexes
Ethics of qualitative research	2, 6	A, F
Policy translation and implementation	7, 8	H, I, K, L

The full mapping of keywords, themes, and actors relevant to this dissertation link will be shared on the open science laboratory and fieldwork notebook. The repository is conceived not as a static archive, but as a living, version-controlled environment subject to ongoing refinement, correction, and enrichment. Following the principles of action research, the structure and content of the repository will evolve in response to new evidence, user feedback, critical input, and implementation needs arising from fieldwork and policy engagement. The mapping exercise will progressively deepen and systematize the documentation of all major analytical categories, conceptual clusters, and empirical references appearing across the chapters and annexes. It will include cross-referenced indexes of themes, legal principles, methodological frameworks, discursive patterns, and institutional actors, providing an integrated navigational and interpretive guide for readers, reviewers, and allied professionals. This process will be grounded in the rigorous logic of transdisciplinary inquiry and the ethical imperative to make visible the underlying structures of violence, resistance, and repair documented throughout the work. In parallel, the repository includes all instruments and codes developed and employed in the course of the research. These encompass survey instruments, thematic coding schemas, case analysis matrices, legal mapping procedures, and computational scripts for organizing and analyzing the dataset. Each component is provided in fully accessible formats and accompanied by detailed documentation to support adaptation, reuse, and local implementation across diverse educational, clinical, legal, or policy contexts. The online version of this work will continue to be updated as part of the dissertation's ongoing contribution to the field, ensuring that its analytical tools, empirical insights, and proposed reforms remain usable, improvable, and contextually relevant. This reflects a core ethical and scientific commitment: that research of this nature ought to remain open, traceable, and accountable, not only in its results but also in its mechanisms, limitations, and possible futures.

Índice temático y mapeo

A continuación se presenta un mapeo temático de los conceptos principales de la tesis, alineado con los capítulos y anexos en los que cada uno se desarrolla de manera más sustantiva. Esta tabla ayuda a orientar al lector y aclara la arquitectura conceptual en las dimensiones empírica, jurídica y aplicada del trabajo. Cabe señalar que, debido a la presión institucional sostenida, las restricciones abusivas y las condiciones estructuralmente hostiles soportadas durante las etapas finales de la preparación de la tesis, coincidiendo con una intensa carga de trabajo académico, jurídico y de coordinación, no ha sido posible incluir en esta versión impresa la totalidad del contenido, las pruebas y los recursos analíticos. Las severas restricciones de formato, junto con los plazos urgentes y los repetidos episodios de obstrucción y violencia, limitaron aún más la capacidad de presentar el documento en su forma completa y prevista.

La coacción en la psiquiatría es un tema central que aparece a lo largo de toda la tesis. Se aborda en la sección 1.1 en su forma histórica bajo la represión institucional y la psiquiatría carcelaria, en la sección 1.2 como parte del marco actual del tratamiento involuntario, y en las secciones 1.6 y 1.7 como fracaso sistémico y exclusión diagnóstica relacionada con el poder. También ocupa un lugar destacado en las secciones 2.2, 2.4 y 2.7 en el análisis de la coacción mediante métodos mixtos y metodologías reflexivas. Las secciones 3.1 a 3.3 detallan las experiencias vividas de coacción, especialmente en entornos institucionales, mientras que las secciones 4.1 a 4.4 amplían este análisis mediante documentación etnográfica de prácticas coercitivas. La sección 5.1 relaciona la coacción psiquiátrica con la indefensión aprendida, mientras que la sección 6.2 trata la coacción como una violación de los derechos humanos internacionales.

La violencia estructural se identifica en las secciones 1.2, 1.3 y 1.6 como algo inherente a los sistemas psiquiátricos farmacocéntricos. Se desarrolla analíticamente en las secciones 2.1, 2.2 y 2.7 como un hallazgo empírico y un desafío metodológico, y se documenta con más detalle a través de los testimonios de los participantes en las secciones 3.3 y 4.3. Sus efectos a largo plazo sobre la salud y el desarrollo neurológico se analizan en las secciones 5.1 y 5.2, y sus implicaciones legales se examinan en la sección 6.2.

La traición institucional se explora a partir de la sección 1.5, con especial énfasis en las secciones 3.4 a 3.7, como un fenómeno relacional y organizativo que afecta tanto a los usuarios como a los

profesionales. En las secciones 4.1 a 4.4, se analiza mediante la reconstrucción narrativa y la evidencia etnográfica. El término reaparece en las secciones 5.1 y 6.2 al abordar la impunidad estructural, la responsabilidad forense y el fracaso de las garantías legales.

La injusticia epistémica aparece como concepto central en la sección 1.5, sobre fundamentos jurídicos y epistémicos, y se desarrolla en la sección 1.7 desde la perspectiva del diagnóstico y la exclusión. Desde el punto de vista metodológico, enmarca las secciones 2.1, 2.2, 2.5 y 2.6. Los datos empíricos que reflejan la injusticia epistémica se presentan en las secciones 3.2 a 3.6 y de nuevo en 4.5 y 4.6 a través de la supresión de testimonios y la exclusión narrativa. Las secciones 5.2 y 5.4 la relacionan con los diagnósticos reduccionistas, y 7.1 y 7.3 proponen respuestas educativas.

La toma de decisiones compartida se trata como un contramodelo a la coacción en psiquiatría, discutido en la sección 1.4 en relación con la desprescripción y la autonomía del usuario. También forma parte de los instrumentos de investigación descritos en la sección 2.3 y analizados en los resultados de las secciones 3.1 y 3.6. Vuelve a aparecer en la sección 5.5 como parte de las propuestas de reforma legal, y en la 7.2 dentro de los marcos orientados al futuro para la atención psiquiátrica basada en los derechos.

El farmacocentrismo y la sobremedicación se analizan en la sección 1.3 como características sistémicas de la atención psiquiátrica española. La sección 1.4 se centra en alternativas como la desprescripción y la ética de la medicación a largo plazo. Estos temas se mencionan posteriormente en los resultados empíricos (secciones 3.6 y 5.4) y se abordan de forma normativa en las secciones 6.1 y 6.3 a través de propuestas de alfabetización neurobiológica, regulación somática y sistemas expertos de código abierto.

La investigación-acción transdisciplinaria se describe en las secciones 1.0, 1.8 y 2.1 como la metodología general. También sustenta el trabajo de las secciones 2.4 y 2.9 a través de su aplicación en métodos mixtos, reflexividad y transformación sistémica. El diseño se reafirma en las secciones 5.5 y 7.1 a 7.3 en referencia a su futura implementación a través de la educación One Health y la gobernanza participativa.

La responsabilidad jurídica se desarrolla en las secciones 1.2, 1.5 y 1.6 con respecto a las prácticas coercitivas y las violaciones de derechos. Las secciones 3.7 y 4.3 analizan la ambigüedad jurídica, el silenciamiento institucional y las deficiencias en la rendición de cuentas. La sección 5.5 propone nuevas normas jurídico-pedagógicas, mientras que la sección 6.2 aborda la armonización de la práctica nacional con el derecho internacional de los derechos humanos y los principios de la CDPD.

La psiquiatría biocultural y la atención informada por el trauma aparecen en las secciones 1.4 y 1.6, y de forma más explícita en las secciones 2.1 y 2.5 como fundamentos de un nuevo paradigma clínico. La sección 5.2 vincula el trauma biocultural con el neurodesarrollo, y las secciones 7.1 y 7.3 lo presentan como parte de una transformación curricular para los profesionales de la salud mental y la asistencia social.

La soberanía narrativa y la justicia testimonial se articulan en las secciones 4.3, 4.5 y 4.6 como correctivos de la violencia epistémica y los diagnósticos reduccionistas. Estos temas también

enmarcan los métodos participativos (secciones 2.3 y 2.8) y reaparecen en las secciones 5.4 y 6.3 dentro de las propuestas de reforma estructural y educativa.

La salud única se introduce en la sección 1.8 y se desarrolla como concepto unificador en las secciones 2.8, 5.5, 6.1 y 7.3. Proporciona un marco para la ética integradora, la educación interdisciplinaria y el diseño de sistemas resilientes que abordan conjuntamente la salud mental, física y ecológica.

La IA ética y los sistemas expertos en psiquiatría aparecen en las secciones 6.3 y 7.2, donde se proponen como herramientas para la gobernanza ética y el empoderamiento de los pacientes. Están vinculados al diseño participativo, la salud mental de precisión y la supervisión basada en los derechos, y forman parte de la respuesta estructural propuesta en el marco BEACON de la UE.

La reforma educativa se aborda en las secciones 5.5, 6.1, 7.1 y 7.3 como un paso necesario para prevenir la violencia epistémica y el fracaso estructural en el futuro. Incorpora la pedagogía informada sobre el trauma, la alfabetización neurobiológica, la ética relacional y el aprendizaje participativo, con énfasis en la resiliencia y la justicia del sistema a largo plazo.

Por lo tanto, se está poniendo a disposición en línea una versión ampliada e interactiva de esta tesis en forma de libro electrónico de acceso abierto. Esta edición viva incorpora todos los anexos, análisis actualizados, notas metodológicas ampliadas, tablas de pruebas y mapas temáticos, así como las herramientas, instrumentos y códigos utilizados en esta investigación. Seguirá creciendo en precisión, profundidad y aplicabilidad, en línea con los principios de la investigación-acción y la responsabilidad científica. Para acceder a la versión actualizada, incluidos los índices dinámicos y la documentación incorporada, visite el repositorio y la plataforma de difusión específicos que acompañan a este trabajo:

Palabras clave temáticas	Capítulos Anexos
Violencia estructural	1, 4, 5, 6 D, G, K
Coacción psiquiátrica	1, 3, 5 C, F, G
Toma de decisiones compartida	2, 7 F, J, K
Injusticia epistémica	1, 2, 4, 5 C, G
Investigación-acción	2, 3, 4 B, G
Derechos humanos y marcos jurídicos	1, 6, 8 G, H, I, K
Metodología biocultural	2, 4, 5 D, F
Testimonio y pruebas narrativas	4, 5 B, C
Atención dialógica y relacional	3, 7 A, F
Diagnóstico psiquiátrico y medicación	3, 5 D, F
Traición institucional y represión	4, 6 B, C
Alternativas a la coacción	5, 7 A, F
Transformación y reforma de los	7, 8 H, I, J, K

Palabras clave temáticas	Capítulos Anexos	
sistemas		
Ciencia abierta y pedagogía	7	J, M
Posicionalidad del investigador superviviente	2	F
Ética de la investigación cualitativa	2, 6	A, F
Traducción e implementación de políticas	7, 8	H, I, K, L

El mapeo completo de las palabras clave, los temas y los actores relevantes para esta tesis se compartirá en el laboratorio de ciencia abierta y en el cuaderno de trabajo de campo. El repositorio no se concibe como un archivo estático, sino como un entorno vivo, con control de versiones, sujeto a continuas mejoras, correcciones y enriquecimientos. Siguiendo los principios de la investigación-acción, la estructura y el contenido del repositorio evolucionarán en respuesta a nuevas evidencias, comentarios de los usuarios, aportaciones críticas y necesidades de implementación que surjan del trabajo de campo y de la participación en las políticas. El ejercicio de mapeo profundizará y sistematizará progresivamente la documentación de todas las principales categorías analíticas, grupos conceptuales y referencias empíricas que aparecen a lo largo de los capítulos y anexos. Incluirá índices con referencias cruzadas de temas, principios jurídicos, marcos metodológicos, patrones discursivos y actores institucionales, proporcionando una guía de navegación e interpretación integrada para los lectores, revisores y profesionales afines. Este proceso se basará en la lógica rigurosa de la investigación transdisciplinaria y en el imperativo ético de visibilizar las estructuras subyacentes de violencia, resistencia y reparación documentadas a lo largo del trabajo. Paralelamente, el repositorio incluye todos los instrumentos y códigos desarrollados y empleados en el curso de la investigación. Estos abarcan instrumentos de encuesta, esquemas de codificación temática, matrices de análisis de casos, procedimientos de mapeo jurídico y scripts computacionales para organizar y analizar el conjunto de datos. Cada componente se proporciona en formatos totalmente accesibles y va acompañado de documentación detallada para facilitar su adaptación, reutilización y aplicación local en diversos contextos educativos, clínicos, jurídicos o políticos. La versión en línea de este trabajo se seguirá actualizando como parte de la contribución continua de la tesis al campo, garantizando que sus herramientas analíticas, conocimientos empíricos y reformas propuestas sigan siendo utilizables, mejorables y contextualmente relevantes. Esto refleja un compromiso ético y científico fundamental: que la investigación de esta naturaleza debe permanecer abierta, trazable y responsable, no solo en sus resultados, sino también en sus mecanismos, limitaciones y posibles futuros.

